

Promoção da saúde Sinais e sintomas Rinorreia

Identificação Prurido Vermelhidão

Exame clínico Astenia Sudorese

Relação médico-paciente Anamnese

Exame físico Entrevista Queixa principal

Porto & Porto

Exame Clínico

Oitava edição



GUANABARA
KOOGAN

Exame Clínico



O GEN | Grupo Editorial Nacional – maior plataforma editorial brasileira no segmento científico, técnico e profissional – publica conteúdos nas áreas de ciências da saúde, exatas, humanas, jurídicas e sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados à educação continuada e à preparação para concursos.

As editoras que integram o GEN, das mais respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade e seriedade.

A missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informação científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao crescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.

Exame Clínico

Editor

Celmo Celeno Porto

Professor Emérito da Faculdade de Medicina da UFG.
Doutor em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da UFMG.
Especialista em Clínica Médica e Cardiologia.
Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.
Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.
Membro Honorário da Academia Nacional de Medicina.

Coeditor

Arnaldo Lemos Porto

Especialista em Clínica Médica e Cardiologia.
Coordenador do Centro de Cardiologia do Hospital Santa Helena de Goiânia.
Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Oitava edição



- O autor deste livro e a EDITORA GUANABARA KOOGAN LTDA. empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, *e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data da entrega dos originais à editora*. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências da saúde, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre terapêutica medicamentosa e reações adversas a fármacos, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas neste livro estão corretas e de que não houve alterações nas dosagens recomendadas ou na legislação regulamentadora.
- O autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2017 by
EDITORA GUANABARA KOOGAN LTDA.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Travessa do Ouvidor, 11 – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-040
Tels.: (21) 3543-0770/(11) 5080-0770 | Fax: (21) 3543-0896
www.grupogen.com.br | editorial.saude@grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da EDITORA GUANABARA KOOGAN LTDA.
- Capa: Editorial Saúde
Produção digital: Geethik
- Ficha catalográfica

P881e

8. ed.

Porto, Celmo Celeno

Exame clínico / Celmo Celeno Porto, Arnaldo Lemos Porto. - 8. ed. - [Reimpr.] - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017.
il.

ISBN 978-85-277-3102-7

1. Clínica médica. I. Porto, Arnaldo Lemos. II. Título.

16-37057

CDD: 616.075

CDU: 616-07

Colaboradores

Abrahão Afiune Neto

Especialista em Cardiologia. Doutor em Cardiologia pela USP. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG e do Curso de Medicina da UniEvangélica. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Aguinaldo Figueiredo de Freitas Jr.

Especialista em Cardiologia. Doutor em Cardiologia pela USP. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG.

Aiçar Chaul

Especialista em Dermatologia. Ex-Professor do Departamento de Medicina Tropical e Saúde Pública da UFG. Chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFG.

Alexandre Roberti

Especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutor em Ciências da Saúde pela UFG. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Coordenador da Disciplina de Práticas Integradoras II da Faculdade de Medicina da UFG.

Alexandre Vieira Santos Moraes

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Doutor em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina da UNIFESP. Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG e de Ginecologia e Obstetrícia do Curso de Medicina da UniEvangélica.

Américo de Oliveira Silverio

Especialista em Gastroenterologia. Mestre em Hepatologia pela Fundação Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG e do Curso de Medicina da PUC-Goiás.

Antonio Carlos Ximenes

Especialista em Reumatologia. Doutor em Reumatologia pela USP. Chefe do Departamento de Medicina Interna do Hospital Geral de Goiânia. Coordenador do Centro Internacional de Pesquisa.

Arnaldo Lemos Porto

Especialista em Clínica Médica e Cardiologia. Coordenador do Centro de Cardiologia do Hospital Santa Helena de Goiânia. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Cacilda Pedrosa de Oliveira

Especialista em Clínica Médica e Gastroenterologia. Doutora em Gastroenterologia pela USP. Professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG.

Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira

Psicóloga Especialista em Psicodrama Terapêutico e Terapia Familiar Sistêmica. Mestre em Educação pela UFG. Doutora em Psicologia pela UnB. Coordenadora do Programa de Estudos e Prevenção do Suicídio da Faculdade de Medicina da UFG.

Claudio Henrique Teixeira

Especialista em Clínica Médica e Geriatria.

Cláudio Jacinto Pereira Martins

Especialista em Clínica Médica. Professor da Faculdade de Medicina da UNIUBE e da Disciplina de Semiologia Clínica da Faculdade de Medicina da UFTM.

Danilo Rocha Dias

Mestre em Reabilitação Oral. Doutor em Ciências da Saúde pela UFG. Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFG.

Delson José da Silva

Especialista em Neurologia. Mestre e Doutor pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Chefe da Unidade de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da UFG. Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia.

Denise Sisteroli Diniz Carneiro

Especialista em Neurologia. Mestre em Medicina Tropical pela UFG. Doutora em Ciências da Saúde pela UFG. Professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.

Denise Viuniski da Nova Cruz

Especialista em Clínica Médica. Doutora em Educação pela UNIVALI. Professora de Semiologia e Clínica Médica do Curso de Medicina da UNIVALI.

Diego Antônio Arantes

Mestre em Odontologia. Professor Substituto da Área de Diagnóstico Bucal da Faculdade de Odontologia da UFG.

Eduardo Camelo de Castro

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Professor de Ginecologia e Obstetrícia do Curso de Medicina e do Curso de Pós-Graduação em Reprodução Humana da PUC-Goiás.

Edvaldo de Paula e Silva

Especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular. Professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFG.

Elisa Franco de Assis Costa

Especialista em Clínica Médica e Geriatria e Gerontologia. Mestre em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela UFG. Professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG.

Érika Aparecida da Silveira

Mestre em Epidemiologia pela UFPEL. Doutora em Saúde Pública pela UFMG. Professora da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG. Líder do Grupo de Estudos em Obesidade Grave da UFG.

Fábيا Maria Oliveira Pinho

Especialista em Nefrologia. Doutora em Nefrologia pela USP. Professora do Curso de Medicina da PUC-Goiás.

Fernanda Rodrigues da Rocha Chaul

Especialista em Dermatologia. Médica do Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFG.

Fernanda Tenório Lopes Barbosa

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFG.

Frederico Barra de Moraes

Especialista em Ortopedia e Traumatologia. Mestre em Ciências da Saúde pela UnB. Doutor em Ciências da Saúde pela UFG. Professor do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da UFG.

Gabriela Cunha Fialho Cantarelli Bastos

Especialista em Clínica Médica e Geriatria. Especialista em Docência do Ensino Superior. Professora do Curso de Medicina da

PUC-Goiás. Líder de Grupo Balint.

Gil Eduardo Perini

Especialista em Clínica Médica e Cardiologia. Ex-Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Membro do Corpo Clínico do Hospital do Coração de Goiânia.

Heitor Rosa

Especialista em Gastroenterologia. Doutor pela Faculdade de Medicina da UFG. Professor Emérito da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Emérito da Academia Goiana de Medicina.

Helena Elisa Piazza

Especialista em Clínica Médica. Mestre em Ciências Médicas pela UFSC. Professora de Semiologia do Curso de Medicina da UNISUL.

Hélio Moreira

Especialista em Proctologia. Doutor pela Faculdade de Medicina da UFG. Professor Emérito da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

João Damasceno Porto

Especialista em Gastroenterologia. Mestre em Gastroenterologia pela UFG. Professor Emérito da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Joffre Marcondes de Rezende

Especialista em Gastroenterologia. Professor Emérito da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

José Abel Alcanfor Ximenes

Especialista em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Mestre em Medicina Tropical pela UFG. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

José Reinaldo do Amaral

Especialista em Psiquiatria. Mestre em Psiquiatria pela UFRJ. Professor do Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Marco Antonio Alves Brasil

Especialista em Psiquiatria. Doutor em Psiquiatria pela UFRJ. Professor Titular da Faculdade de Medicina da UFRJ. Psiquiatra do Centro Psiquiátrico Pedro II.

Marco Henrique Chaul

Especialista em Dermatologia. Médico do Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFG.

Maria Auxiliadora Carmo Moreira

Especialista em Pneumologia. Mestre em Pneumologia pela Escola Paulista de Medicina. Doutora em Ciências da Saúde pela UFG. Professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.

Maria do Rosário Ferraz Roberti

Especialista em Hematologia e Hemoterapia. Doutora em Clínica Médica pela USP. Professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Coordenadora da Disciplina de Práticas Integradoras I da Faculdade de Medicina da UFG. Hematologista do Hemocentro de Goiânia.

Marianne de Oliveira Falco

Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral. Mestre e Doutora em Ciências da Saúde pela UFG.

Mauricio Sérgio Brasil Leite

Especialista em Anatomia Patológica e Citologia. Ex-Professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Nádia do Lago Costa

Mestre e Doutora em Ciências da Saúde pela UFG. Professora da Faculdade de Odontologia da UFG.

Nilzio Antonio da Silva

Especialista em Reumatologia. Doutor em Reumatologia pela USP. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG. Membro Honorário da Sociedade de Reumatologia. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Osvaldo Vilela Filho

Especialista em Neurocirurgia. Neurocirurgião do Serviço de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFG. Professor do Curso de Medicina da PUC-Goiás.

Paulo César Brandão Veiga Jardim

Especialista em Cardiologia. Doutor em Ciências pela USP. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Paulo Humberto Siqueira

Especialista em Otorrinolaringologia. Professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFG.

Paulo Sérgio Sucasas da Costa

Especialista em Pediatria. Mestre e Doutor em Pediatria pela USP. Pós-Doutorado pela UBC (Canadá). Professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.

Pedro Jorge Leite Gayoso de Souza

Especialista em Clínica Médica e Terapia Intensiva. Preceptor da Residência Médica do Hospital de Urgência de Goiânia. Membro do Corpo Clínico do Hospital Neurológico de Goiânia.

Rafael Oliveira Ximenes

Especialista em Clínica Médica e Gastroenterologia. Pesquisador do Serviço de Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas da UFG.

Rejane Faria Ribeiro-Rotta

Mestre e Doutora em Diagnóstico Bucal. Professora da Faculdade de Odontologia da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.

Renato Sampaio Tavares

Especialista em Clínica Médica e Hematologia. Mestre em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela UFG. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Pesquisador do Serviço de Hematologia Clínica do Hospital das Clínicas da UFG.

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Especialista em Cardiologia e Cardiopediatria. Mestre e Doutora em Educação pela UFG. Professora do Curso de Medicina da PUC-Goiás. Líder de Grupo Balint.

Roberto Luciano Coimbra

Especialista em Urologia. Membro do Corpo Clínico do Hospital Santa Helena de Goiânia.

Rodrigo Oliveira Ximenes

Especialista em Clínica Médica e Gastroenterologia. Mestre em Ciências da Saúde pela UFG. Médico do Serviço de

Endoscopia Digestiva do Hospital das Clínicas da UFG.

Salvador Rassi

Especialista em Radiologia. Doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Goiana de Medicina.

Sebastião Eurico de Melo-Souza

Especialista em Neurologia. Neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia. Ex-Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Goiana de Medicina.

Siulmara Cristina Galera

Especialista em Clínica Médica e Geriatria. Mestre em Medicina pela UFPR. Doutora em Cirurgia pela UFC. Professora do Curso de Medicina da UNIFOR.

Thiago de Souza Veiga Jardim

Especialista em Cardiologia. Mestre e Doutor em Ciências da Saúde pela UFG. Professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG.

Vardeli Alves de Moraes

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Doutor em Obstetrícia pela UNIFESP. Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.

Yosio Nagato

Especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular. Médico do Hospital Geral do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social de Goiânia. Ex-Professor do Departamento de Técnica Operatória da Faculdade de Medicina da UFG. Membro Titular da Academia Goiana de Medicina.



Atualize-se com o melhor conteúdo da área.

Conheça o **GEN Medicina**, portal elaborado pelo GEN | Grupo Editorial Nacional para prover conteúdo científico atualizado e de alta qualidade por meio de artigos, vídeos, entrevistas, depoimentos, casos clínicos e muito mais.

O professor **Celmo Celeno Porto**, que faz parte do time de renomados colaboradores do portal, formado por especialistas em diversas áreas da Medicina, convida seus leitores para acessar seus artigos em: <http://genmedicina.com.br/author/celmopoporto/>



ROCA



Dedicatória

Ao reler, mais uma vez, o que escrevi nesta página há mais de trinta anos, quando veio à luz a primeira edição do *Exame Clínico*, vejo que minha vida tem uma geografia e uma história entrelaçadas de maneira estreita nos lugares onde vivi e vivo, e onde encontrei as pessoas com quem convivi e convivo. Estes lugares e estas pessoas me possibilitaram ser o que sou e fazer o que faço.

Quero reverenciar a memória das pessoas que já não estão mais entre nós, mas que sempre terão lugar de destaque em minhas recordações: meus pais, *Calil e Lourdes*, que me trouxeram a este mundo e tudo fizeram para que eu estivesse bem preparado para bem viver as oportunidades que surgissem; minha primeira esposa, *Virginia*, companheira dedicada em todos os momentos dos longos anos em que vivemos juntos.

Uma palavra especial quero dirigir à *Indiara*, que trouxe luz e calor primaveris para o outono de minha vida, não só pela sua inesgotável vitalidade, como pela sua refinada inteligência.

Mais uma vez, dedico este livro aos meus filhos, genro e nora – *Arnaldo, Liliana, Godiva, Roberto e Moema* – responsáveis por colocar em minha vida os meus netos e minha bisneta – *Bruna, Camila, Kalil, Artur, Frederico, Eduardo e Maria Fernanda* – que não fazem ideia da dimensão do meu orgulho por eles e de quantas alegrias me proporcionam.

Por fim, dedico este livro aos estudantes e professores que o transformaram em um companheiro para o aprendizado do exame clínico, que é, sem dúvida, a base insubstituível para a medicina de excelência.

Celmo Celeno Porto

Material Suplementar

Este livro conta com o seguinte material suplementar:

- Vídeos de habilidades clínicas
- Roteiros pedagógicos com listas de verificação para exames clínicos
- Ilustrações da obra em formato de apresentação (restrito a docentes)
- Código de ética do estudante de Medicina
- Fundamentos etimológicos da linguagem médica
- Glossário de termos e expressões populares de interesse médico.

O acesso ao material suplementar é gratuito. Basta que o leitor se cadastre em nosso *site* (www.grupogen.com.br), faça seu *login* e clique em GEN-IO, no *menu* superior do lado direito. Em seguida, clique no *menu* retrátil () e insira o PIN de acesso localizado na primeira capa interna deste livro.

É rápido e fácil! Caso haja alguma mudança no sistema ou dificuldade de acesso, entre em contato conosco (sac@grupogen.com.br).

Atenção! Não aceitaremos devolução caso a etiqueta esteja raspada.



GEN-IO (GEN | Informação Online) é o ambiente virtual de aprendizagem do GEN | Grupo Editorial Nacional, maior conglomerado brasileiro de editoras do ramo científico-técnico-profissional, composto por Guanabara Koogan, Santos, Roca, AC Farmacêutica, Forense, Método, Atlas, LTC, E.P.U. e Forense Universitária.

Os materiais suplementares ficam disponíveis para acesso durante a vigência das edições atuais dos livros a que eles correspondem.

Prefácios

Oitava edição

Medicina de excelência

Só é possível exercer medicina de excelência se o exame clínico for excelente! A razão desta premissa é simples: somente quem examina bem um paciente aventa hipóteses diagnósticas consistentes, escolhe os exames complementares necessários e os interpreta corretamente. Além disso, estabelece as bases de uma boa relação médico-paciente, coloca em prática os princípios bioéticos e transforma em ações concretas as qualidades humanas, indispensáveis para o exercício da medicina e das demais profissões da área da saúde.

O grande desafio continua sendo conciliar os avanços tecnológicos com o método clínico. É preciso saber que um não substitui o outro; em vez disso, ambos se completam para atingir a máxima eficiência na difícil tarefa de cuidar de pacientes.

A aprendizagem do método clínico pode ser adquirida de diversas maneiras e utilizando-se diferentes técnicas didáticas; desde que haja condições adequadas para o ensino, pode-se chegar aos mesmos resultados. O essencial continua sendo o contato direto com os pacientes, a única maneira de se alcançar o verdadeiro aprendizado das profissões da saúde. Para isso, um manual que sistematize o exame clínico dos pacientes pode ser muito útil para professores e estudantes.

Ao preparar a 8ª edição do *Exame Clínico*, procuramos atualizar os conhecimentos indispensáveis sobre o método clínico, acrescentando alguns aspectos sugeridos por estudantes e professores que utilizaram o livro em seus cursos.

Ampliamos e reorganizamos os Roteiros, agora denominados *Roteiros pedagógicos*, para que o objetivo de auxiliar o estudante a sistematizar as várias etapas do exame clínico fique mais claro. Vale ressaltar que todos os Roteiros estão disponíveis *on-line* e podem ser baixados gratuitamente. O conjunto dos Roteiros pode ser usado como um caderno de exercícios, o que o transforma em uma excelente estratégia didática para a aprendizagem do método clínico.

Mais uma vez, desejo expressar minha gratidão aos professores que participaram do *Exame Clínico*, tanto aos que colaboram desde a 1ª edição quanto aos que iniciaram em edições posteriores, contribuindo para o sucesso da obra entre os professores e estudantes dos cursos da área da saúde.

Um agradecimento especial à equipe liderada por Juliana Affonso, que não poupa esforços para oferecer o mais alto padrão aos livros da área da saúde do Grupo GEN, tornando a leitura fácil e agradável.

Celmo Celso Porto
Goiânia, janeiro de 2017

Sétima edição

Tornar-se médico

A participação do exame clínico no processo de “tornar-se médico” é decisiva. O encontro com cada paciente durante o aprendizado do método clínico é o único caminho seguro para se ver, compreender e aprender a essência da Medicina, na qual se reúnem, além dos conhecimentos sobre os sinais e sintomas das doenças, os princípios éticos e os da relação médico-paciente.

Mas, afinal, o que significa *tornar-se médico*? Ninguém se torna médico no momento em que se recebe o diploma na festa de formatura nem quando faz o seu registro no Conselho Regional de Medicina. A colação de grau é apenas uma solenidade que simboliza a conclusão do curso. Portanto, não é nessa cerimônia que, em um passe de mágica, se faz a transformação de um estudante em médico. A festa de formatura é uma comemoração em que os familiares e amigos compartilham a alegria do formando que conclui uma importante etapa da vida. No Conselho Regional de Medicina, adquire-se o direito legal de se exercer a profissão; contudo, não é em nenhum desses momentos que alguém se torna médico de verdade.

Tornar-se médico é um processo longo e complexo, que talvez tenha início quando se decide estudar Medicina ou, algumas vezes, até antes, mas que tem um marco mais evidente quando da aprovação no vestibular.

Os primeiros encontros com pacientes são cruciais para a formação profissional, e isso tem ocorrido cada vez mais precocemente. *Aliás, seria bom que a primeira aula fosse realizada com um paciente, e não com um cadáver.* Sem dúvida, os primeiros contatos com pacientes são decisivos. É a hora da verdade! Nestes encontros, o estudante percebe se tem ou não vocação para esta profissão. Em outras palavras, as reações diante de uma pessoa doente, fragilizada, em sofrimento, esperançosa ou desiludida, são a prova de fogo para o desejo de ser médico.

Isso não significa que tudo se esclareça nos primeiros encontros com pacientes. Aliás, nesse ponto, pode até mesmo surgir a incômoda pergunta: *é isso mesmo que eu quero?* Não há respostas prontas para esse tipo de questionamento. O processo de “tornar-se médico” é lento e, por vezes, penoso. Além disso, é uma somatória de pensamentos, reflexões, decisões, ações, dúvidas e perguntas – algumas com respostas, outras não.

Uma coisa é certa: o processo de tornar-se médico exige profundas modificações no âmbito interior e exterior, e nem sempre é fácil aceitá-las. Quem poderá ajudar nessa transição? A família? Sim, o apoio dos familiares é importante para renovar energias que podem chegar à exaustão. Os colegas? Bons colegas estimulam o estudo e ajudam no crescimento emocional. Os professores? Muitos farão isso, outros não. Alguns professores, inclusive, podem exercer influência negativa em razão de eles próprios não terem alcançado sucesso no processo de tornar-se médico. Conheci e convivi com médicos e professores que nunca conquistaram a postura de verdadeiros médicos; adquiriram o direito legal de exercer a profissão médica e a docência, mas em um patamar em que jamais puderam ajudar seus alunos a se tornarem bons médicos. Não era competência técnica que lhes faltava; ao contrário, alguns deles eram exímios especialistas em determinadas áreas. O que estes não conseguiram foi impor *alma* à carreira médica, incorporando os *valores e as atitudes que caracterizam um verdadeiro médico*. Sabiam prescrever medicamentos e fazer intervenções, porém, não tinham, por exemplo, o indispensável respeito pelos pacientes. Não sabiam reconhecer a fragilidade deles ou até tiravam proveito disso, como se não estivessem tratando de seres humanos com alma, emoções, família, medos e necessidades. Pessoas que, na ânsia de curar-se, elegeram esses médicos para lhes dar conforto. Como “professores” com esta mentalidade poderiam ajudar os estudantes sob sua responsabilidade a se tornarem médicos na acepção mais nobre da palavra? Simplesmente, impossível. Se um dia reconhecer, entre seus professores, esse tipo de médico, fuja dele!

Por fim, não se deve esquecer, nem um minuto sequer, de que adquirir informações, aprender manobras e dominar técnicas não são ações suficientes para “tornar-se médico”. É necessário algo mais, aquilo que de fato faz a diferença entre uma profissão da área de saúde e todas as outras: a *relação profissional-paciente honesta, dedicada respeitosa*.

O que há de novo na sétima edição

Para continuar a merecer a preferência dos estudantes de Medicina e de outros cursos da área de saúde que utilizam esta obra como apoio para aprender a examinar pacientes, a sétima edição de *Exame Clínico* foi completa e minuciosamente renovada e aprimorada. O projeto gráfico conferiu à obra uma aparência moderna e promoveu modificações que visaram a torná-la agradável de ser manuseada. Todos os desenhos, sem exceção, foram refeitos. Quanto ao conteúdo, além de terem sido adicionados novos capítulos, uma rigorosa atualização de todos os outros foi realizada, sempre em busca do que é essencial para uma medicina de excelência.

Mais uma vez, agradeço aos professores que colaboram desde a primeira edição e aos que entraram para o grupo mais recentemente, com a mesma dedicação e competência. Agradeço também aos meus editores, Aluisio Affonso e Juliana Affonso, e a toda a equipe da Guanabara Koogan, responsável por esta edição tão diferente das anteriores.

Celmo Celso Porto
celeno@cardiol.br
Goiânia, 2012

Sexta edição

O *Exame Clínico*, manual que se destina a dar aos estudantes as *Bases para a Prática Médica*, sem as quais não é possível uma medicina de excelência, por mais máquinas de que se disponha, precisa estar sempre atualizado, não só no que diz respeito à semiotécnica, mas também em tudo que permita acompanhar a renovação que está ocorrendo nas maneiras de ensiná-lo, principalmente tendo em conta as mais recentes metodologias, ativas e interativas, seja o PBL e a problematização de condições clínicas, seja a utilização de técnicas didáticas que estão renovando o ensino tradicional, tais como Laboratório de Habilidades e outros recursos. Para o sucesso de qualquer uma dessas propostas pedagógicas é indispensável um “manual” que contenha o

essencial para o ensino/aprendizagem do método clínico, organizado de maneira simples e objetiva e que deixa espaço para a introdução das peculiaridades de cada uma delas.

Para isso, a 6ª edição do *Exame Clínico* passou por uma rigorosa análise crítica, sem alterar a linha de pensamento seguida desde a 1ª edição, publicada há quase 30 anos, quando afirmamos que “nada pode entrar no lugar do exame clínico, quando se quer exercer uma medicina de excelência, por ser ele insubstituível em três condições: 1) para formular hipóteses diagnósticas; 2) para estabelecer uma boa relação médico–paciente; e 3) para a tomada de decisões. Apoiado nestas premissas é possível tirar o máximo proveito dos avanços científicos em todas as áreas do conhecimento humano para aplicá-los na tarefa de cuidar de pacientes”.

Além disso, é no exame clínico, momento em que médico e paciente estão juntos e comprometidos um com o outro, que se pode encontrar o elo de ligação entre a ciência (médica) e a arte (médica), o que poderia ser sintetizado na expressão “Arte Clínica”, que é a capacidade de levar para cada paciente a ciência médica, metaforicamente representada pela seguinte equação: $AC = E [MBE + (MBV)^2]$. O componente principal é a *Ética* (E), pois é ela que dá o verdadeiro sentido a qualquer ato médico e a tudo que se possa fazer com o paciente, seja qual for a ação executada. A *Medicina Baseada em Evidências* (MBE) ocupa um lugar na equação porque, quando se lança mão de técnicas estatísticas adequadas, pode-se encontrar o que há de mais útil na crescente avalanche de informações e “novidades” diagnósticas e terapêuticas. Contudo, o componente mais destacado da equação, por isso elevado ao quadrado, aparece na equação com a denominação *Medicina Baseada em Vivências* (MBV), entendida como fenômeno existencial, absolutamente pessoal, intransferível, não mensurável, associado tanto à racionalidade como às emoções, que inclui aspectos éticos, legais e socioculturais, cujo aprendizado só é possível vivenciando com pacientes o processo saúde–doença, ou seja, um com o outro (eu–tu). Tudo isso está no âmago de um exame clínico bem-feito, única oportunidade para colocar em prática qualidades como integridade, respeito e compaixão pelo paciente. Mais do que isso: naquele momento passa para o primeiro plano a condição humana do paciente, em suas singularidade e individualidade.

Desejamos expressar nossa gratidão a todos os que participaram da revisão desta 6ª edição, permanecendo fiéis ao “espírito do livro”, nascido do contato direto com os alunos, que muito influíram na sua forma final. Agradecemos sensibilizados as manifestações de aprovação de professores e estudantes de medicina e de outras profissões da área de saúde, que representam o maior estímulo para cuidarmos deste livro com o maior carinho e atenção.

Celmo Celeno Porto
Goiânia, janeiro de 2008

Quinta edição

Arte clínica é levar para cada paciente a ciência médica

A medicina nasceu associada a rituais mágicos e místicos que os povos mais primitivos usavam para cuidar de seus doentes.

A observação empírica do que estava acontecendo com a pessoa doente é a raiz mais profunda do exame clínico. Todavia, o momento mais significativo na evolução do método clínico foi representado por Hipócrates e seus discípulos da Escola de Kós, quando passaram a considerar as doenças como fenômenos naturais e sistematizaram o exame dos pacientes.

Pode-se dizer que aí nasceu a Arte Clínica, que, ao longo dos séculos, foi recebendo as mais diversas contribuições, representadas por conhecimentos mais exatos sobre o corpo humano e as lesões dos órgãos, por novas manobras semióticas, pela invenção de aparelhos e máquinas cada vez mais sofisticados. Ao mesmo tempo que os exames complementares foram sendo incluídos na prática médica, ficou claramente comprovado que nada pode substituir o exame clínico por ser ele o único método que nos permite ver o paciente em sua totalidade.

Para sintetizar o momento em que se encontra a Arte Clínica, inspirado na tendência atual de transformar todas as atividades humanas em números e fórmulas, propusemos a seguinte equação para a Arte Clínica (AC).

$$AC = E [MBE + (MBV)^2]$$

O componente principal da equação é a *Ética* (E), pois é ela que dá o verdadeiro sentido ao ato médico, partindo da premissa de que a medicina é uma profissão que deve estar a serviço do bem-estar humano e da coletividade.

A *Medicina Baseada em Evidências* (MBE), surgida na década de 90 como fruto da epidemiologia clínica, ocupa um lugar na equação porque fornece informações úteis para estudar a evolução da maior parte das doenças, a utilidade de exames complementares e de alguns tratamentos, mas não é seu componente mais importante.

Como elemento mais destacado, que decide inclusive o resultado final da equação, aparece o que denominamos *Medicina Baseada em Vivências* (MBV), resultante do convívio direto com pacientes e que inclui diversos componentes, entre os quais

destacam-se qualidades humanas, bom senso, capacidade de comunicação e de fazer julgamentos do que é útil para cada paciente (tirocínio profissional) e sensibilidade para ver a pessoa em sua individualidade e em sua totalidade. Tendo em conta que este componente (MBV) é o marcador de qualidade da Arte Clínica, vale dizer, da prática médica, consideramos que deve ser elevado ao quadrado.

Isto posto, como definir o papel do Exame Clínico? A nosso ver ele faz parte de todos os componentes da equação. Senão vejamos: a Ética é um conjunto de princípios e normas que para serem aplicados precisam ser transformados em Códigos, Leis e Resoluções, que vão estar presentes desde o momento inicial do Exame Clínico, ou seja, quando estamos fazendo a identificação de uma pessoa que temos diante de nós na condição de paciente, e permanece em todos os atos executados pelo médico, seja para fins diagnósticos ou terapêuticos. Isto porque todo ato médico tem um componente técnico e implicação ética.

A Medicina Baseada em Evidências (MBE), apoiando-se em técnicas estatísticas, formula propostas e sugere condutas (Consensos e Diretrizes) a partir de dados obtidos durante o Exame Clínico. (Mesmo quando as informações originam-se em exames complementares, o Exame Clínico continua sendo peça fundamental do trabalho do médico.)

O Exame Clínico está na essência da Medicina Baseada em Vivências (MBV) porque seu núcleo de luz é representado pela relação do médico com o seu paciente. Só adquire vivência clínica quem trabalha com os doentes e seus familiares, reconhecendo que acima de tudo e em primeiro lugar está a condição humana do paciente. Mais do que isto, significa ter capacidade de transformar dados estatísticos, fluxogramas, árvores de decisão, informações e conhecimentos de diferentes áreas – não apenas da área biológica, mas também das ciências sociais e humanas – em ações concretas e específicas para cada paciente.

Por fim, o Exame Clínico permite reconhecer que as doenças podem ser semelhantes, mas os doentes nunca são exatamente iguais.

Desejamos dizer que, ao prepararmos a 5ª edição do Exame Clínico, continuamos fiéis aos objetivos propostos desde o nascimento do livro, ou seja, fornecer aos estudantes de medicina, de maneira simples e objetiva, os elementos que constituem as bases para a prática médica.

Celmo Celso Porto
Goiânia, janeiro de 2004

Quarta edição

Carta aos estudantes de medicina

Prezado estudante,

Em primeiro lugar, quero lhe dizer que você está iniciando uma nova fase de sua vida e não apenas uma nova etapa do Curso Médico. A grande diferença é que, de agora em diante, talvez hoje à tarde ou amanhã de manhã, você estará sentado ao lado do leito de um paciente, fazendo a primeira ou uma das primeiras histórias clínicas de sua vida. Antes de mais nada, volte-se para o fundo de sua mente e de seu coração e veja se é capaz de responder às seguintes perguntas: *Você está no lugar certo? É esta a profissão que realmente deseja exercer?* Se você não puder respondê-las de imediato, reflita um pouco; talvez você só poderá fazê-lo com segurança à medida que for se relacionando com os seus pacientes.

Agora, vá à luta, ou seja, vá entrevistar um paciente! Um momento: não se esqueça de verificar se você está vestido adequadamente, se seus sapatos estão limpos, se seus cabelos estão bem penteados; veja, enfim, se você está dignamente preparado para sentar-se ao lado de um paciente. Preste muita atenção na linguagem que vai usar – ela deve ser correta, simples, clara, e nenhuma palavra que sair de sua boca deve ser capaz de trazer ansiedade ou criar dúvidas na cabeça de seu paciente. Não sei se, neste momento, você deve ter um leve sorriso ou se seu semblante deve permanecer sério. Isso vai depender das condições de seu paciente. De qualquer maneira, procure transmitir serenidade e segurança em suas palavras, gestos e atitudes. Sei que você está inseguro, nervoso, indeciso com relação à semiotécnica. Isso é normal. O importante é saber, desde o início, colocar acima de tudo a condição humana do paciente. Isso não é uma questão técnica. Depende de sua maneira de ver as pessoas.

Nada substitui o que se assimila no contato direto com o paciente. Leituras, palestras, computador, recursos audiovisuais servem apenas para facilitar e compreender o que se passa junto ao paciente. Por isso, a prática médica é trabalhosa e exige o cultivo de qualidades humanas que não se confundem com habilidades psicomotoras ou técnicas.

As qualidades humanas fundamentais na relação médico/paciente são: *integridade*, que é a disposição para agir de forma correta, seja o paciente quem for; *respeito*, que significa a capacidade de aceitar a condição humana do paciente, sabendo que ele se torna mais frágil e mais sensível pela própria doença; e *compaixão*, representada por interesse verdadeiro pelo sofrimento

do paciente.

Permita-me, então, sugerir-lhe algumas posturas que podem ser de utilidade para o resto de sua vida como médico.

A primeira é: assuma *individualmente* o exame clínico do paciente. É você e ele. Faça dele seu paciente. Não divida estes momentos com nenhum colega. De minha parte, não tenho dúvida de que o aprendizado do exame clínico exige que o trabalho seja feito individualmente, tal como faço em meu consultório. Sei que foi interessante e proveitoso trabalhar em dupla ou em grupo em outras etapas do curso – nas salas de anatomia, nos laboratórios de bioquímica, nas salas de patologia –, mas, agora, tem que ser apenas você e seu paciente. Somente assim haverá condições para você compreender e aprender as experiências e as vivências que constituem o que denominamos *relação médico-paciente*. É bom que você tenha consciência de que duas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo: o aprendizado semiotécnico e o da relação médico/paciente. O primeiro é fácil de sistematizar, mas não é suficiente para a prática médica. Tomar uma decisão clínica não é o mesmo que dar um laudo de um exame complementar. A *pessoa* do paciente como um todo vai pesar muito neste momento.

Ao fazer o exame clínico, preste atenção em você, no paciente e em algum membro da família que estiver participando. É necessário, também, que você perceba de imediato que a anamnese não se limita a uma série de perguntas que você vai fazendo e que o paciente vai tentando responder. Quem pensa que anamnese é isso nunca vai conseguir ser um clínico! Muitos fenômenos estão acontecendo em sua mente e na do paciente. A obrigação é sua de reconhecê-los, sabendo que incluem, inevitavelmente, seu mundo afetivo e o do paciente. Não pense que você vai conseguir ficar absolutamente neutro, distante, imperturbável. Aliás, se isso acontecer, é conveniente você se perguntar de novo: *Escolhi a profissão certa para mim?* Mesmo que deseje ser assim, mais cedo ou mais tarde descobrirá que você não é um técnico consertando um robô. (De acordo com as leis da robótica, no futuro os robôs serão consertados por robôs. Em contrapartida, os pacientes continuarão sendo cuidados pelos médicos.)

A segunda sugestão que lhe faço é estabelecer *cumplicidade* com seu paciente. Isso quer dizer muita coisa, mas vou resumir tudo em poucas palavras. Como você ainda não sabe diagnosticar e não pode receitar qualquer medicamento ou realizar qualquer procedimento, não pense que sua presença e seu trabalho nada significam para ele. Torne-se cúmplice do paciente para que ele possa receber os melhores cuidados possíveis. Não perca esta oportunidade para aprender desde logo que mais importante que diagnosticar, receitar ou operar é *cuidar* do paciente. E isso você pode fazer até melhor do que o Residente ou o Professor que é especialista na doença do seu paciente. Saiba desde agora o segredo dos médicos de sucesso: eles cuidam dos seus pacientes!

Outra sugestão é que haja *continuidade* em sua relação com o paciente. Isso significa que cada paciente que você entrevistar deve receber seus cuidados – que seja uma rápida visita diariamente – até que receba alta ou – infelizmente, isso vai acontecer – até seus momentos finais, se ele morrer. Aliás, não posso deixar de lhe dizer algumas palavras sobre a morte. Talvez, poucos queiram tocar neste assunto durante seu curso de medicina. A verdade é que muitos de nossos pacientes apresentam doenças incuráveis, algumas fatais em curto prazo, e você tem que se preparar para essa eventualidade. A afirmativa de que cuidar dos pacientes é o que há de mais importante na profissão médica poderá ser comprovada com muita nitidez (e com algum sofrimento) ao lado de um paciente em fase terminal. O que você deve fazer em tais circunstâncias? Isso não posso resumir em poucas palavras. Descubra você mesmo. Mas, de uma coisa eu sei: esta é a hora em que o lado humano da Medicina ocupa todo o tempo e o espaço que se vai dedicar ao paciente. Aqui o valor da semiotécnica é zero. Então, o que vai valer? Seria uma palavra de conforto? Um gesto de apoio? Ou apenas uma presença silenciosa?

Falei de *individualidade*, *cumplicidade* e *continuidade*. Mas, não poderia esquecer de tocar em outra questão: *privacidade*. Ou seja, você e o paciente em uma sala tal como o médico em seu consultório. Sei que isso é quase impossível nas condições atuais, pois os hospitais universitários continuam apegados ao ultrapassado sistema de alojamentos coletivos. Mas, se você descobrir uma sala vazia perto da enfermaria de seu paciente, leve-o para lá, para criar privacidade, e aí você vai descobrir que a relação médico/paciente atinge níveis mais profundos, tal como você sempre pensou que deveria ser. Não sendo possível fazer isso, procure criar um clima de privacidade mesmo que haja na enfermaria vários pacientes, outros estudantes, enfermeiras e médicos. Mas, às vezes, o melhor a fazer é voltar em outra hora!

Não quero me alongar muito, pois sei de sua ansiedade para começar a fazer seu aprendizado clínico. Permita-me terminar, fazendo-lhe uma proposta: veja com seriedade o lado técnico do exame clínico e o execute com o máximo de rigor e eficiência, mas descubra nele – tanto na anamnese quanto no exame físico – as oportunidades para desenvolver sua capacidade de se relacionar com os pacientes. Vale dizer, saiba identificar desde o primeiro paciente os fenômenos da relação médico/paciente. Assim fazendo, você poderá perceber os primeiros elos de ligação entre a ciência (médica) e a arte (médica). Aí, então, você verá descortinar-se diante de si o lado mais belo da Medicina.

Uma palavra sobre esta 4ª edição do *Exame Clínico*. Como você verá, continuamos no esforço de encontrar as bases da prática médica atual, ou seja, o núcleo de conhecimentos e técnicas que permitem examinar bem um paciente e compreendê-lo em sua totalidade, sempre em linguagem clara, simples e objetiva. O livro foi inteiramente revisto, muitas ilustrações foram substituídas, mas a maior novidade é a ênfase no paciente idoso com quem você conviverá todo dia ao fazer sua iniciação

clínica.

Um abraço e votos de uma bela carreira médica.

Celmo Celso Porto
Goiânia, janeiro de 2000

Terceira edição

O lugar do exame clínico na medicina moderna

Nos últimos anos, o grande progresso da tecnologia tem provocado várias perguntas. A mais inquietante delas é: *será que a memória de um computador carregada com todas as informações contidas nos tratados de medicina e ciências afins não seria capaz de substituir, até com vantagens, o trabalho que os médicos fazem com apoio no exame clínico?*

Colocada nestes termos, a indagação já estabelece uma disputa entre o método clínico e a tecnologia médica, como se houvesse antagonismo entre ambos. Por isso, antes de mais nada, é preciso recusar este confronto. Ele é falso. Não há conflito entre a medicina clínica e a tecnológica. São coisas diferentes. Uma pode completar a outra, mas nenhuma pode substituir a outra. Cada uma tem seu lugar, mas, a meu ver, o exame clínico tem um papel especial em três pontos cruciais da prática médica: *para formular hipóteses diagnósticas, para estabelecer uma boa relação médico/paciente e para a tomada de decisões.*

O médico que levanta hipóteses diagnósticas consistentes é o que escolhe com mais acerto os exames complementares. Ele sabe o que rende mais para cada caso, otimizando a relação custo/benefício, além de interpretar melhor os valores laboratoriais, as imagens e os gráficos construídos pelos aparelhos. Quem faz bons exames clínicos aguça cada vez mais seu espírito crítico e não se esquece de que os laudos de exames complementares são *apenas* resultados de exame e nunca representam uma avaliação global do paciente. Na verdade, correlacionar com precisão os dados clínicos com os exames complementares pode ser considerada a versão moderna do “olho clínico”, segredo do sucesso dos bons médicos, cuja essência é a capacidade de valorizar detalhes sem perder a visão de conjunto.

Bastaria isso para garantir um lugar de destaque para o exame clínico na medicina moderna – ou de qualquer tempo –, mas, no presente momento, precisamos nos empenhar na revalorização da relação médico/paciente, porque, ao menosprezar seu lado humano, a medicina perdeu o que ela tem de melhor. Neste ponto, o exame clínico é insuperável.

A relação médico/paciente nasce e se desenvolve durante o exame clínico, e sua qualidade depende do tempo e da atenção que dedicamos à anamnese, trabalho que nenhum aparelho consegue realizar com a mesma eficiência que nos dá a entrevista. Aliás, os pacientes têm notado que, quando se interpõe entre eles e o médico uma máquina, o médico se deslumbra com ela e se esquece deles. Transfere para a máquina os cuidados e o carinho que antes eram dedicados ao doente. Sem dúvida, a qualidade do trabalho do médico depende de muitos fatores, mas a relação médico/paciente continua sendo um ponto fundamental.

Decisão diagnóstica não é o resultado de um ou de alguns exames complementares, por mais sofisticados que sejam, tampouco o simples somatório dos gráficos, imagens ou valores de substâncias existentes no organismo. É um processo muito mais complexo porque utiliza todos esses elementos mas não se resume a eles. Numa decisão diagnóstica, bem como no planejamento terapêutico, precisamos levar em conta outros fatores, nem sempre aparentes ou quantificáveis, relacionados ao paciente como um todo, principalmente se soubermos colocar acima de tudo sua condição de pessoa humana. Aí, também, o exame clínico continua insuperável. Somente ele tem flexibilidade e abrangência suficientes para encontrar as chaves que individualizam – personalizam, melhor dizendo – cada diagnóstico que fizermos. *A doença pode ser a mesma, mas os doentes nunca são exatamente iguais.* Sempre existem particularidades advindas das características antropológicas, étnicas, psicológicas, culturais, sócio-econômicas e até ambientais.

O avanço da tecnologia parece que obrigou o médico a transferir para os aparelhos ou para os técnicos que os manuseiam o poder decisório. A experiência está mostrando que isso não foi bom para a prática médica. É necessário, portanto, recuperar o poder de decisão, e a única maneira de conseguir isso é recolocando o exame clínico como base de nosso trabalho.

Por fim, merece registro o movimento de revalorização do *médico de família*, que vem crescendo no mundo inteiro, por ser considerada a melhor estratégia para estender à população inteira uma boa assistência médica com menor custo e sem perda de qualidade.

Estas considerações permitem-nos dizer que o grande desafio da medicina moderna é conciliar o método clínico com os avanços tecnológicos. Quem compreender este desafio saberá o significado da expressão que vem atravessando os séculos sem perder sua força e sua atualidade: *a medicina é uma ciência e uma arte!* Mais ainda, quem souber incorporar com espírito crítico as maravilhas da tecnologia vai valorizar cada vez mais a parte mais simples e mais nobre de nossa profissão – o exame clínico – e terá encontrado o elo de ligação entre a ciência (médica) e a arte (médica).

Chegar à 3ª edição com várias reimpressões em espaço de tempo relativamente curto é a melhor demonstração de que esta obra atende aos anseios dos professores e estudantes que desejam recolocar o exame clínico em lugar de destaque na medicina moderna.

Celmo Celso Porto
Goiânia, janeiro de 1996

Segunda edição

Quanto maior o avanço da tecnologia médica, mais necessário se torna o método clínico. Paradoxo? Não. A experiência dos médicos com espírito crítico demonstra que quem tira melhor proveito dos métodos complementares são aqueles que mais dominam o método clínico. Escolher os exames adequados, interpretá-los corretamente, saber valorizar ou desprezar achados dúbios ou inesperados são decisões que dependem inteiramente de um amplo conhecimento do paciente, em seus aspectos físicos, psicológicos e até culturais, só possível pelo exame clínico.

Por outro lado, o mesmo progresso tecnológico nos obriga a modernizar continuamente o método clínico, revendo conceitos e eliminando detalhes que vão perdendo o lugar na investigação diagnóstica.

Estas idéias serviram de base para o preparo deste manual em sua primeira edição. Continuam inteiramente válidas para justificar as modificações introduzidas e a inclusão de dois capítulos inéditos, um sobre *Sinais e Sintomas*, e outro sobre o *Exame Psíquico*, escritos com o mesmo espírito que permeia todo o livro – simplicidade e objetividade –, em busca do núcleo de conhecimentos que sirva de apoio aos estudantes de medicina e de áreas afins em sua iniciação clínica.

Celmo Celso Porto
Goiânia, abril de 1992

Primeira edição

Um tema e o seu momento

Um dos aspectos mais acabrunhadores da vitoriosa Medicina do século XX é o fato de ela ter-se tornado tão espetacular quanto cara e tão cara que corra o risco de perder o seu mercado de consumo. A recente campanha desenvolvida nos Estados Unidos pelo Senador Edward Kennedy deixou muito claro que o povo mais rico do mundo não pode pagar o custo da Medicina que lhe é oferecida. Se os norte-americanos não podem, quem pode?

É bem sabido que os médicos ganham hoje menos do que no passado. Mas o custo da assistência nunca foi tão elevado. De onde, então, a distorção? Ao que tudo indica, de dois erros fundamentais, dos quais os médicos têm sido importantes partícipes: o primeiro, o uso, na rotina, dos mesmos recursos tecnológicos usados na pesquisa; segundo, a ignorância de que os recursos da tecnologia são úteis para esclarecer dúvidas suscitadas pela anamnese e pelo exame físico, mas desastrosos quando empregados para substituir a estes procedimentos básicos.

É perfeitamente aceitável que, para abrir uma nova estrada nos domínios do desconhecido, o homem se sirva de complexos e onerosos recursos tecnológicos. No entanto, uma vez aberta a estrada, é de esperar que sua utilização se faça à base de recursos bem mais simples.

Os médicos assim não têm entendido. Depois de nos munirmos de impressionante parafernália para pesquisar um tema, dominado o tema, insistimos em aplicar, na rotina, aos nossos pacientes, os conhecimentos adquiridos utilizando o mesmo poderoso e caro equipamento que nos serviu para o desbravamento inicial.

Embora não se possa negar à investigação ricamente armada de um paciente um grau de precisão elevado, é forçoso reconhecer que jamais poderemos aplicar este tipo de rotina à população em geral. Os automóveis que mais se vendem em um país não são necessariamente os melhores automóveis nele fabricados. São aqueles que, em face da qualidade, mais se aproximam do poder aquisitivo do povo a que são oferecidos.

O retorno ao simples é um imperativo em Medicina. Mas, para usar o simples sem perda apreciável de eficiência, é preciso contar com bons profissionais. Só a um bom navegador a bússola leva porto seguro. O bom médico é aquele que usa, na rotina, processos simples, mas enriquecidos em sua capacidade de informar pela solidez de seus conhecimentos. Na formação desses conhecimentos, a tecnologia pode e deve ser utilizada em sua maior dimensão. Entretanto, em sua aplicação, a tecnologia só figurará na razão inversa da excelência do aprendizado.

A situação é comparável à busca de objetos numa casa às escuras. Se a casa nos for desconhecida, pouco ou nada conseguiremos, e os riscos serão altos. No entanto, se acendermos as luzes e estudarmos cuidadosamente onde estão as portas, os corredores, os móveis e os objetos neles guardados, poderemos, sem luzes, encontrar o que quisermos. A iluminação é a tecnologia que usamos na formação do conhecimento. O sucesso da caminhada no escuro é o emprego eficiente do conhecimento adquirido.

A única forma de podermos oferecer um padrão satisfatório de assistência médica a todo o povo brasileiro, por um preço compatível com sua capacidade de comprá-la, é o emprego bem orientado das técnicas da anamnese e do exame físico, complementadas por recursos tecnológicos tão simples quanto possível. Observações bem documentadas têm demonstrado que, quanto mais hábil é o médico na tomada da anamnese e na feitura do exame físico, menor é o número de exames complementares de que ele necessita para chegar ao diagnóstico com um mesmo grau de certeza.

Infelizmente, a atenção dada à anamnese e ao exame físico perdeu muito terreno nas últimas décadas, tamanho o fascínio que os recursos tecnológicos puseram diante dos olhos dos médicos. A legislação previdenciária, que rege o trabalho de mais de 90% da população médica brasileira, pouco reconhecimento dá, em suas tabelas de valores, ao tempo despendido durante a anamnese e o exame físico do paciente. A ínfima remuneração atribuída a essas atividades estimula o médico a tentar substituí-las por investigações instrumentais. O erro assim cometido é tanto mais grave quanto se sabe que cerca de dois terços dos indivíduos que procuram assistência médica não possuem patologia orgânica. São ansiosos, angustiados, em busca de esclarecimento e reafirmação. A única maneira de fazer o diagnóstico correto desses pacientes e de, eventualmente, libertá-los dos problemas que os afligem é através de uma boa anamnese e de um bom exame físico. Não cumprindo essas etapas com adequação, o médico transforma em pacientes orgânicos todos os que batem à sua porta. Com isso o atendimento se torna caro e prejudicial. Caro pelo elevado custo dos exames inutilmente solicitados e pelo absenteísmo ao trabalho a que sua feitura obriga o paciente. Prejudicial porque o doente que sem patologia orgânica é tratado como tal tende a agravar sua ansiedade, podendo, algum tempo após, vir a realmente apresentar a patologia que não tinha mas que lhe foi inculcada.

O livro do Prof. Celmo Celeno Porto e de seus colaboradores é uma contribuição positiva a um esforço que se impõe: o de recompor a hierarquia da anamnese e do exame físico junto aos estudantes e aos profissionais da Medicina. Esta necessidade, de cunho internacional, possui cores ainda mais dramáticas em nossa terra. Sem essas duas etapas fundamentais, as conquistas tecnológicas, de que tanto nos orgulhamos, não conseguirão levar-nos ao sucesso que buscamos. E o que é talvez mais importante: não conseguiremos oferecer ao nosso povo uma Medicina ao alcance de sua bolsa. E uma Medicina inacessível ao doente, por mais brilhante que seja, é uma Medicina inútil.

Exame Clínico possui como mérito maior, no entender deste analista, a simplicidade, a objetividade e originalidade de sua estruturação, que têm como respaldo a competência dos homens que a conceberam. Dentro do momento médico que vivemos, o lançamento desta obra é extremamente oportuno.

Mario Rigatto

Apresentação da primeira edição

No prefácio deste livro, Mario Rigatto recolocou a posição correta do exame clínico em face dos progressos científicos e tecnológicos, que dotaram a Medicina de recursos extraordinários para o diagnóstico. Disse bem que “o retorno ao simples é um imperativo em Medicina”. Sem menosprezar a significação desses recursos, o certo é que, na maioria dos casos, o diagnóstico e, conseqüentemente, a orientação terapêutica podem advir de rigorosa e hábil colheita de dados, seguida da realização de alguns exames complementares simples e acessíveis. E, mesmo quando necessário o apelo aos métodos mais diferenciados, sua indicação será sempre precedida de exame clínico minucioso.

A “metamorfose da Medicina”, para usar a expressão de Jean Hamburger, não tirou do ato médico, como reconheceu o mestre francês, o seu caráter humano, que continua a repousar no relacionamento médico/paciente. Por isso, o ensino da Semiologia, ou da Iniciação ao Exame Clínico, como se batiza em outros programas, conserva todo o prestígio e a prioridade.

Representando, no curso médico, a aproximação inicial do aluno com o doente, essa etapa do ensino é onerada por dificuldades de ordem técnica e psicológica. Daí a importância de que se reveste o desenvolvimento paralelo de objetivos cognitivos, psicomotores e afetivos. Os conhecimentos são instrumentos essenciais para a compreensão de informações recolhidas da entrevista e dos métodos semiotécnicos, através dos quais o aluno deve adquirir as habilidades necessárias. Esses objetivos se hão de completar pela adoção, desde o início, de atitudes emocionais e éticas adequadas no trato com os doentes.

O programa de ensino da Semiologia deve ser predominantemente prático, conhecendo o normal e procurando confrontá-lo com os achados patológicos. É conveniente integrar a preparação semiótica, incluindo as técnicas elementares ajustadas à indagação de aparelhos e sistemas habitualmente estudados nas clínicas especializadas. Parece-nos essencial, ainda, expor os

alunos, desde logo, às variantes da semiologia pediátrica.

A literatura médica brasileira é rica em textos de Clínica Propedêutica, bastando citar a tradição afortunada do livro de Vieira Romeiro, cuja primeira edição remonta a 1919, a penúltima, ainda em vida do autor, a 1964 e, finalmente, a última, refundida sob a direção de Affonso Berardinelli Tarantino, a 1980.

Surge, agora, o livro do Prof. Celmo Celeno Porto e colaboradores, todos docentes da Faculdade de Medicina da UFG, distinguindo-se por seu objetivo prático e procurando salientar os elementos essenciais do método clínico, como base indispensável para a atuação médica. Foram, propositadamente, eliminadas referências a minúcias semióticas e a procedimentos ou técnicas de menor relevância, que perderam o lugar na prática médica atual e desviam a atenção do aluno do que é essencial. Acredita o autor principal que a recuperação do prestígio do método clínico, principal elemento do tripé formado pela clínica, radiologia e laboratório, depende de sua simplificação. Por outro lado, observa-se o propósito de estabelecer conotações entre os dados clínicos e as alterações anátomo-patológicas, valorizando o método anátomo-clínico, de tradicional significação. Não faltou, ainda, a esquematização das principais síndromes, relativas a cada um dos capítulos da Semiótica especializada.

Nota-se o esforço para dar unidade ao tratamento dos vários temas, o que se obteve graças à experiência dos autores, treinados no ensino da Semiologia no curso da Faculdade a que pertencem. É, sem dúvida, um livro útil e oportuno, que muito recomenda a capacidade e diligência do editor e seus colaboradores.

Clementino Fraga Filho
Rio de Janeiro, abril de 1980

Sumário

1 Iniciação ao Exame Clínico

Celmo Celso Porto, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco, Fábila Maria Oliveira Pinho, Gabriela Cunha Fialho Cantarelli Bastos, Helena Elisa Piazza, Heitor Rosa

Introdução
Evolução do método clínico
Evolução dos exames complementares
O exame clínico e a internet
Medicina | Arte e ciência
Primeiros contatos do estudante de medicina com o paciente
Relação estudante de medicina-paciente do ponto de vista humano e ético,10
Princípios do aprendizado da relação médico-paciente
Exame clínico e relação médico-paciente
Clerkship (aprendizado ao lado do leito)
Diagnóstico, terapêutica e prognóstico

2 Laboratório de Habilidades Clínicas

Fábila Maria Oliveira Pinho, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco, Celmo Celso Porto

Introdução
Infraestrutura para funcionamento do Laboratório de Habilidades
Objetivos do Laboratório de Habilidades
Treinamento da semiótica da anamnese
Treinamento da semiótica do exame físico
Treinamento de procedimentos e técnicas especiais
Laboratório de Habilidades de Comunicação
Laboratório de Habilidades como método de avaliação

3 Método Clínico

Fábila Maria Oliveira Pinho, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco, Denise Viuniski da Nova Cruz, Arnaldo Lemos Porto, Celmo Celso Porto

Introdução
Posições do paciente e do examinador para o exame clínico
Divisão da superfície corporal para o exame clínico
Anamnese
Exame físico
A aula prática e o encontro clínico

4 Anamnese

Celmo Celso Porto, Fábila Maria Oliveira Pinho, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Aspectos gerais

Semiotécnica da anamnese
Anamnese em pediatria
Anamnese em psiquiatria
Anamnese do idoso
Considerações finais
Roteiro pedagógico para anamnese

5 Técnicas Básicas do Exame Físico

Fábia Maria Oliveira Pinho, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco, Arnaldo Lemos Porto, Celmo Celeno Porto

Introdução
Inspeção
Palpação
Percussão
Ausculta
Olfato como recurso de diagnóstico
Ambiente adequado para o exame físico
Instrumentos e aparelhos necessários para o exame físico

6 Sinais e Sintomas

Celmo Celeno Porto, Delson José da Silva, Rejane Faria Ribeiro-Rotta, Nádia do Lago Costa, Diego Antônio Arantes, Danilo Rocha Dias, Fernanda Tenório Lopes Barbosa, Denise Sisteroli Diniz, Gil Eduardo Perini, Osvaldo Vilela Filho, Cláudio Jacinto Pereira Martins, Renato Sampaio Tavares

Introdução
Os sintomas como linguagem dos órgãos
A dor como sintoma padrão
Sintomas gerais
Pele, tecido celular subcutâneo e fâneros
Olhos
Ouvidos
Nariz e cavidades paranasais
Faringe
Laringe
Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras
Diafragma e mediastino
Sistema cardiovascular
Sistema digestivo
Região bucomaxilofacial
Esôfago
Estômago
Intestino delgado
Cólon, reto e ânus
Fígado, vesícula e vias biliares
Pâncreas
Rins e vias urinárias
Órgãos genitais masculinos
Órgãos genitais femininos

Mamas
Sistema hemolinfopoético
Ossos
Articulações
Coluna vertebral
Bursas e tendões
Músculos
Sistema endócrino
Hipotálamo e hipófise
Tireoide
Paratireoides
Suprarrenais
Gônadas
Metabolismo e condições nutricionais
Desnutrição
Sistema nervoso central
Sistema nervoso periférico
Roteiro pedagógico para análise do sintoma dor

7 Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais

Marco Antonio Alves Brasil, José Reinaldo do Amaral, Celmo Celeno Porto

Introdução
Sistematização do exame psíquico
Roteiro pedagógico para o exame psíquico e avaliação das condições emocionais

8 Médicos, Pacientes e Famílias

Celmo Celeno Porto, Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira

Introdução
Médicos
Pacientes
Famílias

9 Exame Clínico do Idoso

Elisa Franco de Assis Costa, Siulmara Cristina Galera, Celmo Celeno Porto, Claudio Henrique Teixeira

Introdução
Anamnese do paciente idoso
Modificações decorrentes do envelhecimento
Avaliação funcional do idoso
Considerações finais
Roteiro pedagógico para exame clínico do idoso e avaliação geriátrica ampla

10 Exame Físico Geral

Fábia Maria Oliveira Pinho, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco, Paulo Sérgio Sucasas da Costa, Érika Aparecida da Silveira, Marianne de Oliveira Falco, Delson José da Silva, Arnaldo Lemos Porto, Celmo Celeno Porto

Introdução
Semiotécnica
Roteiro pedagógico para o exame físico geral

11 Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros

Aiçar Chaul, Fernanda Rodrigues da Rocha Chaul, Marco Henrique Chaul

Pele

Mucosas

Fâneros

Roteiro pedagógico para exame físico da pele

12 Exame dos Linfonodos

Maria do Rosário Ferraz Roberti, Rejane Faria Ribeiro-Rotta, Nádia do Lago Costa, Diego Antônio Arantes, Danilo Rocha Dias, Fernanda Tenório Lopes Barbosa, Celmo Celso Porto

Introdução

Exame dos linfonodos

Semiotécnica

Características semiológicas

Exame do baço

Adenomegalias e esplenomegalia

Roteiro pedagógico para exame dos linfonodos

13 Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso

Celmo Celso Porto, Arnaldo Lemos Porto, Abrahão Afiune Neto, Aguinaldo Figueiredo de Freitas Jr., Edvaldo de Paula e Silva, Yosio Nagato

Introdução

Pulso radial

Pulsos periféricos

Síndrome isquêmica

Pulso capilar

Pulso venoso, turgência ou ingurgitamento jugular

Roteiro pedagógico para exame dos pulsos radial, periféricos e venoso

14 Exame da Pressão Arterial

Arnaldo Lemos Porto, Paulo Cesar Brandão Veiga Jardim, Thiago de Souza Veiga Jardim

Introdução

Histórico

Fatores determinantes da pressão arterial

Regulação da pressão arterial

Determinação da pressão arterial

Problemas mais comuns na medida da pressão arterial

Pressão diferencial

Valores normais da pressão arterial e variações fisiológicas

Hipertensão arterial

Hipotensão arterial

Roteiro pedagógico para avaliação da pressão arterial

15 Exame de Cabeça e Pescoço

Celmo Celso Porto, Alexandre Roberti, Rejane Faria Ribeiro-Rotta, Nádia do Lago Costa, Diego Antônio Arantes, Danilo Rocha Dias, Fernando Tenório Lopes Barbosa, Paulo Humberto Siqueira

Cabeça

Pescoço

Roteiro pedagógico para exame de cabeça e pescoço

Roteiro pedagógico para exame dos olhos, dos ouvidos, do nariz e da garganta

Roteiro pedagógico para diagnóstico diferencial da dor na região bucomaxilofacial

16 Exame do Tórax

Celmo Celso Porto, Arnaldo Lemos Porto, Maria Auxiliadora Carmo Moreira, Aguinaldo Figueiredo de Freitas Jr., Abrahão Afiune Neto, Alexandre Vieira Santos Moraes, Eduardo Camelo de Castro, Mauricio Sérgio Brasil Leite, Salvador Rassi

Introdução

Projeção na parede torácica dos pulmões, do coração, do fígado, do fundo do estômago e do baço

Pontos de referência anatômicos, linhas e regiões torácicas

Exame da pele

Exame das mamas

Principais afecções das mamas

Exame dos pulmões

Síndromes brônquicas e pleuropulmonares

Exame do coração

Exame da aorta

Exame das artérias carótídeas

Roteiro pedagógico para exame físico das mamas

Roteiro pedagógico para exame do coração

Roteiro pedagógico para exame dos brônquios, dos pulmões e das pleuras

17 Exame do Abdome

Celmo Celso Porto, Americo de Oliveira Silverio, Cacilda Pedrosa de Oliveira, Heitor Rosa, Helio Moreira, José Abel Alcanfor Ximenes, Rafael Oliveira Ximenes, Rodrigo Oliveira Ximenes, João Damasceno Porto, Mauricio Sérgio Brasil Leite

Introdução

Pontos de referência anatômicos do abdome

Regiões do abdome

Projeção dos órgãos nas paredes torácica e abdominal

Inspeção

Palpação

Percussão

Ausculta

Exame da região anoperineal e toque retal

Principais síndromes abdominais

Roteiro pedagógico para exame do abdome

18 Exame dos Órgãos Genitais

Roberto Luciano Coimbra, Alexandre Vieira Santos Moraes, Eduardo Camelo de Castro, Vardeli Alves de Moraes

Órgãos genitais masculinos

Órgãos genitais femininos

Roteiro pedagógico para exame físico dos órgãos genitais masculinos

Roteiro pedagógico para exame físico dos órgãos genitais femininos

19 Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades

Celmo Celso Porto, Nilzio Antonio da Silva, Antonio Carlos Ximenes, Frederico Barra de Moraes

Anamnese

Semiotécnica

Ossos

Coluna vertebral

Articulações

Doenças musculoesqueléticas mais frequentes

Extremidades

Roteiro pedagógico para exame físico da coluna vertebral

Roteiro pedagógico para exame físico das articulações dos membros superiores

Roteiro pedagógico para exame físico das articulações dos membros inferiores

Roteiro pedagógico para exame físico das extremidades

20 Exame Neurológico

Sebastião Eurico de Melo-Souza

Introdução

Anamnese

Exame físico

Fala e linguagem

Avaliação do nível de consciência

Minixame do estado mental – MEEM (*minimal state*)

Principais síndromes neurológicas

Roteiro pedagógico para exame neurológico

Roteiro pedagógico para exames dos nervos periféricos

21 Sinais Vitais

Celmo Celso Porto, Pedro Jorge Leite Gayoso de Souza

Introdução

Ritmo e frequência do pulso

Pressão arterial

Ritmo e frequência respiratórios

Temperatura corporal

Oximetria de pulso

Nível de consciência

Roteiro pedagógico para avaliação dos sinais vitais

Bibliografia

Exame Clínico

Capítulo 1



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Iniciação ao Exame Clínico

Celmo Celeno Porto

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Fábia Maria Oliveira Pinho

Gabriela Cunha Fialho Cantarelli Bastos

Helena Elisa Piazza

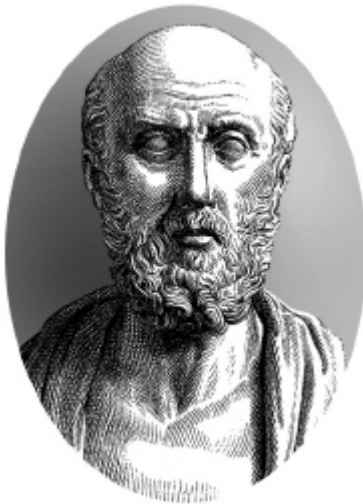
Heitor Rosa

- Introdução
- Evolução do método clínico
- Evolução dos exames complementares
- O exame clínico e a internet
- Medicina | Arte e ciência
- Primeiros contatos do estudante de medicina com o paciente
- Relação estudante de medicina-paciente do ponto de vista humano e ético
- Princípios do aprendizado da relação médico-paciente
- Exame clínico e relação médico-paciente
- *Clerkship* (aprendizado ao lado do leito)
- Diagnóstico, terapêutica e prognóstico

INTRODUÇÃO

A pedra angular da medicina ainda é o exame clínico, e nunca será demais ressaltar sua importância. A experiência tem mostrado que os recursos tecnológicos disponíveis só são aplicados em sua plenitude e com o máximo proveito quando se parte de um exame clínico bem-feito.

Esta profissão tem suas raízes na medicina hipocrática, que data de mais de 2 mil anos, uma vez que foi por intermédio de Hipócrates que a anamnese foi estabelecida na estrutura do exame clínico.



Hipócrates

Por mais paradoxal que possa parecer nesta época de máquinas e aparelhos, deve-se conferir um destaque especial à *anamnese* na iniciação clínica do estudante de medicina.

Os exames complementares, inclusive os executados pelos computadores eletrônicos, que, aos poucos, invadem o campo da medicina, aumentam continuamente as possibilidades de se identificar com precisão e rapidez as modificações orgânicas provocadas por diferentes enfermidades; em contrapartida, à medida que esses recursos se desenvolvem e se tornam mais complicados, passa a ser exigida do médico uma segura orientação clínica para que ele saiba escolher de modo adequado os exames mais úteis para cada caso e possa interpretar, com espírito crítico, os respectivos resultados.

Esta é uma das características da medicina atual que, certamente, irá acentuar-se com o progresso técnico da profissão. Houve uma época em que os exames complementares disponíveis eram tão escassos que o médico não desenvolvia sua capacidade de escolha; na verdade, não havia muito a escolher. Hoje, acontece o contrário: os exames subsidiários à disposição são muitos, e crescem a cada dia. Desse modo, passou a se exigir do médico a capacidade de saber escolher o mais conveniente.

Um exemplo relativamente recente é o da bioquímica do sangue: dispunha-se apenas de poucos exames, como dosagem de ureia, glicose, bilirrubina e mais alguns testes, e chegou-se a estabelecer como rotina a solicitação de “bioquímica do sangue”, sem necessidade de especificar as dosagens que se desejavam. Esse modo de proceder traduzia as limitações do laboratório, que, por sua vez, simplificava o trabalho do médico. Em nossos dias, entretanto, mesmo os laboratórios mais modestos são capazes de realizar centenas de exames bioquímicos, cabendo ao médico decidir-se pelos que lhe serão mais úteis – e, para fazê-lo, seu apoio é o *exame clínico*.

Boxe

Medicina moderna

Sem dúvida, a medicina moderna apoia-se em um tripé formado pelo exame clínico, pelo laboratório e pelos métodos de imagem; porém, o pé principal continua sendo o exame clínico. Talvez, possamos até dizer que o laboratório e os métodos de imagem são o apoio mais forte, mas aquele que confere o equilíbrio à estrutura – e, portanto, o principal – é o exame clínico.

EVOLUÇÃO DO MÉTODO CLÍNICO

Coube a Hipócrates (460 a 356 a.C.) sistematizar o método clínico, conferindo à anamnese e ao exame físico – este basicamente apoiado na inspeção e na palpação – uma estruturação que pouco difere da que se emprega hoje. Em uma visão retrospectiva da evolução do método clínico, os acontecimentos que merecem registro serão descritos a seguir.

O primeiro deles é a medida da temperatura corporal por meio do *termômetro clínico*, proposto por Santório, entre 1561 e 1636, que pode ser considerado o ponto de partida da utilização de aparelhos simples que permitem obter dados de grande valor diagnóstico. No que se refere à temperatura corporal, merece referência também a construção de *curvas térmicas*, tal como se faz atualmente, por Ludwig, em 1852.



Auenbrugger

Em 1761, Auenbrugger publicou o trabalho *Inventum Novum*, no qual sistematizou a percussão do tórax, correlacionando os dados fornecidos por este método aos achados anatomopatológicos, propiciando grande avanço no diagnóstico das doenças pulmonares. A incorporação da percussão à prática médica, contudo, ocorreu apenas após a publicação do livro *Essai sur les Maladies et Lésions du Coeur et des Gros Vaisseaux*, por Corvisart, em 1806.

Em 1761, foi publicado o livro de Morgagni (*De Sedibus et Causis Morborum per Anatomem Indagatis – Sobre os Lugares e Causas das Doenças Investigadas Anatomicamente*), que pode ser considerado a primeira sistematização dos conhecimentos anatomopatológicos nos quais os clínicos se apoiaram para desenvolver o método clínico de modo a fazer diagnósticos com o paciente em vida, correlacionando-os com os achados de necropsia.



Morgagni

Em 1819, Laennec publicou sua obra *De la Auscultation Médiate*, descrevendo o estetoscópio e as principais manifestações estetoacústicas das doenças do coração e dos pulmões. Pouco depois, em 1839, Skoda contribuiu imensamente para o progresso do método clínico, ao correlacionar os dados de exame físico do tórax, principalmente os de percussão e de ausculta, com os achados de necropsia, no trabalho *Abhandlung über Perkussion und Auskultation*.



Skoda

Associando os conhecimentos anatomopatológicos às técnicas do exame físico – inspeção, palpação, percussão e ausculta –, o exame clínico atingiu sua plenitude, e, a partir daí, o diagnóstico das doenças impulsionou, de modo grandioso, o progresso da medicina com reflexos ainda nos dias de hoje.

Em meados do século 19 (1851-1852), Helmholtz e Ruete abriram um novo caminho ao introduzir na prática médica o oftalmoscópio, que é indispensável ao médico, tanto quanto o termômetro, o estetoscópio e o esfigmomanômetro.

Samuel von Basch, em 1880, Riva-Rocci, em 1896, e Korotkoff, em 1905, cada um com diferentes contribuições, possibilitaram a construção de esfigmomanômetros sensíveis e precisos e estabeleceram as bases para a determinação da pressão arterial.

No fim do século 19 e nas primeiras décadas do 20, Freud, ao publicar o livro *Interpretação dos Sonhos*, descortinou o mundo inconsciente, possibilitando a compreensão dos aspectos psicodinâmicos da relação médico-paciente.



Freud

Pode-se dizer que as histórias clínicas registradas por Hipócrates e seus discípulos criaram as bases do exame clínico, ao valorizarem o relato ordenado dos sintomas, dos antecedentes pessoais e familiares e das condições de vida do paciente. Mais de 2 mil anos depois, Freud dá uma relevante contribuição ao desnudar as raízes dos relatos feitos pelos pacientes, descobrindo fenômenos psicológicos de grande importância na relação médico-paciente e reforçando o valor da anamnese na prática médica. A maior contribuição de Freud para os clínicos é o conhecimento da “transferência” e “contratransferência” como base da relação entre o médico (terapeuta) e seu paciente, sendo inclusive fundamental na adesão do paciente ao tratamento.



Balint

Ainda no século 20, Balint, médico e psicanalista húngaro, ampliou a contribuição freudiana, descrevendo, pela primeira vez, uma teoria sobre a relação entre o médico e seu paciente. A publicação de seu livro *O Médico, seu Paciente e a Doença*, em 1957, é um marco no desenvolvimento da medicina e do método clínico. Balint enfatiza o processo de adoecimento, a anamnese menos dirigida e a escuta terapêutica.

EVOLUÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES

Nos primórdios deste campo, encontra-se o nome de Virchow, cuja obra fundamental – *Celular Pathologie* –, publicada em 1858, pode ser considerada o marco inicial da aplicação de exames laboratoriais como parte fundamental do diagnóstico. (O exame usado por Virchow foi o esfregaço sanguíneo para o reconhecimento das afecções hematológicas.)



Virchow

Alguns anos após, entre 1880 e 1890, Pasteur e Koch fizeram suas principais descobertas no campo da bacteriologia, criando a possibilidade de conhecer e isolar os agentes causadores de inúmeras enfermidades. Essas descobertas motivaram o desenvolvimento do diagnóstico etiológico, cada vez mais importante na prática médica, pois foi com base nele que se pôde introduzir tratamentos específicos até então quase inexistentes.

Também merece destaque Salkowski, que, entre 1874 e 1893, publicou o *Manual de Química Fisiológica* que teve grande influência na incorporação de exames laboratoriais na prática médica.



Roentgen

Em 1895, Roentgen descobriu os raios X, sem dúvida a mais importante descoberta até hoje realizada no que se refere a diagnóstico por imagem das enfermidades.

Logo a seguir, entre 1902 e 1906, Einthoven construiu o primeiro eletrocardiógrafo.

Os estudos sobre a radioatividade realizados por Pierre e Marie Curie na virada do século criaram as bases para a aplicação dos radioisótopos na medicina; os aparelhos que captam a radioatividade do iodo radioativo fixado pela tireoide foram colocados em uso, pela primeira vez, em 1940.

A eletroencefalografia humana, criada em 1924 por Hans Berger, representou um marco na propedêutica armada das afecções neurológicas.

O gastroscópio semiflexível de Wolf e Schindler, construído em 1932, teve importante papel no desbravamento da endoscopia profunda, mas foi a descoberta das fibras ópticas que permitiu a Hirschowitz, em 1958, a introdução da fibroendoscopia na prática médica, início de uma verdadeira revolução na investigação diagnóstica e começo de uma nova era terapêutica que evoluiu ainda mais quando foi associada à transmissão e à formação eletrônica de imagens, constituindo a videoendoscopia.

A construção da primeira unidade de processamento eletrônico por von Neuman, entre 1940 e 1950, inaugurou uma nova época no diagnóstico das doenças, pois, com apoio nesta tecnologia, inúmeros aparelhos começaram a ser construídos, com grandes possibilidades diagnósticas.

Após 1950, o progresso tecnológico acelerou e tornou-se impessoal, não sendo mais possível identificar os descobridores de várias técnicas, tais como a *termografia*, a *ultrassonografia*, a *xerografia*, a *tomografia computadorizada* e a *ressonância magnética*, desenvolvidas por equipes anônimas no interior dos laboratórios de pesquisa das grandes indústrias eletrônicas.

Em 1953, Crick e Watson, ao descreverem a estrutura em dupla-hélice do DNA, abriram um novo campo na compreensão das doenças, dando origem à medicina preditiva, cujas possibilidades irão influir decisivamente na prática médica, reforçando ainda mais a importância do exame clínico.

Boxe

O grande desafio atual é conciliar o método clínico com os avanços tecnológicos, retirando do primeiro os pormenores inúteis e superados, sem querer estabelecer confronto entre um e outro. A posição correta consiste em integrar os avanços científicos e tecnológicos com o método clínico, que continua sendo a base da prática médica. Desse modo, a medicina ganha eficiência e não perde seu lado humano.

Boxe

Flexibilidade do método clínico

Uma das características fundamentais do método clínico é sua flexibilidade, ou seja, é possível adaptá-lo às mais diversas situações que ocorrem na assistência à saúde sem que se perca sua capacidade básica: identificar as doenças e conhecer os doentes.

A proposta deste livro é auxiliar no ensino/aprendizagem do método clínico em sua totalidade. Isto porque somente aqueles que o dominam completamente são capazes de fazer as adaptações necessárias para atender as particularidades de todas as profissões da saúde. Tanto pode ser a minuciosa Avaliação Geriátrica Ampla que exige longo tempo, como para o atendimento de um paciente nos serviços de Emergências e Urgências, quando somos obrigados a obter os dados em alguns minutos.

Seja como for não se pode esquecer que um atendimento de boa qualidade sempre depende de um bom exame clínico.

O EXAME CLÍNICO E A INTERNET

O exame clínico vem sofrendo modificações desde sua sistematização por Hipócrates há mais de 2.000 anos, sem perder suas características essenciais. Nas últimas décadas surgiu um fato novo, a internet, cujas possibilidades e consequências sobre o método clínico ainda estão em plena evolução.

Em primeiro lugar, é necessário destacar a facilidade de se obterem informações sobre a saúde e as doenças, tanto pelos médicos como pelos pacientes. Antes, quase tudo que se conhecia sobre o processo saúde-doença ficava em poder dos profissionais da saúde. Apenas uma pequena parte era acessível à população, em publicações ou pelo primeiro veículo de massa que surgiu – o rádio. A televisão ampliou o acesso aos conhecimentos, porém, em ambos os pacientes eram apenas receptores do que se desejasse fazer chegar a eles. A internet modificou radicalmente esta situação. A possibilidade de se obterem informações sobre sintomas, doenças, exames, diagnóstico, prognóstico, medicamentos, cirurgias, ou seja, um imenso volume de dados que está a um clique de todos os que possuam um equipamento capaz de introduzi-lo no mundo virtual.

Na internet os pacientes e familiares encontram informações sobre hospitais, laboratórios clínicos, clínicas de imagem, sociedades médicas e tudo que desejarem saber sobre o médico, incluindo onde se formou, que especialização fez e até seu currículo Lattes...

Hoje, o grande informante sobre saúde e doenças não é o médico ou o farmacêutico, cujo papel não pode ser menosprezado neste contexto. É o “Dr. Google” que está sempre a postos, dia e noite, para responder às mais variadas indagações de qualquer pessoa. Contudo, a grande diferença é: o “Dr. Google” só dá informações genéricas, enquanto o médico faz o “raciocínio clínico” que permite a ele transformar informações em decisão diagnóstica, terapêutica ou prognóstica, específica para cada paciente. Outro momento em que os pacientes procuram o “Dr. Google” é após a consulta para saber mais sobre o diagnóstico e os medicamentos. Isto vai exigir que o médico esteja seguro de tudo que fala ou prescreve.

Tudo isto vem despertando novas situações que vão refletir-se intensamente no campo da saúde, podendo-se citar como exemplos o “paciente *expert*”, as “comunidades virtuais” e as “consultas a distância”.

O “paciente *expert*” pode ser considerado um novo tipo de doente. Ao consultar inúmeros *sites*, fazer indagações e trocar ideias com outros participantes do mundo virtual, ele adquire um volume de conhecimentos que, às vezes, nem um médico especialista possui naquela área. Aí, então, é fácil deduzir o que vai acontecer durante uma consulta. Além de responder às perguntas tradicionais da anamnese, ele fará questionamentos sobre aspectos diagnósticos, realização e resultados de exames complementares, esquemas terapêuticos, só possíveis porque tem inúmeros conhecimentos sobre o motivo que o levou a procurar um médico ou outro profissional de saúde. O relacionamento com este novo tipo de paciente vai ser diferente. O médico precisa ter segurança em seus conhecimentos, mas também é necessário que ele reconheça não ser mais o “dono” dos conhecimentos científicos sobre o tema daquele encontro clínico. Se não respeitar os conhecimentos do paciente a relação com ele se enfraquece. O contrário acontecerá se souber tirar proveito para se estabelecer uma efetiva parceria que trará inegáveis resultados positivos. É provável que esta parceria vá refletir-se em muitos aspectos, entre os quais a adesão ao tratamento, muita baixa nas doenças crônicas, por exigirem mudanças de hábitos e uso contínuo de medicamentos.

As “comunidades virtuais” dos pacientes que reúnem principalmente pacientes com doenças crônicas, raras ou estigmatizantes podem ser consideradas um importante fenômeno social da era da internet. São um sucedâneo dos tradicionais “grupos de apoio”, mas com outras características que facilitam sua organização e atuação. Não podem ser menosprezadas, muito menos, ignoradas. Os profissionais de saúde precisam conhecê-las para integrá-las no sistema de saúde. Poderão ter um papel significativo em muitas questões, não apenas na difusão de conhecimentos, mas também sobre aspectos éticos, legais, administrativos, econômicos e políticos.

Outra questão de crescente interesse são as “consultas a distância” e as “consultas virtuais”, quando o encontro clínico que é, pela sua própria natureza, essencialmente presencial, passa a ser feito por intermédio de aplicativos de mensagem instantânea, tais como *Whats App*, *Viber*, *Messenger* e similares. Muitos pacientes se sentem à vontade para enviar mensagens aos médicos por estes aplicativos por estarem habituados a se comunicarem com seus familiares, amigos, colegas desta maneira. O tema é de tamanha importância que o Conselho Federal de Medicina (CFM) já se posicionou, partindo da premissa de que consultas por

mídias sociais não constituem “ato médico completo”, o que não quer dizer que fica proibido este tipo de comunicação entre o médico e o paciente. Por exemplo, após um exame clínico “presencial”, a critério do médico e a partir de acordo prévio com o paciente ou responsável, é perfeitamente aceitável o envio de resultados de exames complementares ou de novas informações por meio eletrônico.

Não são apenas as “consultas” que são possíveis “a distância”. Exames poderão ser feitos pelo próprio paciente e enviados eletronicamente ao médico ou para quem ele quiser!

O impacto dos recursos técnicos já existentes e dos que estão por vir sobre o exercício das profissões da saúde deve ser analisado de várias perspectivas, a começar pelo desafio que representa para os cursos de graduação. Contudo, ênfase especial merece a influência sobre a relação médico-paciente, que já foi essencialmente paternalista/autoritária, quando o médico assumia total controle em função de monopolizar os conhecimentos sobre as doenças e os tratamentos. Ainda há momentos para o comportamento paternalista, mas já não é o único nem o preponderante. O relacionamento com os pacientes é cada vez mais de parceria e compartilhamento, o que permite classificá-lo de “contratualista”, no qual as partes reconhecem seus direitos e deveres, possibilidades e limitações.

De que maneira tudo isso vai interferir no exame clínico? Como o “Dr. Google” vai participar? Primeiro, o paciente vai chegar à consulta com um grande número de informações, muitas das quais não entendeu quase nada. Isto não impede que as utilize durante a anamnese do modo que puder ou quiser. A entrevista passa a ser dialogada, mais com perguntas do paciente do que o relato dos sintomas. Segundo, após a consulta, quando ele tiver um diagnóstico e uma proposta terapêutica ou avaliação prognóstica, vai voltar ao “Dr. Google” para conferir tudo que o médico falou!

Como se pode ver, inúmeras questões vêm à tona quando se aborda este tema, tais como competência, relação médico-paciente, sigilo ou confidencialidade, responsabilidade ética e legal. Portanto, não se pode desconhecer as interfaces entre a internet e as profissões da saúde com suas inegáveis interferências, positivas e negativas. O essencial é que se preservem os fundamentos da medicina de excelência, entre os quais se destaca o papel insubstituível do exame clínico (bem feito). É nele que se pode incluir competência científica, princípios éticos e qualidades humanas.

O lado mais negativo é utilizar os recursos virtuais, principalmente as mídias sociais, para divulgar nomes e/ou fotografias de pacientes e de atos médicos (cirurgias, partos) e relatos clínicos, com o objetivo de autopromoção ou simplesmente como manifestação exibicionista. Seja qual for o motivo isto constitui infração ética grave e pode dar origem a processo no Conselho Regional de Medicina que resulta em severa punição.

Boxe

O Conselho Federal de Medicina editou uma Resolução relacionada a estas questões, estabelecendo que é vedado ao médico “consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou a distância”, pois considera insubstituível a consulta presencial. Mas isso não impede o médico de orientar por telefone ou outros meios os pacientes que já conheça ou estejam sob seus cuidados, desde que não quebre a confidencialidade e o sigilo.

MEDICINA | ARTE E CIÊNCIA

Quando se diz que a medicina é uma ciência e uma arte, não é uma afirmativa gratuita, uma frase de efeito ou um pensamento saudosista; tampouco representa um modo de reagir aos avanços tecnológicos no campo da medicina. Aliás, quanto mais precisos e mais sensíveis forem os aparelhos e as máquinas, melhor para todos, médicos e pacientes, desde que se saiba reconhecer, claramente, suas possibilidades e limitações.

Nos últimos anos, a partir do rápido progresso da informática, excelentes lições puderam ser extraídas das tentativas de se desenvolverem sistemas lógicos com a finalidade de se fazerem diagnósticos clínicos. Pensou-se que a memória do computador carregada com todas as informações contidas nos tratados de medicina e áreas afins seria capaz de fazer diagnósticos rápidos e perfeitos, melhores do que os dos médicos. A realidade, entretanto, foi diferente, e o entusiasmo inicial durou pouco. Somente tiveram êxito relativo as experiências restritas à interpretação de gráficos e imagens, como os eletrocardiogramas, as cintigrafias e as imagens radiológicas, constituídos por elementos facilmente transferíveis para algum tipo de linguagem de computador.

O mesmo não acontece com os dados clínicos, extremamente variáveis e mutáveis, por isso mesmo, inteiramente adequados para os processos mentais, que nos levam a fazermos diagnósticos, uma vez que eles não se restringem a raciocínios lógicos e racionais; na verdade, sem que se perceba, pois, como tais processos se passam em nível inconsciente, utilizamos numerosos elementos aparentemente desprovidos de conexão com os fatos relatados ou observados para tirar conclusões, aí incluindo dados psicológicos, sociais, culturais ou de outra natureza. Não há noção exata de quanto influenciam em muitas de nossas

decisões diagnósticas e terapêuticas. Isso mostra por que a aplicação das técnicas estatísticas e da ciência computacional aos métodos dedutivos ou intuitivos que constituem a essência da medicina clínica não funcionou adequadamente.

No estágio atual de desenvolvimento, os computadores, não excluindo os dotados de “inteligência artificial”, são ótimos para armazenar dados, arquivar, correlacionar informações, ou aplicações semelhantes, mas continuam insuficientes para avaliação de um paciente na profundidade e abrangência de que se necessita para uma boa prática médica.

Quando lembramos que a medicina é um conjunto de conhecimentos, técnicas, tradições, que se foram acumulando por mais de 2 mil anos, que inclui o ser humano e suas relações com o meio ambiente e o contexto cultural (aspecto muito bem definido quando se diz que ninguém nasce, ninguém vive, ninguém adoce e ninguém morre da mesma maneira em todos os lugares), fica fácil compreender as imensas limitações da tecnologia em tentar fazer o que nossa mente consegue, apoiando-se em elementos lógicos e não lógicos, em nível consciente e inconsciente, onde estão armazenados o saber e a história da humanidade.

E o que tem a ver com tudo isso o exame clínico? Ele é, simplesmente, o traço de união, o elo de ligação entre a arte e a ciência médica; ou melhor, é no exame clínico que se pode fazer a fusão da ciência e da arte; e isso se dá de muitas maneiras.

Analizando o fato de que podemos armazenar os conhecimentos científicos que devem ser organizados e aplicados de maneira objetiva em conformidade com as rígidas regras que a ciência exige, absolutamente racionais e facilmente codificáveis, só temos a ganhar com a computação eletrônica de dados, uma vez que tudo se passa com inquestionável predomínio do objetivo sobre o subjetivo, tal como acontece em qualquer ramo das ciências. A medicina, no entanto, não se enquadra nesses limites, pois, por outro lado, temos os princípios éticos, a relação médico-paciente, as inúmeras maneiras de sentir, sofrer, interpretar o que se sente, de relatar o que se passa no íntimo de cada um, na doença e na saúde. Além disso, há as nuances impressas pelo contexto cultural, pela interferência do meio ambiente, pela participação dos fenômenos inconscientes, muitos deles mal aflorando nas perguntas do médico e nas respostas do paciente. Então, revela-se o subjetivo caminhando, lado a lado, com o objetivo ou até suplantando-o; a intuição passa a valer tanto quanto ou mais que os processos racionais e lógicos. Os limites precisos exigidos pela ciência (médica) dão lugar às fronteiras mal definidas e às referências instáveis, necessariamente mutáveis, que vão constituir o outro componente da profissão médica, que podemos chamar de arte (médica).

No exame clínico, e somente nele, estes dois lados andam juntos, um penetrando no território do outro, intercomunicando-se, completando-se, influenciando-se mutuamente, entrelaçando o lado lógico e racional com o intuitivo e subjetivo.

É justamente esta característica do método clínico – sua flexibilidade, às vezes considerada sua parte mais frágil pelos que pouco conhecem deste método – que permite essa fusão, fazendo com que a arte e a ciência médicas se harmonizem e se completem.

Boxe

O outro lado da medicina

O que torna a medicina tão diferente de tantas outras profissões é este lado não científico, não racional, que permite ver além da célula lesionada e do órgão doente. Neste ponto estão os obstáculos que se antepõem aos técnicos que tentam transpor para a linguagem dos computadores o mundo da medicina clínica.

O método clínico penetra neste mundo complexo sem dificuldades, porque concilia o lado racional, que trabalha com os conhecimentos científicos, com outros aspectos ainda pouco conhecidos da natureza humana, que se tornam mais complexos ainda quando há dor, sofrimento, risco de morte. No entanto, pouco conhecer ou desconhecer não significa inexistir nem justifica ignorar este outro lado. Ao contrário, é importante valorizá-lo porque nele estão os mistérios que fazem parte do estar saudável e do ficar doente.

O método clínico, ao unir a arte com a ciência, amplia a percepção do médico para conceber a saúde e as doenças em uma visão multidimensional (ou, para usar o termo da moda, multifatorial), envolvendo aspectos físicos, psicológicos, sociais, familiares, culturais, ambientais, históricos, geográficos, todos interdependentes, influenciando uns aos outros, para formar uma teia de correlações, impossíveis de serem aprisionadas nas fórmulas matemáticas das máquinas que, se comparadas com a mente humana, são apenas *aparentemente* maravilhosas.

O exame clínico, ao fazer essa fusão, rompe os limites da ciência cartesiana e positivista, aceitando a presença do imponderável. Quem compreende isso sabe o significado da afirmativa de que a medicina é arte e ciência. Se assim pensarmos, poderemos incorporar todos os avanços tecnológicos ao nosso trabalho, sem a ilusão ou o receio de que o computador – símbolo atual das ciências – substitua o médico na parte mais simples e mais nobre de sua atividade: o exame clínico.

A conclusão é simples: medicina de excelência só é possível se o exame clínico for excelente.

Boxe

Princípios bioéticos

Desde o primeiro encontro com um paciente, o estudante precisa ter em mente – e por em prática – um dos componentes fundamentais de todo ato médico que são os princípios bioéticos:

Autonomia: o paciente tem direito de tomar decisões em tudo que se refere à sua saúde e ao que a ela se relaciona

Beneficência: significa a obrigação de procurar fazer o bem, ou seja, é necessário colocar em primeiro lugar os benefícios

Não maleficência: é fundamental evitar danos ao paciente

Justiça: atuar com absoluta isenção no que se refere à distribuição de bens e benefícios que possam estar relacionados à saúde do paciente.

As bases científicas da medicina devem fazer parte do ensino médico do primeiro ao último ano, devendo ser sempre enfatizada a importância de uma prática de medicina baseada em evidências. Contudo, o outro lado da prática médica, que reúne intuição, bom-senso, reconhecimento das necessidades pessoais, culturais e sociais do paciente, adequada relação médico-paciente e formação humanística, também deve ser parte integrante da formação do médico, configurando a medicina baseada na vivência. Assim, o ensino ministrado durante os anos de graduação deve visar ao aprendizado não apenas de conhecimentos, mas também de habilidades e atitudes que só se aprendem no contato direto com pacientes, sempre subordinados aos princípios éticos.

Até os anos 1990, a iniciação clínica do estudante de medicina correspondia à sua entrada no hospital de ensino, pois nos primeiros anos ele atuava nos laboratórios de ciências biológicas, estudando anatomia, fisiologia, bioquímica, genética e as demais disciplinas básicas do curso. A entrada no hospital marcava, de maneira nítida, o término de uma etapa e o começo de outra. Era o momento em que o aluno se diferenciava, assumindo integralmente as características de estudante de medicina. A mudança era radical; modificava-se inclusive seu modo de trajar, já que o trabalho no hospital exige indumentária própria. A roupa e os sapatos brancos serviam de símbolo para marcar tão profundas alterações.

No entanto, nos últimos anos as escolas médicas passaram por um processo de reforma curricular, e uma característica importante hoje é a inserção precoce do estudante de medicina na comunidade e nos serviços de saúde, quando já passa a usar o jaleco branco e a entrar em contato com pacientes desde o início do curso. Na comunidade, embora ainda não aprenda especificamente o método clínico, o estudante já inicia sua relação com o paciente, começando a dar seus primeiros passos na iniciação clínica. Essa inserção precoce na comunidade faz com que não haja uma diferença tão marcante entre o ciclo anteriormente chamado de básico e o ciclo profissional, mas, ao contrário, desenvolve um progressivo cotidiano médico, que permanece durante todo o curso e faz com que o estudante possa tornar-se médico da maneira mais adequada.

Atualmente, o aprendizado da semiologia acontece em vários cenários, e não somente nos hospitais universitários. Em algumas escolas médicas, para se ensinar a construção de uma história clínica, os professores utilizam os pacientes de enfermarias; em outras, já se preferem pacientes provenientes de ambulatórios ou postos de saúde. A enfermaria talvez seja um local privilegiado para ensino de técnicas de exame físico, reconhecimento de padrões e demonstração de situações em que o exame físico é alterado – e continua sendo usada com esse objetivo. Já a história clínica construída a partir de pacientes de ambulatórios ou postos de saúde, que apresentam problemas menos complexos, possibilita que o raciocínio hipotético-dedutivo possa ser praticado pelos alunos desde o início.

As escolas médicas que adotam metodologias ativas, como o PBL (*Problem Based Learning*), utilizam, ainda, o Laboratório de Habilidades (LH) e de Comunicação como recursos didáticos para a aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades necessários para o exame de um paciente (ver Capítulo 2, *Laboratório de Habilidades Clínicas*).

Boxe

Momento de definição

Ao fazer sua iniciação clínica, o estudante deve autoanalisar-se e situar-se em um dos comportamentos.

Evidentemente, isso exige amadurecimento e força moral que uns terão mais que outros. O momento torna-se oportuno para um balanço na vida estudantil de cada um, porquanto o trabalho em qualquer local em que haja doentes exige, antes de mais nada, *participação*. O estudo nos livros e nas anotações de aula tem alguma importância, mas não se compara com os *trabalhos* práticos. É claro que, de início, a participação do estudante é bastante limitada, pois ele ainda não dispõe de conhecimentos e habilidades que lhe permitirão um envolvimento mais direto. *Participação crescente e responsabilidade progressiva* constituem a chave do aprendizado clínico. Tarefas simples, como pesar o paciente todo dia, podem ser um dos passos iniciais para esta caminhada que vai atingir o clímax quando o estudante se sentir inteiramente responsável por um paciente. O começo é trabalhoso e insípido como em qualquer área. A *iniciação clínica* exige o aprendizado de aspectos elementares, mas essenciais para a vida toda. Aprender a fazer anamnese compara-se ao duro aprendizado das primeiras letras. Adquirir as habilidades psicomotoras fundamentais – inspeção, palpação, percussão e ausculta – é comparável ao treinamento psicomotor pelo qual passam as crianças que estão aprendendo a escrever. A mesma insegurança e falta de jeito demonstrada pela criança ao empunhar o lápis é reconhecida no estudante que ensaia seus primeiros golpes de percussão.

Equipe de saúde

Ao se começarem as atividades na comunidade, nas UBAS/SUS (Unidade Básica de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde), e posteriormente nos hospitais, o primeiro fato que deve ser compreendido é que ali só se pode trabalhar em equipe com a participação de outros profissionais. Talvez seja a oportunidade para se perceber, de maneira concreta, que o médico por si só pouco ou nada pode fazer. A *equipe de saúde* tem como peças fundamentais o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o farmacêutico, o biomédico, o psicólogo, o assistente social e o fisioterapeuta. Atualmente, outros profissionais estão ampliando a equipe de saúde, como, por exemplo, o fonoaudiólogo, o dentista, o musicoterapeuta, o arteterapeuta e o terapeuta ocupacional.

Além do pessoal de formação superior já mencionado, as equipes de saúde contam com os auxiliares e técnicos, entre eles técnicos em enfermagem, em laboratório e em radiologia. Em especial nas equipes de Saúde da Família, o estudante desenvolve uma grande parceria com o agente comunitário de saúde, que é um membro importante da equipe multiprofissional.

Além disso, é com a equipe multiprofissional que o estudante aprenderá, paulatinamente, a desenvolver parcerias com o conselho que integra o *controle social* de cada área de abrangência do PSF (Programa de Saúde da Família, hoje chamado de Estratégia da Saúde da Família), com os Conselhos Tutelares (da criança e adolescente e do idoso) e com a Polícia Comunitária.

Disso se depreende que o relacionamento do estudante se fará com muitos profissionais, e o primeiro aprendizado é compreender as funções de cada um, respeitando-as e valorizando-as, para que o trabalho de todos se harmonize na busca de um objetivo comum, qual seja, a promoção e a recuperação da saúde, a prevenção das doenças e a reabilitação dos pacientes.

Trabalho prático

O momento culminante da iniciação clínica é o trabalho com o paciente. É possível que, no começo, haja algumas dificuldades. O comportamento dos pacientes é variável perante os alunos iniciantes. Enquanto uns colaboram, aceitando prazerosamente as frequentes solicitações dos estudantes, outros assumem atitude um tanto reservada e alguns chegam a expressar, a princípio, franco repúdio.

Antes de tudo, é necessário compreender a condição humana desses pacientes, muitos deles padecendo de afecções graves, causadoras de sofrimento e preocupações, justificando, às vezes, algumas atitudes em relação aos estudantes.

Boxe

Responsabilidade do estudante de medicina em um hospital de ensino (Rosa, 1970)

O bom conceito de uma escola depende da qualidade do aluno. Embora reconhecendo que a recíproca também seja válida, ou seja, o conceito e a qualidade do médico dependem da qualidade da escola, vemos que esta segunda alternativa é secundária e de menor importância

Observe muito e pense sempre; é uma atitude que distingue o bom do mau profissional e impede que se aja precipitadamente. Faça predominar o bom-senso

Participe ativamente dos trabalhos da equipe

Discuta sempre que houver oportunidade e necessidade, em vez de permanecer com as dúvidas

Faça da investigação e da experimentação aliados constantes da prática clínica

Cada estudante será o seu próprio censor: cumpra suas tarefas sem precisar ser monitorado

Lembre-se de que o paciente é o melhor professor e o melhor livro. Respeite-o pela sua condição humana e por sua utilidade no progresso da medicina. Ele deve ser o centro de nossa atenção

Todo trabalho exige seriedade

Seja honesto consigo, pois, assim, também o será com tudo e todos

Seja criterioso.

Não espere, contudo, elogios pela responsabilidade bem cumprida, pois o cumprimento de uma missão é uma satisfação pessoal que exalta nosso amor-próprio e eleva nosso conceito perante nós mesmos.

Pequenas dificuldades sempre aparecem: seja o paciente que finge estar dormindo ou que se esconde no banheiro quando vê chegar o horário de atividades didáticas, seja aquele que presta informações díspares após repetidas solicitações para relatar seus padecimentos.

Tudo isso pode acontecer e há que se estar prevenido. Como única sugestão, diríamos: trate os pacientes de modo humano, respeite suas limitações e saiba compreender sua condição de enfermos; procure dar a eles algo em troca do que lhe estão dando, como um momento de atenção, uma palavra de conforto ou um gesto de carinho. Agindo desse modo, todas as dificuldades serão superadas!

RELAÇÃO ESTUDANTE DE MEDICINA-PACIENTE DO PONTO DE VISTA HUMANO E ÉTICO

Nada melhor para iniciar este tópico do que relembrar algumas recomendações contidas nos livros do maior médico de todos os tempos, que foi Hipócrates, escritas há mais de 2 mil anos, e que permanecem vivas e atuais como verdades permanentes:

“Quando um médico entra em contato com um doente, convém estar atento ao modo como se comporta; deve estar bem-vestido, ter uma fisionomia tranquila, dar toda a atenção ao paciente, não perder a paciência e ficar calmo diante de dificuldades. É um ponto importante para o médico ter uma aparência agradável, porque aquele que não cuida do próprio corpo não está em condições de se preocupar com os outros. Deve, ainda, saber calar-se no momento oportuno e mostrar-se gentil e tolerante; não deve agir de modo impulsivo ou precipitado; nunca deve estar de mau humor nem mostrar-se demasiadamente alegre.”

No relacionamento com o paciente, portanto, é importante a aparência do médico. O uso da roupa branca, sob a forma de avental, sobre o uniforme branco ou sobre a roupa comum, contribui para uma boa aparência e funciona como um equipamento de proteção individual (EPI). Por isso, dentro do hospital ou da UBAS/SUS, é essencial que o avental branco faça parte do uniforme, como proteção contra infecções. O mesmo deve acontecer com os calçados, que devem ser fechados para proteção contra acidentes perfurocortantes. As vestes brancas têm ainda um simbolismo, demonstrando a preocupação com a limpeza e a higiene por parte de quem as traja.

Para adentrar o hospital, o estudante de medicina deve estar vestido de branco e ter uma aparência agradável, que subentende asseio corporal, unhas aparadas, cabelos penteados e, quando compridos, devidamente presos, roupas limpas e um aspecto saudável. A recente Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), que entrou em vigor pela portaria nº 485, em 11 de novembro de 2005, prevê a proibição do uso de adornos pelos profissionais de saúde em ambiente hospitalar. Para a Comissão Tripartite Permanente Nacional, normatizadora da NR-32, são considerados adornos alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, *piercings* expostos, gravatas e crachás pendurados com cordão. Além de descaracterizarem sua figura de futuro médico, eles são elementos de transmissão de bactérias, podendo contribuir para a disseminação de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). O estudante deve ainda ser comedido em suas atitudes, em sua linguagem e em seu comportamento. As brincadeiras, os ditos jocosos, as discussões de assuntos alheios ao ensino e ao interesse dos enfermos devem ser deixados para outra oportunidade e outro local. O ambiente hospitalar exige respeito e discrição.

A profissão médica exige autodisciplina; o estudante deve aprender a se impor desde cedo. Ao entrar em contato com os pacientes nas enfermarias ou no ambulatório, melhor dizendo, *nos consultórios*, e iniciar seu aprendizado prático junto a eles, o estudante de medicina encontrará, certamente, algumas dificuldades que necessitam ser superadas. Muitas delas são previsíveis e decorrem de tensões criadas pelo próprio curso médico. No dizer do educador George Miller, a faculdade é uma fonte geradora de tensões, e cada estudante reage a essas tensões de acordo com a sua maturidade emocional. É importante que ele saiba que muitas dessas reações são normais e comuns à maioria dos seus colegas. Algumas delas são expostas a seguir.

É comum o estudante logo verificar que, para numerosas doenças, não existe tratamento eficaz, e o médico nada mais pode fazer que proporcionar alívio aos sintomas e acompanhar a evolução da moléstia. Esse fato causa profunda decepção àqueles que, em suas fantasias de adolescentes, imaginam o médico como um profissional quase onipotente, capaz de influir decisivamente sobre a vida e a saúde. O estudante sente-se frustrado, como alguém que foi ludibriado na escolha de sua carreira. É necessária maturidade para reagir a esse sentimento de frustração, adaptar-se à realidade da profissão médica e saber que sempre há o que ser feito no contexto de “Cuidados Paliativos”. Vale ressaltar que os cuidados paliativos devem ser iniciados tão logo seja feito o diagnóstico de doenças sem tratamento modificador de sua história natural. O estudante poderá sentir que tão gratificante quanto curar as doenças é aliviar o sofrimento do paciente frente aos sintomas físicos, emocionais e espirituais que acompanham sua enfermidade.

Outra causa frequente de ansiedade é verificar o valor relativo de toda afirmação em medicina. Nada existe de absoluto; os mesmos sintomas podem decorrer de doenças diferentes; a mesma doença pode produzir sintomas diversos; cada paciente é um universo particular com apenas alguma semelhança com o próximo; cada paciente reage de maneira diferente ao mesmo tratamento; as verdades em medicina são relativas e provisórias.

Ao verificar a divergência existente na opinião de dois professores, o aluno fica desorientado e, em lugar de perceber que essa situação é normal em medicina e que ele mesmo deve procurar pensar e decidir por si próprio, reage de maneira diferente. O estudante imaturo reage com hostilidade à escola e ao corpo docente, desejando, no íntimo, estar matriculado em outra faculdade, na qual os professores fossem mais bem preparados e lhe dessem uma orientação mais segura. É esta uma reação normal da pessoa emocionalmente dependente, que necessita de apoio e que se sente insegura.

Vale lembrar que, nas faculdades que adotam metodologias ativas, esse fenômeno é quase inexistente, pois os alunos estudam por si e apenas se encontram com os professores para discutir sobre o que estudaram. O papel do professor que “tudo sabe” e do estudante que, como “tábula rasa” (do latim, “folha em branco”, que significa “nada saber”), aceita sem discussão o que lhe é imposto pelo professor está cedendo lugar a um processo dialético de ensino-aprendizagem no qual o estudante é ator de seu processo de aprendizagem, buscando em livros, em periódicos e em fontes confiáveis da mídia eletrônica o que há de mais atualizado sobre o tema a ser estudado, e o professor é um moderador, um ativador e um parceiro nesse processo de aquisição e construção do conhecimento.

Esta situação, entretanto, longe de ser prejudicial, é benéfica, pois é importante treinar o estudante para as incertezas da medicina, ensinando-lhe, desde cedo, a desenvolver o seu juízo crítico, o seu discernimento, para que não fique, no futuro, preso a esquemas e regras que passa a aceitar passivamente. Ademais, a medicina é uma ciência com constantes descobertas e modificações, e o aluno deve ser capaz de buscar o conhecimento atualizado não apenas durante a graduação, mas por todos os anos em que se mantiver ativo profissionalmente.

Outra fonte de ansiedade resulta da tomada de consciência da extensão de conhecimentos que necessita adquirir no reduzido tempo de que dispõe. Os professores, inadvertidamente, podem contribuir para agravar a situação. Cada docente é um especialista em determinado setor, e o aluno convive com vários deles ao mesmo tempo, verificando, desde cedo, ser impossível corresponder ao que cada professor espera dele. Sendo impossível demonstrar um desempenho altamente satisfatório em todas as disciplinas que lhe são ministradas, termina por escolher aquelas para as quais foi mais vivamente motivado, desprezando as demais e racionalizando sua atitude com a interpretação de que assim o faz porque deseja dedicar-se a tal setor da medicina ou porque aquelas que desprezou são mal ensinadas. Cria-se, assim, o perigo da especialização precoce, que deve ser evitada a todo custo.

Outra frequente fonte de ansiedade decorre da impressão que alguns alunos têm de estarem os professores mais interessados na observação dos fatos, na pesquisa clínica, do que no propósito de curar ou recuperar os enfermos. É louvável a atitude de tais alunos em se preocuparem com a sorte dos enfermos, porém é necessária uma introspecção sincera para verificar se, na verdade, estão preocupados realmente com os pacientes ou se seu sentimento deriva de uma necessidade compulsiva de agradar para obter reconhecimento. Se assim for, tal atitude é também indício de imaturidade. É importante considerar todo paciente, humanamente, como pessoa digna de todo respeito e consideração, e nada deve ser feito sem o seu consentimento. Isso não impede, entretanto, que a medicina seja exercida com espírito científico e que todo doente possa contribuir para o aprimoramento dos nossos conhecimentos, o que, em última análise, resulta em benefício dos próprios doentes. É necessária uma atitude deliberada de observação criteriosa dos fatos para que se possam tirar conclusões válidas. Não se pode dissociar o ensino da pesquisa, e quando não há pesquisa, o ensino tende a deteriorar-se.

Finalmente, outro importante ponto de angústia dos alunos – especialmente os que estudam a relação médico-paciente de maneira curricular na graduação – é a convivência com professores e preceptores que não reforçam no ambiente da prática (enfermarias, ambulatórios) o que aprenderam sobre a boa relação médico/estudante-paciente na teoria em discussões reflexivas na sala de aula. A abordagem ao paciente apenas em seu contexto biológico, deixando de lado a visão holística do doente no contexto social em que se insere, bem como atitudes rudes, manifestações de sintomas de *burnout* ou mesmo o fato de não se preocuparem em olhar o paciente nos olhos e mostrar-se interessados no que ele tem a dizer, fazem com que o estudante se sinta

irritado e desmotivado. Nesse contexto, sabe-se que muitos preceptores são “médicos no papel de professores”, e não “professores que também são médicos”, o que os faz despreparados para o ensino da boa relação médico-paciente nos ambientes de prática, focando apenas no conteúdo essencial biologicista da especialidade pela qual é responsável.

Vencidas todas as tensões que possam surgir no ambiente hospitalar ou em qualquer local em que se presta assistência à saúde, estará o estudante em condições de estabelecer um bom relacionamento com os pacientes e desenvolver uma atitude útil ao seu aprendizado e benéfica aos pacientes sob os seus cuidados.

Mais uma vez as escolas médicas de vanguarda que oferecem uma nova metodologia acabam por modificar tal estrutura descrita. Ao optar por metodologias problematizadoras ou especificamente pelo PBL, deixam de lado as especialidades dos professores, dando ênfase à transdisciplinaridade, em que um tutor precisa moderar a discussão dos alunos sobre temas que não obrigatoriamente têm a ver com sua especialidade. Um exemplo dessa situação é o fato de um tutor de semiologia moderar a discussão problematizada sobre semiologia, patologia e radioimagem, sendo, por exemplo, um cardiologista.

PRINCÍPIOS DO APRENDIZADO DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

Os fundamentos são:

Considerar acima de tudo a condição humana do paciente. No relacionamento estudante-paciente, a primeira manifestação do estudante deve ser de empatia e de interesse pelo doente. O paciente deve ser tratado humanamente e jamais como simples caso a ocupar um leito numerado; deve ser chamado respeitosamente por seu nome próprio, antecedido de Sr. ou Sra. quando se tratar de um adulto. O estudante deve lembrar-se de que o paciente é alguém muito importante para a própria família, que depende dele ou que espera por ele e deseja vê-lo recuperado. Enquanto o estudante está em aprendizado, o paciente encontra-se em seu momento de maior sofrimento, angústia e dor. Ele vai ao hospital em busca da saúde perdida e espera encontrar compreensão, ajuda e respeito por parte de todos os que o assistem para alcançar seu objetivo.

Cuidado com as palavras e as atitudes. Nos hospitais universitários, costuma-se discutir os casos clínicos à beira do leito ou nas salas de consultas dos ambulatorios. Isso ainda faz parte da dinâmica do trabalho dessas instituições em função da necessidade de ministrar ensino prático aos estudantes de medicina. Por menos que pareça, os pacientes estão sempre muito atentos a tudo o que se fala sobre eles, principalmente nos casos mais graves. Comentários inadequados, expressões que traduzam possíveis diagnósticos de doenças malignas ou incuráveis e prognósticos pessimistas podem ser fonte de ansiedade e sofrimento psíquico que aumentam o padecimento do paciente. É necessário desenvolver o hábito de discutir o diagnóstico diferencial, as hipóteses diagnósticas e o prognóstico em outro local, longe dos pacientes. Por outro lado, tendo em conta que nem sempre é possível evitar essas discussões na presença do paciente, todo cuidado deve ser tomado com palavras e atitudes capazes de atemorizá-lo ou de levá-lo a conhecer a gravidade de seu mal ou a natureza incurável de sua enfermidade.

Palavras que soam como estigmas, tais como *câncer*, *AIDS*, *doença de Chagas*, *hanseníase*, *incurável*, *óbito* e outras tantas, não devem ser mencionadas de modo inconsequente na presença do paciente. Há momentos em que são inevitáveis, e, nesses casos, o médico tem de escolher o momento mais oportuno e a maneira mais adequada para dizê-las, e assegurar-se de que o paciente já esteja ciente de seu diagnóstico, e não terá a revelação feita de maneira inadvertida durante o momento da discussão à beira do leito.

Todo paciente deve merecer a mesma atenção. É frequente o estudante entusiasmar-se com casos raros, difíceis e complicados, menosprezando aqueles mais simples com os quais está em contato diariamente. Todo paciente deve merecer a mesma atenção, por mais banal que seja seu caso. Para ele, o seu problema é o mais importante de todos e merece consideração séria por parte do médico. O paciente está sempre receoso de que tenha uma doença grave, e é dever do médico tranquilizá-lo. Além disso, muitos estudantes demonstram alegria ao se depararem com casos diferentes, oportunidades de realizar procedimentos e achados interessantes/novos no que diz respeito à sua formação. Entretanto, é necessário ter sempre em mente o sofrimento causado pela moléstia ao paciente, devendo o estudante impreterivelmente conter o entusiasmo em tais situações de aprendizagem.

Disposição para ouvir. Ao obter a história clínica, é preciso demonstrar disposição para ouvir. Deixar o paciente falar à vontade, interrompendo-o o mínimo possível, apenas quando estritamente necessário. É importante que o paciente externar tudo o que o preocupa ou aborrece, mesmo que, aparentemente, não tenha relação direta com a doença que se procura diagnosticar. Nunca se deve interromper o paciente com observações como estas: “*Isso não interessa*”, “*Só responda ao que eu perguntar*” e outras semelhantes.

Durante as entrevistas, o estudante deve esforçar-se ao máximo para interessar-se realmente pelo que lhe diz o paciente, procurando, depois, ordenar os dados fornecidos e fazer indagações complementares que forem necessárias.

Saber como dirigir-se aos pacientes. Ao dirigir-se ao paciente, deverá o estudante mostrar-se educado no falar e no agir. Em

vez de ordenar, usar sempre “por favor”. Ao realizar o exame físico, evitar ferir o pudor do paciente. Em nenhuma hipótese, o paciente deverá ser hostilizado ou obrigado a se submeter a exames ou procedimentos pelo simples fato de estar em um ambiente de ensino ou hospital-escola.

O procedimento médico, diante de certas atitudes agressivas do paciente, deve ser de compreensão e tolerância.

Há pacientes que estão sempre gratos ao médico, por menos que este tenha feito em seu benefício. Há outros que estarão sempre revoltados e insatisfeitos, por mais que se faça em seu favor.

O estudante deve colocar-se em uma posição equânime e tratar ambos com bondade e compreensão.

Conhecer os limites em que pode atuar. Embora o estudante de medicina esteja legalmente impedido de executar qualquer ato médico, no hospital de ensino ele recebe a incumbência de realizar, sob supervisão docente, tarefas de crescente complexidade, que culminam no período do internato, com desempenho de todas as atividades inerentes ao exercício da profissão médica.

Assim como um menor não responde pelos seus atos perante a lei, também o estudante de medicina não é responsável pelos atos médicos que pratica.

Toda atividade que desempenha ele o faz por delegação de função e sob a responsabilidade única e exclusiva dos docentes. À medida que desenvolve seus conhecimentos e suas habilidades, igualmente se familiariza com as questões de ética médica e com os deveres da profissão.

Deveres fundamentais. O estudante deve, desde logo, aprender a cultivar dois preceitos considerados deveres fundamentais do médico: guardar absoluto respeito pela vida humana e exercer seu mister com dignidade e consciência.

O primeiro deles é, do ponto de vista filosófico, a condição primeira da existência da medicina como arte e como ciência de curar.

Não há condição alguma nem situação capaz de justificar a quebra desse princípio. A missão do médico é a de preservar a vida e a saúde, sendo individualmente responsável por qualquer conduta que possa causar dano à integridade ou à vida de uma pessoa.

O médico jamais deve contribuir direta ou indiretamente, por ação ou omissão, para abreviar a duração de uma vida entregue aos seus cuidados.

O segundo preceito manda exercer a profissão com dignidade e consciência. As palavras dignidade e consciência pressupõem o reconhecimento e a aceitação de padrões éticos de comportamento, tais como distinção entre o bem e o mal, retidão de caráter, honestidade de propósitos, desejo de servir ao próximo e à comunidade, busca incessante de aperfeiçoamento técnico e moral.

Tudo o que contribui para enfraquecer o caráter ou destruir a personalidade torna a pessoa incompatível com o exercício da medicina, como, por exemplo, o uso de drogas, o alcoolismo e todos os desvios patológicos do comportamento humano.

Aprimoramento contínuo. É necessário ainda o aprimoramento constante por meio do estudo continuado. O que se aprende durante o curso médico é, na realidade, muito pouco em face da extensão e da contínua evolução da medicina.

O objetivo principal das escolas médicas deve ser o de criar no estudante o hábito do estudo, a curiosidade científica, o espírito de observação, o desejo de aprender, dando-lhe a base necessária para que possa desenvolver todas as suas potencialidades no futuro. Estudar deve ser um hábito de todo médico, para que ele não se veja ultrapassado e se mantenha atualizado, eficiente e útil à comunidade e ao seu tempo.

Compromisso fundamental. O estudante deve recordar-se de que decidiu dedicar toda a sua vida à saúde do próximo. A menos que abandone a profissão, estará, para o resto de sua vida, a serviço de seus semelhantes, qualquer que seja a especialidade ou o local de trabalho que escolher.

Boxe

O exame clínico como base de uma medicina de excelência

O estudante precisa aproveitar ao máximo a oportunidade de aprender a examinar um paciente, única maneira de exercer uma medicina de excelência. Os adventos tecnológicos muito auxiliam no diagnóstico e tratamento de doenças, mas não são capazes de substituir o exame clínico bem-feito.

EXAME CLÍNICO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

A relação médico-paciente apresenta um componente cultural que não depende do que o médico faz. É uma herança do poder mágico dos feiticeiros, xamãs e curandeiros que antecederam o nascimento da profissão médica, mas que ainda hoje muito influencia na maneira como os pacientes veem os médicos. Não há por que menosprezar este fenômeno ligado à evolução da humanidade. Existe, contudo, outro componente da relação médico-paciente, este, sim, estreitamente ligado à própria ação do médico, pois ele surge durante a anamnese e é fruto da maneira como ela é feita; portanto, depende do médico. Por isso, é necessário tomar consciência da importância deste momento, porque ele é decisivo. Daí a razão de se dizer que o aprendizado do método clínico, cuja única maneira de aprender é fazendo o exame clínico, é também a principal oportunidade para estabelecer as bases do aprendizado da relação médico-paciente que servirão para o resto da vida.

Sem dúvida, o essencial deste aprendizado está nas vivências do próprio estudante, nascidas na realização de entrevistas, quando ele assume o papel de médico dentro de uma situação real e verdadeira, como a propiciada pelo exame de pacientes em postos de saúde, serviços de emergências ou um hospital. O treinamento em Laboratório de Habilidades é muito útil, mas jamais a tecnologia educacional conseguirá reproduzi-la em toda a sua amplitude; ficará faltando seu ingrediente principal, que é resultante da interação de duas pessoas que se põem frente a frente em busca de algo relevante para ambas.

Se o estudante tiver oportunidade – e isso depende de como o professor orienta o ensino do exame clínico – de analisar os acontecimentos vivenciados por ele, duas coisas acontecem ao mesmo tempo: aprende a *técnica* de fazer a anamnese e reconhece os *processos psicodinâmicos* nos quais ele e o paciente se envolvem, querendo ou não, proposital ou inconscientemente.

É inevitável e necessário que o estudante descubra seu lado humano, com suas possibilidades e limitações, certezas e inseguranças, até então amortecido nos trabalhos feitos nos anfiteatros anatômicos, laboratórios das cadeiras básicas e laboratórios de simulação. Somente a partir do momento em que tem diante de si pessoas fragilizadas pela doença, pelo receio da invalidez, pelo medo de morrer, é que o estudante percebe que o trabalho do médico não se resume apenas à técnica, embora tenha que dominá-la o melhor possível para ser competente, e que há alguma coisa mais, diferente de tudo o que viu até então, que interfere com seus valores, crenças, atitudes, sentimentos e emoções, obrigando-o a refletir sobre a carreira médica.

Nesta hora o papel do professor de semiologia atinge seu ponto mais nobre, se ele souber tirar proveito daquelas situações para mostrar aos seus alunos que aquele algo diferente é a relação médico-paciente que está nascendo.

São as primeiras raízes, ainda débeis, de um processo que precisa ser cultivado a cada dia, em múltiplas situações, agradáveis ou sofridas, para se poder compreender o mais rápido possível a complexidade das situações que o aluno está vivendo. Alguns estudantes, talvez os mais sensíveis e os mais maduros, notam logo que participam de alguma coisa que ultrapassa os limites que eles previam existir no trabalho direto com pacientes. Muitos desenvolvem uma ansiedade que lhes tira o sono, desperta questionamentos, provoca dúvidas. Tudo isso é inevitável, porque a aprendizagem verdadeira do método clínico é indissociável da aprendizagem da relação médico-paciente.

Os professores precisam estar atentos, preparados e disponíveis para não desperdiçar a oportunidade que os próprios estudantes nos oferecem para formarmos a mente e abrir o coração dos futuros médicos.

Estamos convencidos de que a recuperação do prestígio da profissão médica, tão reclamada, começa aí, valorizando desde cedo a relação estudante-paciente, não por meio de palavras e preleções, mas orientando-os nestes passos iniciais, mostrando para eles que a relação médico-paciente nada tem a ver com aparelhos e máquinas, não importa quão sofisticados sejam. Que ela continua dependendo da palavra, dos gestos, das atitudes, do olhar, da expressão fisionômica, da presença, da capacidade de ouvir, da compreensão, enfim, de um conjunto de elementos que só existem na condição humana do médico.

A relação médico-paciente é uma relação interpessoal que tem princípios aplicáveis a qualquer tipo de relação, mas a condição de médico e a doença a fazem particular e diferente de todas as outras. (No livro *Cartas aos Estudantes de Medicina*, estas questões foram abordadas com mais extensão e profundidade.)

CLERKSHIP (APRENDIZADO AO LADO DO LEITO)

Adotamos essa designação à falta de um termo correspondente na língua portuguesa.

Clerkship, portanto, é o trabalho do estudante junto ao leito e consiste, fundamentalmente, na participação direta nas atividades assistenciais dispensadas aos pacientes internados.

Procurando uma sistematização prática, conseguimos destacar os seguintes elementos:

Cada aluno pode ficar responsável por um ou mais pacientes sob supervisão do docente

O estudante deve prestar assistência diária ao paciente, inclusive aos sábados, domingos, feriados e dias santos. Aos pacientes em estado grave, a assistência deve ser prestada não apenas no horário programado para aulas, mas a qualquer hora do dia ou da noite. O *clerkship* deve reproduzir a situação real da atividade médica

O atendimento ao paciente deve ser feito como primeira obrigação do estudante no serviço em que estiver desenvolvendo

tais atividades

O estudante deve fazer o exame clínico completo, seja qual for o paciente que estiver acompanhando

Os exames complementares poderão ser requisitados pelo aluno; entretanto, será obrigatório o visto do professor

Atos médicos simples serão executados pelo estudante, desde que receba autorização para tal. *Atos médicos simples* são: aplicar injeções, passar sondas, fazer curativos e outros, a critério do professor responsável pelo paciente. A medicação do paciente é da responsabilidade direta do docente, cabendo ao estudante acompanhá-la para compreendê-la. Quando um plano terapêutico já estiver em execução, o estudante pode receber autorização para, a cada dia, prescrever na papeteleta os medicamentos em uso, mas sem autoridade para modificá-los por sua própria iniciativa, a não ser em situações de urgência

Atos médicos mais diferenciados, tais como punções cavitárias, diálises, biopsias e intervenções cirúrgicas da exclusiva competência do responsável pelo paciente terão o acompanhamento ou mesmo a ajuda do estudante. Sua participação nesses atos é obrigatória e, sempre que possível, terá a condição de auxiliar, não devendo ser mero espectador. No caso de operações e partos, a participação do estudante será restrita ao nível de atuação para o qual estiver capacitado

Todas as atividades desenvolvidas pelos estudantes no *clerkship* (confeção de observações clínicas, registro diário da evolução, prescrição de medicamentos, realização de atos médicos simples) devem ser registradas por escrito e devidamente assinadas. Em nenhuma circunstância, admite-se o anonimato.

DIAGNÓSTICO, TERAPÊUTICA E PROGNÓSTICO

A atividade médica não se restringe ao binômio médico-paciente nem fica completa com a feitura do diagnóstico e a instituição de uma terapêutica.

Ao binômio médico-paciente junta-se um terceiro elemento, que veio tornar mais complexo o trabalho do médico ao exigir o que se denomina avaliação prognóstica.

O terceiro elemento costuma ser representado por um ou mais membros da família, habitualmente aquele(s) que apresenta(m) laços afetivos íntimos e/ou responsabilidade mais direta, ou seja, pai, mãe, filho, marido, esposa, irmão. Em contrapartida, não é raro que seja representado por pessoa ou instituição cujos interesses situam-se no campo médico-trabalhista, previdenciário, pericial ou médico-legal; são empresas, instituições previdenciárias ou seguradoras ou o próprio poder judiciário.

A cada dia, é mais frequente a participação deste terceiro elemento, sendo ele um dos fatos que vêm caracterizando o componente social da medicina. Vejamos qual o objetivo primordial de cada um dos componentes desta tríade em relação aos três elementos nucleares da atividade médica: o *diagnóstico*, a *terapêutica* e o *prognóstico*.

O paciente, salvo raras exceções, não tem especial interesse no diagnóstico nem no prognóstico. Sua principal preocupação é a terapêutica, que lhe restitua o bem-estar perdido. O terceiro elemento coloca em primeiro lugar o prognóstico, desejando saber se o caso é grave ou não, se determinará invalidez parcial ou total e assuntos desta natureza. Qual seria a preocupação fundamental do médico? É o diagnóstico! Pois só lhe será possível satisfazer adequadamente aos dois outros membros da tríade se conseguir reconhecer o problema do paciente; vale dizer: se conseguir chegar a um diagnóstico correto. Junte-se a isso a necessidade de conhecer a pessoa como um todo, além de identificar sua doença (ver Capítulo 8, *Médicos, Pacientes e Famílias*).

Diagnóstico

Antes de tudo, é mister recordar o significado dos termos *sintoma*, *sinal*, *síndrome* e *entidade clínica*.

Sintoma é uma sensação subjetiva anormal sentida pelo paciente e não visualizada pelo examinador (p. ex., dor, má digestão, tontura, náuseas).

Sinal é um dado objetivo que pode ser notado pelo examinador mediante inspeção, palpação, percussão, ausculta ou evidenciado por meios subsidiários (p. ex., tosse, vômito, edema, cianose, presença de sangue na urina).

Nem sempre é possível fazer distinção absoluta entre sintoma e sinal, porque alguns, tais como dispneia, vertigens e outros tantos, são sensações subjetivas para o paciente, mas ao mesmo tempo podem ser constatados objetivamente pelo examinador. Talvez, por isso, no linguajar médico, os termos *sinal* e *sintoma* sejam usados praticamente como sinônimos, sem se atender à definição já enunciada.

Síndrome é o conjunto de sintomas e/ou sinais que ocorrem associadamente e que podem ser determinados por diferentes causas.

Entidade clínica significa uma doença cuja história está reconhecida no todo ou em parte e cujas características lhe dão individualidade nosológica.

História natural de uma doença é um conjunto de elementos que se vão acumulando com a evolução do processo mórbido. O diagnóstico que fazemos em um dado momento representa apenas um corte transversal na história natural de uma enfermidade.

Tipos de diagnóstico

Não existem fronteiras bem definidas entre os vários tipos de diagnóstico: *anatômico*, *funcional*, *sindrômico*, *clínico* e *etiológico*. Assim, frequentemente um diagnóstico sindrômico poderá ser, também, anatômico ou funcional, ou os dois ao mesmo tempo.

Diagnóstico anatômico é o reconhecimento de uma alteração morfológica (p. ex., hepatomegalia, megaesôfago, estenose mitral etc.).

Diagnóstico funcional é a constatação de distúrbio da função de um órgão (p. ex., extrassístolia, insuficiência renal, insuficiência cardíaca etc.).

Sabendo-se que *síndrome* é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem associadamente e podem ser ocasionados por diferentes causas, entende-se por *diagnóstico sindrômico* o reconhecimento de uma síndrome (p. ex., insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal aguda, hipertensão portal, síndrome de Cushing e muitas outras). Não é raro que os diagnósticos sindrômico e funcional sejam a mesma coisa.

Boxe

Utilidade do diagnóstico sindrômico

Do ponto de vista prático, o diagnóstico sindrômico é de grande utilidade, pois permite ao médico restringir suas indagações na fase em que está procurando identificar a doença dentro de uma faixa de possibilidades mais reduzida, dando mais objetividade na condução do caso.

Diagnóstico clínico é o reconhecimento de uma entidade nosológica caracterizada por sua expressão mais importante. Assim, quando se diz “doença de Chagas”, estamos nos referindo a uma entidade cujo elemento principal é o fato de o organismo estar parasitado pelo *Trypanosoma cruzi*, sem que isso queira dizer que haja comprometimento do esôfago, do cólon ou do coração. Se adicionarmos a informação de que há megaesôfago, estaremos fazendo também um diagnóstico anatômico, e se houver referência à insuficiência cardíaca estaremos acrescentando um diagnóstico sindrômico ou funcional.

Chama-se *diagnóstico etiológico* o reconhecimento do agente causal de uma alteração mórbida. Cada vez, torna-se mais relevante o diagnóstico etiológico. Houve época em que o diagnóstico etiológico não era uma preocupação dos médicos, pois pouco ou nada influiria nas possibilidades terapêuticas reconhecer ou não o agente causador de uma afecção. A procura do diagnóstico etiológico é uma das características da medicina moderna e mantém íntima relação com a possibilidade sempre desejada de se instituir tratamento específico. É verdade que muitas doenças ainda têm etiologia desconhecida, a mostrar que o caminho percorrido pela medicina está ainda em seu princípio. A busca constante da etiologia das doenças é uma das alavancas que mais tem feito avançar a ciência médica.

A utilização rotineira da radiografia e de outros métodos de imagem como auxiliar quase obrigatório do diagnóstico fez nascer o diagnóstico radiológico, o ultrassonográfico, o endoscópico, entre outros. Cada método novo de exame que vai sendo introduzido na prática médica conduz a novas maneiras de diagnóstico, e fala-se hoje, correntemente, em diagnóstico laboratorial, sorológico, eletrocardiográfico, endoscópico e assim por diante.

De qualquer modo, deve-se procurar em todo paciente a obtenção de todos os tipos de diagnóstico, pois muito mais rico de informações é o caso no qual se conseguiram todos eles.

Boxe

Fatores de risco

Ultimamente, está ganhando força uma nova maneira de enfocar uma doença: é o reconhecimento e a valorização dos chamados *fatores de risco*, sobre os quais podemos atuar modificando a história natural de uma doença. Reconhecer fatores de risco faz parte do conceito de diagnóstico, em seu mais amplo sentido.

Hipótese diagnóstica

No decorrer do exame clínico é que nasce(m) a(s) hipótese(s) diagnóstica(s). Quanto mais consistente for(em), maior será a probabilidade de bem cuidar do paciente. A escolha correta de exame complementar depende da qualidade da(s) hipótese(s) diagnóstica(s).

Raciocínio diagnóstico

A elaboração de um diagnóstico é um processo intelectual bastante complexo, realmente difícil de ser decomposto em suas várias partes. No entanto, tentaremos pôr em evidência seus componentes principais com a intenção de fornecer aos estudantes, em fase de iniciação clínica, alguns elementos que lhes sejam úteis no desenvolvimento do raciocínio clínico.

O componente básico é a capacidade de coletar os dados que alimentarão o raciocínio. Vale dizer, a capacidade de fazer a anamnese e de executar o exame físico do paciente, para o que se exige certo número de informações e um conjunto de habilidades intelectuais e psicomotoras

O segundo componente que participa desse processo intelectual é a sistematização da coleta de dados. Esta sistematização propicia a possibilidade de fornecer à mente os elementos que irão se articular entre si e com conhecimentos previamente adquiridos

A organização mental dos dados obtidos é a terceira parte do processo, que culminará na elaboração do diagnóstico

A última etapa começa no momento em que se encontra uma conclusão capaz de sintetizar todo o processo iniciado no primeiro contato com o paciente.

Quase sempre é uma ou mais hipótese diagnóstica.

Lembre-se

“Depois da observação e do saber vem o *juízo*, e este é o fator mais importante em matéria de diagnóstico.”

“Todo diagnóstico instantâneo (“queima-roupa”) deve ser condenado. É impressionante, mas perigoso.”

“Em matéria de diagnóstico, nunca se devem dar *palpites*. Uma vez dado ao hábito de seguir *palpites*, estar-se-á perdido em matéria de diagnóstico.”

“Os erros de diagnóstico podem originar-se de má observação, de ignorância e de falta de juízo. Os primeiros nunca são perdoáveis.”

Terapêutica

Terapêutica ou tratamento são todas as medidas usadas com a intenção de beneficiar o paciente.

São inúmeros os métodos e os recursos disponíveis que determinaram o surgimento de expressões como tratamento cirúrgico, tratamento sintomático, tratamento clínico, tratamento paliativo, radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, terapêutica ocupacional ou praxiterapia, e assim por diante.

Prognóstico

Fazer prognóstico é tentar prever o que vai acontecer no futuro do paciente em função da enfermidade que o acometeu. A elaboração de prognóstico depende fundamentalmente do conhecimento da história natural de uma doença e da possibilidade de

modificá-la por qualquer tipo de intervenção terapêutica.

Classicamente, é considerado *quanto à vida e quanto à validade*.

O prognóstico quanto à vida é classificado em *bom, mau e incerto*, estando implícito nas próprias palavras o significado de cada uma. Usa-se, também, a expressão *prognóstico reservado* quando as possibilidades ainda não estão bem definidas, havendo risco de desenlace fatal.

Quanto à validade, fala-se em *capacidade normal e incapacidade parcial ou total*. É necessário ressaltar que cada vez aumenta mais a exigência de correta avaliação da capacidade do paciente em virtude da crescente solicitação para se colocar o trabalho do paciente entre os parâmetros que não podem ser perdidos de vista pelo médico.

Pode ser feito também em função do tempo a vir, falando-se, então, em *prognóstico imediato e prognóstico tardio*.

Estabelecer um prognóstico é tarefa difícil, mas da qual não se pode esquivar. Só é possível fazê-lo a partir de diagnósticos corretos e detalhados.

Boxe

As cinco perguntas que o médico deve fazer a si

A medicina tem muitas limitações, e é necessário utilizá-la em toda sua plenitude. O que se pode dar ao paciente ainda é pouco diante dos inumeráveis problemas sem solução ou com soluções pouco satisfatórias com que nos deparamos constantemente.

Estamos plenamente convencidos de que a essência do trabalho do médico encontra-se no ato de examinar os pacientes, e, por isso, ao término de cada exame, cinco perguntas devem ocorrer ao examinador:

1. A história clínica foi bem tomada?
2. O exame físico foi feito corretamente?
3. Foram aventadas todas as possibilidades diagnósticas?
4. Os exames complementares foram adequadamente pedidos e interpretados com espírito crítico?
5. A relação médico-paciente foi satisfatória?

Quando todas essas perguntas puderem ser respondidas afirmativamente, teremos justificados, de antemão, os inumeráveis erros a que estão sujeitos todos aqueles que têm inteligência bastante para perceber a limitação dos seus próprios conhecimentos.

Boxe

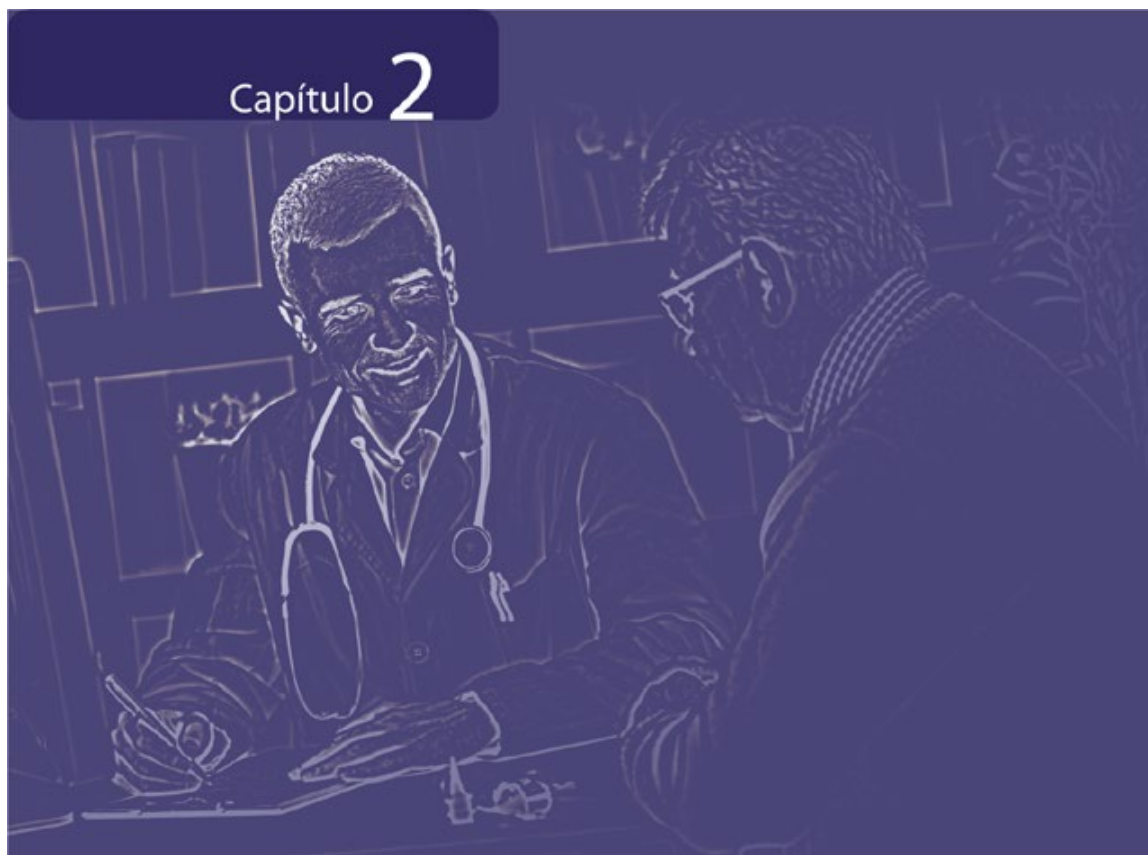
Avaliação da qualidade de vida

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu qualidade de vida (QV) como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores em que vive em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações”.

A qualidade de vida do paciente deve ser um aspecto fundamental da prática de todas as profissões de saúde. Para avaliá-la há questionários genéricos, os quais abrangem os aspectos fundamentais da vida de qualquer pessoa, e os específicos construídos em função das particularidades dos pacientes tais como idosos, vivendo com HIV/AIDS, em diálise, e inúmeras outras condições.

Ao fazer o exame clínico, ato básico de prática médica, deve-se incluir os elementos para avaliação da qualidade de vida dos pacientes.

Capítulo 2



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Laboratório de Habilidades Clínicas

Fábia Maria Oliveira Pinho

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Celmo Celeno Porto

- Introdução
- Infraestrutura para funcionamento do Laboratório de Habilidades
- Objetivos do Laboratório de Habilidades
- Treinamento da semiótica da anamnese
- Treinamento da semiótica do exame físico
- Treinamento de procedimentos e técnicas especiais
- Laboratório de Habilidades de Comunicação
- Laboratório de Habilidades como método de avaliação

INTRODUÇÃO

O processo ensino-aprendizagem da semiologia é realizado, atualmente, em vários cenários, e não somente nos hospitais universitários. Em muitas escolas médicas, para ensinar a elaboração de uma história clínica, os professores contam com pacientes de enfermarias; em outras, já preferem aqueles provenientes de ambulatórios ou unidades básicas de saúde.

A enfermaria é um local privilegiado para o ensino-aprendizagem de técnicas de exame físico, reconhecimento de padrões, demonstração de situações em que o exame físico é alterado, e, por isso mesmo, continua sendo usada com esse objetivo.

Já a história clínica construída a partir de pacientes de ambulatórios ou unidades básicas de saúde, que apresentam problemas menos complexos, permite que o raciocínio hipotético-dedutivo possa ser desenvolvido pelos alunos desde o início do curso médico.

As escolas médicas que adotam metodologias ativas, como PBL (*Problem Based Learning*), utilizam, ainda, o Laboratório de Habilidades (LH) como recurso didático para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para o exame clínico.

O primeiro LH foi instalado em 1975, na Faculdade de Medicina da Universidade de Limburg, em Maastricht, na Holanda. Atividades acadêmicas eram desenvolvidas em função de um programa longitudinal para os diversos tipos de habilidades necessárias à prática médica. No Brasil, o curso de Medicina da Universidade de Londrina instalou, em 1998, o primeiro LH do país. Logo depois, outras escolas médicas brasileiras, seguindo modernas tendências pedagógicas internacionais, começaram a utilizar o LH como um instrumento de apoio pedagógico. Essas escolas apresentam currículo inovador, fundamentado no aprendizado baseado em problemas, teste de progressão, inserção precoce do estudante em atividades de atenção à saúde e desenvolvimento de atitudes médicas.

Boxe

A tendência é que cada escola médica se mobilize para criar seus próprios Laboratório de Habilidades. Além da aquisição de diversos modelos e manequins, é necessária uma equipe dedicada e dotada de capacidade para desenvolver as mais variadas atividades práticas de integração das disciplinas básicas com as clínicas.

INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES

Para criar um LH, é necessário um espaço físico composto de várias pequenas salas que possibilite treinamentos com, no máximo, 10 estudantes, 1 professor e 1 monitor. O espaço físico destinado ao LH deve ser um importante aliado na realização das diversas atividades que ali serão desenvolvidas. É fundamental equipá-lo de modo a simular ambientes pelos quais os estudantes serão expostos durante ou após sua formação acadêmica.

O LH deve conter salas que simulem cenários de enfermaria clínica, enfermaria cirúrgica, enfermaria materno-infantil, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, consultórios médicos (salas-espelho), sala de curativos, sala de emergência, posto de enfermagem, salas de treinamento semiológico, salas de aula, entre outros.

O mobiliário para cada sala deve ser constituído por macas, bancos, negatoscópios, quadros brancos e outros acessórios, dependendo dos objetivos de cada atividade a ser desenvolvida neste espaço.

A aquisição de materiais, equipamentos e manequins para o LH dependerá da disponibilidade da instituição e dos objetivos propostos para o laboratório. Recomenda-se a aquisição de alguns modelos e manequins simuladores para desenvolver e treinar as habilidades necessárias à formação básica do médico. Manequins simuladores que permitem o treinamento de ausculta cardíaca, respiratória e abdominal, tanto normais quanto patológicas, pulsos centrais e periféricos, pressão arterial sistêmica, reanimação cardiopulmonar, reação a medicamentos, entre outros, são necessários, caso o objetivo do LH esteja relacionado com a propedêutica médica. Modelos para treinamento de procedimentos como punção venosa superficial e profunda, punção arterial, cateterismo vesical, sondagem nasogástrica, exame de fundo de olho, toque vaginal, palpação de mamas, toque obstétrico, toque retal e prostático, toracocentese, paracentese, punção lombar, intubação orotraqueal, punção venosa e intramuscular e reanimação cardiopulmonar também são primordiais para cumprir tal objetivo. Do mesmo modo, são indispensáveis diversos materiais, instrumentos e equipamentos, como os de proteção individual (EPI), tubos, cateteres, sondas, agulhas, estetoscópios, esfigmomanômetros, rinoscópios, otoscópios, diapasão, oftalmoscópios, espelho anal e vaginal, lupas, lanternas, termômetros, balanças, macas, banquinhos, martelo de reflexos, entre outros, para treinar as mais variadas habilidades dentro do ambiente do laboratório (ver Quadro 5.1 no Capítulo 5, *Técnicas Básicas do Exame Físico*).

Para o desenvolvimento e treinamento de habilidades de comunicação, será necessário adquirir um sistema de áudio e vídeo com possibilidade de reprodução e transmissão de som e imagem, em ambiente acústico adequado. Para tal objetivo, também é

recomendado contar com atores, profissionais ou estudantes de artes cênicas, para encenar situações fictícias, criadas pelos professores de semiologia, no intuito de aprimorar a relação médico-paciente-famíliares-comunidade.

Boxe

É importante lembrar que as atividades desenvolvidas e treinadas no LH não podem “substituir” o paciente, mas tão somente garantir o treinamento de ações que possam ser sucessivamente repetidas para proporcionar ao aluno maior segurança e postura ética quando ele estiver diante de uma situação real. É nesse ambiente que os alunos treinam o dia a dia da profissão, desenvolvendo as esferas cognitivas (conhecimentos), psicomotoras (habilidades) e afetivas (em suas múltiplas facetas), de maneira plena, antes de lidar com um paciente real.

É primordial a formação de uma equipe de docentes afinada com a metodologia e capaz de criar roteiros de aulas e cenas/situações para o desenvolvimento e treinamento das habilidades necessárias a uma sólida formação médica; outro passo fundamental é contar com funcionários capacitados para o controle do acervo – que deve ser mantido em local arejado e seguro –, e realização de manutenção periódica.

Por fim, é indispensável a formação de uma equipe de monitores, composta de estudantes em nível mais avançado, para auxiliar durante as aulas e avaliações.

Quanto mais amplo e completo for o LH, maior será sua participação no projeto pedagógico do curso e melhores serão seus resultados. Atualmente, um LH integrado e ativo pode ser utilizado não somente na semiologia médica, mas desde o início do curso, nas atividades comunitárias e preventivas, passando pelas atividades ambulatoriais, cirúrgicas e de terapia intensiva, pela conclusão do curso médico (internato) e, por fim, atingindo a pós-graduação e a educação continuada, direcionadas a médicos já formados.

Os diversos centros universitários de habilidades e simulação, espalhados por diversos países do mundo, divulgam que o custo-benefício da criação de um LH é mais que satisfatório. Sabe-se que o treinamento em manequins e simuladores, após implantação plena do LH, é considerado econômico, já que os equipamentos são idealizados para suportar um grande número de atividades e utilização por parte dos estudantes.

OBJETIVOS DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES

No LH, é possível fazer o treinamento das técnicas de construção de uma história clínica e do exame físico antes do contato do estudante com o paciente.

Inicialmente, o professor orienta como fazer a anamnese, e, em seguida, o aluno a desenvolve utilizando-se de pacientes-atores que encenam a história clínica fictícia. As histórias clínicas encenadas pelos atores são escritas sob a forma de “cenas teatrais” pelos professores, com o intuito de alcançar os objetivos de aprendizagem propostos pela disciplina no que se refere aos conhecimentos teóricos, às habilidades de comunicação e às atitudes éticas e humanistas (Figura 2.1A).



Figura 2.1 Laboratório de Habilidades.

Já o exame físico é ensinado aos estudantes e repetidamente treinado, a partir de manequins e modelos que simulam reações humanas em diversas situações clínicas, ou também pacientes-atores como alternativa, quando não for possível a realização do exame no manequim (Figura 2.1B).

Boxe

Os manequins e os atores profissionais nunca irão substituir os pacientes, mas apenas antecedem o contato com eles, que, neste caso, será realizado nas instituições que prestam assistência médica.

Os objetivos específicos desta metodologia são:

Desenvolver a postura ética na relação médico-paciente

Desenvolver a capacidade de realizar uma anamnese completa

Desenvolver a habilidade de realizar inspeção, palpação, percussão e ausculta

Desenvolver a habilidade de realizar o exame físico geral

Desenvolver a habilidade de realizar a semiotécnica dos exames específicos cardiovascular, respiratório, abdominal, dermatológico, neurológico, locomotor, endócrino-reprodutor e geniturinário masculino e feminino.

Boxe

Vantagens do Laboratório de Habilidades

No LH, desenvolve-se uma série de atividades que fortalecem o aprendizado e podem ser repetidas individualmente sob orientação de um professor. Vantagens na utilização deste laboratório são:

Complexas situações clínicas podem ser desenvolvidas e simuladas

Os procedimentos podem ser repetidos muitas vezes, o que seria inaceitável para os pacientes

O erro pode ser corrigido de imediato, sem haver constrangimento por parte do estudante e do paciente

A dependência da presença de pacientes no momento do treinamento é excluída

Pode representar um fator de motivação importante tanto para adquirir conhecimentos como habilidades

Sendo um espaço de treinamento e desenvolvimento de habilidades, oferece maior segurança ao estudante quando for examinar o paciente real.

TREINAMENTO DA SEMIOTÉCNICA DA ANAMNESE

A semiotécnica da anamnese é ensinada em um ambiente, dentro do LH, que simula um consultório médico. Esse espaço é composto de um consultório tipo sala-espelho (Figura 2.2) com corredores laterais que circundam esta sala.

Durante a consulta médica simulada, o aluno-médico e o paciente-ator ficam dentro do consultório médico, em um ambiente pseudoprivativo. O professor e os alunos-observadores, sempre em pequenos grupos (8 a 10 alunos), ficam nos corredores laterais ao consultório, assistindo à consulta – do início ao fim –, porém sem serem vistos pelo aluno-médico ou paciente-ator.

A história clínica encenada pelo paciente-ator segue um *script* criado pelos professores de semiologia médica, focado nos objetivos a serem alcançados pelos estudantes durante a elaboração de uma anamnese. Os pacientes-atores podem ser atores profissionais ou estudantes/estagiários de artes cênicas.

Enquanto o aluno-médico conversa com o paciente-ator e desenvolve sua anamnese, todos os outros alunos observam a cena e também preparam as suas próprias. Depois que o aluno-médico termina sua anamnese, o professor permite que os alunos observadores façam perguntas complementares ao paciente-ator, que, porventura, não tenham sido questionadas pelo aluno-médico durante sua entrevista. Ao término da entrevista simulada, todos os acadêmicos se reúnem com o professor para comentar acertos e falhas, esclarecer dúvidas e discutir situações relacionadas com atitudes semiológicas e éticas que, por acaso, tenham surgido durante a consulta.



Figura 2.2 Consultório tipo sala-espelho.

Uma alternativa bastante usual de estabelecer esse treinamento é a filmagem da cena em que o aluno-médico realiza a anamnese com o paciente-ator em *videotape*. Tal cena poderá ser assistida posteriormente pelos estudantes e o professor, apontando acertos e falhas ocorridas durante a consulta simulada.

Boxe

É de extrema importância que o professor, em algumas ocasiões, faça o papel do médico na consulta simulada. A maioria dos estudantes tem a figura do professor como exemplo e mentor, seguindo, assim, sua prática e conduta.

TREINAMENTO DA SEMIOTÉCNICA DO EXAME FÍSICO

A semiotécnica do exame físico é ensinada em uma sala ampla, dentro do LH, na qual o professor demonstra a técnica nos manequins/modelos simuladores, nos pacientes-atores ou nos próprios alunos e, em seguida, permite que os estudantes repitam as manobras por várias vezes, até dominarem a técnica (Figura 2.3).

Esse encontro entre professor e alunos, em pequenos grupos, constitui um momento muito rico, pois há uma integração entre conhecimento teórico aprendido, prática assistida e, posteriormente, treinada, bem como posturas eticamente discutidas. Desse modo, os acadêmicos que realizam a semiotécnica no LH tornam-se mais bem preparados para o momento de lidar diretamente com um paciente real nas unidades de assistência à saúde, sejam ambulatoriais, sejam hospitalares.

No LH, podem ser desenvolvidas várias técnicas semiológicas nos manequins/modelos simuladores, destacando-se as seguintes:

Semiotécnica das técnicas básicas do exame físico: inspeção, palpação, percussão e ausculta

Semiotécnica do exame físico geral: temperatura, medidas antropométricas, hidratação, mucosas e edema

Semiotécnica do sistema cardiovascular: aferição da pressão arterial (Figura 2.4) e da frequência cardíaca, ausculta cardíaca normal e patológica, pulsos centrais e periféricos

Semiotécnica do sistema respiratório: percussão, palpação e ausculta respiratória normal e patológica, frequência respiratória

Semiotécnica do abdome: palpação, percussão e ausculta abdominal normal e patológica

Semiotécnica dermatológica: inspeção das lesões da pele e fâneros (Figura 2.5)

Semiotécnica do sistema neurológico: manobras e reflexos, exame oftalmoscópico (Figura 2.6), exame otoscópico (Figura 2.7)

Semiotécnica do sistema locomotor: manobras e reflexos

Semiotécnica do sistema endócrino-reprodutor-urinário, masculino e feminino: palpação de mamas (Figura 2.8), toque vaginal e obstétrico (Figura 2.9), toque retal para avaliação prostática (Figura 2.10).

TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS ESPECIAIS

No LH, podem ser desenvolvidos, nos manequins/modelos simuladores, vários procedimentos e técnicas, entre eles:

Intubação orotraqueal (Figura 2.11)

Reanimação cardiopulmonar (Figura 2.12)

Punção arterial

Punção venosa central e periférica (Figura 2.13)

Punção lombar (Figura 2.14)

Toracocentese

Paracentese

Sondagem vesical (Figura 2.15)

Sondagem nasogástrica (Figura 2.16)

Diluição de medicamentos (Figura 2.17)

Lavagem das mãos (Figura 2.18)

Uso de equipamentos de proteção individual (Figura 2.19).

No LH, os estudantes também têm a oportunidade de manusear adequadamente aparelhos médicos que compõem os diversos tipos de ambientes hospitalares, como monitor cardíaco, cardioversor, ventilador mecânico, oxímetro de pulso, entre outros.



Figura 2.3 Demonstração, do professor aos alunos, da semiotécnica do exame físico no manequim.



Figura 2.4 Aferição da pressão arterial em manequim simulador.



Figura 2.5 Inspeção das lesões da pele utilizando lupa.



Figura 2.6 Exame oftalmoscópico em modelo.



Figura 2.7 Exame otoscópico em modelo.



Figura 2.8 Exame de mamas em modelos.

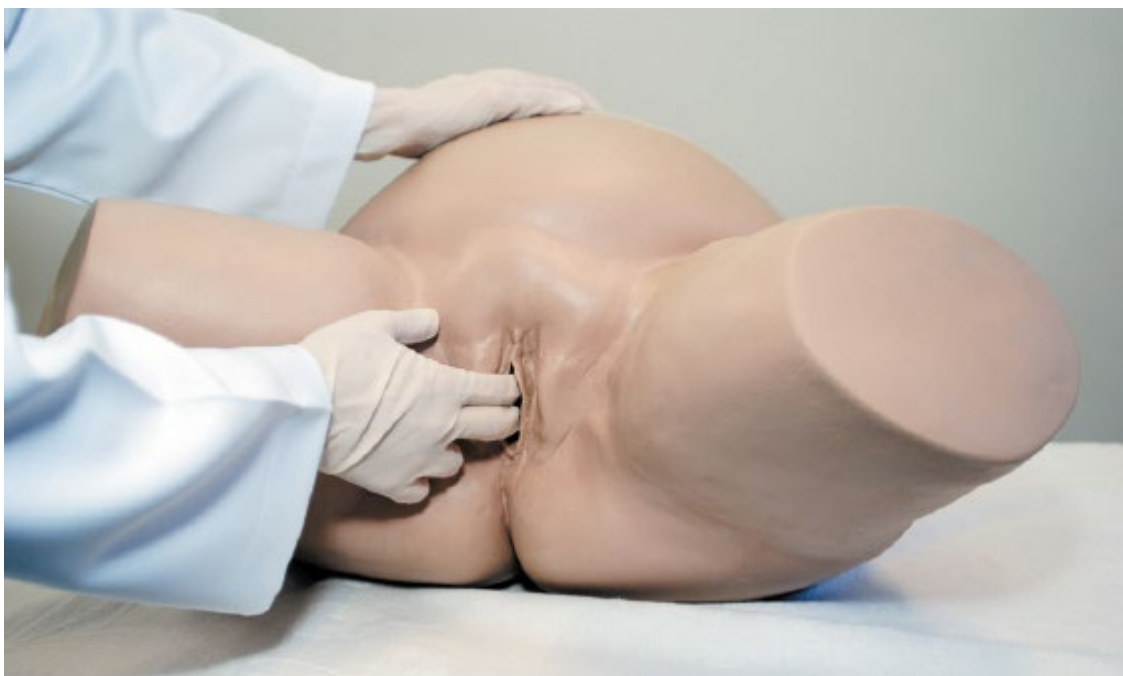


Figura 2.9 Toque vaginal e obstétrico em modelo.



Figura 2.10 Toque retal para avaliação prostática em modelo.



Figura 2.11 Técnica de intubação orotraqueal.



Figura 2.12 Reanimação cardiopulmonar em manequim simulador.



Figura 2.13 Técnica de punção venosa periférica em modelo.



Figura 2.14 Técnica de punção lombar em modelo.



Figura 2.15 Sondagem vesical em manequim simulador.



Figura 2.16 Sondagem nasogástrica em manequim. Alunos realizando teste de localização da sonda.



Figura 2.17 Aluna aprendendo a técnica de diluição de medicamentos.



Figura 2.18 Lavagem das mãos.



LABORATÓRIO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO

Comunicação efetiva e interação são hoje apontadas como competências clínicas, essenciais para exercício de uma boa medicina. A comunicação é uma habilidade clínica fundamental na prática médica e pode ser ensinada e aprendida.

Para ser eficaz, a abordagem biopsicossocial, adotada em diversos cursos médicos, necessita de um forte componente comunicacional nas diversas fases da relação médico-paciente, especificamente, na consulta, nas atividades de educação para a saúde e na relação com os familiares do paciente.

Sabe-se que as consequências relacionais, especialmente habilidades comunicacionais, empatia e construção de vínculo, são fatores que interferem em uma adequada relação médico-paciente-familiar.

Adequada comunicação e relação médico-paciente tem impacto significativo no cuidado e no aumento na qualidade da atenção à saúde. Já a falta de habilidade de comunicação está relacionada a má prática clínica e erros médicos.

Desenvolver a habilidade de se comunicar com o paciente e seus familiares faz parte do trabalho de construção da consciência da responsabilidade social do trabalho médico, fundamental para que ele desempenhe seu papel com dignidade.

Assim, algumas escolas médicas, têm criado o Laboratório de Habilidades de Comunicação. Este laboratório tem por objetivo proporcionar ao estudante conhecimento e treinamento nas habilidades de comunicação, necessárias para se estabelecer uma boa relação médico-paciente-familiar-equipe, visando ao desempenho efetivo e eficiente da prática médica.

Objetivos do Laboratório de Habilidades de Comunicação

Sensibilizar o aluno quanto aos diferentes aspectos da comunicação e sua importância na profissão médica

Discutir sobre a comunicação verbal e não verbal

Ajudar o aluno a lidar com situações consideradas “difíceis”, sistematizando observações e procedimentos para esse fim

Desenvolver no aluno a capacidade de comunicar boas e más notícias

Desenvolver competências e habilidades de comunicação nas relações interpessoais com o paciente, com sua família e com a equipe multiprofissional

Refletir sobre o cuidado com o paciente gravemente enfermo sob cuidados intensivos e/ou sob cuidados paliativos

Refletir sobre a terminalidade da vida, a morte e o morrer e discutir como comunicar-se com pacientes, familiares e a equipe nessas situações especiais.

Na educação médica, é consenso que a habilidade de comunicação deve ser desenvolvida ao longo de toda a graduação, de maneira sistematizada, em diversos cenários de ensino e, preferencialmente, em pequenos grupos, utilizando metodologias ativas.

Diversas *metodologias ativas*, sempre em pequenos grupos de alunos, podem ser adotadas para se alcançarem os objetivos de um Laboratório de Habilidades de Comunicação. São elas:

Discussão de textos e casos

Observação do aluno junto ao paciente (tempo real)

Filmagem do aluno com o paciente e discussão

Medicina narrativa (leitura e escrita)

Dramatização (psicodrama)

Role-playing

Discussão de filmes e/ou cenas curtas

Atividades lúdicas

Autorreflexão e autoavaliação

Aprendizagem baseada em problemas

Oficinas de habilidades interpessoais

Grupo Balint.

Ressalta-se que a qualidade da comunicação na relação médico-paciente favorece os índices de satisfação do paciente com a consulta, a adesão ao tratamento e, principalmente, a tomada de decisões consideradas “difíceis”, tanto para o profissional quanto para o paciente e seus familiares.

A experiência do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) com o Laboratório de Habilidades de Comunicação (Habcom) no internato médico tem sido inovadora e gratificante (Figura 2.20). A equipe de professores, formada por profissionais de diversas áreas do conhecimento, como medicina, psicologia, filosofia, sociologia, teologia e gestão, tem promovido possibilidades de ensino-aprendizagem bastante satisfatórias no processo de aprendizagem das habilidades de comunicação.

LABORATÓRIO DE HABILIDADES COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

No contexto educacional, a avaliação implica obter informações, por meio da aplicação de métodos específicos, que podem subsidiar a tomada de decisões que interessam tanto ao processo do aprendizado como ao estudante. A avaliação pode ser considerada ainda um processo de aprendizagem formativa.

Em relação à avaliação do estudante de medicina, pode-se adotar o conceito genérico de que esta é um processo de coleta de informações, realizado por meio de atividades sistemáticas e formais, que permite saber o que o estudante conhece, sabe fazer e, efetivamente, faz de modo adequado, de maneira que se possa interferir no processo educacional, corrigindo distorções e reforçando aspectos positivos. Evidentemente, essa interferência deve repercutir sobre o sujeito principal do processo educacional, o estudante de medicina. Vivenciar uma avaliação formativa pode fornecer ao estudante uma aprendizagem ativa de pontos altamente relevantes do fazer médico.

Nos últimos anos, o LH também tem sido utilizado no processo de avaliação nos cursos médicos, principalmente nos 2 anos finais do curso – o internato.

O OSCE (*Objective Structured Clinical Examination* – Exame Clínico Estruturado por Estações) é uma técnica válida e efetiva para se avaliar as habilidades médicas em um curso de medicina e é, em geral, realizado em um LH.

No OSCE, os estudantes são avaliados em seus conhecimentos científicos, competências clínicas e/ou cirúrgicas, habilidades de comunicação e de desenvolvimento do fazer médico e atitudes ético-relacionais, bem como de tomadas de decisão, tópicos importantes na prática médica.



Figura 2.20 Aula no Laboratório de Habilidades de Comunicação.

O OSCE é realizado em estações (10 a 20 estações) em que cada estudante pode ser avaliado em diversos tópicos. Em cada estação, os alunos examinados são solicitados a desempenhar tarefas clínicas distintas, como obter uma história clínica, realizar um exame físico geral ou específico, executar uma manobra ou um procedimento médico, avaliar e interpretar exames laboratoriais, avaliar uma radiografia ou um traçado eletrocardiográfico, instruir um paciente sobre seu diagnóstico e/ou tratamento, todos com avaliação de uma adequada relação médico-paciente e raciocínio clínico.

Durante a avaliação, os alunos permanecem em cada estação por um tempo predeterminado, onde realizam a tarefa

solicitada sob a supervisão de um professor, empregando um instrumento de registro, tipo *checklist* (lista de verificações) (Figura 2.21). Ao final do tempo previsto, quando se emite um sinal sonoro audível para todos, os alunos passam para a estação seguinte, alterando a ocupação das várias estações. Nesse tipo de avaliação podem ser utilizados manequins ou modelos simuladores, bem como atores profissionais, alunos voluntários dos cursos de medicina e de artes cênicas ou professores, para o papel de paciente-ator (Figura 2.22).



Figura 2.21 Professor avaliando aluno em uma estação do OSCE (Exame Clínico Estruturado por Estações), montada com manequim simulador.



Figura 2.22 Professor avaliando aluno em uma estação do OSCE (Exame Clínico Estruturado por Estações), montada com

paciente-ator.

Essa avaliação tem sido utilizada amplamente no internato médico, bem como em nível de pós-graduação, como, por exemplo, nas provas de seleção de residência médica. Atualmente, há uma tendência das escolas médicas brasileiras em adotar o OSCE nas avaliações clínicas durante todo o curso, desde o 1º ano, sob o modelo de mini-OSCE.

Uma variação do OSCE é um sistema denominado VOSCE (OSCE virtual), desenvolvido por Lok e sua equipe (2006). É um programa que utiliza personagens virtuais para ajudar na construção das habilidades de comunicação médico-paciente. O ambiente permite que os estudantes possam entrevistar uma paciente virtual chamada Diana (*Digital Animated Avatar*), usando discurso e gestos. Um instrutor, também virtual, fornece retorno imediato sobre o desempenho do aluno.

Capítulo 3



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Método Clínico

Fábia Maria Oliveira Pinho

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Denise Viuniski da Nova Cruz

Arnaldo Lemos Porto

Celmo Celeno Porto

- Introdução
- Posições do paciente e do examinador para o exame clínico
- Divisão da superfície corporal para o exame clínico
- Anamnese
- Exame físico
- A aula prática e o encontro clínico

INTRODUÇÃO

Houve, em determinada época, quem dissesse que o método clínico acabava de ser superado pelos recursos tecnológicos e, para simbolizar esta afirmativa, um radiologista colocou sobre sua mesa, dentro de uma redoma, um estetoscópio e uma antiga “valva” (nome arcaico do espéculo vaginal), dizendo que aqueles instrumentos não passavam de meras antiguidades.

A evolução da medicina, no entanto, mostrou que aquele médico cometera um grosseiro erro de previsão ao superestimar o potencial diagnóstico dos raios X e dos aparelhos de uma maneira geral. O símbolo da tecnologia moderna é o computador eletrônico, e, quando se vê seu aproveitamento na elaboração da própria anamnese, concluímos que o método clínico, em vez de se tornar obsoleto, está cada vez mais vivo. Na verdade, mudam-se apenas alguns procedimentos e determinadas maneiras para sua aplicação, mas o essencial permanece, formando o arcabouço que caracteriza a arte clínica, cuja base continua sendo o exame do paciente.

O exame clínico tem papel especial em três pontos cruciais da prática médica ou de outra profissão na área da saúde:

Estabelecer uma boa relação médico-paciente

Formular hipóteses diagnósticas (raciocínio clínico)

Tomar decisões.

A iniciação ao exame clínico tem suas bases em alguns procedimentos que constituem o método clínico (Figura 3.1). São eles:

Entrevista

Inspeção

Palpação

Percussão

Ausculta

Uso de alguns instrumentos e aparelhos simples.

A aferição do peso e da altura é um componente importante do método clínico, pois indica o estado nutricional do paciente e conseqüentemente sua evolução ao longo da doença. Nos ambientes hospitalares e ambulatoriais ocorrem casos de desnutrição ou risco nutricional, os quais, muitas vezes, não são avaliados. O quadro nutricional do paciente é um importante aspecto na formulação de hipóteses diagnósticas e na tomada de decisões, portanto não pode ser esquecido.

Boxe

Observações fundamentais

Adquirir as informações essenciais e desenvolver as habilidades psicomotoras básicas para utilizar o *método clínico* devem constituir os objetivos fundamentais quando se inicia o estudo da propedêutica médica, já que todo o restante depende disso.

Não se espera que o estudante consiga dominar o *método clínico* com total desenvoltura nesta fase de seu aprendizado; isso leva tempo, depende de dedicação, esforço continuado e longo treinamento. Contudo, as bases do método devem ficar firmemente assentadas: sem elas, o desenvolvimento do aprendizado do exame do paciente torna-se mais difícil, mais lento e sempre será incompleto, não havendo possibilidade de suprir sua falta por meio de extensos conhecimentos obtidos de exames complementares de qualquer natureza.

POSIÇÕES DO PACIENTE E DO EXAMINADOR PARA O EXAME CLÍNICO

Para executar o exame físico, costuma-se usar fundamentalmente as seguintes posições:

Decúbito dorsal (Figura 3.2)

Decúbito lateral (direito e esquerdo) (Figuras 3.3 e 3.4)

Decúbito ventral (Figura 3.5)

Posição sentada (no leito, em uma banqueta ou cadeira) (Figura 3.6)

Posição ortostática (Figura 3.7).

O examinador deve se posicionar de modos diferentes, ora de um lado, ora de outro, de pé ou sentado, procurando sempre uma posição confortável que lhe permita máxima eficiência em seu trabalho e mínimo incômodo para o paciente. A recomendação para o examinador se posicionar à direita do paciente é clássica; contudo, não quer dizer que ele deva permanecer sempre nesta posição. O examinador deverá deslocar-se, livremente, como lhe for conveniente.

DIVISÃO DA SUPERFÍCIE CORPORAL PARA O EXAME CLÍNICO

Para a localização dos achados semióticos na superfície corporal, utiliza-se uma nomenclatura padronizada de acordo com a divisão proposta pela Comissão Internacional de Nomenclatura Anatômica contida na *Nômina Anatômica*.

O Quadro 3.1 e as Figuras 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 mostram como a superfície do corpo humano podem ser divididas.

ANAMNESE

Entrevista é uma técnica de trabalho comum às atividades profissionais que exigem o relacionamento direto do profissional com sua clientela, como é o caso do repórter, do assistente social, do psicólogo, do enfermeiro, do nutricionista, do cirurgião dentista e do médico.

A entrevista, em sentido lato, pode ser definida como um processo social de interação de duas ou mais pessoas que se desenvolve diante de uma situação que exige necessariamente um ambiente no qual as pessoas interajam. A situação apresenta elementos de orientação para a ação das pessoas envolvidas na entrevista, quais sejam os objetos físicos (o local de trabalho, os instrumentos), os objetos culturais (os conhecimentos prévios, os valores, as crenças) e os objetos sociais (as pessoas envolvidas na entrevista).

A entrevista no exercício das profissões da saúde é um processo social de interação profissional-paciente (e/ou seu acompanhante), diante de uma situação que envolve um ou mais problemas de saúde.

A iniciativa da consulta, regra geral, cabe ao paciente, que, ao sentir-se convicto de que algo não está bem consigo, decide procurar o profissional de saúde (médico, odontólogo, psicólogo, nutricionista) para confirmar ou não a sua situação. Se a iniciativa cabe ao paciente, sua plena execução cabe ao médico ou a outro profissional de saúde ou mesmo a equipe multidisciplinar, conforme o caso requerer.

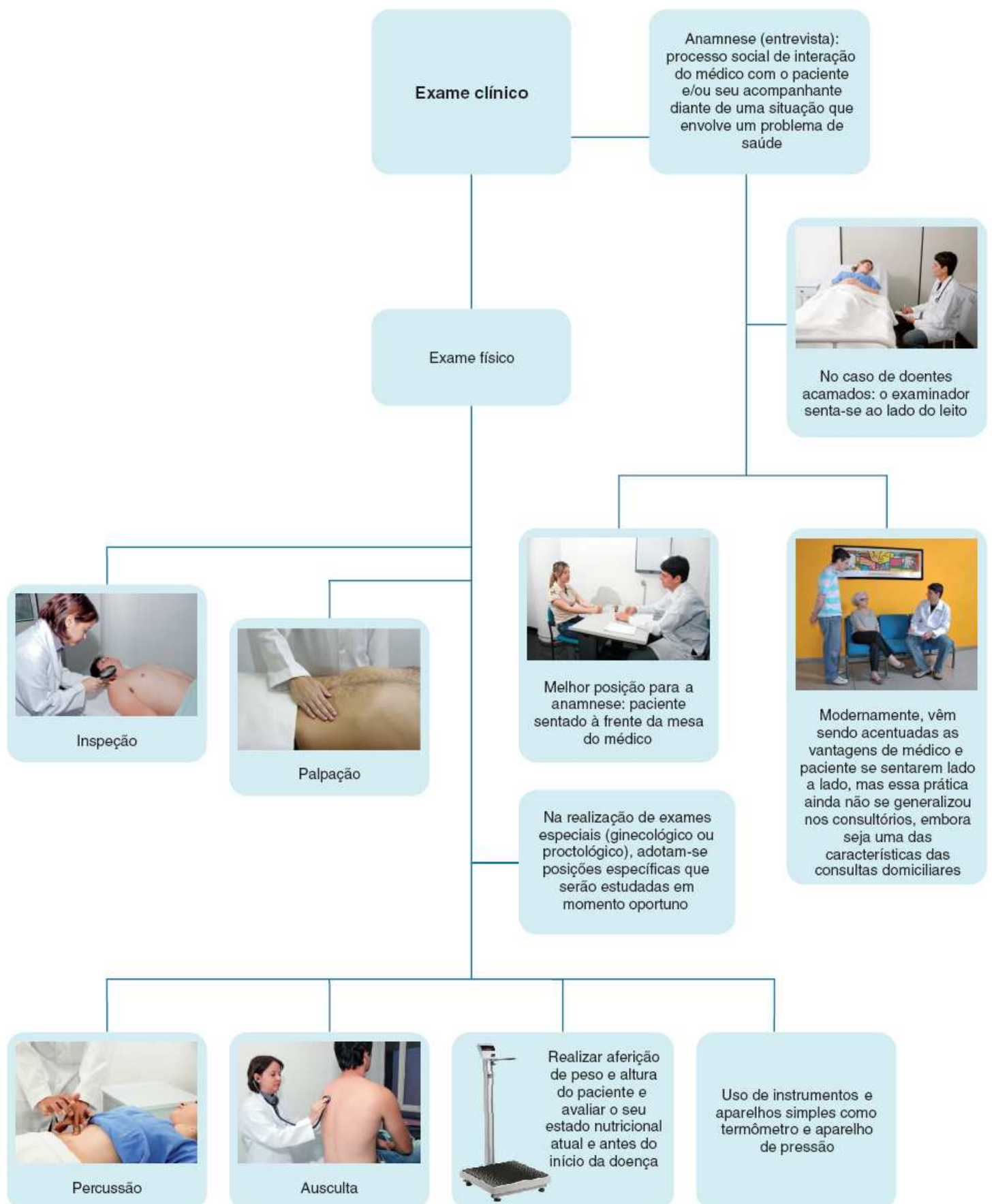


Figura 3.1 Procedimentos básicos do método clínico.



Figura 3.2 Decúbito dorsal: paciente em decúbito dorsal, com os membros superiores repousados sobre a maca em mínima abdução.



Figura 3.3 Decúbito lateral direito: paciente em decúbito lateral direito com o membro superior esquerdo repousado sobre seu corpo e o membro superior direito fletido em abdução.



Figura 3.4 Decúbito lateral esquerdo: paciente em decúbito lateral esquerdo com o membro superior direito repousado sobre seu corpo e o membro superior esquerdo fletido em abdução.



Figura 3.5 Decúbito ventral: paciente em decúbito ventral com os membros superiores sob o rosto, o qual se encontra fletido para o lado.



Figura 3.6 Sentado (no leito, em uma banqueta ou em uma cadeira): paciente sentado com as mãos repousadas sobre as coxas.



Figura 3.7 Posição ortostática: paciente de pé, com os pés moderadamente afastados um do outro e os membros

superiores pendendo naturalmente junto ao corpo.

Quadro 3.1

Divisão da superfície corporal em regiões.

I. Regiões da cabeça

1. Frontal; 2. Parietal; 3. Occipital; 4. Temporal; 5. Infratemporal

II. Regiões da face

6. Nasal; 7. Oral; 8. Mentoniana; 9. Orbitária; 10. Infraorbitária; 11. Jugal (da bochecha); 12. Zigomática; 13. Parotidomasseterina

III. Regiões do pescoço

14. Anterior do pescoço; 15. Esternocleidomastóidea; 16. Lateral do pescoço; 17. Posterior do pescoço

IV. Regiões do peito

18. Infraclavicular; 19. Mamária; 20. Axilar; 21. Eterna

V. Regiões do abdome

22. Hipocôndrica; 23. Epigástrica; 24. Lateral (Flanco); 25. Umbilical; 26. Inguinal (Fossa ilíaca); 27. Pubiana ou hipogástrica

VI. Regiões do dorso

28. Vertebral; 29. Sacra; 30. Escapular; 31. Infraescapular; 32. Lombar; 33. Supraescapular; 34. Interescapulovertebral

VII. Região perineal

35. Anal; 36. Urogenital

VIII. Regiões do membro superior

37. Deltóidea; 38. Anterior do braço; 39. Posterior do braço; 40. Anterior do cotovelo; 41. Posterior do cotovelo; 42. Anterior do antebraço; 43. Posterior do antebraço; 44. Dorso da mão; 45. Palma da mão

IX. Regiões do membro inferior

46. Glútea; 47. Anterior da coxa; 48. Posterior da coxa; 49. Anterior do joelho; 50. Posterior do joelho; 51. Posterior da perna; 52. Anterior da perna; 53. Calcaneana; 54. Dorso do pé; 55. Planta do pé

O profissional de saúde, ao conhecer os fatores capazes de interferir na entrevista, poderá criar condições que favoreçam uma integração maior entre ele e seu paciente, tornando possível uma interação “ótima”. Isso será alcançado se o profissional de saúde conseguir do paciente uma predisposição positiva para fornecer informações durante toda a entrevista.

O ambiente (consultório, ambulatório, enfermaria, quarto de hospital ou a própria residência do paciente) e o instrumental utilizado pelo profissional de saúde são os objetos físicos que interferem na anamnese. Dessa maneira, um ambiente adequado (silencioso, agradável, limpo) e um instrumental apropriado (aparelhos que funcionem bem, por exemplo) são condições indispensáveis para uma boa entrevista.

O emprego de gravadores não é conveniente na entrevista clínica, pois poderá atuar como forte inibidor para o paciente. As anotações de próprio punho do profissional de saúde continuam sendo a melhor maneira de registrar as informações prestadas pelo paciente. O registro digital é utilizado atualmente como alternativa para listar os dados da entrevista médica; neste caso, o profissional de saúde ou o estudante deve estar atento para não dispensar mais importância à máquina que ao paciente. O aluno

iniciante costuma se valer de um roteiro impresso para conduzir a anamnese; a condição de iniciante justifica tal procedimento (Figura 3.13).

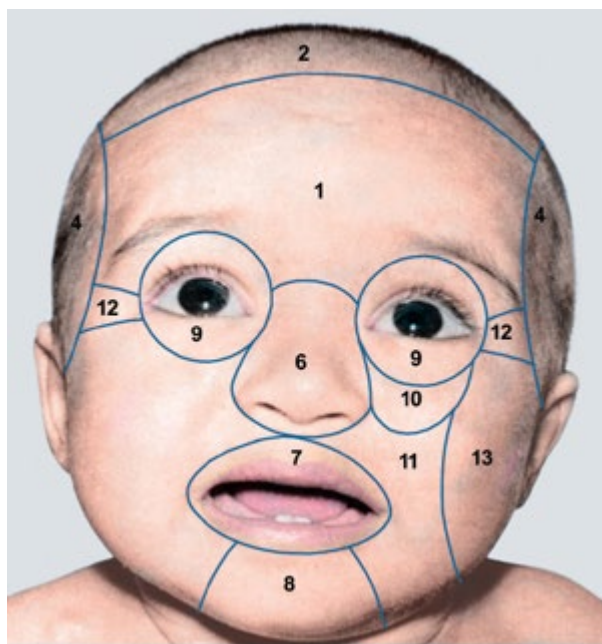


Figura 3.8 Divisão da superfície corporal em regiões: cabeça e face (vista anterior).

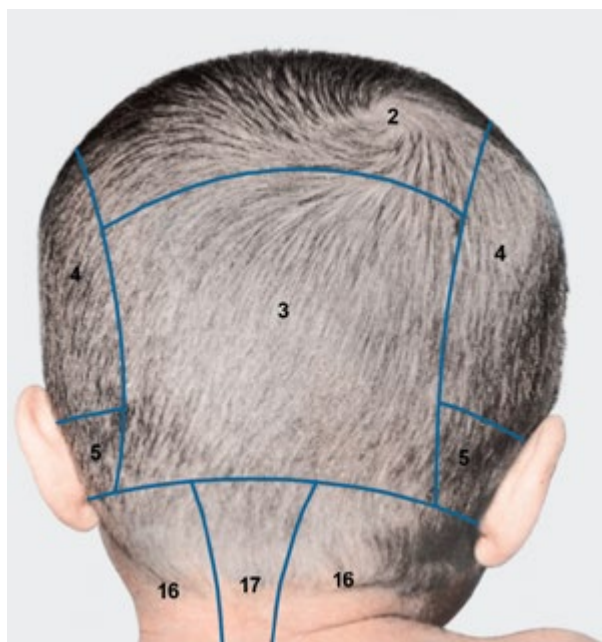


Figura 3.9 Divisão da superfície corporal em regiões: cabeça e pescoço (vista posterior).

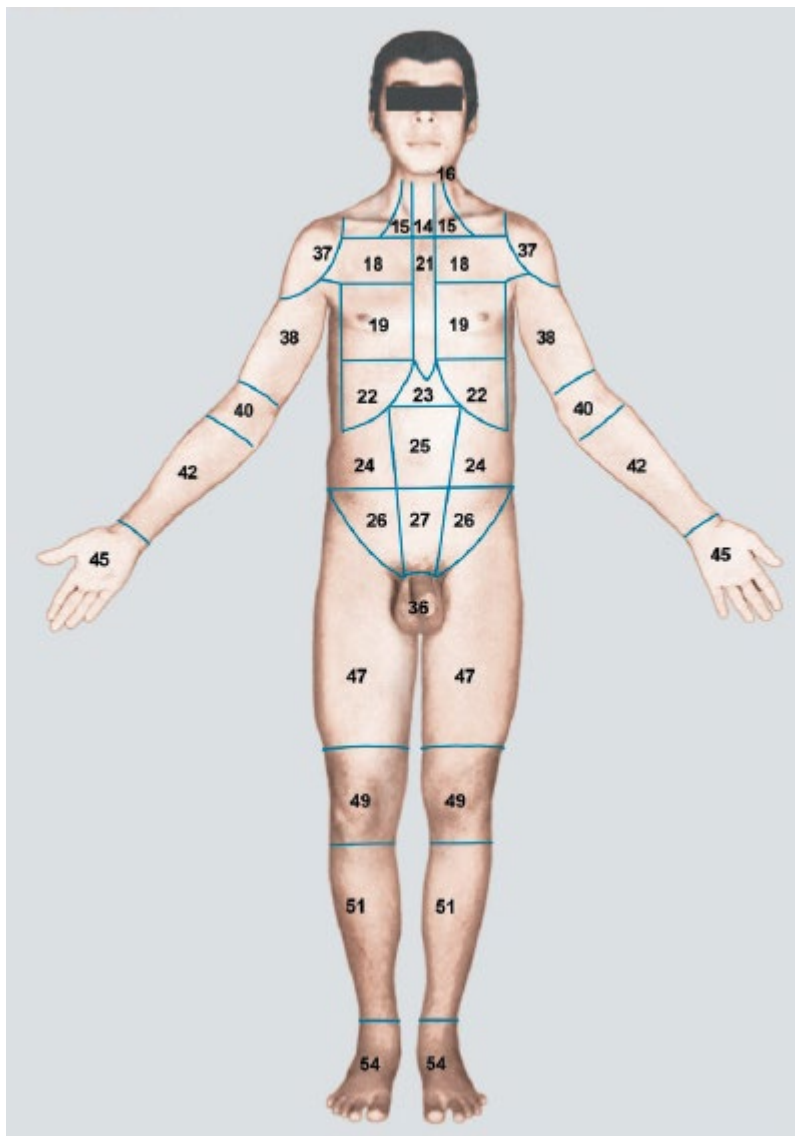


Figura 3.10 Divisão da superfície corporal em regiões: pescoço, tórax, abdome, membros superiores e inferiores (vista anterior).

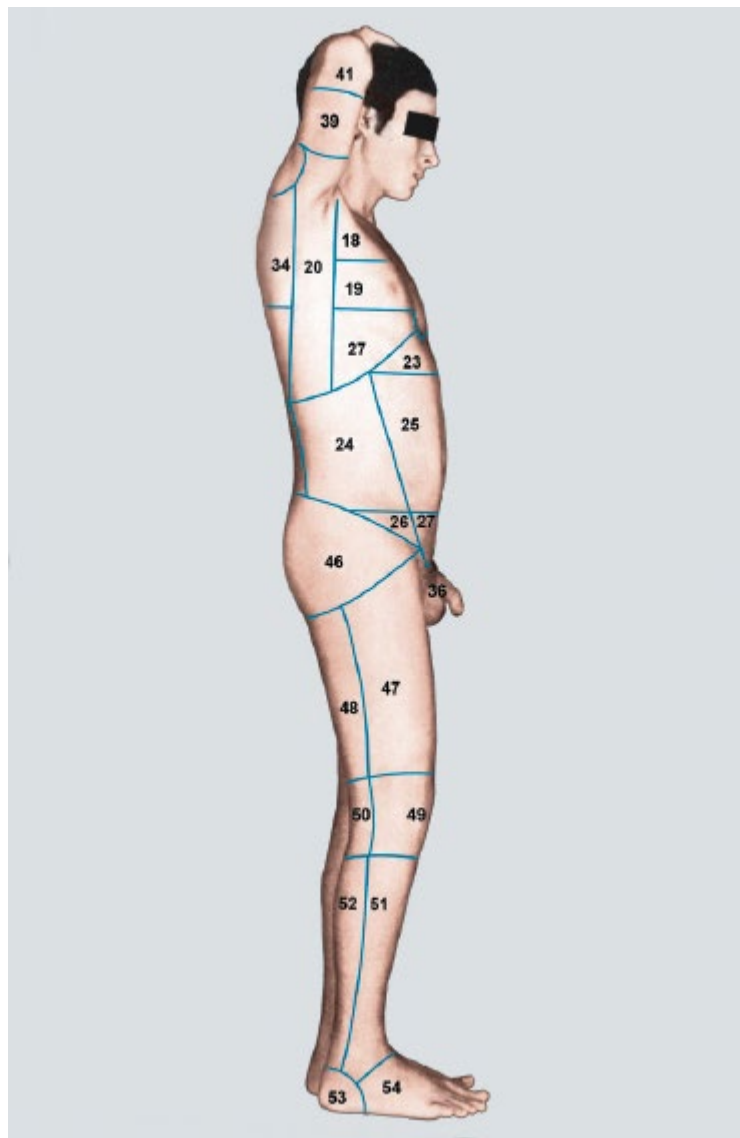


Figura 3.11 Divisão da superfície corporal em regiões: tórax, abdome, dorso, membros superiores e inferiores (vista lateral).

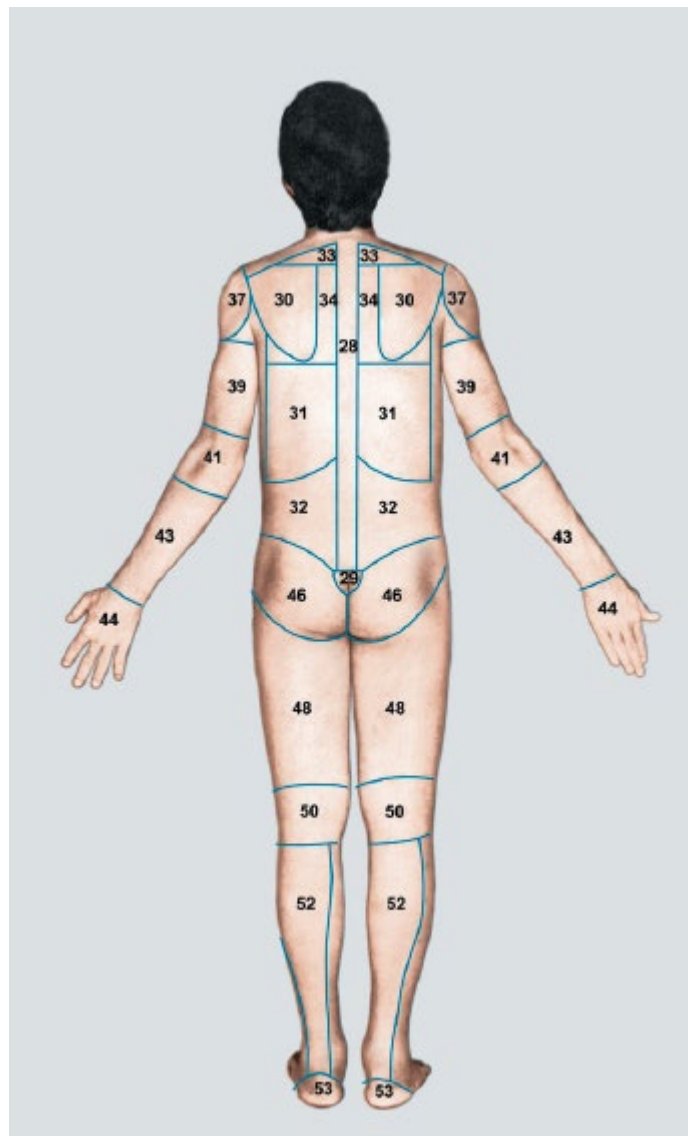


Figura 3.12 Divisão da superfície corporal em regiões: tórax, dorso, membros superiores e inferiores (vista posterior).

Valorizando o ambiente e o instrumental, criam-se condições favoráveis para a interação do profissional de saúde com o paciente.

Boxe

A melhor exemplificação da necessidade de ambiente adequado é bem conhecida dos médicos: são as chamadas “consultas de corredor” e as “consultas em eventos sociais”, quando os “clientes” abordam o médico ao passarem por ele pelos corredores dos hospitais ou o interrogam durante as festas às quais o médico comparece. Tais “consultas” são inevitavelmente incompletas e tirar conclusões diagnósticas delas é um ato de adivinhação. Desde logo os estudantes devem aprender que o corredor do hospital e os salões de festa são ambientes inadequados para a entrevista médica.

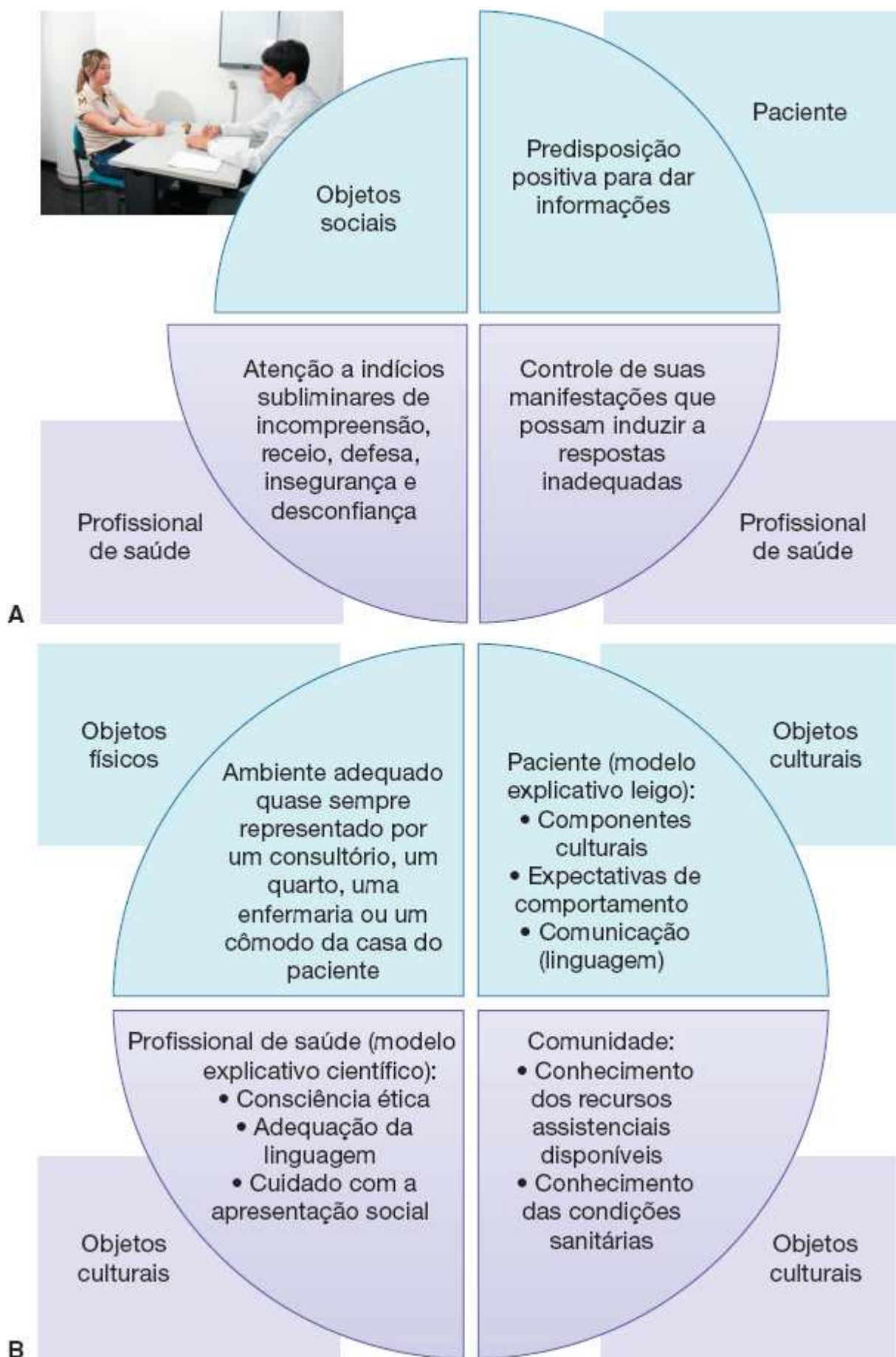


Figura 3.13 Elementos que interferem na anamnese.

A cultura fornece aos membros de uma sociedade, além do instrumental básico de comunicação entre eles – que é a língua –, os padrões de comportamento social que devem orientar suas ações.

O médico e o paciente, regra geral, têm maneiras distintas de sentir, pensar e agir: o médico apoia suas atitudes, como

profissional, em um quadro de referência científico, enquanto o paciente apoia suas atitudes em um modelo explicativo leigo. A utilização de quadros de referências distintos para orientar as ações pode dificultar o desenrolar da entrevista entre o médico e o paciente; assim, deve o médico preocupar-se não só em conhecer e compreender os elementos culturais que orientam a ação do paciente, como também fazer uma análise de si próprio, no sentido de tornar conscientes os valores básicos que orientam sua ação.

O médico deve dar atenção especial à linguagem utilizada durante a entrevista, pois o conjunto de símbolos (termos e expressões) utilizado pela profissão médica nem sempre é compreendido pelo paciente, uma vez que seu quadro de referência pode ser distinto.

Boxe

Muitos pacientes têm problema de compreensão e, no entanto, por inibição ou acanhamento, “fingem” estar entendendo perfeitamente o que lhes fora perguntado ou explicado. O grau de incompreensão acompanha de perto as diferenças sociais entre o médico e o paciente. Essas barreiras podem ser superadas no momento em que o médico entende e aceita a necessidade de levar em conta a cultura de seus pacientes.

O médico deve conhecer, também, os padrões normativos que a cultura criou para ele e para o seu paciente. A nossa cultura estabelece, por exemplo, que tanto o médico quanto o paciente devem se apresentar bem compostos em termos de higiene e aparência pessoal; o paciente espera que o médico se interesse por seu caso e que lhe dê atenção, enquanto o médico espera que o paciente responda de modo adequado às suas perguntas. O conhecimento adequado do médico, dos padrões normativos que regem a sua conduta e a do paciente, bem como o conhecimento das expectativas de comportamento que o paciente tem do profissional médico, ou seja, a conduta que o paciente espera que o médico tenha, são elementos úteis para realizar uma boa entrevista.

A entrevista médico-paciente desenvolve-se, pois, em um ambiente específico, seguindo padrões normativos preestabelecidos pela cultura.

O médico não deve se esquecer de que, além dos objetos físicos e culturais, existem os objetos sociais. Estes objetos sociais são o próprio médico e o paciente; assim, a reação do paciente frente à ação do médico, ou vice-versa, é um estímulo a uma nova ação deste último, e assim sucessivamente. Logo, existe uma interestimulação entre o médico e o paciente. Se o médico apresenta uma fisionomia tensa após uma resposta do paciente, isso será um elemento de orientação para a ação posterior do paciente, que poderá sentir-se preocupado e passar a responder conforme uma nova perspectiva.

O médico, ao conhecer que os objetos sociais se interestimulam, deve ter o máximo cuidado em controlar e alterar o comportamento do paciente; por outro lado, deve desenvolver sua intuição no sentido de captar no paciente indícios subliminares, como uma leve hesitação ao apresentar uma resposta ou um franzir de testa, que permitirão desenvolver condições que levem a uma interação mais eficaz com o paciente.

Boxe

Relato de um encontro clínico fora do “padrão”

Ao se fazer a anamnese, o significado de uma pergunta pode ser totalmente diferente para o médico e para o paciente, como se pode observar a partir do relato do encontro clínico descrito, a seguir, em cinco atos.

1º ato

Um paciente que morava nas margens de um afluente do Rio Negro, ao se sentir adoentado, sem poder trabalhar, decide ir à procura de um médico em Manaus. Levanta cedo, guarda no embornal a farofa que sua mulher preparou naquela madrugada, pega sua rede, uma camisa e uma cueca. Embarca em sua canoa e rema durante várias horas para chegar ao Rio Negro no final daquela tarde, a tempo de pegar o barco que o levaria a Manaus. Não se esqueceu de levar seu radinho de pilha, único elo de ligação dele com o mundo.

2º ato

Naquela mesma noite, o médico que o atenderia no dia seguinte e que era professor da Faculdade de Medicina foi para seu escritório, em sua casa, para estudar e preparar uma aula, hábito que cultivara durante toda a sua vida. Consultou livros, visitou alguns *sites* da internet, ouviu um pouco de música clássica e foi dormir ao lado de sua mulher.

3º ato

O sol nascia sobre a Floresta Amazônica quando o ribeirinho saiu da rede após uma noite maldormida, já que estava intranquilo e inseguro. Era a primeira vez que deixava sua casa, sua mulher e seus filhos em busca de assistência médica. Na mesma hora, o médico acordou, bem disposto, contente com a vida, pois gostava de seu trabalho como médico e como professor. Tinha grande interesse pelos pacientes e pelos seus alunos. Tomou um bom café da manhã, beijou sua mulher, pegou seu carro para deixar os filhos no colégio e ir para o hospital onde atenderia os pacientes no ambulatório de clínica médica. No mesmo momento, o ribeirinho desembarcou no cais de Manaus; tomou um café com leite no primeiro boteco que encontrou e pediu informações a um guarda sobre como chegar ao Hospital Universitário.

4º ato

O médico e o paciente chegaram quase juntos ao hospital. Era um dia tranquilo de atendimento, e a funcionária que o atendeu foi atenciosa e prestativa; deu-lhe uma ficha para que fosse examinado naquela manhã mesmo na clínica geral.

5º ato

O médico já havia tomado seu lugar na sala de consulta do ambulatório. Naquele dia não havia estudantes; estavam em greve. O paciente permaneceu sentado em um banco em frente à sala cujo número correspondia à sua senha. Ele era analfabeto, mas conhecia números. Uma auxiliar abre a porta e chama seu nome. Levanta-se e caminha um pouco assustado naquele ambiente totalmente estranho, tendo em seus pensamentos a lembrança de sua mulher e de seus filhos. O médico, demonstrando educação, põe-se de pé para receber o paciente, com ar amistoso, convidando-o a sentar-se diante da escrivaninha. Naquele momento tinha início um “encontro clínico” com toda a sua complexidade, embora parecesse algo tão simples: um paciente em busca de assistência médica! É fácil imaginar a distância entre aquelas duas pessoas – diferenças socioeconômicas, culturais, educacionais. Viviam em mundos diferentes: os desejos, as expectativas, os sonhos, as possibilidades, as limitações, tudo era diferente. Ao iniciar a entrevista, o médico, que sempre se interessou pela relação médico-paciente, levou em conta tudo isso. Mas as vivências e as expectativas eram diferentes como se pode perceber pelo diálogo entre eles:

Médico: Bom dia, seu José. (O médico sabia o nome porque estava no prontuário.)

Paciente: Bom dia, Doutor. (O paciente não sabia o nome do médico. Era apenas o “doutor”.)

Médico: O que o senhor sente? (Era sua maneira de iniciar a anamnese.)

Paciente: O que eu sinto, Doutor, é muita saudade da minha mulher e de meus meninos! Deixei eles ontem de madrugada. Minha mulher toma conta direitinho deles. Eu sei, mas estou preocupado.

Médico (Pensando: “O paciente não entendeu o “significado” de minha pergunta. Vou modificá-la.”): Seu José, o que o senhor tem?

Paciente: Ah! Doutor, não tenho quase nada. Só tenho umas galinhas, um porquinho engordando no chiqueiro, uma rocinha de mandioca, pouca coisa, Doutor.

Médico (Pensando: “Fiz a pergunta de maneira errada, outra vez!”). No mundo interior do paciente naquele momento “sentir” e “ter” não estava relacionado com sua doença. Decidiu, então, mesmo contrariando o que ensinava a seus alunos, fazer uma pergunta mais direta: Seu José, qual é sua doença?

Paciente: Ah! Doutor, o senhor é que sabe, o senhor é médico. O senhor sabe muita coisa, vim aqui pra o senhor me curar, para eu poder voltar logo para minha casa.

Médico (Ao perceber que precisava mudar a estratégia para encontrar um ponto de contato entre ele e o paciente.): Seu José, por favor, tire a camisa e deite-se nesta mesa para que eu possa examiná-lo.

A partir de então, as expectativas do médico e do paciente entraram em sintonia. Naquele momento, o encontro clínico teve início de verdade porque o médico se deu conta de que teria de fazer uma adaptação das “técnicas da entrevista” para aquele paciente que estava diante dele. Naquele caso, a melhor técnica foi fazer a história durante a realização do exame físico. À medida que examinava o paciente, fazia as perguntas que o permitiriam construir uma história clínica.

Esse relato foi descrito antes da abordagem da seção que será vista adiante, *Técnicas da entrevista*, para exemplificar a necessidade de conhecer não apenas as bases e as técnicas de uma entrevista clínica, mas, também, algo indispensável: ter consciência de que o mundo do paciente, incluindo tantos aspectos que o

médico desconhece, pode ser tão diferente do dele que só será possível levar adiante a elaboração da anamnese se ele souber usar a principal qualidade do método clínico, sua flexibilidade. Portanto, ao estudar as técnicas da entrevista, nunca se esqueça: a melhor “técnica” é a que permite estabelecer uma verdadeira comunicação com o paciente.

Técnicas da entrevista

É muito importante que o método clínico seja *centrado no paciente*. Isso significa a compreensão do indivíduo em seu todo e não somente a atenção sobre a queixa principal ou a hipótese diagnóstica. Sobre o indivíduo é importante considerar sua inserção familiar e social, sua história de vida e como o problema de saúde atual está interferindo no convívio familiar e social. Lembre-se de considerar isso desde o primeiro momento em que a pessoa entra no consultório, nunca se esquecendo dos aspectos da anamnese de acordo com o método clínico centrado no paciente.

Boxe

Abordagem da anamnese considerando o método clínico centrado no paciente

- Cumprimentar o paciente com aperto de mão e contato visual (olhar no rosto)
- Apresentar-se ao paciente antes de tudo, caso não esteja em consultório, ou seja, quando a entrevista for à beira do leito
- Chamar o paciente pelo nome ao longo de toda a consulta
- Procurar deixar o paciente à vontade para relatar os problemas e queixas principais. Fazer expressões faciais ou corporais de aprovação ou reprovação poderá inibi-lo
- Perguntar sobre o motivo da consulta ou a causa da internação ao iniciar a anamnese
- Fazer as perguntas transmitindo segurança, calma e interesse no que vai ouvir
- Prestar realmente atenção no relato do paciente
- Encorajar o paciente a relatar seus sentimentos relacionados ao problema que está enfrentando.

Essa abordagem auxilia a boa relação profissional da saúde/paciente e melhora a adesão às prescrições e orientações, bem como no estabelecimento de uma relação de maior confiança e credibilidade. Irá auxiliar ainda no diagnóstico precoce de outros problemas que possam surgir, na redução de riscos e complicações relacionadas à doença atual e até na prevenção de outros problemas.

Com a abordagem centrada na pessoa, algumas decisões podem ser compartilhadas entre profissional e paciente (e/ou familiares); por isso, entender a pessoa como um todo, considerar os sentimentos, as expectativas, os receios e as dúvidas é tão importante para a tomada de decisão e para o planejamento do manejo do problema de saúde. Assim, a relação profissional da saúde/paciente irá se aprofundar cada vez mais, beneficiando ambas as partes.

Tipos de perguntas

Basicamente, podem ser perguntas abertas e perguntas diretas. As perguntas abertas são mais úteis no início da entrevista, pois permitem ao paciente contar sua história espontaneamente. Por exemplo: “Que tipo de problema o(a) senhor(a) está tendo?”, “Quais eram suas condições de saúde antes de surgir esta dor?”.

As perguntas abertas também são usadas para facilitar a narrativa do paciente, o que permite ao médico uma compreensão biopsicossocial do processo de adoecimento.

Após algumas perguntas abertas, o examinador deve direcionar a atenção do paciente com perguntas diretas, as quais reduzem as informações, mas permitem obter dados mais específicos. Por exemplo: “Há quanto tempo surgiu o sintoma?”, “Em que região sente a dor?”.

Usa-se esse tipo de pergunta para o preenchimento da ficha médica ou do prontuário. A compreensão da narrativa e o direcionamento da anamnese por meio de perguntas objetivas possibilitam ao profissional médico levantar pontos importantes para o direcionamento do raciocínio clínico.

Técnicas para entrevistar

O examinador precisa saber o momento de usar o *silêncio*, a *facilitação*, o *confronto*, o *apoio*, a *reafirmação* e a *compreensão*:

Silêncio: há momentos da entrevista em que o examinador deve permanecer calado, mesmo que pareça ter perdido o controle da conversa. Para o paciente loquaz não é uma boa técnica, porque esse tipo de pessoa passa de um tema para outro com muita facilidade e a entrevista perde a objetividade.

O entrevistador deve utilizar o silêncio quando o paciente se emociona. É inadequado dizer ao paciente que não chore ou que se controle. Entregar ao paciente uma caixa de lenços de papel naquele momento é uma atitude de apoio e compreensão.

Esclarecimento: o esclarecimento é diferente da reflexão porque, nesse caso, o médico pode definir de maneira mais clara o que o paciente está relatando. Por exemplo: se o paciente se refere a tonturas, o médico por saber que esse termo tem vários significados, procura esclarecer a qual deles o paciente se refere (vertigem? sensação desagradável na cabeça?)

Facilitação: a facilitação é uma técnica de comunicação verbal ou não verbal que encoraja o paciente a continuar falando, sem direcioná-lo para um tema. Expressões como “Continue”, “Fale mais sobre isso”, assim como gestos de balançar a cabeça, demonstram interesse e compreensão e podem facilitar o relato do paciente.

Confronto: o confronto indica ao paciente que o examinador detectou algum aspecto que merece aprofundamento. Por exemplo: “O(a) senhor(a) parece irritado(a)”, “O senhor(a) está zangado(a)?”.

O confronto deve ser empregado com cuidado, uma vez que seu uso excessivo pode ser interpretado pelo paciente como grosseria ou falta de compreensão.

A interpretação é um tipo de confrontação que se baseia em uma conclusão tirada pelo examinador. Por exemplo: “Parece que o(a) senhor(a) está amedrontado(a)”.

Apoio: afirmações de apoio promovem segurança no paciente. Dizer, por exemplo, “Eu compreendo” no momento em que o paciente demonstrar dúvida ou insegurança pode encorajá-lo a prosseguir no relato ou fornecer mais detalhes.

Expressões tranquilizadoras podem ser necessárias em momentos de dificuldade, mas não se deve fazer afirmativas prematuras sobre diagnóstico ou prognóstico só para aliviar a ansiedade do paciente.

Reafirmação: a reafirmação é uma maneira de transmitir ao paciente uma indicação de que entendeu o que foi dito por ele. A reafirmação encoraja o paciente, que se mostra assustado, aborrecido ou desinteressado. É um modo de reforçar um diálogo que transparece distanciamento. Quando na forma de interrogação, pode parecer um confronto. Dependendo do tom de voz, pode ser entendido pelo paciente como apenas a interpretação que o médico está fazendo de alguma informação.

Compreensão: por palavras, gestos ou atitudes (colocar a mão sobre o braço do paciente, por exemplo) o médico demonstra compreender algo relatado pelo paciente.

Boxe

Normas básicas da entrevista

Não se deve fazer anotações extensas durante a entrevista. A atenção deve ser centralizada no que a pessoa está dizendo, nas expressões faciais e na linguagem corporal.

Pode-se usar um bloco de papel para anotar datas ou nomes importantes para o registro da anamnese.

Digitar no computador durante a narrativa cria um distanciamento entre o profissional de saúde e o paciente que empobrece o relato e interfere na relação profissional de saúde-paciente. É melhor fazer a digitação dos dados obtidos após o término da história da doença atual que é, sem dúvida, o componente principal da anamnese. Se a opção for digitar, o entrevistador deve usar uma estratégia em que o computador fique em segundo plano. O paciente, e não a máquina, deve ficar no foco de atenção do profissional de saúde.

Ao final da entrevista, quando já tiver obtido uma clara impressão do motivo pelo qual o paciente procurou auxílio do profissional de saúde, centrada na história da doença atual, além de conhecer suficientemente a história patológica pregressa, principalmente doenças preexistentes, e ter uma compreensão das condições socioeconômicas e culturais do paciente, o profissional de saúde deve expor ao paciente o que considerou relevante, terminando com as seguintes perguntas: “Compreendi bem o problema do(a) senhor(a)?”, “Deseja acrescentar outras informações?”

Não usar termos técnicos durante a entrevista e, quando empregá-los, estar seguro de que o paciente tenha clara compreensão deles.

Medicina narrativa

A anamnese tradicional organiza todas as informações clínicas que serão consideradas no raciocínio de possíveis hipóteses diagnósticas e na elaboração de uma abordagem diagnóstica e terapêutica. Este modelo decorre do pensamento lógico que tem trazido enormes avanços técnicos no diagnóstico e no manejo de situações cada vez mais complexas. Entretanto, esta técnica de aprender e representar aquilo que o paciente relata durante a consulta para o médico que ouve pode – se não houver um ouvido habilmente treinado – afastar a anamnese daquilo que parece sombrio, onipresente ou incerto, tão próprio das singularidades humanas.

A introdução e os prefácios das edições anteriores deste livro já apontavam a equação da Medicina Arte, teorizando que o ensino (e a prática) do exame clínico é “[...] o elo entre a ciência (médica) e a arte (médica), o que poderia ser sintetizado na já consagrada expressão: $AC = E [MBE + (MBV)^2]$, ou seja, Arte Clínica é o resultado de uma equação que multiplica Ética à soma da Medicina Baseada em Evidências com o quadrado do que há de Medicina Baseada em Vivências”. Elevar ao quadrado a narrativa singular do paciente para somar-se às evidências científicas da medicina contemporânea e assim elevar as escolhas éticas a um patamar de Arte.

Dentro dessa imagem do pensamento, nasce a Medicina Narrativa – termo proposto por Rita Charon (2006) – que pretende [re]aproximar o ensino e a prática da clínica à Literatura; no sentido de ampliar a anamnese tradicional proporcionando ao aluno em formação habilidades linguísticas e estéticas advindas da leitura e do estudo de narrativas literárias e da construção de narrativas clínicas que ofereçam à anamnese o alcance de meandros escondidos da singularidade de cada paciente.

As narrativas literárias e a criação conjunta de narrativas pelos pacientes e seus médicos têm uma potência imanente de ampliar ou de *estrelar* as anamneses tradicionais (Nova Cruz, 2015). Ampliação esta que – especialmente em paciente portadores de doenças crônicas, casos complexos, pacientes em situações de grande fragilidade, como nos cuidados paliativos ou no atendimento no final da vida – pode resgatar incertezas, temores, dúvidas e anseios dos médicos e das pessoas sob seus cuidados (pacientes e seus familiares), construindo uma relação próxima, afetiva e mais satisfatória.

Na abordagem narrativa, o médico se apresenta, e coloca inicialmente uma única questão, a saber: *Me conte tudo aquilo que eu preciso saber sobre o senhor, ou sobre a senhora...* As reticências estão aí justamente para mostrar o caráter aberto da proposição. É certo que o médico habilidoso ainda terá que conduzir a entrevista de modo a completar lacunas, caracterizar sintomas, esclarecer tempos, intervalos, intensidades, durações. Mas estas particularidades técnicas da anamnese não devem impedir o aparecimento de informações sensíveis, profundas, difíceis de serem verbalizadas que de uma forma muito direta e objetiva tendem a ser retidas pelo paciente e negligenciadas pelos médicos.

O encontro clínico descrito de forma narrativa terá um estilo próximo de um texto literário. Neste gênero narrativo, as informações clínicas podem aparecer fragmentadas, porém formando um sentido profundo; o tempo narrativo, em vez de linear e cronológico, traduz o caráter intensivo do acometimento-doença, e o caráter estético da anamnese revela laços afetivos e significativos construídos entre o médico e seu paciente.

O resultado prático pressuposto pela Medicina Narrativa é o de criação de uma autonomia compartilhada, ou seja, médico e paciente como personagens e autores de uma mesma narrativa conjunta e capazes de escolhas que refletem esta relação próxima e efetiva (ver boxe *Relato de um encontro clínico fora do “padrão”*.)

Em suma, a medicina narrativa, como técnica de fazer a entrevista, demonstra a flexibilidade do método clínico, cujo núcleo é a identificação da doença e o conhecimento do paciente.

EXAME FÍSICO

A inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta e o uso de alguns instrumentos e aparelhos simples (termômetro, esfigmomanômetro, otoscópio, oftalmoscópio e outros) são designados, conjuntamente, exame físico, que, junto com a anamnese, constitui o método clínico.

Boxe

Significado psicológico do exame físico

Este componente afetivo mais nítido na anamnese sempre existe no exame físico e precisa ser mais bem reconhecido pelo médico, porque é um dos elementos fundamentais da relação médico-paciente. Sem dúvida, a base da relação médico-paciente encontra-se na anamnese, pois é por meio dela que se estabelecem os laços afetivos entre o médico e o paciente. Contudo, o componente psicológico do exame físico também é muito importante, bastando lembrar a expressão: “Doutor, estou em suas mãos!”, que demonstra de maneira

clara como os pacientes veem o médico nos seus momentos mais difíceis. Nessa expressão estão sintetizados a parte técnica e o significado psicológico. Ser examinado e entregar-se é o significado do que o paciente quer dizer.

Quando o médico *olha* o paciente, ele está fazendo duas coisas: inspecionando seu corpo (parte técnica), ao mesmo tempo que vê a pessoa que se sente doente (componente psicológico), sendo capaz de reconhecer alterações anatômicas quando *inspeciona* e modificações emocionais quando *vê*. Quando o médico *palpa* ou *percut*e também ocorrem duas coisas diferentes: do ponto de vista de técnica semiológica, a palpação e a percussão permitem detectar modificações estruturais e funcionais, mas não se pode esquecer de que no mesmo momento o médico está *tocando* o corpo do paciente com suas mãos; e tocar é mais do que palpar. Quando o médico *ausculta* percebe os ruídos originados no corpo, porém, mais importante, é escutar o que o paciente tem a dizer.

Donde se conclui que no exame físico é necessário saber *inspecionar* e *ver*, *palpar* e *tocar*, *auscultar* e *escutar*. Os dois componentes – parte técnica e componente psicológico – reforçam-se mutuamente, fazendo do exame clínico um inesgotável manancial de conhecimentos sobre o paciente.

Uma análise mais profunda desses fenômenos revela mecanismos psicodinâmicos que escapam à compreensão do paciente e do próprio médico, no que se refere ao componente psicológico, porque é intuitivo, subjetivo e inconsciente, enquanto a parte técnica, por ser racional, objetiva, analítica e consciente, é mais fácil de ser planejada e executada. Saber usar o componente psicológico é uma necessidade que se faz cada vez mais presente para que o médico recupere a parte mais nobre da medicina e a mais respeitada pelos pacientes.

Boxe

Abordagem do exame físico e demais aspectos da consulta considerando o método clínico centrado no paciente

Ao realizar o exame físico, explique o porquê dessa avaliação e, se encontrar alguma alteração, mencioná-la ao paciente

Ao solicitar exames, explique ao paciente sua importância para identificar e entender o problema de saúde apresentado

Procure explicar ao paciente as etapas do diagnóstico, bem como as próximas etapas, inclusive a importância do retorno

É muito importante verificar se o paciente realmente compreendeu tudo

Tenha tempo adequado para a realização de um exame físico cuidadoso

Demonstre atenção ao paciente durante todo o processo

Esclareça suas dúvidas e procure usar linguagem que o paciente compreenda.

A AULA PRÁTICA E O ENCONTRO CLÍNICO

Toda vez que um profissional da saúde tem diante de si uma pessoa – sadia ou doente – que busca os seus serviços, isso representa um “encontro clínico”. O aprendizado prático dos estudantes de medicina e de outras profissões da área da saúde deve ser encarado como um “encontro clínico”, e não apenas como uma “aula prática”, parte indispensável das disciplinas clínicas.

Neste momento várias coisas estão acontecendo: a entrevista que vai permitir a construção da história clínica, indispensável para se fazerem hipóteses diagnósticas consistentes, a partir das quais se fará o raciocínio clínico que levará a uma decisão terapêutica; a relação entre o estudante (no papel de médico) e o paciente; e, acima de tudo, a relação entre duas pessoas, quando, então, o que prevalece são as qualidades humanas.

O modelo biomédico, por ser tecnicista e mecanicista, só dá valor ao que pode ser medido ou visto em imagens. Daí a dificuldade dos profissionais da saúde formados no modelo biomédico em compreenderem a importância e a complexidade do encontro clínico. Isso acontece porque estão presentes fatores emocionais e socioculturais que vão influenciar definitivamente o diagnóstico e a decisão terapêutica, a adesão ao tratamento, o sucesso ou o fracasso do médico.

Isso não quer dizer que se possa esquecer ou desvalorizar os aspectos técnicos, que são indispensáveis para se fazer corretamente a entrevista, da mesma maneira que não se pode desconhecer ou desprezar os fatores emocionais e socioculturais. Semiotécnica, ou seja, técnicas para a entrevista e para o exame físico, princípios bioéticos e qualidades humanas (autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e sigilo) coexistem no encontro clínico, fazendo dele o núcleo luminoso de todas as profissões da área da saúde. Cumpre salientar, por outro lado, que só é possível compreender o exato significado do encontro clínico convivendo com pacientes. Nada substitui o paciente: nem livros, programas de computador, manequins, tampouco laboratórios de habilidades. Mais ainda, é necessário reproduzir o encontro clínico tal como acontece no mundo real, cuja essência é a relação dual entre um profissional da saúde e um paciente. O fato de os estudantes serem aprendizes não impede a vivência plena de um encontro clínico com o paciente.

O essencial é aprender a fazer o exame clínico ao mesmo tempo que se vão incorporando os princípios bioéticos, desenvolvendo a capacidade de relacionamento com o paciente e cultivando as qualidades humanas essenciais – integridade, respeito e compaixão – para o exercício de uma medicina de excelência.

Boxe

Ato médico perfeito

O ato médico perfeito apoia-se em três componentes: competência técnica, princípios éticos e qualidades humanas. Somente quem sabe utilizar o método clínico é capaz de integrá-los de maneira plena e, assim fazendo, exercer uma medicina de excelência.

Boxe

Princípios para o aprendizado do método clínico

Dominar o método clínico em toda a sua amplitude para identificar a doença e conhecer o paciente

Saber avaliar o paciente não apenas do ponto de vista biológico (anatômico, fisiológico, bioquímico, patológico), mas considerá-lo também em seus aspectos emocionais e socioculturais. Em outras palavras: não ficar restrito à “lesão” ou à “disfunção” de um órgão ou parte dele

Compreender que componentes emocionais são concernentes ao campo da subjetividade, tanto do paciente como do médico, incluindo aspectos afetivos e éticos, relacionados ao paciente e à sua família, ao trabalho, às condições econômicas e legais, à representação do paciente na sociedade

Reconhecer que os aspectos socioculturais dizem respeito ao paciente não como um indivíduo isolado como é visto no modelo biomédico, mas inserido em contextos suprapessoais, dos quais participa tanto ativa como passivamente

Compreender desde o primeiro paciente que o encontro clínico é o núcleo luminoso da profissão médica, e é exatamente durante o exame clínico que tudo acontece!

Capítulo 4



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Anamnese

Celmo Celeno Porto

Fábila Maria Oliveira Pinho

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

- Aspectos gerais
- Semiotécnica da anamnese
- Anamnese em pediatria
- Anamnese em psiquiatria
- Anamnese do idoso
- Considerações finais
- Roteiro pedagógico para anamnese

ASPECTOS GERAIS

Anamnese (*aná* = trazer de novo e *mnesis* = memória) significa trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e a pessoa doente.

De início, deve-se ressaltar que a anamnese é a parte mais importante da medicina: primeiro, porque é o núcleo em torno do qual se desenvolve a relação médico-paciente, que, por sua vez, é o principal pilar do trabalho do médico; segundo, porque é neste momento que os princípios éticos passam de conceitos abstratos para o mundo real do paciente, consubstanciados em ações e atitudes; terceiro, porque é cada vez mais evidente que o progresso tecnológico somente é bem utilizado se o lado humano da medicina é preservado.

Boxe

Conclui-se que cabe à anamnese uma posição ímpar, insubstituível, na prática médica.

A anamnese, se bem feita, acompanha-se de decisões diagnósticas e terapêuticas corretas; se mal feita, em contrapartida, desencadeia uma série de consequências negativas, as quais não podem ser compensadas com a realização de exames complementares, por mais sofisticados que sejam.

A ilusão de que o progresso tecnológico eliminaria a entrevista e transformaria a medicina em uma ciência “quase” exata caiu por terra. Já se pode afirmar que uma das principais causas da perda de qualidade do trabalho médico é justamente a redução do tempo dedicado à anamnese. Até o aproveitamento racional das avançadas técnicas depende cada vez mais da entrevista. A realização de muitos exames complementares não resolve o problema; pelo contrário, agrava-o ao aumentar os custos, sem crescimento paralelo da eficiência. Escolher o(s) exame(s) adequado(s), entre tantos disponíveis, é fruto de um raciocínio crítico apoiado quase inteiramente na anamnese.

Boxe

Possibilidades e objetivos da anamnese

Estabelecer condições para uma adequada relação médico-paciente

Conhecer, por meio da identificação, os determinantes epidemiológicos do paciente que influenciam seu processo saúde-doença

Fazer a história clínica registrando, detalhada e cronologicamente, o problema atual de saúde do paciente

Avaliar, de maneira detalhada, os sintomas de cada sistema corporal

Registrar e desenvolver práticas de promoção da saúde

Avaliar o estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo os fatores pessoais, familiares e ambientais que influenciam seu processo saúde-doença

Conhecer os hábitos de vida do paciente, bem como suas condições socioeconômicas e culturais.

Em essência, a anamnese é uma entrevista, e o instrumento de que nos valemos é a palavra falada. É óbvio que, em situações especiais (pacientes surdos ou pacientes com dificuldades de sonorização), dados da anamnese podem ser obtidos por meio da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), da palavra escrita ou mediante tradutor (acompanhante e/ou cuidador que compreenda a comunicação do paciente).

Em termos simples, poder-se-ia pensar que “fazer anamnese” nada mais é que “conversar com o paciente”; contudo, entre uma coisa e outra há uma distância enorme, basicamente porque o diálogo entre o médico e o paciente tem objetivo e finalidade preestabelecidos, ou seja, a reconstituição dos fatos e dos acontecimentos direta ou indiretamente relacionados com uma situação anormal da vida do paciente.

A anamnese é um instrumento para a avaliação de sintomas, problemas de saúde e preocupações, e registra as maneiras como a pessoa responde a essas situações, abrindo espaço para a promoção da saúde.

A anamnese pode ser conduzida das seguintes maneiras:

Deixar que o paciente relate livre e espontaneamente suas queixas sem nenhuma interferência do médico, que se limita a ouvi-lo. Essa técnica é recomendada e seguida por muitos clínicos. A medicina narrativa é inteiramente baseada nesta técnica. O

psicanalista apoia-se integralmente nela e chega ao ponto de se colocar em uma posição na qual não possa ser visto pelo paciente, para que sua presença não exerça nenhuma influência inibidora ou coercitiva

Conduzir a entrevista de maneira mais objetiva, técnica denominada *anamnese dirigida*, tendo em mente um esquema básico. O uso dessa técnica exige rigor técnico e cuidado na sua execução, de modo a não se deixar levar por ideias preconcebidas

Outra maneira seria o médico deixar, inicialmente, o paciente relatar de maneira espontânea suas queixas, para depois conduzir a entrevista de modo mais objetivo.

Qualquer que seja a técnica empregada, os dados coletados devem ser elaborados. Isso significa que uma boa anamnese é o que fica do relato feito pelo paciente depois de ter passado por uma análise crítica com o intuito de estabelecer o significado exato das expressões usadas e a coerência das correlações estabelecidas. Há de se ter cuidado com as interpretações que os pacientes fazem de seus sintomas e dos tratamentos.

A história clínica não é, portanto, o simples registro de uma conversa. É mais do que isso: é o resultado de uma conversação com um objetivo explícito, conduzida pelo examinador e cujo conteúdo foi elaborado criticamente por ele.

As primeiras tentativas são trabalhosas, longas e cansativas, e o resultado não passa de uma história complicada, incompleta e eivada de descrições inúteis, ao mesmo tempo que deixa de ter informações essenciais.

Por tudo isso, pode-se afirmar que a anamnese é a parte mais difícil do método clínico, mas é também a mais importante. Seu aprendizado é lento, só conseguido depois de se realizarem dezenas de entrevistas.

Muito mais fácil é aprender a manusear aparelhos, já que eles obedecem a esquemas rígidos, enquanto as pessoas apresentam individualidade, característica humana que exige do médico flexibilidade na conduta e capacidade de adaptação.

Para que se faça uma entrevista de boa qualidade, antes de tudo o médico deve estar interessado no que o paciente tem a dizer. Ao mesmo tempo, é necessário demonstrar compreensão e desejo de ser útil àquela pessoa, com a qual assume um compromisso tácito que não tem similar em nenhuma outra relação inter-humana. Isso é o que se denomina empatia.

Pergunta-se frequentemente quanto tempo deve-se dedicar à anamnese. Não se pode, é óbvio, estabelecer limites rígidos. Os estudantes que estão fazendo sua iniciação clínica gastam horas para entrevistar um paciente, pois são obrigados a seguir roteiros longos, preestabelecidos; é necessário que seja assim, pois, nessa fase, precisam percorrer todo o caminho para conhecê-lo.

Nas doenças agudas ou de início recente, em geral apresentando poucos sintomas, é perfeitamente possível conseguir uma história clínica de boa qualidade em 10 a 15 min, ao passo que nas doenças de longa duração, com sintomatologia variada, não se gastarão menos do que 30 a 60 min na anamnese.

Em qualquer situação, aproveita-se, também, o momento em que está sendo executado o exame físico para novas indagações, muitas delas despertadas pela observação do paciente.

A pressa é o defeito de técnica mais grosseiro que se pode cometer durante a obtenção da história; tão grosseiro como se se quisesse obter em 2 min uma reação bioquímica que exige 2 h para se completar.

O espírito preconcebido é outro erro técnico a ser evitado continuamente, porque pode ser uma tendência natural do examinador. Muitas vezes essa preconcepção é inconsciente, originada de um especial interesse por determinada enfermidade.

A falta de conhecimento sobre os sintomas da doença limita de maneira extraordinária a possibilidade de se obter uma investigação anamnésica completa. Quando não se conhece um fenômeno, não se sabe que meios e modos serão mais úteis para que seja detectado e entendido; por isso, costuma-se dizer que anamneses perfeitas só podem ser obtidas por médicos experientes. No entanto, histórias clínicas de boa qualidade são conseguidas pelos estudantes após treinamento supervisionado, não muito longo.

A anamnese é, na maioria dos pacientes, o fator isolado mais importante para se chegar a um diagnóstico, mas o valor prático da história clínica não se restringe à elaboração do diagnóstico, que será sempre uma meta fundamental do médico. A terapêutica sintomática só pode ser planejada com acerto e proveito se for fundamentada no conhecimento detalhado dos sintomas relatados. Cada indivíduo personaliza de maneira própria seus padecimentos. Todo paciente apresenta particularidades que escapam a qualquer esquematização rígida. Idiossincrasias ou intolerâncias que a anamnese traz à tona podem ser decisivas na escolha de um recurso terapêutico. Assim, o antibiograma poderá indicar que determinada substância é mais ativa contra determinado germe, porém, se o paciente relatar intolerância àquele antibiótico, sua eficácia farmacologicamente preestabelecida perderá o significado.

Há muitas doenças cujos diagnósticos podem ser feitos quase exclusivamente pela história, como, por exemplo, angina do peito, epilepsia, enxaqueca e neuralgia do trigêmeo, isso sem se falar das afecções neuróticas e psiquiátricas, cujo diagnóstico apoia-se integralmente nos dados da anamnese.

Determinados pacientes tendem a tomar a condução da anamnese, respondendo apenas às perguntas que lhes interessam, questionando o médico, levantando questões a todo momento ou interpretando eles mesmos os sintomas, ao mesmo tempo que emitem opiniões sobre exames a serem efetuados. Chegam a sugerir diagnósticos e tratamentos para seus próprios males. Muitas dessas pessoas são adeptas de leituras de divulgação científica em revistas ou em sites da internet. A primeira preocupação do médico deve ser retomar a direção da entrevista de maneira habilidosa, preocupando-se em não assumir nenhuma atitude hostil proveniente da momentânea perda de sua posição de líder daquele colóquio. (Saiba mais sobre “paciente expert” no Capítulo 1, *Iniciação ao Exame Clínico*.)

Muitas vezes, alguns dados da anamnese ficam mais claros se voltarmos a eles durante o exame físico do paciente. Uma das principais características do método clínico é justamente sua flexibilidade. Contudo, na fase inicial do aprendizado, é melhor procurar esgotar todas as questões durante a anamnese.

Boxe

Decálogo para uma boa anamnese

É no primeiro contato que reside a melhor oportunidade para fundamentar uma boa relação entre o médico e o paciente. Perdida essa oportunidade, sempre existirá um hiato intransponível entre um e outro; cumprimente o paciente, perguntando logo o nome dele e dizendo-lhe o seu. Não use termos como “vovô”, “vovó”, “vozinho”, “vozinha” para os idosos. Demonstre atenção ao que o paciente está falando. Procure identificar de pronto alguma condição especial – dor, sono, ansiedade, irritação, tristeza – para que você saiba a maneira mais conveniente de conduzir a entrevista

Conhecer e compreender as condições socioculturais do paciente representa uma ajuda inestimável para reconhecer a doença e entender o paciente

Perspicácia e tato são qualidades indispensáveis para a obtenção de dados sobre doenças estigmatizantes ou distúrbios que afetam a intimidade da pessoa

Ter sempre o cuidado de não sugestionar o paciente com perguntas que surgem de ideias preconcebidas

Sintomas bem investigados e mais bem compreendidos abrem caminho para um exame físico objetivo. Isso poderia ser anunciado de outra maneira: só se acha o que se procura e só se procura o que se conhece

A causa mais frequente de erro diagnóstico é uma história clínica mal obtida

Obtidas as queixas, estas devem ser elaboradas mentalmente pelo médico, de modo a encontrar o desenrolar lógico dos acontecimentos, que é a base do raciocínio clínico

Os dados fornecidos pelos exames complementares nunca corrigem as falhas e as omissões cometidas na anamnese

Somente a anamnese permite ao médico uma visão de conjunto do paciente, indispensável para a prática de uma medicina humana

O tempo reservado para a anamnese distingue o médico competente do incompetente, o qual tende a transferir para os aparelhos e para o laboratório a responsabilidade do diagnóstico.

SEMIOTÉCNICA DA ANAMNESE

A anamnese se inicia com perguntas do tipo: “O que o(a) senhor(a) está sentindo?”, “Qual é o seu problema?”.

Isso parece fácil, mas, tão logo o estudante começa seu aprendizado clínico, ele percebe que não é bem assim. Não basta pedir ao paciente que relate sua história e anotá-la. Muitos pacientes têm dificuldade para falar e precisam de incentivo; outros – e isto é mais frequente – têm mais interesse em narrar as circunstâncias e os acontecimentos paralelos do que relatar seus padecimentos. Aliás, o paciente não é obrigado a saber como deve relatar suas queixas. O médico é que precisa saber como obtê-las.

O médico tem de estar imbuído da vontade de ajudar o paciente a relatar seus padecimentos. Para conseguir tal intento, o examinador pode utilizar diferentes técnicas: silêncio, facilitação, esclarecimento, confronto, apoio, reafirmação, compreensão,

conforme descrito no item *Técnicas da entrevista* no Capítulo 3, *Método Clínico*.

A resposta do paciente quase sempre nos coloca diante de um sintoma; portanto, antes de tudo, é preciso que se tenha entendido claramente o que ele quis expressar. A informação é fornecida na linguagem comum, cabendo ao médico encontrar o termo científico correspondente, elaborando mentalmente um esquema básico que permita uma correta indagação de cada sintoma.

Elementos componentes da anamnese

A anamnese é classicamente desdobrada nas seguintes partes: identificação, queixa principal, história da doença atual (HDA), interrogatório sintomatológico (IS), antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, condições socioeconômicas e culturais (Quadro 4.1).

Identificação

A *identificação* é o perfil sociodemográfico do paciente que permite a interpretação de dados individuais e outros aspectos relacionados a ele. Apresenta múltiplos interesses; o primeiro deles é de iniciar o relacionamento com o paciente; saber o nome de uma pessoa é indispensável para que se comece um processo de comunicação em nível afetivo.

Boxe

Para a confecção de fichários e arquivos, que nenhum médico ou instituição pode dispensar, os dados da identificação são fundamentais.

Além do interesse clínico, também dos pontos de vista pericial, sanitário e médico-trabalhista, esses dados são de relevância para o médico.

A data em que é feita a anamnese é sempre importante e, quando as condições clínicas modificam-se com rapidez, convém acrescentar a hora.

São obrigatórios os elementos descritos a seguir:

Nome: é o primeiro dado da identificação. Registra-se o nome completo do paciente, sem abreviações. Nunca é demais criticar o hábito de designar o paciente pelo número do leito ou pelo diagnóstico. “Paciente do leito 5” ou “aquele caso de cirrose hepática da Enfermaria 7” são expressões que jamais devem ser usadas para caracterizar uma pessoa

Idade: registra-se em dias ou meses, no caso de crianças abaixo de 1 ano de idade e em anos, no caso de indivíduos acima de 1 ano de vida. Cada grupo etário tem sua própria doença, e bastaria essa assertiva para tornar clara a importância da idade. A todo momento, o raciocínio diagnóstico se apoia nesse dado, e quando se fala em “doenças próprias da infância” está se consagrando o significado do fator idade no processo de adoecimento. Vale ressaltar que, no contexto da anamnese, a relação médico-paciente apresenta peculiaridades de acordo com as diferentes faixas etárias

Sexo/gênero: registra-se masculino ou feminino. Não se falando nas diferenças fisiológicas, sempre importantes do ponto de vista clínico, há enfermidades que só ocorrem em determinado sexo. Exemplo clássico é a *hemofilia*, transmitida pelas mulheres, mas que só aparece nos homens. É óbvio que existem doenças específicas para cada sexo no que se refere aos órgãos sexuais. As doenças endócrinas adquirem muitas particularidades em função desse fator. A questão de gêneros, bastante estudada nos últimos anos, aponta para um processo de adoecimento diferenciado no homem e na mulher, ainda quando a doença é a mesma

Cor/etnia: embora não sejam coisas exatamente iguais, na prática elas se confundem. Em nosso país, onde existe uma intensa mistura de etnias (Figura 4.1), é preferível o registro da cor da pele usando-se a seguinte nomenclatura:

- Cor branca
- Cor parda
- Cor preta
- Etnia indígena
- Etnia asiática.

Uma nova maneira de conhecer as características étnicas do povo brasileiro é pelo exame do DNA de grupos populacionais. Pena *et al.* (2000) demonstraram, pela análise do DNA de 200 homens e mulheres de “cor branca” de regiões e origens sociais diversas, que apenas 39% tinham linhagem exclusivamente europeia (cor branca), enquanto 33% apresentavam herança

genética indígena e 28%, africana (cor preta).

A influência da etnia no processo do adoecimento conta com muitos exemplos; o mais conhecido é o da *anemia falciforme*, uma alteração sanguínea específica dos negros, mas que, em virtude da miscigenação, pode ocorrer em pessoas de outra cor. Outro exemplo é a *hipertensão arterial*, que mostra comportamento evolutivo diferente nos pacientes de cor preta: além de ser mais frequente nesse grupo, a hipertensão arterial apresenta maior gravidade, com lesões renais mais intensas e maior incidência de acidentes vasculares encefálicos. Convém ressaltar que esses dados estão relacionados com os afrodescendentes no continente americano. Em contrapartida, pessoas de cor branca estão mais predispostas aos cânceres de pele.

Quadro 4.1
Elementos componentes da anamnese.

Identificação	Perfil sociodemográfico que possibilita a interpretação dos dados individuais do paciente e outros aspectos relacionados a ele
Queixa principal (QP)	É o motivo da consulta. Sintomas ou problemas que motivaram o paciente a procurar atendimento médico
História de doença atual (HDA)	Registro cronológico e detalhado do problema atual do paciente
Interrogatório sintomatológico (IS)	Avaliação dos sintomas de cada sistema corporal; permite complementar a HDA e avaliar práticas de promoção à saúde
Antecedentes pessoais e familiares	Avaliação do estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo os fatores pessoais e familiares que influenciam seu processo saúde-doença
Hábitos de vida (HV)	Documentar hábitos e estilo de vida do paciente, incluindo ingesta alimentar diária e usual, prática de exercícios, história ocupacional, uso de tabaco, consumo de bebidas alcoólicas e utilização de outras substâncias e drogas ilícitas
Condições socioeconômicas e culturais	Avaliar as condições de habitação do paciente, além de vínculos afetivos familiares, condições financeiras, atividades de lazer, filiação religiosa e crenças espirituais, bem como a escolaridade

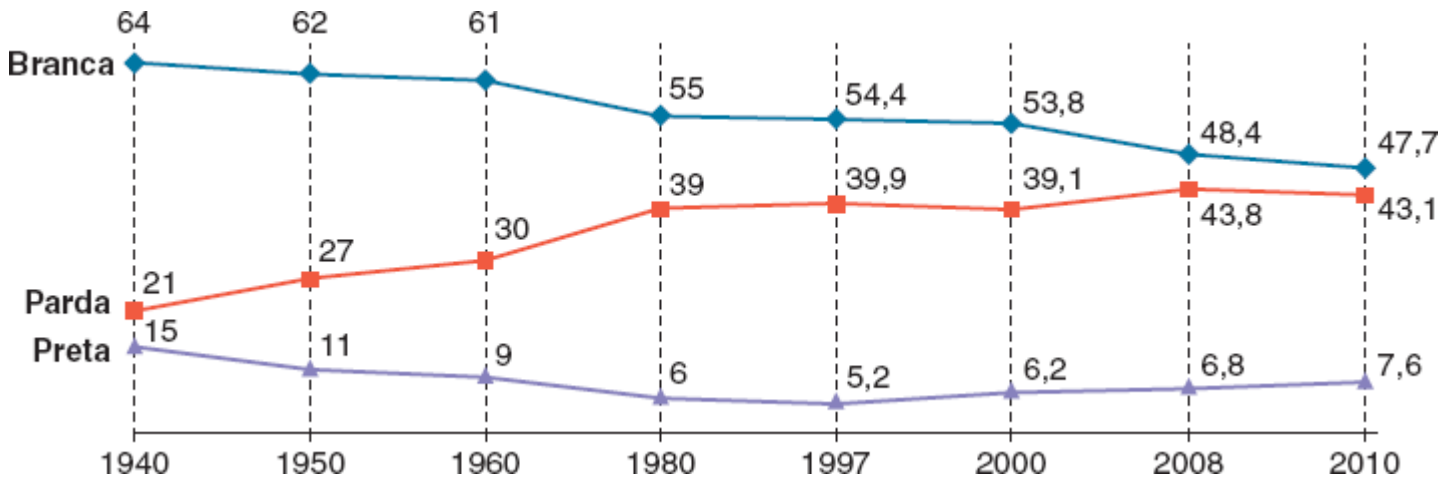


Figura 4.1 População brasileira de acordo com a cor da pele. Os censos demográficos de 1940, 1950, 1960, 1980, 1997 e 2010 mostram a relevância da miscigenação no Brasil. Os de cor branca, que em 1940 representavam 64% da população, no censo de 1997 representavam 54,4%; enquanto isso, os de cor parda passaram de 21 para 39,9%, e os de cor preta, de

15 para 5,2%. No censo de 2000, os dados pouco se alteraram (IBGE, 2000). Já nos dados de 2008, IBGE, ocorreram alterações, que se confirmaram no de 2010.

Considerando o alto grau de miscigenação (Figura 4.1) da população brasileira, há necessidade de se ampliarem os estudos da influência étnica nas doenças prevalentes em nosso país, inclusive nos indivíduos de cor parda. O primeiro passo é o registro correto da cor da pele nos estudos epidemiológicos e nos prontuários médicos.

Estado civil: registram-se as opções: casado(a), solteiro(a), divorciado(a), viúvo(a) e outros. Os outros podem ser: separado(a) – sem homologação do divórcio ou companheiro(a) – pessoa que vive em união estável. Não só os aspectos sociais referentes ao estado civil podem ser úteis ao examinador. Aspectos médico-trabalhistas e periciais podem estar envolvidos, e o conhecimento do estado civil passa a ser um dado valioso

Profissão: é a atividade exercida pelo paciente, de forma profissional, e habilitada por um órgão legal competente. Exemplos: médico, professor, engenheiro, eletricitista etc.

Ocupação atual/Local de trabalho: a ocupação refere-se à atividade produtiva a que o paciente exerce, ao trabalho do dia a dia, suas atribuições. Exemplo: um profissional educador físico, que exerce, atualmente, a ocupação de *personal trainer* ou de preparador físico. Neste item também pode-se registrar casos especiais, em que o paciente não está exercendo suas atividades profissionais, devido a licença trabalhista ou aposentadoria.

Em certas ocasiões, existe uma relação direta entre o local de trabalho do indivíduo e a doença que lhe acometeu. Enquadram-se nessa categoria as chamadas doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Por exemplo, indivíduos que trabalham em pedreiras ou minas podem sofrer uma doença pulmonar determinada pela presença de substâncias inaladas ao exercerem sua profissão; chama-se *pneumoconiose*, e é uma típica doença ocupacional. O indivíduo que sofre uma fratura ao cair de um andaime é vítima de um acidente de trabalho. Em ambos os casos, ao lado dos aspectos clínicos e cirúrgicos, surgem questões de caráter pericial ou médico-trabalhista.

Em outras situações, ainda que a ocupação não seja diretamente relacionada com a doença, o ambiente no qual o trabalho é executado poderá envolver fatores que agravam uma afecção preexistente. Assim, são os locais empoeirados ou enfumaçados que agravam os portadores de enfermidades broncopulmonares, como asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

Naturalidade: local onde o paciente nasceu

Procedência: este item geralmente refere-se à residência anterior do paciente. Por exemplo, ao atender a um paciente que mora em Goiânia (GO), mas que anteriormente residiu em Belém (PA), deve-se registrar esta última localidade como a *procedência*.

Em casos de pacientes em trânsito (viagens de turismo, de negócios), a procedência confunde-se com a residência, dependendo do referencial. Por exemplo: no caso de um executivo que reside em São Paulo (SP) e faz uma viagem de negócios para Recife (PE), caso seja atendido em um hospital em Recife, sua procedência será São Paulo. Caso procure assistência médica logo depois de seu retorno a São Paulo (SP), sua procedência será Recife (PE).

O princípio de territorialização do Sistema Único de Saúde (SUS) trouxe uma nova conotação para o item procedência. Uma vez que os municípios brasileiros são divididos em territórios, o registro da *procedência territorial* é importante para questões financeiras do SUS

Residência: anota-se a residência atual (nesse local deve ser incluído o endereço do paciente).

As doenças infecciosas e parasitárias se distribuem pelo mundo em função de vários fatores, como climáticos, hidrográficos e de altitude. Conhecer o local da residência é o primeiro passo nessa área. Além disso, deve-se lembrar de passagem que a população tem muita mobilidade e os movimentos migratórios influem de modo decisivo na epidemiologia de muitas doenças infecciosas e parasitárias.

É na *identificação* do paciente e, mais especificamente, no registro de sua *residência* que esses dados emergem para uso clínico.

Citemos como exemplos a doença de Chagas, a esquistossomose, a malária e a hidatidose. O conhecimento da distribuição geográfica dessas endemias é um elemento importante no diagnóstico

Nome da mãe: anotar o nome da mãe do paciente é, hoje, uma regra bastante comum nos hospitais no sentido de diferenciar os pacientes homônimos

Nome do responsável, cuidador e/ou acompanhante: o registro do nome do responsável, cuidador e/ou acompanhante de crianças, adolescentes, idosos, tutelados ou incapazes (p. ex., problemas de cognição) faz-se necessário para que se firme a relação de corresponsabilidade ética no processo de tratamento do paciente

Religião: a religião à qual o paciente se filia tem relevância no processo saúde-doença. Alguns dados bastante objetivos, como a proibição à hemotransusão em testemunhas de Jeová e o não uso de carnes pelos fiéis da Igreja Adventista, têm uma

repercussão importante no planejamento terapêutico. Outros dados mais subjetivos podem influenciar a relação médico-paciente, uma vez que o médico usa em sua fala a pauta científica, que muitas vezes pode se contrapor à pauta religiosa pela qual o paciente compreende o mundo em que vive

Filiação a órgãos/instituições previdenciárias e planos de saúde: ter conhecimento desse fato facilita o encaminhamento para exames complementares, outros especialistas ou mesmo a hospitais, nos casos de internação. O cuidado do médico em não onerar o paciente, buscando alternativas dentro do seu plano de saúde, é fator de suma importância na adesão ao tratamento proposto.

Queixa principal

Neste item, registra-se a *queixa principal* ou o *motivo* que levou o paciente a procurar o médico, repetindo, se possível, as expressões por ele utilizadas.

É uma afirmação breve e espontânea, geralmente um sinal ou um sintoma, nas próprias palavras da pessoa, que é o motivo da consulta. Geralmente, é uma anotação entre aspas para indicar que se trata das palavras exatas do paciente.

Não aceitar, tanto quanto possível, “rótulos diagnósticos” referidos à guisa de queixa principal. Assim, se o paciente disser que seu problema é “pressão alta” ou “menopausa”, procurar-se-á esclarecer o sintoma que ficou subentendido sob uma outra denominação. Nem sempre existe uma correspondência entre a nomenclatura leiga e o significado exato do termo “científico” usado pelo paciente. Por isso, sempre se solicita a ele a tradução em linguagem corriqueira daquilo que sente. Contudo, algumas vezes é razoável o registro de um diagnóstico como queixa principal.

Boxe

É um verdadeiro risco tomar ao pé da letra os “diagnósticos” dos pacientes. Por comodidade, pressa ou ignorância, o médico pode ser induzido a aceitar, dando-lhes ares científicos, conclusões diagnósticas feitas pelos pacientes ou seus familiares. As consequências de tal procedimento podem ser muito desagradáveis. Não são poucos os indivíduos que perderam a oportunidade de submeter-se a um tratamento cirúrgico com probabilidade de cura para retirada de um câncer retal pelo fato de terem sugerido ao médico e este ter aceito o diagnóstico de “hemorroidas”. Que o paciente tenha essa suspeita após observar sangue junto com as fezes é perfeitamente compreensível e aceitável. Imperdoável, sob qualquer pretexto, é o médico aceitar esse “diagnóstico” sem ter realizado um exame anorretal que possibilitaria o reconhecimento da neoplasia causadora daquele sangramento.

Às vezes, uma pessoa pode enumerar “vários motivos” para procurar assistência médica. O motivo mais importante pode não ser o que a pessoa enunciou primeiro. Para se obter a queixa principal, nesse caso, deve-se perguntar o que a levou a procurar atendimento médico ou o que mais a incomoda no momento.

Quando o paciente chega ao médico encaminhado por outro colega ou instituição médica, no item correspondente à “queixa principal” registra-se de modo especial o *motivo da consulta*. Por exemplo: para um jovem que teve vários surtos de moléstia reumática, com ou sem sequelas cardíacas, e que vai ser submetido a uma amigalectomia e é encaminhado ao clínico ou cardiologista para averiguação da existência de “atividade reumática” ou alteração cardiovascular que impeça a execução da operação proposta, registra-se, à guisa de queixa principal: “Avaliação pré-operatória de amigdalectomia. O paciente já teve vários surtos de moléstia reumática.”

Boxe

Dicas para o estudante

Sugestões para obter a “queixa principal”:

“Qual o motivo da consulta?”

“Por que o(a) senhor(a) me procurou?”

“O que o(a) senhor(a) está sentindo?”

“O que o(a) está incomodando?”

Exemplos de “queixa principal”:

“Dor de ouvido.”

“Dor no peito há 2 h.”

“Exame periódico para o trabalho.”

História da doença atual

A *história da doença atual* (HDA) é um registro cronológico e detalhado do motivo que levou o paciente a procurar assistência médica, desde o seu início até a data atual.

A HDA, abreviatura já consagrada no linguajar médico, é a parte principal da anamnese e costuma ser a chave mestra para chegar ao diagnóstico.

Algumas histórias são simples e curtas, constituídas de poucos sintomas, facilmente dispostos em ordem cronológica e cujas relações entre si aparecem sem dificuldade. Outras histórias são longas, complexas e compostas de inúmeros sintomas cujas inter-relações não são fáceis de se encontrar.

Boxe

Normas fundamentais para se obter uma HDA

Permita ao paciente falar de sua doença

Determine o sintoma-guia

Descreva o sintoma-guia com suas características e analise-o minuciosamente

Use o sintoma-guia como fio condutor da história e estabeleça as relações das outras queixas com ele em ordem cronológica

Verifique se a história obtida tem começo, meio e fim

Não induza respostas

Apure evolução, exames e tratamentos realizados em relação à doença atual

Leia a história escrita por você para o paciente para que ele possa confirmar ou corrigir algum dado relatado, ou mesmo acrescentar alguma queixa esquecida.

Sintoma-guia

Designa-se como *sintoma-guia* o sintoma ou sinal que permite recompor a história da doença atual com mais facilidade e precisão; por exemplo: a febre na malária, a dor epigástrica na úlcera péptica, as convulsões na epilepsia, o edema na síndrome nefrótica, a diarreia na colite ulcerativa. Contudo, isso não significa que haja sempre um único e constante sintoma-guia para cada enfermidade. O encontro de um sintoma-guia é útil para todo médico, mas para o iniciante adquire especial utilidade; sem grandes conhecimentos médicos e sem experiência, acaba sendo a única maneira para ele reconstruir a história de uma doença.

Sintoma-guia não é necessariamente o mais antigo, mas tal atributo deve ser sempre levado em conta. Não é obrigatório que seja a primeira queixa relatada pelo paciente; porém, isso também não pode ser menosprezado. Nem é, tampouco, de maneira sistemática, o sintoma mais realçado pelo paciente. Na verdade, não existe uma regra fixa para determinar o sintoma-guia. Entre as muitas dificuldades existentes na realização da anamnese, uma delas é a fixação do sintoma-guia. Só a experiência, associada ao acúmulo de conhecimentos, propicia condições ideais para superá-la. Como orientação geral, o estudante deve escolher como sintoma-guia a queixa de mais longa duração, o sintoma mais salientado pelo paciente ou simplesmente começar pelo relato da “queixa principal”.

O passo seguinte é determinar a época em que teve início aquele sintoma. A pergunta padrão pode ser: “Quando o senhor começou a sentir isso?”. Nem sempre o paciente consegue se lembrar de datas exatas, mas, dentro do razoável, é indispensável estabelecer a época provável do início do sintoma. Nas doenças de início recente, os acontecimentos a elas relacionados ainda estão vivos na memória e será fácil recordá-los, ordenando-os cronologicamente. Afecções de longa duração e de começo insidioso com múltiplas manifestações causam maior dificuldade. Nesses casos mais complexos, é válido utilizar-se de certos artifícios, procurando relacionar o(s) sintoma(s) com eventos que não se esquecem (casamento, gravidez, mudanças, acidentes).

O terceiro passo consiste em investigar a maneira como evoluiu o sintoma. Muitas perguntas devem ser feitas, e cada sintoma tem suas características semiológicas. Constrói-se uma história clínica com base no modo como evoluem os sintomas.

Concomitantemente com a análise da evolução do sintoma-guia, o examinador estabelece as correlações e as inter-relações

com outras queixas.

A análise do sintoma-guia e dos outros sintomas termina com a obtenção de informações sobre como eles estão no presente momento.

Visto em conjunto esse esquema para a confecção da anamnese, verifica-se que a meta almejada é obter uma história que tenha início, meio e fim. Fica claro, também, que cada história clínica bem feita tem um fio condutor. Apesar das dificuldades iniciais, o estudante deve esforçar-se para fazer uma história que tenha o sintoma-guia como espinha dorsal, enquanto os outros sintomas se articulam com ele para formar um conjunto compreensível e lógico. Esta é a base do raciocínio clínico.

As primeiras histórias são sempre repletas de omissões porque faltam ao estudante conhecimentos sobre as doenças. Espera-se apenas que ele consiga delinear a “espinha dorsal” da história e que, com o passar do tempo, torne-se capaz de conseguir a reconstituição exata de uma história, por mais complexa que seja.

No Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*, estão descritos, de maneira objetiva, os sinais e sintomas pelos quais as doenças se manifestam.

Esquema para análise de um sintoma

Os elementos que compõem o esquema para análise de qualquer sintoma (Quadro 4.2) são:

Início

Características do sintoma

Fatores de melhora ou piora

Relação com outras queixas

Evolução

Situação atual.

Interrogatório sintomatológico

Essa parte da anamnese, denominada também *anamnese especial* ou *revisão dos sistemas*, constitui, na verdade, um complemento da história da doença atual.

O *interrogatório sintomatológico* documenta a presença ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais.

De um modo geral, uma HDA bem feita deixa pouca coisa para o interrogatório sintomatológico (IS), que é, entretanto, elemento indispensável no conjunto do exame clínico. Pode-se dizer mesmo que este só estará concluído quando um interrogatório sintomatológico, abrangendo todos os sistemas do organismo, tiver sido adequada e corretamente executado.

A principal utilidade prática do interrogatório sintomatológico reside no fato de permitir ao médico levantar possibilidades e reconhecer enfermidades que não guardam relação com o quadro sintomatológico registrado na HDA. Por exemplo: o relato de um paciente conduziu ao diagnóstico de úlcera péptica e, no IS, houve referência a edema dos membros inferiores. Esse sintoma pode despertar uma nova hipótese diagnóstica que vai culminar, por exemplo, no encontro de uma cirrose.

Em outras ocasiões, é no interrogatório sintomatológico que se origina a suspeita diagnóstica mais importante. Essa possibilidade pode ser ilustrada com o caso de um paciente que procurou o médico concentrando a sua preocupação em uma impotência sexual. Ao ser feita a revisão dos sistemas, vieram à tona os sintomas *polidipsia*, *poliúria* e *emagrecimento*, queixas às quais o paciente não havia dado a menor importância. No entanto, a partir delas o médico levantou a suspeita da enfermidade principal daquele paciente – o diabetes melito.

Além disso, é comum o paciente não relatar um ou outro sintoma durante a elaboração da história da doença atual. Tais omissões não querem dizer, necessariamente, que tudo foi informado. Simples esquecimento ou medo inconsciente de determinados diagnósticos podem levar o paciente a não se referir a padecimentos de valor crucial para chegar a um diagnóstico.

Boxe

Importância da promoção à saúde

Outra importante função do interrogatório sintomatológico é avaliar práticas de promoção à saúde. Enquanto se avalia o estado de saúde passado e presente de cada sistema corporal, aproveita-se para promover saúde, orientando e esclarecendo o paciente sobre maneiras de prevenir doenças e evitar riscos à saúde.

Quadro 4.2

Esquema para análise de um sintoma.

Como avaliar o sintoma		Exemplo: dor
Início	Deve ser caracterizado com relação à época de aparecimento. Se foi de início súbito ou gradativo, se teve fator desencadeante ou não	Médico: “Quando a dor surgiu?” Paciente: “Há 3 dias.” Médico: “Como ela começou?” Paciente: “De repente, depois que peguei um saco de cimento.”
Características do sintoma	Definir localização, duração, intensidade, frequência, tipo, ou seja, características próprias a depender do sintoma	Médico: “Onde dói?” Paciente: “A dor é no peito, do lado direito, na frente.” Médico: “A dor irradia? Ela ‘anda’?” Paciente: “A dor vai para as costas.” Médico: “Quanto tempo dura?” Paciente: “O tempo todo, não para.” Médico: “Como é essa dor?” Paciente: “É uma dor forte, em pontada.”
Fatores de melhora ou piora	Definir quais fatores melhoram e pioram o sintoma, como, por exemplo, fatores ambientais, posição, atividade física ou repouso, alimentos ou uso de medicamentos	Médico: “O que melhora a dor?” Paciente: “Melhora quando eu deito do lado direito.” Médico: “O que piora a dor?” Paciente: “A dor piora quando faço esforço físico e à noite quando esfria o tempo.”
Relação com outras queixas	Registrar se existe alguma manifestação ou queixa que acompanhe o sintoma, geralmente relacionado com o segmento anatômico ou funcional acometido pelo sintoma	Médico: “Você está tossindo?” Paciente: “Não.” Médico: “Você tem falta de ar?” Paciente: “Eu sinto um pouco de falta de ar sim.”
Evolução	Registrar o comportamento do sintoma ao longo do tempo, relatando modificações das características e influência de tratamentos efetuados	Médico: “Essa dor se modificou nestes 3 dias?” Paciente: “Ontem eu tomei uma analgésico e a dor melhorou, mas é só o efeito do remédio acabar que a dor volta.”
Situação atual	Registrar como o sintoma está no momento da anamnese também é importante	Médico: “Como está a dor agora?” Paciente: “Agora a dor está muito forte e está dificultando minha respiração. Nada mais melhora. Preciso de ajuda.”

A única maneira de realizar uma boa anamnese especial, particularmente nessa fase de iniciação clínica, é seguir um esquema rígido, constituído de um conjunto de perguntas que correspondam a todos os sintomas indicativos de alterações dos vários aparelhos do organismo. Mais ainda: para tirar o máximo proveito das atividades práticas, o estudante registrará os sintomas presentes e os negados pelo paciente.

A simples citação de uma queixa tem algum valor; porém, muito mais útil é o registro das suas características semiológicas fundamentais.

Boxe

Embora o IS seja a parte mais longa da anamnese e pareça ao estudante algo cansativo cumpre ressaltar que:

A proposta de atender ao paciente de maneira holística inclui o conhecimento de todos os sistemas corporais em seus sintomas e na dimensão da promoção da saúde

Pensando no paciente como um ser mutável e em desenvolvimento, é necessário que se registre o estado atual de todo o seu organismo, para se ter um parâmetro no caso de futuras queixas e adoecimento.

Por exemplo: se, na primeira consulta, o paciente não se queixou de nenhum sintoma referente ao sistema respiratório e, ao retornar após 2 meses, relata tosse com escarros amarelados e dispneia, o médico pode ter uma ideia clara do aparecimento de uma nova doença

Muitas vezes, o adoecimento de um sistema corporal tem correlação com outro sistema, e há necessidade de tal conhecimento para adequar a proposta terapêutica. Um exemplo é a hipertensão arterial, em que pode existir comprometimento dos sistemas cardiovascular, renal, nervoso e endócrino.

Sistematização do interrogatório sintomatológico

Não é fácil sintetizar o interrogatório sintomatológico quando se tem como permanente preocupação uma visão global do paciente. Sem dúvida, a melhor maneira é levar em conta os segmentos do corpo, mas os sistemas do organismo abrangem quase sempre mais de um segmento. A solução é conciliar as duas coisas, reunindo em cada segmento os órgãos de diferentes aparelhos, quando isso for possível. Os sistemas que não se enquadram nesse esquema são investigados em sequência.

No início do aprendizado clínico são muitas as dificuldades, desde a incompreensão dos termos usados pelos pacientes até a escassez de conhecimentos clínicos, além do longo tempo necessário para fazer o interrogatório sintomatológico. Mas é um exercício imprescindível no aprendizado do método clínico. À medida que se adquire experiência, pode-se simplificar de modo a adaptá-lo às circunstâncias em que o exame clínico é realizado. O domínio do método clínico exige um esforço especial nessa fase; porém, a chave do problema está no exame do maior número possível de pacientes, seguindo-se a sistematização proposta a seguir:

1. Sintomas gerais
2. Pele e fâneros
3. Cabeça e pescoço
4. Tórax
5. Abdome
6. Sistema geniturinário
7. Sistema hemolinfopoético
8. Sistema endócrino
9. Coluna vertebral, ossos, articulações e extremidades
10. Músculos
11. Artérias, veias, linfáticos e microcirculação
12. Sistema nervoso
13. Exame psíquico e avaliação das condições emocionais.

Boxe

O Capítulo 6, Sinais e Sintomas, deve ser consultado frequentemente para conhecimentos adicionais sobre as manifestações clínicas das doenças.

Sintomas gerais

Febre. Sensação de aumento da temperatura corporal acompanhada ou não de outros sintomas quando então caracteriza-se a síndrome febril (cefaleia, calafrios, sede etc.).

Astenia. Sensação de fraqueza.

Alterações do peso. Especificar perda ou ganho de peso, quantos quilos, intervalo de tempo e motivo (dieta, estresse, outros fatores).

Sudorese. Eliminação abundante de suor. Generalizada ou predominante nas mãos e pés.

Calafrios. Sensação momentânea de frio com ereção de pelos e arrepiamento da pele. Relação com febre.

Cãibras. Contrações involuntárias de um músculo ou grupo muscular.

Pele e fâneros

Alterações da pele. Cor, textura, umidade, temperatura, sensibilidade, prurido, lesões.

Alterações dos fâneros. Queda de cabelos, pelos faciais em mulheres, alterações nas unhas.

Promoção da saúde. Exposição solar (hora do dia, uso de protetor solar); cuidados com pele e cabelos (bronzamento artificial, tinturas).

Cabeça e pescoço

CRÂNIO, FACE E PESCOÇO

Dor. Localizar o mais corretamente possível a sensação dolorosa. A partir daí, indaga-se sobre as outras características semiológicas da dor.

Alterações do pescoço. Dor, tumorações, alterações dos movimentos, pulsações anormais.

OLHOS

Diminuição ou perda da visão. Uni ou bilateral, súbita ou gradual, relação com a intensidade da iluminação, visão noturna, correção (parcial ou total) com óculos ou lentes de contato.

Dor ocular e cefaleia. Bem localizada pelo paciente ou de localização imprecisa no globo ocular.

Sensação de corpo estranho. Sensação desagradável quase sempre acompanhada de dor.

Prurido. Sensação de coceira.

Queimação ou ardência. Acompanhando ou não a sensação dolorosa.

Lacrimejamento. Eliminação de lágrimas, independentemente do choro.

Sensação de olho seco. Sensação de secura, como se o olho não tivesse lágrimas.

Xantopsia, iantopsia e cloropsia. Visão amarelada, violeta e verde, respectivamente.

Diplopia. Visão dupla, constante ou intermitente.

Fotofobia. Hipersensibilidade à luz.

Nistagmo. Movimentos repetitivos rítmicos dos olhos, tipo de nistagmo.

Escotomas. Manchas ou pontos escuros no campo visual, descritos como manchas, moscas que voam diante dos olhos ou pontos luminosos.

Secreção. Líquido purulento que recobre as estruturas externas do olho.

Vermelhidão. Presença de congestão de vasos na esclerótica.

Alucinações visuais. Sensação de luz, cores ou reproduções de objetos.

Promoção da saúde. Uso de óculos ou lentes de contato, último exame oftálmico.

OUVIDOS

Dor. Localizada ou irradiada de outra região.

Otorreia. Saída de líquido pelo ouvido.

Otorragia. Perda de sangue pelo canal auditivo, relação com traumatismo.

Distúrbios da acuidade auditiva. Perda parcial ou total da audição, uni ou bilateral; início súbito ou progressivo.

Zumbidos. Sensação subjetiva de diferentes tipos de ruídos (campainha, grilos, apito, chiado, cachoeira, jato de vapor, zunido).

Vertigem e tontura. Sensação de estar girando em torno dos objetos (vertigem subjetiva) ou os objetos girando em torno de si (vertigem objetiva).

Promoção da saúde. Uso de aparelhos auditivos; exposição a ruídos ambientais; uso de equipamentos de proteção individual (EPI); limpeza do pavilhão auditivo (cotonetes, outros objetos, pelo médico).

NARIZ E CAVIDADES PARANASAIS

Prurido. Pode resultar de doença local ou sistêmica.

Dor. Localizada no nariz ou na face. Verificar todas as características semiológicas da dor.

Espirros. Isolados ou em crises. Indagar em que condições ocorrem, procurando detectar locais ou substâncias relacionados com os espirros.

Obstrução nasal. Rinorreia; aspecto do corrimento (aquoso, purulento, sanguinolento); cheiro.

Corrimento nasal. Aspecto do corrimento (aquoso, purulento, sanguinolento).

Epistaxe. Hemorragia nasal.

Dispneia. Falta de ar.

Diminuição do olfato. Diminuição (hiposmia) ou abolição (anosmia).

Aumento do olfato. Transitório ou permanente.

Alterações do olfato. Percepção anormal de cheiros.

Cacosmia. Consiste em sentir mau cheiro, sem razão para tal.

Parosmia. Perversão do olfato.

Alterações da fonação. Voz anasalada (rinolalia).

CAVIDADE BUCAL E ANEXOS

Alterações do apetite. Polifagia ou hiperorexia; inapetência ou anorexia; perversão do apetite (geofagia ou outros tipos).

Sialose. Excessiva produção de secreção salivar.

Halitose. Mau hálito.

Dor. Dor de dente, nas glândulas salivares, na língua (glossalgia), na articulação temporomandibular. Trismo.

Úlceras/Sangramento. Causa local ou doença do sistema hemopoético.

Promoção da saúde. Escovação de dentes e língua (vezes/dia); último exame odontológico.

FARINGE

Dor de garganta. Espontânea ou provocada pela deglutição. Verificar todas as características semiológicas da dor.

Dispneia. Dificuldade para respirar relacionada com a faringe.

Disfagia. Dificuldade de deglutir localizada na bucofaringe (disfagia alta).

Tosse. Seca ou produtiva.

Halitose. Mau hálito.

Pigarro. Ato de raspar a garganta.

Ronco. Pode estar associado à apneia do sono.

LARINGE

Dor. Espontânea ou à deglutição. Verificar as outras características semiológicas da dor.

Dispneia. Dificuldade para respirar.

Alterações da voz. Disfonia; afonia; voz lenta e monótona; voz fanhosa ou anasalada.

Tosse. Seca ou produtiva; tosse rouca; tosse bitonal.

Disfagia. Disfagia alta.

Pigarro. Ato de raspar a garganta.

Promoção da saúde. Cuidados com a voz (gargarejos, produtos utilizados).

TIREOIDE E PARATIREOIDES

Dor. Espontânea ou à deglutição. Verificar as outras características semiológicas.

Outras alterações. Nódulo, bócio, rouquidão, dispneia, disfagia.

VASOS E LINFONODOS

Dor. Localização e outras características semiológicas.

Adenomegalias. Localização e outras características semiológicas.

Pulsações e turgência jugular.

Tórax

PAREDE TORÁCICA

Dor. Localização e demais características semiológicas, em particular a relação da dor com os movimentos do tórax.

Alterações da forma do tórax. Alterações localizadas na caixa torácica como um todo.

Dispneia. Relacionada com dor ou alterações da configuração do tórax.

MAMAS

Dor. Relação com a menstruação e outras características semiológicas.

Nódulos. Localização e evolução; modificações durante o ciclo menstrual.

Secreção mamilar. Uni ou bilateral, espontânea ou provocada; aspecto da secreção.

Promoção da saúde. Autoexame mamário; última mamografia/USG (mulheres ≥ 40 anos).

TRAQUEIA, BRÔNQUIOS, PULMÕES E PLEURAS

Dor. Localização e outras características semiológicas.

Tosse. Seca ou com expectoração. Frequência, intensidade, tonalidade, relação com o decúbito, período em que predomina.

Expectoração. Volume, cor, odor, aspecto e consistência. Tipos de expectoração: mucoide, serosa, purulenta, mucopurulenta,

hemoptoica.

Hemoptise. Eliminação de sangue pela boca, através da glote, proveniente dos brônquios ou pulmões. Obter os dados para diferenciar a hemoptise da epistaxe e da hematêmese.

Vômica. Eliminação súbita, através da glote, de quantidade abundante de pus ou líquido de aspecto mucoide ou seroso.

Dispneia. Relação com esforço ou decúbito; instalação súbita ou gradativa; relação com tosse ou chieira; tipo de dispneia.

Chieira. Ruído sibilante percebido pelo paciente durante a respiração; relação com tosse e dispneia; uni ou bilateral; horário em que predomina.

Cornagem. Ruído grave provocado pela passagem do ar pelas vias respiratórias altas reduzidas de calibre.

Estridor. Respiração ruidosa, algo parecido com cornagem.

Tiragem. Aumento da retração dos espaços intercostais.

DIAFRAGMA E MEDIASTINO

Dor. Localização e demais características semiológicas.

Soluço. Contrações espasmódicas do diafragma, concomitantes com o fechamento da glote, acompanhadas de um ruído rouco. Isolados ou em crises.

Dispneia. Dificuldade respiratória.

Sintomas de compressão. Relacionados com o comprometimento do simpático, do nervo recorrente, do frênico, das veias cavas, das vias respiratórias e do esôfago.

Promoção da saúde. Exposição a alergênicos (qual); última radiografia de tórax.

CORAÇÃO E GRANDES VASOS

Dor. Localização e outras características semiológicas; dor isquêmica (angina do peito e infarto do miocárdio); dor da pericardite; dor de origem aórtica; dor de origem psicogênica.

Palpitações. Percepção incômoda dos batimentos cardíacos; tipo de sensação, horário de aparecimento, modo de instalação e desaparecimento; relação com esforço ou outros fatores desencadeantes.

Dispneia. Relação com esforço e decúbito; dispneia paroxística noturna; dispneia periódica ou de Cheyne-Stokes.

Intolerância aos esforços. Sensação desagradável ao fazer esforço físico.

Tosse e expectoração. Tosse seca ou produtiva; relação com esforço e decúbito; tipo de expectoração (serosa, serossanguinolenta).

Chieira. Relação com dispneia e tosse: horário em que predomina.

Hemoptise. Quantidade e características do sangue eliminado. Obter dados para diferenciar da epistaxe e da hematêmese.

Desmaio e síncope. Perda súbita e transitória, parcial ou total, da consciência; situação em que ocorreu; duração; manifestações que antecederam o desmaio e que vieram depois.

Alterações do sono. Insônia; sono inquieto.

Cianose. Coloração azulada da pele; época do aparecimento (desde o nascimento ou surgiu tempos depois); intensidade; relação com choro e esforço.

Edema. Época em que apareceu; como evoluiu, região em que predomina.

Astenia. Sensação de fraqueza.

Posição de cócoras. O paciente fica agachado, apoiando as nádegas nos calcanhares.

Promoção da saúde. Exposição a fatores estressantes; último *check-up* cardiológico.

ESÔFAGO

Disfagia. Dificuldade à deglutição; disfagia alta (bucofaríngea); disfagia baixa (esofágica).

Odinofagia. Dor retroesternal durante a deglutição.

Dor. Independente da deglutição.

Pirose. Sensação de queimação retroesternal; relação com a ingestão de alimentos ou medicamentos; horário em que aparece.

Regurgitação. Volta à cavidade bucal de alimento ou de secreções contidas no esôfago ou no estômago.

Eructação. Relação com a ingestão de alimentos ou com alterações emocionais.

Soluço. Horário em que aparece; isolado ou em crise; duração.

Hematêmese. Vômito de sangue; características do sangue eliminado; diferenciar de epistaxe e de hemoptise.

Sialose (sialorreia ou ptialismo). Produção excessiva de secreção salivar.

Abdome

O interrogatório sobre os sintomas das doenças abdominais inclui vários sistemas, mas, por comodidade, é melhor nos restringirmos aos órgãos do sistema digestivo. Os outros órgãos localizados no abdome devem ser analisados separadamente, reunindo-se o sistema urinário com os órgãos genitais, o sistema endócrino e o hemolinfopoético.

PAREDE ABDOMINAL

Dor. Localização e outras características semiológicas.

Alterações da forma e do volume. Crescimento do abdome; hérnias; tumorações.

ESTÔMAGO

Dor. Localização na região epigástrica; outras características semiológicas.

Náuseas e vômitos. Horário em que aparecem; relação com a ingestão de alimentos; aspecto dos vômitos.

Dispepsia. Conjunto de sintomas constituído de desconforto epigástrico, empanzinamento, sensação de distensão por gases, náuseas, intolerância a determinados alimentos.

Pirose. Sensação de queimação retroesternal.

INTESTINO DELGADO

Diarreia. Duração; volume; consistência, aspecto e cheiro das fezes.

Esteatorreia. Aumento da quantidade de gorduras excretadas nas fezes.

Dor. Localização, contínua ou em cólicas.

Distensão abdominal, flatulência e dispepsia. Relação com ingestão de alimentos.

Hemorragia digestiva. Aspecto “em borra de café” (melena) ou sangue vivo (enterorragia).

CÓLON, RETO E ÂNUS

Dor. Localização abdominal ou perianal; outras características semiológicas; tenesmo.

Diarreia. Diarreia baixa; aguda ou crônica; disenteria.

Obstipação intestinal. Duração; aspecto das fezes.

Sangramento anal. Relação com a defecação.

Prurido. Intensidade; horário em que predomina.

Distensão abdominal. Sensação de gases no abdome.

Náuseas e vômitos. Aspecto do vômito; vômitos fecaloides.

FÍGADO E VIAS BILIARES

Dor. Dor contínua ou em cólica; localização no hipocôndrio direito; outras características semiológicas.

Icterícia. Intensidade; duração e evolução; cor da urina e das fezes; prurido.

PÂNCREAS

Dor. Localização (epigástrica) e demais características semiológicas.

Icterícia. Intensidade; duração e evolução; cor da urina e das fezes; prurido.

Diarreia e esteatorreia. Características das fezes.

Náuseas e vômitos. Tipo de vômito.

Promoção da saúde. Uso de antiácidos, laxantes ou “chás digestivos”.

Sistema geniturinário

RINS E VIAS URINÁRIAS

Dor. Localização e demais características semiológicas.

Alterações miccionais. Incontinência; hesitação; modificações do jato urinário; retenção urinária.

Alterações do volume e do ritmo urinário. Oligúria; anúria; poliúria; disúria; noctúria; urgência; polaciúria.

Alterações da cor da urina. Urina turva; hematúria; hemoglobínúria; mioglobínúria; porfirinúria.

Alterações do cheiro da urina. Mau cheiro.

Dor. Dor lombar e no flanco e demais características semiológicas; dor vesical; estrangúria; dor perineal.

Edema. Localização; intensidade; duração.

Febre. Calafrios associados.

ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS

Lesões penianas. Úlceras, vesículas (herpes, sífilis, cancro mole).

Nódulos nos testículos. Tumor, varicocele.

Distúrbios miccionais. Ver *Rins e vias urinárias*.

Dor. Testicular; perineal; lombossacra; características semiológicas.

Priapismo. Ereção persistente, dolorosa, sem desejo sexual.

Hemospermia. Presença de sangue no esperma.

Corrimento uretral. Aspecto da secreção.

Disfunções sexuais. Disfunção erétil; ejaculação precoce; ausência de ejaculação, anorgasmia, diminuição da libido, síndromes por deficiência de hormônios testiculares (síndrome de Klinefelter, puberdade atrasada).

Promoção da saúde. Autoexame testicular; último exame prostático ou PSA; uso de preservativos.

ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS

Ciclo menstrual. Data da primeira menstruação; duração dos ciclos subsequentes.

Distúrbios menstruais. Polimenorreia; oligomenorreia; amenorreia; hipermenorreia; hipomenorreia; menorragia; dismenorreia.

Tensão pré-menstrual. Cólicas; outros sintomas.

Hemorragias. Relação com o ciclo menstrual.

Corrimento. Quantidade; aspecto; relação com as diferentes fases do ciclo menstrual.

Prurido. Localizado na vulva.

Disfunções sexuais. Dispareunia; frigidez; diminuição da libido; anorgasmia.

Menopausa e climatério. Idade em que ocorreu a menopausa; fogachos ou ondas de calor; insônia.

Alterações endócrinas. Amenorreia; síndrome de Turner.

Promoção da saúde. Último exame ginecológico; último Papanicolaou; uso de preservativos; terapia de reposição hormonal.

Sistema hemolinfopoético

Astenia. Instalação lenta ou progressiva.

Hemorragias. Petéquias; equimoses; hematomas; gengivorragia; hematúria; hemorragia digestiva.

Adenomegalias. Localizadas ou generalizadas; sinais flogísticos; fistulização.

Febre. Tipo da curva térmica.

Esplenomegalia e hepatomegalia. Época do aparecimento; evolução.

Dor. Bucofaringe; tórax; abdome; articulações; ossos.

Icterícia. Cor das fezes e da urina.

Manifestações cutâneas. Petéquias; equimoses; palidez; prurido; eritemas; pápulas; herpes.

Sintomas osteoarticulares.

Sintomas cardiorrespiratórios.

Sintomas gastrintestinais.

Sintomas geniturinários.

Sintomas neurológicos.

Sistema endócrino

O interrogatório dos sintomas relacionados com as glândulas endócrinas abrange o organismo como um todo, desde os sintomas gerais até o psíquico, mas há interesse em caracterizar um grupo de manifestações clínicas diretamente relacionadas com cada glândula para desenvolver a capacidade de reconhecimento, pelo clínico geral, dessas enfermidades.

HIPOTÁLAMO E HIPÓFISE

Alterações do desenvolvimento físico. Nanismo, gigantismo, acromegalia.

Alterações do desenvolvimento sexual. Puberdade precoce; puberdade atrasada.

Outras alterações. Galactorreia; síndromes poliúricas; alterações visuais.

TIREOIDE

Alterações locais. Dor; nódulo; bócio; rouquidão; dispneia; disfagia.

Manifestações de hiperfunção. Hipersensibilidade ao calor; aumento da sudorese; perda de peso; taquicardia; tremor; irritabilidade; insônia; astenia; diarreia; exoftalmia.

Manifestações de hipofunção. Hipersensibilidade ao frio; diminuição da sudorese; aumento do peso; obstipação intestinal; cansaço facial; apatia; sonolência; alterações menstruais; ginecomastia; unhas quebradiças; pele seca; rouquidão; macroglossia;

bradicardia.

PARATIREOIDES

Manifestações de hiperfunção. Emagrecimento; astenia; parestesias; câibras; dor nos ossos e nas articulações; arritmias cardíacas; alterações ósseas; raquitismo; osteomalacia; tetania.

Manifestações de hipofunção. Tetania; convulsões; queda de cabelos; unhas frágeis e quebradiças; dentes hipoplásicos; catarata.

SUPRARRENAIS

Manifestações por hiperprodução de glicocorticoides. Aumento de peso; fâcies “de lua cheia”; acúmulo de gordura na face, região cervical e dorso; fraqueza muscular; poliúria; polidipsia; irregularidade menstrual; infertilidade; hipertensão arterial.

Manifestações por diminuição de glicocorticoides. Anorexia; náuseas e vômitos; astenia; hipotensão arterial; hiperpigmentação da pele e das mucosas.

Aumento de produção de mineralocorticoides. Hipertensão arterial; astenia; câibras; parestesias.

Aumento da produção de esteroides sexuais. Pseudopuberdade precoce; hirsutismo; virilismo.

Aumento de produção de catecolaminas. Crises de hipertensão arterial, cefaleia, palpitações, sudorese.

GÔNADAS

Alterações locais e em outras regiões corporais indicativas de anormalidades da função endócrina.

Coluna vertebral, ossos, articulações e extremidades

Neste item, além do sistema locomotor, serão analisados órgãos pertencentes a outros sistemas pela sua localização nas extremidades.

COLUNA VERTEBRAL

Dor. Localização cervical, dorsal, lombossacra; relação com os movimentos; demais características semiológicas.

Rigidez pós-reposo. Tempo de duração após iniciar as atividades.

OSSOS

Dor. Localização e demais características semiológicas.

Deformidades ósseas. Caroços; arqueamento do osso; rosário raquítico.

ARTICULAÇÕES

Dor. Localização e demais características semiológicas.

Rigidez pós-reposo. Pela manhã.

Sinais inflamatórios. Edema, calor, rubor e dor.

Crepitação articular. Localização.

Manifestações sistêmicas. Febre; astenia; anorexia; perda de peso.

BURSAS E TENDÕES

Dor. Localização e demais características semiológicas.

Limitação de movimento. Localização; grau de limitação.

MÚSCULOS

Fraqueza muscular. Segmentar; generalizada; evolução no decorrer do dia.

Dificuldade para andar ou para subir escadas.

Atrofia muscular. Localização.

Dor. Localização e demais características semiológicas; câibras.

Câibras. Dor acompanhada de contração muscular.

Espasmos musculares. Miotonia; tétano.

Artérias, veias, linfáticos e microcirculação

ARTÉRIAS

Dor. Claudicação intermitente; dor de repouso.

Alterações da cor da pele. Palidez, cianose, rubor, fenômeno de Raynaud.

Alterações da temperatura da pele. Frialdade localizada.

Alterações tróficas. Atrofia da pele, diminuição do tecido subcutâneo, queda de pelos, alterações ungueais, calosidades, ulcerações, edema, sufusões hemorrágicas, bolhas e gangrena.

Edema. Localização; duração e evolução.

VEIAS

Dor. Tipo de dor; fatores que a agravam ou aliviam.

Edema. Localização. Duração e evolução.

Alterações tróficas. Hiperpigmentação, celulite, eczema, úlceras, dermatofibrose.

LINFÁTICOS

Dor. Localização no trajeto do coletor linfático e/ou na área do linfonodo correspondente.

Edema. Instalação insidiosa. Lesões secundárias ao edema de longa duração (hiperqueratose, lesões verrucosas, elefantíase).

MICROCIRCULAÇÃO

Alterações da coloração e da temperatura da pele. Acrocianose; livedo reticular; fenômeno de Raynaud; eritromegalia; palidez.

Alterações da sensibilidade. Sensação de dedo morto, hiperestesia, dormências e formigamentos.

Promoção da saúde. Cuidados com a postura; hábito de levantar peso; movimentos repetitivos; uso de saltos muito altos; prática de ginástica laboral.

Sistema nervoso

Distúrbios da consciência. Obnubilação; estado de coma.

Dor de cabeça e na face. Localização e outras características semiológicas.

Tontura e vertigem. Sensação de rotação (vertigem); sensação de iminente desmaio; sensação de desequilíbrio; sensação desagradável na cabeça.

Convulsões. Localizadas ou generalizadas, tônicas ou clônicas; manifestações ocorridas antes (pródromos) e depois das convulsões.

Ausências. Breves períodos de perda da consciência.

Automatismos. Tipos.

Amnésia. Perda da memória, transitória ou permanente; relação com traumatismo craniano e com ingestão de bebidas alcoólicas.

Distúrbios visuais. Ambliopia; amaurose; hemianopsia; diplopia.

Distúrbios auditivos. Hipocusia; acusia; zumbidos.

Distúrbios da marcha. Disbasia.

Distúrbios da motricidade voluntária e da sensibilidade. Paresias, paralisias, parestesias, anestésias.

Distúrbios esfinterianos. Bexiga neurogênica; incontinência fecal.

Distúrbios do sono. Insônia; sonolência; sonolóquio; pesadelos; terror noturno; sonambulismo; biquismo; movimentos rítmicos da cabeça; enurese noturna.

Distúrbios das funções cerebrais superiores. Disfonia; disartria; dislalia; disritmolalia; dislexia; disgrafia; afasia; distúrbios das gnosias; distúrbios das praxias (ver também Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

Promoção da saúde. Uso de andadores, bengalas ou cadeira de rodas; fisioterapia.

Exame psíquico e avaliação das condições emocionais (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*)

Consciência. Alterações quantitativas (normal, obnubilação, perda parcial ou total da consciência) e qualitativas.

Atenção. Nível de atenção e outras alterações.

Orientação. Orientação autopsíquica (capacidade de uma pessoa saber quem ela é), orientação no tempo e no espaço. Dupla orientação, despersonalização, dupla personalidade, perda do sentimento de existência.

Pensamento. Pensamento normal ou pensamento fantástico, pensamento maníaco, pensamento inibido, pensamento esquizofrênico, desagregação do pensamento, bloqueio do pensamento, ambivalência, perseveração, pensamentos subtraídos, sonorização do pensamento, pensamento incoerente, pensamento prolixo, pensamento oligofrênico, pensamento demencial, ideias delirantes, fobias, obsessões, compulsões.

Memória. Capacidade de recordar. Alterações da memória de fixação e de evocação. Memória recente e remota. Alterações qualitativas da memória.

Inteligência. Capacidade de adaptar o pensamento às necessidades do momento presente ou de adquirir novos conhecimentos. Déficit intelectual.

Sensopercepção. Capacidade de uma pessoa apreender as impressões sensoriais. Ilusões. Alucinações.

Vontade. Disposição para agir a partir de uma escolha ou decisão; perda da vontade; negativismo; atos impulsivos.

Psicomotricidade. Expressão objetiva da vida psíquica nos gestos e movimentos; alterações da psicomotricidade; estupor.

Afetividade. Compreende um conjunto de vivências, incluindo sentimentos complexos; humor ou estado de ânimo; exaltação e depressão do humor.

Comportamento. Importante questionar comportamentos inadequados e antissociais. Idosos podem apresentar comportamentos sugestivos de quadros demenciais.

Outros. Questionar também sobre alucinações visuais e auditivas, atos compulsivos, pensamentos obsessivos recorrentes, exacerbação da ansiedade, sensação de angústia e de medo constante, dificuldade em ficar em ambientes fechados (claustrofobia) ou em ambientes abertos (agorafobia), onicofagia (hábito de roer as unhas), tricotomia (hábito de comer cabelos), tiques e vômitos induzidos.

Boxe

Dicas para o estudante

Antes de iniciar o interrogatório sistematológico (IS), explique ao paciente que você irá fazer questionamentos sobre todos os sistemas corporais (revisão “da cabeça aos pés”), mesmo não tendo relação com o sistema que o motivou a procurá-lo. Assim, você terá preparado o paciente para a série de perguntas que compõe

o IS

Inicie a avaliação de cada sistema corporal com essas perguntas gerais. Exemplos: “Como estão seus olhos e visão?”, “Como anda sua digestão?” ou “Seu intestino funciona regularmente?”. A resposta permitirá que você, se necessário, passe para perguntas mais específicas, e, assim, detalhe a queixa

Não induza respostas com perguntas que afirmam ou neguem o sintoma, como por exemplo: “O senhor está com falta de ar, não é?” ou “O senhor não está com falta de ar, não é mesmo?” Nesse caso, o correto é apenas questionar: “O senhor sente falta de ar?”

Antecedentes pessoais e familiares

A investigação dos antecedentes não pode ser esquematizada rigidamente. É possível e útil, entretanto, uma sistematização que sirva como roteiro e diretriz de trabalho.

Antecedentes pessoais

Considera-se avaliação do estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo fatores pessoais e familiares que influenciam seu processo saúde-doença.

Nos indivíduos de baixa idade, a análise dos antecedentes pessoais costuma ser feita com mais facilidade do que em outras faixas etárias.

Às vezes, uma hipótese diagnóstica leva o examinador a uma indagação mais minuciosa de algum aspecto da vida pregressa. Por exemplo: ao encontrar-se uma cardiopatia congênita, investiga-se a possível ocorrência de rubéola na mãe durante o primeiro trimestre da gravidez. O interesse dessa indagação é por saber-se que essa virose costuma causar defeitos congênitos em elevada proporção dos casos.

Os passos a serem seguidos abrangem os *antecedentes fisiológicos* e *antecedentes patológicos*.

Antecedentes pessoais fisiológicos

A avaliação dos antecedentes pessoais fisiológicos inclui os seguintes itens: *gestação e nascimento*, *desenvolvimento psicomotor e neural* e *desenvolvimento sexual*.

GESTAÇÃO E NASCIMENTO

Investigar:

- Como decorreu a gravidez
- Uso de medicamentos ou radiações sofridas pela genitora
- Víroses contraídas durante a gestação
- Condições de parto (normal, fórceps, cesariana)
- Estado da criança ao nascer
- Ordem do nascimento (se é primogênito, segundo filho etc.)
- Número de irmãos.

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E NEURAL

Investigar:

- Dentição: informações sobre a primeira e a segunda dentições, registrando-se a época em que apareceu o primeiro dente
- Engatinhar e andar: anotar as idades em que essas atividades tiveram início
- Fala: quando começou a pronunciar as primeiras palavras
- Desenvolvimento físico: peso e tamanho ao nascer e posteriores medidas. Averiguar sobre o desenvolvimento comparativamente com os irmãos
- Controle dos esfíncteres
- Aproveitamento escolar.

DESENVOLVIMENTO SEXUAL

Investigar:

- Puberdade: estabelecer época de seu início

Menarca: estabelecer idade da 1ª menstruação

Sexarca: estabelecer idade da 1ª relação sexual

Menopausa (última menstruação): estabelecer época do seu aparecimento

Orientação sexual: atualmente, usam-se siglas como HSM; HSH; HSMH; MSH; MSM; MSHM, em que: H – homem; M – mulher e S – faz sexo com.

Antecedentes pessoais patológicos

A avaliação dos antecedentes pessoais patológicos compreende os seguintes itens:

Doenças sofridas pelo paciente: começando-se pelas mais comuns na infância (sarampo, varicela, coqueluche, caxumba, moléstia reumática, amigdalites) e passando às da vida adulta (pneumonia, hepatite, malária, pleurite, tuberculose, hipertensão arterial, diabetes, artrose, osteoporose, litíase renal, gota, entre outras). Pode ser que o paciente não saiba informar o diagnóstico, mas consiga se lembrar de determinado sintoma ou sinal que teve importância para ele, como icterícia e febre prolongada

Alergia: quando se depara com um caso de doença alérgica, essa investigação passa a ter relevância especial, mas, independente disso, é possível e útil tomar conhecimento da existência de alergia a alimentos, medicamentos ou outras substâncias. Se o paciente já sofreu de afecções de fundo alérgico (eczema, urticária, asma), esse fato merece registro

Cirurgias: anotam-se as intervenções cirúrgicas ou outros tipos de intervenção referindo-se os motivos que a determinaram. Havendo possibilidade, registrar a data, o tipo de cirurgia, o diagnóstico que a justificou e o nome do hospital onde foi realizada

Traumatismo: é necessário indagar sobre o acidente em si e sobre as consequências deste. Em medicina trabalhista, este item é muito importante por causa das implicações periciais decorrentes dos acidentes de trabalho.

A correlação entre um padecimento atual e um traumatismo anterior pode ser sugerida pelo paciente sem muita consistência. Nesses casos, a investigação anamnésica necessita ser detalhada para que o examinador tire uma conclusão própria a respeito da existência ou não da correlação sugerida

Transfusões sanguíneas: anotar número de transfusões, quando ocorreu, onde e por quê

História obstétrica: anotar número de gestações (G); número de partos (P); número de abortos (A); número de prematuros e número de cesarianas (C) (G – P – A – C)

Paternidade: paciente do sexo masculino, questionar número de filhos

Imunizações: anotar as vacinas (qual; época da aplicação/doses)

Medicamentos em uso: anotar: qual, posologia, motivo, quem prescreveu.

Boxe

Dicas para o estudante

Investigue se o paciente tomou as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde de acordo com a faixa etária:

Crianças: BCG; difteria; tétano; coqueluche; hepatite B; poliomielite; meningite por *influenza* B; meningocócica C; pneumocócica 10; sarampo; rubéola; varicela; caxumba; rotavírus (diarreias); febre amarela (a cada 10 anos)

Adolescentes: difteria; tétano; hepatite B; sarampo; caxumba; rubéola; febre amarela (a cada 10 anos)

Adultos e idosos: difteria; tétano; sarampo; caxumba; rubéola; febre amarela (a cada 10 anos). Para 60 anos ou mais: *influenza* ou gripe; pneumonia por pneumococo.

Fonte: Portal do Ministério da Saúde (www.portal.saude.gov.br).

Antecedentes familiares

Os antecedentes começam com a menção ao estado de saúde (quando vivos) dos pais e irmãos do paciente. Se for casado, inclui-se o cônjuge e, se tiver filhos, estes são referidos. Não se esquecer dos avós, tios e primos paternos e maternos do paciente. Se tiver algum doente na família, esclarecer a natureza da enfermidade.

Em caso de falecimento, indagar a causa do óbito e a idade em que ocorreu.

Pergunta-se sistematicamente sobre a existência de enxaqueca, diabetes, tuberculose, hipertensão arterial, câncer, doenças

alérgicas, doença arterial coronariana (infarto agudo do miocárdio, angina de peito), acidente vascular cerebral, dislipidemias, úlcera péptica, coleditiase e varizes, que são as doenças com caráter familiar mais comuns.

Quando o paciente é portador de uma doença de caráter hereditário (hemofilia, anemia falciforme, rins policísticos, erros metabólicos), torna-se imprescindível um levantamento genealógico mais rigoroso e, nesse caso, recorre-se às técnicas de investigação genética.

Boxe

Dicas para o estudante

No item *Desenvolvimento psicomotor e neural, em Antecedentes pessoais fisiológicos*, temos que saber a idade em que determinadas atividades tiveram início para verificar se foram de aparecimento precoce, tardio ou normal. Por exemplo, a partir dos 6 meses de idade, surge o primeiro dente; a partir dos 6 meses também a criança começa a engatinhar e com 1 ano de idade ela anda. A fala desenvolve-se entre 1 e 3 anos de idade, e o controle dos esfíncteres acontece entre 2 e 4 anos de idade

Perguntas sobre a sexualidade devem ser feitas após já se ter conversado bastante com o paciente – assim ele fica mais descontraído e o estudante não se sente tão constrangido

Deve-se começar perguntando sobre o desenvolvimento psicosssexual – quando parou de mamar, se foi amamentado ao seio ou não, quando foi ensinado a usar o “penquinho”. Em seguida, pode-se perguntar como foi sua adolescência e, de forma tranquila, pergunta-se com que idade teve sua primeira relação sexual

Após a informação da sexarca, o estudante, ainda de maneira tranquila, pode perguntar se o paciente mora com familiares ou sozinho, acrescentando a seguinte indagação: “O senhor mora sozinho? Mora com algum companheiro ou companheira?” – de modo a deixar o paciente livre para demonstrar sua orientação sexual

Em seguida, pode-se questionar se o paciente pratica sexo seguro ou não (se usa preservativo, se tem outros parceiros etc.)

Lembre-se sempre que o que é perguntado de maneira adequada, sem demonstrar preconceito, é respondido também com tranquilidade

Mostre-se sempre tranquilo, sem sinais de discriminação, seja qual for a informação do paciente.

Hábitos de vida

A medicina está se tornando cada vez mais uma ciência social, e o interesse do médico vai ultrapassando as fronteiras biológicas para atingir os aspectos sociais relacionados com o doente e com a doença.

Este item, muito amplo e heterogêneo, documenta hábitos e estilo de vida do paciente e está desdobrado nos seguintes tópicos:

Alimentação

Ocupações anteriores

Atividades físicas

Hábitos.

Alimentação

No exame físico, serão estudados os parâmetros para avaliar o *estado de nutrição do paciente*; todavia, os primeiros dados a serem obtidos são os hábitos alimentares do doente.

Toma-se como referência o que seria a alimentação adequada para aquela pessoa em função da idade, do sexo e do trabalho desempenhado.

Induz-se o paciente a discriminar sua alimentação habitual, especificando, tanto quanto possível, o tipo e a quantidade dos alimentos ingeridos – é o que se chama *anamnese alimentar*.

Devemos questionar principalmente sobre o consumo de alimentos à base de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, bem como de água e outros líquidos.

Assim procedendo, o examinador poderá fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa, ambas com interesse médico.

Temos observado que o estudante encontra dificuldade em anotar os dados obtidos. Com a finalidade de facilitar seu trabalho, sugerimos as seguintes expressões, nas quais seriam sintetizadas as conclusões mais frequentes:

“Alimentação quantitativa e qualitativamente adequada”

“Reduzida ingestão de fibras”

“Insuficiente consumo de proteínas, com alimentação à base de carboidratos”

“Consumo de calorias acima das necessidades”

“Alimentação com alto teor de gorduras”

“Reduzida ingestão de verduras e frutas”

“Insuficiente consumo de proteínas sem aumento compensador da ingestão de carboidratos”

“Baixa ingestão de líquidos”

“Reduzida ingestão de carboidratos”

“Reduzido consumo de gorduras”

“Alimentação puramente vegetariana”

“Alimentação láctea exclusiva”.

Ocupações anteriores

Devemos questionar e obter informações tanto da ocupação atual quanto das ocupações anteriores exercidas pelo paciente.

Desse modo, ver-se-á que os portadores de asma brônquica terão sua doença agravada se trabalharem em ambiente enfumado ou empoeirado, ou se tiverem de manipular inseticidas, pelos de animais, penas de aves, plumas de algodão ou de lã, livros velhos e outros materiais reconhecidamente capazes de agir como antígenos ou irritantes das vias respiratórias.

Os dados relacionados com este item costumam ser chamados *história ocupacional*, e voltamos a chamar a atenção para a crescente importância médica e social da medicina do trabalho.

Atividades físicas

Torna-se cada dia mais clara a relação entre algumas enfermidades e o tipo de vida levado pela pessoa no que concerne à execução de exercícios físicos. Por exemplo: a comum ocorrência de lesões degenerativas da coluna vertebral nos trabalhadores braçais e a maior incidência de infarto do miocárdio entre as pessoas sedentárias.

Tais atividades dizem respeito ao trabalho e à prática de esportes e, para caracterizá-las, há que indagar sobre ambos.

Devemos questionar qual tipo de exercício físico realiza (p. ex., natação, futebol, caminhadas etc.); frequência (p. ex., diariamente, 3 vezes/semana etc.); duração (p. ex., por 30 min, por 1 h); e tempo que pratica (p. ex., há 1 ano, há 3 meses).

Uma classificação prática é a que se segue:

Pessoas sedentárias

Pessoas que exercem atividades físicas moderadas

Pessoas que exercem atividades físicas intensas e constantes

Pessoas que exercem atividades físicas ocasionais.

Hábitos

Alguns hábitos são ocultados pelos pacientes e até pelos próprios familiares. A investigação deste item exige habilidade, discrição e perspicácia. Uma afirmativa ou uma negativa sem explicações por parte do paciente não significa necessariamente a verdade! Deve-se investigar sistematicamente o uso de tabaco, bebidas alcoólicas, anabolizantes, anfetaminas e drogas ilícitas.

Uso de tabaco

O uso de tabaco, socialmente aprovado, não costuma ser negado pelos doentes, exceto quando tenha sido proibido de fumar. Os efeitos nocivos do tabaco são indiscutíveis: câncer de pulmão e de bexiga, afecções broncopulmonares (asma, bronquite, enfisema e bronquiectasias), afecções cardiovasculares (insuficiência coronariana, hipertensão arterial, tromboembolia), disfunções sexuais masculinas, baixo peso fetal (mãe fumante), intoxicação do recém-nascido em aleitamento materno (nutriz fumante), entre outras.

Diante disso, nenhuma anamnese está completa se não se investigar esse hábito, registrando-se tipo (cigarro, cachimbo, charuto e cigarro de palha), quantidade, frequência, duração do vício; abstinência (se já tentou parar de fumar).

Uso de bebidas alcoólicas

A ingestão de bebidas alcoólicas também é socialmente aceita, mas muitas vezes é omitida ou minimizada por parte dos doentes. Que o álcool tem efeitos deletérios graves sobre o fígado, cérebro, nervos, pâncreas e coração não mais se discute; é fato comprovado. O próprio alcoolismo, em si, uma doença de fundo psicossocial, deve ser colocado entre as enfermidades importantes e mais difundidas atualmente.

Não deixar de perguntar sobre o tipo de bebida (cerveja, vinho, licor, vodka, uísque, cachaça, gin, outras) e a quantidade habitualmente ingerida, frequência, duração do vício; abstinência (se já tentou parar de beber).

Boxe

Nos últimos anos, tem sido amplamente praticado o chamado *binge drinking* ou *heavy drinking* (beber *exageradamente*), principalmente entre jovens. O *binge drinking* é definido como o consumo de cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma única ocasião por homens ou quatro ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma única ocasião por mulheres, pelo menos uma vez nas últimas 2 semanas. Esse tipo de padrão de consumo de álcool expõe o bebedor a situações de risco, tais como danos à saúde física, sexo desprotegido, gravidez indesejada, overdose de drogas ilícitas, quedas, violência, acidentes de trânsito, comportamento antissocial e dificuldades escolares, tanto em jovens como na população geral.

Para facilitar a avaliação do hábito de usar bebidas alcoólicas, pode-se lançar mão da seguinte esquematização:

Pessoas abstinências, ou seja, não usam definitivamente nenhum tipo de bebida alcoólica

Uso ocasional, em quantidades moderadas

Uso ocasional, em grande quantidade, chegando a estado de embriaguez

Uso frequente em quantidade moderada

Uso diário em pequena quantidade

Uso diário em quantidade para determinar embriaguez

Uso diário em quantidade exagerada, chegando o paciente a avançado estado de embriaguez.

Essa graduação serve inclusive para avaliar o grau de dependência do paciente ao uso de álcool.

Para reconhecimento dos pacientes que abusam de bebidas alcoólicas, vem sendo bastante difundido o questionário CAGE (sigla em inglês), composto de quatro pontos a serem investigados: necessidade de diminuir (*Cut down*) o consumo de bebidas alcoólicas; sentir-se incomodado (*Annoyed*) por críticas à bebida; sensação de culpa (*Guilty*) ao beber; necessidade de beber no início da manhã para “abrir os olhos” (*Eye-opener*), ou seja, para sentir-se em condições de trabalhar.

Boxe

Questionário CAGE

Você já sentiu a necessidade de diminuir a quantidade de bebida ou de parar de beber?

Você já se sentiu aborrecido ao ser criticado por beber?

Você já se sentiu culpado em relação a beber?

Alguma vez já bebeu logo ao acordar pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca?

Dois respostas positivas identificam 75% dos dependentes de álcool com uma especificidade de 95%.

Uso de anabolizantes e anfetaminas

O uso de anabolizantes por jovens frequentadores de academias de ginástica tornou-se hoje uma preocupação, pois tais substâncias levam à dependência e estão correlacionadas a doenças cardíacas, renais, hepáticas, endócrinas e neurológicas. A utilização de anfetaminas, de maneira indiscriminada, leva à dependência química e, comparadamente, traz prejuízos à saúde. Alguns sedativos (barbitúricos, morfina, benzodiazepínicos) também causam dependência química e devem ser sempre investigados.

Uso de drogas ilícitas

As drogas ilícitas incluem: maconha, cocaína, heroína, *ecstasy*, LSD, *crack*, *oxi*, chá de cogumelo, inalantes (cola de sapateiro, lança-perfume). O uso dessas substâncias ocorre em escala crescente em todos os grupos socioeconômicos, principalmente entre

os adolescentes. O hábito de frequentar festas *rave* pode estar associado ao uso abusivo de drogas ilícitas. Não deixar de questionar sobre tipo de droga, quantidade habitualmente ingerida, frequência, duração do vício e abstinência.

A investigação clínica de um paciente que usa drogas ilícitas não é fácil. Há necessidade de tato e perspicácia, e o médico deve integrar informações provenientes de todas as fontes disponíveis, principalmente de familiares.

Condições socioeconômicas e culturais

As condições socioeconômicas e culturais avaliam a situação financeira, vínculos afetivos familiares, filiação religiosa e crenças espirituais do paciente, bem como condições de moradia e grau de escolaridade.

Este item está desdobrado em:

Habitação

Condições socioeconômicas

Condições culturais

Vida conjugal e relacionamento familiar.

Habitação

Importância considerável tem a habitação. Na zona rural, pela sua precariedade, as casas comportam-se como abrigos ideais para numerosos reservatórios e transmissores de doenças infecciosas e parasitárias. Como exemplo, poder-se-ia citar a doença de Chagas. Os triatomíneos (barbeiros) encontram na “cafua” ou “casa de pau a pique” seu hábitat ideal, o que faz dessa parasitose importante endemia de várias regiões brasileiras.

Na zona urbana, a diversidade de habitação é um fator importante. Por outro lado, as favelas e as áreas de invasão propiciam o surgimento de doenças infectoparasitárias devido à ausência de saneamento básico, proximidade de rios poluídos, ineficácia na coleta de lixo e confinamento de várias pessoas em pequenos cômodos habitacionais. Por outro lado, casas ou apartamentos de alto luxo podem manter, por exemplo, em suas piscinas e jardins, criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, dificultando o controle da dengue. A habitação não pode ser vista como fato isolado, porquanto ela está inserida em um meio ecológico do qual faz parte.

Neste item, é importante questionar sobre as condições de moradia: se mora em casa ou apartamento; se a casa é feita de alvenaria ou não; qual a quantidade de cômodos; se conta com saneamento básico (água tratada e rede de esgoto), com coleta regular de lixo; se abriga animais domésticos, entre outros.

A poluição do ar, a poluição sonora e visual, os desmatamentos e as queimadas, as alterações climáticas, as inundações, os temporais e os terremotos, todos são fatores relevantes na análise do item habitação, podendo propiciar o surgimento de várias doenças.

Condições socioeconômicas

Os primeiros elementos estão contidos na própria identificação do paciente; outros são coletados no decorrer da anamnese. Se houver necessidade de mais informações, indagar-se-á sobre rendimento mensal, situação profissional, se há dependência econômica de parentes ou instituição.

A socialização da medicina é um fato que anda de par com esses aspectos socioeconômicos. Não só em relação ao paciente em sua condição individual, mas também quando se enfoca a medicina dentro de uma perspectiva social.

Todo médico precisa conhecer as possibilidades econômicas de seu paciente, principalmente sua capacidade financeira para comprar medicamentos. É obrigação do médico compatibilizar sua prescrição aos rendimentos do paciente. A maior parte das doenças crônicas (hipertensão arterial, insuficiência coronária, dislipidemias, diabetes) exige uso contínuo de um ou mais medicamentos. No Brasil, atualmente, há distribuição gratuita de medicamentos para doentes crônicos e cabe ao médico conhecer a lista desses remédios para prescrevê-los quando for necessário. Uma das mais frequentes causas de abandono do tratamento é a incapacidade de adquirir remédios ou alimentos especiais.

Condições culturais

É importante destacar que as condições culturais não se restringem ao grau de escolaridade, mas abrangem a religiosidade, as tradições, as crenças, os mitos, a medicina popular, os comportamentos e hábitos alimentares. Tais condições culturais devem ser respeitadas em seu contexto. Quanto à escolaridade, é importante saber se o paciente é analfabeto ou alfabetizado. Vale ressaltar se o paciente completou o ensino fundamental, o ensino médio ou se tem nível superior (graduação e pós-graduação). Tais informações são fundamentais na compreensão do processo saúde-doença. Partir de algo simples, como grau de

escolaridade (alfabetizado ou não), é a maneira mais prática de abordar esse aspecto da anamnese. Todavia, é o conjunto de dados vistos e ouvidos que permitirá uma avaliação mais abrangente.

Vida conjugal e relacionamento familiar

Investiga-se o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos e entre cônjuges.

Em várias ocasiões temos salientado as dificuldades da anamnese. Chegamos ao tópico em que essa dificuldade atinge o seu máximo. Inevitavelmente, o estudante encontrará dificuldade para andar nesse terreno, pois os pacientes veem nele um “aprendiz”, adotando, em consequência, maior reserva a respeito de sua vida íntima e de suas relações familiares. Há que reconhecer esse obstáculo, mas preparando-se desde já, intelectual e psicologicamente, para, em época oportuna e nos momentos exatos, levar a anamnese até os mais recônditos e bem guardados escaninhos da vida pessoal e familiar do paciente. Tal preparo só é conseguido quando se associa o amadurecimento da personalidade a uma sólida formação científica.

ANAMNESE EM PEDIATRIA

A particularidade mais marcante reside no fato de a obtenção de informações ser feita por intermédio da mãe ou de outro familiar. Às vezes, o informante é a babá, um vizinho ou outra pessoa que convive com a criança.

Os pais – ou os avós, principalmente – gostam de “interpretar” as manifestações infantis em vez de relatá-las objetivamente. É comum, por exemplo, quando o recém-nascido começa a chorar mais do que o habitual, a mãe ou a avó “deduzir” que o bebê está com dor de ouvido, isso com base em indícios muito inseguros ou por mera suposição.

Outra característica da anamnese pediátrica é que esta tem de ser totalmente dirigida, não havendo possibilidade de deixar a criança relatar espontaneamente suas queixas.

Durante a entrevista, o examinador deve ter o cuidado de observar o comportamento da mãe, procurando compreender e surpreender seus traços psicológicos. O relacionamento com a mãe é parte integrante do exame clínico da criança.

ANAMNESE EM PSIQUIATRIA

A anamnese dos pacientes com distúrbios mentais apresenta muitas particularidades que precisam ser conhecidas pelos médicos, mesmo os que não se dedicam a esse ramo da medicina (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

ANAMNESE DO IDOSO

Ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Às vezes, os estudantes questionam o detalhamento – *excessivo*, como costumam dizer – da anamnese como é exposto neste livro, argumentando que não é assim que se faz na vida prática. Na verdade, o que estamos propondo é um esquema para o aprendizado do método clínico. Para isso, é necessário ser o mais abrangente possível, de modo a incluir quase tudo de que se precisa nas inúmeras maneiras em que é feito o exercício da profissão médica, sempre pensando, é claro, que o trabalho do médico deve ter a mais alta qualidade. É a única maneira de aprender os “fundamentos” do método clínico que será a principal base para o exercício da profissão médica em seu mais alto nível.

A transposição ou adaptação deste esquema para “prontuários” e “fichas clínicas” precisa levar em conta as diferentes condições em que se dá o exercício profissional. Em hospitais universitários, por exemplo, os prontuários costumam ser muito detalhados, constituindo verdadeiros cadernos. Isso é justificável porque, durante o curso de medicina e na pós-graduação, é necessário aproveitar ao máximo a oportunidade de obter dos pacientes um conjunto de dados que vão permitir uma visão ampla e profunda das enfermidades. Nestes casos, os prontuários se assemelham ao esquema de anamnese aqui proposto. De modo diferente, por motivos óbvios, nos postos de saúde as fichas clínicas são mais simples, contendo apenas os dados essenciais do exame do paciente. Entre um extremo e outro, encontra-se uma grande variedade de modelos de fichas e prontuários, muitos deles buscando uma maneira adequada para o uso dos dados clínicos em computador. Em clínicas especializadas, determinados aspectos são extremamente detalhados, enquanto os protocolos de pesquisa clínica são especificamente preparados para esclarecer questões que estão sendo investigadas.



Por isso, para se adquirir uma sólida base do método clínico, é indispensável a realização de histórias clínicas com a maior abrangência possível, não importando o tempo e o esforço que sejam despendidos. O domínio do método clínico depende deste primeiro momento. As adaptações que vão ser feitas mais tarde, ampliando ou sintetizando um ou outro aspecto da anamnese, não irão prejudicar a correta aplicação do método clínico.

Roteiro pedagógico para anamnese

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Nome:

Idade: Sexo/gênero: Feminino () Masculino () Cor/etnia: Branca () Parda () Preta () Indígena () Asiática ()

Estado civil: Casado(a) () Solteiro(a) () Divorciado(a) () Viúvo(a) () Outros ()

Profissão: Ocupação atual/Local de trabalho:

Naturalidade Procedência:

Residência:

Nome da mãe:

Nome do responsável/cuidador/acompanhante (em caso de criança, adolescente, idoso ou incapaz):

Religião: Plano de saúde:

Queixa principal (motivo principal que levou o paciente a procurar o médico, repetindo, se possível, as expressões por ele utilizadas):

História da doença atual (Permita ao paciente falar de sua doença. Determine o sintoma-guia. Descreva o sintoma com suas características e analise-o minuciosamente. Use o sintoma-guia como um fio condutor da história e estabeleça relações das outras queixas com ele em ordem cronológica. Verifique se a história

obtida tem começo, meio e fim. Não induza respostas. Apure evolução, exames e tratamentos já realizados).

Interrogatório sintomatológico

Estado geral: febre; calafrios; sudorese; mal-estar; astenia; alteração peso (kg/tempo); edema; anasarca.

Pele e fâneros: prurido; icterícia; palidez; rubor; cianose; alterações na pele (textura; umidade; temperatura; sensibilidade); diminuição tecido subcutâneo; alterações de sensibilidade; dormência, lesões cutâneas; queda de cabelos; pelos faciais em mulheres; alterações das unhas.

Promoção da saúde: exposição solar (protetor solar); cuidados com pele e cabelos.

Cabeça: cefaleia; enxaqueca; tonturas; traumas.

Olhos: dor ocular; ardência; lacrimejamento; prurido; diplopia; fotofobia; nistagmo; secreção; escotomas; acuidade visual; exoftalmia; amaurose; olho seco.

Promoção da saúde: uso de óculos ou lentes de contato; último exame de vista.

Ouvidos: dor; otorreia; otorragia; acuidade auditiva; zumbidos; vertigem; prurido.

Promoção da saúde: uso de aparelhos auditivos; exposição ruídos ambientais; uso de equipamentos de proteção individual (EPI); limpeza dos ouvidos (cotonetes, outros objetos, pelo médico).

Nariz e cavidades paranasais: dor; espirros; obstrução nasal; coriza; epistaxe; alteração do olfato; dor facial.

Cavidade bucal e anexos: sialose; halitose; dor de dentes; sangramentos; aftas; ulcerações; boca seca; uso de próteses dentárias; dor na articulação temporomandibular (ATM).

Promoção da saúde: escovação (dentes e língua) – quantas vezes/dia; último exame odontológico.

Faringe: dor de garganta; pigarro; roncos.

Laringe: dor; alterações na voz.

Promoção de saúde: cuidados com a voz (gargarejos, produtos usados).

Vasos e linfonodos: pulsações; turgência jugular; adenomegalias.

Mamas: dor; nódulos, retrações; secreção papilar (especificar qual mama).

Promoção da saúde: autoexame mamário; última ultrassonografia/mamografia (mulheres com idade > 40 anos).

Sistema respiratório: dor torácica; tosse; expectoração; hemoptise; vômica; dispneia; chieira; cianose.

Promoção da saúde: exposição a alérgenos (qual); última radiografia de tórax.

Sistema cardiovascular: dor precordial; palpitações; dispneia aos esforços; dispneia em decúbito; ortopneia; dispneia paroxística noturna; edema; síncope; lipotímia; cianose progressiva; sudorese fria.

Promoção da saúde: exposição a fatores estressantes; último *check-up* cardiológico.

Sistema digestório: alterações do apetite (hiporexia; anorexia; perversão; compulsão alimentar); disfagia; odinofagia; pirose; regurgitações; eructações; soluços; dor abdominal; epigastria; dispepsia; hematêmese; náuseas; vômitos; ritmo intestinal (normal; diarreia; obstipação intestinal); esteatorreia; distensão abdominal; flatulência; enterorragia; melena; sangramento anal; tenesmo; incontinência fecal; prurido anal.

Promoção da saúde: uso de antiácidos; uso de laxantes; uso de chás digestivos.

Sistema urinário: dor lombar; disúria; estrangúria; anúria; oligúria; poliúria; polaciúria; nictúria; urgência miccional; incontinência urinária; retenção urinária; hematúria; colúria; urina com mau cheiro; edema; anasarca.

Sistema genital masculino: dor testicular; priapismo; alterações jato urinário; hemospermia; corrimento uretral; fimose; disfunções sexuais.

Promoção da saúde: autoexame testicular; último exame prostático ou PSA; uso de preservativos.

Sistema genital feminino: ciclo menstrual (regularidade; duração dos ciclos; quantidade de fluxo menstrual; data da última menstruação); dismenorreia; TPM (cefaleia, mastalgia, dor em baixo ventre e pernas, irritação, nervosismo e insônia); corrimento vaginal; prurido vaginal; disfunções sexuais; uso de anticoncepcionais orais outro tipo de contracepção.

Promoção da saúde: último exame ginecológico; terapia de reposição hormonal; último exame de Papanicolaou; uso de preservativos.

Sistema hemolinfopoiético: adenomegalias; esplenomegalias; sangramentos.

Sistema endócrino: alterações no desenvolvimento físico (nanismo; gigantismo; acromegalia); alterações no desenvolvimento sexual (puberdade precoce ou atrasada); tolerância a calor e frio; relação entre apetite e peso; nervosismo; tremores; alterações pele e fâneros; ginecomastia; hirsutismo.

Sistema osteoarticular: dor óssea; deformidades ósseas; dor, edema, calor, rubor articular; deformidades articulares; rigidez articular; limitação de movimentos; sinais inflamatórios; atrofia muscular; espasmos musculares; câibras; fraqueza muscular; mialgia.

Promoção de saúde: cuidados com a postura, hábito de levantar peso, como pega utensílios em locais altos ou baixos, movimentos repetitivos (trabalho), uso de saltos muito altos; prática de ginástica laboral.

Sistema nervoso: síncope; lipotímia; torpor; coma; alterações da marcha; convulsões; ausência; distúrbio de memória; distúrbios de aprendizagem; alterações da fala; transtornos do sono; tremores; incoordenação de movimentos; parestias; paralisias; parestesias; anestésias.

Promoção de saúde: uso de andadores, cadeira de rodas, fisioterapia.

Exame psíquico e condições emocionais: (ver *Roteiro pedagógico para o exame psíquico e avaliação das condições emocionais* no Capítulo 7)

Antecedentes pessoais

Fisiológicos

Gestação e nascimento: gestação (normal/complicações), condições do parto (normal domiciliar/normal hospitalar/cesáreo/gemelar/uso de fórceps); ordem de nascimento; quantidade de irmãos.

Desenvolvimento psicomotor e neural (idade que iniciou a dentição; o engatinhar; o andar; o falar e controle de esfínteres; desenvolvimento físico; aproveitamento escolar):

Desenvolvimento sexual: puberdade (normal/precoces/tardia); menarca (idade), menopausa (idade), sexarca (idade); orientação sexual (HSM, HSH, HSMH, MSH, MSM, MSMH).

Patológicos

Doenças da infância (sarampo, varicela, caxumba, amigdalites, outras):

Traumas/acidentes:

Doenças graves e/ou crônicas (HAS, diabetes, hepatite, malária, artrose, litíase renal, gota, pneumonia, osteoporose, outras):

Cirurgias: *Transfusões sanguíneas* (no/quando/onde/motivo):

História obstétrica:

Gesta: Para: Aborto: (espontâneo ou provocado) Prematuro: Cesárea:

Paternidade: filhos

Imunizações (qual vacina/quando/doses):

Alergias:

Medicamentos em uso atual (qual/posologia/motivo/quem prescreveu):

Antecedentes familiares

Doenças dos familiares (pais, irmãos, avós, tios, primos, cônjuge e filhos):

Hábitos de vida

Alimentação:

Ocupação atual e ocupações anteriores:

Viagens recentes (onde, período de estadia):

Atividades físicas diárias e regulares:

Atividade sexual (no de parceiros/hábitos sexuais mais frequentes/uso de preservativos):

Manutenção do peso:

Consumo de bebida alcoólica (tipo de bebida, quantidade, frequência, duração do vício; abstinência):

Uso de tabaco (tipo, quantidade, frequência, duração do vício; abstinência):

Uso de outras drogas ilícitas (tipo, quantidade, frequência, duração do vício; abstinência):

Uso de outras substâncias:

Condições socioeconômicas e culturais (condições de moradia; saneamento básico e coleta de lixo):

Contato com pessoas ou animais doentes (onde, quando e duração):

Vida conjugal e ajustamento familiar (relacionamento com pais, irmãos, cônjuge, filhos, outros familiares e amigos):

Condições econômicas (rendimento mensal, dependência econômica, aposentadoria):

Capítulo 5



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinite Dor
Otorrria Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Técnicas Básicas do Exame Físico

Fábia Maria Oliveira Pinho

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Arnaldo Lemos Porto

Celmo Celeno Porto

- Introdução
- Inspeção
- Palpação
- Percussão
- Ausculta
- Olfato como recurso de diagnóstico
- Ambiente adequado para o exame físico
- Instrumentos e aparelhos necessários para o exame físico

INTRODUÇÃO

Ao exame físico, a maioria dos pacientes sente-se ansiosa por se sentir exposta, apreensiva por receio de sentir dor e amedrontada em relação ao que o médico possa encontrar.

Os estudantes, por sua vez, sentem-se inseguros e apreensivos no início do aprendizado clínico, uma vez que têm receio de provocar desconforto no paciente.

Para superar esses aspectos, o estudante deve se preparar técnica e psicologicamente. Uma boa semiotécnica exige o estudo prévio de como aplicar corretamente a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Do ponto de vista psicológico, nada melhor do que estar imbuído do papel de médico, cujo principal objetivo é ajudar o paciente. Mesmo sabendo da condição de estudante, o paciente pode sentir-se bem quando percebe que está sendo examinado com seriedade e atenção. Ser gentil e ter delicadeza constituem componentes fundamentais do exame físico, principalmente dos pacientes que sofrem dor ou apresentam sintomas desagradáveis.

O estudante deve permanecer calmo, organizado e competente. Durante o exame físico – menos ao fazer a ausculta –, pode-se continuar a fazer indagações ao paciente, de preferência relacionadas com os dados obtidos naquele momento, perguntando, por exemplo, se a palpação está provocando ou piorando a dor. Outras vezes, é neste momento que novas perguntas podem ser necessárias para completar informações obtidas durante a anamnese. Mantenha o paciente informado do que pretende fazer. Quando é necessária a participação ativa dele – por exemplo, aumentar a profundidade da respiração ao palpar o fígado –, faça a solicitação em linguagem acessível ao paciente. É natural que o exame físico do estudante seja sempre mais demorado que o de um médico experiente.

Para obter os dados do exame físico, é preciso utilizar os sentidos – visão, olfato, tato e audição. As habilidades necessárias ao exame físico são:

Inspeção

Palpação

Percussão

Ausculta.

Para executá-las, é fundamental treinar a repetição e a prática supervisionada em manequins, em pessoas saudáveis (atores e próprios colegas) e em pacientes. (Ver Capítulo 2, *Laboratório de Habilidades Clínicas*.)

As precauções para realização do exame físico são apresentadas na Figura 5.1.

INSPEÇÃO

É a exploração feita a partir do sentido da visão. Investigam-se a superfície corporal e as partes mais acessíveis das cavidades em contato com o exterior. A inspeção começa no momento em que se entra em contato com o paciente realizando-se uma “inspeção geral”.

A “inspeção direcionada” pode ser panorâmica ou localizada – pode ser efetuada a olho nu ou com auxílio de uma lupa (Figura 5.2).





Figura 5.1 Precauções ao realizar o exame físico.

Raramente se emprega a inspeção panorâmica com visão do corpo inteiro; entretanto, para o reconhecimento das dismorfias ou dos distúrbios do desenvolvimento físico, é conveniente abranger, em uma visão de conjunto, todo o corpo.

Mais empregada é a inspeção de segmentos corporais, e, a partir daí, deve-se fixar a atenção em áreas restritas. As lesões cutâneas tornam-se mais evidentes quando ampliadas por uma lupa que tenha capacidade de duplicar ou quadruplicar seu tamanho.



Figura 5.2 Inspeção com auxílio de uma lupa.

Semiotécnica

A inspeção exige boa iluminação, exposição adequada da região a ser inspecionada e uso ocasional de determinados instrumentos (lupa, lanterna, otoscópio, oftalmoscópio e outros) para melhorar o campo de visão e ter em mente as características normais da área a ser examinada, como apresentado a seguir:

A iluminação mais adequada é a luz natural incidindo obliquamente. Todavia, cada vez mais dependemos de iluminação artificial. Para uma boa inspeção, a luz deve ser branca e de intensidade suficiente. Ambientes de penumbra não são adequados para que se vejam alterações leves da coloração da pele e das mucosas; por exemplo, cianose e icterícia de grau moderado só são reconhecidas quando se dispõe de boa iluminação. Para a inspeção das cavidades, usa-se um foco luminoso, que pode ser uma lanterna comum

A inspeção deve ser realizada por partes, desnudando-se somente a região a ser examinada, sempre respeitando o pudor do paciente. Assim, quando se vai examinar o tórax, o abdome permanece recoberto, e vice-versa. O desnudamento das partes genitais causa sempre constrangimento do doente. Na verdade, a única recomendação a ser feita é que o examinador proceda de tal modo que seus menores gestos traduzam respeito pela pessoa que tem diante de si. Se, em determinadas ocasiões, encontrar obstinada recusa por parte do paciente, o estudante deve interromper seu exame e solicitar ao professor o auxílio necessário. O estudante inicia seu aprendizado, seja em unidades básicas de saúde ou em hospitais universitários, em contato com os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em sua maioria de baixo poder econômico e pouca escolaridade. Essa particularidade deve realçar na mente do aluno a necessidade de respeito e recato, pois essas pessoas humildes e indefesas costumam sofrer caladas e resignadas por medo de levantar a voz para um protesto ou uma negativa

O conhecimento das características da superfície corporal, assim como da anatomia topográfica, permitirá ao estudante reconhecer eventuais anormalidades durante a inspeção. Por esse motivo, e com a finalidade de educar a visão, será dada ênfase ao estudo das lesões elementares da pele

Há duas maneiras fundamentais de se fazer a inspeção:

- Olhando frente a frente a região a ser examinada: a isso se designa inspeção frontal, que é o modo padrão desse procedimento
- Observando a região tangencialmente: essa é a maneira correta para pesquisar movimentos mínimos na superfície corporal, tais como pulsações ou ondulações e pequenos abaulamentos ou depressões

A posição do examinador e do paciente depende das condições clínicas do paciente e do segmento corporal a ser inspecionado. De modo geral, o paciente senta-se à beira do leito ou da mesa de exame, a menos que essa posição seja contraindicada ou impossibilitada. O examinador deve ficar de pé diante do paciente, movimentando-se de um lado para o

outro, de acordo com a necessidade. No paciente acamado, a posição do paciente e a sequência do exame físico precisam ser adaptadas de acordo com as circunstâncias. Para examinar as costas e auscultar os pulmões, deve-se inclinar o paciente ora para um lado ora para outro

A inspeção começa durante a anamnese, desde o primeiro momento em que se encontra com o paciente, e continua durante todo o exame clínico.

Boxe

Para finalizar, vale a pena lembrar a máxima que diz: “Cometem-se mais erros por não olhar do que por não saber.”

Boxe

Dicas para o estudante

Mantenha a sala de exame com temperatura agradável

Mantenha a privacidade na hora do exame, evitando interrupções

Adquira o hábito de prestar atenção às expressões faciais do paciente, ou mesmo de perguntar se está tudo bem, enquanto prossegue no exame físico, pois fontes de dor e preocupações podem ser reveladas

Sempre utilize um avental ou lençol para cobrir o paciente

Durante o exame, mantenha o paciente informado de cada passo para deixá-lo tranquilo.

PALPAÇÃO

A palpação frequentemente confirma pontos observados durante a inspeção.

A palpação recolhe dados por meio do *tato* e da *pressão*. O tato fornece impressões sobre a parte mais superficial, e a pressão, sobre as mais profundas.

Pela palpação percebem-se modificações de textura, temperatura, umidade, espessura, consistência, sensibilidade, volume, dureza, além da percepção de frêmito, elasticidade, reconhecimento de flutuação, crepitações, vibração, pulsação e verificação da presença de edema e inúmeros outros fenômenos que serão estudados no decorrer do curso.

Por conveniência didática, relacionamos juntamente com os vários tipos de palpação outros procedimentos – vitropressão, puntipressão e fricção com algodão – que fogem um pouco do que se entende por palpação no sentido estrito.

Semiotécnica

A técnica da palpação deve ser sistematizada, com a abordagem tranquila e gentil. O paciente fica tenso ao ser tocado bruscamente, dificultando o exame. Explique cada etapa do exame ao paciente e a maneira como ele pode cooperar. Recomenda-se que o examinador aqueça as mãos, friccionando uma contra a outra antes de iniciar qualquer palpação. A posição do examinador e do paciente depende das condições clínicas do paciente e do segmento corporal a ser palpado. Geralmente, o paciente fica em decúbito dorsal, e o examinador de pé, à direita do paciente.

Esse procedimento apresenta muitas variantes, que podem ser sistematizadas da seguinte maneira:

Palpação com a mão espalmada, em que se usa toda a palma de uma ou de ambas as mãos (Figuras 5.3 e 5.4)

Palpação com uma das mãos superpondo-se à outra (Figura 5.5)

Palpação com a mão espalmada, em que se usam apenas as polpas digitais e a parte ventral dos dedos (Figura 5.6)

Palpação com a borda da mão

Palpação usando-se o polegar e o indicador, em que se forma uma “pinça” (Figura 5.7)

Palpação com o dorso dos dedos ou das mãos. Esse procedimento é específico para avaliação da temperatura (Figura 5.8)

Digitopressão, realizada com a polpa do polegar ou do indicador. Consiste na compressão de uma área com diferentes objetivos: pesquisar a existência de dor, avaliar a circulação cutânea, detectar a presença de edema (Figura 5.9)

Puntipressão, que consiste em comprimir com um objeto pontiagudo um ponto do corpo. É usada para avaliar a sensibilidade dolorosa e para analisar telangiectasias tipo aranha vascular (Figura 5.10)

Vitropressão, realizada com o auxílio de uma lâmina de vidro que é comprimida contra a pele, analisando-se a área através da própria lâmina. Sua principal aplicação é na distinção entre eritema de púrpura (no caso de eritema, a vitropressão provoca o apagamento da vermelhidão e, no de púrpura, permanece a mancha) (Figura 5.11)

Fricção com algodão, em que, com uma mecha de algodão, roça-se levemente um segmento cutâneo, procurando ver como o paciente o sente (Figura 5.12). É utilizada para avaliar sensibilidade cutânea

Pesquisa de flutuação, em que se aplica o dedo indicador da mão esquerda sobre um lado da tumefação, enquanto o da outra mão, colocado no lado oposto, exerce sucessivas compressões perpendicularmente à superfície cutânea. Havendo líquido, a pressão determina um leve rechaço do dedo da mão esquerda, ao que se denomina flutuação

Outro tipo de palpação bimanual combinada é a que se faz, por exemplo, no exame das glândulas salivares (Figura 5.13), quando o dedo indicador da mão direita é introduzido na boca, enquanto as polpas digitais dos outros dedos – exceto o polegar – da outra mão fazem a palpação externa na área de projeção da glândula; outro exemplo de palpação bimanual é o toque ginecológico combinado com a palpação da região suprapúbica.



Figura 5.3 Palpação com a mão espalmada, usando-se toda a palma de uma das mãos.



Figura 5.4 Palpação com a mão espalmada, usando-se ambas as mãos.



Figura 5.5 Palpação com uma das mãos superpondo-se à outra.

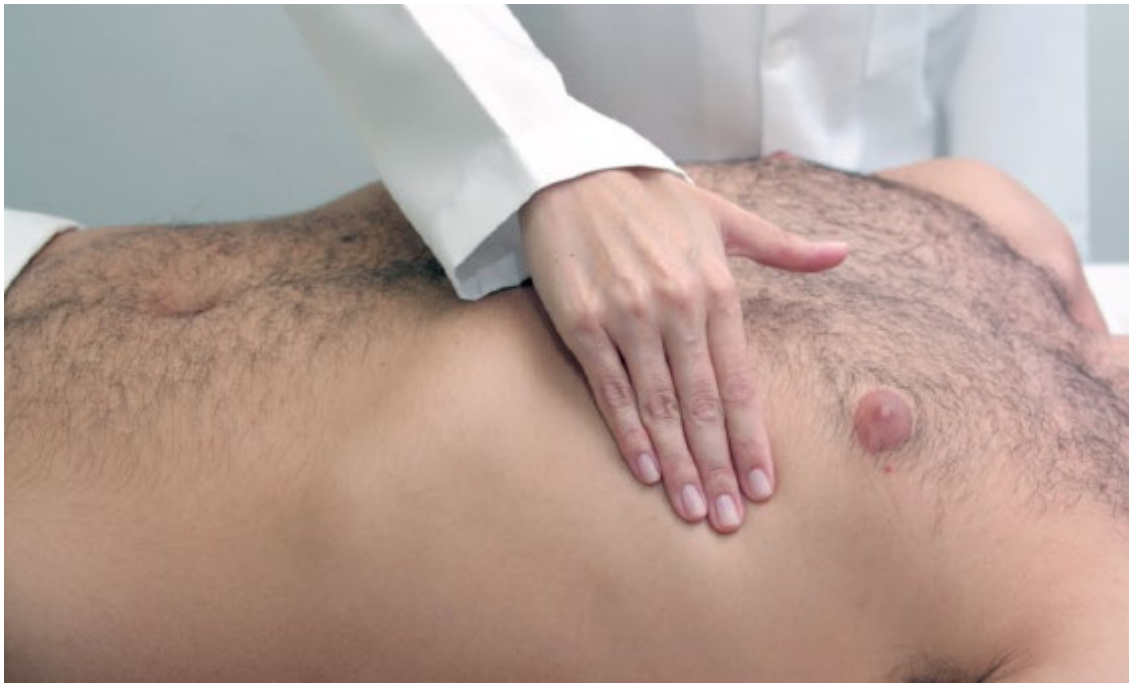


Figura 5.6 Palpação com a mão espalmada, usando-se apenas as polpas digitais e a parte ventral dos dedos.



Figura 5.7 Palpação usando-se o polegar e o indicador, formando uma “pinça”.



Figura 5.8 Palpação com o dorso dos dedos.



Figura 5.9 Digitopressão realizada com a polpa do polegar ou do indicador.



Figura 5.10 Puntipressão usando-se um estilete não perfurante e não cortante.



Figura 5.11 Vitropressão realizada com uma lâmina de vidro.



Figura 5.12 Fricção com algodão.



Figura 5.13 Exemplo de palpação bimanual (palpação das glândulas salivares).



Figura 5.14 Percussão direta. A ponta dos dedos golpeia diretamente a região que se quer percutir.



Figura 5.15 Percussão digitodigital. Na mão que vai golpear, todos os dedos, exceto o médio, ficam estendidos sem nenhum esforço. O dedo médio da mão esquerda – plexímetro – é o único a tocar na região a ser percutida.



Figura 5.16 Percussão digitodigital. Pode-se usar outra forma de posicionar os dedos da mão que golpeia. O dedo polegar e o indicador ficam semiestendidos, o mínimo e o anular fletidos com as extremidades quase tocando a palma da mão, enquanto o dedo médio – plexor – procura adotar a forma de um martelo.

Boxe

Dicas para o estudante

A ansiedade, tão comum no estudante em sua fase de iniciação clínica, torna as mãos frias e sudorentas, e é necessário ter o cuidado de enxugá-las antes de começar o exame

Cumpre alertar, especialmente às alunas, que as unhas, além de bem cuidadas, devem estar curtas. A marca de unhas na pele após a palpação é uma falta imperdoável

Deve-se identificar as regiões dolorosas e deixá-las para serem palpadas por último

Para palpar o abdome, deve-se posicionar o paciente em decúbito dorsal, com a cabeça em um travesseiro, os membros inferiores estendidos ou joelhos fletidos e os membros superiores ao lado do corpo ou cruzados à frente do tórax, para evitar tensão da musculatura abdominal

Ainda ao palpar o abdome, devem-se utilizar métodos para distrair a atenção do paciente: em voz baixa e tranquila, deve-se solicitar que ele realize inspirações profundas para relaxamento muscular, ou simplesmente manter um diálogo com ele

Deve-se treinar o tato utilizando pequenos sacos de superfícies diversas (lã, linhagem, plástico, seda etc.) com conteúdos também diferenciados (sementes, algodão etc.). A utilização desses sacos, palpando-os de olhos fechados, aprimora o tato.

PERCUSSÃO

A percussão baseia-se no seguinte princípio: ao se golpear um ponto qualquer do corpo, originam-se vibrações que têm características próprias quanto à intensidade, ao timbre e à tonalidade, dependendo da estrutura anatômica percutida.

Ao se fazer a percussão, observa-se não só o som obtido, mas também a resistência oferecida pela região golpeada.

Semiotécnica

A técnica da percussão sofreu uma série de variações no decorrer dos tempos; hoje, usa-se basicamente a *percussão direta* e a *percussão digitodigital*, e, em situações especiais, a *punho-percussão*, a *percussão com a borda da mão* e a *percussão tipo piparote*.

A *percussão direta* é realizada golpeando-se diretamente, com as pontas dos dedos, a região-alvo (Figura 5.14). Para tal, os dedos permanecem fletidos na tentativa de imitar a forma de martelo, e os movimentos de golpear são feitos pela articulação do punho. O golpe é seco e rápido, não se descuidando de levantar sem retardo a mão que percute. Essa técnica é utilizada na percussão do tórax do lactente e das regiões sinusais do adulto.

A *percussão digitodigital* é executada golpeando-se com a borda ungueal do dedo médio ou do indicador da mão direita a superfície dorsal da segunda falange do dedo médio ou do indicador da outra mão.

Ao dedo que golpeia designa-se *plexor*, e o que recebe o golpe é o *plexímetro*.

A mão que percute pode adotar duas posições, ou seja:

Todos os dedos, exceto o dedo médio, que procura imitar a forma de um martelo, ficam estendidos sem nenhum esforço (Figura 5.15)

O polegar e o indicador ficam semiestendidos, o mínimo e o anular são fletidos de tal modo que suas extremidades quase alcancem a palma da mão, enquanto o dedo médio procura adotar a forma de martelo (Figura 5.16).

A movimentação da mão se fará apenas com a movimentação do punho. O cotovelo permanece fixo, fletido em ângulo de 90° com o braço em semiabdução (Figura 5.17).

O dedo plexímetro – médio ou indicador da mão esquerda – é o único a tocar a região que está sendo examinada. Os outros e a palma da mão ficam suspensos rentes à superfície. Caso se pouse a mão, todas as vibrações são amortecidas, e o som torna-se abafado.

O golpe deve ser dado com a borda ungueal, e não com a polpa do dedo, que cairá em leve obliquidade, evitando que a unha atinja o dorso do dedo plexímetro.





Figura 5.17 Percussão digitodigital. A sequência de imagens mostra que a movimentação da mão que percute faz-se com o uso exclusivo da articulação do punho; o cotovelo permanece fixo.

Logo às primeiras tentativas de percussão será observado que este procedimento é impossível de ser executado com unhas longas.

A intensidade do golpe é variável, suave quando se trata de tórax de crianças, ou com certa força no caso de pessoas adultas com paredes torácicas espessas. Somente com o treino, o estudante aprenderá a dosar a intensidade do golpe.

É aconselhável a execução de dois golpes seguidos, secos e rápidos, tendo-se o cuidado de levantar o plexor imediatamente após o segundo golpe. Retardar na sua retirada provoca abafamento das vibrações.

A sequência de dois golpes facilita a aquisição do ritmo que permitirá uma sucessão de golpes de intensidade uniforme quando se muda de uma área para outra.

Em órgãos simétricos, é conveniente a percussão comparada de um e outro lado.

As posições do paciente e do médico variam de acordo com a região a ser percutida. De qualquer maneira, é necessário adotar uma posição correta e confortável.

O som que se pode obter pela percussão varia de pessoa para pessoa. No início, o estudante tem dificuldade em conseguir qualquer espécie de som. Alguns têm mais facilidade e em poucas semanas obtêm um som satisfatório; outros demoram mais tempo. Aqueles que têm dedos grossos e curtos obtêm som mais nítido e de tonalidade mais alta. Com maior ou menor dificuldade, todo estudante aprende a percutir. O segredo é o treinamento repetido até que os movimentos envolvidos nesse procedimento sejam automatizados.

Para treinar, sugerimos a seguinte estratégia:

Automatizar o movimento da mão que percute. Parte-se de uma posição correta: examinador em posição ortostática, ombros relaxados, braços em semiabdução, próximos ao tórax, cotovelo fletido formando ângulo de 90°. Passa-se, então, a executar movimentos de flexão e extensão da mão em velocidade progressiva. Este exercício visa impedir a criação de dois vícios comuns: a percussão com o pulso rígido e a movimentação da articulação do cotovelo. Na verdade, o que se procura com este exercício é “amolecer” a articulação do punho

Automatizar a direção do golpe. Inicialmente marca-se um ponto na mesa ou em um objeto comum (um livro, por exemplo)

e procura-se percutir o alvo sem olhar para ele. Em seguida, faz-se o mesmo exercício com a percussão digitodigital

Automatizar a força e o ritmo dos golpes até se obter o melhor som com o mínimo de força. O ritmo pode ser constante, mas a força do golpe varia conforme a estrutura percutida. As estruturas maciças e submaciças exigem um golpe mais forte para se produzir algum som, enquanto as que contêm ar ressoam com pancadas mais leves. Ao se treinar o ritmo da percussão, deve-se ter o cuidado de não deixar o plexor repousando sobre o plexímetro após o segundo golpe, conforme já salientamos anteriormente

A obtenção dos três tipos fundamentais de sons deve ser treinada previamente antes de se passar à percussão do paciente, usando-se os seguintes artifícios:

- Som maciço: é obtido percutindo-se a cabeceira da cama, o tampo de uma mesa, uma parede ou um bloco de madeira
- Som pulmonar: é emitido ao se percutir um colchão de mola, uma caixa contendo pedaços de isopor ou mesmo um livro grosso colocado sobre a mesa
- Som timpânico: é o que se consegue percutindo uma caixa vazia ou um pequeno tambor

A última etapa do treinamento é a percussão do corpo humano. Independentemente de se aprofundar na semiologia digestiva e respiratória, devem-se percutir áreas do tórax normal para obtenção do som pulmonar; a área de projeção do fígado, para se ter som maciço; e sobre o abdome, para conseguir som timpânico.

Em situações especiais, podem-se utilizar as seguintes técnicas de percussão:

Punho-percussão: mantendo-se a mão fechada, golpeia-se com a borda cubital a região em estudo e averigua-se se a manobra desperta sensação dolorosa (Figura 5.18)

Percussão com a borda da mão: os dedos ficam estendidos e unidos, golpeando-se a região desejada com a borda ulnar, procurando observar se a manobra provoca alguma sensação dolorosa (Figura 5.19)

Percussão por piparote: com uma das mãos o examinador golpeia o abdome com piparotes, enquanto a outra, espalmada na região contralateral, procura captar ondas líquidas chocando-se contra a parede abdominal. A percussão por piparote é usada na pesquisa de ascite (Figura 5.20).

As técnicas punho-percussão e percussão com a borda da mão são usadas no exame físico dos rins. Os golpes são dados na área de projeção deste órgão (regiões lombares), e o surgimento de dor é sugestivo de lesões inflamatórias das vias urinárias altas (pielonefrite).

Boxe

Dicas para o estudante

Treine a técnica da percussão utilizando a superfície de um livro

Treine a flexão e a extensão da mão mantendo o antebraço imóvel por meio do seguinte exercício: coloque o antebraço descansando sobre a mesa, deixando a mão pendente, fletindo-a e estendendo-a repetidamente

Na percussão digitodigital pode-se usar como plexor o dedo médio ou indicador da mão direita, bem como plexímetro o dedo médio ou indicador da outra mão. A escolha depende da habilidade do estudante

A percussão pode ser uma técnica difícil para os iniciantes, mas, como em todas as novas habilidades, a perfeição depende de muito treinamento; portanto, dedique-se, pratique e não desista!

Tipos de sons obtidos à percussão

Os sons obtidos à percussão poderiam ser classificados quanto à intensidade, ao timbre e à tonalidade, as três qualidades fundamentais vibrações sonoras.

Entretanto, para fins práticos é mais objetivo classificá-los da seguinte maneira:

Som maciço: é o que se obtém ao percutir regiões desprovidas de ar (na coxa, no nível do fígado, do coração e do baço)

Som submaciço: constitui uma variação do som maciço. A presença de ar em quantidade restrita lhe concede características peculiares



Figura 5.18 Punho-percussão com mão fechada.



Figura 5.19 Percussão com a borda da mão.



Figura 5.20 Percussão por piparote. Para aumentar a sensibilidade dessa manobra, o paciente deve colocar a borda de sua mão no meio do abdome a fim de impedir a transmissão do impulso pelo tecido subcutâneo.

Som timpânico: é o que se consegue percutindo sobre os intestinos ou no espaço de Traube (fundo do estômago) ou qualquer área que contenha ar, recoberta por uma membrana flexível

Som claro pulmonar: é o que se obtém quando se golpeia o tórax normal. Depende da presença de ar dentro dos alvéolos e demais estruturas pulmonares.

AUSCULTA

A inclusão da ausculta com estetoscópio no exame clínico, na primeira metade do século 19, foi um dos maiores avanços da medicina, desde Hipócrates.

Laennec construiu o aparelho protótipo, dando-lhe o nome de estetoscópio, da língua grega (*sthetos* = peito e *skopeo* = examinar) (ver Capítulo 1, *Iniciação ao Exame Clínico*).

Em 1855, Camman, nos EUA, idealizou o estetoscópio biauricular flexível, fato responsável pela divulgação universal desse instrumento.

A ausculta consiste em ouvir os sons produzidos pelo corpo. Em sua maioria, os ruídos corporais são muito suaves e devem ser canalizados através de um estetoscópio para serem avaliados.

Estetoscópio

Há vários tipos de estetoscópio: estetoscópio clássico, master, digital, com amplificador, eletrônico e pediátrico (Figura 5.21).

Os principais componentes de um estetoscópio clássico são: olivas auriculares, armação metálica, tubos de borracha, receptores (Figura 5.22).

Existem estetoscópios que fornecem excelente sensibilidade acústica, por meio de um sistema de amplificação e de filtragem de ruídos externos, inclusive com sistema de ausculta de dupla frequência que permite, com único diafragma, o monitoramento dos sons de alta e baixa frequências, sem a necessidade de rotação, bastando apenas modificar a pressão exercida com os dedos sobre o auscultador (Figura 5.21B).

Os estetoscópios digitais oferecem amplificações de sons até 18 vezes maiores que os estetoscópios tradicionais. A acústica superior é combinada a um processador digital de sinais, possibilitando gravação, armazenamento e reprodução de sons. Os sons gravados podem ser transferidos para um computador para serem armazenados e posteriormente analisados. Contudo, os estetoscópios digitais atuais necessitam de aperfeiçoamento nas técnicas de transferências de sons. Tais características desse estetoscópio permitem sua utilização no treinamento das habilidades de ausculta (Figura 5.21C).

Existem ainda estetoscópios próprios para pessoas com deficiência auditiva, capazes de enviar os sons a fones de ouvido que são colocados sobre aparelhos auditivos intracanaís ou retroauriculares (Figura 5.21D).

Já os estetoscópios eletrônicos, também fornecem excelente sensibilidade acústica e um sistema de purificação de amplificação e de filtragem ideal para ouvir todos os sons corporais, com redução de ruídos ambientes em até 75% (Figura 5.21E).

Os modelos de estetoscópios ideais para pediatria e neonatologia apresentam receptores com tamanhos reduzidos para perfeita adaptação em crianças e recém-nascidos, possibilitando a ausculta dos sons de baixa e alta frequência (Figura 5.21F).

Outro tipo de estetoscópio utilizado é o obstétrico, monoauricular e constituído por uma campânula receptora de grande diâmetro, próprio para a ausculta fetal que se consegue em área mais dispersa do que os fenômenos estetoacústicos audíveis no tórax.



A



B



C



D



E



F

Figura 5.21 Tipos de estetoscópio: clássico (A); master (B); digital (C); com amplificador (D); eletrônico (E); pediátrico (F).

Semiotécnica

Para uma boa ausculta, deve-se obedecer às seguintes normas:

Ambiente de ausculta: ambiente silencioso é condição indispensável para permitir uma boa ausculta. Os ruídos cardíacos e broncopulmonares são de pequena intensidade e, para ouvi-los, é necessário completo silêncio. Conversas, barulhos produzidos por veículos ou outras máquinas impossibilitam a realização de uma boa ausculta. Quando um estudante está auscultando, o restante do grupo deve guardar absoluto silêncio

Posição do paciente e do examinador: o médico e o paciente devem colocar-se comodamente no momento da ausculta.

A posição habitual do paciente para a ausculta do coração é o decúbito dorsal com a cabeça apoiada ou não em um travesseiro. O paciente sentado com o tórax ligeiramente inclinado para a frente ou em decúbito lateral esquerdo são outras posições para se auscultar melhor sons cardíacos específicos. Nas três posições, o examinador fica em pé, à direita do paciente.

Para se auscultarem os ruídos respiratórios, o paciente mantém-se sentado, um pouco inclinado para a frente. O examinador posiciona-se à direita do paciente, durante a ausculta anterior, e à esquerda, durante a ausculta posterior.

A posição mais frequente do paciente para a ausculta do abdome é o decúbito dorsal, com o examinador em pé, à direita dele

Instrução do paciente de maneira adequada: as solicitações feitas ao paciente devem ser claras. Assim, quando se deseja que ele altere seu modo de respirar – aumentar a amplitude, inspirar profundamente, expirar de modo forçado, parar a respiração –, isso deve ser feito em linguagem compreensível. Quando se quer, por exemplo, uma expiração forçada, a melhor maneira de obtê-la é solicitar ao paciente que esvazie o peito, soprando todo o ar que for possível

Escolha correta do receptor: refere-se ao tipo e tamanho do receptor. De maneira geral, deve ser usado o receptor de diafragma de maior diâmetro, com o qual é efetuada toda a ausculta. Contudo, vale salientar algumas particularidades que têm valor prático; entre elas, o fato de o receptor de diafragma ser mais apropriado para ouvir ruídos de alta frequência, enquanto a campânula capta melhor os ruídos de baixa frequência

Aplicação correta do receptor: o receptor, seja do tipo de diafragma ou de campânula, deve ficar levemente apoiado sobre a pele, procurando-se, ao mesmo tempo, obter uma perfeita coaptação de suas bordas na área que está sendo auscultada. A aplicação correta do receptor impede a captação de ruídos ambientais que interferem na percepção dos sons. Além disso, a compressão intensa da campânula sobre a pele a transforma em um receptor de diafragma – a própria pele do paciente distendida fortemente pelas rebordas do receptor faz o papel de membrana –, anulando sua vantagem na ausculta de ruídos de baixa frequência.



1. Olivas auriculares: são pequenas peças cônicas que propiciam uma perfeita adaptação ao meato auditivo, de modo a criar um sistema fechado entre o ouvido e o aparelho. A inclinação das olivas deve ficar orientada no sentido frontal. Essa é a inclinação natural do canal auditivo e fornece um bloqueio adequado do ruído ambiental.

2. Armação metálica: provida de mola, põe em comunicação as peças auriculares com o sistema flexível de borracha. A mola metálica serve para proporcionar um perfeito ajuste do instrumento.

3. Tubos de borracha: em geral, são utilizados tubos com diâmetro entre 0,3 e 0,5 cm e comprimento de 25 a 30 cm. Dá-se preferência aos estetoscópios que apresentem tubos de menor comprimento e maior diâmetro.

4. Receptores: existem dois tipos de receptores: o de campânula e o de diafragma. Utiliza-se mais frequentemente o diafragma, que dispõe de uma membrana semirrígida com diâmetro de 3 a 3,5 cm, pois sua superfície achatada é melhor para ruídos de alta frequência (ruídos respiratórios, intestinais, sopros e bulhas cardíacas). Já a campânula em superfície côncava, com diâmetro de 2,5 cm, é ideal para sons suaves de baixa frequência (sopros, bulhas cardíacas anormais e acessórias).

Figura 5.22 Componentes do estetoscópio.

Boxe

Dicas para o estudante

Deve-se manter a sala de exames com temperatura agradável. Se o paciente tremer, as contrações musculares involuntárias poderão abafar outros sons

As olivas do estetoscópio devem ficar bem ajustadas. Ajuste a tensão e experimente olivas de plástico e de borracha para escolher quais as mais confortáveis

Deve-se manter o diafragma firmemente posicionado contra a pele do paciente, o suficiente para deixar uma discreta impressão depois de retirado

Nunca se deve auscultar sobre as roupas do paciente. Em situações especiais, pode-se colocar o estetoscópio sob a roupa para auscultar, porém com cuidado para que o tecido não seja friccionado contra o estetoscópio

A pilificação do tórax pode gerar sons de estertoração fina que simulam ruídos respiratórios anormais. Para minimizar esse problema, umedeça os pelos (chumaço de algodão com água) antes de auscultar a região

Ausculata é uma habilidade de difícil domínio. Inicialmente, é preciso reconhecer os sons normais, para só depois passar a perceber os sons anormais e os sons “extras” (desdobramento de bulhas, cliques, B3 e B4, estalidos de abertura de valvas)

É necessário saber que, em algumas regiões do corpo, mais de um som será auscultado, o que pode causar confusão; como exemplo, podemos citar a ausculta do tórax em que se verificam ruídos respiratórios e cardíacos simultaneamente. É preciso treinar a audição para se ouvir seletivamente, auscultando-se

apenas um som por vez. Para tanto, recomenda-se a utilização de manequins em laboratório de habilidades ou o treinamento por meio da apreciação musical de orquestra e bandas, buscando identificar os diferentes sons dos instrumentos.

OLFATO COMO RECURSO DE DIAGNÓSTICO

O olfato não tem a mesma importância da inspeção, palpação, percussão e ausculta; entretanto, algumas vezes, a percepção de um determinado odor pode fornecer um indício diagnóstico.

Normalmente, mesmo pessoas saudáveis e razoavelmente limpas exalam um odor levemente desagradável.

Em determinadas doenças, no entanto, odores diferentes são eliminados em decorrência da secreção de certas substâncias; por exemplo, o hálito da pessoa que ingeriu bebida alcoólica é característico; os pacientes com cetoacidose diabética eliminam um odor que lembra o de acetona; no coma hepático, o hálito tem odor fétido; e nos pacientes com uremia, há hálito com cheiro de urina.

A halitose é um odor desagradável que pode ser atribuído a diferentes causas (má higiene bucal, cáries dentárias, próteses mal adaptadas, afecções periodontais, infecções de vias respiratórias, alterações metabólicas e algumas afecções do aparelho digestivo).

Um dos odores mais observados, sobretudo em pessoas de baixo padrão socioeconômico, é decorrente da ausência de cuidados higiênicos. Trata-se do próprio odor despreendido da superfície corporal e que impregna as roupas e o próprio corpo do paciente.

AMBIENTE ADEQUADO PARA O EXAME FÍSICO

A sala de exames deve ser tranquila, confortável, bem iluminada, com privacidade e temperatura agradável. Se possível, evite ruídos que possam causar distração, como máquinas com barulhos contínuos, músicas ou conversas de pessoas que atrapalhem principalmente a ausculta dos ruídos corporais.

São necessários mesa de exame ou maca, lençol descartável, lençol ou avental para cobrir o paciente e mesa à beira do leito para colocar os instrumentos e aparelhos que serão utilizados durante o exame.

INSTRUMENTOS E APARELHOS NECESSÁRIOS PARA O EXAME FÍSICO

Uma vez obtida e anotada a anamnese, segue-se o exame físico. Para se realizar o exame físico, é necessária uma série de instrumentos e aparelhos simples, os quais são descritos e apresentados no Quadro 5.1.

Vale destacar que esses instrumentos e aparelhos utilizados no exame físico costumam ser usados em muitos pacientes e transformam-se em veículos de transmissão de infecções.

Limpar o estetoscópio, a fita métrica e o termômetro com chumaço de algodão com álcool entre o exame de um paciente e outro é uma medida de controle eficaz.

Os instrumentos para endoscopia simples, exceto os descartáveis, têm de ser adequadamente esterilizados.

Além da limpeza dos instrumentos, para evitar transmissão de microrganismos entre pacientes ou entre o paciente e o examinador, é imprescindível a lavagem das mãos, como citado anteriormente.

Boxe

Aspectos psicológicos do exame físico

Não se pode esquecer, durante o exame clínico, do significado psicológico do exame físico. Para o paciente, as técnicas que usamos para identificar alterações anatômicas ou funcionais contêm outro componente, este muitas vezes esquecido pelo médico. Desse modo, na *inspeção* está incluído o ato de *olhar*; na *palpação* e na *percussão*, o de *tocar*, e, na *ausculta*, o de *escutar*. Se estivermos conscientes do significado psicológico das técnicas semióticas, iremos verificar que isso reforça a relação médico-paciente pela proximidade que se estabelece com o doente. É necessário, portanto, compreender que *inspecionar* e *olhar* são indissociáveis, enquanto *palpar* e *tocar* são procedimentos que se complementam. A síntese desse duplo significado do exame físico é mais bem compreendida se nos lembrarmos do que os pacientes querem expressar quando nos dizem: “Doutor, estou em suas mãos!” Essa expressão tem duplo sentido: o paciente espera que de nossas

mãos saia uma prescrição ou um ato cirúrgico capaz de livrá-lo de um padecimento, assim como está nos entregando sua vida, permitindo-nos decidir o que é melhor para ele.

Quadro 5.1

Instrumentos e aparelhos necessários para o exame físico.



Estetoscópio

Instrumento utilizado para se auscultar sons cardíacos, respiratórios e abdominais.



Esfigmomanômetro

Aparelho utilizado para aferir a pressão arterial. Pode ser à base de mercúrio, aneroides ou eletrônicos/digitais.



Lanterna de bolso

Serve para iluminar as cavidades não alcançadas pela luz natural e para pesquisar reflexos fotomotores.



Abaixador de língua

Utilizado para melhor visualização da cavidade oral. São descartáveis e podem ser de madeira ou plástico.



Fita métrica

Serve para medir diâmetros corporais – cefálico, torácico, abdominal – ou qualquer alteração mensurável, como tamanho de fígado e baço.



Termômetro

Instrumento utilizado para medir a temperatura corporal. Pode ser de mercúrio ou eletrônico/digital. Pode-se determinar a temperatura oral, axilar, retal ou da membrana timpânica (muito útil em crianças).



Lupa

É uma lente biconvexa com capacidade de aumento de 4 a 8 vezes o normal. Muito utilizada nos exames dermatológicos.



Martelo de reflexos

Pequeno martelo de borracha utilizado para testar reflexos tendinosos.



Agulha descartável e algodão

Servem para pesquisar sensibilidade tátil e dolorosa.



Diapasão

Instrumento vibratório, de aço, utilizado no exame do ouvido e do sistema nervoso.



Rinoscópio

Instrumento que permite a visualização do interior da cavidade nasal.



Balança antropométrica com haste milimetrada

Serve para determinar peso corporal e altura do paciente. Pode ser mecânica ou



Oftalmoscópio

Avalia, através da pupila, o fundo de olho.



Otoscópio

Visualiza o canal auditivo e o tímpano.



Anuscópio

Instrumento em forma de espêculo,



Espêculo vaginal

Instrumento que mantém

		metálico ou descartável (acrílico), utilizado para visualizar o ânus e a porção distal do reto.	as paredes vaginais afastadas, facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico. Pode ser metálico ou descartável (acrílico).		eletrônica.
--	--	---	--	--	-------------

Capítulo 6



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Sinais e Sintomas

Celmo Celeno Porto

Delson José da Silva

Rejane Faria Ribeiro-Rotta

Nádia do Lago Costa

Diego Antônio Arantes

Danilo Rocha Dias

Fernanda Tenório Lopes Barbosa

Denise Sisteroli Diniz

Gil Eduardo Perini

Osvaldo Vilela Filho

Cláudio Jacinto Pereira Martins

Renato Sampaio Tavares

- Introdução
- Os sintomas como linguagem dos órgãos
- A dor como sintoma padrão
- Sintomas gerais
- Pele, tecido celular subcutâneo e fâneros
- Olhos
- Ouvidos
- Nariz e cavidades paranasais
- Faringe
- Laringe
- Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras
- Diafragma e mediastino
- Sistema cardiovascular
- Sistema digestivo
- Região bucomaxilofacial
- Esôfago
- Estômago
- Intestino delgado
- Cólon, reto e ânus
- Fígado, vesícula e vias biliares
- Pâncreas
- Rins e vias urinárias
- Órgãos genitais masculinos
- Órgãos genitais femininos

-
- Mamas
- Sistema hemolinfopoético
- Ossos
- Articulações
- Coluna vertebral
- Bursas e tendões
- Músculos
- Sistema endócrino
- Hipotálamo e hipófise
- Tireoide
- Paratireoides
- Suprarrenais
- Gônadas
- Metabolismo e condições nutricionais
- Desnutrição
- Sistema nervoso central
- Sistema nervoso periférico
- Roteiro pedagógico para análise do sintoma dor

INTRODUÇÃO

Boxe

Considerando que o mesmo sintoma pode ser a “linguagem” de vários órgãos, sugerimos ao estudante que, ao estudar um determinado sintoma, busque informações sobre ele nos vários itens em que é abordado; exemplo: a dispneia é descrita no estudo da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios, dos pulmões, das pleuras, do coração, do diafragma e do mediastino. Assim, terá uma visão abrangente do sintoma e suas causas.

As doenças manifestam-se por sinais e sintomas que o paciente relata ou que o médico descobre ao fazer o exame clínico. Tradicionalmente, o termo *sintoma* designaria as sensações subjetivas anormais sentidas pelo paciente e não visualizadas pelo médico (p. ex., dor, má digestão, náuseas), enquanto *sinais* seriam as manifestações objetivas, reconhecíveis por meio de inspeção, palpação, percussão, ausculta ou meios subsidiários (p. ex., edema, cianose, tosse, presença de sangue na urina). Contudo, nem sempre é possível uma rígida distinção entre sintoma e sinal, porque algumas manifestações, como dispneia, tosse, vômitos, entre outras, são sensações subjetivas para o paciente, mas podem ser constatadas objetivamente pelo médico. Talvez por isso, e pela lei do menor esforço, no linguajar médico cada vez mais os termos *sinal* e *sintoma* sejam usados praticamente como sinônimos.

Denomina-se *sinal patognomônico* ou *sintoma típico* aquela manifestação que indica, com alta probabilidade, a existência de uma determinada lesão ou doença. É necessário cautela para usar essas expressões, pois, de maneira geral, a certeza diagnóstica somente é obtida pela associação de sintomas e sinais, e não pela presença de um deles isoladamente. Por outro lado, deve-se estar prevenido para a ocorrência frequente de *sintomas atípicos*, ou seja, manifestações que não preenchem as características semiológicas consideradas “próprias ou específicas” de uma entidade clínica; exemplo, a dor da angina do peito não apresenta as características semiológicas clássicas em 30% dos pacientes, mas, sabendo-se analisá-la, podem-se encontrar uma ou mais características clínicas que vai permitir ao médico levantar a possibilidade de isquemia miocárdica.

Boxe

Os sinais, os sintomas e o raciocínio diagnóstico

O raciocínio diagnóstico é um processo complexo que começa no primeiro contato com o paciente. Conhecer as características dos sintomas relatados é a base do raciocínio. Esse processo não é fruto apenas da obtenção de informações que nos levariam a uma conclusão inevitável; é um verdadeiro quebra-cabeça, cujas peças são criadas no decorrer do próprio jogo. É claro que é necessário ter armazenadas na mente as regras e as peças-chave para decifrar o enigma representado pelo diagnóstico. Quando se dispõe das informações básicas sobre os sintomas, seus mecanismos e suas causas, à medida que se progride na entrevista do paciente, o médico cria hipóteses e possibilidades, a partir das quais suas indagações tornam-se mais objetivas; ou seja, à medida que o quebra-cabeça é montado, as perguntas que o médico faz ao paciente tornam-se cada vez mais adequadas para reforçar ou afastar uma determinada possibilidade. Por isso, quando se têm na memória as principais características dos sintomas e suas principais causas, a anamnese fica mais objetiva e interessante. Este capítulo tem como proposta a sistematização dos conhecimentos essenciais sobre os sinais e sintomas.

No Quadro 6.1 encontra-se o esquema básico para análise de qualquer sintoma.

Quadro 6.1

Esquema para análise de um sintoma.

Início

- Marcar a época em que o sintoma surgiu é fundamental. Se ele ocorrer episodicamente, considera-se o início do primeiro episódio como referência principal, definindo a seguir a duração dos outros

- O modo como o sintoma se apresentou (súbito ou gradativo) e os fatores ou situações que o desencadearam ou o acompanharam em seu início devem ser bem esclarecidos

Principais características semiológicas

- Duração (definir a duração do sintoma é um dado fundamental, o que se fará sem dificuldade desde que se conheça a época em que ele teve início)
- Localização
- Qualidade
- Intensidade (leve, moderado, intenso)
- Relações com as funções do órgão ou sistema, direta ou indiretamente relacionados com o sintoma

Evolução

- Analisar a evolução ao longo do tempo e as modificações ocorridas, incluindo a influência de tratamentos efetuados

Relação de dois ou mais sintomas entre si

- Procurar definir as relações entre os principais sintomas, identificando sempre que possível o sintoma-guia

Identificação dos fatores que agravam ou aliviam

Esclarecimento das características do sintoma no momento do exame

Boxe

Sinais e sintomas com base em evidências estatísticas

Como subproduto do movimento que deu origem à Medicina Baseada em Evidências (MBE), surgiram propostas para se aplicarem técnicas estatísticas para avaliação dos sinais e sintomas relatados pelos pacientes; entre estas destaca-se o manual *Evidence-Based Physical Diagnosis*, de Steven McGee, publicado em 2007.

O valor das técnicas estatísticas, essência da MBE, é inquestionável na avaliação da eficácia de medicamentos e outros modos de tratamento, bem como na definição do valor diagnóstico de novos equipamentos e testes laboratoriais.

A proposta básica de McGee foi analisar a sensibilidade e a especificidade de dados obtidos no exame físico, assim como o poder discriminatório dos sinais e sintomas para aventar hipóteses diagnósticas, mas também para avaliar outros parâmetros, tais como risco de vida e tempo de internação. Contudo, as técnicas estatísticas disponíveis não são inteiramente adequadas para isso, em virtude da variabilidade das manifestações clínicas e do grande número de combinações possíveis. Na maior parte dos pacientes, o raciocínio diagnóstico exige que a interpretação dos sinais e sintomas seja feita no contexto de cada paciente. Apenas em situações especiais é possível interpretar isoladamente um determinado sinal ou sintoma: são os chamados sinais ou sintomas patognomônicos.

Quando se raciocina a partir de dois ou mais sintomas, a sensibilidade e a especificidade de cada um deles

dependem do contexto clínico, no qual sempre existem inúmeras variáveis. Basta, por exemplo, mudar a idade do paciente para modificar radicalmente o significado diagnóstico de um sintoma ou sinal. Tomemos como modelo a febre. Considerada de maneira isolada, seu poder discriminatório é muito baixo, pois um sem-número de doenças infecciosas ou de outras naturezas podem se acompanhar de febre. Portanto, tanto a sensibilidade como a especificidade são muito baixas. Se acrescentarmos outro sinal ou sintoma, o poder discriminatório da febre se modifica completamente. Se o sintoma for tosse, por exemplo, a possibilidade de uma infecção pulmonar é evidente; se a febre for de longa duração, o raciocínio diagnóstico nos encaminha para tuberculose pulmonar; se for de curta duração, a possibilidade de pneumonia bacteriana passa para primeiro lugar; se a febre estiver associada a linfadenopatia muda inteiramente o raciocínio diagnóstico, e assim por diante.

A sensibilidade, a especificidade e o poder discriminatório de sinais e sintomas não precisam ser “quantificados” para serem bem utilizados no raciocínio diagnóstico. A “sensibilidade” clínica é que nos leva à hierarquização das manifestações clínicas no complexo processo mental que é o raciocínio diagnóstico.

OS SINTOMAS COMO LINGUAGEM DOS ÓRGÃOS

Os sintomas podem ser considerados a linguagem dos órgãos. Em certas condições é uma linguagem direta; em outras, é simbólica. Linguagem direta quando o sintoma expressa uma modificação localizada naquele órgão (dor cardíaca na isquemia miocárdica; dispneia na congestão pulmonar; diarreia nas enterocolites), e linguagem simbólica quando é a expressão somática de transtornos emocionais (disfagia histerica; tosse de origem emocional; dor precordial na depressão; dispneia suspirosa na ansiedade). Contudo, o organismo não se comporta tão esquematicamente, visto que o ser humano é constituído por duas partes indivisíveis – a mente e o corpo –, inteiramente imbricadas. Mente e corpo, físico e psíquico, são absolutamente solidários; um não existe sem o outro. Apesar de ora um ficar mais em evidência que o outro, ambos, na saúde e na doença, estão sempre presentes. Por isso, é necessário reconhecer que esta subdivisão em *linguagem direta* e *linguagem simbólica* serve apenas como um recurso didático que facilita sua compreensão.

Quando um sintoma surge, o paciente, assim como o médico, não tem condições de reconhecer prontamente se ele expressa uma alteração do órgão (linguagem direta) ou se ele expressa uma alteração emocional projetada naquele órgão (linguagem simbólica). É necessário analisar todos os dados clínicos, e não raramente dados obtidos de exames complementares.

Boxe

Dor precordial

Tanto a dor cardíaca de origem isquêmica como a dor precordial de origem emocional são absolutamente reais e verdadeiras, diferindo apenas na sua origem. Uma é a consequência da estimulação das terminações nervosas por substâncias químicas produzidas pela hipoxia, enquanto a outra é produzida por substâncias químicas originadas no sistema límbico durante uma frustração, uma perda ou qualquer condição que agride o sistema emocional do paciente. No primeiro caso, é no “coração anatômico” que se origina a dor; no segundo, a dor é sentida no “coração simbólico”, que está projetado na nossa mente.

Admitindo-se a unicidade mente-corpo, não é difícil compreender que em todo sintoma há um componente físico e um psíquico. O componente físico está restrito aos aspectos anatômicos do órgão, enquanto o componente psíquico está intimamente relacionado com os aspectos socioculturais em que se insere cada pessoa. Heranças raciais, influências religiosas, organização social, aspectos econômicos se interpenetram na mente humana e atingem os sistemas que captam as sensações que se originam nos órgãos, dando aos sintomas significados diferentes quando o contexto é outro.

O inverso também é verdadeiro, ou seja, os órgãos podem ser a expressão de manifestações originadas no sistema límbico, pois é ali que se faz a conexão entre os órgãos e o meio ambiente.

Por isso, ao se fazer a análise de um sintoma, o médico precisa ter referências anatômicas, fisiológicas, psicológicas e socioculturais, estas para poder valorizar as expressões usadas e a maneira de o paciente sentir o que se passa em seu organismo.

A DOR COMO SINTOMA PADRÃO

A dor é a manifestação clínica mais frequente e pode ser tomada como sintoma padrão.

É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tissular potencial ou real ou mesmo a nenhuma lesão, embora ainda assim descrita com termos sugestivos de que dano tecidual houvesse de fato ocorrido (definição da IASP – International Association for the Study of Pain). É essencialmente uma manifestação subjetiva, variando sua apreciação de um indivíduo para outro e até em um mesmo indivíduo, quando submetido a estímulos idênticos, porém em circunstâncias distintas.

Anatomia funcional da dor

Transdução

É o mecanismo de ativação dos nociceptores, fenômeno que se dá pela transformação de um estímulo nóxico – mecânico, térmico ou químico – em potencial de ação (Figura 6.1).

Os nociceptores são terminações nervosas livres de fibras mielínicas finas (A-delta ou III), sensíveis aos estímulos mecânicos e/ou térmicos nóxicos, ou amielínicas (C ou IV), sensíveis àqueles estímulos e aos químicos (nociceptores C polimodais).

Os estímulos mecânicos e térmicos nóxicos, além de excitarem os nociceptores a eles sensíveis, promovem dano tecidual e vascular local, causando liberação ou formação de uma série de substâncias, tais como os íons hidrogênio e potássio, serotonina, histamina, cininas, leucotrienos, prostaglandinas e substância P, as quais, por sua vez, atuam nos nociceptores a elas sensíveis – fenômeno denominado *transdução* – por meio de três mecanismos distintos: ativação direta (potássio, hidrogênio, cininas, serotonina e histamina), sensibilização (cininas, prostaglandinas e substância P) e produção de extravasamento do plasma (substância P e cininas).

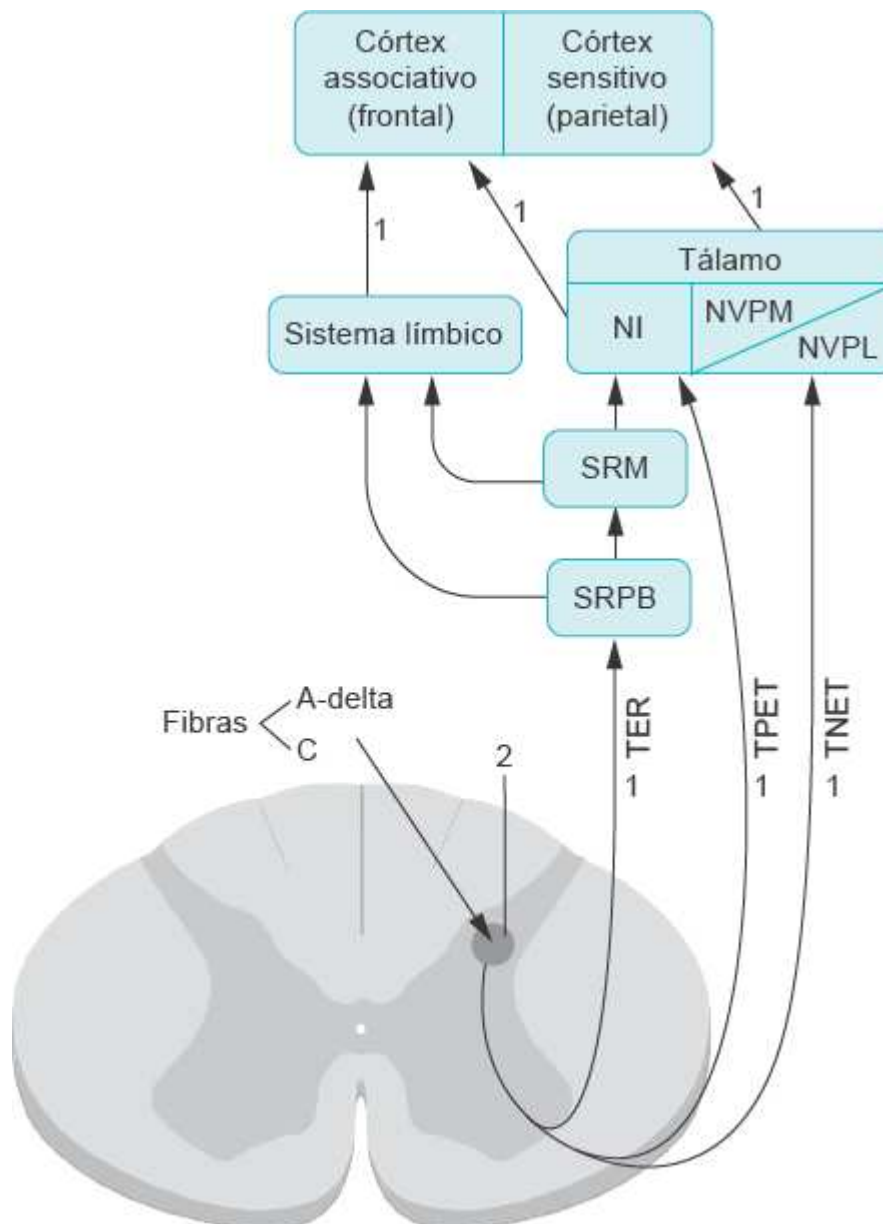


Figura 6.1 Vias nociceptivas. (1) Vias nervosas de transmissão do impulso doloroso. TER = trato espinorreticular; TPET = trato paleoespinalâmico; TNET = trato neoespinalâmico; SRPB = substância reticular pontobulbar; SRM = substância reticular mesencefálica; NI = núcleos inespecíficos; NVPL = núcleo ventroposterolateral; NVPM = núcleo ventroposteromedial. (2) Células transmissoras.

Cumprasse assinalar que a estimulação isolada de fibras A-delta cutâneas, no ser humano, produz dor em pontada; a de fibras C cutâneas, dor em queimação; e a de fibras A-delta e C musculares, dolorimento (*aching pain*) ou câibra.

Admitindo-se que a dor seja um sinal de alarme, compreende-se que o estímulo adequado para provocar dor em um tecido é aquele que em geral seja capaz de lesioná-lo. Assim, os nociceptores musculares são mais sensíveis ao estiramento e à contração isquêmica; os articulares, aos processos inflamatórios e aos movimentos extremos; os viscerais, à distensão, à tração, à isquemia, ao processo inflamatório e à contração espasmódica; os das cápsulas das vísceras maciças, à distensão; os miocárdicos, à isquemia; e os tegumentares, a uma variedade de estímulos mecânicos, térmicos e químicos nódicos, mas não à distensão e à tração.

Observa-se, também, uma extrema variabilidade na sensibilidade dos diferentes tecidos e órgãos aos estímulos dolorosos, o que reflete a distinta concentração e distribuição de terminações nociceptivas neles. Os parênquimas cerebral, hepático, esplênico e pulmonar, por exemplo, são praticamente indolores. Em contrapartida, o tegumento e o revestimento fibroso do sistema nervoso (meninges), dos ossos (periósteo), da cavidade abdominal (peritônio parietal) e da cavidade torácica (pleura parietal) são extremamente sensíveis.

Mais recentemente foram identificadas estruturas denominadas *nociceptores silenciosos*, presentes nas terminações periféricas das fibras C de nervos articulares, cutâneos e viscerais, mas não dos músculos. Em condições normais, tais receptores encontram-se “desativados” (silenciosos), insensíveis aos estímulos mecânicos. Quando sensibilizados, porém, como na vigência de um processo inflamatório ou de estímulos químicos ou térmicos, eles se tornam ativos e altamente responsivos aos estímulos mecânicos, mesmo àqueles inócuos.

Transmissão

É o conjunto de vias e mecanismos que permite que o impulso nervoso, originado ao nível dos nociceptores, seja conduzido para estruturas do sistema nervoso central relacionadas ao reconhecimento da dor (Figura 6.1).

As fibras nociceptivas (A-delta e C), oriundas da periferia, constituem os prolongamentos periféricos dos neurônios pseudounipolares situados nos gânglios espinais e de alguns nervos cranianos (trigêmeo, principalmente, facial, glossofaríngeo e vago). Aquelas provenientes de estruturas somáticas cursam por nervos sensoriais ou mistos e apresentam uma distribuição dermatômica. Já as provenientes das vísceras cursam por nervos autônomos simpáticos (cardíacos médio e inferior, esplâncnico maior, menor e médio, esplâncnicos lombares etc.) e parassimpáticos (vago, glossofaríngeo e esplâncnicos pélvicos – S2, S3 e S4).

O nervo vago é responsável pela inervação dolorosa do parênquima pulmonar (muito discreta) e dos dois terços superiores do esôfago. O parassimpático pélvico é responsável pela inervação do cólon descendente, sigmoide, reto e boa parte da bexiga e uretra proximal. Os nervos simpáticos, por sua vez, são responsáveis pela inervação dolorosa do coração, da maior parte do trato gastrointestinal (terço inferior do esôfago, estômago, delgado, cólon ascendente e transversal, fígado, vias biliares e pâncreas) e de grande parte do trato geniturinário, sendo que a bexiga e a uretra proximal têm inervação parassimpática e simpática.

Os impulsos que seguem pelos nervos simpáticos passam pelo tronco simpático e ganham os nervos espinais pelos ramos comunicantes brancos. Os aferentes nociceptivos cardíacos adentram a medula espinal entre o 1º e o 5º segmentos torácicos, os do trato digestivo, entre o 5º segmento torácico e o 2º lombar, e os do trato geniturinário, entre o 10º torácico e o 2º lombar. Os impulsos que trafegam pelo parassimpático pélvico atingem a medula entre o 2º e o 4º segmentos sacrais, via respectivos nervos espinais.

Os prolongamentos centrais dos neurônios pseudounipolares adentram a medula espinal (ou o tronco cerebral), sobretudo pela raiz dorsal (porção ventrolateral), mas também pela raiz ventral, na qual se bifurcam em ramos ascendente e descendente, constituindo o trato dorsolateral ou de Lissauer. Tais ramos fazem sinapse com neurônios situados em variadas lâminas de Rexed do corno dorsal; as fibras C cutâneas terminam principalmente nas lâminas I e II, as fibras A-delta cutâneas, bem como os aferentes musculares (A-delta e C), nas lâminas I e V e os aferentes viscerais (C e A-delta), nas lâminas I, II, V e X.

Vários são os neurotransmissores presentes nesses aferentes, destacando-se o glutamato, aparentemente responsável pela excitação rápida dos neurônios medulares, e a substância P, envolvida na excitação lenta destes. Outras substâncias, tais como a somatostatina, o polipeptídeo intestinal vasoativo e o polipeptídeo relacionado com o gene da calcitonina, parecem atuar, não pela ativação ou inibição direta dos neurônios medulares, mas, sim, pela modulação da transmissão sináptica.

Dos neurônios do corno dorsal originam-se as vias nociceptivas, que podem ser divididas em dois grupos principais (Figura

Vias do grupo lateral: filogeneticamente mais recentes, quase totalmente cruzadas e representadas pelos tratos neoespinotalâmico (espinotalâmico lateral), neotrigeminotalâmico, espinocervicotalâmico e sistema pós-sináptico da coluna dorsal, terminam, predominantemente, nos núcleos talâmicos ventrocaudal (ventral [VPL] + ventral posteromedial [VPM]), submédio, porção medial do tálamo posterior (POm) e porção posterior do núcleo ventromedial (VMpo), de onde partem as radiações talâmicas para o córtex somestésico (fibras provenientes de VPL e VPM), orbitofrontal (fibras oriundas de POm) e insular (fibras procedentes de VMpo). Por serem essas vias e estruturas somatotopicamente organizadas, estão elas envolvidas no aspecto sensorial-discriminativo da dor

Vias do grupo medial: filogeneticamente mais antigas, parcialmente cruzadas, terminam direta (tratos paleoespinotalâmico e paleotrigeminotalâmico) ou indiretamente (tratos espinorreticular e espinomesencefálico e sistema ascendente multissináptico proprioespinal) nos núcleos mediais (dorsomedial) e intralaminares (centromediano, parafascicular e central lateral) do tálamo medial, após sinapse na formação reticular do tronco cerebral e na substância cinzenta periaquedutal, de onde partem as vias reticulotálâmicas (emitem colaterais para o sistema límbico e para a substância cinzenta periventricular). Do tálamo medial partem radiações difusas para todo o córtex cerebral. As vias do grupo medial não são somatotopicamente organizadas e estão relacionadas com o aspecto afetivo-motivacional da dor (Figura 6.1).

Independentemente de sua origem (somática ou visceral), as fibras nociceptivas trafegam no sistema nervoso central pelas mesmas vias. Vale ressaltar que os aferentes nociceptivos viscerais pélvicos parecem cursar por uma via própria na profundidade do funículo posterior, próximo à linha mediana (a maior parte das vias nociceptivas cursa pelo quadrante anterolateral da medula espinal) e que, de modo geral, as vias viscerais são com certa frequência bilaterais, e não unilaterais, como as somáticas. Tal fato, associado à extrema ramificação dos nervos viscerais (um mesmo nervo participa da inervação de diversas vísceras), ao relativamente pequeno número de aferentes viscerais (compreendem apenas 10% das fibras da raiz dorsal), ao proporcionalmente elevado número de fibras C (condução lenta) nos nervos viscerais (1 fibra A para 10 fibras C; na raiz dorsal, tal proporção é de 1 para 2) e à chegada dos aferentes de uma mesma víscera em múltiplos segmentos medulares, justifica a baixa precisão da dor visceral tanto em termos de localização como de qualificação.

Modulação

Além de vias e centros responsáveis pela transmissão da dor, há centros e vias responsáveis por sua supressão. Curiosamente, as vias modulatórias são ativadas pelas próprias vias nociceptivas.

O primeiro sistema modulatório descrito, denominado *Teoria do Portão ou das Comportas*, foi proposto por Melzack e Wall (Figura 6.2). Como se sabe, as fibras amielínicas (C) e mielínicas finas (A-delta) conduzem a sensibilidade termoalgésica, enquanto as fibras mielínicas grossas (A-alfa e A-beta) conduzem os demais tipos de sensibilidade (tato, pressão, posição, vibração).

Segundo essa teoria, a ativação das fibras mielínicas grossas excitaria interneurônios inibitórios da substância gelatinosa de Rolando (lâmina II) para os aferentes nociceptivos, impedindo a passagem dos impulsos dolorosos; ou seja, haveria fechamento da comporta, ao passo que a ativação das fibras amielínicas e mielínicas finas inibiria tais interneurônios inibitórios, permitindo a passagem dos impulsos nociceptivos (abertura da comporta). Esse mecanismo explica por que uma leve fricção ou massagem de uma área dolorosa proporciona alívio da dor.

Outro sistema modulatório está esquematizado na Figura 6.3. A estimulação elétrica da substância cinzenta periventricular/periaquedutal (PVG, *periventricular gray*; PAG, *periaqueductal gray*) produz acentuada analgesia, a qual acompanha-se por aumento da concentração dos opioides endógenos no liquor e é revertida pela administração de naloxona (antagonista opioide). Demonstrou-se, posteriormente, que analgesia similar podia ser obtida pela estimulação elétrica do bulbo rostroventral – BRV (núcleos da rafe magno, magnocelular e reticular paragigantocelular lateral) – e do tegmento pontino dorsolateral – TPD (locus ceruleus e subceruleus) – ou pela microinjeção de morfina em qualquer dessas regiões (PVG-PAG, BRV e TPD). Essa analgesia podia ser revertida por lesão do BRV, secção bilateral do funículo dorsolateral da medula espinal e administração intrarraquidiana de antagonistas serotoninérgicos e noradrenérgicos. Postulou-se, então, que a estimulação elétrica da substância cinzenta periventricular (PVG) e periaquedutal (PAG) excitaria o bulbo rostroventral (BRV) e o tegmento pontino dorsolateral (TPD), de onde partem vias descendentes inibitórias para os neurônios nociceptivos do corno dorsal. Tais vias cursam bilateralmente pelos funículos dorsolaterais da medula espinal e utilizam como neurotransmissor, respectivamente, a serotonina (via rafe-espinal, proveniente do BRV) e a norepinefrina (via reticuloespinal, oriunda do TPD).

A estimulação elétrica de outras estruturas pode também proporcionar alívio da dor. Tal é o caso da estimulação do funículo posterior da medula espinal, lemnisco medial, tálamo ventrocaudal, cápsula interna, córtex somestésico e córtex motor. Todas essas estruturas estão, pois, de alguma forma, envolvidas na modulação da dor. Vilela Filho, em 1996, propôs a existência do

circuito modulatório prosencéfalo-mesencefálico, que justificaria a analgesia obtida pela estimulação dessas áreas do sistema nervoso (Figura 6.4).

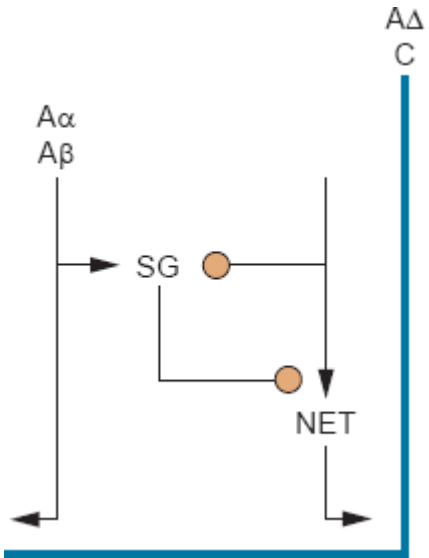


Figura 6.2 Teoria do Portão ou das Comportas de Melzack e Wall. SG = interneurônio da substância gelatinosa (lâmina II); NET = neurônio de projeção espinotalâmico (célula de origem do trato neoespinotalâmico).

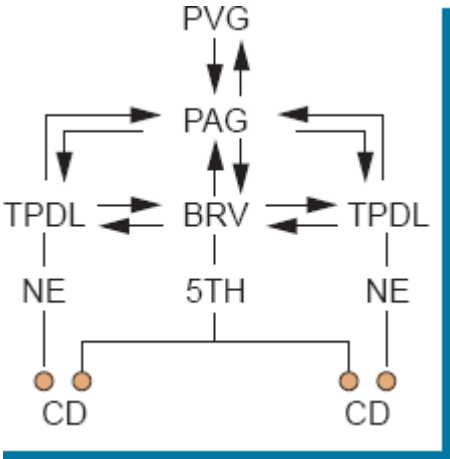


Figura 6.3 Centros modulatórios da dor. PVG = substância cinzenta periventricular; PAG = substância cinzenta periaquedutal; BRV = bulbo rostroventral; TPD = tegmento pontino dorsolateral; CD = corno dorsal; NE = norepinefrina; 5TH = 5-hidroxitriptamina (serotonina); → = excitação; ⊘ = inibição.

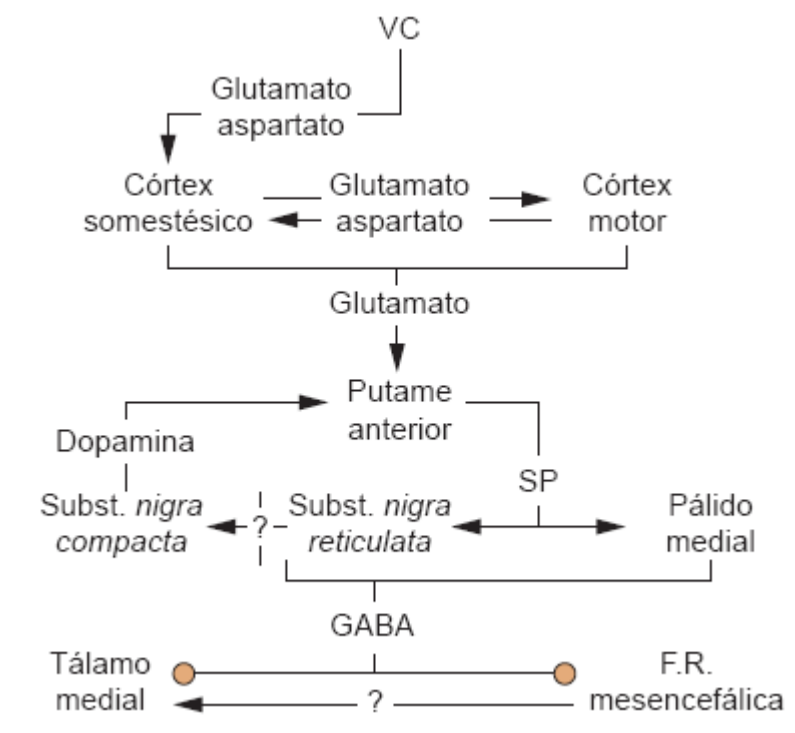


Figura 6.4 Circuito modulatório prosencéfalo-mesencefálico. VC = núcleo ventrocaudal do tálamo; SP = substância P; ? = neurotransmissor desconhecido; F.R. = formação reticular; → = excitação; ● = inibição.

Pode-se concluir que a dor pode ser provocada tanto pela ativação das vias nociceptivas como pela lesão das vias modulatórias (supressoras), o que a torna semelhante a outras funções envolvidas na manutenção da homeostase, como a pressão arterial e a temperatura.

Boxe

Opioides endógenos

A estimulação elétrica da PVG-PAG promove profunda analgesia. A aplicação de ínfimas doses de morfina nessas regiões reproduz a analgesia obtida pela estimulação. Em ambos os casos, a analgesia pode ser revertida pela administração parenteral de naloxona (antagonista opioide). Como a aplicação segmentar de morfina no espaço subaracnóideo, epidural ou mesmo diretamente na medula espinal também proporciona acentuada analgesia, concluiu-se que a ação sistêmica da morfina deve-se à sua atuação tanto no tronco cerebral como na medula espinal.

Uma vez mapeadas as áreas de atuação da morfina no sistema nervoso central, seus receptores foram prontamente identificados, tendo-se distinguido os seguintes tipos principais: *mu*, *delta* e *kappa*. Seguindo a descoberta dos receptores opioides, passou-se a investigar quais substâncias endógenas se ligariam a eles. A primeira substância identificada foi a encefalina, um pentapeptídeo; posteriormente, foram isoladas a betaendorfina, a dinorfina e a nociceptina. Essas substâncias, denominadas opioides endógenos, têm em comum a sequência inicial de aminoácidos (tirosina-glicina-glicina-fenilalanina e metionina ou leucina) e a atividade analgésica (betaendorfina > encefalina > dinorfina > nociceptina).

A betaendorfina é sintetizada a partir da pró-opiomelanocortina, atua nos receptores *mu* e está presente em células do hipotálamo basal (seus axônios projetam-se para o sistema límbico, PAG e *locus ceruleus*) e do núcleo do trato solitário.

A encefalina pode ser de dois tipos: metionina-encefalina e leucina-encefalina. É sintetizada a partir da pró-encefalina A e encontra-se distribuída principalmente pelo hipotálamo, PAG, bulbo rostroventral e corno dorsal da medula espinal; atua preferencialmente nos receptores *delta*, mas também nos *mu*.

A dinorfina, o mais fraco dos opioides endógenos, é derivada da pró-dinorfina ou pró-encefalina B, atua nos receptores *kappa* e tem distribuição similar à da encefalina.

A nociceptina é um peptídeo que possui um receptor amplamente expresso no sistema nervoso central,

particularmente no córtex cerebral e em núcleos noradrenérgicos e serotoninérgicos, com importante participação na memória e na ansiedade.

O conhecimento dos opioides endógenos é importante para compressão dos fenômenos dolorosos e abre possibilidades para descobertas de substâncias que controlam ou eliminam a dor.

Aspectos afetivo-motivacional e cognitivo-avaliativo da dor

Até o momento abordamos a dor como um tipo de sensação, ou seja, seu *aspecto sensorial-discriminativo*. É esse aspecto que nos permite identificar algumas das mais importantes características da experiência dolorosa, quais sejam, sua localização, duração, intensidade (parcialmente) e qualidade (parcialmente). Isso só é possível graças ao alto nível de organização somatotópica das vias (vias do sistema lateral) e estruturas (núcleos VPL e VPM do tálamo e córtex somestésico) envolvidas nessa dimensão da dor.

A dor, contudo, não é apenas uma sensação. A resposta final a um estímulo álgico compreende também uma série de reações reflexas, emocionais e comportamentais e depende do aprendizado e da memorização de experiências prévias, do grau de atenção ou de distração, do estado emocional e do processamento e integração das diversas informações sensoriais e cognitivas. Trata-se dos *aspectos afetivo-motivacional e cognitivo-avaliativo* da dor.

Aspecto afetivo-motivacional

As vias nociceptivas do grupo medial não são somatotopicamente organizadas e, por esse motivo, parecem não contribuir para o aspecto sensorial-discriminativo da dor. Em contrapartida, estão relacionadas por meio de suas conexões com a formação reticular do tronco cerebral, hipotálamo, núcleos mediais e intralaminares do tálamo e sistema límbico, estruturas reconhecidamente comprometidas com a regulação das emoções e do comportamento, incluindo as dimensões afetiva (experiência desagradável, ruim, amedrontadora) e motivacional (ação motivada pela dor, como a reação de retirada ou de fuga) da dor.

Diversas são as evidências que apoiam esses aspectos da dor. Assim, em um experimento realizado em gatos acordados, aos quais se ensinou desligar o estímulo elétrico nódico, aplicado em um nervo periférico, quando ele se tornava máximo, pôde-se observar que a atividade elétrica do núcleo gigantocelular (localizado na formação reticular bulbar) aumentava com o incremento da intensidade do estímulo aplicado e atingia o máximo quando o animal executava a manobra aversiva (desligava o estímulo). A estimulação elétrica direta desse núcleo (ou da formação reticular mesencefálica) provocava a mesma resposta obtida com a estimulação elétrica nódica do nervo periférico: a anulação do estímulo. A lesão do núcleo gigantocelular e da formação reticular mesencefálica, em contrapartida, reduzia marcadamente a resposta desses animais aos estímulos álgicos.

O sistema límbico e o hipotálamo (doravante também considerado como parte integrante do sistema límbico) são constantemente bombardeados por estímulos internos e externos, parte deles conduzidos pelas vias do grupo medial. Os córtices temporal e parietal, responsáveis pela integração das informações sensoriais, visuais e auditivas, apresentam íntima conexão com a amígdala e o hipocampo, importantes componentes do sistema límbico. A área pré-frontal, considerada por muitos a mais importante área associativa cortical, apresenta conexões diretas com o hipotálamo, núcleo dorsomedial do tálamo (tálamo medial), giro do cíngulo e formação reticular mesencefálica e bulbar. As informações que alcançam o sistema límbico são adequadamente avaliadas e, quando significativas, as emoções e os comportamentos são exteriorizados no momento apropriado.

A estimulação elétrica do sistema límbico pode provocar uma série de reações emocionais e comportamentais, algumas delas claramente relacionadas com a dor. A estimulação elétrica do hipotálamo posteromedial, por exemplo, considerado o centro simpático do sistema nervoso autônomo, provoca elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca e midríase bilateral; no animal acordado, tais respostas associam-se à reação de fuga, que pode ser também obtida com a estimulação da amígdala (reação de raiva também é comum), hipocampo e fórnix. A ativação do cíngulo pode induzir ansiedade e a da área septal, sensação de prazer e conforto.

Muito interessantes são as respostas obtidas com a lesão de diversas dessas estruturas, todas elas direta ou indiretamente conectadas com as vias nociceptivas do grupo medial. A lesão do giro do cíngulo (cingulotomia), do hipotálamo posteromedial (hipotalamotomia posteromedial), dos núcleos talâmicos mediais e intralaminares (talamotomia medial/intralaminar) e da via reticulotalâmica (tratotomia mesencefálica medial) e a desconexão da área pré-frontal (lobotomia ou leucotomia pré-frontal) promove marcada redução do componente afetivo-motivacional da dor, sem interferir no seu componente sensorial-discriminativo, ou seja, o paciente continua perfeitamente capaz de perceber os estímulos álgicos, mas eles perdem aquela conotação desagradável e desprazerosa.

Os núcleos intralaminares do tálamo, relevantes terminações das vias do grupo medial, emitem suas eferências, sobretudo para os núcleos da base (*striatum* = putame + caudado), que provavelmente estão relacionados com a resposta motora somática

desencadeada pelo estímulo doloroso, como, por exemplo, deixar cair uma xícara de café quente, para não queimar a mão (o córtex motor e a via corticoespinal estão também envolvidos com essa resposta). O hipotálamo, por sua vez, é o responsável pelas respostas motoras autonômicas (viscerais) frente aos estímulos dolorosos, tais como hipertensão arterial, taquicardia, sudorese, palidez e midríase. Tais respostas são mediadas pela formação reticular do tronco cerebral, via reticuloespinal e corno lateral da medula toracolombar (T1-L2).

Aspecto cognitivo-avaliativo

As primeiras experiências dolorosas do ser humano compreendem apenas seus aspectos sensorial-discriminativo e afetivo-motivacional. Ao morder o dedo, por exemplo, o bebê sente dor e a manifesta, emocionalmente, pelo choro. Com o passar dos anos, a dor passa a ser relacionada com certas polaridades como prazer/castigo e bom/mau. As influências culturais e religiosas tomam vulto no simbolismo da dor: para alguns, a manifestação pública da dor deve ser refreada, como sinal de força; para outros, sua manifestação deve ser encorajada, como modo de angariar simpatia e solidariedade. Todas essas informações e experiências dolorosas vão sendo armazenadas no âmbito da memória. Da avaliação e do julgamento desses dados dependerá o que o indivíduo considerará como dor.

Tudo isso só é possível graças às vias e estruturas responsáveis pela dimensão cognitivo-avaliativa da dor.

O impulso doloroso chega ao córtex somestésico através das vias nociceptivas de condução rápida do grupo lateral, onde a informação é processada. Essa informação, juntamente com outras de natureza tátil, propioceptiva, auditiva e visual, também já processadas, são integradas nas áreas corticais associativas, sobretudo no neocórtex temporal. Os componentes da memória são então ativados à procura de uma experiência prévia similar. Por fim, entra em ação o julgamento da experiência sensorial, quando ela é definida como dolorosa ou não (nesse processo a área pré-frontal é de grande relevância); em caso afirmativo, dependendo de sua intensidade e do risco que a situação representa para o organismo, uma estratégia de resposta já padronizada é escolhida ou uma nova estratégia é definida.

A intensidade da dor depende de uma série de fatores: intensidade do estímulo algico, grau de atenção (a atenção acentua a dor) ou de distração (diminui a intensidade), estado emocional (o medo, a apreensão e a ansiedade intensificam a dor) e aspectos culturais e religiosos, entre outros. Assim, o mesmo estímulo doloroso pode ser considerado intenso por um indivíduo e leve por outro ou ainda pelo mesmo indivíduo, quando submetido ao mesmo estímulo em circunstâncias distintas.

Também interessante é o papel do condicionamento na dor. Pavlov demonstrou que, quando o choque e a queimadura eram usados como estímulos condicionantes para a alimentação em cães, esses animais, com o tempo, passavam a responder a esses estímulos sem qualquer manifestação de dor, embora continuassem a reagir adequadamente a outros estímulos dolorosos.

Finalmente, deve-se ressaltar a poderosa influência que o sistema cognitivo-avaliativo exerce sobre os sistemas sensorial-discriminativo e afetivo-motivacional da dor.

Dadas as extensas conexões dos lobos temporal (com a amígdala e o hipocampo) e frontal (com o hipotálamo, tálamo medial/intralaminar e cíngulo) com o sistema límbico, o sistema cognitivo encontra-se em situação ideal para interferir (contribuir ou modificar) nas respostas do sistema afetivo-motivacional. Por outro lado, as eferências frontais para a formação reticular bulbar e mesencefálica (aí se situam importantes centros modulatórios da dor, como o bulbo rostroventral e a PAG) e as eferências do córtex somestésico para o corno dorsal (influência inibitória sobre os neurônios nociceptivos através da via corticoespinal ou piramidal) e certas estruturas subcorticais, de onde se originam as vias extrapiramidais destinadas à medula espinal, influenciam significativamente na transmissão nociceptiva no corno dorsal, afetando, desse modo, o sistema sensorial-discriminativo da dor. Por todos esses motivos, o sistema cognitivo é considerado o centro de controle do processamento doloroso.

Classificação fisiopatológica da dor

A dor pode ser classificada em *nociceptiva*, *neuropática*, *mista* e *psicogênica*.

Dor nociceptiva

Deve-se à ativação dos nociceptores e à transmissão dos impulsos aí gerados pelas vias nociceptivas até as regiões do sistema nervoso central, em que tais impulsos são interpretados. São exemplos de dor nociceptiva a dor secundária a agressões externas (picada de inseto, fratura de um osso, corte da pele), a dor visceral (cólica nefrética, apendicite), a neuralgia do trigêmeo, a dor da artrite e da invasão neoplásica dos ossos (Quadro 6.2).

Dor neuropática

Também é denominada *dor por lesão neural*, *dor por desaferentação* (privação de um neurônio de suas aferências) ou *dor central* (quando secundária às lesões do sistema nervoso central). Decorre de lesão, de qualquer tipo, infligida ao sistema nervoso periférico ou central. Sua etiologia é variada, incluindo afecções traumáticas, inflamatórias, vasculares, infecciosas, neoplásicas, degenerativas, desmielinizantes e iatrogênicas.

Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos não estão claros, mas a lesão do trato neoespinotalâmico (ou neotrigeminotalâmico, para a dor facial) parece ser condição *sine qua non* para o seu surgimento. Outro fato bem definido é que esse tipo de dor é originado dentro do próprio sistema nervoso, independentemente de qualquer estímulo externo ou interno (componente constante). A secção do trato neoespinotalâmico, tão eficaz em eliminar a dor nociceptiva, agrava a dor neuropática (componente constante). Embora várias hipóteses tenham sido propostas na tentativa de explicá-la, este último fato sugere que o mecanismo mais provavelmente envolvido em sua gênese é o da desaferentação.

Quando um neurônio é privado de suas aferências (desaferentação), diversas alterações ocorrem, quais sejam: degeneração dos terminais pré-sinápticos, reinervação do sítio desaferentado por axônios vizinhos (brotamento ou *sprouting*), substituição de sinapses inibitórias por outras excitatórias, ativação de sinapses anteriormente inativas e aumento da eficácia de sinapses antes pouco eficazes. A ocorrência dessas alterações acaba por tornar as células desaferentadas hipersensíveis (células explosivas ou *bursting cells*). A hiperatividade espontânea dessas células, integrantes que são das vias nociceptivas, seria o substrato fisiopatológico para a dor constante (descrita como em queimação ou formigamento) da qual se queixam esses pacientes.

Quadro 6.2
Nociceptores e principais estímulos.

Nociceptores	Estímulos
Tegumentares (pele)	Estímulos mecânicos, térmicos e químicos
Musculares	Estiramento, contração isquêmica
Articulares	Processo inflamatório, movimentos extremos
Vísceras	Processo inflamatório
Esôfago	Distensão e contração
Estômago	Tração, distensão, contração
Intestino delgado	Distensão e contração
Intestino grosso	Contração espasmódica
Bexiga	Contração e distensão
Pâncreas	Isquemia, processo inflamatório
Rins e vias urinárias	Isquemia, distensão e contração
Fígado (cápsula)	Distensão
Pâncreas	Processo inflamatório
Baço (cápsula)	Distensão

Outra hipótese é que o componente constante da dor neuropática se deve à hiperatividade das vias reticulotalâmicas e do tálamo medial. A estimulação elétrica dessas estruturas, em pacientes com dor neuropática, mimetiza a dor referida pelo paciente. Nos pacientes sem esse tipo de dor, a estimulação elétrica das vias reticulotalâmicas e do tálamo medial não produz nenhum efeito. Vilela Filho (1996, 1997) propôs que a hiperatividade do tálamo medial/via reticulotalâmica se deveria à hipoatividade do circuito modulatório prosencéfalo-mesencefálico, secundário à lesão das vias neoespinotalâmica e espinotalâmica anterior, ativadores habituais desse circuito.

O início da dor pode coincidir com a atuação do fator causal, porém, mais comumente, ocorre após dias, semanas, meses ou mesmo anos. A remoção do fator causal em geral não é possível, por não estar mais atuante ou por ser impossível interromper sua atuação.

A maioria dos pacientes apresenta déficit sensorial clinicamente detectável. A distribuição da dor tende a sobrepor-se, pelo menos parcialmente, à da perda sensorial.

A dor neuropática apresenta-se com pelo menos um dos seguintes elementos – constante, intermitente (ambos são espontâneos) e evocado:

Dor constante: está presente em praticamente 100% dos casos, sendo em geral descrita como queimação ou dormência ou formigamento. Trata-se de disestesia (sensação anormal desagradável), normalmente nunca antes experimentada pelo paciente.

O componente constante da dor neuropática, ao contrário da dor nociceptiva, tende a ser agravado pela interrupção cirúrgica das vias da dor, pois tais procedimentos acentuam a desaferentação

Dor intermitente: decorre da ativação das vias nociceptivas pela cicatriz formada no foco lesional ou por efapse (impulsos motores descendentes cruzam para as vias nociceptivas no sítio de lesão do sistema nervoso). A secção cirúrgica completa da via neoespinotalâmica (ou neotrigeminotalâmica, na dor facial) abole essa modalidade de dor

Dor evocada: deve-se aos rearranjos sinápticos decorrentes da desaferentação. A reinervação de células nociceptivas desaferentadas por aferentes táteis, por exemplo, faria com que a estimulação tátil, ao ativar neurônios nociceptivos, produzisse uma sensação dolorosa, desagradável (*alodinia*). A substituição de sinapses inibitórias por outras excitatórias, o aumento da eficácia de sinapses antes pouco efetivas e a ativação de sinapses anteriormente inativas, por outro lado, poderiam tornar tais células hiper-responsivas aos estímulos dolorosos, manifestando-se clinicamente sob a forma de *hiperpatia*. Como a dor evocada depende da estimulação dos receptores e do tráfego dos impulsos pelas vias nociceptivas, ela pode ser também aliviada pela secção cirúrgica da via neoespinotalâmica (ou neotrigeminotalâmica, na dor facial).

São exemplos de dor neuropática: a dor das polineuropatias (a polineuropatia diabética, na qual há acometimento predominante de fibras mielínicas finas e amielínicas, e a alcoólica [compromete indistintamente qualquer tipo de fibra]), a neuralgia pós-herpética (acomete preferencialmente fibras mielínicas grossas do ramo oftálmico do nervo trigêmeo ou dos nervos intercostais, manifestando-se, em geral, como uma mononeuropatia dolorosa), a dor do membro fantasma, a dor por avulsão do plexo braquial, a dor pós-trauma raquimedular e a dor pós-acidente vascular cerebral (“dor talâmica”).

Dor mista

É aquela que decorre dos dois mecanismos anteriores. Ocorre, por exemplo, em certos casos de dor por neoplasia maligna, quando a dor se deve tanto ao excessivo estímulo dos nociceptores quanto à destruição das fibras nociceptivas.

Boxe

Dor psicogênica

Não tem substrato orgânico conhecido e está relacionada a fatores emocionais. A dor tende a ser difusa, generalizada, imprecisa; às vezes, pode ser localizada, e, nesses casos, a topografia da dor tende a corresponder à da imagem corporal que o paciente tem da estrutura que ele julga doente. Assim, se ele imagina ter um “infarto do miocárdio”, a área dolorida corresponde à do mamilo esquerdo, e não à região retroesternal ou à face medial do braço esquerdo. Se a doença imaginada é “cálculo na vesícula”, a área da dor é a do hipocôndrio direito, e não o ombro ou a área escapular direita. Isso se deve ao paciente desconhecer a dor referida em sua imagem corporal. Tanto é que, se ele erroneamente pensar estar o fígado localizado no hipocôndrio esquerdo, ao imaginar-se com uma “doença do fígado”, relatará dor no hipocôndrio esquerdo, e

não no direito.

A dor psicogênica muda de localização sem qualquer razão aparente. Quando irradiada, não segue o trajeto de qualquer nervo. A intensidade da dor é variável, sendo agravada pelas condições emocionais do paciente, o que, em geral, é contestado por ele. Pode ser relatada como muito intensa, excruciante, lancinante, incapacitante. A descrição da dor costuma ser expressa de maneira dramática (“como uma faca introduzida no corpo”, “como tendo a pele arrancada”). Não infreqüentemente é possível estabelecer-se a concomitância de um evento negativo relevante na vida do paciente e o início da dor. Sinais e sintomas de depressão e ansiedade são freqüentemente identificáveis.

Estes pacientes são fortemente fixados em sua dor, trazendo à consulta uma longa lista de medicamentos já usados e de centros de tratamento e especialistas já procurados. Utilização inadequada e abusiva de medicamentos é comumente observada. Se questionados, podem referir inúmeras cirurgias prévias de indicação duvidosa, sugerindo uma hiper-reatividade a desconfortos relativamente leves. Ao exame físico, em geral sem quaisquer achados relevantes, tendem a literalmente pular ao mero toque da região “dolorosa”, por vezes simulando déficit sensorial de distribuição “histérica” (não segue qualquer padrão dermatômico) e fraqueza muscular. Os exames complementares são normais. As avaliações psiquiátrica e psicológica acabam por identificar depressão, ansiedade, hipocondria, histeria ou transtorno somatiforme.

Tipos de dor

Os tipos de dor são os seguintes:

Dor somática superficial: é a modalidade de dor nociceptiva decorrente da estimulação de nociceptores do tegumento. Tende a ser bem localizada e apresentar qualidade bem distinta (picada, pontada, sensação de rasgar, queimor), na dependência do estímulo aplicado. Sua intensidade é variável e, de certa maneira, proporcional à intensidade do estímulo. Decorre em geral de traumatismo, queimadura e processo inflamatório

Dor somática profunda: é a modalidade de dor nociceptiva consequente à ativação de nociceptores dos músculos, fáscias, tendões, ligamentos e articulações. Suas principais causas são: estiramento muscular, contração muscular isquêmica (exercício exaustivo prolongado), contusão, ruptura tendinosa e ligamentar, síndrome miofascial, artrite e artrose. Trata-se de uma dor mais difusa que a somática superficial, de localização imprecisa, sendo em geral descrita como dolorimento (*aching pain*), dor surda, dor profunda e, no caso da contração muscular isquêmica, como câibra. Sua intensidade é proporcional à do estímulo causal, embora em geral seja de intensidade leve a moderada. Às vezes, pode manifestar-se como dor referida

Dor visceral: é a dor nociceptiva decorrente da estimulação dos nociceptores viscerais. Trata-se de uma dor profunda, tendo características similares às da dor somática profunda, ou seja, é difusa, de difícil localização e descrita como um dolorimento ou como uma dor surda, vaga, contínua, profunda, tendendo a acentuar-se com a solicitação funcional do órgão acometido. Tais características se devem às peculiaridades da inervação nociceptiva visceral.

De modo geral, a dor visceral pode ser relacionada com as seguintes condições: comprometimento da própria víscera (dor visceral verdadeira), comprometimento secundário do peritônio ou da pleura parietal (dor somática profunda), irritação do diafragma ou do nervo frênico e reflexo viscerocutâneo (dor referida).

A *dor visceral verdadeira*, embora em geral apresente as características mencionadas anteriormente, tende a se localizar em local próximo ao órgão que a origina. A dor cardíaca, por exemplo, tem localização retroesternal ou precordial; a dor pleural, na parede do hemitórax correspondente; a dor esofágica é retroesternal ou epigástrica; a dor gastroduodenal localiza-se no epigástrico e no hipocôndrio direito; a dor ileojejunal e dos cólons, embora difusa, é predominantemente periumbilical; a dor do sigmoide e do reto é pélvica e perineal; a dor hepática e biliar localiza-se no hipocôndrio direito e epigástrico; a dor esplênica, no hipocôndrio esquerdo; a dor pancreática, no epigástrico, hipocôndrio esquerdo e meio do dorso; a dor renal, nos flancos; a dor ureteral, nos flancos com irradiação para o baixo ventre e genitália; a dor vesical e uretral proximal é pélvica e no baixo ventre; a dor uterina, no baixo ventre, pélvica, perineal e lombar baixa; a dor ovárica é pélvica, perineal, lombar baixa e nas fossas ilíacas.

Pode-se dizer ainda que determinadas modalidades de dor são mais específicas para determinado tipo de víscera. Assim, a dor das vísceras maciças e a dos processos não obstrutivos das vísceras ocas são descritas como dolorida, surda; a dor dos processos obstrutivos das vísceras ocas é do tipo cólica; a dor por comprometimento da pleura parietal (dor somática profunda e não visceral) é em pontada ou fínada; a dor por isquemia miocárdica é constrictiva ou em aperto e a dor por aumento da secreção do ácido clorídrico (úlcera duodenal), do tipo em queimação ou ardor.

Dor referida pode ser definida como sensação dolorosa superficial, distante da estrutura profunda (visceral ou somática)

cuja estimulação nóxica é responsável pela dor. Obedece à distribuição metamérica (Figuras 6.5 e 6.6). A explicação mais aceita para esse fenômeno é a convergência de impulsos dolorosos viscerais e somáticos superficiais e profundos para neurônios nociceptivos comuns localizados no corno dorsal da medula espinal (sobretudo na lâmina V). Tendo o tegumento um suprimento nervoso nociceptivo muito mais exuberante do que o das estruturas profundas somáticas e viscerais, a representação talâmica e cortical dessas estruturas é muito menor do que a tegumentar. Por conseguinte, os impulsos dolorosos provenientes das estruturas profundas seriam interpretados pelo cérebro como oriundos do tegumento, e o paciente aí localizaria a dor.

São exemplos de dor referida: dor na face medial do braço (dermatomo de T1) nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, dor epigástrica ou periumbilical (dermatomos de T6-T10) na apendicite, dor no ombro (dermatomo de C4) nos indivíduos com doença diafragmática ou irritação do nervo frênico.

O apêndice parece não ser sede de dor visceral verdadeira. Na apendicite, a dor inicialmente localiza-se na região epigástrica ou periumbilical (dor referida) e, posteriormente, por irritação do peritônio parietal suprajacente, passa a ser sentida na fossa ilíaca direita (dor somática profunda).

A irritação do diafragma ou do nervo frênico não é incomum nas doenças de órgãos torácicos e do andar superior do abdome. Nessa eventualidade, o paciente apresenta dor referida no ombro (dermatomo de C4), isto porque o nervo frênico, responsável pela inervação do diafragma, origina-se predominantemente do quarto segmento medular cervical. Afecções da vesícula biliar (colecistite, colelitíase), porém, que não têm qualquer relação com o diafragma, podem também cursar com dor referida no ombro. Nesse caso a dor é explicada pela participação do nervo frênico na inervação nociceptiva da vesícula biliar

Dor irradiada: a dor sentida a distância de sua origem, porém obrigatoriamente em estruturas inervadas pela raiz nervosa ou nervo cuja estimulação nóxica é responsável pela dor. Um exemplo clássico é a ciatalgia, provocada pela compressão de uma raiz nervosa por uma hérnia de disco lombar (Figura 6.7)

Dor de origem central: alterações em determinadas regiões encefálicas, tais como área somestésica primária, tálamo ou tronco cerebral, podem induzir a percepção de sensações desagradáveis, dentre elas a dor em diferentes regiões corporais. Este tipo de dor é comum após acidentes vasculares encefálicos.

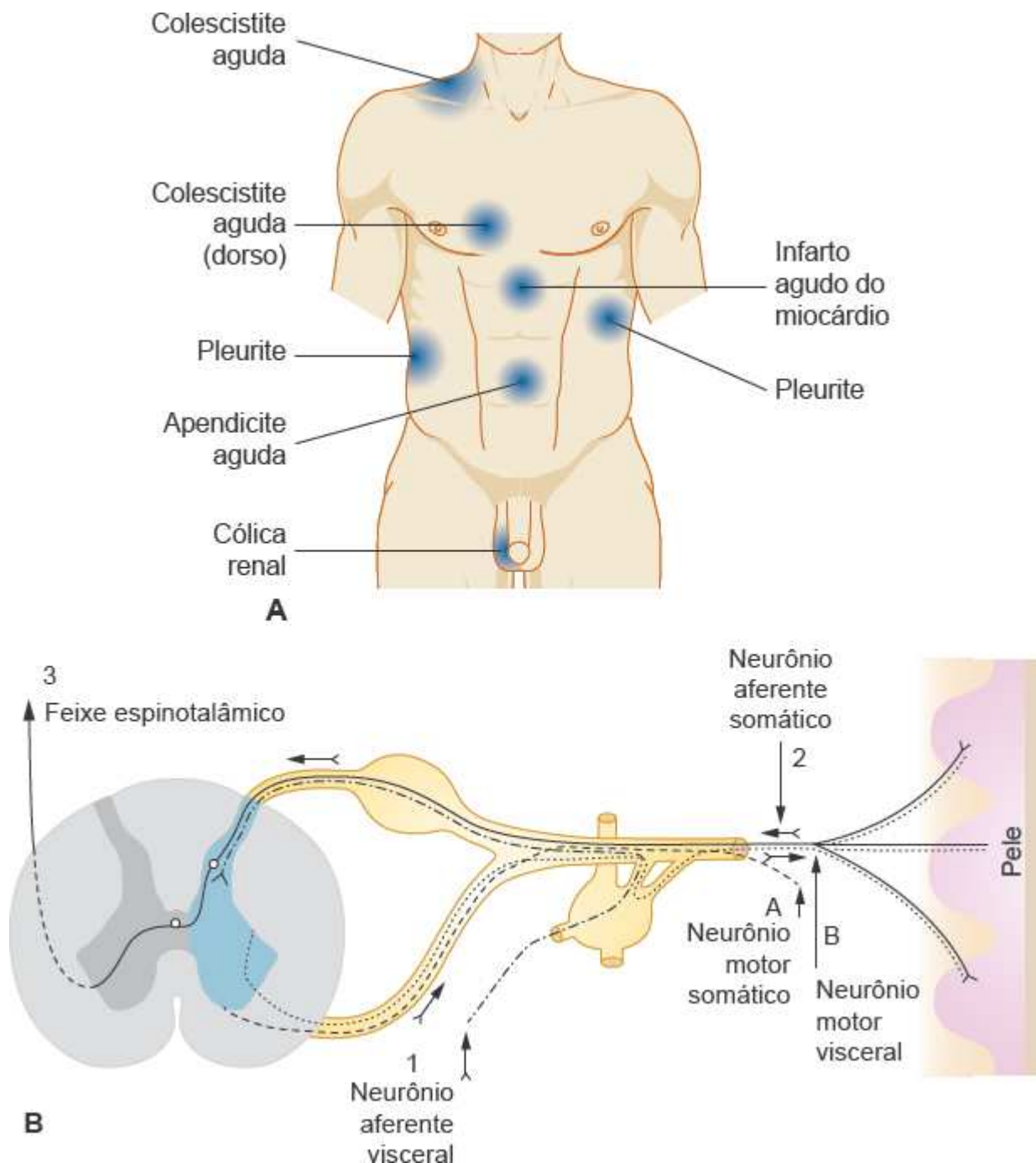


Figura 6.5 Dor referida. **A.** Dor referida de afecções torácicas e abdominais. **B.** O estímulo doloroso procedente de uma víscera é conduzido pelo neurônio aferente visceral (1), penetra na medula juntamente com o neurônio aferente somático (2), que é o responsável pela sensibilidade superficial daquele metâmero. Seja qual for a origem do estímulo – pele ou víscera –, será conduzido aos centros superiores através do feixe espinotalâmico (3). O estímulo doloroso vindo de uma víscera é “percebido” pelo cérebro como se tivesse surgido na área cutânea do metâmero correspondente.

Características da dor nociceptiva

Todos os tipos de dor até agora estudados são modalidades da dor nociceptiva. A dor nociceptiva começa simultaneamente ao início da atividade do fator causal, o qual pode ser em geral identificado. Sua remoção frequentemente culmina com o alívio da dor. Nenhum déficit sensorial é identificado nesses pacientes, e a distribuição da dor corresponde à das fibras nociceptivas estimuladas. Quanto menor o número de segmentos medulares envolvidos na inervação de uma estrutura, mais localizada é a dor (dor somática superficial). Em contrapartida, quanto maior o número de segmentos medulares, mais difusa é a dor (dor visceral e somática profunda).

A dor nociceptiva pode ser espontânea ou evocada:

Dor espontânea: pode ser expressa com as mais variadas designações – pontada, facada, agulhada, aguda, sensação de rasgar, latejante, surda, contínua, profunda, vaga, dolorimento. Todas essas denominações sugerem lesão tissular

Dor evocada: pode ser desencadeada por algumas manobras, tais como: manobra de Lasègue na cialalgia (dor provocada pelo estiramento da raiz nervosa, obtida pela elevação do membro inferior afetado, estando o indivíduo em decúbito dorsal); lavar o rosto e escovar os dentes, nos pacientes com neuralgia do trigêmeo. A dor evocada reproduz a dor sentida pelo paciente.

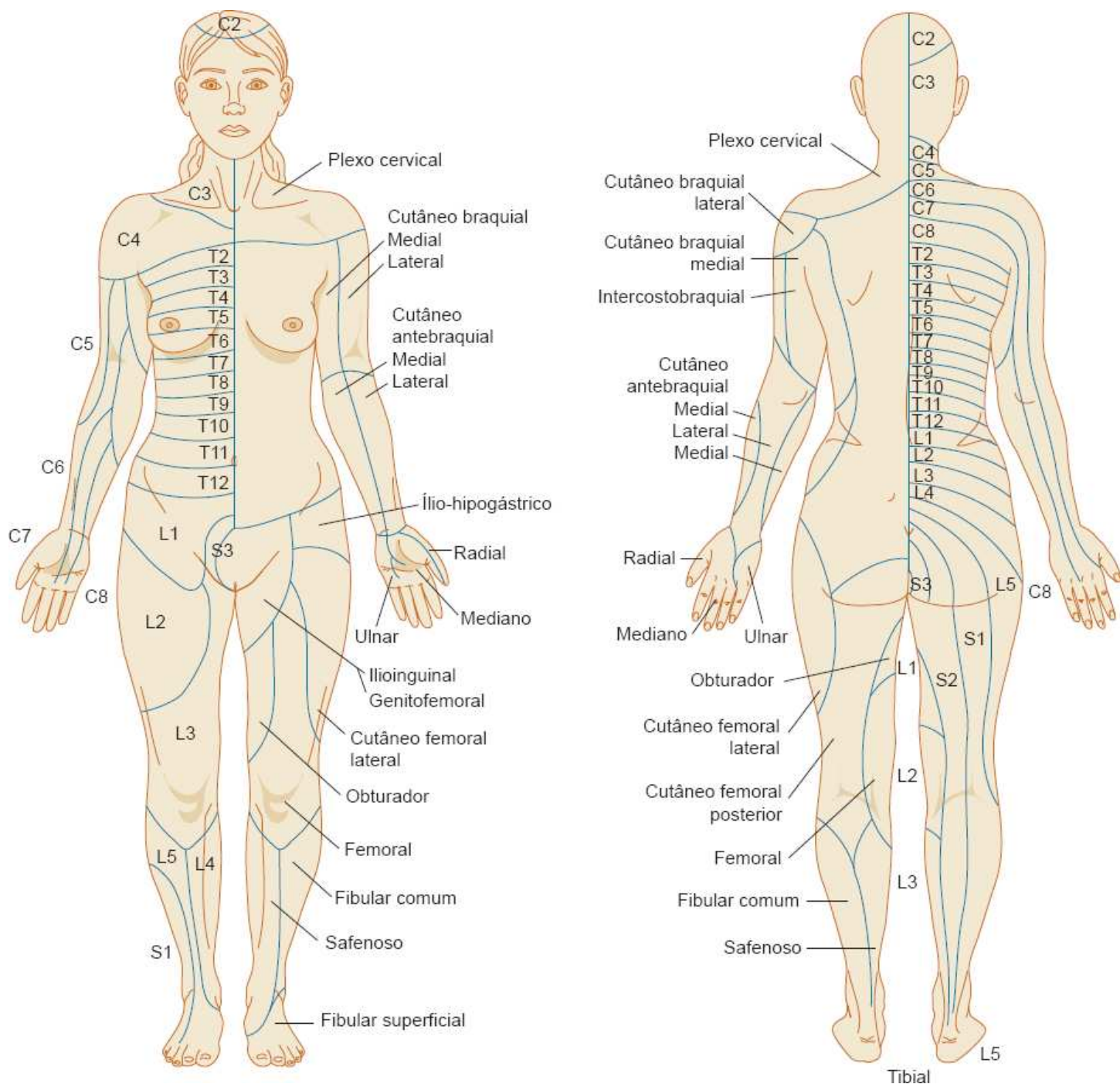


Figura 6.6 Mapa dermatomérico.

Características semiológicas da dor

Todo paciente deve ser sistematicamente avaliado, levando-se em consideração as características semiológicas da dor: localização, irradiação, qualidade ou caráter, intensidade, duração, evolução, relação com funções orgânicas, fatores desencadeantes ou agravantes, fatores atenuantes e manifestações concomitantes.

Localização

Refere-se à região em que o paciente sente a dor. Descrições como “dor na vesícula” carecem de valor semiótico, pois dependem da imagem corporal que o paciente tem, a qual pode ser completamente equivocada. Deve-se solicitar ao paciente que aponte com um dedo a área em que sente a dor, área essa que deve ser anotada utilizando-se a nomenclatura das regiões da

superfície corporal (ver Capítulo 3, *Método Clínico*). Isso pode ser feito em uma folha de papel com o mapa corporal, que deve ser anexada à folha de anamnese.

Caso o paciente refira dor em mais de uma localização, é importante que todas as localizações sejam devidamente registradas no mapa corporal, devendo ser estudadas semiologicamente em separado, a menos que se trate de dor irradiada ou de dor referida, que devem ser avaliadas no contexto da dor original. Diferentes dores, sem relação entre si, podem indicar doença única (exemplo: dor em múltiplas articulações, como nas afecções reumáticas), processos patológicos independentes ou dor psicogênica.

Também é relevante a avaliação da sensibilidade na área de distribuição da dor e adjacências. A presença de hipoestesia é evocativa de dor neuropática, sobretudo se houver um componente descrito como em queimação ou formigamento. Por vezes, porém, a sensibilidade parece estar aumentada. Tal aumento pode indicar hiperestesia (hipersensibilidade aos estímulos táteis) e hiperalgesia (hipersensibilidade aos estímulos álgicos), que ocorrem em uma área sem comprometimento da inervação sensorial, ou alodinia e hiperpatia. Alodinia e hiperpatia ocorrem em uma área de hipoestesia e são excelentes indicadores da dor neuropática. Seu encontro é particularmente útil naqueles casos em que o déficit sensorial é subclínico, quando o diagnóstico de dor neuropática é mais difícil de ser firmado. Naturalmente que uma história adequada concernente à etiologia da dor (lesão do sistema nervoso) facilita o diagnóstico.

Pelo exposto se conclui que a localização da dor é de extrema importância para a determinação de sua etiologia. Vale a pena lembrar que a dor somática superficial tende a ser mais localizada, enquanto a dor somática profunda e a dor visceral, bem como a dor neuropática, tendem a ser mais difusas (Quadro 6.3).

Irradiação

A dor pode ser localizada, ou seja, sem irradiação, irradiada (segue o trajeto de uma raiz nervosa ou nervo conhecido) ou referida:

Dor irradiada: pode surgir em decorrência do comprometimento de praticamente qualquer raiz nervosa, podendo ser o território de irradiação predito pelo exame do mapa dermatomérico (Figura 6.6).

O reconhecimento da localização inicial da dor e de sua irradiação pode indicar a estrutura nervosa comprometida. Assim:

- *Radiculopatia de S1* (lombociatalgia): dor lombar com irradiação para a nádega e face posterior da coxa e perna, até a região do calcanhar
- *Radiculopatia de L5* (lombociatalgia): dor lombar com irradiação para a nádega e face posterolateral da coxa e perna, até a região maleolar lateral (Figura 6.7)
- *Radiculopatia de L4* (lombociatalgia): dor lombar com irradiação para a virilha, face anterior da coxa e borda anterior da canela (também face medial da perna), até a região maleolar medial (Figura 6.7)
- *Radiculopatia de L1*: dor dorsal na transição toracolombar, com irradiação anterior e inferior para a virilha
- *Radiculopatia de T4*: dor dorsal com irradiação anterior, passando pela escápula, para a área mamilar
- *Radiculopatia de C6* (cervicobraquialgia): dor cervical com irradiação para a face lateral do braço e antebraço
- *Neuralgia occipital* (radiculopatia de C2 e/ou C3): dor na transição occipitocervical, com irradiação superior, anterior e lateral, podendo atingir vértex, globos oculares, ouvidos e, às vezes, até a face

Dor referida: não é o mesmo que dor irradiada. As causas e a fisiopatologia são diferentes (Figura 6.5). Exemplos:

- *Apêndice*: dor na região epigástrica
- *Vesícula, fígado*: dor na escápula e no ombro
- *Ureter*: dor na virilha e genitália externa
- *Coração*: dor na face medial do braço.

Quadro 6.3 Localização mais frequente da dor visceral verdadeira.	
Vísceras	Localização
Coração	Retroesternal e precordial
Pleura	Parede do hemitórax correspondente

Esôfago	Retroesternal e região epigástrica
Estômago e duodeno	Região epigástrica e hipocôndrio direito
Íleo, jejuno e cólons	Periumbilical e difusa no abdome
Sigmoide e reto	Região pélvica e períneo
Fígado e vias biliares	Hipocôndrio direito e região epigástrica
Baço	Hipocôndrio esquerdo
Pâncreas	Região epigástrica, hipocôndrio esquerdo e dorso
Rins	Flancos
Ureter	Flancos e genitália
Bexiga e uretra	Região pélvica e região hipogástrica
Útero	Região hipogástrica, região pélvica, períneo e região lombar
Ovários	Região pélvica, períneo, fossas ilíacas e região lombar

Boxe

Irradiação da dor e processos patológicos anteriores

Processos patológicos anteriores ou concomitantes, afetando estruturas inervadas por segmentos medulares adjacentes, aumentam a tendência para que a dor seja sentida em uma área servida por ambos os segmentos medulares, resultando em localização atípica da dor. Assim, a dor da insuficiência coronariana (angina do peito e infarto do miocárdio) pode irradiar-se para o epigástrio, em pacientes portadores de úlcera duodenal, e para o membro superior direito, em indivíduos com fratura recente desta região.

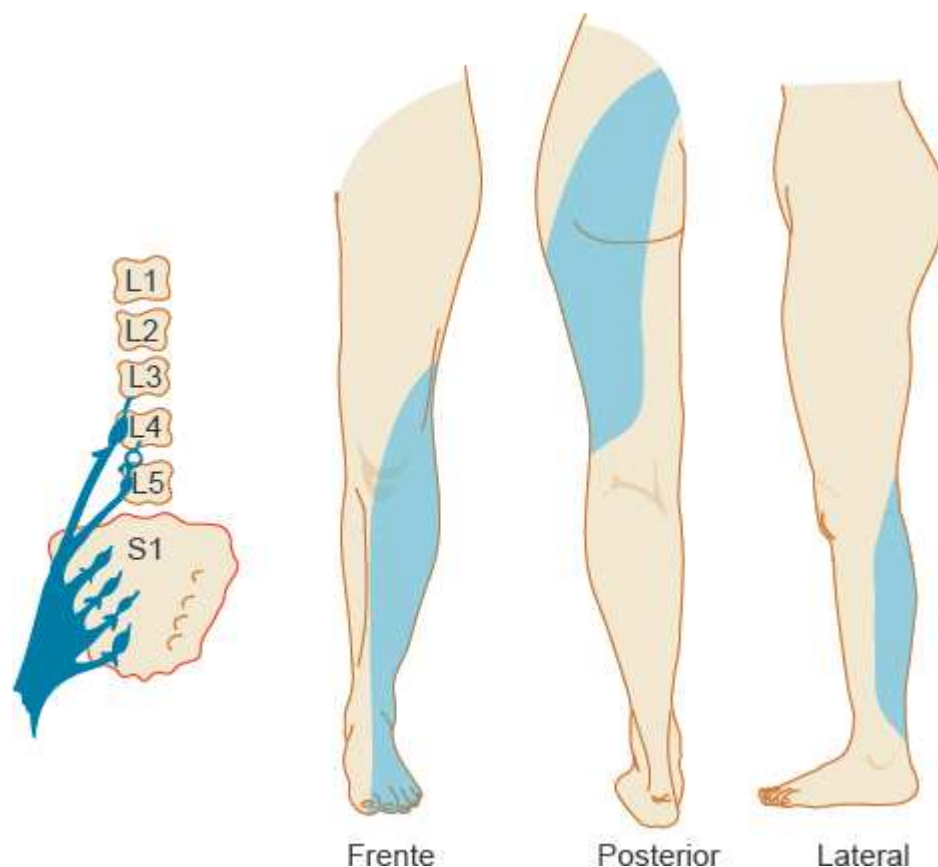


Figura 6.7 Dor irradiada. Dor irradiada em paciente com hérnia discal entre L4 e L5 (lombociatalgia) comprimindo a raiz de L5. A dor é irradiada para a nádega, face posterolateral da coxa e posterolateral da perna.

Qualidade ou caráter

Para se definir a qualidade ou caráter da dor, o paciente é solicitado a descrever como a sua dor se parece ou que tipo de sensação e emoção ela lhe traz. Vários termos são utilizados para descrever a qualidade da dor. Tal variabilidade pode indicar diferentes processos fisiopatológicos subjacentes ou apenas características socioculturais. Não é raro o paciente experimentar extrema dificuldade em qualificar sua dor. Nessa eventualidade, deve-se oferecer-lhe uma relação de termos “descritores” mais comumente usados e pedir-lhe que escolha aquele ou aqueles que melhor caracterizam sua dor.

O primeiro passo é definir se a dor é evocada e/ou espontânea (constante ou intermitente):

Dor evocada: é aquela que só ocorre mediante alguma provocação. São exemplos a alodinia e a hiperpatia, presentes na dor neuropática, e a hiperalgesia primária e secundária, presentes na dor nociceptiva

- *Alodinia:* sensação desagradável, dolorosa, provocada pela estimulação tátil, sobretudo se repetitiva, de uma área com limiar de excitabilidade aumentado (área parcialmente desferentada, hipoestésica). Muitas vezes os pacientes relatam que “o mero contato da roupa ou do lençol é extremamente doloroso”
- *Hiperpatia:* sensação desagradável, mais dolorosa que o usual, provocada pela estimulação nóxica, sobretudo se repetitiva, de uma área com limiar de excitabilidade aumentado (área parcialmente desferentada, hipoestésica)
- *Hiperalgesia:* resposta exagerada aos estímulos aplicados em uma região que se apresenta com limiar de excitabilidade reduzido, podendo manifestar-se sob a forma de dor a estímulos inócuos ou de dor intensa a estímulos leves ou moderadamente nóxicos. Dois tipos de hiperalgesia têm sido descritos:
 - Hiperalgesia primária: é a que ocorre em uma área lesionada e se deve à sensibilização local dos nociceptores
 - Hiperalgesia secundária: é aquela que ocorre ao redor da área lesionada e parece ser secundária à sensibilização dos neurônios do corno dorsal decorrente da estimulação repetitiva e prolongada das fibras C

Dor espontânea: pode ser constante ou intermitente

- *Dor constante:* é aquela que ocorre continuamente, podendo sua intensidade variar, mas sem nunca desaparecer completamente. O indivíduo dorme e acorda com a dor. Na dor neuropática, a dor constante é mais comumente descrita como em queimação ou dormência, formigamento (disestesia). Na dor nociceptiva, diversos termos são utilizados para qualificá-la (ver *Tipos de dor*, neste capítulo)
- *Dor intermitente:* é aquela que ocorre episodicamente, sendo sua frequência e duração bastante variáveis. É, em geral,

descrita como dor em choque, aguda, pontada, facada, fisgada. Deve ser diferenciada das exacerbações da dor constante.

Boxe

Relação entre a qualidade da dor e a causa

A qualidade da dor ajuda a definir o processo patológico subjacente. Assim: dor latejante ou pulsátil ocorre na enxaqueca, abscesso e odontalgia; dor em choque, na neuralgia do trigêmeo, na lombociatalgia, na cervicobraquialgia e na dor neuropática (componente intermitente); dor em cólica ou em torcedura, na cólica nefrética, biliar, intestinal ou menstrual; dor em queimação, se visceral, na úlcera péptica e esofagite de refluxo e, se superficial, na dor neuropática (componente constante); dor constritiva ou em aperto, na angina de peito e infarto do miocárdio; dor em pontada, nos processos pleurais; dor surda, nas doenças de vísceras maciças; dor “doída” ou dolorimento, nas doenças musculares, como a lombalgia, e das vísceras maciças; e dor em câibra, em afecções medulares, musculares e metabólicas.

Boxe

Tipos especiais de dor

Dor fantasma. Alguns indivíduos, após terem parte de seu corpo amputada, têm a sensação de que ela ainda está integrada a seu corpo (sensação fantasma) e que pode ser fonte de profunda dor. A *dor fantasma* ocorre mais comumente após amputação de um membro, embora possa também ocorrer após a enucleação do globo ocular, remoção da mama (mastectomia) ou amputação do pênis. É um tipo de dor neuropática, sendo a secção dos nervos mistos e sensoriais, no ato da amputação, sua causa. Não é raro que tais pacientes apresentem também a chamada *dor do coto*, a qual parece decorrer da hiperexcitabilidade do neuroma formado na extremidade proximal do nervo seccionado. A dor do coto de amputação e a dor fantasma são de difícil tratamento, sendo, atualmente, rebeldes a qualquer tipo de abordagem farmacológica ou cirúrgica disponíveis.

Síndrome complexa de dor regional (SCDR). É caracterizada pela presença de dor associada a alterações vasomotoras, sudomotoras e tróficas. A dor tende a ser excruciante e conta com três componentes: dor constante em queimação ou disestésica, dor intermitente fugaz em choque, provocada por praticamente qualquer movimento, e dor evocada, caracterizada por alodinia e hiperpatia. A dor é tão intensa que o paciente assume uma postura de constante defesa do segmento corporal afetado.

A unha torna-se grande, porque o paciente, em razão da dor, é incapaz de cortá-la. A pele torna-se fina, lisa e brilhante. A temperatura cutânea geralmente aumenta, embora possa diminuir. Há, em geral, aumento local da sudorese (hiperidrose) e variação da coloração da extremidade acometida (pálida, hiperemiada ou arroxeada). As articulações tornam-se rígidas e osteoporose se desenvolve. A síndrome complexa de dor regional pode ser classificada em dois tipos: SCDR-I, quando não há lesão demonstrável de nervo periférico, e SCDR-II, quando há lesão nervosa.

O substrato fisiopatológico subjacente parece ser a hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático.

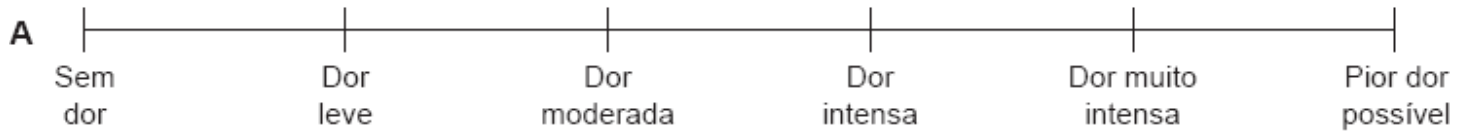
Tal síndrome recebeu, outrora, várias designações, incluindo *distrofia simpática reflexa* (hoje denominada SCDR-I), causalgia (atualmente designada SCDR-II), *dor mantida pelo simpático* e *atrofia de Sudeck*, entre outras.

Intensidade

É um componente extremamente relevante da dor, aliás, o de maior importância para o paciente. Resulta da interpretação global dos seus aspectos sensoriais, emocionais e culturais.

As escalas com expressões verbais como *ausência de dor*, *dor leve*, *dor moderada*, *dor intensa* e *dor insuportável* (*pior dor possível*) são simples, práticas e de amplo uso, mas apresentam a desvantagem de serem muito subjetivas e de conterem poucas opções, o que pode comprometer sua sensibilidade como instrumento de avaliação durante a evolução da doença (Figura 6.8A).

Escala descritiva simples de intensidade da dor



Escala analógica visual de 0 a 10 de intensidade da dor



Escala facial de intensidade da dor



Figura 6.8 Escalas para avaliar a intensidade de dor. Escala descritiva simples de intensidade da dor (**A**), escala analógica de 0 a 10 de intensidade da dor (**B**), escala facial de intensidade da dor (**C**).

Atualmente, prefere-se, para o adulto, a utilização de uma *escala analógica visual para avaliar a intensidade da dor*, a qual consiste em uma linha reta com um comprimento de 10 centímetros, tendo em seus extremos inferior e superior as designações *sem dor* ou *ausência de dor* e *pior dor possível*. O paciente é solicitado a indicar a intensidade de sua dor ao longo dessa linha. O resultado é descrito pelo examinador como intensidade “x” em uma escala de zero a dez (Figura 6.8B).

Para as crianças, idosos e adultos de baixo nível cultural, para os quais a compreensão da escala analógica visual pode ser difícil, podem-se utilizar as *escalas de representação gráfica não numérica*, como a de expressões faciais de intensidade da dor (Figura 6.8C).

Se o paciente tem dificuldade em definir “pior dor possível ou imaginável”, sugerimos que ele a compare com a dor mais intensa por ele já experimentada. A dor do parto, a da cólica nefrética e a de uma úlcera perfurada (no momento da perfuração) são bons exemplos para esse fim.

A determinação do grau (leve, moderado ou intenso) de interferência da dor com relação ao sono, trabalho, relacionamento conjugal e familiar e atividades sexuais, sociais e recreativas fornece pistas indiretas, porém, de certa maneira, objetivas, da intensidade da dor.

A Organização Mundial da Saúde propôs uma “escala de intensidade” em três degraus, correspondendo a dor leve, moderada e intensa, para auxiliar na escolha do analgésico mais adequado.

Duração

Inicialmente, determina-se com a máxima precisão possível a data de início da dor. Em se tratando de uma dor contínua, a duração da dor é o tempo transcorrido entre seu início e o momento da anamnese. No caso de uma dor cíclica, interessa registrar a data e a duração de cada episódio doloroso. Se a dor é intermitente e ocorre várias vezes ao dia, é suficiente que se registre a data de seu início, a duração média dos episódios dolorosos, o número médio de crises por dia e o número médio de dias por mês em que a dor se apresenta.

Dependendo de sua duração, a dor pode ser classificada em *aguda* e *crônica*:

Dor aguda: é uma importantíssima modalidade sensorial, desempenhando, entre outros papéis, o de alerta, comunicando ao

cérebro que algo está errado. Acompanha-se de manifestações neurovegetativas e desaparece com a remoção do fator causal e resolução do processo patológico

Dor crônica: é a que persiste por um período superior àquele necessário para a cura de um processo mórbido (em geral 4 a 6 semanas) ou aquela associada a afecções crônicas (câncer, artrite reumatoide, alterações degenerativas da coluna) ou, ainda, a que decorre de lesão do sistema nervoso. A dor crônica sem papel fisiológico ou de alerta passa a ser um estado mórbido por si só. Sua avaliação, portanto, não pode ficar restrita às características semiológicas da dor, devendo incluir a avaliação do paciente como um todo. É a maior causa de afastamento do trabalho, ocasionando um enorme ônus para o país.

Evolução

Esta característica semiológica revela a trajetória da dor, desde o seu início até o momento da anamnese e, a partir daí, ao longo do acompanhamento do paciente.

Iniciamos sua investigação pelo modo de instalação da dor: se súbito ou insidioso. Dor súbita, em cólica, no hipocôndrio direito, por exemplo, é sugestiva de colelitíase, ao passo que uma dor de início insidioso, surda, na mesma localização, traduz mais provavelmente colecistite ou hepatopatia.

É também relevante definir a concomitância da atuação do fator causal e o início da dor. A dor neuropática pode iniciar-se semanas, meses ou mesmo anos após a atuação do fator causal em mais da metade dos casos. Já o início da dor nociceptiva é sempre simultâneo ao da atuação do fator causal.

Durante sua evolução, a dor pode sofrer as mais variadas modificações. Pacientes com enxaqueca ou cefaleia tensional, em razão do uso abusivo e inadequado de analgésicos, podem evoluir para um diferente tipo de cefaleia, designado cefaleia crônica, cujo tratamento é muito mais difícil. Indivíduos com síndrome complexa de dor regional tipo II (causalgia) provocada por lesão traumática do nervo mediano direito, por exemplo, que inicialmente apresentam dor restrita ao território desaferentado, podem, ao longo dos meses e anos, apresentar também dor no tronco e em outras extremidades.

O não reconhecimento da forma inicial de apresentação da dor (caso o paciente só seja visto tardiamente) torna o diagnóstico extremamente difícil.

Nos pacientes com dor neuropática, os seus componentes (dor constante, intermitente e evocada) frequentemente surgem em épocas diferentes. Assim, um paciente que tinha apenas dor constante, em queimação, bem controlada farmacologicamente, pode voltar a apresentar dor, não pela perda do controle da dor constante (embora isso também possa ocorrer), mas pelo aparecimento de dor intermitente ou evocada.

A dor nociceptiva pode também mudar suas características. Tal é o caso do paciente portador de úlcera péptica, com dor epigástrica em queimação, que, subitamente, passa a apresentar uma dor aguda, intensa, na região epigástrica, a qual, horas após, espalha-se para todo o abdome, caracterizando o quadro típico de uma úlcera perfurada, enquanto a difusão da dor pelo abdome é indicativa da peritonite química decorrente do extravasamento do suco digestivo e consequente irritação peritoneal. Outro exemplo é o de uma paciente, com história prévia de doença biliar, com dor crônica surda no hipocôndrio direito, que passa, subitamente, a apresentar dor intensa, em barra, no andar superior do abdome, associada a vômitos repetitivos, ou de um paciente, com história de etilismo crônico, que passa a apresentar dor súbita como a anteriormente descrita; em ambos os casos, o diagnóstico mais provável é o de pancreatite aguda (doença biliar e etilismo são as causas mais frequentes de pancreatite aguda nos sexos feminino e masculino, respectivamente).

A intensidade da dor pode também variar em sua evolução. Redução progressiva de sua intensidade, sem qualquer alteração na terapêutica, pode sugerir que o quadro doloroso está entrando em remissão, como acontece frequentemente com a dor aguda e em determinados casos de dor crônica. Intensidade inalterada ou progressiva acentuação ao longo dos meses, a despeito de terapêutica adequada, por outro lado, pode sugerir que a dor tenha se tornado crônica.

A dor crônica, em sua evolução, pode também mostrar *ritmicidade* (surtos em relação às ocorrências em um mesmo dia) e *periodicidade* (surtos periódicos ao longo dos meses e anos). A dor da úlcera péptica duodenal, por exemplo, pode adquirir um ritmo próprio ao longo do dia: *dói – come – passa – dói* (a ingestão de alimento “tampona” o ácido clorídrico). A cefaleia em salvas, por outro lado, apresenta uma periodicidade que lhe é peculiar: crises com duração de 15 a 180 min, variando de 1 crise a cada 2 dias até 8 crises por dia, por períodos de 6 a 12 semanas, após o que entra em remissão por cerca de 12 meses.

Além de todas essas alterações evolutivas, a dor pode mudar seu padrão em função do tratamento instituído. Tal é o caso do paciente com dor nociceptiva em um membro inferior ocasionada pela invasão óssea por câncer submetido a cordotomia anterolateral (secção do trato neoespinotalâmico na medula espinal) para alívio da dor; embora a dor inicial possa ser totalmente eliminada, meses após pode surgir um novo tipo de dor (dor neuropática), decorrente da desaferentação provocada pela cirurgia.

Como se pode notar, a mudança das características clínicas de uma dor pode indicar apenas uma alteração evolutiva (p. ex., ampliação da área da dor na causalgia), complicação da mesma enfermidade (p. ex., perfuração da úlcera) ou uma afecção distinta (p. ex., pancreatite aguda na paciente com doença biliar prévia).

Relação com funções orgânicas

A relação da dor com as funções orgânicas é avaliada considerando-se, em primeiro lugar, a localização da dor e os órgãos e estruturas situados na mesma região. Assim, se a dor for cervical, dorsal ou lombar, pesquisa-se sua relação com os movimentos da coluna vertebral (flexão, extensão, rotação e inclinação); se for torácica, com a respiração, movimentos do tórax, tosse, espirro e esforços físicos; se tiver localização retroesternal, com a deglutição, posição e esforços físicos; se for periumbilical ou epigástrica, com a ingestão de alimentos; se no hipocôndrio direito, com a ingestão de alimentos gordurosos; se no baixo ventre, com a micção, evacuação, ovulação e menstruação; se articular ou muscular, com a movimentação daquela articulação ou músculo; se nos membros inferiores, com a deambulação, e assim por diante (Quadro 6.4).

Como regra geral, pode-se dizer que a dor é exacerbada pela solicitação funcional da estrutura em que se origina. Assim, a dor da insuficiência arterial mesentérica (dor surda periumbilical) é intensificada pela alimentação, ao provocar aumento do peristaltismo intestinal. A dor da colecistite (dor surda no hipocôndrio direito) é exacerbada por substâncias que estimulam a liberação de colecistoquinina (produz contração da vesícula e relaxamento do esfíncter de Oddi, permitindo que a bile, tão importante para a digestão dos lipídios, seja lançada no tubo digestivo) pela mucosa intestinal (alimentos gordurosos). A dor em uma articulação ou músculo é acentuada pela movimentação daquela articulação ou contração do músculo. A dor retroesternal acentuada pela deglutição, pelo decúbito dorsal horizontal ou pela flexão do tronco (essas duas posturas favorecem o refluxo de suco gástrico para o esôfago em indivíduos com esfíncter cárdico hipoativo, como na hérnia hiatal) é sugestiva de esofagite de refluxo, ao passo que a dor retroesternal acentuada pelo esforço físico é mais indicativa de doença arterial coronariana (o exercício determina um aumento do trabalho do miocárdio e, quando seu suprimento arterial está comprometido, ocorre isquemia, advindo a dor).

Quadro 6.4 Relação da dor com funções orgânicas.	
Localização	Funções orgânicas
Pescoço, dorso e região lombar	Movimentos da coluna vertebral (flexão, extensão, rotação, inclinação)
Tórax	Movimentos do tórax, movimentos respiratórios, tosse, espirro, realização de esforço físico
Retroesternal	Deglutição, posição do tórax, esforço físico
Região epigástrica ou periumbilical	Ingestão de alimentos
Hipocôndrio direito	Ingestão de alimentos gordurosos
Baixo ventre (região hipogástrica e fossas ilíacas)	Evacuação, micção, menstruação, ovulação
Articulações e músculos	Movimentação da articulação ou músculos
Membros inferiores	Deambulação

Fatores desencadeantes ou agravantes

São aqueles fatores que desencadeiam a dor, em sua ausência, ou que a agravam, se estiver presente. As funções orgânicas estão entre eles. Muitos outros fatores, porém, podem ser determinados. Devemos procurá-los ativamente, pois, além de nos ajudarem a esclarecer a enfermidade subjacente, seu afastamento constitui parte importante da terapêutica a ser instituída. São exemplos: os alimentos ácidos e picantes, bebidas alcoólicas e anti-inflamatórios hormonais ou não hormonais, na esofagite, gastrite e

úlcera péptica; alimentos gordurosos, na doença biliar; chocolate, queijos, bebida alcoólica (sobretudo o vinho), barulho, luminosidade excessiva, esforço físico e menstruação, em um significativo número de enxaquecosos; decúbito dorsal prolongado, tosse e espirro (todos esses fatores determinam elevação da pressão intracraniana), na cefaleia por hipertensão intracraniana (tumor cerebral, hematoma intracraniano); flexão da nuca (estira a meninge inflamada), na meningite e hemorragia subaracnóidea; qualquer movimento que estire a raiz nervosa (elevação do membro inferior estendido, flexão do tronco) ou que aumente a pressão intrarraquidiana (tosse, espirro), na hérnia distal lombossacra; lavar o rosto, escovar os dentes, conversar, mastigar ou deglutir (essas atividades estimulam as terminações nervosas trigeminais), no paciente com neuralgia do trigêmeo; qualquer fator que determine aumento da pressão intra-abdominal, nas doenças de vísceras abdominais; deambulação, na estenose do canal lombar e na insuficiência arterial dos membros inferiores; esforço físico, na coronariopatia, dores musculares, articulares e da coluna; estresse, barulho, vibrações, mudanças climáticas, água fria e atividade física (nesse caso, a dor acentua-se algum tempo e não imediatamente após a atividade física), na dor neuropática; emoção e estresse, em qualquer tipo de dor.

Fatores atenuantes

São aqueles que aliviam a dor. Entre eles encontram-se algumas funções orgânicas, posturas ou atitudes que resguardecem a estrutura ou órgão em que se origina a dor (atitudes antálgicas), distração, ambientes apropriados, medicamentos (analgésicos opioides e não opioides, anti-inflamatórios hormonais e não hormonais, relaxantes musculares, antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos, anestésicos locais), fisioterapia, acupuntura, bloqueios anestésicos e procedimentos cirúrgicos. No caso dos medicamentos, devem-se anotar os seus nomes, as doses e por quanto tempo foram usados.

A distração tende a produzir algum alívio de qualquer dor. Os enxaquecosos procuram locais escuros e sem barulho para alívio. A enxaqueca é também comumente aliviada pelo sono. A ingestão de alimentos é adequada para as dores provocadas pela diminuição do pH (esofagite, gastrite e úlcera péptica). A dor do aparelho digestivo tende a intensificar-se com a atividade peristáltica; por isso, ela é minorada com o jejum ou com o esvaziamento do estômago (vômito). O repouso melhora a dor muscular, articular e da isquemia miocárdica. A distensão das vísceras abdominais maciças (distensão da cápsula hepática, esplênica e renal, da serosa pancreática e bacinete renal) ou ocas é causa de dor, a qual é acentuada pelo aumento da pressão intra-abdominal. Assim, os pacientes tendem a assumir posturas que reduzam a pressão sobre o órgão lesionado e que diminuam a pressão intra-abdominal: na colecistite, flete o tronco e sustenta o hipocôndrio direito com a mão; na nefropatia, o paciente fixa o tronco e inclina-se para o lado oposto àquele afetado; na dor pancreática, o doente senta-se ou deita-se com as coxas e pernas fletidas, de modo a encostar os joelhos no peito. Os pacientes com causalgia (SCDR-II), dada a pronunciada alodinia, assumem uma postura de extremo zelo para com o segmento afetado: tornam-se praticamente reclusos, na tentativa de evitar qualquer estímulo sensorial, causa de dor excruciante; mantêm o membro comprometido imóvel, só com muita dificuldade permitindo o seu exame. Na lombociatalgia, para evitar o estiramento da raiz nervosa (causa de dor), o doente mantém o membro comprometido em atitude antálgica de semiflexão; ao deambular, mantém essa atitude e inclina o tronco para a frente, configurando o ato de saudar (marcha saudatória).

A dor nociceptiva costuma ser responsiva aos anti-inflamatórios, analgésicos opioides e não opioides, acupuntura, fisioterapia, bloqueios anestésicos proximais à região dolorosa, à interrupção cirúrgica da via neoespinotalâmica (ou neotrigeminotalâmica, na dor facial) e a determinados procedimentos ditos modulatórios, como a estimulação elétrica crônica de PVG-PAG (substância cinzenta periventricular e periaquedutal) e à administração intrarraquidiana de opioides.

Tanto o componente intermitente como o evocado da dor neuropática respondem às mesmas estratégias adotadas para a dor nociceptiva. A dor intermitente, adicionalmente, responde aos anticonvulsivantes e, aparentemente, aos anestésicos locais (mexiletina).

O componente constante da dor neuropática, excetuando-se os bloqueios anestésicos proximais, costuma ser resistente às demais terapêuticas mencionadas, podendo, inclusive, ser agravado pela interrupção cirúrgica da via neoespinotalâmica ou neotrigeminotalâmica. É, por outro lado, responsivo aos antidepressivos tricíclicos, neurolépticos (quando associados aos antidepressivos), anestésicos locais (em alguns casos, como na polineuropatia diabética), à destruição cirúrgica das vias reticulotalâmicas (tratotomia mesencefálica medial e talamotomia medial) e a uma série de procedimentos modulatórios, como a estimulação crônica da medula espinal, lemnisco medial, tálamo (VPL e VPM), cápsula interna e córtex motor.

Manifestações concomitantes

A dor aguda, nociceptiva, sobretudo quando intensa, costuma acompanhar-se de manifestações neurovegetativas, que se devem à estimulação do sistema nervoso autônomo pelos impulsos dolorosos, incluindo sudorese, palidez, taquicardia, hipertensão arterial, mal-estar, náuseas e vômitos. Tais características não têm qualquer valor para o diagnóstico etiológico da dor. Por outro lado, várias outras manifestações clínicas associadas à dor e relacionadas com a enfermidade de base são de grande valia para o

diagnóstico, ainda mais quando outros dados como sexo, idade, doenças prévias e hábitos de vida são considerados. Assim, a cefaleia em salvas é mais frequente em homens e associada a lacrimejamento, rinorreia ou obstrução nasal, hiperemia conjuntival, sudorese na face e ptose palpebral parcial; a enxaqueca com aura precedida por escotomas, e acompanhada por disacusia (intolerância ao barulho), fotofobia (intolerância à luminosidade excessiva), náuseas e vômitos é mais frequente em mulheres; a cefaleia da hipertensão intracraniana acentua-se com o decúbito e acompanha-se de vômitos em jato, náuseas e diplopia; a cólica nefrética associa-se a disúria, polaciúria e hematúria; a odinofagia acompanha-se de disfagia; dor torácica em adulto, do sexo masculino, tabagista, se associada a esforço, sugere insuficiência coronária e, se acompanhada de tosse e hemoptise, câncer pulmonar. Tomando como base esses exemplos, pode-se averiguar a importância da determinação das manifestações concomitantes, as quais devem ser bem definidas durante a anamnese.

Boxe

Dor e envelhecimento

Com o envelhecimento, o limiar de dor aumenta e, conseqüentemente, os pacientes idosos podem apresentar problemas graves sem que a dor seja um sinal de alarme. Um exemplo clássico é a grande frequência de infarto do miocárdio e doenças abdominais agudas sem dor.

Poderíamos supor que eles se queixam muito mais de dor do que os pacientes mais jovens, sendo, inclusive, rotulados de poliqueixosos e hipocondríacos, porque o envelhecimento está relacionado com a presença de múltiplas afecções crônicas que se manifestam principalmente por dor, tais como insuficiência coronária, osteoartrose, osteoporose com fraturas, artrite reumatoide, hérnia hiatal e outras.

Cumpra assinalar que muitos idosos deixam de relatar as dores que estão sentindo por considerá-las como consequência inevitável do envelhecimento e, portanto, devem ser suportadas sem queixas. Por outro lado, portadores de demência podem não relatar suas dores em razão de dificuldades de expressão. Nesses casos, podem apresentar-se mais confusos e agitados (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

SINTOMAS GERAIS

São chamados sintomas gerais, porque podem surgir nas mais diversas afecções de qualquer dos aparelhos ou órgãos do corpo humano.

Os principais são a *febre*, a *astenia ou fraqueza*, a *fadiga*, as *alterações do peso* (aumento e perda de peso ou emagrecimento), a *sudorese*, as *cãibras*, os *calafrios* e o *prurido (coceira)*.

Febre

O aumento da temperatura corporal, acima de 37°C, medida na axila, pode passar despercebido pelo paciente quando a elevação é gradual e não atinge níveis altos, ou apresentar múltiplas manifestações, na dependência de muitos fatores, tais como a idade, as condições gerais, o modo de iniciar, além de outros. Por isso, o médico deve estar atento não só para indagar do paciente se ele percebeu uma anormal sensação de calor, que é a expressão direta da febre, mas também para valorizar outros dados que costumam acompanhá-la, destacando-se astenia, inapetência, náuseas e vômitos, palpitações, calafrios, sudorese e cefaleia. Em crianças, o aparecimento de convulsões pode ser a principal manifestação da febre.

Boxe

Hipertermia

Hipertermia não é sinônimo de febre. É uma síndrome provocada por exposição excessiva ao calor com desidratação, perda de eletrólitos e falência dos mecanismos termorreguladores corporais, cujas principais causas são: exposição direta e prolongada aos raios solares, permanência em ambiente muito quente e deficiência dos mecanismos de dissipação do calor corporal.

A febre de início súbito, frequente nas pneumonias, na erisipela, na malária e nas infecções urinárias, quase sempre vem precedida ou acompanhada de calafrios que obrigam o paciente a se agasalhar intensamente, mesmo quando faz calor. Outras

vezes o que predomina são os tremores, e o paciente fica “batendo queixo” (ver *Calafrios*, neste capítulo).

Quando o término da febre é rápido, chama a atenção a sudorese abundante. Deve-se valorizar, também, o relato de suores noturnos, mesmo que o paciente não os relacione com aumento da temperatura, porque muitas vezes são indicativos de febre de intensidade leve a moderada que aparece no período noturno. Deve-se lembrar sempre nesses casos da tuberculose e dos linfomas.

Se o paciente toma a iniciativa de colocar o termômetro, o que deve ser estimulado pelo médico quando se suspeita de febre não confirmada durante o exame clínico, é importante aproveitar essas informações, para se ter uma ideia da intensidade e do horário em que a febre surge.

O modo de evolução é facilmente conhecido pela observação do quadro térmico, mas, mesmo não se dispondo de quadro térmico, é possível avaliar a evolução do quadro febril pela descrição das manifestações indicativas de febre.

Boxe

Raciocínio diagnóstico

No raciocínio diagnóstico, além das características semiológicas da febre (*modo de iniciar, duração, evolução, intensidade, modo de terminar*), é fundamental a análise dos sinais e sintomas localizadores da causa do aumento da temperatura (p. ex., dor de garganta nas amigdalites, dor pleurítica e expectoração hemoptoica nas pneumonias, dor e vermelhidão da pele na erisipela, disúria e polaciúria na cistite e assim por diante). Contudo, em alguns pacientes não há sintomatologia indicativa da origem da febre. Nas febres de curta duração, a causa mais frequente são as infecções causadas por vírus (víroses), podendo-se aguardar alguns dias, na expectativa de surgir alguma manifestação que permita localizar sua origem. Quando a febre se prolonga, ultrapassando 1 semana – condição clínica denominada *febre prolongada* –, é necessário pensar em um grupo de doenças mais importantes que em seu início só apresentam esta manifestação. Entre estas, destacam-se a tuberculose, a endocardite infecciosa, os linfomas, a malária, a pielonefrite, a febre tifoide, a doença de Chagas aguda e as collagenoses.

Febre de origem obscura é uma expressão usada, às vezes com o mesmo sentido de *febre de origem indeterminada*, quando o paciente apresenta temperatura corporal superior a 37,8°C em várias ocasiões, por um período de, pelo menos, 3 semanas, sem definição diagnóstica após 3 dias de investigação hospitalar ou ambulatorial. Inúmeras são as causas, incluindo doenças de origem infecciosa, de origem neoplásica ou hematológica, doenças de diferentes naturezas, medicamentos e provocada pelo próprio paciente (febre factícia). A investigação diagnóstica depende de um exame clínico completo e de um conjunto de exames complementares escolhidos com base em hipóteses diagnósticas consistentes.

As causas de febre são apresentadas no Quadro 6.5.

Boxe

Febre e infecção

Os pacientes costumam relacionar a febre somente com processos infecciosos, automedicando-se, muito frequentemente, com antibióticos. Este hábito deve ser combatido porque só acarreta prejuízos, não só pelos gastos inúteis, mas principalmente pela perda da eficiência destes medicamentos usados em doses e tempo inadequados, pelo mascaramento do quadro clínico e pelo aparecimento de manifestações secundárias. Febre não é sempre um indicativo de infecção.

Astenia

Significa uma sensação de cansaço ou fraqueza, quase sempre acompanhada de mal-estar indefinido que só melhora com o repouso. Junto com a sensação de fraqueza ocorre cansaço ao realizar as atividades habituais. Por isso, embora *astenia* e *fadiga* não tenham o mesmo significado, na linguagem leiga frequentemente são reunidas sob a designação de *fraqueza, desânimo* ou *canseira*.

Boxe

Quando o paciente fala em cansaço ou canseira, pode estar se referindo a três coisas diferentes: *astenia*, *fadiga* e *dispneia*. Cabe ao examinador, com perguntas claras e objetivas, esclarecer o que o paciente quer dizer. De maneira simplificada pode-se dizer que astenia é sensação de fraqueza ou falta de forças; fadiga significa cansaço após mínimos esforços ou mesmo em repouso, e dispneia corresponde à dificuldade para respirar ou falta de ar.

Quadro 6.5

Causas de febre.

- Doenças que causam aumento da produção de calor, sendo exemplo deste grupo o hipertireoidismo
- Doenças que provocam dificuldade ou bloqueio da perda de calor, como se observa na ausência congênita de glândulas sudoríparas, na ictiose, na desidratação grave e em alguns casos de insuficiência cardíaca congestiva
- Quando há lesão de tecidos que resulta em produção de substâncias pirogênicas, aqui incluindo não só as doenças infecciosas e parasitárias, mas também as neoplasias malignas, trombose venosa, necroses e hemorragias (infarto do miocárdio, hemorragia cerebral), doenças hemolinfopoéticas (linfomas e leucoses), doenças imunológicas (colagenoses, doença do soro)
- Doenças que determinam estimulação do centro regulador da temperatura corporal no hipotálamo, sendo exemplos as neoplasias e as hemorragias do sistema nervoso central
- Por ação de medicamentos mediante mecanismos não bem conhecidos
- De origem psicogênica, acompanhando em geral estado de ansiedade

Ver *Temperatura corporal* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.

É comum menosprezar-se essa queixa, pela falta de elementos objetivos em que se possa apoiar o raciocínio. Mas é preciso saber que os pacientes dão a ela, com muita razão, grande importância, pois, além de ser uma sensação desagradável, a astenia impede ou dificulta a execução das atividades habituais, principalmente o trabalho.

A astenia pode apresentar diferentes graus, chegando, nos casos extremos, a obrigar o paciente a ficar deitado, sem disposição para fazer qualquer coisa. Outras vezes ele continua exercendo suas tarefas, mas o faz com dificuldade e desagrado.

Inúmeras são as causas de astenia; entre elas, a mais típica, embora não seja muito frequente, é a *miastenia gravis*, que se caracteriza por excessiva tendência à fadiga muscular que se instala em segmentos do corpo e que seria resultante de um bloqueio progressivo da junção mioneural. Sua causa é desconhecida, mas muitas vezes coexiste com tumor do timo e presença de autoanticorpos antímusculo.

As doenças infecciosas e parasitárias, talvez em função da febre que as acompanha, estão entre as causas mais comuns de astenia e fadiga. Na fase inicial das viroses, essa manifestação pode predominar no quadro clínico, admitindo-se como causa disso a invasão das massas musculares por grande quantidade de vírus.

As neoplasias, principalmente em fase mais avançada, evidenciada pela perda de peso e comprometimento do estado geral, causam grande astenia e fadiga.

Na fase final da síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), a astenia é tão acentuada que o paciente não consegue deixar o leito.

A perda de líquido e de eletrólitos, principalmente sódio e potássio, por vômitos, diarreia, sudorese profusa e diurese intensa é uma importante causa de astenia. A reidratação e a reposição de eletrólitos determinam uma reversão rápida da fraqueza.

A hipoglicemia também deve ser sempre lembrada, pois a normalização dos níveis glicêmicos provoca imediata recuperação dos pacientes.

Doenças crônicas prolongadas, como artrite reumatoide, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica com insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência suprarrenal, hipotireoidismo e insuficiência hepática reduzem progressivamente as forças do paciente a tal ponto que a astenia pode tornar-se uma das manifestações mais desconfortáveis do quadro clínico.

A hipotensão arterial acompanha-se de fraqueza, que praticamente desaparece quando o paciente se deita.

Outra causa frequente de astenia é a utilização de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos por períodos prolongados.

Por fim, deve ser lembrada uma condição, antigamente chamada “psicastenia”, na qual se juntam fraqueza inexplicada e alteração do estado de ânimo, configurando o transtorno depressivo.

Boxe

A astenia e a fadiga, principalmente quando se tornam crônicas, precisam ser corretamente investigadas e compreendidas pelo médico, pois comprometem seriamente a qualidade de vida do paciente.

Fadiga

É uma sensação de cansaço ou falta de energia ao realizar pequenos esforços ou mesmo em repouso. É um sintoma importante de insuficiência cardíaca, estando relacionada com a diminuição do débito cardíaco e aproveitamento inadequado de O₂ pela musculatura esquelética. Ela é relatada pelos pacientes com anemia e doenças crônicas (hipertireoidismo, hipotireoidismo, insuficiência suprarrenal, doença pulmonar obstrutiva crônica, hepatopatia crônica).

Não se pode esquecer, também, de que a ansiedade e a depressão são as causas mais comuns de fadiga. Por isso, deve-se procurar sempre diferenciar a *fadiga orgânica* da *fadiga psicogênica*. Falam a favor da fadiga psicogênica o fato de ela surgir mais em casa do que no trabalho, sendo pior pela manhã do que no final do dia, exatamente o contrário do que acontece na maioria dos pacientes com fadiga orgânica, que se sentem pior no final do dia, ao terminar uma jornada de trabalho.

A fadiga é uma queixa extremamente comum no idoso e, tal como nos pacientes jovens, pode ser um sintoma de doença orgânica ou psíquica. A depressão é uma das causas mais comuns de fadiga nessa faixa etária e pode ser sua única manifestação. Não é raro que a fadiga seja considerada algo normal nesses pacientes. Essa concepção errônea pode provocar sérios prejuízos, pois, por não terem sua queixa valorizada, deixam de receber tratamento adequado, em muitas ocasiões.

Boxe

Síndrome de fadiga crônica

É uma condição clínica caracterizada por fadiga intensa, associada a múltiplos sintomas (mal-estar prolongado após esforço, mialgias, artralhas, cefaleia, transtornos do sono, comprometimento da memória, febre em alguns pacientes), de início bem definido, com duração de, pelo menos, 6 meses e que reduz e/ou prejudica as atividades habituais do paciente.

Alterações do peso

A maior parte das pessoas tem oportunidade de se pesar vez por outra e sabem informar as variações que possam ter ocorrido. Investigar o aumento ou a diminuição do peso faz parte obrigatória da avaliação clínica. (Ver *Avaliação do estado nutricional* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

Aumento de peso

O aumento gradativo de peso quase sempre traduz ingestão exagerada de calorias, mesmo que o paciente insista em dizer que “come pouco”. Por isso, pode ser necessária uma avaliação minuciosa dos hábitos alimentares, detalhando-se o número de refeições, tipos e quantidade de alimentos, e hábito de comer entre as refeições.

Boxe

Aumento rápido do peso

O aumento de peso de rápida instalação na maioria das vezes corresponde à retenção hídrica, seja por doença renal ou cardíaca, seja por alteração hormonal (período menstrual), seja pelo uso de medicamentos que retêm sódio (corticoides, anti-inflamatórios, antagonistas do cálcio). Um paciente pode reter até 5 ℓ de líquido no espaço intersticial antes do aparecimento de edema.

Sobrepeso e obesidade significam que o paciente está acima do peso normal máximo e são consequência de acúmulo de gordura em diferentes partes do corpo (ver *Peso* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Perda de peso

Se o paciente relata perda de peso, é importante ter uma ideia de quantos quilos perdeu e em quanto tempo isso ocorreu. Todas as condições diretamente relacionadas com a alimentação precisam ser esclarecidas, incluindo falta ou privação de alimentos, perda do apetite, dificuldade de mastigação e deglutição, vômitos, diarreia.

As causas de emagrecimento são inúmeras. Com frequência, trata-se apenas de manifestação secundária dentro do quadro clínico. Algumas vezes, contudo, é a principal manifestação clínica a partir da qual o médico vai desenvolver o raciocínio diagnóstico (Quadro 6.6).

Perda ponderal involuntária é manifestação clínica comum e quase sempre é sinal de doença, psiquiátrica ou clínica.

Perda de peso associada à ingestão alimentar relativamente elevada sugere diabetes, hipertireoidismo ou síndrome de má absorção.

A existência de outros sintomas pode configurar síndromes cujo diagnóstico não apresenta dificuldade. Por exemplo, se o paciente relata perda de peso, polidipsia, poliúria e polifagia (a síndrome dos cinco “P”) vem logo à mente a hipótese de diabetes. Outro exemplo: emagrecimento em paciente com exoftalmia desperta de imediato a suspeita de hipertireoidismo.

Emagrecimento acentuado faz parte somente da fase avançada das neoplasias malignas. Isso quer dizer que nas fases iniciais deste grupo de doenças costuma não haver perda de peso ou esta ser de pequena monta.

Todas as doenças infecciosas e parasitárias crônicas causam perda de peso, mas em nosso meio é necessário estar sempre atento para a tuberculose, principalmente a tuberculose pulmonar.

Quadro 6.6

Principais causas de perda de peso.

Privação ou falta de alimentos

Disfagia

Diarreia crônica

Síndrome de má absorção

Cirroze

Hipertireoidismo

Insuficiência suprarrenal

Diabetes

Insuficiência renal crônica

Insuficiência cardíaca de longa duração

Neoplasias malignas

Tuberculose

Síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS)

Transtornos alimentares (anorexia nervosa, bulimia nervosa)

Transtorno depressivo

Inapetência provocada por medicamentos

Muitas outras afecções se acompanham de perda de peso, destacando-se a síndrome de má absorção, cirrose hepática, megaesôfago, insuficiência suprarrenal crônica, endocardite infecciosa, parasitoses intestinais, insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca de longa duração.

Atualmente, adquiriu especial interesse a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), pois em boa parte desses pacientes a perda de peso é manifestação precoce, progressiva e intensa.

Merece referência o emagrecimento no transtorno de ansiedade ou depressivo, na anorexia nervosa e bulimia nervosa e nas toxicomanias, destacando-se o uso de bebidas alcoólicas e cocaína. Pacientes jovens que perdem peso sem causa aparente devem ser investigados nesse sentido.

O ser humano ganha peso dos 25 até aproximadamente os 60 anos; em seguida, o peso tende a reduzir-se em consequência da perda de massa óssea e muscular (osteoporose e sarcopenia). Portanto, nos indivíduos muito idosos, a perda de peso deve ser mais valorizada quando ocorre em curto intervalo de tempo.

Boxe

Perda de peso e envelhecimento

O envelhecimento é caracterizado por alterações da constituição corporal com diminuição da massa óssea, atrofia da musculatura esquelética, redução da água intracelular, além de aumento e redistribuição da gordura corporal. Contudo, não se pode esquecer que o idoso pode perder peso em consequência das mesmas doenças que acometem os jovens e os adultos (tuberculose, AIDS, neoplasias malignas, hipertireoidismo, diabetes, doenças gastrintestinais). Trata-se de um sintoma importante, fazendo parte dos critérios para o diagnóstico da depressão, problema muito comum nessa faixa etária (Quadro 6.6).

Sudorese

Sudorese ou diaforese corresponde à eliminação abundante de suor. É fisiológica durante esforço físico ou em dias muito quentes. Representa uma resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse físico ou psicogênico. É necessário investigar as relações entre a sudorese e outros dados para ser clinicamente valorizada. Exemplos: sudorese costuma ocorrer após rápida diminuição de uma febre, seja espontaneamente como no acesso malárico, seja com o uso de medicamento antipirético; sudorese acompanhando dor retroesternal chama a atenção para a possibilidade de infarto do miocárdio; cólicas intensas (renal, intestinal) acompanham-se de sudorese e outras manifestações autonômicas. No colapso periférico, o paciente pode ficar recoberto de suor frio.

Na insuficiência cardíaca, a sudorese pode ser evidência da estimulação adrenérgica que ocorre como mecanismo compensatório. Na obesidade, pode ocorrer intensa sudorese; e, com as ondas de calor (fogacho), a sudorese é manifestação clínica frequente em mulheres na menopausa.

Boxe

Transtorno de ansiedade

A ansiedade acompanha-se de sudorese localizada principalmente nas axilas, mãos e pés. Mãos frias e sudorentas, característica fácil de se reconhecer ao exame clínico, indicam ansiedade momentânea por causa do próprio exame ou podem fazer parte de um conjunto de manifestações neurovegetativas que acompanham o transtorno de ansiedade.

Sudorese noturna é uma queixa que deve ser sempre valorizada, pois algumas infecções (HIV, tuberculose, endocardite, mononucleose infecciosa, osteomielite) ou neoplasias (leucemia, linfomas, tumores da próstata, renal, testicular, da suprarrenal) podem evoluir inicialmente somente com esta manifestação clínica. Porém, climatério, diabetes, hipertireoidismo, vasculites, além do uso de drogas ilícitas ou bebidas alcoólicas, medicamentos, ansiedade, podem se manifestar por sudorese noturna.

Cãibras

São contrações involuntárias e dolorosas de um músculo ou grupo muscular. São frequentes durante exercícios físicos intensos, em pessoas sem condicionamento adequado.

Podem ocorrer em várias condições clínicas nas quais haja hipocalcemia (hipoparatiroidismo) ou hipopotassemia (síndrome da má absorção, insuficiência renal crônica, insuficiência suprarrenal, uso de diuréticos que espoliam K). Outras causas de cãibras são neuropatias periféricas, diabetes, doença de Parkinson, gravidez, quimioterapia.

Boxe

Cãibras em pessoas idosas

Em pessoas idosas não é incomum a queixa de cãibras noturnas nas pernas, aparentemente sem uma causa bem definida. Nesses casos, é importante avaliar com cuidado a possibilidade de baixa ingestão de alimentos que contêm potássio ou uso de diuréticos.

Um tipo especial são as *cãibras profissionais*, denominadas de acordo com a profissão do paciente – pianistas, escritores, digitadores – relacionadas com a execução de movimentos musculares repetidos.

Calafrios

Refere-se à sensação passageira de frio com ereção dos pelos e arrepiamento da pele. Pode se acompanhar de tremores generalizados. Os pacientes costumam referir-se a esse sintoma como “arrepios de frio”.

Na maior parte dos casos, os calafrios surgem nas febres de início súbito, mas nem sempre os pacientes relacionam um ao outro. Exemplos comuns são os calafrios do acesso malárico e das infecções das vias biliares e vias urinárias altas (pielonefrites). Os calafrios traduzem a invasão do sangue por bactérias ou toxinas.

Outra causa de calafrio são os que acompanham as reações pirogênicas por soros e transfusões de sangue. (Ver *Febre*, neste capítulo.)

Em determinadas condições, como no climatério, os calafrios são manifestações de transtorno neurovegetativo sem relação com febre. Nessas condições, ocorrem sob a forma de fogachos ou ondas de calor e podem se acompanhar de sudorese. (Ver *Sudorese*, neste capítulo.)

Prurido

É uma sensação desagradável na pele, em certas mucosas e nos olhos, que provoca o desejo de coçar; daí a denominação leiga de *coceira*.

A sensação origina-se em terminações nervosas livres na epiderme ou na camada epitelial correspondente das membranas mucosas transicionais (vulva, uretra, ânus, ouvidos e narinas).

A estimulação das terminações nervosas é feita por mecanismos químicos ou mecânicos, estando envolvidos vários mediadores: histamina, neuropeptídeos, tripsina, peptídeos opioides, prostaglandinas, fator ativador de plaquetas.

Tem valor prático analisar o prurido tendo por base a presença ou não de manifestações cutâneas. Prurido não acompanhado de erupção cutânea deve levar à pesquisa de causas sistêmicas (distúrbios hepatobiliares, endócrinos, hematopoéticos, neoplasias malignas, insuficiência renal crônica, reação medicamentosa).

Suas características semiológicas compreendem localização, duração, intensidade, horário em que surge ou se intensifica, fatores que desencadeiam ou agravam, fatores que aliviam e manifestações concomitantes.

Quanto à localização, deve-se diferenciar o *prurido localizado* do *prurido generalizado*.

Prurido localizado está relacionado com doenças da pele (pitíriase rósea, herpes-zóster, pediculose do couro cabeludo ou púbica, dermatite herpetiforme, urticária, dermatose medicamentosa, micoses superficiais).

No prurido generalizado, a pele está aparentemente normal, embora o ato de coçar, por si só, vá provocando alterações cutâneas características, denominadas *sinais de coçadura*.

Entre as causas de prurido generalizado destacam-se o prurido senil, frequente nas estações secas do ano, quando é baixa a umidade do ar, relacionado com alterações circulatórias e da pele (pele seca), icterícia obstrutiva causada pela impregnação cutânea de pigmentos biliares, prurido gravídico, prurido diabético, linfomas e leucemias, insuficiência renal, policitemia, deficiência de ferro.

Prurido nasal, frequentemente acompanhado de espirros, indica contato com alérgeno respiratório.

O aparecimento de prurido à noite, que chega a acordar o paciente, tem tanta importância clínica que serve como referência para diferenciar os *pruridos obrigatórios* dos *pruridos facultativos*.

São causas de prurido obrigatório a pediculose, a escabiose, as picadas de inseto, dermatite de contato, urticária, neurodermatite, prurigo, prurido gravídico, doenças hepatobiliares, insuficiência renal, algumas neoplasias malignas, dermatite herpetiforme, líquen plano.

Prurido facultativo é observado na psoríase, dermatite seborreica, pitíriase, piodermites, micoses superficiais, e em alguns casos de diabetes.

Prurido anal e prurido vulvar

Em crianças, a causa mais comum de prurido anal é a infestação por oxiúros. Em adultos, além desta causa, destacam-se os microtraumatismos causados pelo uso de papel higiênico, a acidez fecal, a má higiene e as hemorroidas externas. Em alguns pacientes não se consegue detectar uma doença local. Acredita-se que possa haver um prurido anal de causa psicogênica. Mas, antes de rotulá-lo assim, é mais prudente investigar as possíveis causas localizadas no próprio ânus.

O prurido vulvar é uma queixa frequente. Tal como no prurido anal, deve-se buscar primeiro uma causa na própria vulva, antes de considerá-lo “funcional” ou “psicogênico”. Qualquer corrimento vaginal pode provocar prurido, independente de sua etiologia. Infecções por *Candida* são frequentes em pacientes diabéticas, mas nem sempre se constata a presença de fungos em mulheres diabéticas com prurido vulvar. Prurido após a menopausa pode ser atribuído à deficiência de estrogênios.

Outros locais de prurido que merecem referência são o canal auditivo externo, sede frequente de eczema, os olhos e as narinas.

Em idosos, o prurido pode ser decorrente do ressecamento da pele (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Alterações emocionais e psíquicas

(Ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*.)

As principais manifestações emocionais e psíquicas são *ansiedade, depressão, obsessões e compulsões, ilusões, alucinações, delírio, agitação psicomotora, manias e hipomanias, fobias, perda de memória, desorientação, mania de perseguição, confusão mental*.

Ansiedade. Sensação desagradável acompanhada de inquietude mental e manifestações somáticas, tais como boca seca, tensão

muscular, palpitações, aperto no peito, respiração insatisfatória com suspiros frequentes (dispneia suspirosa), mãos frias e úmidas, dificuldade para adormecer, sensação de desmaio, inquietação física (tamborilar os dedos, esfregar as mãos, balançar as pernas). Pode ser transitória, relacionada com algum acontecimento real ou imaginário que provoque tensão mental, mas pode tornar-se crônica, caracterizando o transtorno de ansiedade generalizada, que tem critérios bem definidos para o diagnóstico. Um certo grau de ansiedade faz parte da natureza humana, por isso não há uma nítida divisória entre ansiedade normal e patológica.

Boxe

A síndrome do pânico caracteriza-se por ansiedade aguda e intensa, acompanhada de fenômenos neurovegetativos intensos.

Depressão. Alteração do estado de humor com perda do interesse pelas atividades cotidianas (apatia) e do prazer com as coisas da vida (anedonia), redução do interesse sexual, fadiga inexplicável, inapetência, obstipação intestinal, palidez facial, alterações do sono (despertar precoce ou insônia) e dores generalizadas. Pode ser transitória, desencadeada por algum acontecimento desagradável, ou fazer parte do transtorno bipolar ou depressivo, situação grave que interfere profundamente na vida, chegando ao risco de suicídio.

Boxe

Tristeza, por si só, não é sinônimo de transtorno depressivo, embora seja um componente importante dos transtornos do humor.

Obsessões e compulsões. São pensamentos, sentimentos ou imagens recorrentes e persistentes, experimentados como intrusos ou impróprios, ou comportamentos repetitivos ou ritualísticos que a pessoa sente-se impelida a realizar, mesmo sabendo que não são razoáveis ou sem finalidade. Podem fazer parte do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e precisam ser reconhecidas corretamente para instituição de tratamento adequado.

Ilusões. São percepções deformadas de situações normais. Podem estar relacionadas a estado de exaustão e tensão emocional. De uma maneira geral, não têm significado patológico.

Alucinações. Percepção como se fosse real de situações ou objetos que existem apenas na mente daquela pessoa. Podem ser táteis, olfatórias, auditivas (ouvir vozes), gustativas, cenestésicas. As alucinações são importantes componentes de quadros demenciais, em especial esquizofrenia, transtorno obsessivo, demência senil, doença de Alzheimer, mas podem ser desencadeadas por febre intensa, estresse, epilepsia (aura epilética), uso de drogas ilícitas (cocaína, alucinógenos, anfetaminas, heroína, absinto) e alguns medicamentos.

Delírio. Ideação e pensamentos dissociados da realidade, referidos com grande convicção, não passível de mudança por argumentação lógica, podendo ter início por inferência incorreta de fatos reais. Tipos de delírio: persecutórios, de ruína, de grandeza, de ciúme. Causas: transtornos psicóticos (esquizofrenia) e algumas condições clínicas, tais como hipoglicemia, desidratação, infecções, anoxia cerebral por diminuição do débito cardíaco ou hipoventilação alveolar, uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, fase terminal de doenças prolongadas, medicamentos.

Delirium. Também denominado *estado confusional agudo*, caracteriza-se por modificações transitórias do nível de consciência e do comportamento, com desorganização do pensamento, distúrbio da concentração e da atenção, desencadeado por fatores orgânicos, ambientais ou medicamentos. Mais comum em idosos.

Delirium tremens é uma síndrome em que os delírios são acompanhados de tremores generalizados. Ocorre na abstinência de álcool e de outras substâncias psicoativas.

Agitação psicomotora. Alteração da ideação caracterizada por aumento da atividade psíquica, acompanhada de atividade motora e verbal inadequada e descoordenada da realidade, podendo chegar a agressividade. Tem inúmeras causas, destacando-se quadros demenciais, isquemia cerebral, transtorno histérico, ansiedade extrema, ingestão de bebidas alcoólicas e uso de drogas ilícitas.

Mania e hipomania. Alteração psíquica caracterizada por humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável, com estado de euforia, aumento da libido, menor necessidade de sono. Faz parte do transtorno bipolar (fase maníaca), mas pode ser

provocada pelo uso de esteroides, anabolizantes, antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, uso de cocaína e anfetaminas.

Fobias. Tremor ou aversão exagerada a situações, objetos, animais, lugares. Inclui diferentes tipos: fobias simples, agorafobia, fobia social.

Perda de memória. Dificuldade de recordar nomes, acontecimentos, lugares. Pode ser leve, de instalação gradativa, sem interferir de maneira significativa na vida da pessoa, como acontece com os idosos, ou de instalação rápida, com agravamento extremo, como ocorre na doença de Alzheimer que torna a pessoa inteiramente dependente de cuidados especiais. A ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica pode se acompanhar de perda da memória relativa aos acontecimentos daquele momento (amnésia alcoólica).

Mania de perseguição. Condição caracterizada pela sensação de desconfiança exagerada de estar sendo observado ou perseguido por alguém ou por mecanismos de natureza estranha.

Desorientação. Perda da capacidade da pessoa de saber quem ela é (orientação autopsíquica) ou de se localizar no tempo e no espaço. Diferentes graus de perda da orientação podem surgir na esquizofrenia e na depressão grave. Pode ser manifestação precoce da doença de Alzheimer.

Confusão mental. Estado em que a pessoa não consegue se concentrar em relação a si própria e ao meio que a cerca. Os pensamentos ficam confusos, há dificuldade de se expressar e de tomar decisões. O paciente pode falar de maneira desconexa e agir de maneira descontrolada, podendo atingir agitação psicomotora. A intensidade é variável, indo de leve a intensa. Pode ocorrer em inúmeras condições clínicas: concussão cerebral, tumor cerebral, AVE, febre elevada, hipoglicemia, desidratação, hipoxemia, estado de choque, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas, medicamentos. Em pessoas idosas pode ser manifestação inicial ou predominante de várias doenças (infecção urinária, infarto do miocárdio, desidratação).

Demência. Transtorno deficitário crônico da atividade psíquica, principalmente das funções cognitivas, primariamente do juízo, da memória e da orientação.

Boxe

Minixame do estado mental

Não é um exame psiquiátrico ou neurológico, mas é bastante utilizado nos serviços de emergência para uma avaliação rápida da memória, linguagem, orientação temporoespacial e função visuoespacial. (Ver *Minixame do estado mental* no Capítulo 20, *Exame Neurológico*.)

PELE, TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO E FÂNEROS

Os principais sinais e sintomas da pele, do tecido celular subcutâneo e dos fâneros são dor, prurido, febre, palidez, vermelhidão, cianose, albinismo, alterações da umidade, textura, espessura, temperatura, elasticidade, mobilidade, sensibilidade, com atenção especial para identificação de lesões elementares e secundárias (manchas, pápulas, tubérculos, nódulos, nodosidades, vegetações, vesículas, bolhas, pústulas, abscessos, hematomas, queratose, liquenificação, esclerose, edema, atrofia, erosão, ulceração, fissuras, crostas e escaras).

Boxe

Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas

As lesões da pele, da mucosa e dos fâneros tanto expressam doenças localizadas do sistema tegumentar como manifestações de inúmeras doenças sistêmicas (infecciosas, metabólicas, endócrinas, imunológicas) exigindo sempre um exame clínico completo. (Ver Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*.)

OLHOS

Os principais sinais e sintomas das afecções oculares são a *sensação de corpo estranho, queimação ou ardência, dor ocular e*

cefaleia, prurido, lacrimejamento ou epifora, sensação de olho seco, xantopsia, iantopsia e cloropsia, alucinações visuais, vermelhidão, diminuição ou perda da visão, diplopia, fotofobia, nistagmo, escotoma e secreção (Figuras 6.9 e 6.10).

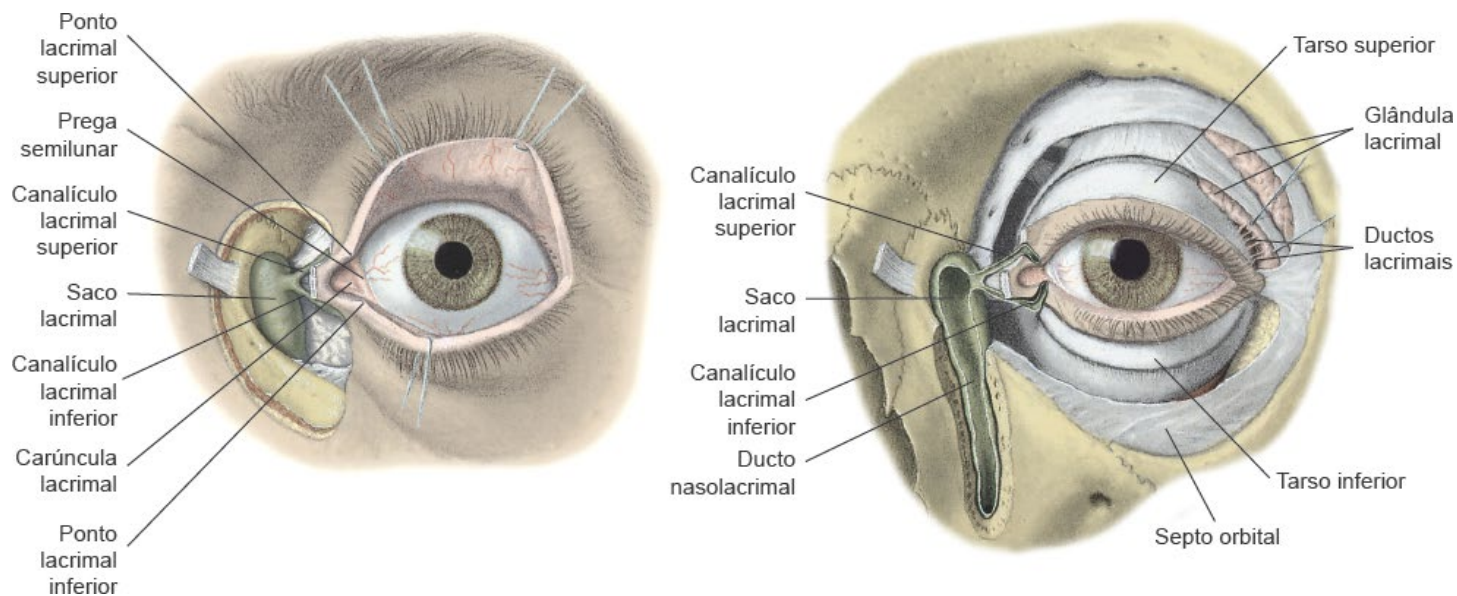
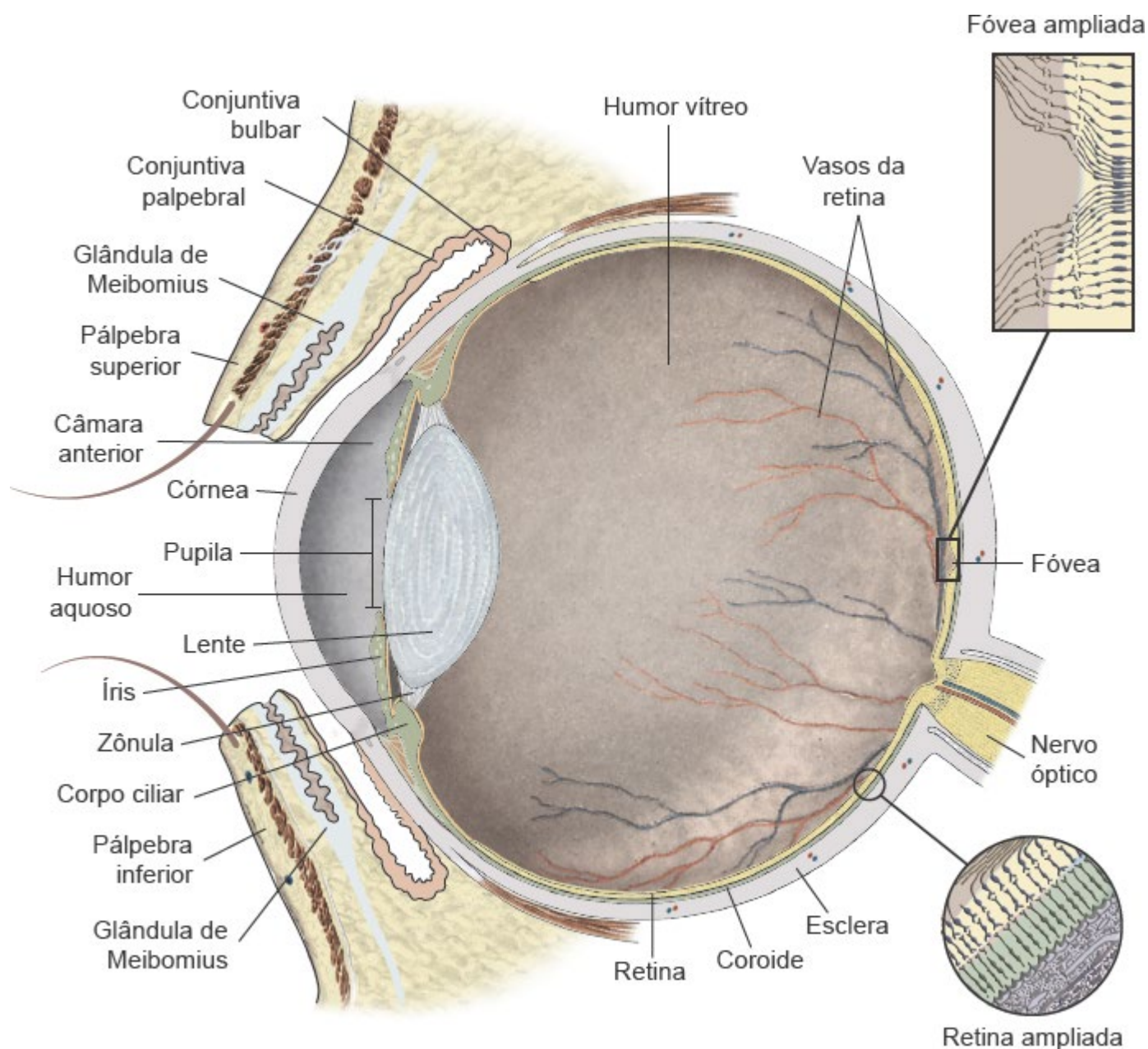


Figura 6.9 Aparelho lacrimal. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)



Ametropias ou vícios de refração

São distúrbios ópticos que não deixam que os raios de luz paralelos entrem exatamente na retina.

Os principais vícios de refração são a hipermetropia (a imagem de um objeto distante é focada atrás da retina e fica sem nitidez), astigmatismo (a refração é desigual nos diferentes meridianos do globo ocular e a imagem fica borrada), a presbiopia (perda da elasticidade da cápsula do cristalino dificulta a visão para perto), miopia (a imagem de um objeto distante é focada na frente da retina, tornando-a de limites imprecisos).

Sensação de corpo estranho

É uma sensação desagradável, quase sempre acompanhada de dor, cujas causas são a presença de corpo estranho na córnea, na conjuntiva bulbar ou na conjuntiva palpebral, cílios virados para dentro roçando a córnea, inflamação corneana superficial, abrasão corneana e conjuntivite.

Queimação ou ardência

É uma sensação de desconforto que leva o paciente a lavar os olhos repetidas vezes para aliviar o incômodo. As causas de queimação ou ardência são erro de refração não corrigido, conjuntivite, queratite, sono insuficiente, exposição a fumaça, poeira, produtos químicos e síndrome de Sjögren.

Dor ocular

Quando a dor se origina na pálpebra ou em estruturas próximas, é do tipo superficial e o paciente é capaz de apontar com o dedo o seu local exato. Pode ser causada por inflamação da pálpebra, dacrioadenite, celulite orbitária, abscesso, periostite, conjuntivite aguda, esclerite, episclerite, corpo estranho corneano, uveíte anterior (irite e iridociclite) e sinusite.

No glaucoma, o paciente relata uma dor ocular, não exatamente localizada, podendo irradiar para a região frontal. É uma dor visceral.

Cefaleia

A cefaleia de origem ocular geralmente é sentida na região frontal e manifesta-se no fim do dia, principalmente após algum trabalho em que a visão de perto foi muito solicitada. Sua principal causa são os vícios de refração não corrigidos. Pode surgir, também, nos processos inflamatórios dos olhos e anexos e no glaucoma crônico simples.

Prurido

Prurido nos olhos quase sempre é sinal de alergia ou de blefarite seborreica, mas pode também ser causado por vício de refração não corrigido. (Ver *Prurido*, neste capítulo.)

Lacrimejamento ou epífora

Traduz excesso de secreção de lágrima ou distúrbio do mecanismo de drenagem. As principais causas são inflamação da conjuntiva ou córnea, obstrução da via lacrimal excretora, aumento da secreção por emoções, hipertireoidismo, dor ocular, presença de corpo estranho na córnea e glaucoma congênito.

Sensação de olho seco

A sensação de não ter lágrimas nos olhos e que é agravada pelo contato com o vento. Ocorre na síndrome de Sjögren, na conjuntivite crônica, na exposição da conjuntiva por mau posicionamento da pálpebra e quando há dificuldade de se fechar a pálpebra adequadamente (paralisia facial).

Xantopsia, iantopsia e cloropsia

Xantopsia significa visão amarelada que ocorre em algumas intoxicações medicamentosas (fenacetina, digitálicos, salicilato de sódio, ácido pícrico) e, às vezes, na icterícia muito intensa. Iantopsia (visão violeta) e cloropsia (visão verde) são menos frequentes e ocorrem também na intoxicação medicamentosa (digitálicos, barbitúrico).

Alucinações visuais

É importante esclarecer se a sensação visual reproduz um objeto ou se limita à percepção de luz ou cores. Na maioria das vezes se devem a afecções orgânicas (geralmente doença do lobo occipital). Em pessoas cegas pode ocorrer um tipo de alucinação visual de difícil explicação. Uma característica importante é que o paciente tem consciência de que se trata de alucinação. Em algumas ocasiões traduzem transtorno mental (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*); às vezes, são causadas por intoxicação exógena (ópio, mescalina, alucinógenos sintéticos [*ecstasy*], cocaína, bebidas alcoólicas [*delirium tremens*]).

Vermelhidão (olho vermelho)

É um sintoma muito comum. Causas: conjuntivite, uveíte, blefarite, episclerite e esclerite, hemorragia subconjuntival, pterígio, ceratites infecciosas, glaucoma. Tosse intensa ou vômitos acompanhados de grande esforço podem provocar hemorragia conjuntival.

Boxe

Vermelhidão ocular acompanhada de dor indica glaucoma agudo, condição que necessita de atendimento urgente, pelo risco de perda irreversível da visão.

Diminuição ou perda da visão

Os pacientes descrevem a diminuição da acuidade visual de várias maneiras. Fatores emocionais podem induzir a exageros, levando o paciente a relatar perda da visão quando, na realidade, há apenas diminuição. O contrário também pode acontecer, ou seja, o paciente não percebe um grave defeito visual, relatando-o como simples embaçamento. Por isso, queixas de diminuição ou perda de visão devem sempre ser avaliadas por métodos objetivos pelo oftalmologista. As causas de perda de visão são apresentadas no Quadro 6.7.

É importante esclarecer há quanto tempo o paciente vem notando alteração na sua acuidade visual; se a diminuição foi progressiva ou súbita, se não havia uma baixa de acuidade há mais tempo ou se só agora foi percebida.

A perda parcial (*ambliopia*) ou total (*amaurose*) da visão ocorre em um ou em ambos os olhos, podendo ser súbita ou gradual.

A *hemeralopia* caracteriza-se por baixa acuidade visual quando a intensidade luminosa diminui. Ocorre nas degenerações da retina, na hipovitaminose A e na miopia em grau elevado.

Os erros de refração são as principais causas de borramento gradual da visão.

A dificuldade de enxergar objetos próximos sugere *hipermetropia* (*hiperopia*) ou *presbiopia*, enquanto a dificuldade de ver objetos distantes indica *miopia*.

Boxe

Perda da visão e dor

A existência ou não de dor junto com a perda da visão tem significado clínico. A súbita perda da visão sem qualquer sensação dolorosa faz pensar em oclusão vascular retiniana e descolamento da retina. Perda súbita da visão acompanhada de dor é observada no glaucoma agudo. No glaucoma crônico a diminuição da visão é gradual e não se acompanha de dor (Quadro 6.7).

Diplopia/percepção da visão dupla

Quando o paciente desenvolve um desvio ocular, o olho desviado não mantém a fixação no objeto de interesse na fóvea (área da

retina responsável pela visão central). É importante conhecer o momento do aparecimento da diplopia, se constante ou intermitente, se ocorre em determinadas posições do olhar ou a determinadas distâncias, se os dois objetos vistos são horizontais ou verticais.

A diplopia pode ser mono ou binocular. As causas de diplopia monocular são cristalino subluxado (p. ex., lente ectópica na síndrome de Marfan), catarata nuclear (o cristalino tem dois pontos focais), coloboma da íris, descolamento da retina.

As causas de diplopia binocular são paralisia de um ou mais músculos extraoculares, restrição mecânica, centralização imprópria dos óculos.

Fotofobia

Fotofobia ou hipersensibilidade à luz acompanha-se de desconforto ocular e deve-se, comumente, a inflamação corneana, afacia (ausência de cristalino), irite, glaucoma agudo, uveíte e albinismo ocular. Alguns medicamentos podem produzir aumento da sensibilidade à luz, como, por exemplo, a cloroquina e a acetazolamida.

Quadro 6.7

Causas de perda da visão.

Perda súbita de visão unilateral

Obstrução da veia central da retina, embolia na artéria central da retina, hemorragia vítrea ou retiniana, neurite óptica, papilite ou neurite retrobulbar, descolamento da retina, comprometendo a mácula, amaurose urêmica, ambliopia tóxica (diminuição da visão por efeito tóxico do álcool, quinina ou chumbo), endoftalmite embólica, trombose da artéria carótida interna e lesões traumáticas do nervo óptico (fratura do canal óptico).

Perda súbita de visão bilateral

Neurite óptica, amaurose urêmica, ambliopia tóxica, traumatismo craniano, enxaqueca oftálmica e neurose histérica (transtorno de conversão).

Perda gradual e unilateral da visão

Vícios de refração, afecções corneanas (queratites, distrofias, reações alérgicas, edema, queratocone), afecções da úvea (inflamações, doenças hemorrágicas, tumores), glaucoma (geralmente do tipo crônico), afecções do vítreo (qualquer opacificação, hemorragia), afecções da retina (lesões vasculares, degeneração tapetoretiniana, ambliopia tóxica, retinite, tumores, descolamento da retina), lesões do nervo óptico (processos inflamatórios, tumores, papiledema, atrofia óptica).

Perda gradual de visão bilateral

Ocorre em quase todas as condições relacionadas no item anterior.

Nistagmo

Movimentos involuntários, repetitivos e rítmicos dos olhos.

Pode ser caracterizado pela frequência (rápido ou lento), pela amplitude (amplo ou estreito), pela direção (horizontal, vertical, rotacional) e pelo tipo de movimento (pendular, *jerk*). No nistagmo pendular, o movimento do olho em cada direção é igual. No *jerk*, há um componente lento em uma direção e um rápido na outra.

O nistagmo é provocado por impulsos motores irregulares para os músculos extraoculares. Pode ser causado por distúrbios oculares (estrabismo, catarata, coriorretinite) ou por disfunções cerebrais. Geralmente é acompanhado de grande diminuição da acuidade visual.

Nistagmo pode estar associado à vertigem postural paroxística benigna.

Escotoma

É uma área de cegueira parcial ou total, dentro de um campo visual normal ou relativamente normal. Nesse ponto, a visão diminui apreciavelmente em relação à parte que o circunda.

Os escotomas podem ser uni ou bilaterais e devem ser investigados quanto à posição, à forma, ao tamanho, à intensidade, à uniformidade, ao início e à evolução.

Quanto à posição, os escotomas classificam-se em centrais (quando correspondem ao ponto de fixação), periféricos (quando situados distante do ponto de fixação) e paracentrais (quando situados próximo ao ponto de fixação).

Com relação à forma, podem ser circulares (traduzem uma lesão focal na retina e na coróide), ovais (indicam uma lesão do feixe papilomacular, sendo característicos da neurite retrobulbar), arciformes (são característicos do glaucoma crônico simples), cuneiformes (ocorrem nas afecções coróideas justapapilares ou, ainda, na atrofia óptica), anulares (o central indica lesão macular, o paracentral corresponde ao glaucoma crônico simples e o periférico, à degeneração pigmentar da retina), pericecais (em todas as alterações que rodeiam e incluem a papila – glaucoma crônico simples, edema de papila, neurite óptica) e hemianópticos (lesão quiasmática).

O tamanho apresenta pouca importância, embora tenha alguma relação com a gravidade da lesão. O mesmo escotoma pode variar de tamanho de um dia para outro, dependendo da progressão da doença que o produz.

Com relação à intensidade, varia de cegueira absoluta a um mínimo detectável de perda da acuidade visual.

O início e a evolução podem ser de grande importância clínica, havendo marcadas diferenças entre as várias doenças. Assim, o início dos escotomas na ambliopia pelo tabaco é gradual e a evolução é muito lenta, enquanto o escotoma central, na esclerose múltipla, surge em poucas horas. Antecedendo os episódios de enxaqueca, são frequentes escotomas cintilantes.

Secreção

A presença de secreção não deve ser confundida com o lacrimejamento, pois tem aspecto purulento. Recobre a parte em que se inserem os cílios ou o próprio globo ocular. A secreção indica processo inflamatório das estruturas externas do olho (blefarite, conjuntivites).

OUVIDOS

Os principais sinais e sintomas das doenças do ouvido são: *dor, otorreia ou secreção auditiva, otorragia, prurido, distúrbios da audição (disacusias), zumbidos e tontura e vertigem* (Figura 6.11).

Dor

A dor de ouvido ou otalgia pode ter várias causas. Às vezes, é uma dor referida, que se origina distante do ouvido; outras vezes é causada por lesões locais. Entre as primeiras, estão a otalgia atribuída à cárie dentária, à sinusite, à amigdalite e à faringite aguda. A irradiação da dor é favorecida pelo grande número de anastomoses nervosas da região. Mais importante, porém, são as otalgias decorrentes de lesões das partes externa e média do ouvido, destacando-se as otites e o furúnculo do meato acústico. Na mastoidite, a dor é de localização menos precisa e exacerba-se ao se fazer pressão sobre o mastoide.

Otorreia ou secreção auditiva

Refere-se à saída de líquido pelo ouvido, que pode ser claro como água, seroso, mucoso, purulento ou sanguinolento.

As secreções claras são constituídas pelo líquido cefalorraquidiano que provém de fraturas da base do crânio. Às vezes, vem misturado com sangue.

As sanguinolentas se devem a pólipos das partes externa ou média do ouvido, otite aguda viral, tumores benignos ou malignos e traumatismos.

As serosas, mucosas ou purulentas têm origem em afecções do pavilhão auditivo (eczema, otite externa, furúnculo), na otite média aguda ou crônica e na mastoidite crônica.

Otorragia

A perda de sangue pelo canal auditivo decorre de traumatismo do meato acústico externo no ato de coçar com palitos ou cotonetes, da ruptura da membrana do tímpano por “tapa” violento no nível do meato auditivo ou de fraturas da base do crânio, que podem estender-se à caixa do tímpano e à parede óssea superior do meato acústico externo.

Prurido

Pode ser causado por eczema no canal auditivo, mas pode, também, ocorrer em doenças sistêmicas como diabetes, linfomas ou hepatite crônica.

Distúrbios da audição (disacusias)

Disacusia significa perda da capacidade auditiva, que pode ser moderada (*hipoacusia*), acentuada (*surdez*) ou total (*anacusia* ou *cofose*).

A disacusia pode ser de *transmissão*, causada por lesões no aparelho transmissor da onda sonora, partes externa e média do ouvido (unidade tímpano-ossicular) e líquidos labirínticos; *neurosensorial* ou de *percepção*, quando a lesão se localiza no órgão de Corti e/ou nervo acústico, estruturas receptoras das ondas sonoras.

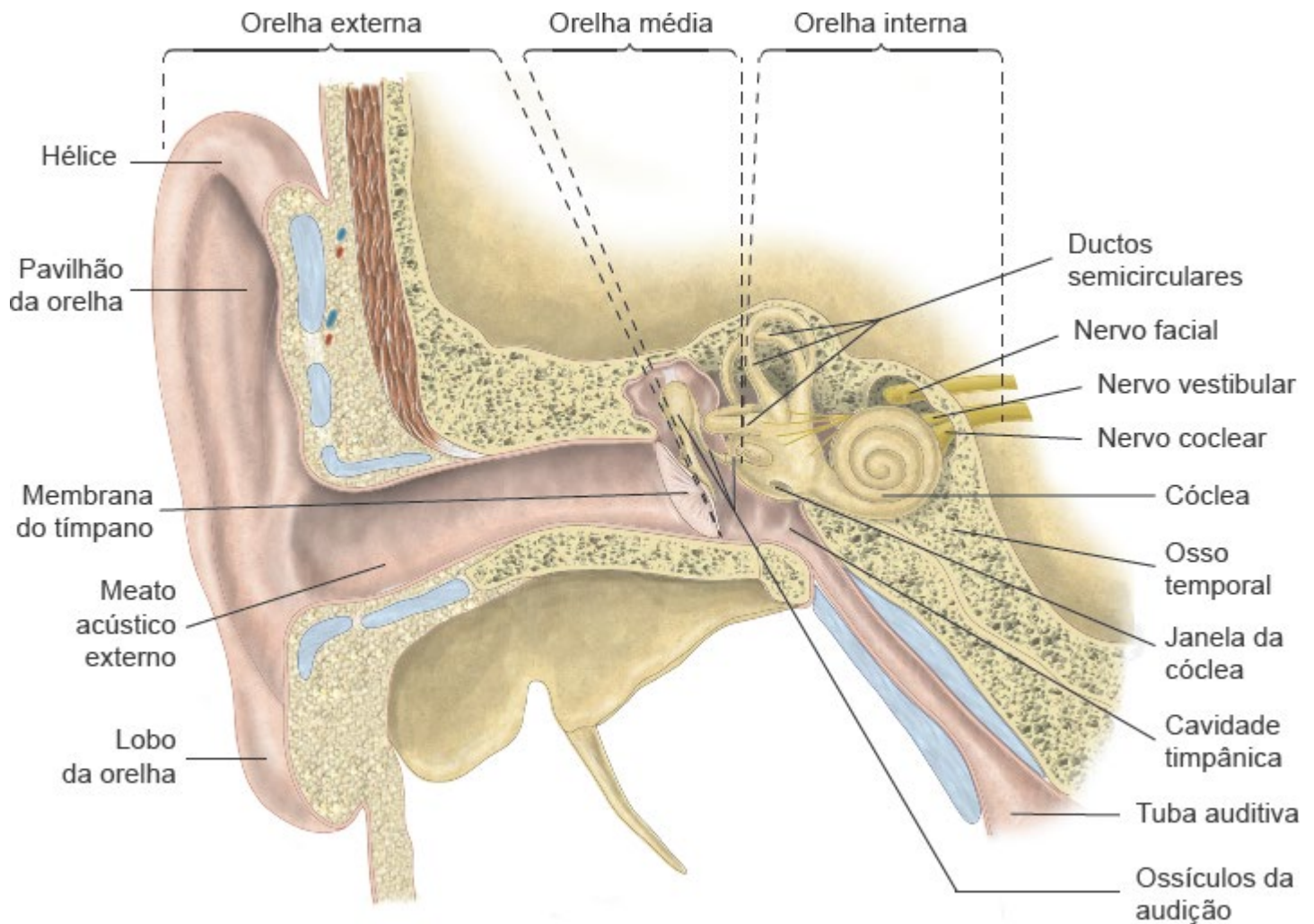


Figura 6.11 Aparelho auditivo.

Pode ser que o paciente sinta impossibilidade de identificar o lugar em que se produz um ruído (paracusia de lugar). Há casos em que o paciente se queixa de ressonância da própria voz no ouvido (*autofonia*) e ainda outros em que determinados ruídos são percebidos com sensação dolorosa (*algiacusia*).

Boxe

Surdez e envelhecimento

A surdez é um importante problema entre os idosos, estimando-se que 50% dos pacientes com 80 anos ou mais têm audição diminuída. A causa mais comum é a *presbiacusia*, quando a perda da audição para sons agudos é maior. Outras causas são representadas por infecções, cerume e doenças neurológicas. Quando evolui para graus muito avançados, pode tornar-se extremamente incapacitante, contribuindo para o

isolamento, maior risco de quedas, depressão e deficiências cognitivas do paciente.

Causas importantes de distúrbios auditivos são medicamentos (anti-inflamatórios não hormonais, aminoglicosídeos, ácido acetilsalicílico, quinino, furosemida).

Zumbidos

Zumbidos, tinido ou acúfenos são sensações auditivas subjetivas, ou seja, percepção de ruídos sem que haja estímulo sonoro. Atribuem-se à irritação de células sensoriais do órgão de Corti, na orelha interna. Manifestam-se como ruídos de jato de vapor, água corrente, campainha, cachoeira, apito, chiado, tinido.

As causas podem ser óticas e não óticas. Entre as primeiras (óticas), encontram-se o tampão de cerume, corpo estranho, otite externa, inflamações agudas ou crônicas do orelha média, esclerose do tímpano, otosclerose, obstrução tubária, afecções do orelha interna, doença de Ménière, medicamentos (quinino, salicilatos, estreptomicina, canamicina, garamicina, neomicina), otosclerose coclear, trauma sonoro, presbiacusia (surdez da idade avançada). O neuroma do acústico, quando ainda limitado dentro do meato acústico interno, pode exteriorizar-se clinicamente apenas por um zumbido “persistente”, antes que surjam a hipoacusia neurossensorial e os transtornos do equilíbrio.

Podem ser causas de zumbidos não óticos a hipertensão arterial, climatério, estase sanguínea no encéfalo (insuficiência cardíaca congestiva), hipertireoidismo.

Zumbidos acompanhados de perda auditiva e vertigem sugerem doença de Ménière.

Nos idosos, os zumbidos são comuns e frequentemente não se encontra uma explicação para seu aparecimento.

Tontura e vertigem

Tontura, também relatada como tontice ou zonzeira, é manifestação que deve ser diferenciada de vertigem, podendo ser descrita como sensação de vazio na cabeça ou de desequilíbrio ou iminente desmaio. A tontura é, em geral, resultado de redução transitória no fluxo sanguíneo cerebral.

Vertigem consiste na sensação de se estar girando em torno dos objetos (vertigem subjetiva) ou os objetos girando em torno de si (vertigem objetiva). É uma sensação angustiante, geralmente acompanhada de perda do equilíbrio, por vezes com queda, sudorese, náuseas, vômitos e zumbidos.

Vertigem de posição é aquela que só surge em determinadas posições da cabeça.

A vertigem (sensação de rotação) é sempre de natureza labiríntica. Os menores movimentos da cabeça, ao acarretarem deslocamento da endolinfa, são capazes de despertar repetidas crises vertiginosas. A intensidade e a duração do estado vertiginoso dependem do fator etiológico desencadeante. Em geral, a vertigem surge subitamente, mas também pode instalar-se insidiosamente. As crises podem apresentar-se em caráter intermitente, com períodos de acalmia mais ou menos longos, assim como sob forma subentrante, quase contínua. São acompanhadas de perturbações do equilíbrio e transtornos da marcha.

Boxe

Vertigem postural paroxística benigna (VPPB) é uma condição clínica em que ocorre vertigem com ou sem nistagmo, estritamente dependentes da postura do paciente.

A *doença de Ménière* é constituída por crises vertiginosas acompanhadas de zumbidos e diminuição da audição de duração variável (de alguns minutos a dias). Durante ou após os episódios vertiginosos, náuseas e vômitos podem ocupar lugar de destaque no quadro clínico. A etiologia básica permanece obscura, mas sabe-se que o processo situa-se no labirinto, com superprodução ou diminuição da reabsorção da endolinfa.

A causa mais comum são as labirintites que acompanham algumas viroses. Nesses casos, não há surdez e os zumbidos são raros ou inexistentes. Outras causas de vertigem são intoxicação alcoólica e uso de alguns medicamentos, como aminoglicosídeos.

Nas afecções centrais, os transtornos do equilíbrio são mais frequentes e mais acentuados, além de poderem surgir sem relação com as crises vertiginosas.

Boxe

Tontura e vertigem

Nem sempre a queixa de tontura corresponde à vertigem; o paciente pode estar se referindo a síncope, convulsão ou outro problema. Pode ser causada por condições neurológicas, cardiovasculares e metabólicas, como a descompensação diabética. No entanto, há uma tendência de atribuí-la a uma labirintite e iniciar a medicação sem antes fazer uma investigação criteriosa. Isso pode ser muito deletério não só porque se deixa de diagnosticar e tratar problemas graves como também porque muitos medicamentos usados para labirintite podem provocar importantes efeitos adversos nos idosos, tais como instabilidade postural e quedas, depressão e parkinsonismo. (Ver *Tonturas e vertigem* no item *Sistema nervoso central*, neste capítulo.)

NARIZ E CAVIDADES PARANASAIS

Os principais sinais e sintomas das afecções do nariz e cavidades paranasais são *dor, espirro ou esternutação, alterações do olfato, obstrução nasal, rinorreia ou corrimento nasal, epistaxe ou sangramento nasal, dispneia e alterações da fonação* (Figura 6.12).

Dor

A dor está presente principalmente nos processos inflamatórios agudos das cavidades sinusais (sinusites) e nas neoplasias nasossinusais. Localiza-se na face, na área correspondente à lesão, podendo irradiar para os ouvidos.

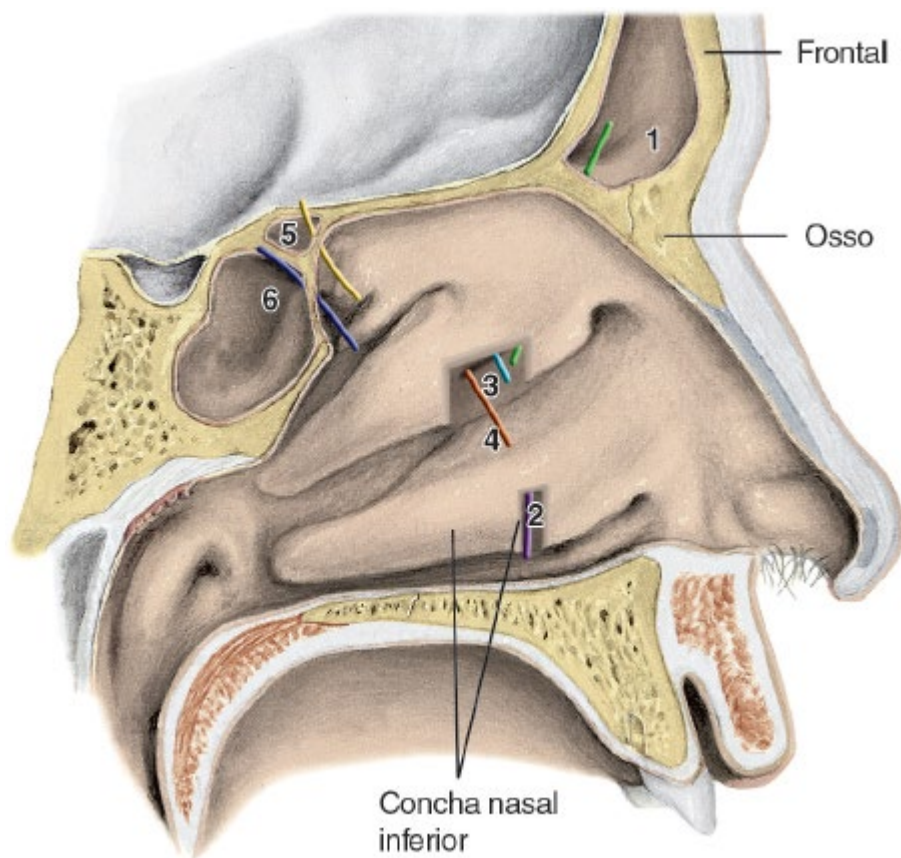


Figura 6.12 Parede externa da fossa nasal. 1. seio frontal; 2. ducto nasolacrimal; 3 e 4. hiato semilunar: drenagem de células etmoidais anteriores e seio maxilar; 5. meato superior: drenagem de células etmoidais posteriores; 6. seio esfenoidal.

Espirro ou esternutação

As crises de espirro ou esternutação podem surgir na fase inicial da rinite catarral aguda do resfriado comum e exprimem comprometimento da mucosa nasal.

Espirros e alergia respiratória

Crises de espirro são, no entanto, características das rinopatias alérgicas. Em geral, acompanham-se de prurido nasal, que pode estender-se à mucosa das conjuntivas. A presença de prurido junto com espirros constitui forte indício de alergia respiratória.

Condicionamentos psicológicos são capazes de determinar espirros. É o caso, por exemplo, de determinados indivíduos que, ao verem uma gravura que mostra uma planta ou animal aos quais são alérgicos, apresentam crises de espirro como se estivessem diante da própria planta ou animal.

Algumas vezes, espirros podem ocorrer quando uma luz forte incide nos olhos.

Alterações do olfato

As alterações do olfato incluem diminuição ou abolição, aumento, cacosmia e parosmia.

Diminuição ou abolição do olfato. A diminuição (*hiposmia*) ou a abolição (*anosmia*) do olfato podem decorrer de causas no interior das narinas que impedem a chegada das partículas odoríferas à zona olfatória na abóbada das fossas nasais (pólipos, edema da rinite alérgica crônica, hipertrofia dos cornetos). A atrofia da mucosa pituitária (ozena), lesões das terminações nervosas olfatórias (neurite gripal), processos intracranianos que atingem o bulbo olfatório (tumores, abscessos, traumatismos) ou atuam indiretamente sobre o mesmo por aumentar a tensão intracraniana (meningites e tumores) também provocam diminuição ou abolição do olfato.

Aumento do olfato. O aumento do olfato (*hiperosmia*) pode surgir na gravidez, no hipertireoidismo e em pacientes neuróticos. Pode ser também decorrente de lesões na ponta do lobo temporal.

Por vezes, a hiperosmia e, também, a parosmia podem surgir como aura epilética (*i. e.*, precedem as crises) ou como equivalente da crise convulsiva.

Cacosmia. Consiste em sentir mau cheiro, distinguindo-se duas variedades: subjetiva e objetiva. Na subjetiva, somente o indivíduo percebe o mau cheiro, como acontece na sinusite purulenta crônica; na objetiva, tanto o indivíduo como as pessoas que dele se aproximam percebem.

A cacosmia objetiva pode ser atribuída a sífilis nasal com sequestros, tumores, corpo estranho.

Na rinite atrofica ozenosa, a cacosmia em geral é só objetiva, devido à atrofia das terminações do nervo olfatório ou à fadiga do nervo em consequência da estimulação contínua pelos odores fétidos que se formam nesse tipo de rinite.

Parosmia. Consiste na interpretação errônea de uma sensação olfatória. É a perversão do olfato. Surge em pacientes com afecção neurológica. Pode ocorrer também como aura na epilepsia.

Obstrução nasal

Está presente em quase todas as enfermidades das fossas nasais – rinites, alergia respiratória, pólipos, vegetações adenoides, neoplasia, hipertrofia de cornetos, imperfuração coanal congênita –, causando o que se pode chamar de insuficiência respiratória nasal, a qual pode ser também de origem funcional (transtornos vasomotores).

Na obstrução unilateral, considerar desvio do septo nasal, corpo estranho e tumor.

Boxe

A obstrução nasal crônica determina respiração bucal de suplência e consequente distúrbios de reflexos pulmonares, com prejuízo da expansão torácica e da própria ventilação pulmonar.

Rinorreia ou corrimento nasal

Inclui diferentes tipos de secreção: serosa ou seromucosa, purulenta ou mucopurulenta, sanguinolenta ou até com fragmentos de falsas membranas, como se observa na difteria nasal.

Quando o paciente informa que tem um corrimento purulento por uma única narina, deve-se pensar na supuração de um seio acessório (sinusite) ou na presença de um corpo estranho.

Em alguns casos, a secreção torna-se muito fétida (sífilis nasal, leishmaniose, neoplasias malignas, corpo estranho, ozena).

A secreção serosa pode vir da própria mucosa (hidrorreia nasal) ou ser atribuída à passagem do líquido cefalorraquidiano pela lâmina crivada do etmoide (hidrorreia cefálica), em consequência de traumatismo por acidente com lesão facial ou cirúrgico.

A causa mais comum de corrimento nasal são as rinites virais ou alérgicas. Nesses casos, a secreção é abundante e aquosa e se acompanha de espirros.

Com frequência, a rinorreia se acompanha de obstrução nasal.

Epistaxe ou sangramento nasal

Epistaxe ou sangramento ou hemorragia nasal constitui, sem dúvida, a mais frequente das hemorragias. Origina-se, com maior frequência, de uma estrutura de intensa vascularização, localizada no septo anterior, conhecida como plexo de Kiesselbach.

Em geral, a epistaxe é de pequena intensidade, origina-se na porção mais anterior da fossa nasal e cede espontaneamente. Por vezes, no entanto, notadamente após os 45 anos, pode apresentar grande intensidade, com o sangramento localizado na parte posterior das fossas nasais, necessitando de atendimento de urgência, pois, na maioria das vezes, não cede espontaneamente.

A quantidade total de sangue eliminado é variável. Há pequenas epistaxes, em que se perdem cerca de 50 a 100 ml de sangue; grandes epistaxes, com perda de 250 a 400 ml de sangue; graves epistaxes, que podem durar muito e causar a perda de mais de meio litro de sangue. Estas duas últimas modalidades de epistaxe são muito mais comuns em pacientes idosos com hipertensão arterial.

As causas de epistaxe podem ser locais ou gerais, sendo mais comuns o ressecamento da mucosa nasal e o traumatismo no ato de limpar o nariz (Quadro 6.8).

Epistaxe unilateral sugere causa mecânica (traumatismo interno ou externo, corpo estranho) ou anormalidade estrutural local (rinite alérgica, ressecamento da mucosa nasal, pólipos nasais, telangiectasias, neoplasias). Epistaxe bilateral ou posterior sugere etiologia clínica (distúrbio hemorrágico, distúrbio da coagulação, hipertensão arterial grave).

Causas locais. Os traumatismos, como quedas, fraturas dos ossos do nariz, contusão do nariz, fratura da base do crânio, ou cirúrgicos (intervenções sobre as cavidades nasossinusais), causam frequentes hemorragias nasais. Em alguns casos, o agente atua diretamente na mucosa. É o que acontece quando se introduzem corpos estranhos ou se assoa violentamente o nariz.

Em crianças uma causa frequente de epistaxe é o hábito de enfiar o dedo no nariz.

Outras causas de epistaxe são as rinites agudas, a sinusite crônica, as ulcerações tuberculosas ou sífilíticas, a miíase nasal, os rinólitos, alguns tumores benignos como o pólipos sangrante do septo, o fibroma da nasofaringe (encontrado quase exclusivamente nos adolescentes do sexo masculino) e os tumores malignos do nariz, das cavidades paranasais e da nasofaringe.

Quadro 6.8
Principais causas de epistaxe.
Traumatismo nasal ou facial
Rinites
Adenoides
Pólipos e tumores
Hipertensão arterial
Cirrose hepática
Doenças hemorrágicas
Epistaxe espontânea

O uso de cocaína é um fator etiológico importante (lesão da mucosa nasal).

Causas gerais. A epistaxe pode ocorrer nos estados febris, nas afecções hemorrágicas (leucemias, anemia aplásica, distúrbios da coagulação), na doença reumática, na gripe, na febre tifoide, na nefrite aguda, na congestão passiva produzida por obstrução da veia cava superior, nos acessos de tosse da coqueluche.

A redução da pressão atmosférica facilita a hemorragia, como se observa na subida a altas montanhas e nos aviadores que voam em grande altura em cabines não pressurizadas. Outra condição ambiental que facilita as epistaxes é a baixa umidade do ar, observada em algumas regiões do país.

Na hipertensão arterial e nas nefrites crônicas a hemorragia nasal é muito frequente. Aliás, a epistaxe pode ser o sintoma que põe a descoberto determinados casos de hipertensão arterial até então ignorados.

As epistaxes não são raras na cirrose do fígado, hemofilia, leucemia, estados purpúricos, telangiectasia hemorrágica hereditária, doença de von Willebrand (epistaxe, gengivorragia e hemorragias genitais) e anemia perniciosa.

Dispneia

Todas as causas de obstrução nasal bilateral podem acarretar dispneia.

A imperfuração coanal congênita, quando bilateral, pode acarretar grave dispneia no recém-nascido, com cianose, asfixia e até a morte da criança.

Boxe

Síndrome de apneia obstrutiva do sono

Esta condição caracteriza-se por episódios repetitivos de paradas de respiração durante o sono com duração de 10 s ou mais, em geral associados a roncos e redução da saturação de oxigênio com redução do sono e sonolência durante o dia.

Em consequência de hipertrofia de vegetações adenoides, a criança apresenta respiração bucal ruidosa (roncos), às vezes interrompida por períodos de silêncio, os quais significam a apneia. O mecanismo da apneia decorreria de hipoventilação alveolar, hipoxia e hipercapnia. Durante o período diurno, estas crianças apresentam sonolência e adinamia. A síndrome da apneia do sono pode ocorrer também em pessoas adultas, geralmente obesas, sem relação com a presença de vegetações adenoides, mas com outras alterações rinofaríngeas.

Alterações da fonação

As fossas nasais atuam, juntamente com as cavidades sinusais, como caixa de ressonância durante a fonação, de modo que determinadas afecções nasobucofaríngeas podem alterar a emissão vocal, dando origem à voz *anasalada* ou *rinolalia*, cuja intensidade estaria na dependência do fator etiológico: véu palatino curto ou paralítico, vegetações adenoides hipertrofiadas, amplas destruições do septo nasal, obstrução nasal aguda ou crônica, fenda palatina.

FARINGE

Os principais sintomas das afecções faríngeas são *dor de garganta*, *dispneia*, *disfagia*, *tosse*, *halitose*, *surdez* e *ronco* (Figura 6.13).

Dor de garganta

Pode ser espontânea, mas piora à deglutição (*odinofagia*) e está presente em quase todas as enfermidades da faringe, inflamatórias ou neoplásicas. Com frequência, a odinofagia provoca dor reflexa nos ouvidos. Pode ocorrer também na neuralgia do glossofaringeo, associada à dor periauricular.

Dispneia

É sintoma pouco comum nas doenças da faringe, mas pode ser observada na hipertrofia exagerada das amígdalas palatinas, que pode chegar ao ponto de desencadear, da mesma maneira que a hipertrofia acentuada das vegetações adenoides, a síndrome de apneia obstrutiva do sono.

Cistos da face faríngea da epiglote e neoplasias malignas avançadas da orofaringe, principalmente da hipofaringe, também podem desencadear quadro dispneico.

Disfagia

É a dificuldade de deglutir, decorrente de processos inflamatórios, neoplásicos ou paralíticos do véu palatino e dos músculos constritores da faringe. É de localização alta (disfagia alta) e pode surgir em estados emocionais. (Ver *Disfagia* no item *Esôfago*.)

Tosse

A hipertrofia amigdaliana pode ser causa de tosse crônica. As secreções oriundas das amígdalas e aspiradas durante o sono podem acarretar laringites, traqueítes, laringotraqueítes e traqueobronquites “descendentes”, causando acessos de tosse.

Tosse pode ser devido a refluxo gastroesofágico.

Uma causa comum é o hábito de fumar, que determina irritação crônica da faringe, mas, nesses casos, não se deve esquecer da possibilidade de câncer.

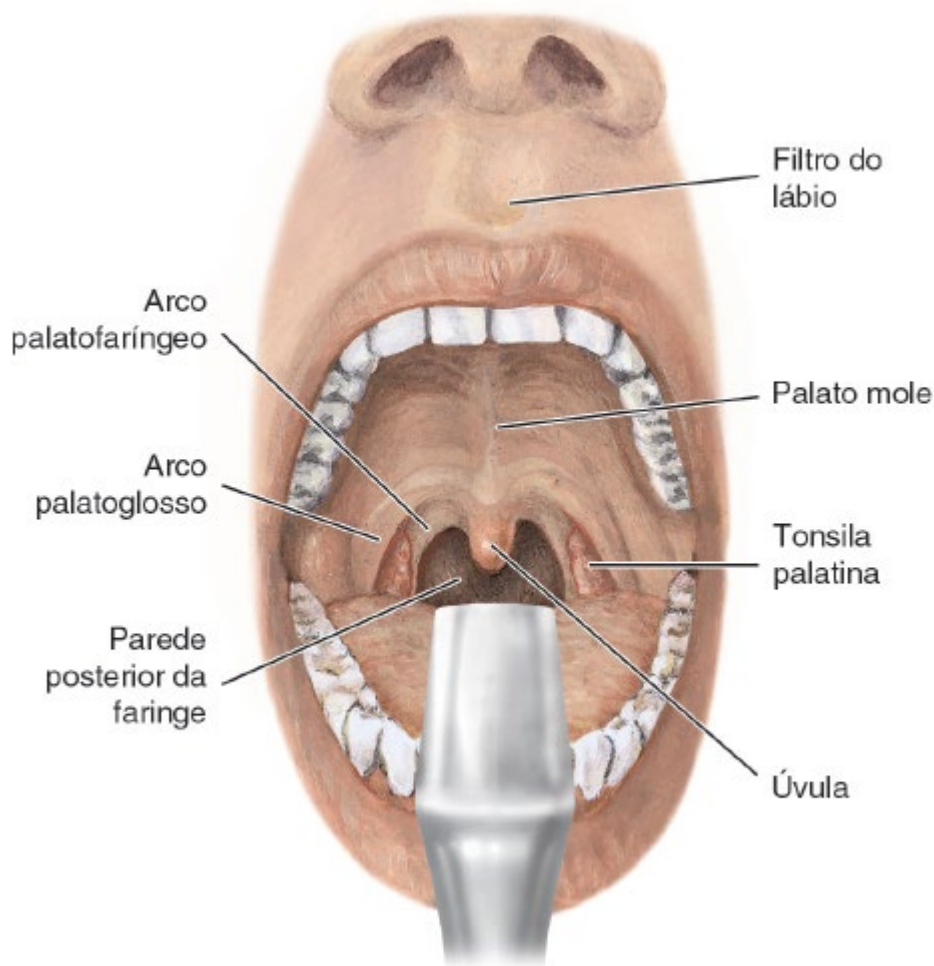


Figura 6.13 Cavidade oral. Dorso da língua e do palato. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Halitose

Determinadas amígdalas, em razão da forma anatômica especial, podem transformar-se em depósito de detritos alimentares e produtos de descamação do próprio epitélio amigdaliano, dando origem às “massas caseosas”, que são pequenas formações esbranquiçadas ou branco-amareladas. Essas massas, devido a processo putrefativo, tornam-se excessivamente fétidas e, quando se acumulam em grande quantidade e em caráter permanente, constituem causa de mau hálito (ver *Exame da cavidade bucal* no

Surdez

A surdez pode ser um sintoma das afecções da faringe. A perda da audição é caracterizada como *surdez de condução* e suas causas são: adenoides hipertrofiadas e neoplasias. A razão da surdez é a obstrução da tuba auditiva.

Ronco

O ronco é uma queixa muito comum. A condição mais grave é o ronco associado à apneia do sono. Durante esses episódios, o paciente torna-se agitado, apresenta dificuldade respiratória e parece lutar para respirar. É comum que pacientes com apneia do sono apresentem vários episódios a cada noite.

LARINGE

Os principais sinais e sintomas das doenças da laringe são *dor, dispneia, alterações da voz (disfonias), tosse, disfagia e pigarro* (Figura 6.14).

Dor

A dor surge nas laringites, agudas ou crônicas, em caráter espontâneo ou à deglutição (odinofagia). Por vezes, torna-se lancinante, como ocorre na artrite cricoaritenóidea e na tuberculose laríngea.

Dispneia

É sintoma relativamente frequente nas laringopatias, incluindo a laringite diftérica ou *crupe*, laringite estridulosa, laringomalacia, membrana congênita entre as cordas vocais, paralisia dos músculos dilatadores da glote, papilomatose infantil, câncer, abscesso laríngeo, corpo estranho e traumatismos laringotraqueais.

Alterações da voz (disfonias)

As alterações da voz apresentam-se em graus variáveis de intensidade, desde discreta *rouquidão* até ausência de voz ou *afonia*. Podem-se observar disfonias nas laringites agudas ou crônicas, na blastomicose, na tuberculose, nos pólipos e tumores endolaringeos, nas paralisias das cordas vocais, no refluxo gastroesofágico, no mau uso da voz, comum em determinadas profissões (professores, oradores, leiloeiros), e na criança que grita em excesso.

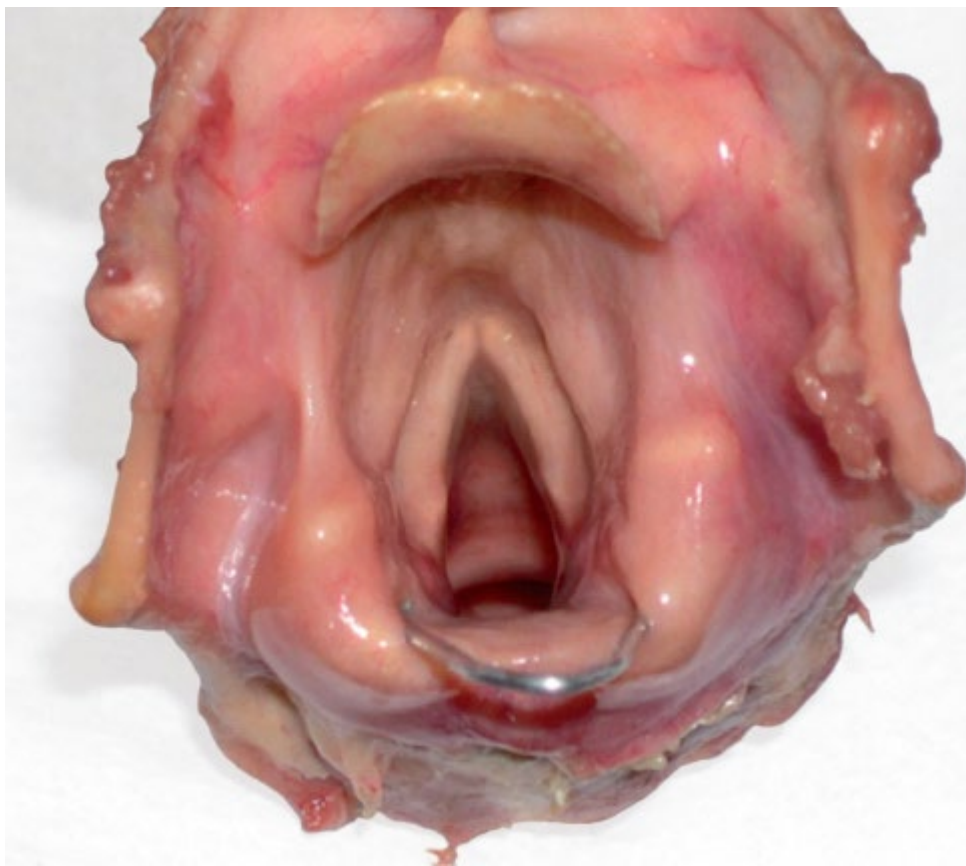


Figura 6.14 Corte esquemático da laringe.

O uso de tubo endotraqueal, durante anestesia geral, pode seguir-se de rouquidão por lesão traumática de corda vocal.

Entre as causas de disфонia que se situam fora da laringe, por compressão do recorrente esquerdo, estão os tumores localizados no mediastino médio inferior, e entre elas incluem-se as neoplasias malignas, as adenomegalias e o aneurisma do arco aórtico.

As alterações da voz também podem ser observadas por ocasião da puberdade (muda vocal), no hipotireoidismo (a voz torna-se lenta, monótona), nos portadores de fenda palatina (a voz se mostra fanhosa).

Distúrbios endócrinos da menopausa, insuficiência hormonal masculina ou feminina e acromegalia podem alterar o timbre e a intensidade da voz.

Tosse

A causa mais frequente são as laringites.

Tosse rouca quase sempre indica comprometimento das cordas vocais.

A região interaritenóidea, cuja mucosa é a sede de predileção de lesões tuberculosas, constitui o ponto mais vulnerável no despertar o reflexo da tosse.

Disfagia

É comum em processos neoplásicos da laringe, principalmente os do vestíbulo laríngeo, na área limitante com a hipofaringe. As laringites agudas e a artrite cricoaritenóidea desencadeiam distúrbios da deglutição, por vezes dolorosos.

Pigarro

Decorre de hipersecreção de muco, que se acumula e adere na parede posterior da faringe (faringite granular crônica), no vestíbulo laríngeo e nas cordas vocais, comum nos tabagistas crônicos, que obriga o paciente a raspar ruidosamente a garganta, principalmente pela manhã, a fim de desprender o muco pegajoso e clarear a voz.

TRAQUEIA, BRÔNQUIOS, PULMÕES E PLEURAS

Os principais sinais e sintomas das afecções do aparelho respiratório são *dor torácica, tosse, expectoração, vômito, hemoptise, dispneia, chiado ou sibilância, coriza, estridor e tiragem* (Figura 6.15).

Dor torácica

As causas de dor torácica podem estar na própria parede do tórax, na traqueia, nos brônquios, nas pleuras, nos pulmões, no coração, no pericárdio, nos vasos, no mediastino, no esôfago, no diafragma e em órgãos abdominais (estômago e duodeno, vesícula e vias biliares, fígado, pâncreas e baço) (Quadro 6.9).

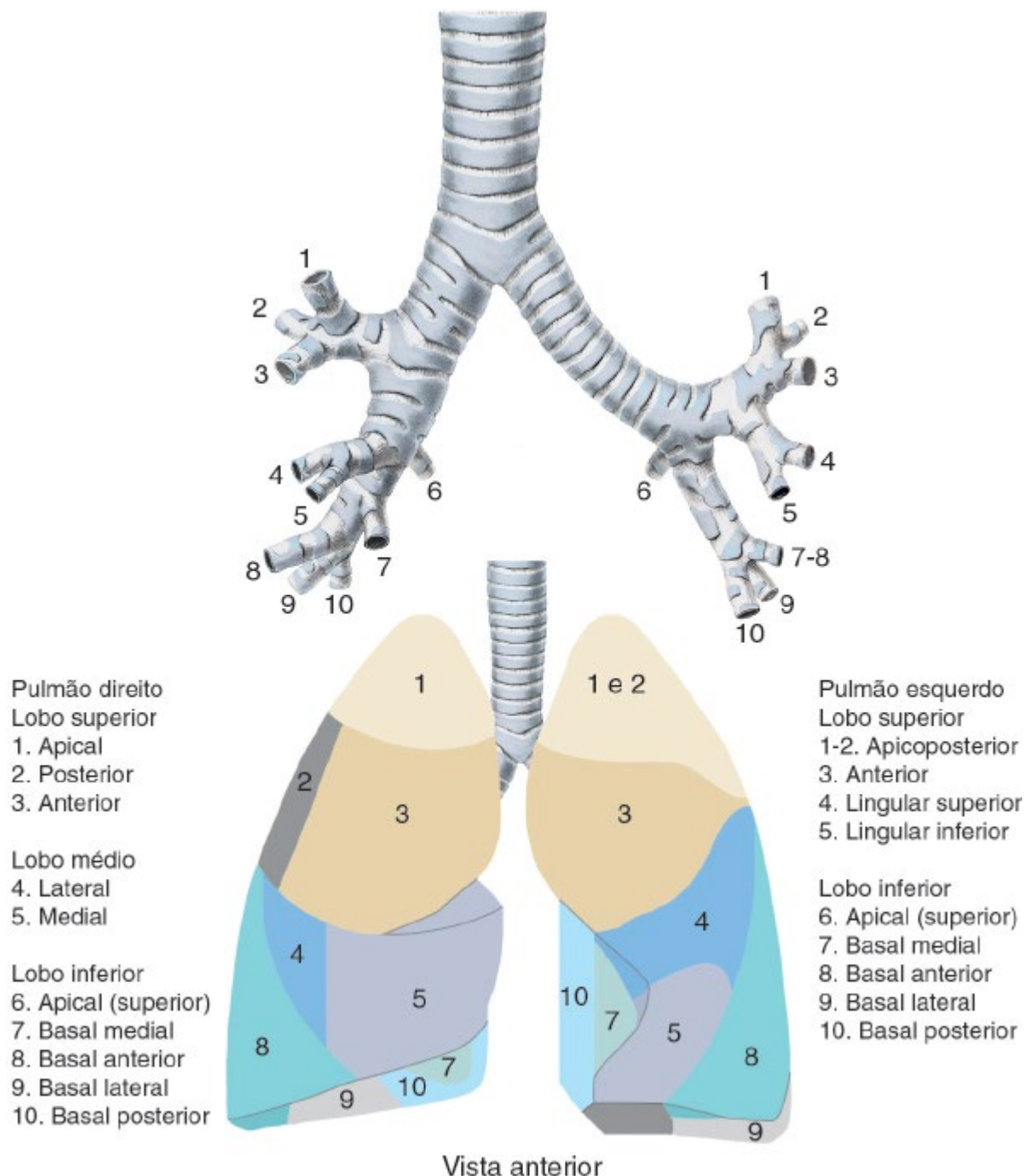


Figura 6.15 Segmentos broncopulmonares. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

As causas de dor na parede torácica quase sempre são fáceis de serem reconhecidas desde que o paciente seja corretamente examinado. Uma de suas principais características é que o paciente pode localizar com precisão a área comprometida. É fundamental que se faça a inspeção e a palpação do local indicado e de todo o tórax com o paciente despido.

Nas laringotraqueítes e nas traqueobronquites agudas o paciente localiza a dor na área de projeção da laringe e da traqueia, colocando a mão espalmada sobre o esterno.

Nas *pleurites*, a dor costuma ser aguda, intensa e em pontada (“dor pleurítica”). O paciente a localiza com precisão e

facilidade. A área em que a dor é sentida é bem delimitada, podendo o paciente cobri-la com a polpa de um dedo, ou fazer menção de agarrá-la sob as costelas com os dedos semifletidos. A dor aumenta com a tosse, manifestação comum nas pleurites, e movimentos inspiratórios profundos, o que faz o paciente reprimi-los, o mesmo acontecendo com os movimentos do tórax. Algumas vezes o decúbito sobre o lado da dor traz algum alívio.

Em muitos casos, quando a dor desaparece a dispneia piora. Isto se deve ao surgimento de derrame pleural.

Na *pleurite diafragmática periférica*, a dor é sentida na área dos nervos intercostais mais próximos, enquanto na *pleurite diafragmática central* ela se localiza no território inervado pelo frênico (pontos frênicos), incluindo o ombro. Na pleurite diafragmática o paciente pode não conseguir definir com precisão o local da dor, se torácica ou abdominal. Não é raro que se apresente com um quadro de falso abdome agudo, principalmente em crianças.

Quadro 6.9 Causas de dor torácica.	
Estrutura ou órgão	Afecção
Parede torácica	Processos inflamatórios superficiais, lesões traumáticas, distensão muscular, neoplasias ósseas, espondiloartrose cervical e torácica, hérnia de disco, compressões radiculares, neuralgia herpética, dorsalgia
Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras	Traqueítes e bronquites, neoplasias, pneumonias, embolia pulmonar, infarto pulmonar, câncer do pulmão, pleurites, pneumotórax espontâneo, traumatismos torácicos
Coração e pericárdio	Angina do peito, infarto do miocárdio, prolapso da valva mitral, miocardiopatias, arritmias, pericardites, síndrome pós-cardiotomia, estenose aórtica
Vasos	Aneurisma da aorta torácica, dissecção aórtica aguda, hipertensão pulmonar
Esôfago	Refluxo gastresofágico, esofagite de refluxo, espasmo do esôfago, hérnia hiatal, câncer do esôfago
Mediastino	Tumores do mediastino, mediastinites, pneumomediastino
Órgãos abdominais	Úlcera péptica, câncer do estômago, cólica biliar, colecistite, hepatomegalia congestiva, pancreatite, neoplasias do pâncreas, esplenomegalia
Causas psicogênicas	Tensão nervosa, transtorno de ansiedade e/ou depressivo, síndrome do pânico

Boxe

Causas de dor torácica com risco à vida

Como se pode ver no Quadro 6.9, há cerca de 50 causas de dor torácica; a maioria não representa risco à vida. No entanto, há 5 condições clínicas que são potencialmente fatais e precisam ser reconhecidas prontamente para se instituir tratamento urgente; são elas: infarto agudo do miocárdio, dissecção aórtica aguda, pneumotórax hipertensivo, embolia pulmonar e ruptura esofágica.

O diagnóstico diferencial apoia-se na análise da dor e das manifestações clínicas associadas, porém a

comprovação diagnóstica depende de exame(s) complementar(es) indicado(s) a partir de hipóteses diagnósticas consistentes, as quais, por sua vez, dependem de um exame clínico bem feito.

A dor no *pneumotórax espontâneo* é súbita, aguda e intensa. Os pacientes costumam compará-la a uma punhalada. Acompanha-se de dispneia, de maior ou menor intensidade, dependendo da pressão na cavidade pleural. Não há febre e a dor surpreende o paciente em plena saúde, na imensa maioria das vezes.

Tendo em vista que as *pneumonias* (bacterianas) iniciam-se na porção periférica dos lobos, onde o parênquima pulmonar está em estreito contato com a pleura parietal, as características da dor são as mesmas das pleurites. Sempre que existir comprometimento subpleural o folheto visceral responde com uma reação inflamatória, que em um estágio mais avançado o faz aderir ao folheto parietal, onde a dor se origina. Quando o foco pneumônico for apical, mediastinal ou diafragmático, são as vias nervosas aferentes que conduzem o estímulo até os centros cerebrais e por isso os pacientes relatam uma sensação dolorosa profunda não bem localizada, bem diferente da anterior. Nas pneumonias a dor vem acompanhada de febre e tosse produtiva, que pode ser hemoptoica.

A sensação dolorosa nas *pneumonites intersticiais* é bem diferente. O paciente queixa-se de dor difusa, como um desconforto, quase sempre de localização retroesternal, que se exacerba com a tosse, que é seca. A origem de dor, nesses casos, é no interstício pulmonar.

O *infarto pulmonar* cortical, parietal ou diafragmático provoca uma sensação dolorosa muito parecida com a das pleurites e das pneumonias. A concomitância de doença emboligênica (trombose venosa profunda, trombose intracavitária) contribui decisivamente para o diagnóstico do infarto pulmonar.

A dor mediastínica, que surge principalmente nos tumores malignos da região, é do tipo profunda, sem localização precisa (mas variando com a sede da neoplasia), surda e mal definida.

Tosse

Consiste em uma inspiração rápida e profunda, seguida de fechamento da glote e contração dos músculos expiratórios, principalmente o diafragma, terminando com uma expiração forçada, após abertura súbita da glote. A última parte da tosse – a expiração forçada – constitui um mecanismo de defesa de grande importância para as vias respiratórias.

A tosse resulta da estimulação dos receptores da mucosa das vias respiratórias, podendo também ser de origem central (tosse psicogênica). Os estímulos podem ser de natureza inflamatória (hiperemia, edema, secreções e ulcerações), mecânica (poeira, corpo estranho, aumento e diminuição da pressão pleural, como ocorre nos derrames e nas atelectasias), química (gases irritantes) e térmica (frio ou calor excessivo).

As vias aferentes mediadas pelo vago partem das zonas tussígenas indo até o bulbo. As vias eferentes dirigem-se do bulbo à glote e aos músculos expiratórios e são formadas pelo nervo laríngeo inferior (recorrente), responsável pelo fechamento da glote, pelo nervo frênico e pelos nervos que inervam os músculos respiratórios, principalmente o diafragma.

A tosse é um mecanismo de alerta ou de defesa das vias respiratórias, as quais reagem aos irritantes ou procuram eliminar secreções anormais, sempre com o objetivo de se manterem permeáveis. Contudo, ela pode tornar-se nociva ao sistema respiratório, em virtude de excessivo aumento da pressão na árvore brônquica, que culmina na distensão dos septos alveolares.

As causas da tosse são apresentadas no Quadro 6.10.

Raramente pode provocar fratura de arcos costais, hérnias inguinais e desconforto nos pacientes recém-operados.

Sua avaliação semiológica inclui as seguintes características: *frequência, intensidade, tonalidade, presença ou não de expectoração, relação com o decúbito, período em que predomina*. Destaca-se, entre essas características, a presença ou não da expectoração, configurando dois tipos básicos: *tosse seca* e *tosse produtiva* (ver *Tosse e expectoração* no item *Sistema cardiovascular*, neste capítulo).

Tipos de tosse

Distinguem-se os seguintes tipos:

Tosse seca ou improdutiva: pode ter origem em áreas fora da árvore brônquica, como o canal auditivo externo, a faringe, os seios paranasais, o palato mole, a pleura parietal e o mediastino

Tosse produtiva: é a que se acompanha de expectoração

Tosse rouca: comum nos tabagistas, é indicativa de laringite crônica. Ocorre também na laringite aguda

Tosse metálica: áspera (tosse de cachorro), indica edema da laringe e dos tecidos circundantes

Tosse bitonal: deve-se à paresia ou paralisia de uma das cordas vocais, que pode traduzir compressão do nervo laríngeo

inferior (recorrente), situado à esquerda do mediastino médio inferior

Tosse quintosa: caracteriza-se por surgir em acessos, mais frequentes de madrugada, com intervalos curtos de acalmia, acompanhada de vômitos e sensação de asfixia. É sugestiva de coqueluche, mas pode ocorrer em outras infecções respiratórias

Tosse-síncope: aquela que, após crise intensa de tosse, resulta na perda de consciência

Tosse crônica: é a que persiste mais do que 3 meses.

A presença de corpo estranho nas vias respiratórias provoca tosse seca, quase contínua. Mas em uma fase mais tardia torna-se produtiva, em virtude da instalação de processo infeccioso secundário.

Quadro 6.10 Causas de tosse.	
Origem do estímulo	Causas
Vias respiratórias superiores	Adenoides, sinusites, amigdalites, faringites, laringite, gotejamento pós-nasal, partículas irritantes suspensas no ar, produtos químicos e gases
Traqueia, brônquios e pulmões	Tabagismo, traqueíte, pós-intubação traqueal, bronquites, bronquiectasia, asma brônquica, abscesso pulmonar, pneumonias, doença pulmonar intersticial, câncer do pulmão, embolia pulmonar, infarto pulmonar, congestão pulmonar, pneumoconiose, corpos estranhos
Pleuras	Pleurites, neoplasias
Esôfago	Refluxo gastresofágico, esofagite, megaesôfago
Coração	Insuficiência ventricular esquerda, edema pulmonar agudo, asma cardíaca, estenose mitral
Mediastino	Neoplasia do mediastino, aneurisma da aorta
Ouvidos	Irritação do canal auditivo externo
Tensão nervosa	Tosse psicogênica
Medicamentos	Inibidores da enzima de conversão da angiotensina

Tosse seca, rebelde, que não cede à medicação comum pode ser um equivalente da asma e como tal deve ser tratada.

O tabagismo é a causa mais comum de tosse crônica, sendo mais acentuada pela manhã, quando costuma ser acompanhada de expectoração.

Há uma tendência dos tabagistas de considerá-la como uma manifestação “normal”. É uma interpretação equivocada e deve ser sempre valorizada, pois costuma ser a primeira manifestação de câncer pulmonar.

Nos enfisematosos a tosse é seca ou com expectoração escassa, enquanto nos bronquíticos é produtiva. O asmático tosse muito na fase secretória, mas com pouca eliminação de secreção, o que pode levar a uma crise dispneica.

Pode ser um sinal precoce de doença pulmonar intersticial que se observa na alveolite alérgica, sarcoidose, fibrose idiopática, condições em que é sempre incomodativo.

Na embolia pulmonar, a tosse costuma ser improdutiva, mas ocorrendo infarto surge expectoração hemoptoica. Na insuficiência ventricular esquerda e na estenose mitral a tosse é seca, mais intensa à noite, podendo surgir aos esforços. No edema pulmonar agudo acompanha-se de secreção espumosa, de coloração rósea.

Tosse seca, noturna, é um sinal importante de insuficiência ventricular esquerda, principalmente em pacientes idosos.

Após intubação traqueal, traqueostomia e nos indivíduos portadores de hérnia hiatal, megaesôfago ou acometidos de acidente vascular cerebral, pode ocorrer tosse produtiva em consequência de aspiração de resíduos gástricos.

Boxe

Causas dos principais tipos de tosse

As características da tosse ou outros sintomas que a ela estejam associados podem conduzir o raciocínio diagnóstico de maneira objetiva para se descobrir a causa:

Tosse seca, frequente. Virose respiratória, pneumopatia intersticial, alergia, ansiedade, uso de medicamento inibidor da enzima de conversão da angiotensina

Tosse crônica, produtiva. Bronquiectasias, tuberculose, bronquite crônica

Tosse matinal com expectoração escassa. Tabagismo

Tosse noturna. Gotejamento nasal, refluxo gastroesofágico, insuficiência cardíaca

Tosse com sibilo. Broncospasmo, asma, alergia, insuficiência cardíaca

Tosse com estridor. Obstrução traqueal

Tosse associada a ingestão de água ou alimentos. Lesão do esôfago superior

Tosse seca com dor em pontada em um hemitórax. Pleurite, pneumonia

Tosse com expectoração hemoptoica. Pneumonia, tuberculose, câncer broncopulmonar, infarto pulmonar, bronquiectasia

Tosse quintosa. Coqueluche e outras infecções respiratórias

Tosse rouca. Laringite crônica, pólipos de cordas vocais

A sinusite crônica é outra causa de tosse, causada pela secreção, que escorre para a faringe (gotejamento pós-nasal).

O refluxo gastroesofágico é a segunda causa mais frequente de tosse crônica improdutiva nos não tabagistas.

Antes do aparecimento dos fármacos antituberculose era frequente a laringite específica. Hoje, predominam as laringites causadas pelo *Paracoccidioides brasiliensis*, fungo responsável pela blastomicose sul-americana. Aliás, não é raro chegar-se ao diagnóstico dessa micose partindo-se de uma tosse rouca.

Há pacientes que apresentam tosse ou seu equivalente, o pigarro, quando em situações que implicam certa tensão emocional, como reuniões e falar em público.

Uma causa de tosse seca que se tornou comum nos últimos anos é a produzida pelos medicamentos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA).

A tosse também pode ser psicogênica. É improdutiva, e quando se chama atenção para o fato a tosse aumenta. É um diagnóstico de exclusão e só pode ser feito após rigorosa avaliação do paciente.

Expectoração

Na maioria das vezes, a expectoração é consequência da tosse, e, quando isso ocorre, fala-se em tosse produtiva.

Não se esquecer de que as mulheres e as crianças têm o costume de deglutir a expectoração. Mesmo que haja produção de catarro, não há expectoração.

É útil examinar o escarro dos pacientes, pois importantes dados para o diagnóstico podem ser aí encontrados.

As características semiológicas da expectoração compreendem o *volume*, a *cor*, o *odor*, a *transparência* e a *consistência* do material eliminado.

Em condições normais as células caliciformes e as glândulas mucíparas da mucosa produzem aproximadamente 100 ml de muco nas 24 h, trazidos até a garganta pela movimentação ciliar e depois deglutidos, inconscientemente, com a saliva. Convém lembrar que um dos efeitos do tabaco é a supressão dos movimentos ciliares, permitindo o acúmulo de secreção durante o dia, mas que atinge volume suficiente para provocar tosse, principalmente pela manhã, acompanhada de expectoração (“toalete brônquica” dos tabagistas).

As características da expectoração dependem de sua composição: a *serosa* contém água, eletrólitos, proteínas e é pobre em células; a *mucoide* (translúcida ou esbranquiçada), além de muita água, contém proteínas, como a mucina, substância pegajosa, incluindo mucoproteínas, eletrólitos, sendo baixo o número de células; a *purulenta* (amarelada ou esverdeada) é rica em piócitos

e tem celularidade alta; a *hemoptoica*, além desses elementos, contém sangue.

No edema pulmonar agudo, a expectoração tem aspecto seroso, coloração rósea e é rica em espuma.

A expectoração do asmático é mucoide, com alta viscosidade, lembrando a clara de ovo, sendo difícil de ser eliminada e aderindo facilmente às paredes do recipiente que a contém. Nesses casos, às vezes, encontram-se pequenas formações sólidas, brancas e arredondadas, justificando a expressão “escarro perolado”.

Nas fases iniciais da bronquite a expectoração é mucoide, mas com o passar do tempo torna-se mucopurulenta.

O enfisematoso, particularmente o tipo “magro”, quase não expectora, em oposição ao “gordo”, que o faz quase constantemente.

Na bronquite crônica, a expectoração pode ser predominantemente mucosa, passando para mucopurulenta ou francamente purulenta, com a progressão do processo infeccioso. Essa mudança denuncia, na maioria das vezes, a participação de germes como o *Pneumococcus* e o *Haemophilus*.

Os bronquíticos crônicos e os portadores de bronquiectasias, principalmente nas reagudizações, eliminam pela manhã grande quantidade de secreção, acumulada durante a noite, ao que se denomina “toalete brônquica”.

A expectoração desses pacientes, ao ser analisada em um recipiente, dispõe-se em quatro camadas após algumas horas, assim constituídas: uma camada espumosa (a mais superficial); uma camada mucosa contendo formações purulentas semissólidas; novamente uma zona de muco e, no fundo do frasco, uma camada purulenta branca ou esverdeada.

A presença de expectoração contribui decisivamente para diferenciar as lesões alveolares (pneumonias bacterianas) das intersticiais (pneumonias virais). No início das pneumonias bacterianas não existe expectoração ou ela é discreta, mas após algumas horas ou dias surge uma secreção abundante, amarelo-esverdeada, pegajosa e densa. Nessa fase pode ocorrer escarro hemoptoico vermelho-vivo ou cor de tijolo. Nas pneumonias por bacilos gram-negativos (*Klebsiella*, *Aerobacter*, *Pseudomonas*), a expectoração adquire um aspecto de geleia de chocolate. Quando estão presentes anaeróbios (bacteroides), o hálito fétido e o escarro pútrido chamam a atenção do médico, embora isso costume ocorrer tardiamente.

Intensa fetidez da expectoração é típica do abscesso pulmonar.

Na tuberculose pulmonar, a expectoração, na maioria das vezes, contém sangue desde o início da doença. Pode ser francamente purulenta, inodora, aderindo às paredes do recipiente onde o paciente escarra.

Além da tuberculose, expectoração hemoptoica é observada no infarto pulmonar, bronquiectasias, abscesso pulmonar, neoplasias, edema pulmonar agudo e nos distúrbios hemorrágicos.

No gotejamento pós-nasal (sinusite crônica, rinite alérgica) a tosse é mais intensa à noite e quase sempre a expectoração é mucopurulenta.

Convém lembrar que o escarro colhido para exame deve ser enviado rapidamente ao laboratório, pois só assim os resultados terão significado diagnóstico.

Vômitica

Consiste na eliminação mais ou menos brusca, através da glote, de uma quantidade abundante de pus ou líquido de aspecto mucoide ou seroso.

A vômitica tem grande semelhança com expectoração, pois é eliminada por tosse. Essa denominação se deve ao fato de parecer um vômito. Ocorre quando uma cavidade é drenada bruscamente para um brônquio.

Suas causas mais frequentes são o abscesso pulmonar, o empiema, as bronquiectasias, as mediastinites supuradas, o abscesso subfrênico e as lesões cavitárias da tuberculose.

Hemoptise

É a eliminação, com a tosse, de sangue proveniente de uma fonte abaixo das cordas vocais, ou seja, da traqueia, dos brônquios ou dos pulmões.

As hemoptises podem ser devidas a hemorragias brônquicas ou alveolares e diferentes causas (Quadro 6.11).

Na origem brônquica, seu mecanismo é por ruptura de vasos previamente sãos, como ocorre no carcinoma brônquico, ou de vasos anormais, dilatados, neoformados, como sucede nas bronquiectasias e na tuberculose.

Nas hemorragias de origem alveolar a causa é a ruptura de capilares ou transudação de sangue, mesmo sem haver solução de continuidade no endotélio para o interior dos alvéolos.

Quadro 6.11

Causas de hemoptise.

Tuberculose

Bronquites

Bronquiectasias

Pneumonias

Micoses pulmonares

Abscesso pulmonar

Câncer do pulmão

Traumatismo torácico

Embolia pulmonar

Infarto pulmonar

Fístula arteriovenosa

Doenças hemorrágicas

Estenose mitral

Insuficiência ventricular esquerda

Leucemias

Corpo estranho

Medicamentos (anticoagulantes)

Boxe

Para melhor entender a origem das hemoptises convém lembrar que há no pulmão duas circulações: a sistêmica, que por fazer parte do sistema aórtico é de alta pressão e corresponde às artérias brônquicas, e a pulmonar, formada pelos ramos da artéria pulmonar, que apresenta pressão bem menor.

Há ocasiões em que é possível suspeitar de qual circulação provém o sangue se estivermos atentos para as seguintes características: as hemoptises originadas nas artérias brônquicas são em geral volumosas, o sangue pode ser recente ou não, saturado, com ou sem catarro. É o que ocorre nas bronquiectasias, nas cavernas tuberculosas, na estenose mitral e nas fístulas arteriovenosas. Quando o sangue provém de ramos da artéria pulmonar, seu volume costuma ser menor. É o que ocorre nas pneumonias, nas broncopneumonias, nos abscessos e no infarto pulmonar.

Apesar de a tuberculose não ser mais a principal causa de hemoptise, continua sendo a doença mais temida pelos pacientes e

seus familiares.

As grandes hemoptises dos jovens no passado foram substituídas, hoje, pelas pequenas e repetidas hemoptises do carcinoma brônquico nos homens de meia-idade e nos idosos, principalmente tabagistas.

Atualmente, a causa mais frequente são as bronquiectasias, mas a tuberculose ainda é responsável por muitos casos, juntamente com a aspergilose oportunista que se instala nas cavernas saneadas (*fungus ball*).

Na infância, as causas mais frequentes de hemoptise ou de expectoração hemoptoica são as pneumonias bacterianas e os corpos estranhos. Nos jovens, a tuberculose e a estenose mitral. Em nosso meio, a blastomicose é causa comum de hemoptise, sobretudo pela sua possível associação com a tuberculose. As hemoptises devidas ao adenoma brônquico e ao tumor carcinoide são, em geral, de determinado volume, sendo o primeiro mais comum na mulher. Os bronquíticos raramente apresentam hemoptise, embora com frequência tenham estrias de sangue no escarro. Hemoptise em paciente submetido a intervenção cirúrgica recente faz pensar em embolia pulmonar.

A expressão *expectoração hemoptoica* traduz a presença de sangue juntamente com secreção mucosa ou mucopurulenta.

Boxe

Diagnóstico diferencial entre epistaxe, hemoptise, estomatorragia e hematêmese

Deve-se iniciar o diagnóstico diferencial partindo das vias respiratórias superiores. Hemorragias nasais (*epistaxe*) podem confundir-se com *hemoptise*, embora seja fácil diferenciá-las pela rinoscopia anterior. Em ambos os casos, antes de ser eliminado, o sangue ao descer pela laringe provoca tosse, sensação de asfixia, o que pode confundir o médico.

As *estomatorragias* são facilmente identificadas pelo exame da cavidade bucal.

A *hematêmese* é que mais facilmente se confunde com a hemoptise. Na hematêmese, o sangue eliminado pode ser vermelho-vivo ou ter o aspecto de borra de café, contendo ou não restos alimentares, de odor ácido, e não é arejado. Quase sempre é precedida de náuseas e vômitos. Na história pregressa desses pacientes, na maioria das vezes há referência a úlcera péptica, esofagite, varizes esofágicas ou melena. Quando as hematêmeses são de grande volume, de sangue não digerido, o diagnóstico diferencial torna-se difícil, mesmo porque, muitas vezes, a presença de sangue na faringe, seja procedente da árvore respiratória ou do tubo digestivo, provoca tosse e o reflexo do vômito.

Dispneia

Refere-se à dificuldade para respirar, podendo o paciente ter ou não consciência disso; em geral, faz referência a “falta de ar” ou “cansaço”.

As causas são múltiplas, incluindo afecções das vias respiratórias, pleuras, pulmões, coração, mediastino, caixa torácica (Quadro 6.12).

É necessário caracterizar a dispneia em relação às condições em que surge. Assim, *dispneia aos grandes esforços* é aquela que surge após esforços acima dos habituais. *Dispneia aos médios esforços* é a que decorre das atividades habituais, antes realizadas sem dificuldade. Dispneia aos pequenos esforços é a que surge durante as atividades rotineiras da vida. *Dispneia de repouso* é a dificuldade respiratória mesmo durante o repouso. *Ortopneia* é a dispneia que impede o paciente de ficar deitado e o obriga a assentar-se ou a ficar de pé para obter algum alívio. *Dispneia paroxística noturna* é a que surge à noite, depois que o paciente já dormiu algumas horas. *Trepopneia* é a dispneia que aparece em decúbito lateral, como acontece nos pacientes com derrame pleural, que preferem deitar sobre o lado doente para liberar o lado são. *Platipneia* é um tipo raro de dispneia que se caracteriza por surgir na posição sentada, aliviando-se pelo decúbito. Aparece pós-pneumectomia, na hipovolemia e na cirrose hepática (ver *Dispneia* no item *Sistema cardiovascular*, neste capítulo).

Do ponto de vista do aparelho respiratório, as causas de dispneia podem ser divididas em *atmosféricas*, *obstrutivas*, *parenquimatosas*, *toracopulmonares*, *diafragmáticas* e *pleurais*. Além das causas relacionadas com o aparelho respiratório, é conveniente referir-se às *afecções cardíacas*, *neurológicas* e à dispneia de origem *psicogênica*.

Quadro 6.12

Causas de dispneia.

Deformidade torácica

Lesões traumáticas da parede do tórax

Obstrução das vias respiratórias superiores

Laringites

Edema angioneurótico

Bronquites e bronquiolites

Asma brônquica

Enfisema pulmonar

Pneumonias

Pneumoconiose

Micose pulmonar

Fibrose pulmonar

Neoplasias broncopulmonares

Embolia e infarto pulmonar

Atelectasia

Pneumotórax

Derrame pleural

Tumores do mediastino

Estenose mitral

Insuficiência ventricular esquerda

Anemia

Obesidade

Transtorno de ansiedade

Síndrome do pânico

Causas atmosféricas. Atmosfera pobre em oxigênio ou com pressão parcial diminuída, como ocorre nas grandes altitudes, provoca dispneia mesmo a pequenos esforços. De início, o organismo compensa a rarefação do ar com taquipneia, mas se tal situação perdura, surge a sensação de falta de ar.

Os pacientes com insuficiência respiratória crônica, mas compensada, ao mudarem de altitude, quase sempre se queixam de dispneia, ao fazerem qualquer esforço físico.

Causas obstrutivas. As vias respiratórias, da faringe aos bronquíolos, podem sofrer redução de calibre, causando dispneia. As obstruções laringeas, comumente parietais, são ocasionadas por difteria, laringite estridulosa, edema angioneurótico, estenose por tuberculose, blastomicose ou neoplasia.

As obstruções da traqueia são decorrentes de corpo estranho ou de compressão extrínseca, por bócio, neoplasia, aneurisma da aorta ou adenomegalia mediastínica.

As obstruções bronquiolares surgem na asma e nas bronquiolites.

Causas parenquimatosas. Todas as afecções que reduzem a área de hematose de modo intenso, tais como condensações e rarefações parenquimatosas (pneumonia, fibrose, enfisema), determinam dispneia. Quando o processo se instala lentamente, a dificuldade respiratória costuma ser menor, pois o organismo dispõe de tempo para se adaptar.

Causas toracopulmonares. As alterações capazes de modificar a dinâmica toracopulmonar, reduzindo sua elasticidade e sua movimentação, ou provocando assimetria entre os hemitórax, podem provocar dispneia. Nessas condições se incluem as fraturas dos arcos costais, a cifoescoliose e alterações musculares, tais como miosites, pleurodinias ou mialgias intensas.

Causas diafragmáticas. Sendo o diafragma o mais importante músculo respiratório, contribuindo com mais de 50% da ventilação pulmonar, toda afecção que interfira com seus movimentos pode ocasionar dispneia. As principais são paralisia, hérnias e elevações uni ou bilaterais provocadas por ascite, hepatoesplenomegalia ou gravidez.

Causas pleurais. A pleura parietal é dotada de inervação sensorial, e sua irritação (pleurite seca) provoca dor que aumenta com a inspiração. Para evitá-la, o paciente limita ao máximo as incursões respiratórias, bem como deitar sobre o lado que o incomoda. Esses dois mecanismos juntos explicam a dispneia desses pacientes. Já os grandes derrames, embora não se acompanhem de dor, reduzem a expansão pulmonar, causando também dispneia, principalmente se forem de formação rápida. O extravasamento de ar para o espaço pleural (pneumotórax espontâneo) com colapso parcial ou total provoca dispneia intensa de início súbito.

Causas cardíacas. Decorrem de falência do ventrículo esquerdo ou de estenose de valva mitral, tendo como denominador comum a congestão passiva dos pulmões (ver *Dispneia* no item *Sistema Cardiovascular*, neste capítulo).

Causas neurológicas. Qualquer condição que se acompanhar de hipertensão intracraniana, alterando o ritmo respiratório, pode causar dispneia. Um exemplo desse tipo de dispneia é a respiração de Cheyne-Stokes (Figura 6.19).

Causas psicogênicas. A dispneia psicogênica está relacionada com transtornos emocionais e faz parte do quadro do transtorno de ansiedade e da síndrome de hiperventilação. Na síndrome do pânico o paciente pode apresentar intensa dificuldade respiratória.

A dispneia psicogênica intensa acompanha-se de modificações decorrentes da alcalose respiratória provocada pela hiperventilação, especialmente espasmos musculares e parestesias, podendo provocar a perda da consciência.

Chieira ou sibilância

Chieira, chiadeira, chiado ou sibilância é como o paciente se refere a um ruído que ele pode perceber, predominantemente na fase expiratória da respiração, quase sempre acompanhado de dispneia. O ruído tem timbre elevado e tom musical, podendo ser comparado ao miado de gato.

A chieira resulta da redução do calibre da árvore brônquica, devida a espasmo (broncospasmo) ou edema da parede. Dependendo de seu grau, pode ser o prenúncio da crise asmática, ou a principal manifestação da crise.

Boxe

Na infância pode surgir durante um simples resfriado, em episódios isolados, sem maior significado. No adulto, contudo, costuma ser a primeira manifestação de uma asma de origem infecciosa, que vai perpetuar-se mediante repetidas crises de broncospasmo.

Quando a sibilância for localizada ou unilateral e persistente, pode indicar a presença de tumor ou corpo estranho ocluindo um brônquio.

Além da asma e da bronquite, a chieira pode ser observada nos infiltrados eosinofílicos, na tuberculose brônquica, nas neoplasias brônquicas malignas e benignas. Determinados fármacos colinérgicos, betabloqueadores e inalantes químicos, assim como vegetais e pelos de animais, podem provocar chieira.

A insuficiência ventricular esquerda acompanhada de broncospasmo é a condição extrapulmonar que mais provoca chieira. Recebe a denominação de *asma cardíaca* porque se assemelha à asma brônquica, mas está relacionada com a congestão passiva dos pulmões, causada por insuficiência ventricular esquerda (ver *Dispneia* no item *Sistema cardiovascular*, neste capítulo).

Crianças portadoras de cardiopatias congênitas acianogênicas com *shunts* esquerda-direita podem apresentar chieira mesmo sem sinais clínicos de insuficiência cardíaca.

Cornagem

Consiste na dificuldade inspiratória por redução do calibre das vias respiratórias superiores, na altura da laringe, e que se manifesta por um ruído (estridor) bastante alto.

Chama a atenção o fato de o paciente deslocar a cabeça para trás, em extensão forçada, para facilitar a entrada do ar.

As causas mais comuns são a laringite, a difteria, o edema da glote e os corpos estranhos.

Estridor

É um tipo de respiração ruidosa, parecido com a cornagem. É característica na laringite estridulosa dos recém-nascidos e traduz acentuada dificuldade na passagem do ar nas vias respiratórias superiores.

Tiragem

Corresponde ao aumento da retração que os espaços intercostais apresentam em consequência das variações da pressão entre os folhetos pleurais durante as fases da respiração. É mais visível nos indivíduos magros e nas crianças. Dificilmente é observada nos obesos.

Na inspiração a pressão intrapleural é negativa em relação à pressão atmosférica, fato que é a causa de uma discreta retração dos espaços intercostais.

Nas oclusões brônquicas, a impossibilidade do ar de penetrar na árvore respiratória aumenta a negatividade intrapleural na inspiração, ocasionando uma depressão anormal dos espaços intercostais, fato a que se chama tiragem.

A localização da tiragem depende do nível e do local da obstrução.

Na asma brônquica é observada em todo o tórax porque o espasmo da musculatura brônquica é generalizado. Nas oclusões por corpo estranho ou neoplasia localizada ao nível da laringe ou acima da bifurcação da traqueia, a tiragem também é observada em todos os espaços intercostais.

Se o obstáculo estiver em um brônquio principal, o fenômeno pode ser visto no hemitórax correspondente. Quanto mais periférica for a oclusão, mais restrita será a área onde a tiragem estará presente.

De qualquer maneira, durante a inspeção do tórax é necessário prestar atenção na movimentação dos espaços intercostais, pois este dado pode ser bastante útil ao raciocínio diagnóstico. Por exemplo, em uma criança dispneica, a presença de tiragem em um hemitórax é altamente sugestiva de corpo estranho encravado no brônquio principal do lado correspondente.

DIAFRAGMA E MEDIASTINO

As manifestações clínicas das doenças do diafragma e do mediastino são indissociáveis das dos pulmões, do esôfago e dos grandes vasos, mas é possível reconhecer alguns sintomas que mais fazem pensar em acometimento destas estruturas.

Destacam-se, no caso do diafragma, a *dor*, o *soluço* e a *dispneia*.

Com relação ao mediastino, as manifestações mais importantes incluem *comprometimento do simpático*, *do nervo recorrente*, *do nervo frênico*, *compressão das veias cavas*, *comprometimento das vias respiratórias* e *do esôfago*.

Dor. A dor da pleurite diafragmática pode localizar-se em duas regiões, em função da dupla inervação do diafragma. Na área de projeção da hemícúpula afetada, ocupando uma faixa na parte inferior do tórax e região abdominal mais próxima, a qual corresponde à inervação da sua porção periférica, dada por ramos sensoriais dos nervos intercostais de T7-T12. A outra localização, no ombro e no pescoço do lado afetado, corresponde à distribuição periférica de C3, C4 e C5, onde se origina o

nervo frênico, responsável pela inervação da parte central do diafragma (Figura 6.16).

Na colecistite e no abscesso subfrênico o mesmo pode ocorrer, pois em ambas as condições o processo inflamatório pode comprometer o diafragma.

Nos grandes derrames pleurais e no dolicomegaesôfago, em virtude da pressão que o esôfago alongado e dilatado exerce sobre o diafragma, pode haver uma dor surda, sentida difusamente na base do tórax, às vezes referida para o ombro, quando há estimulação das terminações nervosas da parte central do diafragma.

Soluço. O soluço ou singulto é o resultado da contração espasmódica de uma ou de ambas as hemicúpulas diafragmáticas concomitante com o fechamento da glote. Acompanha-se de um ruído causado pela vibração das cordas vocais com a glote fechada.

As causas de soluço diretamente relacionadas com o diafragma são as hérnias diafragmáticas, mas muitas outras afecções podem provocar soluço, incluindo doenças que comprometem a pleura e o mediastino, refluxo gastroesofágico, hérnia hiatal, gastrite, câncer gástrico, uremia, megaloesôfago, acidose metabólica, meningoencefalites, neoplasias cerebrais e no pós-operatório de cirurgia abdominal.

Uma causa relativamente comum é a ingestão de bebidas alcoólicas, admitindo-se que nesses casos haja uma alteração da mucosa ao nível da junção esofagogástrica e uma ação central com estimulação dos núcleos relacionados com o controle do funcionamento diafragmático.

Dispneia. Uma vez que o diafragma é responsável por mais de 50% da capacidade de expansão dos pulmões, compreende-se por que as afecções que comprometem sua mobilidade – grandes hérnias e eventrações, derrames pleurais volumosos, grandes ascites, paralisia do nervo frênico – provocam dispneia.

Comprometimento do simpático. O comprometimento do simpático cervicotorácico manifesta-se por uma síndrome constituída por miose, enoftalmia e redução da fenda palpebral, denominada síndrome de Claude Bernard-Horner.

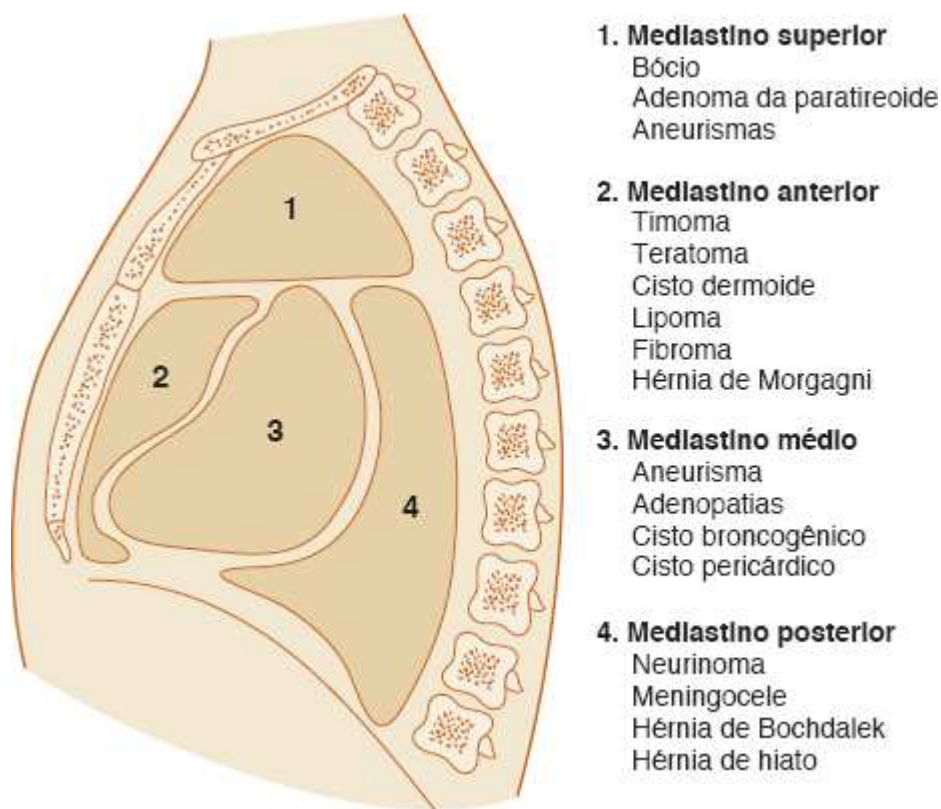


Figura 6.16 Distribuição topográfica preferencial das neoplasias do mediastino.

A causa mais frequente são os tumores dos ápices pulmonares.

Comprometimento do nervo recorrente. O comprometimento do nervo recorrente está relacionado com sua trajetória, que, à esquerda, forma uma alça sob a crossa aórtica. Quando o nervo é comprimido por aneurisma aórtico ou tumor do mediastino, surge voz bitonal, rouquidão ou afonia.

Comprometimento do nervo frênico. O comprometimento do nervo frênico, quase sempre por compressão causada por massa tumoral, traduz-se por soluço e paralisia da hemicúpula diafragmática.

Compressão das veias cavas. As veias cavas são facilmente comprimidas porque suas paredes são delgadas e a pressão do sangue é relativamente baixa.

Na compressão da *veia cava superior* surge turgência nas jugulares com ausência de pulsação e sinais de estase circulatória encefálica, expressa por zumbidos, cefaleia, tonturas, sonolência e torpor.

Quando há compressão da *veia cava inferior* ocorre ascite, hepatomegalia e edema dos membros inferiores.

Em ambas as condições, pode chamar a atenção do médico a circulação colateral, com características particulares em cada uma das condições (ver Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Comprometimento das vias respiratórias. O comprometimento da traqueia ou dos brônquios por compressão ou invasão, no caso de tumores malignos, traduz-se por dispneia, tosse e, quando o obstáculo se localiza acima da bifurcação da traqueia ou nos brônquios principais, produz retração dos espaços intercostais e das fossas supraclaviculares durante a inspiração, fenômeno denominado tiragem.

Comprometimento do esôfago. A principal manifestação clínica do comprometimento do esôfago é a disfagia.

As causas de compressão do esôfago, bem como da traqueia, dos brônquios e das veias são as massas mediastinais, destacando-se o bócio intratorácico, o adenoma paratireóideo, os aneurismas da aorta e de seus primeiros ramos, os timomas, os teratomas, as adenomegalias neoplásicas, os cistos brônquicos, os tumores de tecido nervoso (neurinomas) e as hérnias diafragmáticas.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

As manifestações clínicas das doenças cardiovasculares dependem, em primeiro lugar, do segmento comprometido; por isso, é necessário estudar separadamente os sintomas das afecções do *coração*, das *artérias*, das *veias*, dos *linfáticos* e da *microcirculação* (Figura 6.17).

Coração

As doenças do coração manifestam-se por variados sinais e sintomas, alguns originados do próprio coração, outros em diferentes órgãos nos quais repercutem as alterações do mau funcionamento cardíaco. Os principais são *dor*, *palpitações*, *dispneia*, *intolerância aos esforços*, *tosse e expectoração*, *chieira*, *hemoptise e expectoração hemoptoica*, *desmaio (síncope e lipotímia)*, *alterações do sono*, *cianose*, *edema*, *astenia ou fraqueza* e *posição de cócoras (squatting)*.

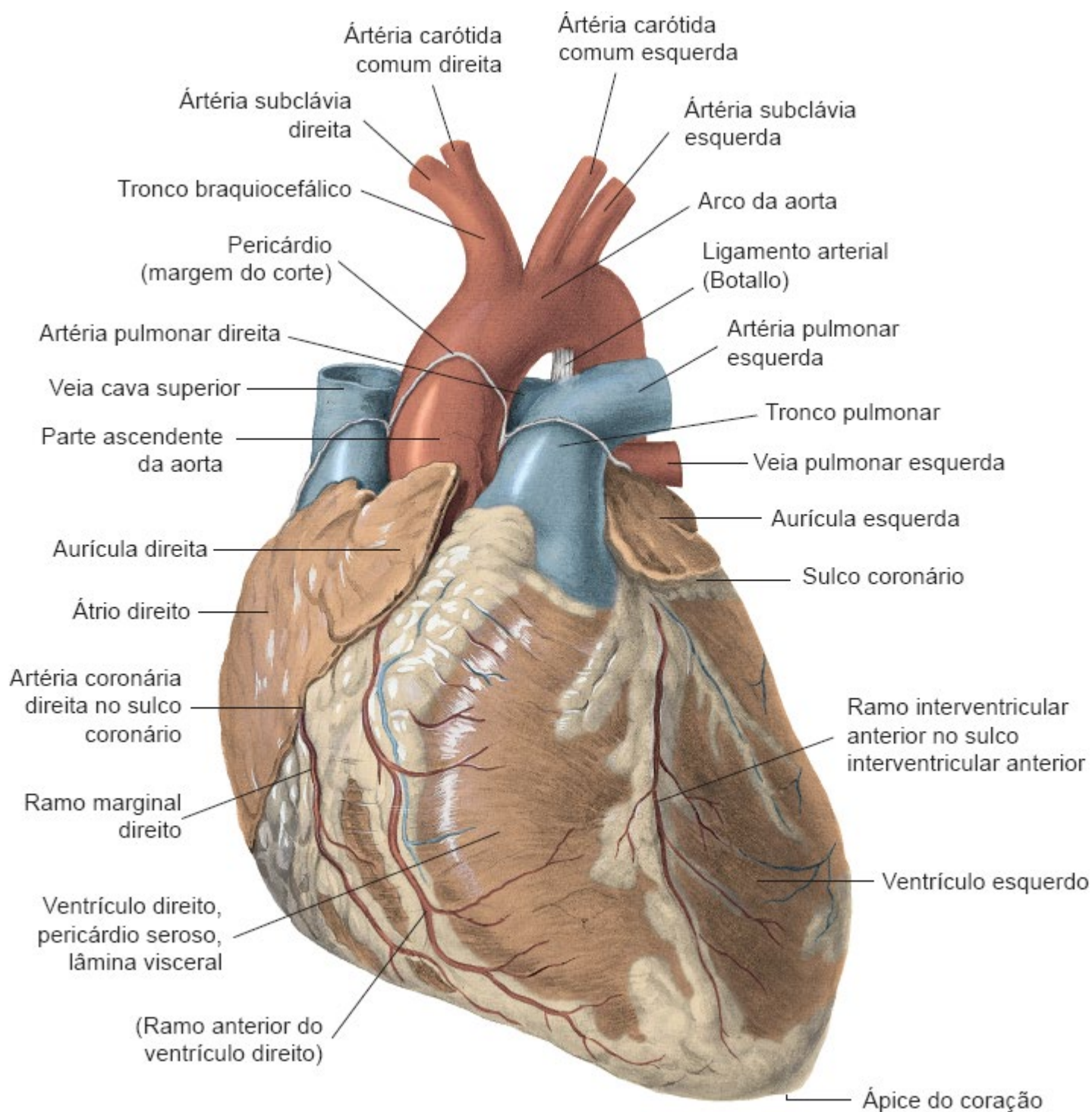


Figura 6.17 Sistema cardiovascular. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Dor

Dor precordial ou retroesternal pode ter origem no coração ou na pleura, no esôfago, na aorta, no mediastino, no estômago e na própria parede torácica. Por isso, é muito importante no raciocínio diagnóstico distinguir a dor decorrente de alterações do coração e dos grandes vasos da originada em outros órgãos (Quadro 6.9).

A dor relacionada ao coração e à aorta compreende a dor da isquemia miocárdica, a dor pericárdica, a dor de origem aórtica e a dor de origem psicogênica.

Dor da isquemia miocárdica

A dor de origem isquêmica é decorrente da hipoxia celular. Toda vez que há desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, ocorre estimulação das terminações nervosas da adventícia das artérias e do próprio miocárdio por substâncias químicas liberadas durante a contração.

A causa mais comum de isquemia miocárdica é a aterosclerose coronária (doença arterial coronariana) e suas complicações,

principalmente espasmo e trombose, assumindo características clínicas especiais na angina do peito e no infarto do miocárdio; outra causa importante é a estenose aórtica.

A *localização* típica da dor isquêmica miocárdica é a retroesternal, podendo situar-se à esquerda ou, mais raramente, à direita da linha esternal. Ora restringe-se a uma pequena área, ora ocupa toda a região precordial. Em alguns pacientes a localização é atípica (região epigástrica, dorso do tórax, supraesternal, mandíbula, punhos). Para bem avaliá-la, o médico deve valer-se das outras características semiológicas.

Boxe

A dor no nível do mamilo quase nunca é de origem cardíaca, podendo ser psicogênica (somatização de ansiedade e/ou depressão) ou causada por distensão do estômago ou do ângulo esplênico do cólon. Algumas vezes pode estar relacionada com extrassistolia.

Dor nas articulações condroesternais acompanhada de sinais flogísticos e que se acentua à palpação caracteriza a osteocondrite (síndrome de Tietze).

A *irradiação* da dor apresenta estreita relação com sua intensidade. Quanto mais intensa, maior a probabilidade de se irradiar. A dor isquêmica pode ter diversas irradiações: para os pavilhões auriculares, maxilar inferior, nuca, região cervical, membros superiores, ombros, região epigástrica e região interescapulovertebral. Contudo, *a irradiação mais típica é para a face interna do braço esquerdo*.

O *caráter* ou a *qualidade* da dor da isquemia miocárdica quase sempre é constritivo, dando ao paciente a sensação de que alguma coisa aperta ou comprime a região retroesternal. Essa característica define a “dor anginosa”. Basta essa qualidade para levantar a suspeita de isquemia miocárdica. Alguns pacientes relatam uma sensação de aperto na garganta, como se estivessem sendo estrangulados. Aliás, tal sensação pode ser percebida nas áreas de irradiação da dor, como, por exemplo, impressão de aperto, como o de um bracelete muito justo no braço. Mais raramente, a dor isquêmica pode adquirir o caráter de queimação, ardência, formigamento, facada ou desconforto. Nesses casos, também se fala em dor atípica, cuja análise precisa ser mais rigorosa para não se incorrer em erro.

A *duração* da dor é importante para sua avaliação clínica: na angina do peito estável a dor tem duração curta, em geral de 2 a 3 min, raramente ultrapassando 10 min, e é estreitamente relacionada com esforço físico. Isso porque sua origem é apenas hipoxia miocárdica, sem alteração necrobiótica; na angina instável a dor é mais prolongada, chegando a durar 20 min, pois nessa síndrome já há alterações celulares, não estando relacionada com esforço físico. No infarto do miocárdio, em função do surgimento de alterações necróticas, a dor dura mais de 20 min, podendo perdurar várias horas. Contudo, a duração da dor não é elemento semiótico suficiente para se fazer o diagnóstico diferencial entre angina instável e infarto agudo do miocárdio.

A *intensidade* da dor varia de acordo com muitos fatores, entre eles o grau de comprometimento miocárdico, podendo ser classificada em leve, moderada e intensa. Lembrar-se de que a sensibilidade do paciente tem influência preponderante. Na graduação da dor, pode-se usar o critério a seguir:

Dor leve: quando o paciente a sente, mas não se fixa nela, relatando-a como uma sensação de peso ou desconforto, relativamente bem tolerada

Dor moderada: quando o paciente se sente bastante incomodado, agravando-se mais ainda com os exercícios físicos

Dor intensa: é aquela que inflige grande sofrimento, obrigando-o a ficar o mais quieto possível, uma vez que a dor piora a partir de quaisquer movimentos ou pequenos esforços. Nesses casos, acompanha-se de sudorese, palidez, angústia e sensação de morte iminente.

A dor da angina do peito típica ocorre na maioria dos casos após esforço físico, mas pode ser desencadeada por todas as condições que aumentam o trabalho cardíaco, tais como emoções, taquicardia, frio, refeição copiosa. No infarto do miocárdio, contudo, a dor pode ter início quando o paciente está em repouso.

O alívio da dor pela interrupção do esforço é uma das características fundamentais de angina do peito clássica (angina estável). O efeito de vasodilatadores coronários precisa ser corretamente analisado, sendo importante avaliar o tempo gasto para desaparecimento da dor pelo uso de nitrato por via sublingual, pois na angina do peito a dor desaparece 3 ou 4 min após; se levar mais tempo (5 ou 10 min), provavelmente não se trata de angina estável, podendo ser a forma instável da angina. A dor do infarto persiste ou melhora muito pouco com os nitratos.

A dor é, sem dúvida, o sintoma que mais levanta a suspeita de isquemia miocárdica. É necessário valorizar todas as características semiológicas, as quais, muitas vezes, não se apresentam juntas. Não se pode esquecer de que um terço dos pacientes apresenta *dor atípica*, mas, nesses casos, quase sempre está presente alguma manifestação clínica que levanta a

suspeita de angina ou de infarto do miocárdio, tais como a irradiação da dor, relação com esforço físico, sudorese. Precordialgia intensa, acompanhada de náuseas, vômitos e sudorese, sugere infarto agudo do miocárdio. Dor precordial durante crise de palpitações pode decorrer de taquiarritmia, que provoca isquemia miocárdica relativa.

Pacientes com miocardiopatia dilatada podem queixar-se de dor precordial de difícil explicação.

Boxe

Diagnóstico diferencial da dor retroesternal e precordial causada por isquemia miocárdica

Dor torácica que surge com as mudanças de decúbito ou movimentos do pescoço e do tórax origina-se na coluna cervical ou dorsal (*ver Coluna vertebral*, neste capítulo)

Dor que se agrava com a tosse é provocada por pericardite, pleurite ou compressão de uma raiz nervosa

Dor retroesternal que ocorre após vômitos intensos é causada por laceração da mucosa da junção esofagogástrica

Dor retroesternal durante a deglutição é causada por espasmo esofágico ou esofagite (*ver Esôfago*, neste capítulo).

Dor pericárdica

A dor da inflamação do pericárdio localiza-se na região retroesternal e se irradia para o pescoço e as costas. Pode ser do tipo “constritiva”, “peso”, “opressão”, “queimação” e ter grande intensidade; costuma ser contínua, durando várias horas; não se relaciona com os exercícios; agrava-se com a respiração, com o decúbito dorsal, com os movimentos na cama, com a deglutição e com a movimentação do tronco. O paciente pode ter alívio ao inclinar o tórax para a frente ou quando adota a posição genupeitoral.

O mecanismo provável da dor da pericardite é o atrito entre os folhetos do pericárdio com estimulação das terminações nervosas ou uma grande e rápida distensão do saco pericárdico por líquido.

É provável que a irritação das estruturas vizinhas – pleura mediastinal, por exemplo – também participe do mecanismo da dor da pericardite.

Dor de origem aórtica

Os aneurismas da aorta de crescimento lento geralmente não provocam dor, mas a dissecção aórtica aguda determina quadro doloroso importante, com início súbito, grande intensidade, tipo lancinante, localização retroesternal ou face anterior do tórax, com irradiação para o pescoço, região interescapular e ombros. Durante a crise dolorosa o paciente fica inquieto – deita-se, levanta-se, revira na cama, adota posturas estranhas, comprime o tórax contra a cama ou a parede, tentando obter alívio.

É a separação brusca das camadas da parede arterial, particularmente da adventícia, com súbita distensão das terminações nervosas aí situadas, que estimula intensamente as fibras do plexo aórtico, determinando dor intensa.

O principal diagnóstico diferencial é com o infarto agudo do miocárdio.

Dor de origem psicogênica

A dor de origem psicogênica ocorre em indivíduos com ansiedade e/ou depressão, podendo fazer parte da *síndrome de astenia neurocirculatória* (neurose cardíaca) ou do *transtorno do pânico*. A dor limita-se à região mamilar, no nível do *ictus cordis*, costuma ser surda, persiste por horas ou semanas e acentua-se quando o paciente tem contrariedades ou emoções desagradáveis. Não está relacionada com exercícios e pode ser acompanhada de hiperestesia do precórdio. Além da dor, o paciente se queixa de palpitações, dispneia suspirosa, dormências, astenia, instabilidade emocional e depressão. A dor pode desaparecer com exercício físico, analgésicos, ansiolíticos, antidepressivos e placebos.

Os pacientes portadores de angina do peito ou que já tiveram infarto do miocárdio preocupam-se tanto com o coração, que se alteram emocionalmente por causa de qualquer tipo de dor torácica. Em alguns, torna-se difícil diferenciar a dor precordial isquêmica da dor psicogênica. Explica-se este fato pelo significado simbólico do coração na cultura ocidental, considerado a sede do amor, das emoções e da própria vida.

Boxe

Dor precordial e significado simbólico do coração

O conhecimento de lesão cardíaca ou o simples medo de doença do coração pode desencadear profundas alterações na mente de qualquer um de nós, pois, mais do que o comprometimento anatômico do órgão central da circulação, o que nossa mente passa a alimentar é o receio, mais em nível inconsciente, em que tem grande importância o significado simbólico de nossos órgãos, de comprometimento da fonte de nossa vida afetiva. O médico que sabe levar em conta estes aspectos psicológicos e culturais compreende melhor seus pacientes e pode exercer a medicina com melhor qualidade.

Palpitações

Podem ser definidas como a percepção incômoda dos batimentos cardíacos. Os pacientes as relatam com várias denominações: taquicardia, palpitações, “batecum”, falhas, disparos, arrancos, paradas, tremor no coração.

Devem ser analisadas quanto a frequência, ritmo, horário de surgimento, modo de instalação e término, fatores desencadeantes e sintomas associados; suas principais causas estão sumariadas no Quadro 6.13.

Quanto à frequência de aparecimento, podem ser ocasionais, episódicas ou paroxísticas, e permanentes. Ocasionais sugerem extrassístoles; as episódicas ou paroxísticas caracterizam-se por terem início e fim bem definidos, como nas crises de taquicardia e na fibrilação atrial paroxística. São chamadas permanentes quando o paciente não relata períodos de ausência de sintomas, como na fibrilação atrial crônica e na extrassístolia frequente.

Quanto ao ritmo, as palpitações podem ser de origem aleatória ou sempre ligadas a algum evento, como alimentação, decúbito ou uso de medicamentos; no que diz respeito ao horário, deve-se observar se guardam alguma relação com o ritmo circadiano.

As palpitações podem ter início e fim súbitos ou, apesar do início repentino, podem desaparecer gradualmente, de maneira quase imperceptível.

Quadro 6.13 Causas de palpitações (cardíacas e não cardíacas).	
Cardíacas	
Arritmias	
Insuficiência cardíaca	
Miocardites	
Miocardiopatias	
Não cardíacas	
Hipertensão arterial	
Hipertireoidismo	
Anemia	
Esforço físico	
Emoções	
Síndrome do pânico	

Fatores desencadeantes como o uso de café, chá, refrigerantes tipo “cola”, tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos e drogas ilícitas, exercícios físicos e emoções devem sempre ser pesquisados.

As palpitações podem acompanhar-se de outros sintomas como sudorese fria, tontura, dor precordial, dispneia e desmaio (síncope).

Cumprе salientar que a percepção incômoda dos batimentos cardíacos (palpitações) nem sempre significa alteração do ritmo cardíaco (arritmia). Pacientes com hipertireoidismo relatam palpitação, mas o ritmo cardíaco destes pacientes é regular, embora a frequência seja alta. Em contrapartida, pacientes com extrassístolia ventricular muito frequente ou com fibrilação atrial crônica, nos quais praticamente inexistem períodos com ritmo normal, raramente se queixam de palpitações.

Em relação à importância clínica do sintoma “palpitação”, interessa saber:

Se as palpitações são relacionadas com esforço físico

Se traduzem alteração do ritmo cardíaco

Se é um sintoma relacionado com alterações emocionais.

Palpitações aos esforços físicos surgem durante o exercício e desaparecem com o repouso. É necessário distinguir entre taquicardia fisiológica do exercício e outras causas de palpitação, quando a sensação de mal-estar e o aparecimento e intensidade da taquicardia parecem desproporcionais ao esforço realizado. (Os pacientes dizem: “A qualquer esforço que faço, o coração parece querer sair pela boca”.) Caracterizar também se as palpitações aparecem aos grandes, médios ou aos pequenos esforços. Nos pacientes com doença cardíaca podem ter o mesmo significado que a dispneia de esforço.

Boxe

Relato da palpitação

A maneira pela qual o paciente relata a palpitação pode permitir ao médico presumir o tipo de arritmia cardíaca. Sensação de “falhas, arrancos ou tremor” indica quase sempre a ocorrência de extrassístoles. “Disparo do coração” significa extrassístoles em salva ou paroxismos de taquicardia de curta duração. Palpitações de início e fim súbitos, bem caracterizados, sugerem taquicardia paroxística ou episódios de fibrilação atrial.

Palpitações constituem queixa frequente dos pacientes com problemas emocionais. A somatização de transtornos emocionais que terminam por envolver o aparelho circulatório deve sempre ser lembrada, considerando-se o significado simbólico do coração.

Pacientes sugestionáveis podem assumir queixas de parentes ou conhecidos, cardiopatas ou falecidos por doença cardíaca. As palpitações são relatadas frequentemente pelos pacientes com ansiedade e depressão.

Queixa de “palpitação”, “coração batendo forte”, “coração acelerado”, foi incluída como um dos critérios diagnósticos do *transtorno do pânico*.

O exame físico pode detectar alterações do ritmo e da frequência cardíaca coincidente com as queixas do paciente. O eletrocardiograma *standard* de 12 derivações é útil nas arritmias muito frequentes; já nas palpitações ocasionais ou paroxísticas, o eletrocardiograma de 24 h (Holter) é o método mais adequado para correta avaliação do paciente.

O teste ergométrico ou a simples observação do paciente após esforço físico (como subir escadas, por exemplo) pode ajudar a diagnosticar palpitação induzida pelo esforço.

Deve-se considerar a palpitação como sintoma de origem emocional somente após serem excluídas as causas orgânicas.

Dispneia

Na linguagem dos pacientes, a dispneia de origem cardíaca recebe a designação de “cansaço”, “canseira”, “falta de ar”, “fôlego curto”, “fadiga” ou “respiração difícil”. Não se deve esquecer de que é preciso diferenciá-la da *astenia* e da *fadiga*, pois algumas expressões usadas pelos pacientes podem causar confusão.

Boxe

A dispneia constitui um dos sintomas mais importantes dos cardiopatas e significa a sensação consciente e desagradável do ato de respirar. Apresenta-se sob duas formas – uma subjetiva, que é a dificuldade respiratória sentida pelo paciente, e a outra objetiva, que se evidencia pelo aprofundamento ou pela aceleração dos movimentos respiratórios e pela participação ativa da musculatura acessória da respiração (músculos do pescoço na inspiração e músculos abdominais na expiração).

A dispneia no cardiopata indica congestão pulmonar decorrente da insuficiência ventricular esquerda, apresentando características próprias quanto à *duração*, à *evolução*, à *relação com esforço* e à *posição adotada pelo paciente*, que permitem reconhecer os seguintes tipos: dispneia de esforço, dispneia de decúbito, dispneia paroxística e dispneia periódica ou de Cheyne-Stokes (Figuras 6.18 e 6.19).

A *dispneia aos esforços* é o tipo mais comum na insuficiência ventricular esquerda.

A análise da relação com esforços deve levar em conta, em primeiro lugar, as atividades habitualmente exercidas pelo paciente. Isso porque, para um trabalhador braçal, exercício pesado é algo diferente do que é entendido por uma pessoa de vida sedentária. Para um lactente, um grande esforço seria a amamentação.

De conformidade com o tipo de exercício, é classificada em *dispneia aos grandes, médios e pequenos esforços*. A diferença fundamental entre a dispneia de esforço de uma pessoa normal e a de um cardiopata está no grau de atividade física necessária para produzir a dificuldade respiratória. Assim, quando um cardiopata relata dispneia aos grandes esforços, isso significa que passou a ter dificuldade respiratória ao executar uma atividade anteriormente feita sem qualquer desconforto; por exemplo, escadas que eram galgadas sem problemas passam a provocar falta de ar, não consegue andar depressa, subir uma rampa, executar trabalhos costumeiros ou praticar um esporte para o qual estava treinado.

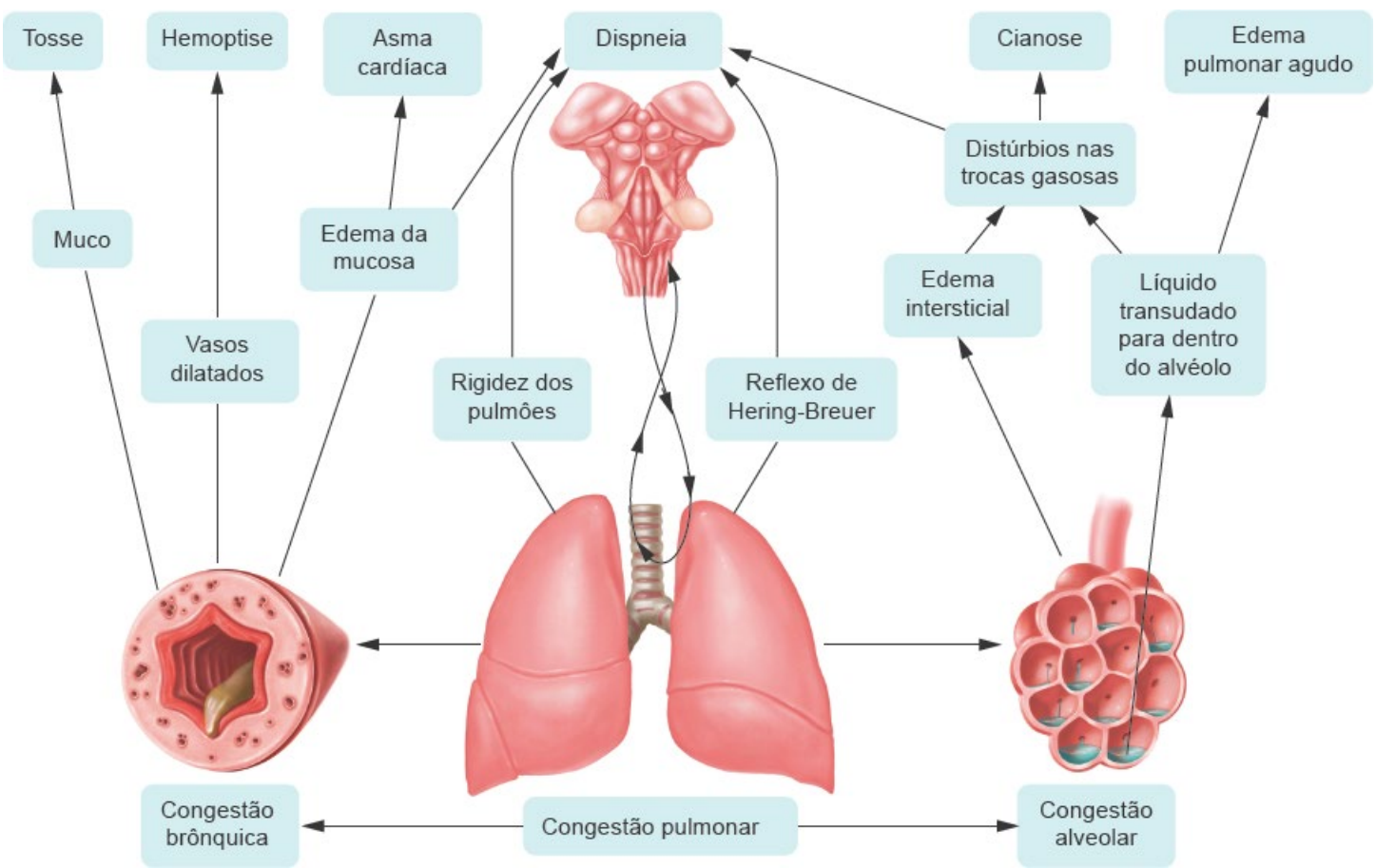


Figura 6.18 Mecanismos dos sinais e sintomas respiratórios na insuficiência cardíaca. (Adaptada de Rushmer.)

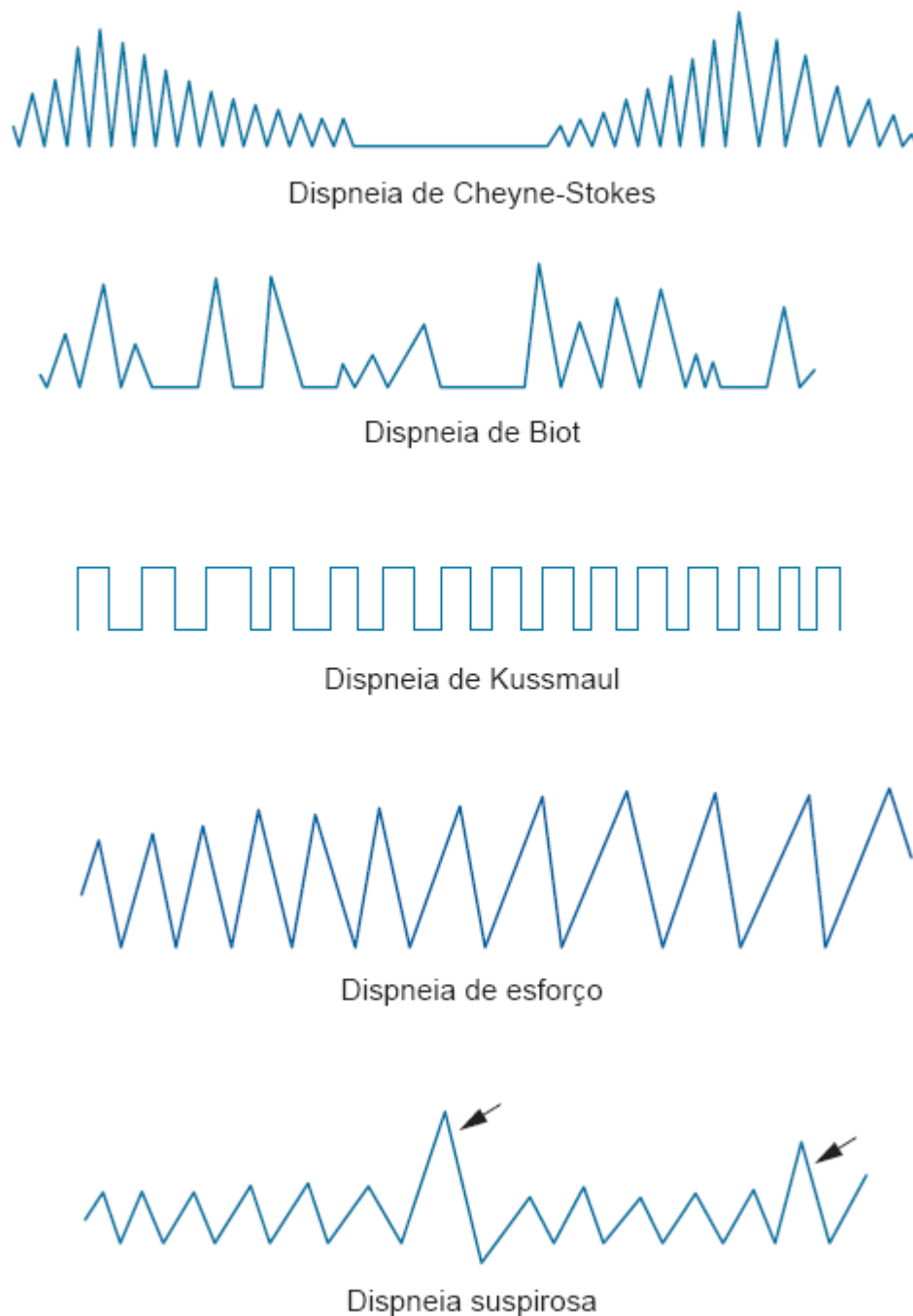


Figura 6.19 Representação esquemática dos vários tipos de dispnéia.

A dispnéia aos médios esforços é a que surge durante a realização de exercícios físicos de intensidade mediana, tais como andar em local plano a passo normal ou subir alguns degraus, mesmo devagar.

A dispnéia aos pequenos esforços é a que ocorre ao fazer exercícios leves, como tomar banho, trocar de roupa, mudar de posição na cama. Às vezes, a dispnéia é provocada por atividades que exigem mínimos esforços, como o ato de falar mais alto ou mais depressa.

A dispnéia de esforço da insuficiência ventricular esquerda caracteriza-se por ser de rápida progressão, passando dos grandes aos pequenos esforços em curto período de tempo (em dias ou semanas). Este modo de evolução a diferencia da dispnéia das enfermidades pulmonares e anemias, condições em que a falta de ar agrava-se lentamente (em meses ou anos) ou permanece estacionária por longo tempo.

A *dispnéia de decúbito* é a que surge quando o paciente se põe na posição deitada. Para aliviá-la, o paciente eleva a cabeça e o tórax, usando dois ou mais travesseiros, chegando a adotar, consciente ou inconscientemente, a posição semissentada para dormir; em fase mais avançada, quando a dispnéia se torna muito intensa, o paciente é forçado a sentar-se na beira do leito, com as pernas para fora, quase sempre fletindo a cabeça para a frente e segurando com as mãos as bordas do colchão para ajudar o trabalho da musculatura acessória da respiração – é o que se chama *ortopneia*. Explica-se a dispnéia de decúbito pelo aumento da congestão pulmonar em virtude do maior fluxo de sangue proveniente dos membros inferiores e da área esplâncnica. Este tipo de dispnéia se origina tão logo o paciente se deita, particularidade que permite diferenciá-la da dispnéia paroxística.

A *dispneia paroxística* ocorre com mais frequência à noite, justificando, por isso, a clássica denominação de *dispneia paroxística noturna*. Sua característica principal consiste no fato de o paciente poder dormir algumas horas, após o que acorda com intensa falta de ar, acompanhada de sufocação, tosse seca e opressão torácica, que o obriga a sentar-se na beira da cama ou levantar-se e encaminhar-se até uma janela aberta para respirar. Durante a crise dispneica pode haver broncospasmo, responsável pelo aparecimento de chieira cuja causa é a congestão da mucosa brônquica. Nessas condições recebe a denominação de *asma cardíaca* (Figura 6.18).

Nas crises mais graves, além da intensa dispneia, surge tosse com expectoração espumosa, branca ou rósea, cianose, respiração ruidosa pela presença de sibilos e estertores finos. Este conjunto de sintomas caracteriza o *edema agudo do pulmão*, a condição mais grave da congestão pulmonar, que põe em risco a vida do paciente (Figura 6.18).

Os pacientes que apresentam falência ventricular esquerda aguda, consequência de crise hipertensiva ou de infarto do miocárdio, ou que têm uma obstrução da via de entrada do ventrículo esquerdo – estenose mitral – são os mais propensos a desenvolverem o quadro de edema agudo do pulmão.

Isso ocorre em consequência do aumento da pressão do átrio esquerdo, transmitida às veias pulmonares, tal como em um sistema de vasos comunicantes, que redundam em rápido aumento da pressão no leito capilar dos pulmões. Após determinado nível pressórico pode haver transudação de líquido para dentro dos alvéolos. Se isso ocorre abruptamente, desencadeia o quadro de edema agudo do pulmão.

A *dispneia periódica* ou de *Cheyne-Stokes* caracteriza-se por períodos de apneia, seguidos de movimentos respiratórios, a princípio superficiais, mas que se vão tornando cada vez mais profundos até chegar a um máximo, após o qual vão diminuindo paulatinamente de amplitude até uma nova fase de apneia; e assim sucessivamente. As pausas de apneia têm uma duração variável de 10 a 30 s, podendo atingir até 60 s. Nesses casos, o paciente pode entrar em estado de torpor, tornar-se sonolento ou inconsciente, e as pupilas se contraírem (miose), podendo surgir cianose ao término da fase de apneia. Ao terminar a fase apneica, o paciente recupera-se parcialmente (Figura 6.19).

A dispneia periódica surge não só nos portadores de enfermidades cardiovasculares, em especial a hipertensão arterial e a cardiopatia isquêmica, mas, também, em pacientes com afecções do tronco cerebrospinal, hipertensão intracraniana, hemorragia cerebral, uremia, intoxicação por barbitúricos ou opiáceos.

Lactentes e idosos podem apresentar, durante o sono, este tipo de respiração, mas sem atingir a intensidade apresentada pelos pacientes com cardiopatia ou encefalopatia. Nessas condições, não implica doença.

O mecanismo da respiração periódica é o seguinte: durante a fase de apneia ocorre uma gradativa diminuição da tensão de O_2 e um aumento da tensão de CO_2 . A tensão elevada de CO_2 estimula o centro respiratório, de maneira súbita e enérgica, produzindo a hiperpneia, a qual, por sua vez, determina queda progressiva no nível de CO_2 e aumento da oxigenação arterial, até chegar a um nível insuficiente para estimular o centro respiratório, o qual deixa de gerar os estímulos responsáveis pelos movimentos respiratórios. Isso dura determinado período de tempo até que se alterem novamente os níveis de CO_2 no sangue; e assim sucessivamente.

Em todos os tipos de dispneia decorrente de insuficiência ventricular esquerda há elevação da pressão no leito vascular pulmonar, secundária ao aumento de pressão no átrio esquerdo. É a pressão elevada nos capilares pulmonares o fator responsável pela transudação de líquido para o espaço intersticial, resultando na congestão pulmonar. A congestão pulmonar, portanto, é a causa básica da dispneia dos cardiopatas (Figura 6.18).

Considerando que os pulmões se situam em uma cavidade circunscrita por paredes osteomusculares com capacidade limitada de expansão, é fácil compreender que o aumento de líquido nos pulmões determina redução do seu conteúdo aéreo, da capacidade pulmonar total e da capacidade vital.

Além disso, a congestão pulmonar provoca rigidez do parênquima pulmonar com diminuição de sua expansibilidade, o que constitui outro importante fator na fisiopatologia da dispneia cardíaca.

Cumprе ressaltar, ainda, que o edema intersticial e a congestão pulmonar crônica vão estimular a proliferação do tecido conjuntivo, diminuindo a expansibilidade pulmonar. A diminuição da expansibilidade pulmonar, por sua vez, exige maior esforço respiratório com redução da reserva ventilatória, tanto a expiratória como a inspiratória.

Há que notar, finalmente, que o edema intersticial e a fibrose difusa decorrente da congestão crônica dificultam progressivamente a difusão dos gases no nível da membrana alveolocapilar.

À dispneia dos cardíacos costuma estar associada a taquipneia, em consequência da diminuição da expansibilidade pulmonar e da exacerbação do reflexo de Hering-Breuer, em virtude de impulsos aferentes vagais originados no parênquima pulmonar congesto.

A todos estes fatores, soma-se, ainda, o trabalho exagerado da musculatura respiratória com maior consumo de oxigênio.

Intolerância aos esforços

A dispneia e a intolerância aos esforços ocorrem juntas com grande frequência, mas não são sintomas exatamente iguais. Seus mecanismos fisiopatológicos apresentam algumas diferenças significativas. A dispneia depende basicamente da congestão pulmonar, enquanto a intolerância aos esforços se relaciona diretamente com a disfunção miocárdica e, em particular, com a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo.

Tosse e expectoração

A tosse é um sintoma frequente na insuficiência ventricular esquerda, constituindo um mecanismo de valor na manutenção da permeabilidade da árvore traqueobrônquica quando há aumento de secreções. Caracteriza-se por ser seca, mais intensa à noite, podendo ser muito incômoda, impedindo o paciente de dormir. Pode estar relacionada com os esforços físicos, como a dispneia e a palpitação.

Sua causa também é a congestão pulmonar; por isso, ela quase sempre está associada à dispneia (Figura 6.18).

Quando existe expectoração, ela é escassa, do tipo seroso, de pouca consistência, contém ar e é rica em albumina, o que lhe confere aspecto espumoso.

No edema pulmonar agudo, o líquido que inunda os alvéolos não é formado unicamente por plasma, pois contém hemácias; aí, então, a expectoração adquire aspecto róseo ou francamente hemoptoico (Figura 6.18).

A congestão pulmonar facilita a instalação de infecção bacteriana, e, quando isso ocorre, a expectoração torna-se mucopurulenta, de cor amarelada ou esverdeada, a indicar a instalação de bronquite ou broncopneumonia, complicando a congestão pulmonar.

A expectoração sanguinolenta nos pacientes cardíacos pode decorrer dos seguintes mecanismos: passagem de eritrócitos de vasos pulmonares congestos para os alvéolos, como ocorre no edema pulmonar agudo; ruptura de vasos endobrônquicos dilatados, que fazem conexão entre a circulação venosa brônquica e a pulmonar, como acontece na estenose mitral e necrose hemorrágica do parênquima nos casos de infarto pulmonar.

Nos aneurismas da aorta, na pericardite e quando há grande dilatação do átrio esquerdo, podem ocorrer acessos de tosse por compressão brônquica, irritação do vago ou do nervo recorrente (ver *Diafragma e mediastino*, neste capítulo).

Chieira

Chieira, chiado ou sibilância significa o aparecimento de um ruído sibilante junto com a respiração, quase sempre difícil. Este chiado traduz a passagem de ar, em alta velocidade, através de bronquíolos estreitados.

O sibilo é um som musical, contínuo, prolongado, predominantemente expiratório, mas que pode aparecer também na inspiração. Os sibilos são mais frequentes na asma brônquica e na bronquite crônica. Contudo, podem ser auscultados na dispneia paroxística noturna e na asma cardíaca, quando a congestão pulmonar se acompanha de broncospasmo e edema da mucosa bronquiolar (Figura 6.18). Também são comuns nos lactentes portadores de cardiopatias congênitas acianogênicas com hiperfluxo pulmonar.

Boxe

Asma brônquica e asma cardíaca

O aparecimento de chieira e sibilos nos obriga a distinguir entre *asma brônquica* e *asma cardíaca*, para o que se conta com os seguintes dados: a asma cardíaca costuma surgir na posição deitada e melhora quando o paciente se senta ou fica de pé; acompanha-se de taquicardia, ritmo de galope e estertores finos nas bases pulmonares; na asma brônquica a dispneia não é aliviada pela mudança de posição, os sibilos são disseminados e predominam sobre os estertores. Caso persistam dúvidas, a radiografia simples do tórax e a ultrassonografia pulmonar são recursos de grande valor, pois permitem evidenciar a congestão pulmonar, que é o substrato anatomopatológico principal da asma cardíaca, enquanto na asma brônquica o que se encontra é hiperinsuflação pulmonar.

Hemoptise e expectoração hemoptoica

Hemoptise é a eliminação de sangue puro procedente da traqueia, brônquios ou pulmões.

O sangue é eliminado pela tosse e é vermelho-vivo e arejado.

Expectoração hemoptoica significa a presença de sangue junto com secreção (serosa, mucosa ou mucopurulenta).

A hemoptise deve ser diferenciada das hemorragias provenientes do nariz (epistaxe), das gengivas (estomatorragia) e do trato gastrointestinal (hematêmese). A hematêmese pode ser em forma de sangue vivo, como ocorre nas varizes esofágicas, úlcera péptica, lesões agudas da mucosa gastroduodenal e neoplasias, ou como sangue coagulado, “digerido”, que é de cor escura, podendo ter aspecto de “borra de café”.

A hemoptise e a expectoração hemoptoica podem ocorrer nas doenças broncopulmonares e cardíacas, mas suas características semiológicas permitem esclarecer sua origem. Assim, quando a hemoptise é acompanhada de expectoração espumosa e rósea, a causa é edema pulmonar agudo por insuficiência ventricular esquerda (Figura 6.18); expectoração hemoptoica “cor de tijolo” indica pneumonia pneumocócica; raia de sangue recobrimdo grumos de muco ocorrem nas bronquites e nas hemorragias dos tumores endobronquiais; sangue escuro, misturado com expectoração mucosa, com o aspecto de geleia de framboesa, observa-se no infarto pulmonar e na pneumonia necrosante; hemoptise volumosa com sangue vivo, brilhante, rutilante, indica ruptura dos vasos brônquicos, devendo-se pensar em estenose mitral, bronquiectasias, tuberculose pulmonar e carcinoma brônquico.

Desmaio (síncope e lipotimia)

Desmaio é a perda súbita e transitória da consciência (*síncope*) decorrente de perfusão cerebral inadequada. Nem sempre, contudo, o desmaio ocorre em sua forma completa, podendo ser parcial a perda da consciência (*pré-síncope* ou *lipotimia*).

Pode ser de origem psicogênica (impactos emocionais, medo intenso) ou por redução aguda – mas transitória – do fluxo sanguíneo cerebral.

Quase sempre o quadro evolui rapidamente para a recuperação da consciência, pois, se não houver melhora da perfusão cerebral, sobrevirá a morte em curto período de tempo.

As causas de desmaio estão sintetizadas no Quadro 6.14.

A investigação diagnóstica de um paciente que teve desmaio compreende a análise do episódio em si – tempo de duração, ocorrência ou não de convulsão, incontinência fecal ou urinária, mordedura da língua, sudorese e palidez –, bem como dos sintomas que precedem o desmaio e as manifestações surgidas após a recuperação da consciência. É necessário também investigar as condições gerais do paciente, o tempo decorrido desde a última alimentação, o grau de tensão emocional, a posição do indivíduo no momento da crise, a execução de esforço físico ou mudança súbita na posição do corpo, a temperatura ambiente, doenças recentes ou prévias.

Entre as manifestações que podem preceder o desmaio destacam-se as palpitações, a dor anginosa, auras, paresias, parestesias, incoordenação, vertigem ou movimentos involuntários.

Na maioria das vezes o episódio sincopal se inicia com a sensação de fraqueza, tontura, sudorese, palidez; outras vezes ocorre subitamente sem manifestações prodrômicas.

Na síncope a pressão arterial baixa de modo rápido e intenso, a frequência cardíaca diminui e a respiração torna-se superficial e irregular.

No período pós-sincopal, costuma haver confusão mental, cefaleia, tonturas, mal-estar, mas o paciente pode recuperar a consciência sem sentir praticamente nada.

Quadro 6.14 Causas de desmaio.

Causas cardíacas (diminuição do fluxo sanguíneo cerebral)

- Arritmias
 - Bradiarritmias (bloqueio atrioventricular)
 - Taquiarritmias (taquicardia paroxística e fibrilação atrial paroxística)
- Diminuição do débito cardíaco
 - Insuficiência cardíaca aguda (infarto do miocárdio)

Obstrução do fluxo sanguíneo pulmonar

Tetralogia de Fallot

Estenose aórtica

Miocardiopatia hipertrófica

Embolia pulmonar

Hipertensão pulmonar primária

Síndrome de Eisenmenger

- Diminuição mecânica do retorno venoso

Mixoma atrial

Trombose de prótese valvar cardíaca

- Diminuição do volume sanguíneo

Causas extracardíacas

- Hipotensão postural

- Metabólicas

Hipoglicemia

Alcalose respiratória por hiperventilação

- Neurogênicas

Síndrome do seio carotídeo

Síncope pós-micção

Síncope pós-tosse

Neuralgia glossofaríngea

- Obstrução extracardíaca do fluxo de sangue

Trombose carotídea

Compressão torácica

Tamponamento cardíaco

Manobra de Valsalva

- Síncope psicogênica ou vagal (desmaio comum)
- Desmaio histérico devido ao transtorno de conversão

Causas cardíacas

As alterações na origem ou na condução do estímulo podem causar síncope quando há bradicardia com frequência inferior a 40 bpm ou taquicardia com frequência acima de 180 bpm. Batimentos ectópicos (extrassístoles em salva) também podem acompanhar-se de perda parcial da consciência.

Um dado clínico que merece realce é o relato de palpitações imediatamente antes do desmaio.

Boxe

Síndrome de Stokes-Adams

A síncope da bradicardia pode adquirir as características da *síndrome de Stokes-Adams*, na qual se observa perda da consciência, acompanhada de convulsões ou não. A síndrome de Stokes-Adams é mais frequente nos portadores de cardiopatia chagásica crônica e no infarto agudo do miocárdio com bloqueio atrioventricular total.

A síndrome costuma iniciar com tonturas e escurecimento visual, sobrevivendo logo a seguir perda da consciência, com convulsões ou não, eliminação involuntária de fezes e urina, podendo haver parada cardiorrespiratória. A função circulatória se recupera em pouco tempo, mas, caso contrário, a morte ocorre em seguida.

A sequência cronológica dos eventos na síndrome de Stokes-Adams costuma ser assim: 2 a 5 s após a ocorrência da arritmia surge o escurecimento visual com tontura; 10 a 15 s após ocorre a perda da consciência. Se a parada cardíaca durar mais de 1 min, ocorre parada respiratória, sobrevivendo a morte em 1 a 3 min após o início do quadro.

As taquiarritmias (fibrilação atrial e taquicardia paroxística), ao diminuir o fluxo cerebral, causam isquemia cerebral manifestada por tonturas, lipotimia, paralisias focais e transitórias e confusão mental.

Excepcionalmente, a insuficiência cardíaca é capaz de reduzir o fluxo sanguíneo cerebral a ponto de produzir sintomas cerebrais. Isto pode ocorrer na insuficiência ventricular esquerda aguda após infarto agudo do miocárdio e nos casos de insuficiência cardíaca grave. A perda da consciência pode ser resultado também da obstrução súbita de um orifício valvar por mixoma de átrio esquerdo, trombose de uma prótese valvar, embolia pulmonar ou hipertensão pulmonar muito intensa.

Na crise hipertensiva grave e na hipotensão postural pode ocorrer desmaio, especialmente quando a elevação ou a queda dos níveis tensionais se faz bruscamente.

Anoxia cerebral pode ser observada mesmo quando o fluxo cerebral é normal, bastando que a saturação de O₂ no sangue seja baixa. É o que ocorre, por exemplo, na tetralogia de Fallot, cardiopatia congênita na qual a redução do fluxo pulmonar, a mistura do sangue entre os ventrículos e a entrada de sangue venoso na aorta dextroposta reduzem intensamente o conteúdo de oxigênio no sangue que vai para os órgãos. A anoxia é desencadeada por exercícios por haver aumento da desoxigenação periférica.

Na estenose aórtica a perda da consciência é decorrente de um baixo débito cardíaco e desvio do sangue para os músculos esqueléticos. Nesses casos a síncope frequentemente está relacionada com exercício físico.

Causas extracardíacas

Incluem a síncope psicogênica, a hipotensão postural, a síndrome do seio carotídeo, a síncope pós-tosse e pós-micção, a alcalose respiratória por hiperventilação e a hipoglicemia.

A *síncope psicogênica* ou *vagal* é o tipo mais comum de desmaio (*desmaio comum*), podendo ser desencadeada por impacto emocional, visão de sangue, dor intensa, lugar fechado, ambiente quente. Uma de suas principais características é a rápida recuperação ao se colocar o paciente deitado. Em geral, dura poucos segundos e raramente prolonga-se por alguns minutos; nesses casos, não há risco de vida.

A perda da consciência pode ocorrer abruptamente ou ser precedida de sensação de mal-estar geral, fraqueza, tontura, palidez, sudorese, bocejos, desconforto abdominal ou náuseas. O pulso pode tornar-se rápido e a pressão arterial elevada, baixando gradativamente, sem chegar a níveis abaixo do normal.

Admite-se que o mecanismo básico da síncope psicogênica seja o desvio brusco do sangue para os músculos, em consequência de rápida queda da resistência periférica por vasodilatação. Do ponto de vista neurovegetativo, há inibição generalizada do tônus simpático, com aumento relativo da atividade vagal, daí a designação de síncope vasovagal.

A *hipotensão postural* e a *síncope por disfunção neurocardiogênica* caracterizam-se por rápida redução da pressão arterial quando o paciente se levanta do leito e adota a posição de pé. Pode ocorrer em indivíduos normais que permanecem de pé durante muito tempo, em uma posição fixa (desmaio de soldados e colegiais em dias de solenidades). A hipotensão pode ser observada após exercícios físicos exaustivos, inanição, enfermidades prolongadas, desequilíbrio hidreletrolítico com perda de água e depleção de sódio e potássio e volumosas varizes nos membros inferiores. Atualmente, uma causa frequente de hipotensão postural é o uso de medicamentos anti-hipertensivos, principalmente os diuréticos e os bloqueadores simpáticos e vasodilatadores. Por isso, todo paciente em tratamento de hipertensão arterial deve ter sua pressão medida na posição deitada e de pé (ver Capítulo 14, *Exame de Pressão Arterial*.)

Há um tipo especial de hipotensão postural cuja característica é ter caráter crônico e recidivante, podendo ser primária (idiopática) ou associada a várias doenças, incluindo insuficiência suprarrenal, diabetes, síndrome de má absorção, insuficiência cardíaca grave, pericardite constrictiva e estenose aórtica. O quadro clínico é constituído por uma tríade: anidrose, disfunção erétil e hipotensão ortostática. É mais frequente em homens de 40 a 70 anos de idade.

A falta de suor (anidrose) pode ser parcial (em partes do corpo) ou total (no corpo todo). Nictúria e incontinência urinária acompanham a impotência sexual. Este tipo de hipotensão postural é devido a um transtorno da inervação simpática.

A *síndrome do seio carotídeo* caracteriza-se por queda da pressão arterial e acentuada bradicardia após estimulação do seio carotídeo. Clinicamente, o paciente apresenta tonturas, “escurecimento visual”, cefaleia e desmaio. É mais frequente em pacientes idosos.

A *síncope pós-tosse* ocorre em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Sua causa seria o aumento da pressão intratorácica com redução do retorno venoso e do débito cardíaco. Elevação da pressão do liquor com diminuição da perfusão cerebral é considerada outro fator.

Na *síncope pós-micção*, a vasodilatação pode provocar hipotensão súbita e colapso durante ou depois de urinar, logo após o paciente levantar-se de decúbito prolongado. Tem sido observado que este tipo de síncope ocorre com mais frequência após exagerada ingestão de bebida alcoólica.

A *hipoglicemia* pode causar desmaio em diabéticos que receberam dose de insulina ou hipoglicemiante acima das necessidades, em portadores de tumores de células insulares (insulinoma), de cirrose hepática, hepatocarcinoma e da doença de Addison.

A hipoglicemia funcional por jejum prolongado raramente causa perda de consciência, manifestando-se por palpitações, sudorese fria, tonturas, confusão mental e comportamento anormal. Quando o intervalo entre as refeições é muito longo, mesmo os indivíduos saudáveis podem apresentar fraqueza e tremores, por hipoglicemia.

Hiperventilação com alcalose respiratória ocorre principalmente em mulheres jovens, tensas e ansiosas. Os sintomas são dormência nas extremidades e em torno da boca, confusão mental e, às vezes, tetania. O mecanismo da síncope por hiperventilação é a redução do fluxo sanguíneo cerebral por aumento do fluxo sanguíneo periférico, no território esplâncnico e muscular, em razão de uma vasodilatação, resultando em hipotensão.

O *desmaio histérico* é um tipo de transtorno de conversão que expressa por linguagem corporal uma situação inaceitável para a pessoa. Em geral, há queda ao solo, acompanhada de movimentos bizarros, porém sem ferimentos, o que o diferencia das crises convulsivas epiléticas.

Alterações do sono

A insônia é um sintoma frequente em pacientes com insuficiência ventricular esquerda, chegando a constituir um indicador de congestão pulmonar em pacientes que não fazem esforço físico e, portanto, não se queixam de dispneia (principalmente idosos). Nos pacientes com dispneia de Cheyne-Stokes, pode haver dificuldade para dormir justamente porque este tipo de dispneia predomina ou se acentua no período noturno.

A causa da insônia é a estase sanguínea encefálica, com edema cerebral e hipertensão do líquido cefalorraquidiano, além de

anoxia dos neurônios cerebrais, relacionada com a diminuição do débito cardíaco.

Sono inquieto e pesadelos também podem ser observados na insuficiência ventricular esquerda.

Cianose

Cianose significa coloração azulada da pele e das mucosas, em razão do aumento da hemoglobina reduzida (desoxigenada) no sangue capilar, ultrapassando 5 g por 100 ml. A quantidade normal de hemoglobina reduzida é de 2,6 g. É óbvio, portanto, que os pacientes intensamente anêmicos nunca apresentam cianose, porque não haveria hemoglobina reduzida suficiente para isso. Em contrapartida, em pacientes com policitemia pode ocorrer cianose com hipoxemia leve.

Em idosos, cianose periférica pode surgir mesmo com diminuição leve do débito cardíaco ou da pressão arterial sistêmica.

O grau e a tonalidade da coloração cianótica podem ser variáveis. Em alguns pacientes, somente as mucosas tornam-se levemente azuladas, sem mudança na cor da pele; em outros, a cor dos tegumentos pode ser azul-clara ou arroxeada. Na cianose grave a pele é arroxeada e as mucosas, quase negras.

O exame do paciente deve ser feito de preferência sob luz natural ou sob foco luminoso forte, observando-se os lábios, a ponta do nariz, a região malar (bochechas), os lóbulos das orelhas, a língua, o palato, as extremidades das mãos e dos pés. Luz artificial fraca impede o reconhecimento de cianose leve.

A inspeção deve ser feita nos lugares em que a pele é mais fina e em áreas ricas de capilares sanguíneos. Nos casos de cianose intensa, todo o tegumento cutâneo adquire tonalidade azulada ou mesmo arroxeada. Quando é discreta, restringe-se a determinadas regiões.

A pigmentação e a espessura da pele modificam o aspecto da cianose, podendo mascarar-la completamente. A impregnação da pele por bilirrubina (icterícia) também dificulta o reconhecimento da cianose.

Deve-se esclarecer se a cianose surgiu no nascimento, como na tetralogia de Fallot, ou após anos de evolução da cardiopatia, e se ela aparece ou piora após esforço físico.

Importa saber se se trata de *cianose generalizada ou segmentar* porque o raciocínio clínico é completamente diferente em uma situação e outra.

A cianose é generalizada quando presente no corpo todo e localizada ou segmentar quando se restringe a determinados segmentos corporais, ou seja, apenas o segmento cefálico, um dos membros superiores ou um dos membros inferiores.

Os pacientes cianóticos podem apresentar outros sintomas decorrentes da anoxia tissular, tais como irritabilidade, sonolência, torpor, crises convulsivas, angina do peito, hipocratismo digital, nanismo ou infantilismo.

Quanto à intensidade, a cianose é classificada em leve, moderada e grave.

No exame do paciente cianótico, determinadas características semiológicas são importantes para o raciocínio diagnóstico, destacando-se as que se seguem:

Na história clínica é relevante a duração da cianose. Se ela existir desde o nascimento, leva-nos a pensar que seja devida a uma doença cardíaca congênita

Existência ou não de hipocratismo digital, ou seja, deformidade dos dedos que se tornam globosos, lembrando a forma de baqueta de tambor com unhas convexas em todos os sentidos, como vidro de relógio.

A combinação de cianose com baqueteamento é frequente em pacientes com alguns tipos de cardiopatia congênita e nas doenças pulmonares (fibrose pulmonar, bronquiectasia, enfisema pulmonar, câncer broncogênico, fístula arteriovenosa pulmonar).

Quanto à fisiopatologia, há quatro tipos de cianose: central, periférica, mista e por alterações da hemoglobina.

A *cianose do tipo central* é a mais frequente, podendo ocorrer nas seguintes condições:

Diminuição da tensão de O₂ no ar inspirado, como ocorre nas grandes altitudes

Distúrbio da ventilação pulmonar, incluindo obstrução das vias respiratórias por neoplasia ou corpo estranho, aumento da resistência nas vias respiratórias, como ocorre na bronquite crônica grave, no enfisema pulmonar avançado e na asma brônquica; paralisia dos músculos respiratórios (fármacos bloqueadores neuromusculares, miastenia *gravis*, poliomielite); depressão do centro respiratório (atribuída a medicamentos depressores centrais); respiração superficial para evitar dor (pleurites); atelectasia pulmonar (hidrotórax, pneumotórax)

Distúrbio da difusão, por aumento da espessura da membrana alveolocapilar, infecções como se observa nas broncopneumonias e bronquites, fibrose pulmonar e congestão pulmonar

Distúrbios na perfusão em consequência de cardiopatia congênita, grave insuficiência ventricular direita, embolia pulmonar ou destruição da árvore vascular pulmonar

Curto-circuito ou *shunt* de sangue da direita para a esquerda, como se observa na tetralogia de Fallot, tronco comum, síndrome de Eisenmenger, transposição dos grandes vasos, atresia tricúspide, comunicação interatrial e interventricular com hipertensão pulmonar, fistulas vasculares pulmonares.

A *cianose do tipo periférico* ocorre em consequência da perda exagerada de oxigênio no nível da rede capilar por estase venosa ou diminuição, funcional ou orgânica, do calibre dos vasos da microcirculação. Este tipo de cianose ocorre em áreas distais, principalmente nos membros inferiores, e sempre se acompanha de pele fria.

A causa mais comum de cianose periférica é a vasoconstrição generalizada devida à exposição ao ar ou à água fria.

Pode acontecer, também, na insuficiência cardíaca congestiva grave (a estase venosa periférica retarda a circulação nos capilares que se encontram dilatados), no colapso periférico com diminuição do volume-minuto, ou pode depender de obstáculo na circulação de retorno, como ocorre na flebite ou na flebotrombose. Se o obstáculo estiver no mediastino (compressão mediastínica), haverá cianose no rosto, pescoço, braços e parte superior do tórax.

A cianose por distúrbios vasomotores ocorre na doença de Raynaud e na acrocianose (ver *Microcirculação*, neste capítulo).

A *cianose do tipo misto* é assim chamada porque se associam os mecanismos da cianose do tipo central com os do tipo periférico; exemplo típico é a cianose da insuficiência cardíaca congestiva grave, na qual, além da congestão pulmonar que impede uma oxigenação adequada do sangue, há estase venosa periférica com grande perda de oxigenação (mecanismo periférico).

A diferenciação entre cianose do tipo central e do tipo periférico pode apresentar dificuldade. A aplicação de bolsa de água quente e a elevação do membro cianótico podem fazer desaparecer a cianose periférica. A cianose central diminui ou desaparece com a inalação de O₂.

A *cianose por alteração da hemoglobina* deve-se a modificações químicas que impedem a fixação do oxigênio por este pigmento. Assim, a metemoglobina ou sulfemoglobina dificulta a oxigenação porque estes derivados da hemoglobina não são facilmente dissociáveis, pela perda de sua afinidade pelo oxigênio. Produzem uma coloração azul-acinzentada. A metemoglobina produz cianose quando atinge no sangue 20% da hemoglobina total. Esta alteração surge pela inalação ou ingestão de substâncias tóxicas que contenham nitritos, fenacetina, sulfanilamida, anilinas.

Boxe

Cianose e oximetria de pulso

A oximetria de pulso, que está se tornando de uso rotineiro, é mais sensível do que a observação de cianose para detectar insaturação de O₂. Daí sua importância para monitorar pacientes com doenças que podem se acompanhar de insaturação de O₂ arterial.

Edema

As expressões “inchaço” e “inchume” são as mais usadas pelos pacientes para relatar este sintoma. Convém lembrar que tais expressões são usadas também com significado de crescimento ou distensão do abdome (“inchaço na boca do estômago”, por exemplo).

O edema é resultante de aumento do líquido intersticial, proveniente do plasma sanguíneo. Embora possa haver edema intracelular, do ponto de vista semiológico, a expressão se refere ao extracelular ou intersticial.

Boxe

Cumprе salientar que o peso corporal pode aumentar até 10% do total, sem que apareçam sinais evidentes de edema. Aliás, aumento brusco do peso corporal permite suspeitar de retenção líquida, antes de o edema tornar-se clinicamente detectável.

No edema cardíaco, o acúmulo de líquido não se restringe ao tecido subcutâneo, podendo acumular-se, também, nas cavidades serosas, seja no abdome (ascite), no tórax (hidrotórax), no pericárdio (hidropericárdio) e na bolsa escrotal (hidrocele).

A pele da região edemaciada torna-se lisa e brilhante quando o edema é recente; mas, se for de longa duração, ela adquire o aspecto de “casca de laranja”, consequência de seu espessamento, com retrações puntiformes, correspondentes aos folículos pilosos.

Localiza-se primeiramente nos membros inferiores, pela ação da gravidade, iniciando-se em torno dos maléolos. À medida que progride, atinge as pernas e as coxas. Quando alcança a raiz dos membros inferiores, deve-se pensar na possibilidade de outra doença associada, como, por exemplo, varizes ou trombose venosa em uma das pernas.

Por influência da gravidade, o edema cardíaco aumenta com o decorrer do dia, atingindo máxima intensidade à tarde; daí a denominação de edema vespertino, diminuindo ou desaparecendo com o repouso noturno.

Com o agravamento da disfunção cardíaca o edema atinge o corpo todo, inclusive o rosto, quando recebe a denominação *anasarca*.

Nos pacientes que permanecem acamados ou em lactentes, o edema localiza-se predominantemente nas regiões sacral, glútea, perineal e parede abdominal.

Quando o edema é de origem cardíaca, encontram-se os outros sinais de insuficiência ventricular direita, ou seja, ingurgitamento das jugulares, hepatomegalia e refluxo hepatojugular; isso é importante no diagnóstico diferencial.

Nos casos em que há lesão da valva tricúspide e na pericardite constritiva, a ascite predomina sobre o edema das extremidades.

A fisiopatologia do edema cardíaco, como dos outros edemas, apresenta ainda aspectos não esclarecidos, embora se saiba que os mecanismos principais envolvem o equilíbrio que regula o intercâmbio de líquido, em nível capilar, entre o compartimento intravascular e o intersticial.

Como se sabe, cinco são os fatores fundamentais que regulam este equilíbrio: o primeiro é a *pressão hidrostática*, que tende a expulsar água e eletrólitos para fora do lúmen capilar; o segundo é a *pressão oncótica* das proteínas circulantes, que se opõe à pressão hidrostática e que determina a retenção de líquidos no interior do lúmen vascular; constitui o terceiro fator a *permeabilidade capilar*, a qual se comporta como membrana semipermeável, ou seja, permeável à água e aos eletrólitos e impermeável às proteínas; o *fluxo linfático* e a *osmolaridade intra e extravascular* também participam desse equilíbrio (ver *Edema* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

Na extremidade arterial do capilar, a pressão hidrostática é maior que a pressão oncótica, de modo que o líquido intravascular passa para o espaço intersticial; em contrapartida, na extremidade venosa do capilar, sendo a pressão hidrostática menor que a pressão oncótica, ocorre reabsorção de líquido intersticial para o intravascular.

Este delicado balanço de forças faz com que haja permanente circulação de líquido do tecido intersticial em torno dos capilares, desde a extremidade arterial até a extremidade venosa.

Na insuficiência cardíaca direita, a elevação da pressão hidrostática nos capilares venosos constitui um dos fatores que aumentam a passagem de água para o interstício, no qual vai acumular-se.

Outro fator seria o aumento de produção de aldosterona, hormônio que regula a retenção de sódio e a eliminação de potássio. O aumento de pressão venosa nos rins e a diminuição da volemia, consequência da fuga de líquido do compartimento intravascular para o intersticial, constituem os estímulos para o aumento da secreção de aldosterona. Na regulação desses fenômenos participam os “receptores de volume”, disseminados por toda a árvore arterial para defender o organismo exatamente contra a diminuição do volume sanguíneo. A aldosterona provoca retenção ativa de sódio pelos rins. O sódio aumenta a pressão osmótica intravascular à qual são sensíveis os osmorreceptores hipotalâmicos, que, por sua vez, provocam a produção de hormônio antidiurético, responsável pela retenção de água pelos rins para restabelecer o volume sanguíneo circulante.

Desse modo, ao lado da elevação da pressão hidrostática, tem papel importante na formação do edema cardíaco a retenção de sódio. Na verdade, o edema da insuficiência cardíaca é um mecanismo de defesa de que o organismo dispõe para garantir uma adequada perfusão dos tecidos. As alterações dinâmicas que dão início à formação do edema, à medida que a retenção de líquido aumenta, desencadeiam outras modificações do equilíbrio hidreletrolítico que culminam em um círculo vicioso que tende a aumentar cada vez mais o edema.

É necessário diferenciar o edema de origem cardíaca do postural, da obesidade, da insuficiência venosa, do renal, do medicamentoso e da hipoproteïnemia.

Boxe

Insuficiência ventricular direita

O edema de origem cardíaca faz parte da tríade indicativa de insuficiência ventricular direita: edema, hepatomegalia dolorosa e ingurgitamento jugular.

Astenia ou fraqueza

Está presente na maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio.

Na insuficiência cardíaca, a astenia se deve principalmente à diminuição do débito cardíaco, responsável pela má oxigenação dos músculos esqueléticos.

Já nos pacientes que estiveram em anasarca e apresentaram diurese abundante pela administração de diurético, a redução do volume sanguíneo pode causar hipotensão postural e grande astenia. Além disso, a depleção de sódio e potássio também determina astenia. Na hipopotassemia, além da astenia outro sintoma importante são as câibras.

A astenia dos cardiopatas que permanecem longo tempo acamados pode estar relacionada também com a atrofia muscular devida à própria insuficiência cardíaca ou por falta de exercício físico. Por fim, a inapetência causada por medicamentos provoca diminuição de ingestão de alimentos, o que muito contribui para a astenia dos cardíacos.

Posição de cócoras (*squatting*)

Essa posição é observada nos pacientes com cardiopatia congênita cianótica com fluxo sanguíneo pulmonar diminuído (estenose e atresia pulmonar, atresia tricúspide e tetralogia de Fallot).

Tais pacientes assumem com frequência e de modo instintivo a posição de cócoras, apoiando as nádegas nos calcanhares, porque descobrem que esta posição alivia a dispneia. Muitas vezes, as mães não percebem que os filhos gostam de ficar nessa posição e, somente quando alertadas pelo médico, passam a notá-la.

Sem dúvida, a posição de cócoras alivia os sintomas do paciente cianótico porque melhora a saturação arterial de oxigênio, mas sua explicação fisiopatológica exata ainda permanece obscura.

A explicação mais aceita é a de que, nessa posição, há elevação da pressão arterial sistêmica por compressão das artérias femorais e ilíacas; além disso, ocorreria uma redução do leito arterial, com aumento da pressão na aorta e no ventrículo esquerdo, diminuindo o curto-circuito da direita para a esquerda. Haveria, também, certa congestão sanguínea venosa nos membros inferiores em consequência da compressão das veias ilíacas, determinando uma redução do retorno venoso. A diminuição do retorno venoso, por sua vez, teria como consequência a mobilização de uma quantidade menor de sangue insaturado da musculatura dos membros inferiores.

Artérias

Os principais sintomas das afecções arteriais são *dor*, *modificações da cor* e da *temperatura da pele*, *alterações tróficas* e *edema*.

Dor

A dor das doenças arteriais pode manifestar-se como formigamento, queimação, constrição, aperto, câibras, sensação de peso ou fadiga.

A dor mais característica de enfermidade arterial isquêmica crônica é a *claudicação intermitente*, a qual surge durante a realização de um exercício (caminhar ou correr, por exemplo) e intensifica-se a tal ponto que obriga o paciente a interromper o que está fazendo. Com a interrupção do exercício a dor desaparece rapidamente, permitindo-lhe retomar a atividade por período mais ou menos igual ao anterior, após o que a dor reaparece, fazendo-o parar outra vez, e assim sucessivamente (Figura 6.20).

De início, a claudicação intermitente só surge quando o paciente faz longas caminhadas; mas, com a progressão da doença, a distância que ele consegue caminhar vai diminuindo, e, depois de algum tempo, não consegue andar sem dor nem dentro de casa.

A dor isquêmica é causada pelo acúmulo de catabólitos ácidos (ácido láctico) e produtos da degradação dos tecidos que estimulam as terminações nervosas.

Este sintoma é tão importante que sua análise correta permite avaliar o grau de comprometimento da artéria e a evolução da doença.

Quando a isquemia se agrava, ocorre outro tipo de dor que não depende da realização de exercício, sendo inclusive mais intensa quando o paciente se deita; daí receber o nome de *dor de repouso*.

É necessário, entretanto, reconhecer, antes de tudo, se a dor é, de fato, de origem isquêmica, ou se é provocada por insuficiência venosa ou se é uma dor neuropática.

A piora da dor na posição deitada é decorrência da diminuição do fluxo de sangue para os membros inferiores, que é um pouco maior na posição de pé, em virtude da ação da gravidade. Por isso, o paciente com este tipo de dor prefere dormir com o membro comprometido pendente, na tentativa de obter algum alívio; em contrapartida, em geral a dor não desaparece porque esta posição acaba provocando edema do membro afetado (edema postural), agravando ainda mais a isquemia. Aí então o

paciente senta-se, coloca o pé sobre a cama e passa a afagar com delicadeza a área comprometida, cuidando para que nada, além da sua mão, a toque, pois até o roçar do lençol intensifica a dor, tornando-a intolerável.

A dor de repouso é um sintoma de extrema gravidade, pois traduz isquemia intensa com risco de gangrena, possível de ocorrer à simples diminuição da temperatura ambiente.

Modificações da cor da pele

A cor da pele depende do fluxo sanguíneo, do grau de saturação da hemoglobina e da quantidade de melanina.

No que se refere às doenças das artérias, as alterações da pele compreendem palidez, cianose, eritrocianose, rubor e o fenômeno de Raynaud.

A *palidez* aparece quando há diminuição acentuada do fluxo sanguíneo no leito cutâneo, seja por oclusão (embolia ou trombose) ou por espasmo.

Surge *cianose* quando o fluxo de sangue no leito capilar se torna muito lento, provocando o consumo de quase todo o oxigênio, com consequente aumento da concentração da hemoglobina reduzida.

A *eritrocianose*, coloração vermelho-arroxeadada observada nas extremidades dos membros com isquemia intensa, aparece no estágio de pré-gangrena. Ela é atribuída à dilatação de capilares arteriais e venosos, última tentativa do organismo para suprir as necessidades de oxigênio dos tecidos.

O *rubor* ocorre principalmente nas doenças vasculares funcionais e se deve à dilatação arteriolar e capilar.

Boxe

Fenômeno de Raynaud

O *fenômeno de Raynaud* é uma alteração mais complexa, que ocorre nas extremidades, principalmente as superiores, caracterizada por palidez, cianose e rubor de aparecimento sequencial. Nem sempre, contudo, ocorrem as três fases. Podem-se observar palidez e cianose, por exemplo, ou cianose e rubor, sem palidez.

Esse fenômeno costuma ser desencadeado pelo frio e por alterações emocionais. É observado em diversas arteriopatias, nas doenças do tecido conjuntivo e do sistema nervoso, em afecções hematológicas, na compressão neurovascular cervicobraquial, em traumatismos neurovasculares e em intoxicações exógenas por metais pesados e por derivados do *ergot*, usados para tratamento da enxaqueca.

Sua fisiopatologia é a seguinte: na primeira fase há um vasospasmo com diminuição do fluxo sanguíneo para a rede capilar da extremidade, que se traduz pela palidez da pele. Na segunda fase, desaparece o espasmo das arteríolas e dos capilares arteriais e surge espasmo dos capilares venosos e vênulas, determinando estase sanguínea, que provoca maior extração de oxigênio com aumento da hemoglobina reduzida, responsável pela cianose. Na terceira fase, desaparece o vasospasmo e ocorre vasodilatação, sendo o leito capilar inundado por sangue arterializado, que torna a pele ruborizada.

O *livedo reticular* é uma alteração da coloração da pele caracterizada por uma cianose em forma de placas, circundando áreas de palidez. Nas formas mais intensas a pele adquire o aspecto de mármore, donde veio a denominação de *cutis marmorata*.

O livedo reticular e o fenômeno de Raynaud sofrem grande influência da temperatura ambiente, aumentando com o frio e diminuindo com o calor.

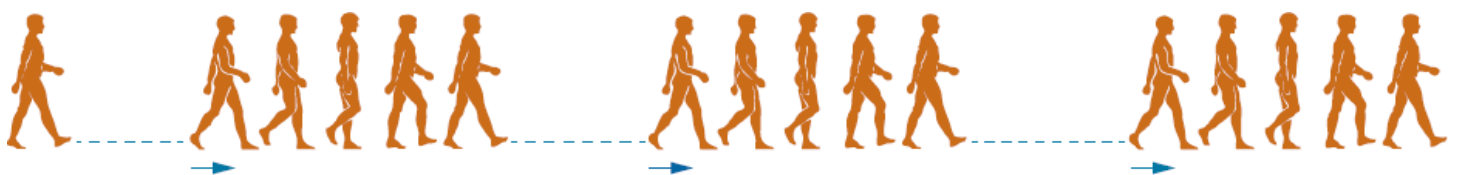


Figura 6.20 Claudicação intermitente. Após caminhar alguns metros, o paciente começa a sentir dor na panturrilha, a qual se intensifica até obrigá-lo a parar. Após algum tempo em repouso, a dor desaparece, voltando o paciente a caminhar aproximadamente a mesma distância, quando, então, a dor reaparece.

Modificações da temperatura da pele

A temperatura da pele depende, basicamente, da magnitude do fluxo sanguíneo.

Nas doenças arteriais obstrutivas, a redução do aporte de sangue provoca *frialdade da pele*.

Nos casos agudos, a interrupção abrupta do fluxo sanguíneo determina tão nítida alteração da temperatura da pele que a topografia da frialdade serve para se avaliar o nível da obstrução, o grau do vasospasmo e a magnitude da circulação colateral preexistente (Figura 6.21).

Nas obstruções crônicas, em virtude da instalação gradativa da oclusão, existe tempo para a formação de uma circulação colateral que vai suprir parcialmente as necessidades metabólicas dos tecidos, havendo, então, menor queda da temperatura da pele.

A frialdade da pele torna-se mais evidente quando cai a temperatura ambiente, pois o frio, poderoso agente vasoconstritor, vai atuar na circulação colateral, reduzindo-a.

Alterações tróficas

As alterações tróficas compreendem atrofia da pele, diminuição do tecido subcutâneo, queda de pelos, alterações ungueais (atrofia, unhas quebradiças ou hiperqueratósicas), calosidades, lesões ulceradas de difícil cicatrização, edema, sufusões hemorrágicas, bolhas e gangrena.

A maior parte das alterações tróficas ocorre nas arteriopatias crônicas. Nas oclusões agudas costumam surgir apenas bolhas, edema e gangrena.

A *pele atrófica* torna-se brilhante e lisa, rompendo-se com pequenos traumatismos. Tal alteração é comum nas extremidades e nos cotos de amputação. A atrofia da pele costuma estar associada à diminuição do tecido subcutâneo, queda de pelos e a alterações ungueais.

As *calosidades* aparecem nos pontos de apoio, geralmente na cabeça do primeiro e quinto metatarsianos, nas polpas dos pododáctilos e nos calcanhares. São muito dolorosas e podem ulcerar-se.

As *úlceras* podem ser minúsculas ou extensas, dependendo do grau de comprometimento arterial. Localizam-se de preferência nas bordas dos pés, polpas digitais, regiões periungueais, calcanhar e regiões maleolares. Surgem espontaneamente ou após traumatismos, compressão, longa permanência no leito ou enfaixamento com atadura ou gesso. São muito dolorosas. O fundo contém material necrótico e são de difícil cicatrização. Uma das características das úlceras isquêmicas é serem mais dolorosas no decúbito horizontal do que com os membros pendentes, em virtude da ausência da ação da gravidade sobre a circulação arterial naquela posição. Por este mesmo motivo, a dor é mais intensa à noite.

Nos diabéticos e nos hansenianos, as ulcerações localizam-se de preferência nas polpas digitais e nas áreas de pressão da planta dos pés. Têm contornos nítidos, bordas circulares e hiperqueratósicas. Em geral são indolores. Podem conter secreção purulenta. Este tipo de úlcera recebe o nome de *mal perfurante plantar*.

Na hipertensão arterial de longa duração e na anemia falciforme pode-se encontrar uma ulceração que se localiza preferencialmente na face lateral da perna, em seu terço inferior. É superficial, tem contorno regular, fundo necrótico e é muito dolorosa. É provocada por obstrução de arteríolas da pele (arterioloesclerose e microembolias).

As *lesões bolhosas* que aparecem nas oclusões arteriais agudas traduzem grave comprometimento da circulação. As bolhas têm vários tamanhos e surgem em áreas cianóticas. Assemelham-se às produzidas por queimadura e indicam avançado grau de isquemia.

Boxe

Gangrena é a morte de tecidos em consequência de isquemia intensa, aguda ou crônica. Pode ser desencadeada por pequenos traumatismos, compressão, infecção, micose interdigital ou surgir espontaneamente. Ela se apresenta sob duas formas – *gangrena úmida* e *gangrena seca*.

A *gangrena úmida* apresenta limites imprecisos, é dolorosa, acompanha-se de edema e de sinais inflamatórios. Surge no diabetes, na tromboangiíte obliterante, na trombose venosa profunda e em determinadas infecções graves da pele e do tecido subcutâneo. Acompanha-se de secreção serossanguinolenta ou purulenta de intenso mau cheiro. A pele necrosada fica escura (preta) e tem consistência elástica à palpação, deslizando facilmente sobre os planos profundos.

A gangrena úmida, associada à infecção e à toxemia, pode ser fatal; é uma condição que deve ser tratada em caráter de emergência.

A *gangrena seca* é assim denominada pelo fato de os tecidos comprometidos sofrerem desidratação, tornando-se secos, duros, com aspecto mumificado. A pele torna-se escura e firmemente aderida aos planos

profundos. Observa-se nítida delimitação entre a parte sadia e a comprometida. Com a evolução do processo surge um sulco denominado “sulco de delimitação”, no qual se origina uma secreção de odor fétido.

Durante sua instalação, a gangrena seca apresenta dor; contudo, com o evoluir do processo, torna-se indolor.

Este tipo de gangrena ocorre principalmente na arteriosclerose obliterante periférica, podendo ser vista também na evolução tardia das oclusões arteriais agudas.

A gangrena úmida e a gangrena seca são devidas à isquemia, ou seja, dependem da deficiência do suprimento de oxigênio para os tecidos, enquanto a gangrena gasosa é causada por bactérias anaeróbicas, do gênero *Clostridium*, produtoras de exotoxinas histotóxicas. O tecido necrótico apresenta crepitação característica, pela produção de gás, e odor fétido.

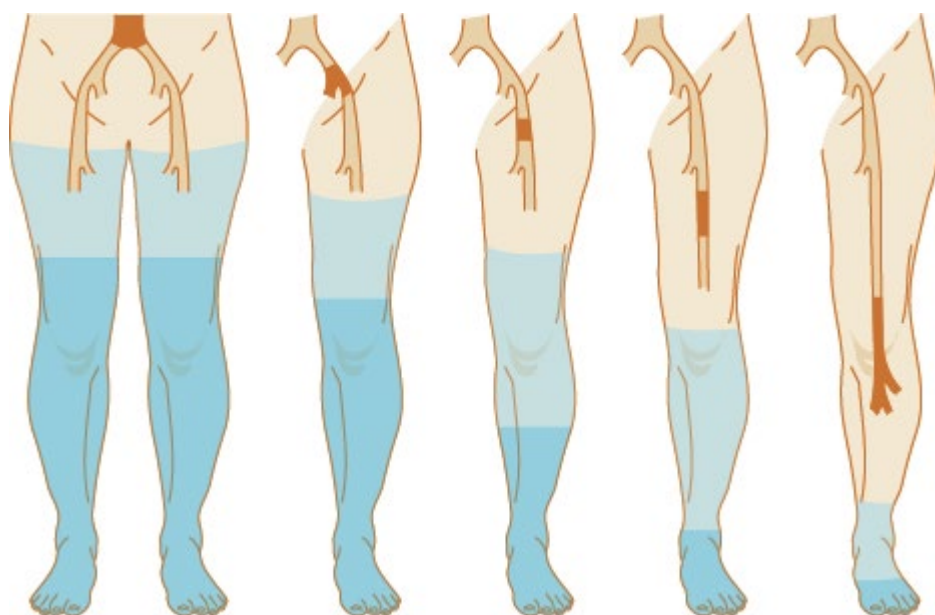


Figura 6.21 Relação entre o local de oclusão da artéria e o nível de frialdade da pele. As áreas azul-claras representam as regiões que podem ou não esfriar, variando sua extensão de acordo com a intensidade do vasospasmo e/ou da circulação colateral preexistente. (Adaptada de Wolosker.)

Edema

O edema que se observa nas doenças arteriais isquêmicas decorre de vários fatores, tais como aumento da permeabilidade capilar em razão da isquemia; tendência dos pacientes a manterem os pés pendentes para aliviar a dor, o que dificulta o retorno venoso; processo inflamatório nas artérias e, às vezes, presença de trombose venosa associada.

Veias

Os principais sintomas das doenças venosas são *dor*, *edema*, *alterações tróficas* (hiperpigmentação, eczema, úlceras e dermatofibrose), *hemorragias* e *hiperidrose*.

Dor

A queixa mais comum dos pacientes que têm varizes dos membros inferiores é uma dor de intensidade leve a moderada referida como peso nas pernas, queimação, ardência, cansaço, câibras, dolorimento, fínçada ou ferroadada. Dor intensa, associada a edema e cianose, levanta a suspeita de trombose venosa profunda.

O mecanismo provável da dor da estase venosa é a dilatação da parede das veias.

Suas características dependem das condições psíquicas do paciente, da profissão, das atividades físicas, do tipo de varizes, do horário do dia e do grau de insuficiência venosa.

Nas microvarizes a dor costuma ser em queimação ou ardência; outras vezes adquire a sensação de peso e cansaço. As microvarizes podem ser assintomáticas, mas são muito valorizadas pelo aspecto estético.

As varizes médias e as calibrosas provocam sensação de peso, cansaço, formigamento e queimação nos pés. A dor é tanto

mais intensa quanto maior a insuficiência venosa. Permanecer de pé agrava o padecimento do paciente. Nas mulheres a dor costuma ser mais frequente no período pré-menstrual e durante a menstruação.

A dor da insuficiência venosa é mais intensa no período vespertino, ao final de uma jornada de trabalho, ou após longos períodos na posição de pé. Quando a insuficiência é muito grave, a dor pode estar presente desde o momento em que o paciente se levanta da cama. Nesses casos, a sensação de intumescimento das veias e peso nas pernas e nos pés diminui quando ele começa a andar.

Boxe

Ao contrário da dor da insuficiência arterial, a da insuficiência venosa melhora com a deambulação e pode tornar-se mais intensa com a interrupção da marcha. Também, diferentemente da dor isquêmica, ela melhora com o repouso no leito com os pés elevados. Contudo, nem sempre é assim, pois alguns doentes, paradoxalmente, relatam piora, com sensação de queimação, quando se deitam. Nesses casos, o paciente não consegue ficar quieto, procurando colocar as pernas nas partes mais frias da cama (síndrome das pernas inquietas).

É frequente também o relato de dor sob a forma de câibras noturnas.

Nas flebites superficiais ocorre dor no trajeto venoso comprometido.

Edema

O edema da insuficiência venosa crônica costuma surgir no período vespertino e desaparece com o repouso, sendo mais intenso nas pessoas que permanecem muito tempo sentadas e com os pés pendentes. Tal fato torna-se bem evidente ao final de viagens longas.

O edema é mole e depressível, localizando-se de preferência nas regiões perimaleolares, mas pode alcançar o terço proximal das pernas na insuficiência venosa mais grave. Na síndrome pós-trombótica, quando o edema torna-se permanente, há aumento global do volume do pé, da perna e até da coxa, sem que aparentem estar edemaciados.

Pode ser uni ou bilateral, predominando no lado em que o retorno do sangue estiver mais prejudicado, diferentemente do edema da insuficiência cardíaca, da hipoproteïnemia e das nefropatias, que apresenta intensidade igual nas duas pernas.

Seu mecanismo de formação é o aumento da pressão hidrostática no interior das veias, das vênulas e dos capilares venosos, fenômeno que ocasiona a saída de líquido para o espaço intersticial.

À medida que o edema se torna crônico, acumulam-se substâncias proteicas no interstício do tecido celular subcutâneo. Tais substâncias desencadeiam repetidas reações inflamatórias da pele e do tecido subcutâneo, vermelhidão da pele, aumento da temperatura e dor na região correspondente. Tal quadro é denominado *celulite subaguda* ou *crônica*.

Alterações tróficas

As principais alterações tróficas das venopatias são hiperpigmentação, eczema, úlceras e dermatofibrose.

Na insuficiência venosa de longa duração podem surgir manchas acastanhadas na pele, esparsas ou confluentes, situadas no terço inferior da perna, predominantemente na região perimaleolar interna. Em alguns casos, a *hiperpigmentação* atinge toda a circunferência da perna.

A hiperpigmentação é devida ao acúmulo de hemossiderina na camada basal da derme, a qual provém das hemácias que migram para o interstício e ali são fagocitadas pelos macrófagos.

O *eczema varicoso* ou *dermatite de estase* pode apresentar-se sob a forma aguda ou crônica. Nos casos crônicos, são frequentes as reagudizações.

Na forma aguda observam-se pequenas vesículas que secretam um líquido seroso, que pode ser abundante. Acompanha-se de prurido, mais intenso no período vespertino e noturno, admitindo-se que sua causa seja a liberação de histamina das células destruídas pela anoxia secundária à insuficiência venosa.

A *úlcera* é uma complicação frequente da insuficiência venosa grave, devida a varizes ou trombose venosa profunda (síndrome pós-trombótica). Tais ulcerações podem surgir em consequência de mínimos traumatismos, como o ato de coçar em áreas correspondentes à flebite superficial ou nos locais de ruptura de varizes.

A localização principal dessas úlceras é na região maleolar interna, mas podem surgir em outras áreas. Em casos avançados atingem toda a circunferência do terço inferior da perna. (As úlceras situadas acima do terço médio da perna geralmente têm

outra etiologia que não a insuficiência venosa crônica.)

As úlceras são rasas, têm bordas nítidas, apresentando uma secreção serosa ou seropurulenta. São menos dolorosas do que a úlcera isquêmica. A dor é maior quando a perna está pendente, melhorando com sua elevação, exatamente o contrário do que ocorre com a úlcera isquêmica.

Nos pacientes com insuficiência venosa crônica os repetidos surtos de celulite e a cicatrização de ulcerações acabam determinando uma *fibrose* acentuada do tecido subcutâneo e da pele (*dermatofibrose*), com diminuição da espessura da perna, que adquire o aspecto de “gargalo de garrafa”. A fibrose leva à ancilose da articulação tibiotársica, prejudicando mais ainda o retorno venoso, por interferir no mecanismo da bomba venosa periférica.

Hemorragias e hiperidrose

As varizes, principalmente as dérmicas, rompem-se com relativa frequência, espontaneamente ou após traumatismo, causando hemorragias de grau variável, às vezes abundantes.

Na insuficiência venosa crônica grave de longa duração é comum o aparecimento de sudorese profusa ou hiperidrose no terço distal das pernas.

Linfáticos

Os principais sintomas das afecções dos linfáticos são *dor* e *edema* que podem ser localizados em diferentes regiões (Figura 6.22).

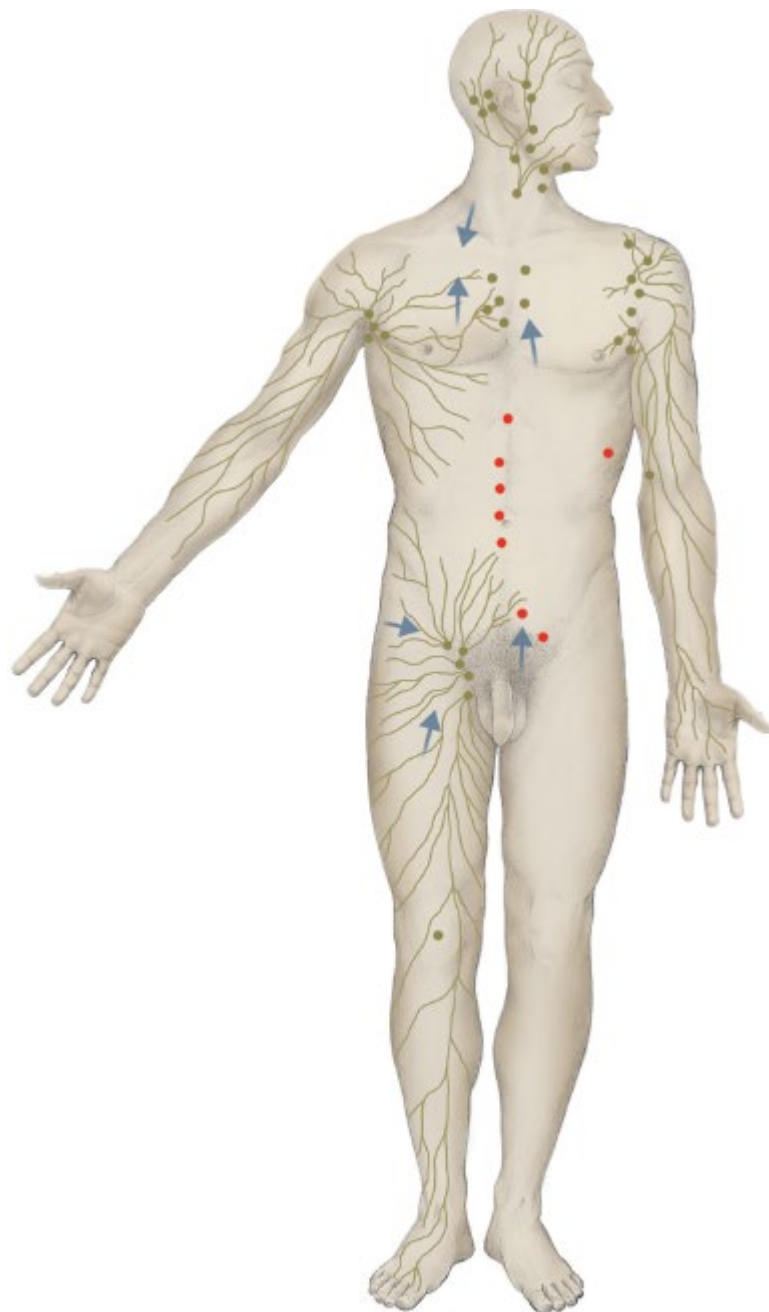


Figura 6.22 Sistema linfático superficial (verde) e profundo (vermelho). (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Dor

A dor surge somente na linfangite aguda e nas adenomegalias de crescimento rápido que acompanham os processos inflamatórios. Localiza-se no trajeto do coletor linfático ou na área em que se situa o linfonodo comprometido. É necessário estar atento para não confundir as linfangites com as flebites (inflamação da veia).

Edema

O edema linfático ou linfedema pode ser ocasionado por bloqueio ganglionar ou dos coletores linfáticos como consequência de processo neoplásico, inflamatório (linfangite) ou parasitário (filariose).

O bloqueio ganglionar ocorre com frequência nas metástases neoplásicas, acompanhando-se de edema unilateral, de evolução rápida, atingindo todo o membro. A princípio, o edema é mole, mas vai-se tornando cada vez mais duro com o passar dos dias. É frio e não regride significativamente com o repouso, mesmo quando o paciente eleva o membro comprometido.

O edema resultante do comprometimento de coletores linfáticos é de instalação insidiosa, iniciando-se pela extremidade do membro afetado, ascendendo levemente com o passar dos meses ou dos anos. É duro, não depressível, frio, leva à deformidade do membro e não diminui substancialmente com o repouso, mesmo com a elevação do membro. O edema de longa duração

geralmente produz hiperqueratose da pele e lesões verrucosas que caracterizam o quadro denominado *elefantíase*.

Há vários tipos de linfedema, conforme se vê no Quadro 6.15, dependendo da etiologia, do tempo de evolução e das complicações.

Quadro 6.15 Classificação do linfedema.	
Primário (congenito, precoce ou tardio)	
Secundário	
• Por alterações dos vasos linfáticos	
Erisipela	
Estase venosa crônica	
Traumatismo	
Filariose	
Pós-cirurgia	
Cirurgia de varizes	
Safenectomia para revascularização miocárdica	
Dissecção inguinal para circulação extracorpórea	
• Por alterações dos linfonodos	
Neoplasias	
Fibrose pós-radioterapia	
Esvaziamento ganglionar cirúrgico	
Tuberculose	
Medicamentos	

Microcirculação

As manifestações clínicas indicativas de distúrbios no nível da microcirculação são *alterações da coloração e da temperatura da pele, alterações da sensibilidade e edema*.

Alterações da coloração e da temperatura da pele

As alterações da coloração e da temperatura da pele – palidez, cianose, acrocianose, fenômeno de Raynaud e livedo reticular – foram vistas ao analisarmos os sintomas das doenças arteriais.

Alterações da sensibilidade

Tais alterações são representadas por *diminuição da sensibilidade* (p. ex., sensação de dedo dormente), *aumento da sensibilidade* ou *hiperestesia* e *fenômenos parestésicos* (dormência e formigamentos). São comuns nos distúrbios da microcirculação, mas precisam ser diferenciadas das afecções dos nervos periféricos. Aliás, em algumas condições tanto o sistema vascular como o sistema nervoso podem estar envolvidos concomitantemente. É o que se observa, por exemplo, na tromboangiite obliterante, na qual o processo inflamatório que começa nas artérias de pequeno calibre vai avançando e acaba englobando as veias e o nervo satélite.

Edema

O acúmulo de líquido intersticial depende de fatores gerais (hipoproteinemia, retenção de sódio) e de alterações locais, destacando-se o aumento da permeabilidade capilar e a obstrução de linfáticos.

SISTEMA DIGESTIVO

A melhor análise dos sinais e sintomas das doenças do sistema digestivo é a feita para cada órgão separadamente, mesmo sabendo que se incorrerá em repetições. Aliás, tais repetições, como já frisamos anteriormente, são necessárias para se aprender a analisar o mesmo sintoma tendo como ponto de referência órgãos diferentes.

Abordaremos, antes, as alterações do apetite. Muito embora este sintoma se deva a múltiplas causas, muitas das quais não relacionadas com o sistema digestivo, é usual incluí-lo na anamnese deste sistema.

Alterações do apetite

Apetite é o desejo de alimentar-se e corresponde a um estado afetivo-instintivo, reforçado por vivências anteriores.

Deve-se distinguir *fome* de *apetite*, porque, embora intimamente relacionados, não têm o mesmo significado. A fome corresponde a uma sensação desagradável, resultante de contrações gástricas (fome gástrica), associada a um estado geral de fraqueza (fome celular).

Em algumas doenças, como o diabetes e o hipertireoidismo, o apetite costuma estar aumentado. Diz-se, nesse caso, que existe *polifagia*, *hiperorexia* e *bulimia*. Em outras enfermidades o apetite está diminuído (*inapetência* ou *anorexia*), como nos estados infecciosos, nos transtornos depressivos, nas neoplasias malignas e em consequência do uso de medicamentos (digitálicos, diuréticos, anorexígenos).

Pode-se observar também perversão do apetite; nesse caso, o paciente demonstra desejo de ingerir substâncias não alimentícias ou que não está habituado a usar. A perversão do apetite que ocorre na gravidez recebe a denominação de *pica* e *malacia*.

Nos pacientes anemiados, com infestação por ancilostomídeos, é comum o desejo de comer terra (geofagia).

Boxe

Bulimia nervosa e anorexia nervosa

É um transtorno alimentar que consiste em episódios repetidos de ingestão exagerada de alimentos que se acompanha de sentimento de perda do controle alimentar, podendo haver mecanismos compensatórios, tais como vômito autoinduzidos, jejuns e exercícios intensos, uso de laxantes ou diuréticos.

A anorexia nervosa também é um transtorno alimentar que se caracteriza por uma perturbação profunda da percepção da imagem corporal, com busca incessante de se tornar magro(a), resultando em acentuada perda de peso, que pode chegar à inanição.

REGIÃO BUCOMAXILOFACIAL

A região bucomaxilofacial é representada por um conjunto de estruturas anatômicas localizadas, na sua maioria, na região

supra-hióidea que inclui: maxila, mandíbula, cavidade bucal, complexo dentoalveolar, articulação temporomandibular (ATM), músculos da mastigação, cavidades paranasais e glândulas salivares (Figuras 6.23 e 6.24).

Os principais sinais e sintomas das doenças que acometem essa região são: *dor, limitação da abertura bucal, disfunção da ATM, halitose, xerostomia, sangramento gengival* (Figura 6.25).

Os pacientes também podem relatar a existência *de ulcerações, nódulos, vesículas e bolhas, manchas e placas*. (Ver *Exame da região bucomaxilofacial* no Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.)

Dor

Uma das dores mais comuns na cavidade bucal é a dor de dente (odontalgia), a qual se manifesta de forma bem localizada ou pode se confundir com dores provenientes de outras estruturas, como mucosa bucal, osso e estruturas adjacentes como as glândulas salivares, articulação temporomandibular, músculos da mastigação, seio maxilar (Quadro 6.16).

As causas mais comuns de odontalgia estão relacionadas a cárie dentária, alterações pulpares e dos tecidos de suporte dos dentes – o periodonto.

A perda do esmalte do dente, provocada por cárie dentária, abrasão, erosão ou traumatismo, expõe a dentina, que é muito sensível a frio, calor, ácidos e doces. A depender da extensão de dentina exposta, a dor pode ser aguda, bem localizada, de curta duração, que desaparece quando se retira o estímulo. Quando há grande perda de esmalte dentário, o estímulo constante desencadeia um processo inflamatório da polpa, chamado pulpíte. Nesses casos, a dor é aguda e latejante, a princípio localizada, mas com o evoluir do processo irradia para as regiões próximas ao dente comprometido, podendo até dificultar a indicação do local exato da dor. Sua intensidade aumenta com substâncias frias, quentes, doces e ácidas e persiste após a remoção das mesmas; exacerba-se quando o paciente se deita em virtude do aumento da circulação intrapulpar.

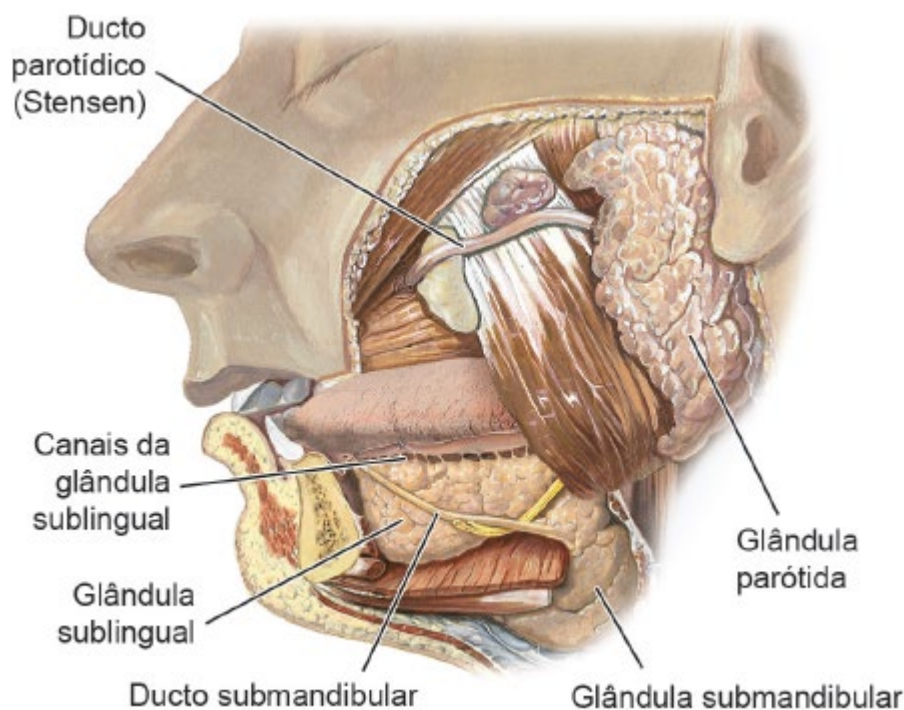


Figura 6.23 Glândulas salivares maiores da cavidade bucal. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

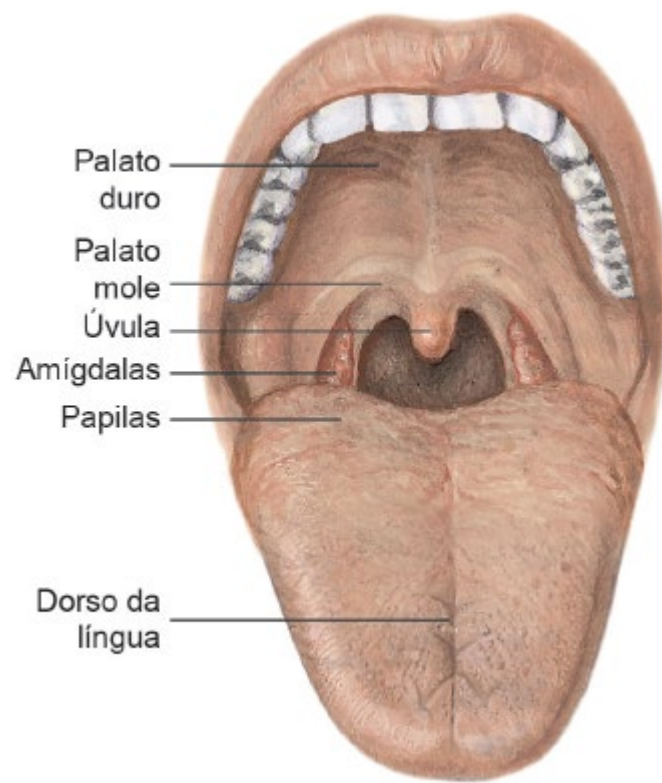


Figura 6.24 Cavidade bucal e suas principais estruturas. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

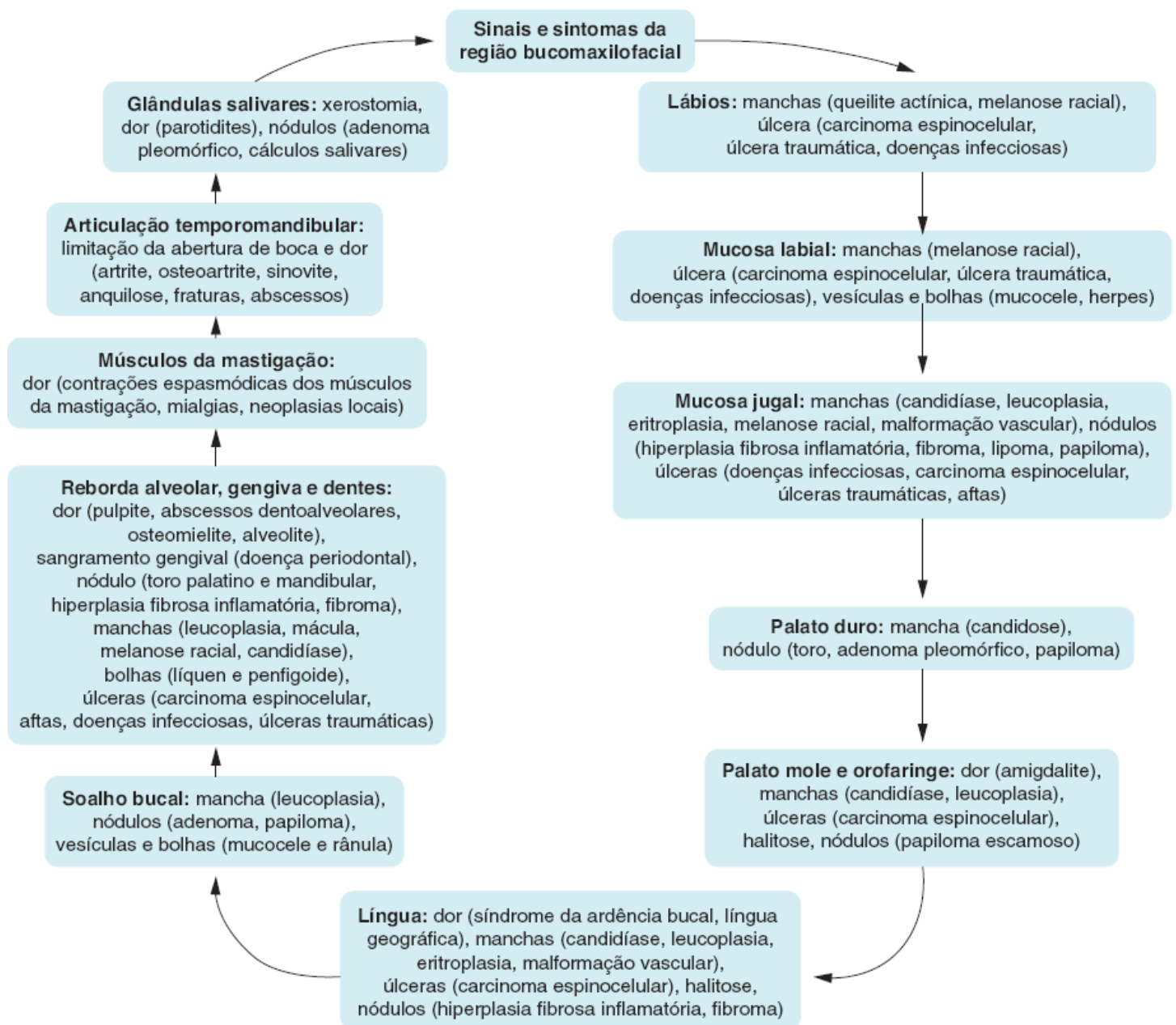


Figura 6.25 Principais sinais e sintomas da região bucomaxilofacial. Este fluxograma também sugere uma sequência sistemática para a realização do exame físico da região bucomaxilofacial. (Ver Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.)

Quadro 6.16

Dor na região bucomaxilofacial e seu diagnóstico diferencial.

Localização	Por que se confundem?	Como diferenciar
Dente + periodonto	As respostas clínicas ao estímulo ou percussão nos dentes são semelhantes nos casos de pulpite e abscessos periodontais/periapicais	Testes de sensibilidade dentária indicarão a vitalidade do dente. Palpação da gengiva pode revelar secreção purulenta nos abscessos periodontais Imagens radiográficas podem mostrar a existência de lesões de cárie ou alterações ósseas na região periodontal

Dente + músculos + seios maxilares	Apesar de as odontalgias serem na maioria das vezes bem localizadas, dores musculares crônicas podem gerar dor secundária nos dentes. Assim, infecções sinusais podem se acompanhar de dor nos dentes, cujos ápices radiculares estejam próximos do assoalho dos seios maxilares	Testes de sensibilidade, percussão e exames radiográficos devem ser realizados para descartar origem dentária da dor História de gripe recente, dor que se agrava ao abaixar a cabeça e palpação do seio maxilar ou transiluminação podem sugerir a existência de sinusite dos seios maxilares. Palpação muscular pode indicar a origem muscular da dor
Cabeça (cefaleias) + músculos + ATM (disfunção temporomandibular – DTM) + seios paranasais	DTM com envolvimento muscular pode ser referida como cefaleia, pois os músculos temporais se originam na fossa temporal. Dores musculares na região cervical também podem se referir para a cabeça (principalmente regiões pós-auricular, parietal e temporal) Sinusite dos seios paranasais também podem se manifestar como dor na região temporal e na região frontal	Uma história clínica detalhada, definindo localização, qualidade da dor, intensidade, duração, frequência, fatores agravantes e atenuantes, pode contribuir para o diagnóstico diferencial Palpação dos músculos pode revelar a origem muscular da dor Exames de imagem podem evidenciar a existência de sinusite nos seios paranasais, ou alterações intracranianas
Ouvido + ATM + músculos	Dor na região de ATM pode ser relatada como dor de ouvido, ou vice-versa Da mesma forma, dores musculares podem ser relatadas como dores articulares	A história clínica, a palpação e os testes funcionais ajudam a diferenciar entre dor por disfunção temporomandibular (DTM) e otalgia. Porém, na maioria dos casos, as DTMs se manifestam como associação de dores musculares e articulares, o que requer exame especializado para diagnóstico e tratamento
Parótida + ATM + dentes/periodonto + músculos	O aumento de volume na região lateral da face pode ter origem em processos infecciosos. Abscessos originados em dentes ou no periodonto podem se disseminar nos espaços intramusculares causando tumefação e limitação de abertura bucal A dor na região de parótida pode se assemelhar a dor articular, e o fato de as estruturas estarem próximas pode gerar	A história clínica pode contribuir para a identificação da estrutura acometida É necessário fazer exame completo das estruturas intraorais (dentes/periodonto) e extraorais (músculos, articulação e glândula parótida) Dores de origem glandular geralmente são acompanhadas por dor a estímulo salivar, e diminuição do fluxo salivar

	dúvidas no diagnóstico diferencial	
Nervos (neuralgias) + mucosites + músculos + dentes	Apesar de as dores neuropáticas comumente apresentarem características bem específicas (dor paroxística em choque, de curta duração e resposta exacerbada a estímulos), elas podem se apresentar com características semelhantes a mucosite (ardência, formigamento, queimação), odontalgia (pulsátil, aguda, constante) ou a mialgia (difusa, e resposta exacerbada a estímulo funcional)	A história clínica e exames completos extraorais e intraorais são fundamentais Testes funcionais e palpação ajudam a identificar dores musculares Testes a estímulos ajudam a identificar a região/estrutura e o tipo de resposta dolorosa Testes anestésicos contribuem para o diagnóstico diferencial

Em relação aos tecidos de suporte do dente (osso alveolar, ligamento periodontal), as dores mais comuns estão relacionadas ao abscesso agudo periapical e periodontal, alveolite e osteomielite.

Os abscessos são processos inflamatórios, caracterizados pela formação de pus. Afetam as porções periapical e periodontal do dente, surgindo dor aguda, intensa, pulsátil, contínua; no início é localizada, mas geralmente evolui para dor referida a distância. Outros sinais relacionados são tumefação e extrema sensibilidade à percussão dentária (vertical/horizontal) e à palpação dos tecidos moles. O calor aplicado sobre a área aumenta a dor pela expansão de gases. Algumas vezes o frio pode dar alívio temporário.

A alveolite é a complicação mais comum após uma extração dentária difícil e traumática. É conhecida como “alvéolo seco”, mas basicamente é uma osteomielite focal na qual o coágulo sanguíneo se desintegrou ou foi deslocado, resultando em odor desagradável e dor intensa, mas sem supuração.

A dor de dente pode ainda ser secundária, tendo sua origem primária em afecções dos seios paranasais (sinusite), musculatura da mastigação ou ATM. Este fato, associado a deficiências no processo de diagnóstico, tem levado a inúmeros tratamentos endodônticos e extrações dentárias desnecessários, com o agravante da não remissão da dor.

Boxe

Osteomielite

A osteomielite é um processo inflamatório agudo ou crônico nos espaços medulares ou nas superfícies corticais do osso, no caso específico do complexo maxilomandibular, o qual se estende além do sítio inicial (geralmente uma infecção bacteriana). Na grande maioria dos casos é uma complicação de infecção dentária (abscesso agudo), que se dissemina pelos espaços medulares do osso, provocando necrose. Fratura dentária e traumatismo da maxila e da mandíbula também podem causar osteomielite. Os principais sintomas são: dor intensa, febre, linfadenopatia regional, mobilidade e sensibilidade dolorosa dos dentes envolvidos, presença de fragmentos ósseos com esfoliação espontânea (sequestros). A parestesia ou anestesia do lábio inferior pode ocorrer quando o osso comprometido é a mandíbula e o canal mandibular está envolvido, onde passa o nervo alveolar inferior. A osteomielite aguda não tratada devidamente pode evoluir para a crônica, a qual pode surgir sem um episódio agudo prévio. Neste caso, tumefação, dor, fístula, secreção purulenta e sequestro ósseo são os principais sintomas. Dentre vários fatores que podem predispor à osteomielite dessa região incluem-se doenças crônicas sistêmicas, imunocomprometimento, doenças associadas com diminuição de vascularização do osso (displasias) e uso de bisfosfonados.

A dor na língua (glossalgia ou glossodina), na maioria das vezes, é descrita pelo paciente como uma sensação de queimadura, tal como acontece ao se tomar café quente. A causa mais comum são as glossites, processo inflamatório que pode ter causas locais ou sistêmicas; por isso, a avaliação semiológica não pode ficar restrita à cavidade bucal. Sem dúvida, as características da própria língua, facilmente examinada pela inspeção, trazem contribuição relevante. A causa mais frequente de ardência ou queimação na língua é higiene bucal inadequada, o que propicia acúmulo de restos epiteliais, bactérias e fungos,

resultando em aspecto de placa branca e densa em toda a língua (saburra lingual). As reações de hipersensibilidade ao material utilizado para confecção de próteses, pastas dentais, enxaguatórios bucais também devem ser investigadas. Variações anatômicas da língua como as fissuras (língua fissurada) e áreas migratórias de atrofia do epitélio (língua geográfica) podem favorecer os sintomas de ardência e queimação. É necessário considerar também as doenças carenciais, especialmente deficiência da vitamina C, do complexo B e de niacina (pelagra), cirrose hepática, leucoses, colagenosas, manifestações paraneoplásicas, intoxicações exógenas (mercúrio, bismuto, chumbo), uso de medicamentos (difenil-hidantoína, penicilina), lesões locais incluindo estomatite aftosa (aftas), estomatite herpética, neoplasias. Traumatismos provocados por prótese dentária defeituosa também podem provocar dor na língua.

Boxe

Síndrome de ardência bucal

Alguns pacientes com distúrbios emocionais relatam sensação de dor na língua sem nenhuma evidência objetiva de inflamação como, por exemplo, na síndrome da ardência bucal (SAB).

A SAB deve ser considerada no diagnóstico das queixas de queimação e ardência bucal. Neste caso, as queixas geralmente são de ocorrência contínua durante o dia, sem interferir no sono, que persistem por pelo menos 4 meses, especialmente na língua, em que não se observam alterações na mucosa e nenhuma causa local ou sistêmica é identificada. A SAB pode estar associada a xerostomia, parestesia e disgeusia. Sua possível gênese multifatorial pode ter a participação de constituintes salivares, distúrbios hormonais, alterações nervosas periféricas e centrais e fatores psicogênicos como ansiedade e depressão.

Limitação da abertura da boca (trismo)

Consiste na dificuldade ou impossibilidade temporária ou permanente de abertura da boca, que pode ter causa intra ou extra-articular (ATM). Alguns exemplos de limitação da abertura de boca são: desarranjo interno ou luxação da ATM, fratura da cabeça da mandíbula, sinovite traumática, artrite inflamatória e osteoartrite, anquilose, traumas ou fraturas de ossos da face, edema pós-cirúrgico, após o bloqueio nervoso para tratamento dentário, hematomas, infecções agudas dos tecidos orais (abscessos dentoalveolares), parotidite aguda, tétano, neoplasias malignas na região da articulação temporomandibular e contrações espasmódicas dos músculos da mastigação.

Disfunção temporomandibular (DTM)

É um termo genérico para designar um conjunto de sintomas dos músculos da mastigação (masseter, temporal, pterigóideos lateral e medial, digástrico) e ATMs, de etiologia multifatorial. O sintoma mais frequente é a dor, que pode estar associada a restrição do movimento mandibular (limitação da abertura bucal) e ruídos articulares. A dor pode estar relacionada a sobrecarga exercida durante a função da ATM: hábito como de apertamento e ranger dos dentes (bruxismo cêntrico e excêntrico); alterações nas relações entre maxila e mandíbula devido a perda dentária; má oclusão (encaixe dos dentes). Outras causas: subluxação, alterações degenerativas (osteoartrose) ou inflamatórias (artrite reumatoide). A dor se localiza na área da articulação, piora com os movimentos mastigatórios e pode irradiar ou ser referida no ouvido, na cabeça e na região cervical. As dores musculares estão associadas a processos inflamatórios e podem apresentar pontos “gatilhos”, que, ao serem acionados, além de desencadear dor local, esta pode manifestar-se a distância em outros músculos e estruturas (p. ex., dente, ouvido).

Halitose (mau hálito)

É a expressão usada para definir um odor bucal desagradável, geralmente percebido pelos circunstantes e, menos frequentemente, pelo próprio paciente.

Em condições normais, o hálito humano não tem odor, sendo, no jovem, geralmente doce e agradável; no entanto, com o aumento da idade torna-se mais intenso, mas habitualmente não é desagradável.

A queixa de halitose requer exame cuidadoso, não só da cavidade bucal, mas também dos sistemas respiratório e digestivo, da pele e das mucosas. A halitose pode ser também de origem metabólica ou psicogênica.

As lesões locais representam cerca de 90% das causas da halitose, que podem ocorrer devido a uma higiene bucal inadequada (resíduos alimentares, impacto alimentar, placa bacteriana, depósitos de cálculo dentário), permitindo a fermentação ou putrefação de substâncias orgânicas; saburra lingual, língua pilosa; higiene deficiente em aparelhos protéticos;

doenças gengivais e periodontais (p. ex., gengivite ulcerativa necrosante aguda); lesões abertas de cáries dentárias; lesões de tecido mole com ulcerações, hemorragia ou necrose, áreas submetidas à cirurgia ou extração dentária.

As causas gerais ou não bucais são: respiratórias (rinite crônica, gotejamento pós-nasal, pólipos, adenoidite crônica, corpo estranho, amigdalite, ozena, sinusite, laringite, bronquite, bronquiectasia, abscesso do pulmão e câncer); uso de bebidas alcoólicas; hábito de fumar ou mascar tabaco; ingestão frequente de alimentos e bebidas fortemente aromatizadas (alho, cebola); digestivas (divertículo faringoesofágico, inflamação crônica do intestino, alterações funcionais, dispepsias, obstrução intestinal, insuficiência hepática); metabólicas (diabetes, uremia); psicogênicas (ansiedade, principalmente); por jejum prolongado.

Xerostomia

A xerostomia, também conhecida como boca seca, pode ou não estar relacionada à falta de saliva, ou seja, nem sempre este sintoma indica uma real falta ou diminuição na produção de saliva. As causas mais frequentes são fatores que desidratam a boca e ressecam a mucosa bucal e dentre estes fatores incluem-se: respiração bucal e o ronco, desidratação, uso excessivo da fala, geralmente relacionada à profissão. Outras causas: doenças das glândulas salivares, como a síndrome de Sjögren, diabetes melito, radiação da cabeça e pescoço, quimioterapia e uso de alguns medicamentos.

ESÔFAGO

Os principais sintomas das doenças do esôfago são *disfagia*, *odinofagia*, *pirose*, *dor esofágica*, *regurgitação*, *eructação*, *solução*, *sialose* e *hematêmese* (Figura 6.26).

Disfagia

Define-se disfagia como dificuldade à deglutição. A disfagia que ocorre nas duas primeiras fases da deglutição é chamada de orofaríngea ou alta, e a da terceira fase da deglutição, de disfagia esofágica ou baixa (Quadro 6.17).

A disfagia orofaríngea pode ser facilmente reconhecida: o alimento permanece no todo ou em parte na cavidade bucal após a tentativa de deglutição, podendo haver aspiração para a árvore traqueobrônquica, seguida de tosse, ou regurgitação nasal.

Na disfagia esofágica o paciente tem a sensação de parada do bolo alimentar no esôfago, embora não possa localizar precisamente o nível da obstrução. Pode ser devida tanto a uma obstrução de natureza orgânica, como a alterações motoras. De modo geral, a disfagia que se manifesta somente para sólidos é sugestiva de obstáculo mecânico, enquanto a que ocorre tanto com alimentos sólidos como líquidos indica alteração da motilidade esofágica.

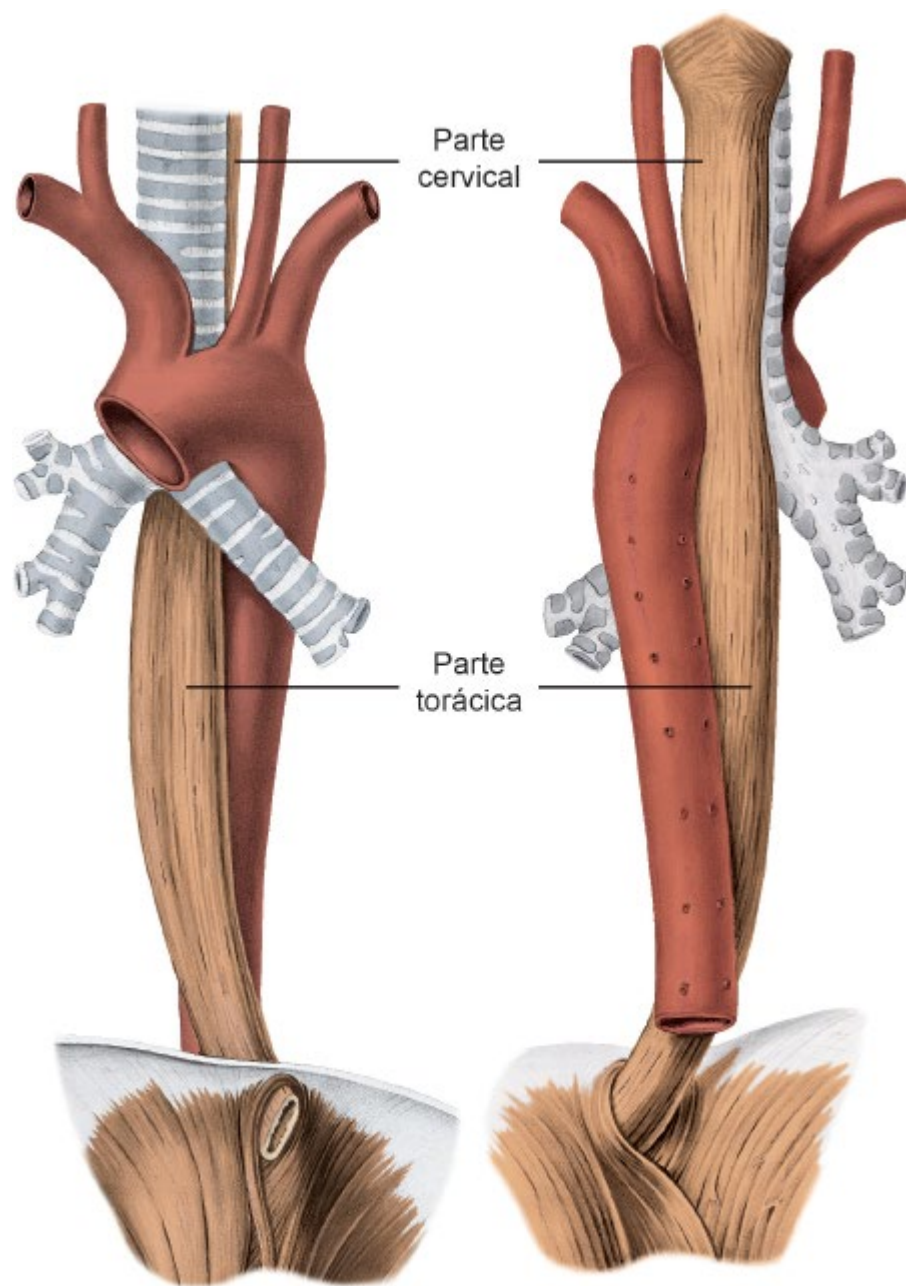


Figura 6.26 Esôfago. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Quadro 6.17

Causas de disfagia.

Disfagia orofaríngea ou alta

- Causas mecânicas

Processos inflamatórios da boca e da faringe

Compressões extrínsecas (bócio, adenomegalias, hiperostose vertebral)

Divertículo de Zenker ou faringoesofágico

Anel esofágico superior

- Miopatias

Distrofia muscular

Dermatomiosite, polimiosite

Hipertireoidismo

Mixedema

Miastenia *gravis*

- Doenças do sistema nervoso central (transtornos que afetam os músculos faríngeos)

Acidente vascular cerebral

Parkinsonismo

Esclerose múltipla

Tumores cerebrais

Doença do neurônio motor

Poliomielite bulbar

Doenças degenerativas

- Distúrbio funcional

Incoordenação faringoesofágica

Relaxamento incompleto do esfíncter superior do esôfago

- Disfagia psicogênica

Globo histérico

Transtorno de ansiedade

Disfagia esofágica ou baixa

- Mecânicas

Neoplasias

Estenoses

Compressões extrínsecas

Anel esofágico inferior (anel de Schatzki)

Corpo estranho

- Motoras

Refluxo gastresofágico

Esofagopatia chagásica (megaesôfago)

Acalasia idiopática

Espasmo difuso do esôfago

Doenças do tecido conjuntivo

Esclerose sistêmica progressiva

Lúpus eritematoso disseminado

Distrofia muscular

Neuropatia do sistema nervoso autônomo

Diabetes

Alcoolismo

Síndrome de pseudo-oclusão intestinal

Doenças do sistema nervoso central

Paralisia pseudobulbar

Esclerose lateral amiotrófica

Parkinsonismo

Outras causas

Amiloidose primária

Esofagites

Estenose cáustica

É importante considerar a evolução da disfagia. Nas obstruções de natureza orgânica a disfagia é intermitente, como se observa nas membranas e anéis, e progressiva nas neoplasias e na estenose péptica. Nas desordens motoras do esôfago, a disfagia é intermitente. No megaesôfago, é lentamente progressiva.

Quando a disfagia tem uma longa duração – de anos – com pouco comprometimento do estado geral do paciente, trata-se, certamente, de doença benigna; quando, ao contrário, a história clínica registra início recente, com acentuada perda de peso, a hipótese diagnóstica que se impõe é a de neoplasia maligna, sobretudo se o paciente tiver mais de 40 anos de idade.

Outros sintomas associados à disfagia também contribuem para o diagnóstico. A pirose é praticamente constante na esofagite péptica no refluxo gastresofágico frequentemente associado a hérnia hiatal, enquanto a dor retroesternal acompanha com frequência os transtornos motores, especialmente o espasmo difuso.

A disfagia não deve ser confundida com a pseudodisfagia e com o chamado *globus hystericus* (globo histérico). A pseudodisfagia é a sensação de desconforto que algumas pessoas experimentam com a descida do bolo alimentar ao ingerir alimentos mal fragmentados ou quando comem apressadamente. *Globus hystericus* é a sensação de corpo estranho localizado ao nível da fúrcula esternal e que se movimenta de cima para baixo e de baixo para cima, desaparecendo completamente durante a alimentação, para reaparecer em seguida. Como o próprio nome indica, é considerado manifestação de origem psicogênica. Estudos manométricos sugerem haver nesses casos um aumento do tônus do esfíncter superior do esôfago.

Odinofagia

Corresponde à dor que surge com a ingestão de alimentos. Pode ocorrer como sintoma isolado, porém comumente está associada à disfagia. Localiza-se atrás do esterno, ora mais alta, ora mais baixa, sendo relatada como urente, em punhalada, constrictiva ou espasmódica. A dor urente representa um grau mais intenso da pirose e é frequente na esofagite péptica, sendo exacerbada pela ingestão de alimentos ácidos ou condimentados. Na esofagite aguda produzida por substâncias cáusticas, como o hidróxido de sódio (soda cáustica), a deglutição é extremamente dolorosa.

Constitui sintoma predominante na candidíase do esôfago, na esofagite actínica, na esofagite herpética e nas ulcerações agudas produzidas por medicamentos que, por alguma razão, permanecem por tempo prolongado em contato com a mucosa esofágica. Dentre os medicamentos capazes de causar tais ulcerações da mucosa esofágica, destacam-se o cloreto de potássio, o brometo de emeprônio (Cetiprin®), os anti-inflamatórios e alguns antibióticos, como a doxiciclina, as tetraciclina e a clindamicina.

Nos distúrbios motores esofágicos, a odinofagia se deve a contrações musculares de maior intensidade no esôfago distal ou a lesões associadas da mucosa.

Pirose

Comumente relatada pelo paciente como “azia”, “queimor” ou “queimação”, a pirose é um sintoma considerado altamente sugestivo de refluxo gastresofágico. Na maioria das vezes é de localização retroesternal, percebida no nível do apêndice xifoide, podendo propagar-se para a região epigástrica, para ambos os lados do tórax ou, mais comumente, em direção ascendente, até o nível do manúbrio esternal. Ocorre, quase sempre, após as refeições, podendo ser desencadeada por alimentos, tais como frituras, bebidas alcoólicas, café, frutas cítricas, chocolate, alimentos fermentados, ou pela posição de decúbito. Acompanha-se, às vezes, de regurgitação de pequenas quantidades de líquido de sabor azedo ou amargo.

Pirose constante sugere insuficiência do mecanismo impediante do refluxo, cujas causas mais comuns são a hérnia hiatal e a hipotonia do esfíncter inferior do esôfago; outras causas são hipersecreção e estase gástrica, operações prévias sobre a região do cárdia, como a cardiomiectomia para tratamento do megaesôfago, e alterações motoras acompanhadas de hipoperistaltismo, como ocorre na esclerose sistêmica progressiva.

Dor esofágica

A dor espontânea, que se distingue da odinofagia por não depender do ato de deglutir, mas que pode com ela coexistir, pode ser causada por mudança do pH intraluminal decorrente de refluxo gastresofágico, atividade motora anormal e processos inflamatórios ou neoplásicos da parede esofágica.

O caráter da dor varia em função da doença de base. Na esofagite péptica é comum a dor urente, que representa, na verdade, uma acentuação da pirose. Nos distúrbios motores do esôfago, especialmente no espasmo difuso e nas formas hipercinéticas da esofagopatia chagásica e da acalasia idiopática, é referida como dor em cólica, constrictiva ou dilacerante. No câncer do esôfago,

a dor, quando presente, é surda, contínua, indicando quase sempre extensão da neoplasia às estruturas mediastinais. Na ruptura espontânea do esôfago (síndrome de Boerhaave), assim como nas perfurações ou rupturas acidentais, a dor é de grande intensidade e se acompanha de sintomas gerais que denunciam a gravidade do quadro clínico.

Uma causa relativamente comum de dor esofágica é representada pelo chamado *esôfago quebra-nozes*, denominação dada ao esôfago com contrações peristálticas de grande amplitude e longa duração.

Boxe

Dor esofágica e dor cardíaca

A dor esofágica pode confundir-se com a dor da isquemia miocárdica. Nem sempre é fácil o diagnóstico diferencial, uma vez que ambas podem causar sensação de opressão retroesternal e irradiar para o pescoço, os ombros e membros superiores. Atenção: os vasodilatadores empregados no tratamento da dor anginosa podem aliviar certos tipos de dor esofágica. O exame clínico fornece dados importantes, e quando há referência a outros sintomas esofágicos ou cardíacos, torna-se mais fácil a distinção. Outros dados que podem auxiliar no diagnóstico diferencial são: a dor anginosa que se manifesta após exercício e atenua com o repouso, enquanto a dor esofágica ocorre comumente com o paciente deitado, em repouso, melhorando quando se põe de pé e caminha alguns passos. Mas na angina instável a dor não depende de esforço físico para surgir; o uso de antiácidos pode produzir alívio da dor esofágica, mas não da dor cardíaca. A comprovação da origem da dor quase sempre depende de exames complementares.

Regurgitação

Entende-se por regurgitação o retorno do alimento ou de secreções contidas no esôfago ou estômago à cavidade bucal, sem antecedentes de náuseas nem a participação dos músculos abdominais.

A regurgitação de pequena quantidade de líquido, pela manhã, é chamada de *pituíta*. As causas de regurgitação esofágica podem ser mecânicas ou motoras.

As causas mecânicas mais comuns são: estenoses, neoplasias, divertículo faringoesofágico (divertículo de Zenker) e obstrução do lúmen esofágico por alimento (geralmente carne).

Os distúrbios motores mais frequentes são o megaesôfago chagásico, a acalasia idiopática e, mais raramente, o espasmo difuso do esôfago.

A regurgitação de conteúdo gástrico refluído para o esôfago é comum na hérnia hiatal por deslizamento e na doença péptica ulcerosa. Os seguintes fatores favorecem a regurgitação do conteúdo gástrico: hipotonia do esfíncter inferior do esôfago, aumento da pressão intragástrica ou intra-abdominal e as mudanças posturais, como a inclinação do tronco para a frente, o decúbito dorsal e o decúbito lateral direito.

A regurgitação ocorre quase sempre após as refeições. No megaesôfago encontram-se dois tipos de regurgitação: a ativa, dinâmica ou ortostática, que surge durante ou imediatamente após as refeições, decorrente da incoordenação motora do esôfago, e a passiva, de decúbito ou clinostática, que se manifesta tardiamente, com o paciente deitado, quase sempre à noite.

Boxe

Regurgitação noturna representa um grande risco, pela possibilidade de aspiração do material regurgitado para a árvore respiratória, causando repetidos surtos de broncopneumonia.

Um tipo especial de regurgitação é o representado pelo que se denomina *mericismo*, o qual consiste na volta, à boca, de pequenas quantidades de alimento que, na maioria das vezes, é novamente deglutido pelo paciente, à maneira dos ruminantes. Não tem outro significado a não ser o embaraço que pode causar ao paciente.

Eructação

A eructação não constitui sintoma próprio das doenças do esôfago e ocorre, na maioria das vezes, em consequência da ingestão de maior quantidade de ar durante as refeições, ou em situações de ansiedade.

A deglutição de grande quantidade de ar constitui a *aerofagia*, comum em pacientes ansiosos.

No megaesôfago, entretanto, a eructação pode ser considerada um sintoma esofágico. O paciente deglute propositalmente maior quantidade de ar durante as refeições com a finalidade de auxiliar a passagem do alimento para o estômago; o ar deglutido acumula-se na parte superior do esôfago, impelindo o alimento para baixo, à maneira de um êmbolo de pressão; em seguida, é expelido pela eructação.

Soluço

O soluço também não constitui sintoma específico das doenças do esôfago, nem do aparelho digestivo.

O soluço, que é causado por contrações espasmódicas do diafragma, pode ser devido a numerosas causas, tais como doenças do sistema nervoso central, irritação do nervo frênico ou do diafragma, estimulação reflexa e doenças que comprometem o mediastino, pleura e órgãos intra-abdominais. Contudo, pode ser considerado como parte da sintomatologia esofágica em duas condições: na hérnia hiatal e no megaesôfago. Na hérnia hiatal pode manifestar-se episodicamente ou tornar-se persistente e intratável pelas medidas clínicas habituais. No megaesôfago e na acalasia o soluço é relativamente frequente durante as refeições. (Ver *Diafragma e mediastino*, neste capítulo).

Sialose

A sialose, também denominada sialorreia ou ptialismo, caracteriza-se pela produção excessiva de secreção salivar, sendo observada nas esofagopatias obstrutivas de modo geral e, em particular, no megaesôfago chagásico.

A hipersalivação nesses casos se deve ao chamado reflexo esôfago-salivar de Roger, segundo o qual as glândulas salivares são estimuladas reflexamente a partir de receptores situados na parede esofágica. No megaesôfago chagásico parecem atuar outros fatores diretamente relacionados com a doença de Chagas, uma vez que a hipersalivação persiste mesmo após a remoção cirúrgica do esôfago.

A sialose é também encontrada com frequência nos pacientes hipersecretores com doença péptica ulcerosa.

Hematêmese

A hematêmese ou vômito com sangue caracteriza a hemorragia digestiva alta, assim entendida aquela em que a sede do sangramento se localiza desde a boca até o ângulo de Treitz (ângulo formado na junção entre o duodeno e o jejuno).

A causa mais comum de sangramento de origem esofágica são as varizes do esôfago. A hematêmese por ruptura das varizes é, na maioria das vezes, volumosa e contém sangue ainda não alterado por ação do suco gástrico. A hematêmese de menor volume, de origem esofágica, pode ocorrer no câncer do esôfago, nas úlceras esofágicas e em outras condições mais raras (Quadro 6.18).

Convém lembrar que a primeira tarefa do médico é diferenciar a hematêmese da hemoptise. Na maioria dos casos, isso não é difícil quando se coletam corretamente os dados clínicos (ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras*, neste capítulo).

Quadro 6.18 Causas de hematêmese.
Varizes esofágicas
Hérnia hiatal
Câncer esofágico
Úlcera péptica
Lesões agudas da mucosa gastroduodenal (LAMGD)
Câncer gástrico
Doenças hemorrágicas

ESTÔMAGO

Os principais sintomas das doenças do estômago são *dor, dispepsia, náuseas e vômitos e pirose* (Figura 6.27).

Dor

O sintoma mais frequente das doenças do estômago é a dor epigástrica.

A dor visceral do estômago e do bulbo duodenal é percebida na linha mediana, abaixo do apêndice xifoide. Ocorre nos pacientes com úlcera péptica, gastrite aguda e câncer gástrico.

Nos Quadros 6.19 e 6.20 estão sumarizados alguns aspectos da dor abdominal e da dor que se origina nos órgãos do sistema digestivo. Consulte ambos simultaneamente, pois a localização da dor é elemento-chave para definir sua causa.

Boxe

Dor abdominal aguda e crônica

É fundamental para o raciocínio diagnóstico esclarecer se a dor abdominal é aguda ou crônica, e identificar a localização e a irradiação e as manifestações clínicas associadas, tendo em conta a projeção dos órgãos na parede abdominal (Quadros 6.19 e 6.20 e Figura 17.2).

Doenças inflamatórias ou neoplásicas que afetam a face serosa do estômago determinam dor contínua e intensa na parte alta do abdome, principalmente epigástrica. Quando uma lesão gástrica se estende a estruturas retroperitoneais, é comum a dor ser percebida na região dorsal do tronco.

A descrição clássica do quadro clínico da úlcera péptica, particularmente da úlcera duodenal, ressalta a importância de certas características semiológicas da dor epigástrica, destacando-se as variações rítmicas da dor a que se atribuía valor diagnóstico.

De fato, o alívio da dor imediatamente após ingestão de alimentos é relatado por muitos pacientes com úlcera péptica, particularmente úlcera duodenal. Assim, dor que surge ou se intensifica nos períodos pós-prandiais tardios e cessa total ou parcialmente nos períodos pós-prandiais precoces seria altamente sugestiva da úlcera duodenal. Contudo, estudos clínicos rigorosos, realizados após o advento da endoscopia – por meio da qual a separação entre portadores de úlcera péptica e pacientes com dor epigástrica com estômago e duodeno normais se faz com exatidão muito maior do que pela radiografia – revelam que a ritmicidade da dor não é nem muito sensível nem específica como indicador de úlcera, o que diminuiu seu valor diagnóstico. Mas quando está presente, junto com outros dados clínicos, continua sendo útil na análise das causas de dor epigástrica.

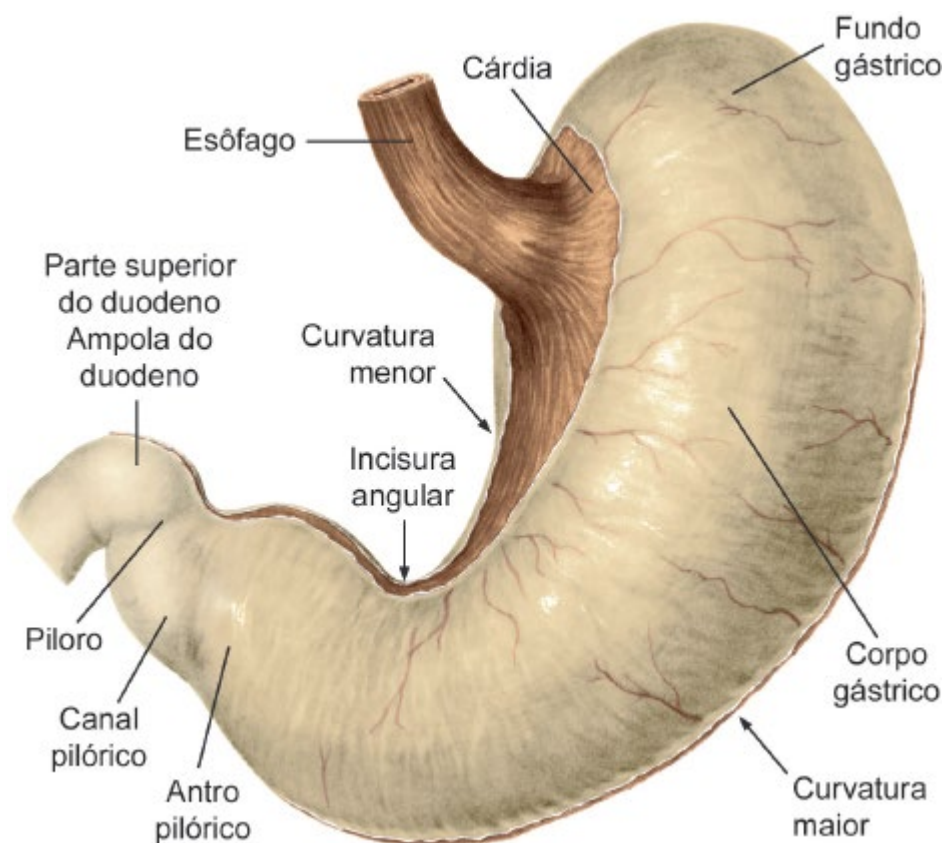


Figura 6.27 Divisão anatômica do estômago. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Quadro 6.19

Causas de dor abdominal.

Órgão ou estrutura	Afecção
Parede abdominal	Hérnias, eventração, lesões traumáticas, herpes-zóster
Coração	Infarto do miocárdio
Esôfago	Esofagite de refluxo, hérnia hiatal
Pulmões e pleuras	Pneumonias, pleurites
Estômago e duodeno	Úlcera péptica, gastrites, câncer do estômago, síndrome dispéptica
Pâncreas	Pancreatites, neoplasias do pâncreas
Vesícula e vias biliares	Colelitíase, colecistite, câncer
Fígado	Congestão passiva, hepatite, câncer do fígado, abscesso hepático
Intestino delgado	Enterites, parasitoses intestinais, obstrução intestinal
Intestino grosso e apêndice	Colites, câncer do cólon, megacólon, diverticulite, apendicite

Peritônio	Peritonite
Baço	Esplenomegalia
Vasos	Trombose mesentérica
Rins e vias urinárias	Litíase, rins policísticos, cistite
Ovário, anexos e útero	Cólica menstrual, cólica uterina, anexites
Aorta e artérias	Aneurisma, trombose arterial
Dor psicogênica	Transtorno de ansiedade e/ou depressão

Quadro 6.20
Localização da dor originada no sistema digestivo.

Localização da dor	Órgão afetado	Principais doenças
Retroesternal	Esôfago	Esofagite
Ombro direito	Vesícula biliar	Colecistite
Escápula direita	Vias biliares	Cólica biliar (colelitíase)
Epigástrica	Estômago Duodeno Vesícula biliar Vias biliares Fígado Pâncreas	Úlcera péptica Úlcera péptica Colecistite Colangite Hepatite/congestão passiva Pancreatite
Dorso	Pâncreas	Pancreatite
Hipocôndrio direito	Fígado Vesícula biliar	Hepatite Colecistite
Hipocôndrio esquerdo	Baço	Esplenomegalia
Umbilical	Intestino delgado Apêndice	Cólica intestinal Apendicite
Hipogástrio	Cólon	Colite ulcerativa

Flancos	Cólon	Colite ulcerativa Diverticulose/diverticulite
Fossa ilíaca direita	Cólon Apêndice	Colite Apendicite
Fossa ilíaca esquerda	Cólon Divertículo de Meckel	Colite Diverticulite
Sacro	Reto	Proctite Abscesso perirretal

Um contingente expressivo de pacientes cuja única ou principal queixa é a dor epigástrica, bem localizada, apresenta estômago normal à endoscopia e ausência de evidência objetiva de qualquer doença orgânica. Supõe-se que nesses casos a dor resulte de anormalidades funcionais do estômago. Elementos de ordem clínica revelam que isto ocorre junto com transtornos emocionais, reforçando a possibilidade de dor de origem psicogênica nesses casos.

Boxe

A dor do infarto agudo do miocárdio tem localização epigástrica em 25% dos pacientes. Para diferenciá-la da dor de origem gástrica são importantes as outras características semiológicas e as manifestações clínicas associadas.

Dispepsia

Dispepsia é a designação empregada para um conjunto de sintomas relacionados com a parte alta do abdome. Embora cada um desses sintomas possa manifestar-se isoladamente, frequentemente eles ocorrem juntos, o que torna o emprego do termo dispepsia mais apropriado para denotar o conjunto do que qualquer um dos sintomas em particular.

Boxe

Síndrome dispéptica

A síndrome dispéptica, portanto, compõe-se de dor ou desconforto epigástrico, seu elemento básico, acompanhado de empanzimento, sensação de distensão do abdome por gases, pirose, saciedade precoce, náuseas com vômitos ocasionais, intolerância a alimentos gordurosos e eructações.

Conforme o quadro clínico, classifica-se a dispepsia em três tipos:

Dispepsia tipo refluxo: o principal sintoma é o desconforto ou pirose retroesternal

Dispepsia tipo úlcera: o sintoma predominante é a dor epigástrica

Dispepsia tipo dismotilidade: nela prevalece a sensação de plenitude gástrica.

A patogênese deste complexo sintomático é obscura. A dispepsia ocorre, frequentemente, associada às manifestações de doenças digestivas não gástricas (hepatopatias, pancreatopatias, doenças das vias biliares) e a doenças localizadas fora do tubo digestivo (cardiopatias, insuficiência renal).

A dispepsia pode ser a expressão clínica de qualquer doença orgânica do estômago; contudo, um contingente expressivo é constituído por indivíduos nos quais a mais exaustiva investigação não revela afecção orgânica de qualquer natureza. Qualifica-se a dispepsia, nesses casos, de essencial ou funcional, sendo quase sempre expressão de somatização, no nível do estômago, de transtornos emocionais (*dispepsia psicogênica*).

Boxe

Sinais de alerta

Início acima dos 50 anos
Vômitos persistentes
Icterícia
Perda de peso.

Náuseas e vômitos

Manifestações comuns de doenças do estômago e do duodeno são as náuseas e os vômitos. Frequentemente, são apenas manifestações associadas à dor: portadores de úlcera gástrica ou duodenal e gastrites podem apresentar vômitos simultaneamente com a crise dolorosa, sem que isso denote obstrução pilórica. Nesse caso, o vômito consiste em suco gástrico puro ou contendo pequena quantidade de bile; alimentos, quando presentes, são os recentemente ingeridos. Em contrapartida, vômitos contendo grande quantidade de alimentos ingeridos várias horas antes são fortemente indicativos de estase gástrica, enquanto a presença de grande quantidade de bile no vômito sugere obstrução intestinal alta.

Vômitos com sangue (hematêmese) denotam lesões a montante do ângulo de Treitz. As causas mais comuns de hematêmese são a úlcera péptica, as varizes esofágicas, as lacerações da transição esofagogástrica pelo esforço do vômito (síndrome de Mallory-Weiss), as lesões agudas da mucosa gastroduodenal (LAMGD) e o carcinoma do estômago (Quadro 6.21).

Pirose

Pirose é a sensação de queimação retroesternal. É a expressão da inflamação ou irritação da mucosa esofágica causada pelo refluxo gastresofágico, que pode ocorrer independentemente de qualquer doença gástrica, mas frequentemente se associa a doença péptica e a toda condição que determine estase gástrica.

Quadro 6.21 Causas de vômitos.

Síndrome dispéptica

Gastrites

Úlcera péptica

Câncer gástrico

Obstrução pilórica

Hepatite

Cólica biliar

Obstrução intestinal

Peritonite

Labirintopatia

Enxaqueca

Hipertensão intracraniana

Gravidez

Intoxicação alcoólica

Vômitos de origem psicogênica

Medicamentos

INTESTINO DELGADO

Os principais sintomas das afecções do intestino delgado são *diarreia*, *esteatorreia*, *dor*, *distensão abdominal*, *flatulência* e *dispepsia*, *hemorragia digestiva*, além de alguns *sintomas* relacionados com outros sistemas (Figura 6.28).

Diarreia

A diarreia, o sintoma mais comum nas doenças do intestino delgado, é definida como a diminuição da consistência das fezes e da quantidade de evacuações (mais de três por dia).

Pode ser decorrente de vários mecanismos:

Aumento da pressão osmótica do conteúdo intraluminal (diarreia osmótica): ocorre quando há acúmulo de substâncias não absorvíveis no lúmen do intestino delgado, que retardam a absorção de água e eletrólitos ou promovem a passagem de líquido para o lúmen intestinal. Constituem exemplos a diarreia secundária à ingestão de laxativos salinos não absorvíveis, como o hidróxido de magnésio, e, em particular, a diarreia provocada por defeito da digestão ou da absorção de nutrientes, como se vê nos casos de má absorção

Aumento da secreção de água e eletrólitos pela mucosa intestinal (diarreia secretora): é consequência do estímulo para a síntese de AMP cíclico intracelular, do que resulta secreção ativa de água e eletrólitos pela mucosa do delgado. Citam-se como exemplos a diarreia provocada por enterotoxinas bacterianas e por determinados medicamentos (teofilina, prostaglandinas)

Aumento da permeabilidade da mucosa intestinal (diarreia exsudativa): é observado quando o acometimento da mucosa por alterações inflamatórias, neoplásicas ou isquêmicas resulta em passagem anormal de líquidos para o lúmen do intestino delgado. São exemplos a diarreia da doença de Crohn, das enterites bacterianas ou parasitárias e dos linfomas difusos do delgado

Alterações da motilidade do intestino delgado (diarreia motora): decorre de modificações do trânsito nesse segmento do intestino. Em algumas condições, como no hipertireoidismo ou na diarreia funcional psicogênica, as alterações da motilidade aceleram o trânsito pelo delgado. Em outras, a diminuição da motilidade resulta em estase do conteúdo intraluminal, como ocorre na esclerose sistêmica progressiva. Nessa situação, pode haver proliferação anormal de bactérias no intestino delgado que causam desconjugação dos sais biliares. Consequentemente, há prejuízo à digestão de gorduras, instalando-se um mecanismo “misto” na gênese da diarreia.

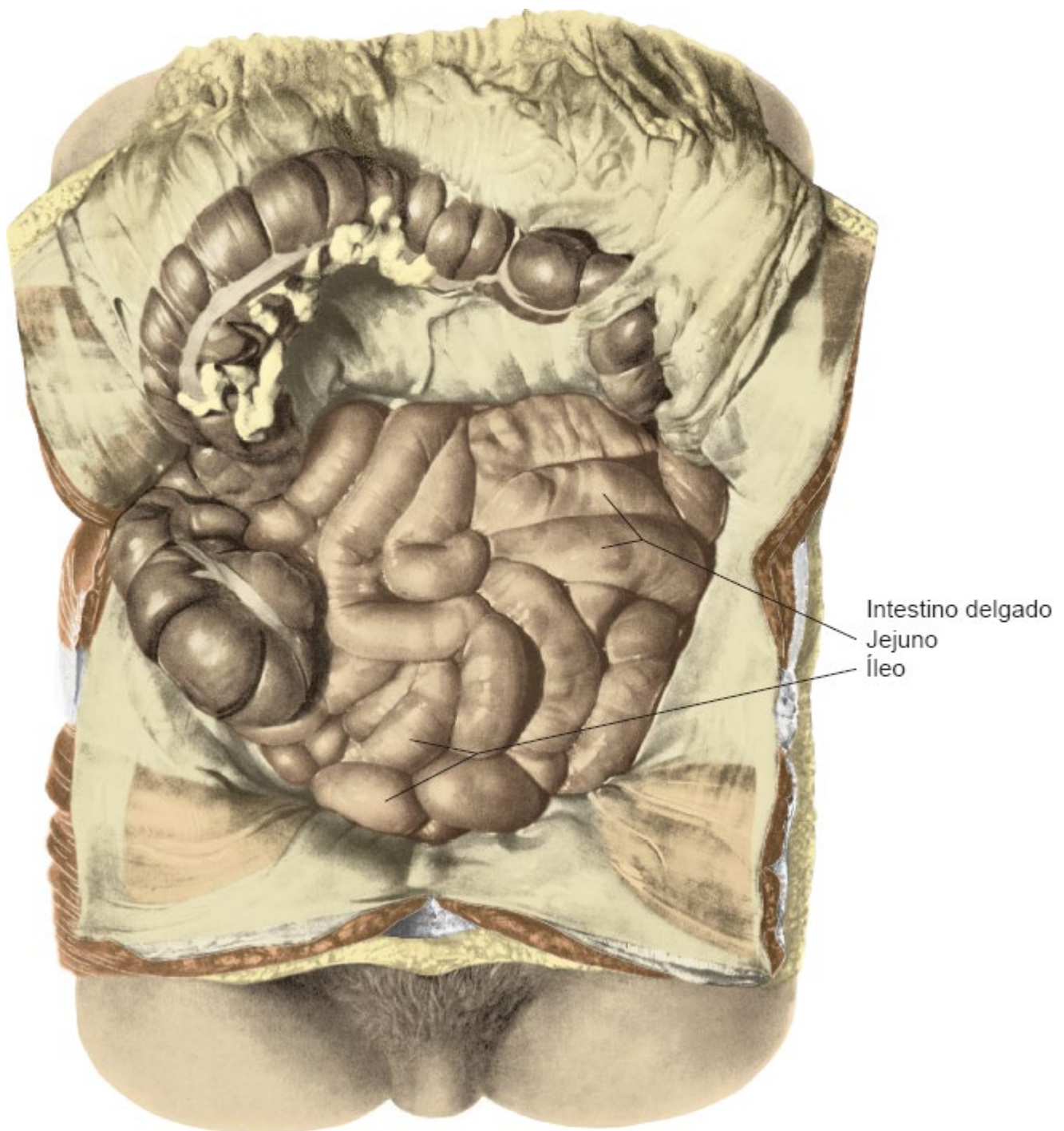


Figura 6.28 Intestino delgado. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Informações adequadas sobre as características clínicas da diarreia são essenciais para o raciocínio diagnóstico. É necessário certificar-se, em primeiro lugar, da própria existência da diarreia. A presença de fezes líquidas, em grande volume, e um número aumentado de evacuações tornam fácil o reconhecimento da diarreia. Em alguns casos, entretanto, o aumento do teor de líquido provoca mudanças menos evidentes na consistência e no volume das fezes. Por outro lado, há condições com aumento do número diário das dejeções, como em casos de hipertireoidismo ou de ansiedade, sem que haja aumento do teor líquido das fezes.

A duração do processo diarreico é de grande ajuda no raciocínio clínico. As diarreias agudas, de poucos dias de duração (até 4 semanas), são, em geral, devidas a processos de natureza diferente dos da diarreia crônica (Quadro 6.22).

Dados quanto ao volume, consistência e aspecto das fezes, bem como a frequência das evacuações, são úteis para se caracterizar o acometimento – exclusivo ou predominante – do intestino delgado. Nesse caso, as dejeções costumam ser volumosas e amolecidas, quando não francamente líquidas ou semilíquidas. O volume aumentado das fezes pode ser aparente em cada evacuação ou quando se procura determinar o volume emitido em 24 h. O número de evacuações está aumentado, mas dificilmente alcança a grande frequência observada nas afecções inflamatórias das porções mais distais do intestino grosso. São comuns as alterações do aspecto das fezes, que podem apresentar-se mais claras, brilhantes, leves e espumosas. As evacuações

podem ser acompanhadas da eliminação de grande quantidade de gases, o que confere um caráter “explosivo” às dejeções. O cheiro das fezes pode ser muito desagradável, chegando a ter caráter pútrido. As evacuações podem ser precedidas de cólicas abdominais de localização periumbilical, ou de dor difusa, predominando no hemiabdomene direito. Raramente, há eliminação de sangue vivo ou ocorrência de urgência retal ou tenesmo intenso.

Quadro 6.22 Causas de diarreia.
Diarreia aguda
Infecções virais, bacterianas e parasitárias
Intoxicação alimentar
Retocolite ulcerativa
Medicamentos
Laxativos
Diarreia de origem psicogênica
Diarreia crônica
Cólon irritável
Câncer do cólon
Parasitoses intestinais
Doença inflamatória do intestino (doença de Crohn)
Retocolite ulcerativa
Síndrome de má absorção
Uso abusivo de laxativos
Diabetes
Hipertireoidismo
Intolerância à lactose
Síndrome de Zollinger-Ellison
Medicamentos

São comuns os restos alimentares, nas dejeções, sendo importante diferenciar se são restos de alimentos normalmente não digeríveis, como os que contêm fibras vegetais (fragmentos de verduras, “pele” de tomate, casca de feijão), ou se são restos de alimentos normalmente digeríveis, como os que contêm amido ou proteína animal (fragmentos de batata, grãos de arroz, pedaços de carne ou ovo). A presença de restos não digeríveis é inespecífica e nada mais indica do que a liquefação das fezes. Em contrapartida, o reconhecimento de restos de alimentos normalmente digeríveis é evidência forte a favor da presença de defeitos na digestão.

Boxe

Um elemento que apresenta grande especificidade, como indicador de distúrbio da digestão ou da absorção dos nutrientes, é a presença de gorduras, definidora da *esteatorreia*, conforme se verá adiante.

Dejeções de grande volume, grande teor líquido aparente, frequência moderadamente aumentada, ocasionalmente contendo restos de alimentos normalmente digeríveis ou a presença inequívoca de gordura, caracterizam o que se denomina *diarreia alta*, indicativa de comprometimento exclusivo ou predominante do intestino delgado.

Tais características contrapõem-se ao que se denomina *diarreia baixa*, que indica o comprometimento das porções mais distais do intestino grosso. Nesse caso, a diarreia apresenta-se com maior número de evacuações, nas quais há eliminação de pequena quantidade de fezes, muito frequentemente contendo muco, pus ou sangue, acompanhadas de puxo, urgência retal e tenesmo.

Estes dois padrões de diarreia não são mutuamente excludentes. Isto porque, em alguns casos de doenças do intestino delgado, a passagem para o intestino grosso de substâncias que não foram absorvidas, como ácidos graxos livres ou sais biliares, promove alterações da mucosa dos cólons, gerando condições para a instalação de uma *diarreia baixa*. Além disso, não é incomum a ocorrência de alterações inflamatórias acometendo simultaneamente a mucosa do intestino delgado e dos cólons, como se observa na doença de Crohn. Por outro lado, quando o processo patológico incide exclusiva ou predominantemente nas porções mais distais do intestino delgado, a diarreia resultante pode ter características clínicas tais que não se enquadre, perfeitamente, em nenhum destes dois padrões.

Boxe

Cinco perguntas-chave para a análise da diarreia

Diante de um paciente com diarreia, procurar responder a 5 perguntas:

1. Trata-se de diarreia aguda ou crônica? (Considera-se crônica quando ultrapassa 4 semanas de duração)
2. Há dados que permitam caracterizar diarreia alta ou diarreia baixa?
3. É possível caracterizar esteatorreia?
4. A diarreia é de causa infecciosa ou não infecciosa?
5. Há outras manifestações clínicas indicativas de uma condição clínica específica? (Exemplos: retocolite ulcerativa, AIDS, síndrome de má absorção, cirurgia gástrica ou intestinal.)

Ver *Síndrome diarreica e síndrome disentérica* no Capítulo 17, *Exame do Abdome*.

Esteatorreia

É definida como o aumento da quantidade de gorduras excretadas nas fezes, as quais se tornam volumosas, amareladas ou acinzentadas, fétidas e, algumas vezes, espumosas.

Em condições normais, eliminam-se nas fezes cerca de 5% do aporte diário total de gorduras. O aumento da ingestão de lipídios não acarreta elevação da gordura fecal, graças à enorme capacidade do organismo de promover a digestão e a absorção dos nutrientes, em geral, e das gorduras, em particular. Assim sendo, a esteatorreia constitui uma das manifestações clínicas mais específicas no sentido de indicar a presença de defeito nos processos de digestão e absorção.

Do ponto de vista etiopatogênico, a esteatorreia pode ser decorrente de vários mecanismos, que implicam má absorção exclusiva do componente lipídico da dieta ou má absorção global de todos os macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas e gorduras (Quadro 6.23).

A esteatorreia pode ser completamente inaparente, o que é mais provável de acontecer nos casos em que o aumento da excreção de gorduras seja de pouca monta. Na grande maioria das vezes, a esteatorreia associa-se à diarreia e, muito frequentemente, esta tem as características de *diarreia alta*, observando-se, então, evacuações muito volumosas e número de dejeções moderadamente aumentado, às vezes com eliminação de alimentos normalmente digeríveis. É, também, comum a concomitância de manifestações indicativas do aumento do conteúdo gasoso do intestino grosso, proveniente da digestão bacteriana de substratos não absorvidos, como cólicas periumbilicais, distensão abdominal e flatulência.

Quadro 6.23
Mecanismos etiopatogênicos de esteatorreia.
Lipólise alterada
Insuficiência pancreática (pancreatite crônica)
Deficiência de mistura da lipase com o quimo (gastrectomia, vagotomia)
pH impróprio (síndrome de Zollinger-Ellison)
Solubilização intraluminal alterada
Insuficiência hepatocelular (cirrose hepática)
Obstrução biliar (colestase intra ou extra-hepática)
Desconjugação de sais biliares (proliferação bacteriana)
Deficiência absoluta de sais biliares (doença ou ressecção)
Absorção intestinal alterada
Lesão da mucosa intestinal (doença celíaca)
Ressecções intestinais extensas
Abetalipoproteinemia
Transporte alterado
Doença dos linfáticos intestinais (linfangiectasia intestinal primária ou secundária, doenças sistêmicas e afecções torácicas)
Mecanismos mistos ou de natureza desconhecida
Ação de medicamentos (neomicina, colchicina)
Infecções e parasitoses intestinais (estrongiloidíase)
Neuropatia visceral (diabetes)

Diarreia associada à esteatorreia, tendo como mecanismo etiopatogênico o aumento da pressão osmótica intraluminal, costuma cessar ou diminuir com um período de jejum completo.

O aumento do teor fecal de gorduras pode induzir modificações nas fezes mesmo na ausência de diarreia franca. As dejeções passam a ser volumosas, brilhantes e lustrosas, com tendência a clareamento das fezes, as quais, não raro, apresentam-se flutuando na água do vaso sanitário. Esta modificação de peso relativo das fezes não é diretamente relacionada com o aumento do teor de gorduras, mas sim com o aumento do conteúdo gasoso das dejeções, que frequentemente acompanha a esteatorreia. Deve ser lembrado que fezes normais, contendo grandes quantidades de gases, flutuam na água. Outras características, como viscosidade aumentada ou formação de bolhas (“fezes pegajosas e espumosas”), podem ser relatadas pelos pacientes. É comum, também, referência a modificação do cheiro das fezes, que pode passar a ser muito desagradável, francamente pútrido, ou lembrar o cheiro de “manteiga rançosa”. O aumento do teor gasoso das fezes pode gerar “evacuações explosivas” associadas à esteatorreia. Na dependência do nível de excreção fecal de gorduras, a presença de esteatorreia pode ser reconhecida pela emissão de uma substância oleosa, esbranquiçada, que se mistura ou se adiciona às fezes, ou pela formação, na água do vaso sanitário, de gotas ou placas de gordura. Em casos de aumento muito acentuado da perda intestinal de lipídios, pode haver relato de evacuações contendo exclusivamente gorduras.

Ver *Síndrome de má absorção* no Capítulo 17, *Exame do Abdome*.

Dor

A dor abdominal é um sintoma comum nas doenças do intestino delgado. Junto com a diarreia ou outro sintoma, pode compor um quadro clínico cuja análise dirige o raciocínio diagnóstico para o delgado (Quadro 6.19).

Mecanismos da dor originada no intestino delgado

A dor abdominal originada no intestino delgado pode decorrer dos seguintes mecanismos:

Distensão das paredes do intestino delgado: ocorre estimulação das terminações nervosas, em consequência do acúmulo do conteúdo intraluminal, quando há má absorção de nutrientes ou secreção ou exsudação anormal para o lúmen intestinal. Este mecanismo pode também ocorrer se houver aumento anormal do conteúdo, como nos casos de esvaziamento gástrico anormalmente rápido em consequência de gastrectomia ou cirurgia bariátrica ou então quando há acúmulo do conteúdo a montante de um segmento intestinal obstruído

Aumento da tensão muscular das paredes do intestino: ocorre excitação das terminações nervosas intraparietais decorrente de contrações vigorosas ou espasmódicas da musculatura do delgado. Este mecanismo pode ocorrer nos distúrbios funcionais por ação local de agentes tóxicos, químicos, biológicos ou metabólicos, na intoxicação por chumbo, na porfiria, ou na cetoacidose diabética. Contrações intensas da musculatura do jejuno ou íleo ocorrem na obstrução mecânica e como fenômeno reflexo, quando há inflamação da mucosa intestinal

Alterações inflamatórias ou congestivas do intestino delgado: liberam mediadores químicos, como as cininas e as prostaglandinas, quando há inflamação ou congestão da mucosa ou de toda a parede do delgado

Isquemia intestinal: resulta, também, na liberação de mediadores químicos, os quais, juntamente com outros metabólitos, como o ácido láctico, ocasionam estimulação das terminações nervosas intraparietais

Alterações inflamatórias do peritônio: terminações nervosas sensoriais estão presentes nos folhetos visceral e parietal do peritônio e são sensíveis à ação dos mediadores químicos da inflamação. A extensão de processos inflamatórios do intestino delgado para regiões localizadas do peritônio visceral pode ocorrer na doença de Crohn, nas doenças infectoparasitárias e nas neoplasias. Por outro lado, instala-se peritonite generalizada quando há perfuração de um segmento do intestino, como se pode observar em qualquer doença inflamatória ou na diverticulite de Meckel.

É importante caracterizar bem a localização da dor, o que pode ser feito não só inquirindo o paciente, mas solicitando-lhe que mostre, com sua própria mão, o local e a extensão da área que dói e os sítios de irradiação da dor. Quando a dor tem origem exclusiva no intestino, sem que haja comprometimento peritoneal, a sua localização é, em geral, imprecisa, no centro do abdome, próximo da linha média. Se o processo patológico situar-se no jejuno ou no íleo proximal, possivelmente a dor será localizada na região periumbilical. Se o processo interessar os segmentos mais distais do íleo, a dor pode ser localizada um pouco abaixo da cicatriz umbilical, na linha média. Se a origem da dor for no íleo terminal, ela será provavelmente percebida no

quadrante inferior direito do abdome.

Quando a dor decorre de peritonite restrita, sua localização vai corresponder à da sede do processo patológico. Muito frequentemente, as doenças do intestino delgado podem cursar com peritonite focal, como se vê na doença de Crohn, que afeta preferencialmente o íleo terminal. Desse modo, a sede da dor atribuída ao comprometimento do peritônio perivisceral é, também, no quadrante inferior direito do abdome. Quando há peritonite generalizada, a dor pode ser sentida difusamente em todo o abdome.

A irradiação da dor depende do mecanismo etiopatogênico e da sua intensidade. Quando ela é causada por distensão das paredes do intestino ou por contrações vigorosas da sua musculatura, a irradiação para o dorso somente ocorre quando o estímulo é muito intenso. Por outro lado, quando há peritonite restrita, produzindo dor localizada no quadrante inferior direito do abdome, pode haver irradiação para a base da coxa, independente da sua intensidade.

É importante verificar se houve ou não variações do local da dor na evolução do quadro clínico. Assim, se o quadro se inicia com dor abdominal, restrita à região periumbilical, mas que após algumas horas se desloca para a fossa ilíaca direita, deve-se pensar em comprometimento peritoneal perivisceral de um processo originário das paredes do intestino, uma ileíte aguda, por exemplo. Caso haja, algumas horas mais tarde, extensão da dor para o quadrante inferior esquerdo do abdome, deve-se pensar na generalização da inflamação peritoneal.

Influem na intensidade da dor o estado físico e emocional do paciente, a presença de outros sintomas e o efeito de medicamentos usados. Uma dor intensa acompanha-se de manifestações autonômicas, como náuseas, vômitos, sudorese, palidez cutânea e inquietude.

Na avaliação da dor abdominal, é necessário obter dados sobre sua qualidade ou caráter. A dor visceral originada de distensão ou da contração das paredes musculares do intestino costuma ser descrita como “distensão” ou “torção”. Quando há alterações inflamatórias, congestivas ou isquêmicas, é possível que se apliquem as designações “contração” ou “peso”. Sensações semelhantes a “queimação” ou “pontada” podem ser referidas para designar a participação do peritônio perivisceral no processo inflamatório.

Boxe

Cólica intestinal

A dor com características de cólica apresenta início relativamente abrupto, com agravamento rápido e progressivo da sua intensidade que, ao atingir o seu acme, frequentemente se associa a manifestações autonômicas. Em seguida, a dor diminui gradualmente até que se torne pouco intensa ou desapareça completamente. O reconhecimento da cólica permite atribuir a dor à distensão das paredes do intestino ou à contração de sua musculatura.

Contribuem também, para o reconhecimento das causas da dor abdominal associada às doenças do intestino delgado, as modificações do sintoma em função de mudanças de posição do paciente ou de sua movimentação. Quando a dor é gerada exclusiva ou predominantemente no intestino, sem que haja comprometimento do peritônio, há tendência do paciente em movimentar-se ativamente, a procurar posições que lhe tragam algum alívio, fletindo o tronco ou comprimindo o abdome com as mãos. Mas quando a dor provém de inflamação do peritônio, o paciente prefere ficar imóvel e quieto, pois movimentos de flexão do tronco ou compressão do abdome costumam agravar a sensação dolorosa, o mesmo acontecendo com a tosse ou movimentação brusca do corpo para sentar-se ou mudar de posição. Nos casos em que há irritação peritoneal localizada na fossa ilíaca direita, pode haver piora da dor com a extensão completa do membro inferior do mesmo lado, o que faz com que o paciente adote uma posição de semiflexão da coxa sobre o abdome, mesmo ao deambular.

Outros dados de interesse incluem a influência da alimentação e a presença de outras manifestações digestivas, como vômito, distensão abdominal, meteorismo e modificações na eliminação de gases e fezes. Quando a dor é produzida por processo envolvendo o tubo digestivo, a eliminação de gases e fezes pode desencadear a dor ou agravá-la, o que nem sempre ocorre quando a dor advém de inflamação peritoneal ou de afecção fora do tubo digestivo. Os vômitos podem fazer parte das manifestações autonômicas reflexas que acompanham qualquer tipo de dor abdominal intensa. Entretanto, quando surgem após vários minutos do pico de intensidade de uma cólica intestinal com eliminação de material muito volumoso ou de cor escura e odor fecaloide, é quase certo tratar-se de obstrução intestinal. Nesses casos, há frequentemente distensão abdominal e redução acentuada ou mesmo parada da eliminação de gases e fezes. Do mesmo modo, cólicas intestinais acompanhadas de meteorismo intenso, seguidas de eliminação abundante de gases e fezes com melhora importante ou completa do quadro doloroso, sugerem obstrução mecânica parcial e transitória. Nesses casos, particularmente nos de evolução crônica, podem os pacientes relatar espontaneamente a percepção da formação de “caroços móveis” no abdome, que podem corresponder ao peristaltismo

exacerbado.

Por fim, a presença de outras manifestações concomitantes com a dor abdominal, como febre, hemorragia digestiva, anemia, desidratação, alterações urinárias ou menstruais, vai contribuir para o diagnóstico da causa da dor abdominal.

Boxe

Dor perineal

A localização da dor perineal indica uma causa retal, anal, escrotal ou prostática no homem; na mulher, além das doenças anorretais, a dor perineal pode estar relacionada a doenças vulvares e vaginais.

Um tipo especial de dor perineal é a denominada proctalgia fugaz, relacionada a contrações espasmódicas do músculo puborretal ou de outros elementos musculares do assoalho pélvico.

Distensão abdominal, flatulência e dispepsia

Em grande número de doenças do intestino delgado, em especial naquelas em que ocorre má absorção, pode surgir um conjunto de sintomas indicativos de aumento do conteúdo gasoso do tubo digestivo. Nesses casos, observa-se distensão abdominal associada à flatulência.

A principal queixa destes pacientes é uma sensação de repleção abdominal, muitas vezes referida como “excesso de gases”. Além da sensação desconfortável de repleção, pode ser relatado aumento do volume e da tensão das paredes do abdome. O paciente percebe as vibrações provocadas pela movimentação do conteúdo intraluminal, podendo também escutar os ruídos correspondentes, às vezes tão exacerbados que pessoas que convivem com o paciente os percebem. Concomitantemente, aumenta a eliminação de gases, evidenciada pelo maior número de flatos e pela quantidade maior de gases emitidos.

Dor contínua, de pequena intensidade, difusa por todo o abdome, indica a distensão das paredes do abdome. Mas, o que se observa, mais comumente, são cólicas periumbilicais, coincidentes com a percepção dos ruídos abdominais e, não raro, precedendo a eliminação de gases ou fezes, fato que alivia instantaneamente o quadro doloroso.

Boxe

Sintomas dispépticos constituem manifestação comum das afecções do intestino delgado. São sensações desagradáveis, que incluem pirose, eructações, desconforto no epigástrio, saciedade precoce, plenitude ou empachamento pós-prandial e náuseas, acompanhadas ou não de vômitos.

Estes sintomas são decorrentes do aumento do conteúdo de líquido do intestino delgado, de má absorção, deficiência de propulsão e excesso de gases produzidos pela fermentação bacteriana de açúcares não absorvidos. Mas é preciso lembrar que manifestações dispépticas podem ocorrer em doenças de esôfago, estômago, duodeno, pâncreas, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, bem como em condições clínicas sem substrato orgânico bem definido.

Deve ser esclarecido se a distensão abdominal, a flatulência e outras manifestações associadas apresentam-se isoladamente ou junto com diarreia e, em particular, com esteatorreia. Se tal acontece, deve-se pensar em processo patológico que comprometa a absorção dos nutrientes. Por outro lado, a concomitância destes mesmos sintomas com dor abdominal intensa, contínua, com exacerbações periódicas, pode indicar uma obstrução mecânica de algum segmento do tubo digestivo. Nesse caso, tem valor diagnóstico a observação dos períodos em que há diminuição ou mesmo parada da eliminação de gases e fezes.

Quando a flatulência e a distensão abdominal ocorrem isoladamente, é necessário investigar se há algum alimento ou grupo de alimentos que possam ter relação com o quadro. Em particular, por ser de ocorrência muito frequente a intolerância à lactose, é necessário inquirir detalhadamente sobre a ingestão de leite e seus derivados. É relativamente comum que os próprios pacientes com deficiência de lactase não percebam a associação da ingestão do leite com seus sintomas. O feijão, outro alimento comum em nossa alimentação e que contém determinados açúcares complexos não digeríveis, passíveis de fermentação pelas bactérias do cólon, pode ser responsável por sintomas de distensão abdominal e flatulência.

Hemorragia digestiva

A hemorragia digestiva é definida pela passagem de sangue do continente intravascular para o lúmen do tubo gastrointestinal,

sendo eliminado pelo vômito (*hematêmese*) ou por defecação (*enterorragia e melena*) (Quadro 6.24).

As manifestações clínicas decorrentes de hemorragia no nível do intestino delgado vão depender de vários fatores, entre os quais se destacam a localização do sangramento e sua magnitude, determinada pelo volume, velocidade e duração do sangramento.

É a referência a *melena* o que mais sugere hemorragia no nível do intestino delgado, uma vez que há tempo para digestão do sangue extravasado entre o ângulo de Treitz e a válvula ileocecal. As fezes tornam-se enegrecidas, mas podem guardar uma leve tonalidade avermelhada.

Muito frequentemente, o sangramento no intestino delgado provoca aumento do teor líquido das fezes, daí ser comum a associação de melena com amolecimento das fezes e aumento do número de evacuações ou com diarreia exuberante. Junto com a mudança de cor e da consistência, costuma haver modificação do aspecto das fezes, que ficam mais viscosas e aderentes. Por isso, é comum os pacientes se referirem à eliminação de uma “graxa preta”, “cola preta” ou “borra de café”. Quase sempre a melena apresenta outra característica peculiar, que é o odor pútrido.

A hemorragia no intestino delgado pode expressar-se também por *enterorragia*, ou seja, eliminação de sangue vivo pelo ânus. Isto pode ocorrer em função de uma ou mais das seguintes condições: local de sangramento próximo à válvula ileocecal, perda sanguínea rápida e intensa e existência de fatores que aceleram a velocidade do trânsito intestinal. Mesmo quando o sangramento manifesta-se por enterorragia, é provável que apareça melena ou o aspecto do sangue eliminado sugira algum grau de digestão.

Quadro 6.24 Causas de hemorragia digestiva originada no intestino delgado.
Afecções de natureza inflamatória
Doença de Crohn
Tuberculose intestinal
Paracoccidioidomicose
Estrongiloidíase
Enteropatia actínica
Tumores e condições associadas
Pólipos
Tumores benignos (adenoma, leiomioma, lipoma)
Tumores malignos (linfomas, adenocarcinoma, carcinoide)
Afecções de natureza vascular
Hemangiomas
Angiodisplasias
Telangiectasia hemorrágica
Fístulas

Oclusões arteriais agudas

Vasculites

Anomalias congênitas não vasculares

Divertículo de Meckel

Diverticulose intestinal

Doenças sistêmicas

Púrpuras

Leucemias

Uremia

Síndrome de má absorção (deficiência de vitamina K)

Ação de medicamentos

Ação local (álcool, salicilatos, sais de potássio)

Ação sistêmica (corticoides, anticoncepcionais, anticoagulantes)

Muito mais rara é a possibilidade de a hemorragia do intestino delgado resultar em *hematêmese*. Isto pode ocorrer quando o local do sangramento é próximo ao ângulo de Treitz e quando a hemorragia for maciça. A associação com melena, nesses casos, é praticamente obrigatória e é também provável que o aspecto do sangue eliminado pelo vômito sugira certo grau de digestão.

Alguns sintomas das hemorragias digestivas estão relacionados com as repercussões hemodinâmicas do sangramento. Assim, quando o sangramento é intenso e rápido, observam-se manifestações indicativas de colapso circulatório. O paciente pode estar bem em repouso, mas quando fica de pé ou faz algum exercício físico apresenta tonturas, escurecimento visual, sensação de vertigem e palpitações. Quando a hemorragia é pouco intensa e de baixa velocidade, insidiosa ao longo do tempo, é possível que seja completamente inaparente do ponto de vista clínico, não havendo nem mudança das características das fezes. Os sintomas poderão ser apenas os de uma anemia de instalação lenta, às vezes detectável somente à exploração laboratorial.

Uma manifestação comum das hemorragias originadas em pontos próximos à válvula ileocecal é a febre, resultante, provavelmente, de absorção de substâncias pirogênicas produzidas pela digestão do sangue extravasado para o lúmen do tubo digestivo.

A origem no intestino delgado de uma hemorragia é sugerida quando coexistem sintomas próprios das doenças intestinais. A diarreia e a dor abdominal são os mais comuns. Mais frequentemente, cursam com sangramento a doença de Crohn, os linfomas, a tuberculose e a strongiloidíase. Nas condições em que há má absorção, além da diarreia, pode haver esteatorreia, e o sangramento costuma ser acompanhado por hemorragia em outros órgãos, como epistaxe, gengivorragia, petéquias, equimoses e sangramento vaginal.

Ver *Hemorragia digestiva* no Capítulo 17, *Exame do Abdome*.

Outros sintomas

As afecções do intestino delgado repercutem fortemente no organismo como um todo, destacando-se perda de peso, anemia, edema, manifestações carenciais e de insuficiência endócrina.

A *perda de peso* (emagrecimento) decorre de alimentação deficiente, má absorção ou aumento do consumo metabólico.

A redução da ingestão de alimentos pode ser devida à inapetência ou à exclusão progressiva de alimentos que agravam os sintomas do paciente. No entanto, é a má absorção que costuma ser o principal mecanismo de emagrecimento.

A *anemia* pode decorrer da deficiência de ferro, vitamina B₁₂ ou folatos, desnutrição proteica, hemorragia digestiva ou depressão tóxica da eritropoese. Em alguns casos, a anemia pode ser a única manifestação clínica associada à má absorção.

O *edema* quase sempre é a expressão clínica da redução da pressão coloidosmótica do plasma acarretada pela diminuição do nível da albumina, a qual, por sua vez, pode ser consequente à redução da ingestão proteica ou alteração da absorção de nutrientes.

As *manifestações carenciais* são múltiplas, sendo ocasionadas por ingestão alimentar insuficiente ou perturbação da absorção. Destacam-se, entre as manifestações carenciais, a xeroftalmia, a cegueira noturna e a hiperqueratose cutânea por deficiência de vitamina A; o raquitismo e a deficiência do crescimento por carência de vitamina D; as púrpuras e os sangramentos no tubo digestivo por hipovitaminose K; as queilites, a glossite, a pelagra e as parestesias por deficiência do complexo B; lesões eczematoides nas extremidades por falta de ácidos graxos essenciais.

As *principais manifestações de insuficiência endócrina* são as alterações menstruais, disfunção sexual, insuficiência suprarrenal, hipotireoidismo e hipopituitarismo. Os mecanismos envolvidos não são bem conhecidos, mas ingestão deficiente e alterações na absorção são fatores importantes. Mais recentemente, tem sido valorizada a atividade endócrina do sistema digestivo, seguramente implicada no comprometimento difuso do intestino delgado.

CÓLON, RETO E ÂNUS

Os principais sintomas das doenças do cólon, reto e ânus são *dor, diarreia, obstipação ou constipação intestinal, sangramento anal (enterorragia), prurido anal, distensão abdominal, náuseas e vômitos e anemia e emagrecimento* (Figura 6.29).

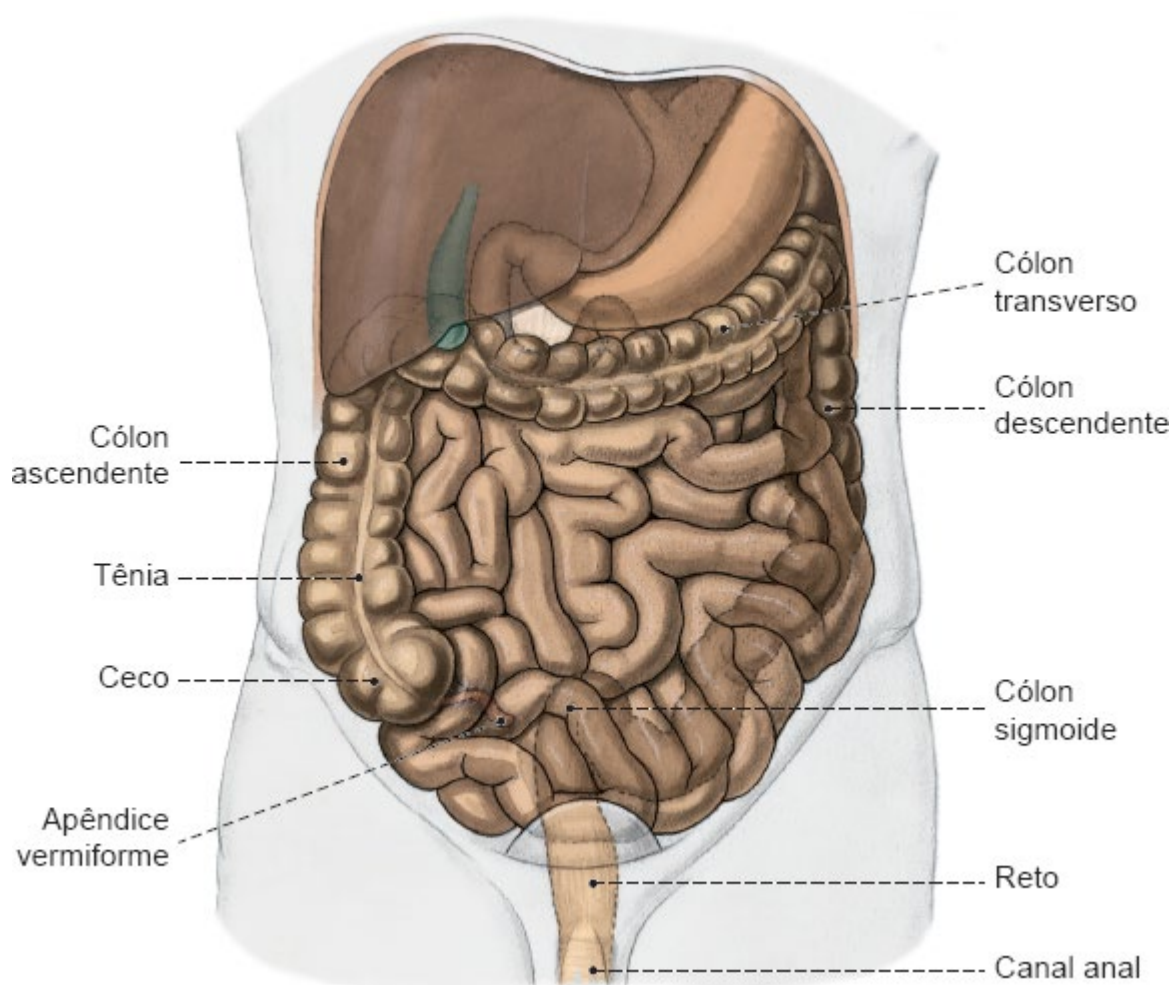


Figura 6.29 Intestino grosso. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

A dor é o sintoma mais comum nas doenças do cólon, reto e ânus.

Boxe

Localização da dor: perineal e abdominal

A *dor perineal* é mais fácil de ser avaliada porque esta região pode ser investigada diretamente pela inspeção e pela palpação, ou por meio de instrumentos simples. Além disso, na maioria das vezes a dor origina-se em lesões ali situadas, destacando-se a trombose hemorroidária, os abscessos e as fissuras. As manobras propedêuticas realizadas durante o exame agravam ou despertam dor, facilitando sua análise semiológica.

Um tipo especial de sensação dolorosa perineal é o *tenesmo*, cuja característica principal é a dor ser acompanhada de desejo imperioso de defecar. O paciente sente uma dor intensa, espasmódica, e tem a impressão de que a defecação será abundante, mas elimina apenas pequena quantidade de fezes ou muco. O tenesmo ocorre nas afecções do reto, especialmente nos processos inflamatórios agudos, e na síndrome disentérica.

A *dor abdominal* apresenta maior dificuldade de interpretação em vista do grande número de vísceras e órgãos aí situados, com os quais o intestino grosso mantém estreitas relações anatômicas. Por ser mais difícil, sua avaliação depende de anamnese cuidadosa, espírito crítico e um conhecimento maior das afecções que podem provocá-la. Um bom exemplo dessa dificuldade é a ocorrência de dor abdominal reflexa, em crianças com pneumonia. Por isso, a análise clínica tem que ser abrangente, não podendo restringir-se ao abdome o exame de um paciente que se queixa de dor aí localizada (Quadros 6.19 e 6.20 e Figura 17.2).

A dor abdominal originada no intestino grosso pode ser aguda, de instalação súbita e com pouco tempo de duração; ou crônica, persistindo dias, semanas ou meses. Nesses casos, costuma ter períodos de acalmia.

Causas da dor

A melhor referência para o raciocínio diagnóstico é a localização da dor, em virtude da projeção na parede abdominal das vísceras. Assim:

Dor no quadrante superior direito

São poucas as causas colônicas de dor nessa região, devido à localização profunda da víscera em relação à parede abdominal. Quando presente, deve-se pensar em impactação fecal alta e obstipação intestinal grave. Nessa eventualidade, a dor adquire características de cólica.

Dor no quadrante inferior direito

Nessa topografia, em razão da proximidade do cólon (ceco e início do cólon ascendente) com a parede abdominal, o quadro doloroso é mais facilmente avaliado.

Várias afecções do cólon podem causar dor nessa região, destacando-se a apendicite, o câncer do ceco, processos inflamatórios (doença de Crohn, tuberculose intestinal), invaginação, suboclusão ou oclusão por lesões benignas ou malignas.

Dor no quadrante superior esquerdo

Como causa de dor nessa área, incluem-se a diverticulite, a impactação fecal alta e a obstipação intestinal crônica. A correta interpretação da dor torna-se difícil pela presença de inúmeros órgãos nessa região (estômago, pâncreas, baço, rim) que também podem provocá-la.

Dor no quadrante inferior esquerdo

Sendo o cólon sigmoide normalmente palpável, é possível, com certa segurança, definir por manobras palpatórias a origem do quadro doloroso. A afecção que mais comumente provoca dor nessa região é a doença diverticular do cólon. Os divertículos podem inflamar-se, dando origem a diverticulite ou abscesso, às vezes com perfuração em peritônio livre e consequente peritonite. Nesses casos, inicialmente a dor é bem localizada, mas, com a evolução do processo, torna-se difusa. Além da

doença diverticular, são causas de dor nessa região a obstipação crônica, processos inflamatórios ou irritação da mucosa intestinal – seguida de espasmos, como no cólon irritável – e neoplasias.

Dor abdominal difusa

Embora o paciente informe, algumas vezes, que a dor teve início em determinada região, o que caracteriza este tipo de dor é que, com o passar do tempo, ela se difunde por todo o abdome. Exemplo típico é a dor da peritonite; sua localização inicial depende da lesão que originou o comprometimento do peritônio. Assim, quando ocorre perfuração do sigmoide, como complicação de uma diverticulite, a dor inicia-se no quadrante inferior esquerdo, mas algumas horas após, à medida que o quadro se agrava, torna-se difusa. Mesmo quando a dor não é mais intensa na sua localização inicial, manobras palpatórias adequadas permitem definir com alguma precisão – e isso é fundamental no raciocínio diagnóstico – o órgão em que teve início o processo inflamatório. Em consequência da peritonite, além da sensação dolorosa, a parede abdominal torna-se endurecida, condição denominada *abdome em tábuas*.

Várias afecções podem provocar dor abdominal difusa, destacando-se a colite, a obstipação intestinal e a impactação fecal.

Diarreia

A diarreia caracteriza-se pelo aumento do número de dejeções e diminuição da consistência das fezes (ver *Intestino delgado*, neste capítulo).

Boxe

Disenteria é uma síndrome na qual, além da diarreia, observam-se cólicas intensas e fezes mucossanguinolentas. Além disso, ao final de cada evacuação ocorre tenesmo. A síndrome disentérica pode ser de origem amebiana ou bacilar.

Algumas vezes, torna-se difícil diferenciar uma diarreia causada por afecção do intestino delgado (*diarreia alta*) de uma originada no cólon (*diarreia baixa*). É importante analisar a evolução do quadro diarreico no decorrer de um dia. Existe, inclusive, um aforisma que, embora não tenha valor absoluto, serve como fonte de referência na avaliação de uma diarreia. Costuma-se dizer que o “cólon dorme à noite”; isso significa que, em um paciente que apresenta uma diarreia contínua, dia e noite, deve-se considerar que sua origem possivelmente não é colônica ou exclusivamente colônica.

A diarreia baixa compreende dois grupos: diarreia aguda e diarreia crônica (Quadro 6.22).

Dentre as causas de diarreia aguda, sobressaem: a retocolite ulcerativa inespecífica, na qual quase sempre as fezes são amolecidas e vêm misturadas com sangue, eventualmente com muco e pus; as colites amebianas; as colites e retites actínicas; a doença de Crohn do reto e do cólon. O câncer do intestino grosso, principalmente quando localizado no cólon direito, provoca diarreia em alguma fase de sua evolução e, portanto, não deve ser esquecido no diagnóstico diferencial.

Praticamente todas estas afecções podem causar diarreia crônica. Algumas vezes por não responderem à terapêutica instituída na fase aguda, outras vezes pela própria evolução da doença. Existem, no entanto, algumas enfermidades que têm como característica clínica principal uma diarreia crônica desde o início. Entre elas destaca-se o cólon irritável, que apresenta no seu curso alternância de diarreia e obstipação.

Boxe

Mudança do ritmo intestinal

Tal condição, quando presente, sempre leva a pensar em câncer do intestino grosso. Assim, um paciente que tinha um ritmo intestinal normal e passa a apresentar alternância de obstipação e diarreia obriga o médico a programar uma investigação adequada.

É preciso lembrar que tumores localizados no lado direito do cólon evoluem geralmente com diarreia, quase sempre crônica.

Obstipação ou constipação intestinal

O ritmo intestinal varia de um indivíduo para outro. Considera-se normal desde três evacuações por dia até uma evacuação a

cada 2 dias, ou seja, podem ser normais intervalos de 8 a 48 h entre uma exoneração intestinal e a seguinte, desde que as fezes não sejam líquidas nem ressecadas.

Quando as fezes ficam retidas por mais de 48 h, diz-se que há obstipação ou constipação intestinal, fato designado na linguagem leiga como “prisão de ventre” ou “intestino preso”. Para se caracterizar a obstipação intestinal é importante saber também a consistência das fezes, que podem ser apenas um pouco mais duras, ressecadas ou em cíbalos (fezes em pequenas bolas, como as dos caprinos).

A adequada progressão das fezes no intestino depende de muitos fatores, destacando-se a composição do bolo fecal, em especial da quantidade de fibras na alimentação, a regulação neurovegetativa, merecendo referência a integridade dos plexos intramurais, a ação de hormônios secretados no próprio aparelho digestivo ou fora dele (principalmente da tireoide) e de várias substâncias (serotonina, prostaglandinas). Têm importante papel no ritmo intestinal as condições psicológicas do paciente, pois os arcos reflexos que participam da evacuação intestinal mantêm conexões com o diencéfalo e o córtex.

A multiplicidade de fatores fisiopatológicos que participam da gênese da obstipação permite reconhecer sete grupos de causas (Quadro 6.25):

Relacionadas com a alimentação inadequada (dieta pobre em fibras)

Mecânicas: quando há lesões que ocluem o lúmen ou impedem a contração das paredes intestinais (malformações, oclusão tumoral, processos inflamatórios)

Neurogênicas: há comprometimento das estruturas nervosas (aganglionose ou doença de Hirschsprung, megacólon chagásico, paraplegia, esclerose múltipla)

Metabólico-hormonais: hipotireoidismo, uremia, hiperparatireoidismo, porfiria

Medicamentosas: antiácidos, anticolinérgicos, opiáceos

Relacionadas com a inibição reiterada do reflexo da evacuação (“não atender ao chamado do intestino”) e por hipossensibilidade senil

Psicogênicas: alterações emocionais, muitas vezes ligadas a traumas na infância, depressão.

Quadro 6.25	
Causas de obstipação intestinal.	
Alimentação deficiente em fibras	
Hábitos inadequados de defecação	
Impactação fecal	
Doença de Hirschsprung	
Megacólon chagásico	
Hipotireoidismo	
Hiperparatireoidismo	
Diabetes	
Insuficiência renal crônica	
Cólon irritável	
Lesões obstrutivas do cólon	

Câncer do cólon
Doença de Parkinson
Lesões da medula espinal
Senilidade
Medicamentos (bloqueadores dos canais de cálcio, antidepressivos tricíclicos, suplementos de ferro, antiácidos, anticolinérgicos, opiáceos)
Transtorno depressivo

Sangramento anal (enterorragia)

É um sintoma que leva o paciente a procurar o médico sempre com apreensão. Contudo, na maioria das vezes é provocado por hemorroidas, doença benigna e de fácil solução terapêutica. Isso não significa que, mesmo diante de evidências de hemorroidas, o médico tenha o direito de dar-se por satisfeito e encerrar a investigação sumariamente. Assim procedendo, corre o risco de deixar sem diagnóstico uma lesão localizada a montante do canal anal (câncer do reto e do cólon, por exemplo) que também pode estar sangrando (Quadro 6.26).

Outra causa comum de hemorragia é a doença diverticular difusa dos cólons, na qual sempre se deve pensar quando se trata de indivíduos acima da quarta década da vida que apresentam episódios de sangramento anal.

Os pólipos também sangram com facilidade, sendo uma causa comum de hemorragia digestiva em crianças e jovens. No adulto justifica-se certa preocupação pela possibilidade de estas lesões se malignizarem, dando origem aos adenocarcinomas.

Processos inflamatórios, como as retites e as colites actínicas, também podem sangrar por lesões da mucosa.

Todo sangramento anal nos obriga a pensar também na possibilidade de uma hemorragia de partes mais altas do tubo digestivo (estômago e intestino delgado). Nesses casos, o sangue raramente é vermelho-vivo, mas, sim, escuro, em “borra de café” (melena), ou apresenta aspecto de ter sofrido certo grau de digestão. Contudo, havendo distúrbios da atividade motora do tubo digestivo (atividade mais rápida), o sangue pode ser rapidamente eliminado sob a forma de enterorragia.

Prurido anal

É manifestação clínica que ocorre em diferentes condições e pode tornar-se muito incômoda. Suas causas principais são má higiene, enterobíase (principal causa em crianças), doenças anorretais cutâneas (fissuras, eczemas, dermatite seborreica, psoríase, dermatite de contato) e doenças sistêmicas, em especial o diabetes e as hepatopatias crônicas.

Em determinados pacientes não se consegue identificar uma causa orgânica, considerando-se nesses casos possíveis causas psicogênicas.

Distensão abdominal

Caracteriza-se por aumento de volume do ventre e pode traduzir várias condições, tais como ascite, meteorismo, fecaloma, neoplasias.

Quadro 6.26

Causas de enterorragia.

Hemorroidas
Fissura anal

Câncer do cólon
Pólipos
Diverticulose
Retocolite ulcerativa
Colite amebiana ou bacilar
Proctite

Com relação ao intestino grosso, a distensão abdominal depende de dificuldade do trânsito nos cólons, ou seja, algum obstáculo que impeça a progressão de gases e fezes.

Uma causa importante de distensão aguda é o vólvulo do sigmoide (torção do cólon sigmoide sobre seu próprio eixo), uma complicação grave do megacólon chagásico. Nessa afecção é comum a formação de fecaloma resultante da estagnação fecal no cólon sigmoide ectasiado. Por vezes o fecaloma se amolda às paredes do reto, obliterando por completo o seu lúmen e produzindo um quadro de oclusão intestinal baixa com grande distensão abdominal (impactação fecal).

Outra causa é o câncer do intestino, que pode ocluir o lúmen do órgão, ocasionando acúmulo de fezes e gases a montante da neoplasia. Devem ser citadas também a estenose do cólon e do reto, bridas pós-cirurgia abdominal e dilatação aguda do cólon, presente algumas vezes no megacólon tóxico, uma das complicações da retocolite ulcerativa.

Pacientes com megacólon chagásico apresentam com certa frequência um quadro de distensão abdominal provocada pela incoordenação da atividade motora do cólon, que impede a progressão do conteúdo intestinal. No exame desses pacientes visualiza-se o relevo das alças colônicas – geralmente do cólon sigmoide – na parede abdominal, indicando as “contrações” vigorosas desse segmento do intestino.

Náuseas e vômitos

As náuseas e os vômitos não são frequentes nas afecções do intestino grosso. Contudo, nos pacientes com cólon irritável, tais manifestações são comuns durante as crises dolorosas.

Na oclusão intestinal, os vômitos surgem à medida que o quadro clínico evolui. Após determinado tempo, tornam-se fecaloides.

Anemia e emagrecimento

São as lesões neoplásicas do cólon direito as que costumam evoluir com anemia; isso porque no cólon direito há também reabsorção de ferro. As lesões aí localizadas alteram a fisiologia da mucosa intestinal, ocasionando déficit desse elemento.

Os pacientes com megacólon chagásico apresentam também, com frequência, alterações no esôfago (megaesôfago chagásico) que podem causar dificuldade para deglutir, causando emagrecimento e até caquexia.

A doença diverticular difusa dos cólons pode causar grandes hemorragias que levam à anemia aguda, porém o mais comum é a perda crônica de pequenas quantidades de sangue, imperceptíveis a olho nu, mas que também ocasionam anemia.

Em alguns pacientes com doença hemorroidária, repetidas perdas de sangue provocam anemia de certa intensidade, responsável por parte dos sintomas que os pacientes relatam.

FÍGADO, VESÍCULA E VIAS BILIARES

Os principais sintomas do fígado, da vesícula e das vias biliares são *dor*, *icterícia* e *náuseas e vômitos* (Figuras 6.30 e 6.31).

Dor

A dor originária no fígado, na vesícula e nas vias biliares localiza-se no quadrante superior direito do abdome e apresenta diferentes características, conforme a afecção que a provoca (Quadros 6.19 e 6.20).

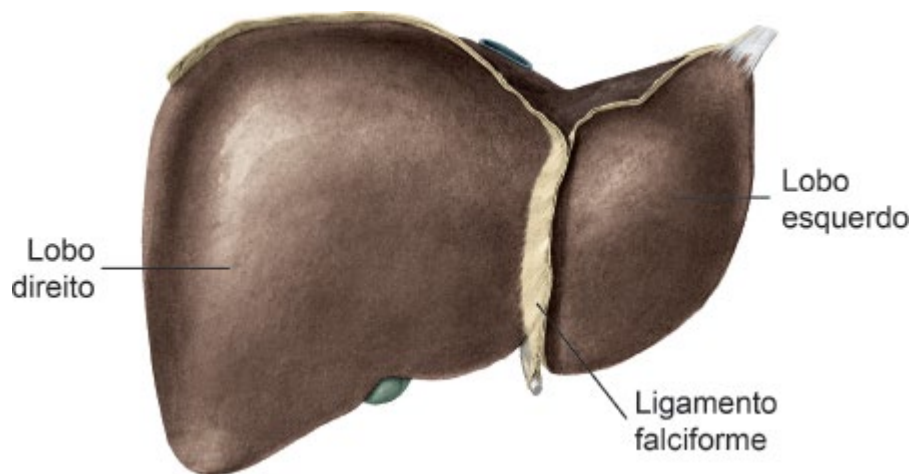


Figura 6.30 Representação esquemática da face anterior do fígado.

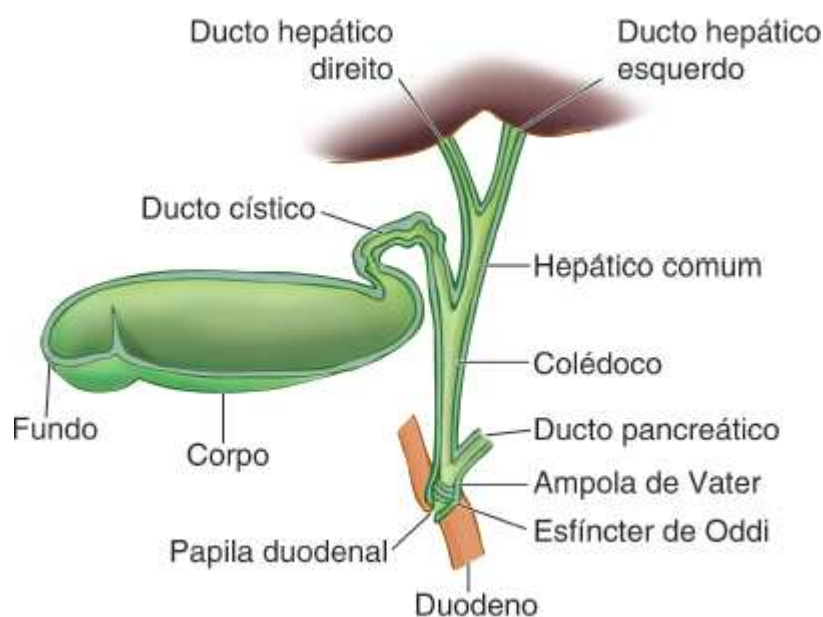


Figura 6.31 Vesícula e vias biliares extra-hepáticas.

O parênquima hepático não tem sensibilidade, mas a cápsula de Glisson, quando distendida rapidamente, ocasiona dor contínua no hipocôndrio direito, sem irradiação, que piora com a palpação e com a realização de esforço físico. Sua causa mais comum é a congestão passiva do fígado, uma das principais manifestações da insuficiência ventricular direita, constituindo o que se denomina *hepatomegalia dolorosa*. Esse tipo de dor pode ocorrer também na hepatite aguda viral e na hepatite alcoólica, quando houver rápido crescimento do fígado.

A dor do abscesso hepático pode ser muito intensa e localiza-se na área de projeção do abscesso, a qual se torna muito sensível, dificultando sobremaneira a palpação da víscera.

A dor originada nas vias biliares apresenta-se de duas maneiras:

Cólica biliar: início súbito, grande intensidade, localização no hipocôndrio direito e duração de várias horas; em geral, o paciente fica inquieto, nauseado, podendo apresentar vômitos. A causa mais frequente é a colelitíase. O aparecimento de icterícia após episódio de cólica biliar sugere a migração do cálculo para o colédoco.

Colecistite aguda: a dor é contínua, localizada no hipocôndrio direito, podendo irradiar-se para o ângulo da escápula ou para o ombro direito, via nervo frênico, quando há comprometimento do diafragma. Acompanha-se de hiperestesia e contratura muscular. A palpação da região ao fazer uma inspiração profunda desperta dor. É o que se chama *sinal de Murphy*.

Boxe

O diagnóstico diferencial da dor originada no fígado e nas vias biliares inclui várias afecções, destacando-se a pancreatite aguda, a úlcera péptica perfurada, a cólica nefrética, a pleurite e, mais raramente, a isquemia

Icterícia

Icterícia consiste em uma coloração amarelada da pele e das mucosas, devida à impregnação dos tecidos por pigmentos biliares, quando os níveis de bilirrubina são maiores que 2 mg/dℓ (normal < 1 mg/dℓ).

Icterícia leve só é visível com boa iluminação, de preferência com luz natural.

A investigação deste sintoma inclui tempo de duração, intensidade e evolução do quadro icterício – se foi de instalação súbita ou gradativa, se vem aumentando progressivamente ou se está havendo flutuação da intensidade. Para o raciocínio diagnóstico, interessa saber também a cor da urina, das fezes e a presença ou não de prurido.

Mecanismos: o aumento de pigmentos biliares no plasma responsável pela icterícia pode ser por destruição excessiva de hemácias (*icterícia hemolítica*), por lesão dos hepatócitos ou condutos biliares intra-hepáticos (*icterícia de origem hepática*) ou por obstrução das vias biliares extra-hepáticas (*icterícia obstrutiva*).

Boxe

Outras causas de coloração amarela da pele e da esclerótica

Em algumas pessoas saudáveis a pele apresenta uma tonalidade amarelada, mas nesses casos a esclerótica não aparece pigmentada. Alguns alimentos (cenoura e mamão) e determinados fármacos, em especial os antimaláricos, contêm substâncias que podem conferir uma coloração amarelada à pele, mas nesses casos a esclerótica também mantém sua cor normal.

Em contrapartida, em afrodescendentes, pode-se perceber uma tonalidade amarelada na parte exposta da esclerótica, dada pelo acúmulo na conjuntiva de uma pequena camada gordurosa; mas, como ele não atinge toda a superfície anterior do olho, basta um exame mais detalhado dos olhos para descartar a possibilidade de icterícia.

Nos casos de icterícia obstrutiva a presença de prurido e a descoloração das fezes chamam a atenção do paciente e têm valor no raciocínio diagnóstico.

As causas mais frequentes de icterícia são: hepatite infecciosa, hepatopatia alcoólica, hepatopatia por medicamentos, cirrose hepática, leptospirose, malária, septicemias, anemias hemolíticas, cirrose biliar, coledocolitíase, neoplasias do pâncreas, pancreatite crônica e neoplasias das vias biliares. Inúmeros medicamentos podem produzir icterícia (Quadro 6.27).

Náuseas e vômitos

As náuseas frequentemente precedem os vômitos, mas algumas vezes ocorrem de forma isolada e o próprio paciente provoca o vômito na tentativa de obter alívio.

Os vômitos são manifestações frequentes das doenças hepatobiliares, ocorrendo na fase inicial da hepatite infecciosa, juntamente com anorexia, nas colecistites e na colelitíase, muitas vezes relacionados com a ingestão de alimentos gordurosos.

Quadro 6.27

Causas de icterícia.

Fígado

Hepatite infecciosa

Hepatite alcoólica

Cirrose hepática

Anomalias genéticas

Hepatopatia por medicamentos (paracetamol, estrogênios, eritromicina, nitrofurantoína, rifampicina, AINEs, clorpromazina, valproato, clavulanato, isoniazida)

Vias biliares

Litíase do colédoco

Colangiólite

Cirrose biliar

Neoplasias da via biliar

Pâncreas

Neoplasias do pâncreas

Pancreatite crônica

Anemias hemolíticas

Doenças infecciosas e parasitárias

Leptospirose

Malária

Septicemia

Nos episódios de cólica biliar, náuseas e vômitos ocorrem quase invariavelmente.

Boxe

Não tem significado especial a presença de bile no material vomitado, pois isso ocorre em quaisquer condições em que haja repetidos vômitos.

PÂNCREAS

Os principais sintomas das doenças pancreáticas são *dor, náuseas e vômitos, icterícia, diarreia e esteatorreia* e os que constituem a *síndrome de má absorção*.

Dor

A dor é o sintoma mais frequente nos processos inflamatórios da glândula (pancreatite). Geralmente é do tipo lancinante nas formas agudas ou nas reagudizações das pancreatites crônicas, mas sua intensidade varia com o tipo e a extensão da lesão.

Sua localização e irradiação dependem da região pancreática acometida. Localiza-se na região epigástrica, à direita da linha mediana, com irradiação para o dorso, quando a região acometida é a cabeça do pâncreas; na região epigástrica, à esquerda da

linha mediana, no acometimento do corpo; e no hipocôndrio esquerdo, com irradiação para o dorso, quando o processo responsável pela dor atinge a cauda (Quadros 6.19 e 6.20).

A forma clássica, ou seja, dor em faixa ou em cinta, só é observada em uma pequena porcentagem de casos, quando toda a glândula é comprometida.

Náuseas e vômitos

Náuseas e vômitos estão presentes na maioria dos pacientes com processo inflamatório do pâncreas. Os vômitos geralmente são de difícil controle, podendo levar, rapidamente, a um desequilíbrio hídrico e eletrolítico.

Icterícia

A icterícia é um sintoma comum nas doenças pancreáticas. Ela poderá ser discreta e fugaz na pancreatite aguda, principalmente na forma edematosa, sendo causada por:

Obstrução do colédoco terminal: causadora da icterícia e da própria pancreatite

Edema do tecido pancreático: comprime o colédoco intrapancreático, determinando a icterícia ou contribuindo para o aumento da obstrução.

Diarreia e esteatorreia

Na vigência de insuficiência pancreática a diarreia caracteriza-se por fezes volumosas, pastosas, brilhantes, de odor rançoso, coloração pálida, deixando traços ou camada oleosa sobre a água do vaso sanitário (ver *Intestino delgado*, neste capítulo).

Boxe

Síndrome de má absorção

Em consequência de deficiência das enzimas pancreáticas, a digestão e a absorção de proteínas, lipídios, vitaminas lipossolúveis e oligoelementos estão prejudicadas, o que acarreta edema tipo carencial, osteoporose e lesões dermatológicas do tipo pelagra.

RINS E VIAS URINÁRIAS

Os sintomas das doenças dos rins e das vias urinárias incluem *alterações miccionais* (hesitação – que corresponde a demora ou atraso involuntário para iniciar o ato de urinar –, urgência – que é a necessidade imperiosa de urinar –, alterações do jato urinário, retenção urinária, incontinência urinária), *alterações do volume e do ritmo urinário* (oligúria, anúria, poliúria, disúria, polaciúria, frequência, noctúria), *alterações da cor da urina* (hematúria, hemoglobínúria, mioglobínúria, porfirinúria, urina turva), *alterações do cheiro da urina, dor, edema e febre e calafrios* (Figura 6.32).

Alterações miccionais

Em condições normais e em clima ameno, uma pessoa adulta elimina de 800 a 2.500 mL de urina por dia.

A capacidade de armazenagem da bexiga é de 400 a 600 mL. Assim, ocorrem 2 a 4 micções por dia. Normalmente o paciente não acorda à noite para urinar ou o faz apenas uma vez, desde que não ingira muito líquido antes de deitar.

Após uma micção normal permanece na bexiga uma pequena quantidade de urina, cerca de 3 a 4 mL, chamada *urina residual*.

Alterações do jato urinário

Um jato urinário fraco, lento e fino no recém-nascido ou em meninos é sugestivo de fimose, estenose do meato uretral ou válvula da uretra posterior.

Hesitação, ou seja, demora para iniciar a micção, *esforço para urinar* e *diminuição da força* e do *calibre do jato urinário* são as manifestações clínicas mais comuns das uropatias obstrutivas infravesicais.

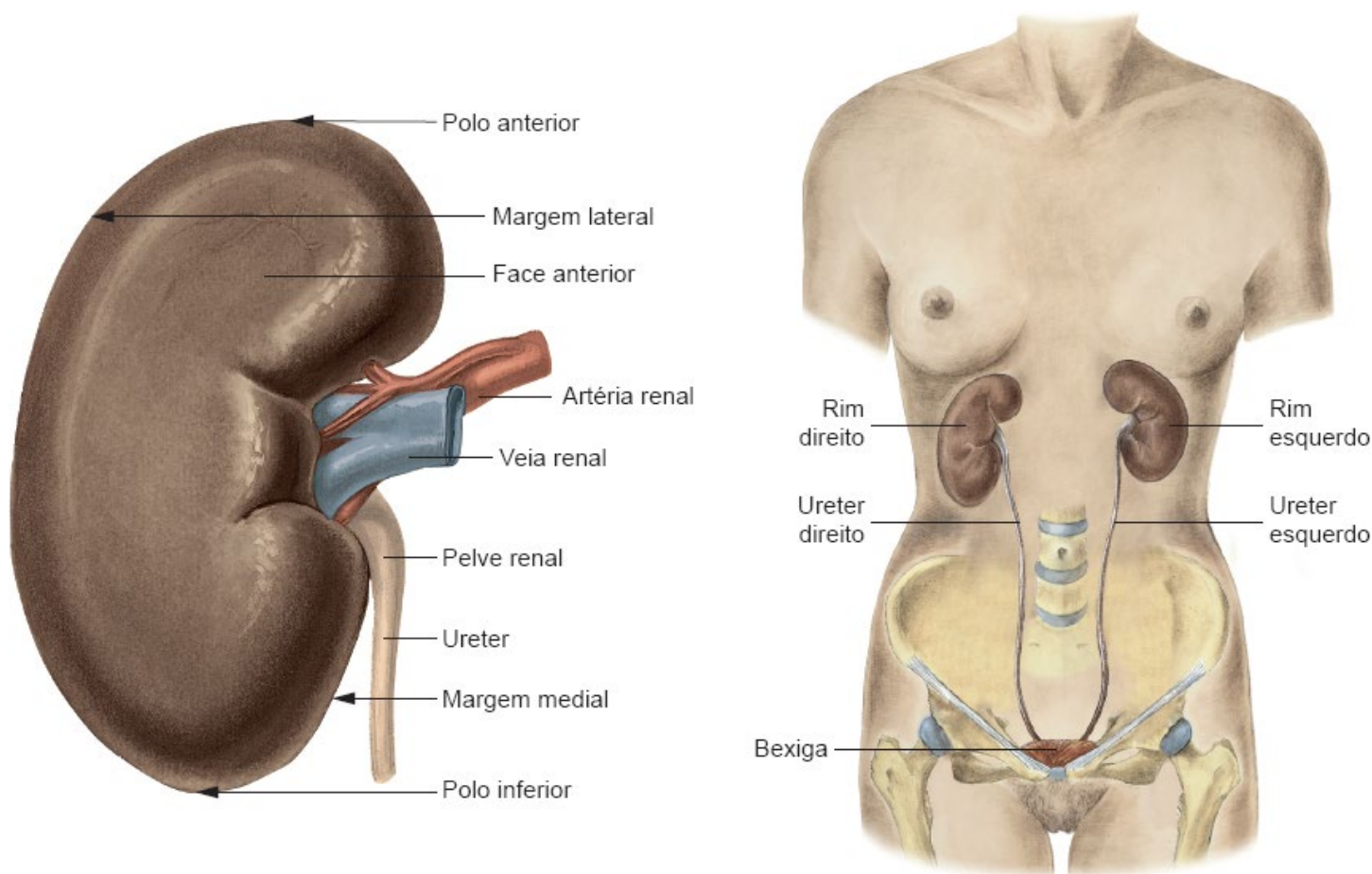


Figura 6.32 Rins e vias urinárias. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Boxe

Incontinência urinária em pessoas idosas

A incontinência urinária está incluída, juntamente com a depressão, as demências, os estados confusionais, as quedas e a síndrome dos maus-tratos, no que se convencionou chamar de *Os Gigantes da Geriatria*. São problemas complexos, muito comuns nos idosos, extremamente incapacitantes e geralmente de etiologia multifatorial. Sua avaliação demanda tempo e seu tratamento é complexo. Além disso, muitas vezes são considerados como um fenômeno normal do envelhecimento, fato que retarda a introdução de medidas terapêuticas.

Na avaliação de uma mulher idosa com incontinência deve-se ter em mente a possibilidade de incontinência de esforço por relaxamento excessivo da musculatura do assoalho pélvico e, no homem idoso, a incontinência por transbordamento em consequência de hipertrofia prostática.

Não se pode esquecer das causas transitórias de incontinência, mais comuns nos idosos em função de terem reserva funcional vesical e uretral menor, destacando-se as infecções, a uretrite atrófica (deficiência estrogênica na mulher idosa), os estados confusionais, medicamentos, imobilidade e fecaloma (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Retenção urinária

Refere-se à incapacidade da bexiga de esvaziar-se, parcial ou completamente. É fundamental diferenciá-la da *anúria*, condição em que a bexiga se encontra vazia por interrupção do funcionamento renal.

Na retenção urinária a bexiga distendida é palpável na região suprapúbica (globo vesical). A passagem de um cateter seguida de desaparecimento do *globo vesical* sela o diagnóstico de retenção. Na anúria a bexiga está vazia e o cateterismo comprova a inexistência de urina.

A retenção urinária pode ser completa ou incompleta. Na forma completa o indivíduo é incapaz de eliminar sequer

quantidades mínimas de urina. Pode ser aguda ou crônica. A retenção completa aguda geralmente é muito dolorosa. O paciente se apresenta ansioso, pálido, com sudorese, e relata um intenso desejo de urinar que se acentua a cada contração da bexiga. Ao exame físico, encontra-se massa suprapúbica, arredondada, tensa, que origina som maciço à percussão, contrastando com o ruído timpânico em torno dela. Ressalte-se que a palpação da região hipogástrica acentua a vontade de urinar.

A retenção urinária incompleta, quase sempre crônica, caracteriza-se pela permanência na bexiga de certa quantidade de urina depois de terminado o ato miccional. Se a quantidade de urina for menor do que a capacidade vesical, diz-se que há uma retenção urinária incompleta sem retenção. Se, ao contrário, a urina que permanece na bexiga, após a micção, for maior do que a capacidade vesical, surge um quadro de retenção urinária incompleta sem distensão.

Boxe

Causas de retenção urinária

O diagnóstico da retenção urinária é feito, basicamente, pelo exame clínico, sendo importante tentar definir o tipo de retenção e seu agente causal. A faixa etária do paciente é um dado relevante no raciocínio diagnóstico. Em crianças, por exemplo, a retenção pode ser ocasionada por cálculo vesical impactado no colo da bexiga ou na uretra, estenose da uretra ou do meato uretral externo, fimose cerrada acompanhada de balanopostite, válvula da uretra posterior ou por disfunção neurovesical. Já em adolescentes e adultos jovens, as causas mais comuns são inflamação da glândula de Cowper de etiologia blenorragica, prostatite, abscesso prostático, polirradiculoneurite, traumatismos uretrais ou da medula espinal. Nos indivíduos mais idosos deve-se pensar na possibilidade de crescimento prostático, benigno ou maligno, esclerose múltipla, uso de medicamentos anticolinérgicos, anti-histamínicos, tranquilizantes (ansiolíticos), antidepressivos ou relaxantes da musculatura lisa.

Na *bexiga neurogênica* a retenção urinária é consequência da incapacidade da musculatura vesical de contrair-se com força adequada, seja por haver lesões do neurônio motor superior que interferem no reflexo da micção, seja por lesões de nervos sacrais responsáveis pela inervação da bexiga.

Incontinência urinária

Quando há obstrução das vias urinárias inferiores, a bexiga não se esvazia adequadamente após cada micção, surgindo a necessidade de urinar mais vezes durante o dia e a noite, ou seja, *polaciúria* e *noctúria*. Aliás, o paciente sente que ainda ficou alguma urina na bexiga após findar a micção, fato que lhe dá a sensação de esvaziamento incompleto da mesma.

A incontinência urinária só ocorre nos casos avançados, sob a forma de incontinência, de urgência ou incontinência paradoxal, ou de transbordamento, que surge quando a pressão intravesical se iguala à resistência uretral, de modo que a urina passa a gotejar continuamente. A urina que permanece na bexiga, após a micção, é como se fosse um líquido estagnado, muito favorável à proliferação bacteriana. Instalada a infecção, surgem dor à micção, urina turva e odor desagradável.

Na incontinência urinária verdadeira, o paciente elimina urina sem perceber, quase continuamente. Isso é observado nas formas completas, na epispadia e em lesões raquimedulares.

Alterações do volume e do ritmo urinário

Oligúria e anúria

Uma dieta normal provoca a eliminação de pelo menos 800 mL de urina, como meio de excreção da ureia e de outros produtos resultantes do metabolismo.

Denomina-se oligúria a excreção de um volume de urina inferior às necessidades para eliminação de catabólitos. Clinicamente, convencionou-se chamar de oligúria uma diurese inferior a 400 mL/dia.

A oligúria geralmente decorre de redução do fluxo sanguíneo renal (insuficiência renal aguda, insuficiência cardíaca) ou da diminuição da capacidade de filtração dos glomérulos (glomerulonefrite, por exemplo).

Quando a diurese é inferior a 100 mL em 24 h, diz-se que há anúria, que é resultante de oclusão bilateral das artérias renais, obstrução de ambos os ureteres ou necrose cortical bilateral.

Poliúria

Corresponde a um volume urinário acima de 2.500 mL/dia.

Como o volume de cada micção está limitado pela capacidade vesical, verifica-se um maior número de micções, inclusive à noite. A medida do volume urinário de 24 h pode ser necessária para confirmação da presença de poliúria, pois o aumento do número de micções (polaciúria) quase sempre nos leva a pensar em aumento do volume urinário.

Existem dois mecanismos básicos de poliúria: por *diurese osmótica*, decorrente da excreção de maior quantidade de solutos, que por sua vez determina maior excreção de água, como no diabetes descompensado, ou então por *incapacidade de concentração urinária*, como se observa no diabetes insípido e na hipopotassemia.

Na insuficiência renal crônica, quando o comprometimento renal é ainda mais moderado, ocorre poliúria pela associação dos dois mecanismos: diurese osmótica, devida à uremia, e incapacidade de concentração. Há também poliúria quando a medula renal está comprometida, como se observa na pielonefrite crônica. As causas de poliúria estão descritas no Quadro 6.28.

Disúria

Disúria significa micção associada à sensação de dor, queimor ou desconforto. Ocorre na cistite, prostatite ou uretrite.

O termo disúria, etimologicamente, significa qualquer alteração da micção, incluindo frequência, hesitação, gotejamento, urgência, estrangúria; contudo, é preferível restringir sua abrangência, usando-o apenas com o significado de dor ou desconforto ao urinar.

Urgência e polaciúria

Urgência corresponde à necessidade súbita e imperiosa de urinar, podendo, mesmo, haver esvaziamento involuntário da bexiga.

Quando a necessidade de urinar ocorre repetidas vezes, com intervalo entre as micções inferior a 2 h e sem que haja concomitante aumento do volume urinário (poliúria), diz-se que o paciente está com polaciúria.

Estes sintomas são provocados por redução da capacidade de armazenagem da bexiga, dor à distensão vesical ou por comprometimento da uretra posterior. Decorrem de várias causas, tais como infecção, cálculo, obstrução, alterações neurológicas. As causas de polaciúria são apresentadas no Quadro 6.29.

A ansiedade também pode manifestar-se com polaciúria, chegando a caracterizar uma condição denominada “bexiga irritável”, somatização de transtornos emocionais no aparelho urinário.

Quadro 6.28 Causas de poliúria.
Diabetes
Diabetes insípido
Insuficiência renal crônica
Polidipsia nervosa
Medicamentos (diuréticos)

Quadro 6.29 Causas de polaciúria.
Cistite
Litíase vesical

Tumor vesical

Hiperplasia prostática

Câncer de próstata

Compressão extrínseca da bexiga

Doenças neurológicas

Tensão nervosa

Transtorno de ansiedade ("bexiga irritável")

Noctúria ou nictúria

Normalmente o indivíduo não acorda à noite para urinar ou o faz apenas uma vez, porque o ritmo de formação de urina decresce fisiologicamente no período noturno.

Denomina-se noctúria quando o ritmo circadiano da diurese se altera, ocasionando a necessidade de se esvaziar a bexiga durante a noite. Como exemplo, temos os pacientes com insuficiência cardíaca, renal ou hepática que retêm líquido durante o dia, principalmente nos membros inferiores. Quando eles se deitam à noite, o líquido retido no interstício retorna à circulação, resultando em aumento da diurese, com maior número de micções no período noturno. As causas de noctúria são apresentadas no Quadro 6.30.

Nos casos de insônia, pode ocorrer noctúria com pequeno volume urinário.

Alterações da cor da urina

A urina normal é transparente, tendo uma tonalidade que varia do amarelo-claro ao amarelo-escuro, conforme esteja diluída ou concentrada. Observa-se alteração da cor na *hematúria*, na *hemoglobinúria*, na *mioglobinúria*, na *porfirinúria* e na chamada *urina turva*.

Determinados corantes e pigmentos tingem a urina de vermelho ou de marrom-avermelhado, tornando necessário fazer a diferenciação com a hematúria, por meio do exame microscópico, que confirma a hematúria pela identificação das hemácias.

Alguns medicamentos modificam a cor da urina, emprestando-lhe aspecto amarelado, azulado, alaranjado, na dependência do pigmento existente no fármaco utilizado.

Hematúria

Hematúria significa presença de sangue na urina, podendo ser macro ou microscópica, ou seja, visível a olho nu ou só detectada ao exame microscópico. Pode ser persistente ou intermitente.

O aspecto da urina depende do volume de sangue e do pH da urina. Basta um centímetro cúbico de sangue em 1,5 ℓ de urina para conferir-lhe cor avermelhada ou marrom, facilmente identificável pelo paciente (hematúria macroscópica).

Pequena quantidade de sangue confere à urina uma cor marrom-escuro, se o pH for ácido. Se a urina for alcalina, a hemoglobina conserva sua cor vermelho-viva por mais tempo.

Boxe

Os sintomas que acompanham a hematúria são importantes para o diagnóstico de sua causa. Exemplos: hematúria acompanhada de febre, calafrios e disúria indica infecção urinária, enquanto a ocorrência de cólica renal sugere litíase urinária.

Pode-se ter uma ideia da origem do sangramento se o paciente souber informar o momento em que surge urina de cor vermelha ou sanguinolenta (início, meio ou final da micção), caracterizando três tipos: hematúria inicial, hematúria terminal e hematúria total.

Hematúria inicial indica origem prostática ou uretral. Isto porque o sangue acumulado na uretra é levado pelo primeiro jato de urina.

Quadro 6.30 Causas de noctúria.
Insuficiência renal crônica
Insuficiência cardíaca
Insuficiência hepática
Síndrome nefrótica
Hipertrofia prostática
Insônia
Ingestão de líquido à noite
Diuréticos

Hematúria terminal, dolorosa, às vezes com sangue rutilante, é encontrada na hiperplasia benigna da próstata, em consequência da ruptura de veias telangiectásicas do colo vesical ou da mucosa prostática quando o paciente faz esforço para urinar. No câncer da próstata a hematúria é rara e só ocorre quando o processo neoplásico invade a mucosa da bexiga ou da uretra. A hematúria terminal também pode ter origem na bexiga, quando um processo neoplásico ou a mucosa inflamada é “espremida” pela contração das fibras musculares do detrusor, na fase final da micção, ou quando cálculos vesicais lesionam a mucosa, provocando sangramento da bexiga no fim do ato miccional.

Hematúria total geralmente depende de lesões situadas acima do colo da bexiga, no ureter ou no rim, pois é necessário que haja tempo para que se misturem na bexiga o sangue e a urina. As principais causas de hematúria total são a glomerulonefrite aguda, a hipertensão arterial maligna, a necrose tubular aguda, rins policísticos, infarto renal, leptospirose, malária, tuberculose renal, síndrome de coagulação vascular disseminada, neoplasias, cálculos e uso de anticoagulantes (Figura 6.33 e Quadro 6.31).

Boxe

Pseudo-hematúria

Alguns pigmentos presentes em medicamentos e alimentos podem conferir uma cor rósea ou vermelha à urina, na ausência de hemoglobina ou hemácias.

Alimentos: beterraba, frutas vermelhas, alimentos com corantes vermelhos

Medicamentos: rifampicina, clorzoxazona, piridina, fenotiazina, fenitoína, doxorrubicina, daunomicina, laxativo com fenolftaleína.

O exame do sedimento urinário identifica a hematúria verdadeira.

Hemoglobinúria, mioglobínúria e porfirinúria

Hemoglobinúria é a presença de hemoglobina livre na urina, condição que acompanha as crises de hemólise intravascular (malária, leptospirose, transfusão de sangue incompatível, icterícia hemolítica).

Mioglobinúria resulta de destruição muscular por traumatismos ou queimaduras.

Porfirinúria é consequência da eliminação de porfirinas ou de seus precursores, os quais produzem coloração vermelho-vinhosa da urina, algumas horas depois da micção (ver *Metabolismo e condições nutricionais*, neste capítulo).

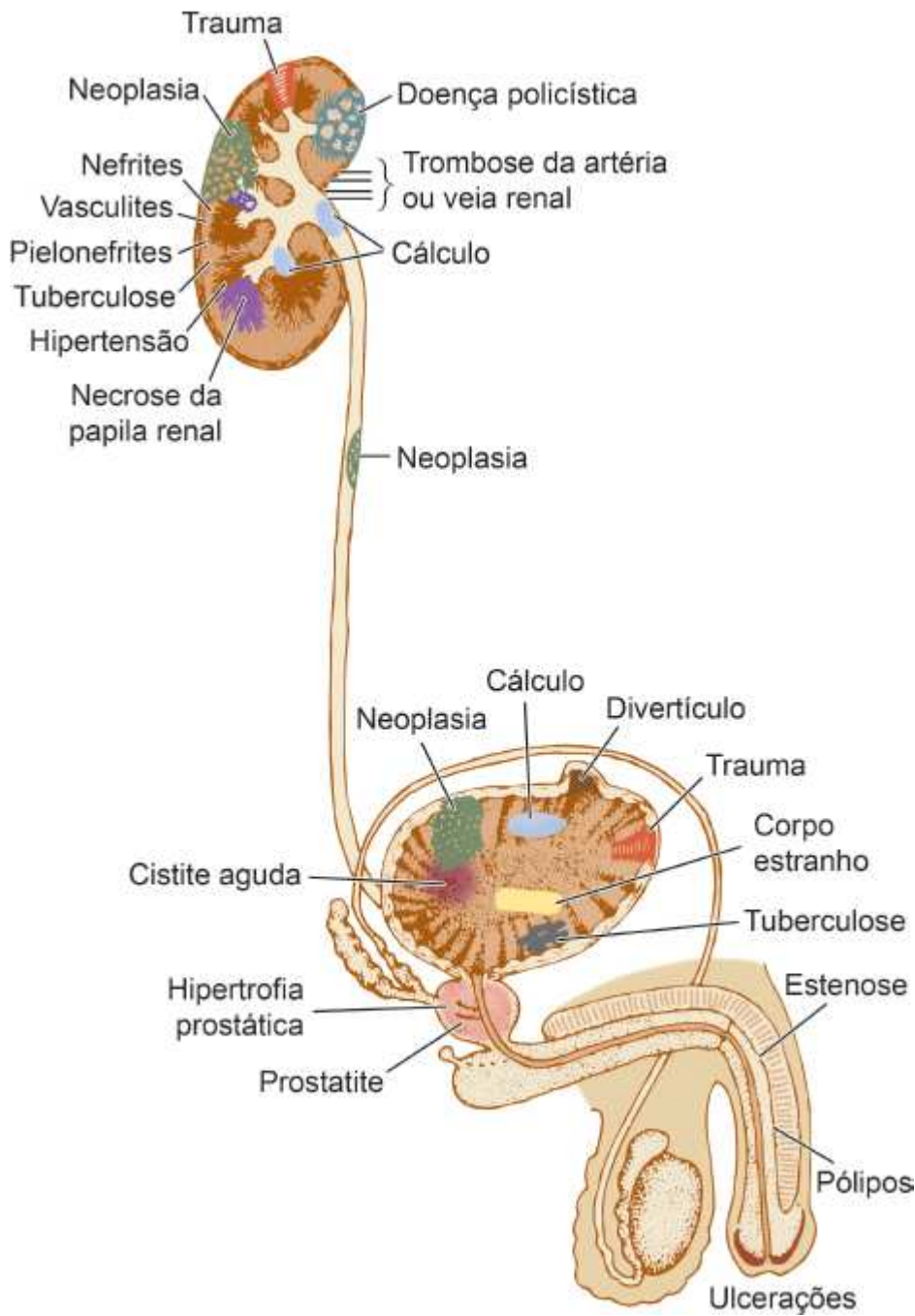


Figura 6.33 Causas de hematúria.

Boxe

Urina turva

Relato de urina turva significa apenas mudança da cor da urina, ocorre com frequência e tem causas diversas.

Sendo a urina uma solução supersaturada, algumas horas após emitida e guardada em um recipiente ela pode apresentar precipitação de diversos tipos de cristais (cristalúria), sendo mais frequentes os de ácido úrico, oxalato de cálcio e uratos amorfos quando a urina é ácida. Se ela for alcalina precipitam o carbonato e o fosfato de cálcio, turvando a urina. Este tipo de turvação não tem importância clínica.

Em contrapartida, urina turva, formando depósito esbranquiçado, de odor desagradável, pode ser indicativa de infecção urinária (cistite, pielonefrite, abscesso renal, perirrenal, uretral ou prostático).

Pacientes com icterícia podem relatar urina escura, cor de Coca-Cola.

Uma causa menos comum de urina turva é a obstrução de linfáticos. Nesse caso, a linfa drenada para as vias urinárias origina a *quilúria*, ficando a urina de coloração esbranquiçada, opalescente. Entre as causas de quilúria encontram-se a filariose, a tuberculose e as neoplasias.

Alterações do cheiro da urina

O cheiro *sui generis* da urina decorre da liberação de amônia.

Um simples aumento da concentração urinária pode determinar cheiro desagradável. Vários medicamentos podem modificar o cheiro da urina, destacando-se as vitaminas e os antibióticos. Porém, fetidez propriamente dita surge nos processos infecciosos, pela presença de pus ou por degradação de substâncias orgânicas.

Quadro 6.31

Causas de hematúria.

Litíase urinária

Glomerulonefrite aguda

Pielite/pielonefrite

Tuberculose renal

Rins policísticos

Neoplasias benignas e malignas dos rins e vias urinárias

Cistite

Poliarterite nodosa

Leucemias

Traumatismo toracoabdominal

Prostatite

Doenças hemorrágicas

Medicamentos (anticoagulantes)

Dor

A dor originada nos rins e vias urinárias pode assumir características diversas, destacando-se a *dor lombar e no flanco*, a *cólica renal ou nefrética*, a *dor vesical*, a *estrangúria ou tenesmo vesical* e a *dor perineal*.

Dor lombar e no flanco

O parênquima renal é insensível, mas a distensão da cápsula dá origem à dor que se localiza na região lombar e no flanco, por ser sua inervação relacionada com a desta parte do tronco. É descrita como profunda, de intensidade variável, fixa e persistente, que piora com a posição ortostática e se agrava no fim do dia. Lembra muito a lombalgia e dela precisa ser diferenciada (ver *Coluna vertebral*, neste capítulo).

Na síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda, nefrite intersticial e pielonefrite aguda, este tipo de dor geralmente está presente.

A obstrução urinária aguda devida a cálculo na pelve renal ou a obstrução ureteropélvica que causa dilatação tubular e aumento dos rins provoca também dor lombar, especialmente quando maior ingestão de líquido aumenta o fluxo urinário.

Alguns pacientes relatam dor semelhante após uso de diurético, principalmente furosemida.

Rins policísticos podem atingir grande volume sem causar dor, exceto quando algum cisto se rompe. Contudo, alguns pacientes relatam dor surda na região lombar ou no flanco.

Na inflamação perinefrética ocorre irritação da cápsula renal que causa dor intensa que aumenta com a movimentação; isso se observa na nefrite intersticial bacteriana, infarto renal, ruptura de cisto renal, quando ocorre hemorragia ou necrose tumoral, e no extravasamento de urina.

Boxe

“Dor nos rins”

Cumprе ressaltar que toda dor lombar ou no flanco, ou mesmo nas costas, costuma ser interpretada pelos pacientes como originária dos rins. No entanto, com muita frequência, ela é de natureza extrarrenal, provocada por contratura da musculatura lombar, alterações degenerativas das vértebras (espondiloartrose) ou comprometimento de disco intervertebral. Por isso, diante da queixa “dor nos rins”, deve-se estar atento para as doenças renais e para as enfermidades da coluna vertebral e anexos.

Cólica renal ou nefrética

Aplica-se esta denominação à dor decorrente de obstrução do trato urinário alto, com súbita dilatação da pelve renal ou do ureter, que se acompanha de contrações da musculatura lisa destas estruturas.

No início, pode haver apenas desconforto na região lombar ou no flanco, irradiando-se vagamente para o quadrante inferior do abdome do mesmo lado. Rapidamente esse desconforto evolui para dor de grande intensidade, acompanhada de mal-estar geral, inquietude, sudorese, náuseas e vômitos. O paciente move-se no leito ou levanta-se à procura de uma posição que lhe traga algum alívio.

A dor da cólica renal em geral começa no ângulo costovertebral, irradiando-se para a fossa ilíaca e região inguinal, alcançando o testículo e o pênis no homem e o grande lábio vaginal na mulher. O episódio doloroso pode durar horas ou dias, ocorrendo alívio espontâneo se houver desobstrução do ureter pelo deslocamento do cálculo ou coágulo. Mais comumente a dor só é aliviada após medicação analgésica ou antiespasmódica. O desaparecimento súbito da dor, ocasionado pela resolução natural da obstrução, é importante no diagnóstico diferencial.

Existem algumas variantes clínicas da cólica renal, na dependência da altura da obstrução. Assim, se a obstrução estiver na junção ureteropélvica, a dor costuma situar-se no flanco e irradiar-se para o quadrante superior do abdome ou mesmo para a região inguinal homolateral; já a obstrução ureterovesical acompanha-se de sintomas de irritação do trígono vesical, representados por disúria, urgência e polaciúria, que fazem pensar em cistite. Cálculo obstruindo o segmento final do ureter pode causar dor persistente no testículo e pênis, ou no grande lábio vaginal do mesmo lado, sem, entretanto, evidenciar sintomas de irritação vesical.

Dor vesical

A dor originada no corpo da bexiga geralmente se localiza na região suprapúbica. Quando ela decorre de irritação envolvendo a região do trígono e do colo vesical, irradia-se para a uretra e o meato externo, podendo ser relatada como uma sensação de queimor.

Estrangúria ou tenesmo vesical

Uma inflamação vesical intensa pode provocar a emissão lenta e dolorosa de urina, chamada estrangúria ou tenesmo vesical, que é decorrente de espasmo da musculatura do trígono e colo vesical.

Dor perineal

Infecção aguda da próstata causa dor perineal intensa, sendo referida no sacro ou no reto. Pode causar também estrangúria.

Edema

O edema que surge nas doenças renais resulta de diferentes mecanismos patogénéticos que lhe conferem características semiológicas próprias.

Na glomerulonefrite o edema é generalizado, mais intenso na região periorbitária pela manhã, quando o paciente acorda. No final do dia, se o paciente estiver deambulando normalmente, predomina nos membros inferiores.

Este edema decorre da retenção de sal e água em consequência das lesões glomerulares. Nas crianças, o aparecimento do edema costuma ser súbito, podendo acompanhar-se de manifestações de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, jugulares ingurgitadas, hepatomegalia dolorosa, dispneia e tosse, quando há comprometimento miocárdico concomitante.

Na glomerulonefrite crônica a evolução e a intensidade do edema são muito variáveis, observando-se, contudo, quase sempre o aparecimento de edema periorbitário, pela manhã. O paciente relata que acorda com os “olhos empapuçados”.

O edema da síndrome nefrótica é generalizado e mais intenso que o da glomerulonefrite, podendo chegar à anasarca, especialmente em crianças. Quando o estado geral do paciente é bom e ele consegue deambular, é comum observar-se, pela manhã, intenso edema facial. No fim do dia, são as pernas que estão edemaciadas. É frequente a presença de ascite e derrame pleural. A intensidade do edema pode variar de acordo com a ingestão de sal, pois na síndrome nefrótica o mecanismo fisiopatológico básico é a redução da pressão oncótica por hipoalbuminemia, com redução do volume plasmático e passagem de água para o espaço intersticial, mas a retenção de sódio e água é um fator importante relacionado com o aumento da produção de aldosterona.

O edema da insuficiência renal crônica é muito variável, na dependência da causa determinante. Depende também da fase da doença, do grau do distúrbio funcional ou de eventuais alterações que ocasionam a descompensação clínica.

Na insuficiência renal aguda o edema decorre geralmente de hiper-hidratação.

Na pielonefrite o edema é de pequena intensidade, quase sempre restrito à localização facial pela manhã.

Febre e calafrios

As infecções urinárias altas, que comprometem os cálices, bacinetes e interstício do parênquima renal, quase sempre se acompanham de febre que pode ter início súbito, precedido de calafrios. Infecções das vias urinárias inferiores também podem provocar febre, mas nesses casos predominam as alterações miccionais.

ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS

O fato de os órgãos genitais masculinos terem uma dupla função – sexual e urinária – possibilita o surgimento de distúrbios tanto miccionais quanto sexuais, isoladamente, ou de maneira associada.

Os sintomas relacionados com a função urinária já foram descritos (ver *Rins e vias urinárias*, neste capítulo) (Figura 6.34).

Os sinais e sintomas não relacionados com a função urinária são: *dor, priapismo, hemospermia, corrimento uretral, disfunções sexuais, infertilidade e manifestações clínicas relacionadas com a atividade endócrina dos testículos*. (Ver Capítulo 18, *Exame dos Órgãos Genitais*.)

Dor

A dor sentida nos órgãos genitais pode ter origem no próprio local ou em outros órgãos (dor referida).

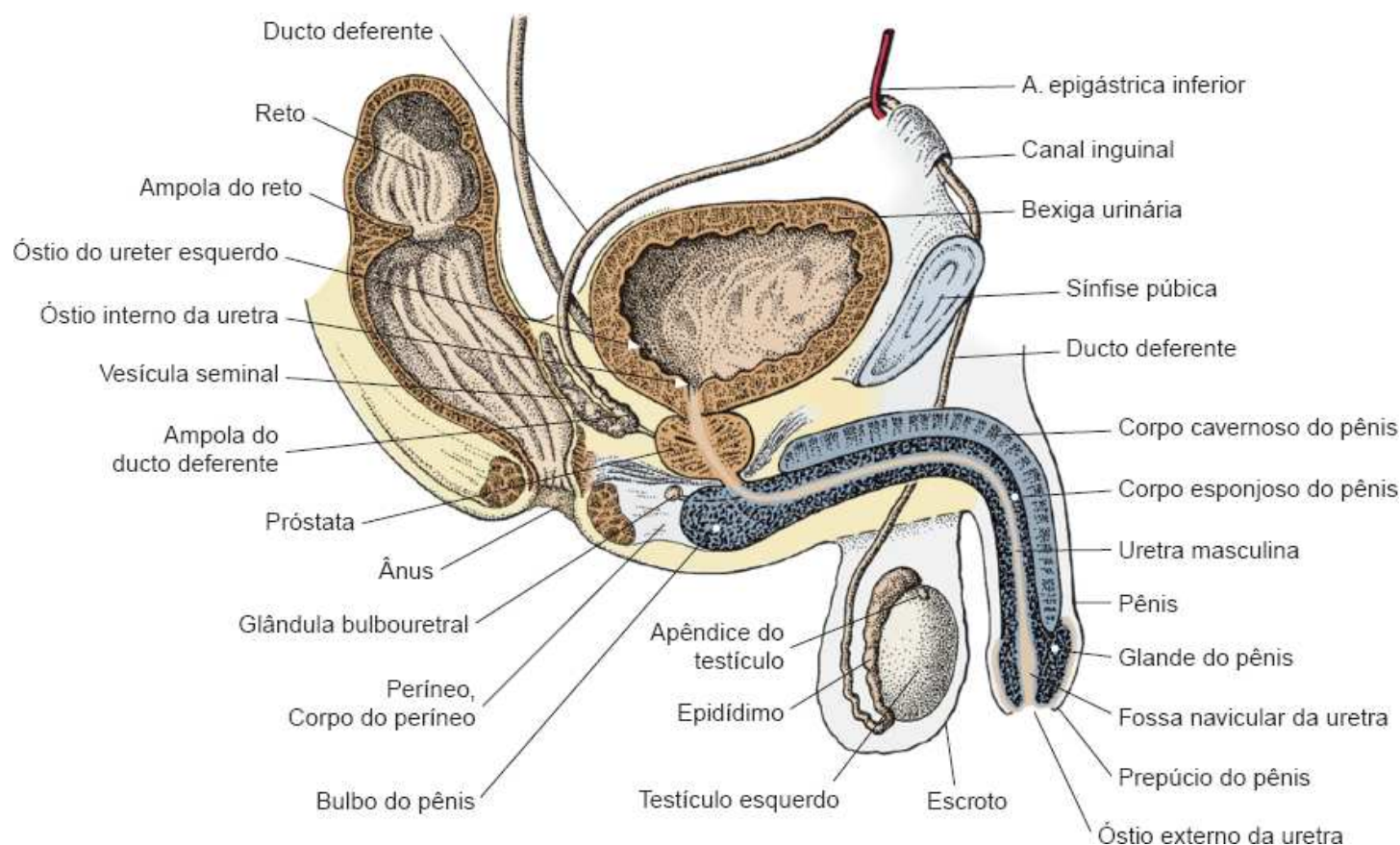


Figura 6.34 Órgãos genitais masculinos. (Adaptada de Wolf-Heiddeger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

A dor testicular é ali originada e ocorre na orquite traumática ou infecciosa. A dor referida ocorre na litíase, nos cálculos localizados no terço superior da uretra. A dor é sentida no testículo por ser comum a inervação destas duas estruturas. Quando o cálculo se localiza no terço inferior da uretra, a dor é percebida na bolsa escrotal.

Tumor testicular maligno pode ser indolor ou provocar dor discreta, apenas com sensação de peso. Mas se houver uma hemorragia espontânea, a dor torna-se intensa, chegando a causar confusão diagnóstica com epididimite aguda ou com torção do cordão espermático.

Na prostatite aguda pode haver dor na região perineal ou na região sacral.

Na epididimite aguda a dor costuma ser estritamente localizada. No entanto, na fase inicial ela pode ser sentida na virilha ou no quadrante abdominal inferior do mesmo lado. Ocasionalmente, a dor de origem epididimária pode irradiar-se para o ângulo costovertebral do mesmo lado, simulando migração de um cálculo ureteral.

Priapismo

Corresponde à ereção persistente, dolorosa e prolongada do pênis, sem desejo sexual. O pênis apresenta-se ereto, aumentado de volume, formando ângulo agudo com a sínfise pubiana.

O mecanismo responsável é essencialmente vascular, mas as causas são várias – neurogênicas, químicas, medicamentosas, tóxicas, infecciosas, alérgicas, traumáticas, hematológicas (leucemia e anemia falciforme). Contudo, na maioria dos casos não se consegue determinar o fator etiológico. Nesse caso, o priapismo é considerado idiopático.

Hemospermia

Significa a presença de sangue no esperma, podendo ter diferentes causas, entre as quais se encontram a tuberculose, esquistossomose, carcinoma das vesículas seminais e da próstata, cirrose hepática com hipertensão portal, discrasias sanguíneas (púrpura, leucemia), papiloma ou lesão cística do verumontano, inflamação da próstata e das vesículas seminais, litíase prostática e hiperplasia benigna da próstata.

O sangramento pode ser discreto, deixando apenas manchas avermelhadas na cueca, ou mais intenso, com a presença de sangue no esperma.

A hemospermia pode ocorrer em pessoas com aparelho geniturinário normal e não ter significado patológico, desaparecendo espontaneamente.

Corrimento uretral

Refere-se à presença de uma secreção que sai pelo meato da uretra. As principais causas são uretrite e prostatite.

Corrimento purulento intenso, amarelado ou verde-amarelado, é o primeiro sinal de blenorragia; surge 3 a 5 dias após o contágio.

Corrimento esbranquiçado que ocorre só pela manhã (“gota matinal”) é encontrado na prostatite, na uretrite traumática – indivíduos neuróticos ou hipocondríacos que espremam com frequência a uretra em busca de secreção – e nos primeiros dias ou semanas que se seguem ao tratamento das uretrites agudas, quando as glândulas de Littre estão hipersensíveis e secretam em excesso substâncias mucoides.

Corrimento uretral serossanguinolento sugere a possibilidade de estreitamento uretral, câncer da uretra ou corpo estranho na uretra.

Disfunções sexuais

As principais disfunções sexuais são *disfunção erétil (impotência sexual)*, *ejaculação precoce*, *ejaculação tardia*, *ausência de ejaculação*, *dispaurenia*, *anorgasmia* e *diminuição ou ausência da libido*.

O advento das modernas técnicas propedêuticas e o melhor conhecimento do mecanismo erector despertaram novo interesse pelos aspectos fisiológicos da ereção peniana. Isso não quer dizer que se devam menosprezar os aspectos psicológicos da sexualidade.

A classificação dos transtornos sexuais masculinos é apresentada no Quadro 6.32.

Disfunção erétil (impotência sexual)

A disfunção erétil ou impotência sexual pode ser *primária* – o paciente sempre foi impotente – ou *secundária*, assim chamada quando o paciente teve, antes de ficar impotente, um período de atividade sexual normal.

Suas causas podem ser de origem orgânica ou psicogênica.

A investigação clínica de um paciente com disfunção erétil é complexa, sendo indispensável começar com um exame clínico minucioso, durante o qual já podem ser descobertas condições capazes de ocasionar a disfunção, entre as quais incluem-se doenças endócrinas, geniturinárias, hematológicas, neurológicas, transtornos emocionais e uso de medicamentos.

Ejaculação precoce

É definida como a incapacidade de controlar o processo de ejaculação, durante a permanência do pênis na vagina, sem que tenha havido tempo suficiente para satisfazer a parceira e a própria pessoa; em geral é de causa psíquica.

Ejaculação tardia

Ereção normal ou prolongada, mas há demora na ejaculação.

Ausência de ejaculação

Pode ser atribuída à falha na emissão do esperma por obstrução dos canalículos ejaculatórios por processos inflamatórios ou após simpactomia, na neuropatia diabética e após linfadenectomia retroperitoneal.

Dispaurenia

É caracterizada por dor durante a relação sexual com sensação de laceração e perda da ereção.

Anorgasmia

É a incapacidade de atingir o orgasmo durante o coito; é uma condição rara, predominantemente de origem psicogênica, mas com inúmeras causas orgânicas que precisam ser sempre investigadas.

Diminuição ou ausência da libido

A libido, ou desejo sexual, é uma atividade psíquica complexa que sofre a influência de múltiplos fatores que envolvem a fantasia, a imaginação, a memória e estímulos originados nos órgãos sensoriais.

A diminuição ou ausência da libido pode ser motivada por um processo orgânico ou por fatores psicossociais. Inibição da libido, com frequência, acompanha os estados depressivos. As principais causas orgânicas da disfunção libídica são expostas no Quadro 6.33.

Boxe

Infertilidade

Refere-se à incapacidade do homem de engravidar uma mulher. Diz-se que um casal é infértil quando, após 1 ano de relações sexuais normais, não ocorre gravidez. Cerca de 30% dos casos de infertilidade deve-se a um fator masculino. Entre os principais estão parotidite epidêmica com comprometimento testicular (orquite), varicoceles, exposição a raios X, cirurgias urológicas.

Manifestações clínicas relacionadas com a atividade endócrina dos testículos

Ver Sistema endócrino, mais adiante.

Quadro 6.32 Tipos de disfunção sexual masculina.	
Ejaculatória	
Ejaculação precoce	
Ejaculação tardia	
Ejaculação retrógrada	
Orgásmica	
Anorgasmia	
Libídica	
Diminuição da libido	
Ausência da libido	
Disfunção erétil (impotência sexual)	
Primária ou secundária	
Psicogênica ou orgânica	
Dispareunia	

Quadro 6.33

Condições associadas a alterações da libido no homem.

Alcoolismo

Insuficiência suprarrenal crônica

Doença de Parkinson

Cirrose hepática

Hemocromatose

Hiperprolactinemia

Hipotireoidismo

Insuficiência cardíaca

Insuficiência renal

Síndrome de Cushing

Tumores feminilizantes

Tumores hipofisários

Medicamentos: tranquilizantes (ansiolíticos), estrogênios, antiandrogênios, anti-histamínicos, hipotensores

Causa psicogênica (transtorno depressivo)

ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS

Os principais sintomas das afecções dos órgãos genitais femininos são *hemorragias, alterações menstruais, dor, tumoração, corrimento, prurido, disfunções sexuais, alterações endócrinas, menopausa e climatério e infertilidade* (Figura 6.35). (Ver Capítulo 18, *Exame dos Órgãos Genitais*.)

Hemorragias

Sangramento sem as características da menstruação normal, compreendendo as hemorragias uterinas orgânicas e as funcionais ou disfuncionais.

A hemorragia uterina de causa orgânica ocorre em um grande número de enfermidades, incluindo inflamações, tumores benignos e malignos, e em afecções não ginecológicas como hepatopatias e coagulopatias.

Nesses casos a hemorragia não é um sangramento cíclico, inexistindo, portanto, ritmo ou periodicidade. É chamada de *metrorragia*.

É conveniente ressaltar que as hemorragias de origem vaginal ou vulvar decorrentes de traumatismos, ulcerações ou neoplasias podem confundir-se com a metrorragia.

É importante a caracterização semiológica da hemorragia, bem como o tipo e o ritmo menstrual da paciente, lembrando que a associação de hemorragia com outros distúrbios menstruais pode ser decorrente de uma única enfermidade.

A perda sanguínea de pequena intensidade no período intermenstrual denuncia o fenômeno da ovulação ou o uso incorreto de anticoncepcional hormonal.

A hemorragia uterina funcional ou disfuncional é uma hemorragia que não se acompanha de tumor, doença inflamatória ou gravidez. Geralmente é causada por disfunção ovariana e ausência de ovulação, estando sempre presentes irregularidades do ciclo menstrual.

Alterações menstruais

Menstruação é o sangramento cíclico que ocorre cada 21 a 35 dias, durando de 2 a 8 dias, com uma perda sanguínea de 50 a 200 mL.

O ciclo menstrual pode apresentar anormalidades quanto ao intervalo entre os fluxos, à duração e à sua intensidade. Assim, temos:

Polimenorreia: quando a menstruação ocorre com intervalos menores que 21 dias

Oligomenorreia: quando a menstruação ocorre com intervalos maiores que 35 dias

Amenorreia: falta de menstruação por um período maior do que três ciclos prévios

Hipermenorreia: quando a menstruação dura mais de 8 dias

Hipomenorreia: quando a menstruação dura menos de 2 dias

Menorragia: quando há excessiva perda de sangue durante o período menstrual. Às vezes confunde-se com hipermenorreia

Dismenorreia: dor acompanhando a menstruação.

Boxe

Dismenorreia

O termo dismenorreia significa “menstruação dolorosa”. Dor na região hipogástrica, tipo cólica, durante a menstruação chama-se *algomenorreia*. Quando esta se acompanha de lombalgia com irradiação para o baixo ventre e para as pernas, náuseas e cefaleia, constitui a *síndrome da dismenorreia*.

A dismenorreia pode ser primária ou secundária:

Dismenorreia primária: quando ocorre sem nenhuma causa orgânica e surge desde os primeiros ciclos menstruais

Dismenorreia secundária: quando relacionada com qualquer doença pélvica orgânica, como endometriose, mioma submucoso, doença inflamatória ou com a presença de DIU.

Entre os mecanismos psicológicos destacam-se as atitudes negativas em relação à menstruação devidas a tabus que envolvem a sexualidade, ausência de conhecimento sobre a natureza feminina, benefícios ganhos com “chantagem emocional” por carência afetiva, aumento do desejo heterossexual que reaviva fatores edipianos, levando a sentimento de culpa, fracasso de engravidar e rejeição da feminilidade.

Teorias anatomofisiológicas responsabilizam o desequilíbrio dos hormônios ovarianos (estrogênio e progesterona) influenciando processos metabólicos no endométrio, como a síntese de prostaglandinas, substâncias que, entre outras ações, estimulam a contração da musculatura lisa.

A sintomatologia da síndrome dismenorreica pode ser leve, moderada ou grave.

Na forma leve os sintomas são bem tolerados e cedem com medicação analgésica, sem prejuízo das atividades habituais.

Na forma moderada a sintomatologia é marcante, prendendo a paciente ao leito ou impossibilitando a execução de suas obrigações.

Na forma grave os sintomas não cedem com medicação analgésica, causando intenso sofrimento que incapacita a paciente periodicamente. Com o passar do tempo, transtornos emocionais associam-se à

Tensão pré-menstrual (TPM)

Tensão pré-menstrual é a denominação dada a um conjunto de sintomas que surge na segunda metade do ciclo menstrual e desaparece com a vinda da menstruação. Os principais são cefaleia, mastalgia, sensação de peso no baixo ventre e nas pernas, irritação, nervosismo e insônia.

Algumas mulheres admitem que esses sintomas são manifestações “normais” da função menstrual, mas, quando alteram seus hábitos de vida, adquirem importância clínica.

Várias teorias procuram explicar sua etiopatogenia, cujo mecanismo básico é a retenção de sódio e água. Assim teríamos:

Hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com retenção de sódio e água nos tecidos. Os estrogênios aumentam a produção de renina que, por sua vez, estimula a secreção de aldosterona, responsável pela retenção de água e sódio. Estes efeitos seriam contrabalançados pela ação da progesterona, que é natriurética. Uma deficiência de progesterona explicaria alguns aspectos da síndrome de tensão pré-menstrual

Hipoglicemia, que é comum na segunda metade do ciclo

Aumento do hormônio antidiurético, que também estimula a retenção de água

Hiperprolactinemia, que provoca desequilíbrio na secreção de LH/FSH, redundando em um corpo lúteo que produz menor quantidade de progesterona

Aumento da produção de vasopressina, a qual, juntamente com a prolactina, produz retenção de líquido

Deficiência de vitamina B6, que provavelmente atua no metabolismo estrogênico e na produção de monoaminas cerebrais.

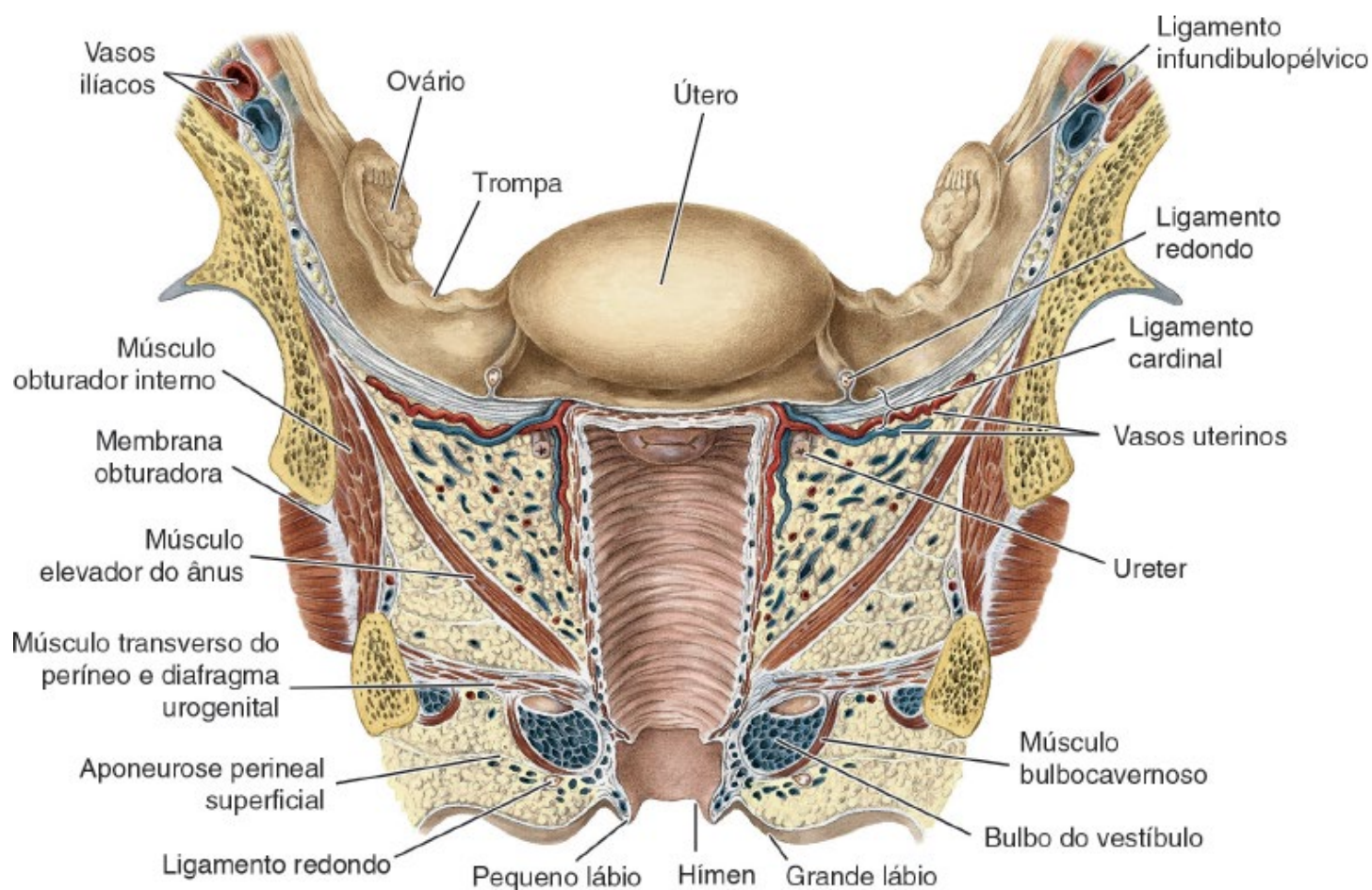


Figura 6.35 Seção frontal da pelve feminina. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Dor

A dor originada nos genitais femininos localiza-se nas regiões pélvica e lombossacra. Pode ser espontânea ou provocada pelo coito, deambulação, ortostatismo ou palpação. Pode ser contínua, paroxística ou relacionada com o ciclo menstrual.

Boxe

Para o diagnóstico diferencial é importante ter em conta causas não ginecológicas nos quadros dolorosos da pelve, regiões lombossacra e perineal, destacando-se as afecções dos órgãos do sistema urinário, digestivo e osteoarticular.

As vias sensoriais do reto e da bexiga são as mesmas do útero e da vagina. Por isso, infecção e litíase urinária, tumores e traumatismos anorretais podem ser relatados como “dor no ovário”. Não esquecer, também, que apendicite e diverticulite manifestam-se às vezes com dor no baixo ventre, com a mesma localização das doenças dos ovários e das trompas.

As principais causas da dor pélvica são os processos inflamatórios, as distopias genitais, os tumores anexiais, a prenhez ectópica e a endometriose.

Nos processos inflamatórios agudos a dor é bem localizada, aguda, contínua, espontânea, podendo, com a expansão do processo, alcançar outras regiões. *Dispareunia* é a regra, tanto nas afecções pélvicas como nas da vulva e da vagina.

As distopias genitais só provocam dor em casos excepcionais. Nas pacientes com prolapso genital pode ocorrer dor lombossacra por estiramento dos ligamentos cardinais e uterossacros. Determinadas retroversões fixas, sequela de ginecopatias anteriores, determinam dor pélvica e lombar, descontínua, crônica, que se acentua com o esforço e durante o coito.

Os tumores anexiais habitualmente não se acompanham de dor. No entanto, aderências, compressões de órgãos vizinhos e a torção dos pedículos tumorais podem desencadear sintomatologia dolorosa, de localização pélvica, contínua, espontânea ou provocada, podendo irradiar-se para o abdome superior e/ou membros inferiores. Nos traumatismos que se acompanham de torção do pedículo, surge dor intensa, espontânea e aguda.

Boxe

A gravidez ectópica, enquanto estiver íntegra, determina dor pélvica de intensidade leve a moderada, sem irradiação, surda, principalmente após esforço. Sua ruptura modifica totalmente o quadro, ocorrendo, então, dor intensa, espontânea, acompanhada de sinais de irritação peritoneal.

Na endometriose, quando as lesões são mínimas não há dor. A extensão do processo provoca sintomatologia clássica: dor periódica (dismenorreia), paroxística e progressiva. A localização geralmente é pélvica, mas pode ser também lombar ou perineal (retal), com agravamento durante a evacuação.

Tumoração

Quando uma paciente relata o aparecimento de uma “tumoração”, esta queixa merece especial atenção, devendo-se esclarecer a época de seu aparecimento, localização, velocidade de crescimento, bem como a presença de outros sintomas que possam ser relacionados com a compressão de órgãos vizinhos.

São múltiplos os tipos de tumorações dos órgãos genitais femininos, incluindo tumores benignos e malignos, cistos e processos inflamatórios crônicos com formação de plastrão.

Não se esquecer de investigar sempre a possibilidade de gravidez.

Corrimento

A genitália externa da mulher no *menacme* (período da vida com atividade menstrual) é úmida, tendo a vagina um pH de 4 a 4,5 (ácido, portanto) devido ao desdobramento do glicogênio do epitélio vaginal em ácido láctico, sob a ação dos bacilos de Döderlein, na presença de estrogênios.

Considera-se como corrimento quando há alteração das características da secreção normal, que tem o aspecto de catarro fluido ou clara de ovo. A secreção aumenta sob a ação estrogênica (pico ovulatório e terapêutica hormonal). É fisiológica a secreção das glândulas vestibulares maiores (Bartholin) durante a excitação sexual, responsável pela lubrificação vaginal.

A avaliação semiológica do corrimento compreende quantidade, aspecto, odor e período do ciclo menstrual em que surge.

Um corrimento aquoso, abundante, parecido com a secreção vaginal normal, mas em grande quantidade (hidrorreia), pode indicar varicocele pélvica, retroversão uterina fixa ou uso de anticoncepcionais orais; quando for amarelo, espesso, fétido e

espumoso, a causa costuma ser tricômonas e/ou gonococos; corrimento branco, em grumos, como nata de leite ou coco ralado, indica a presença de fungos do gênero *Candida*; corrimento com aspecto de água de carne é próprio dos tumores e das inflamações mais graves.

Prurido, ardência e odor fétido sempre acompanham o corrimento patológico. Além do exame direto, a fresco, da secreção, a bacterioscopia e a cultura em meios apropriados podem ser necessárias para o diagnóstico etiológico.

Prurido

O prurido como sintoma isolado é pouco frequente. Pode, entretanto, ser muito intenso e penoso para a paciente. Costuma surgir nas lesões distróficas da vulva (principalmente em pacientes idosas), nas vulvites micóticas e alérgicas. O prurido vulvar é frequente no diabetes. Não se deve esquecer que o câncer da vulva está sempre associado ao prurido.

Disfunções sexuais

O ato sexual, o orgasmo e a libido são atividades instintivas e, portanto, espontâneas, mas a vida sexual envolve aspectos que ultrapassam os limites biológicos, envolvendo aspectos culturais e espirituais.

Sabendo-se que a mulher é historicamente reprimida, torna-se fácil compreender por que é nela que repercutem com mais evidência os tabus e as distorções relacionadas com a atividade sexual.

Nos últimos anos, contudo, a mentalidade feminina vem se modificando, permitindo às mulheres levarem ao médico suas dificuldades e insatisfações sexuais, entre as quais sobressaem a *dispareunia* e a *frigidez*.

Não é necessário salientar que o questionamento deve ser hábil, delicado e mais cuidadoso do que o habitual, só possível quando apoiado em uma relação médico/paciente adequada.

Dispareunia

A dispareunia compreende os distúrbios dolorosos durante o coito, que incluem o vaginismo e a contratura dolorosa da musculatura vaginal, podendo impossibilitar inclusive a penetração do pênis. Esta é chamada *dispareunia inicial* ou *externa* (dor “por fora”, como referem as pacientes). Outro tipo de dispareunia é a terminal ou interna (dor “por dentro”, na linguagem leiga). Ambas podem ser relativas ou absolutas, conforme impossibilitem ou apenas dificultem o coito.

A dispareunia pode ser orgânica, decorrente de lesões do canal vaginal, ou a somatização de problemas emocionais. O vaginismo é decorrente de espasmo reflexo de lesões dolorosas de localização vulvar como ulcerações, vulvites micóticas e herpéticas, estenose, malformações, distrofias e cicatrizes dolorosas; ou vaginais, como colpites intensas, atrofia e cicatrizes.

A dispareunia *terminal* ou *interna* tem como causas principais as lesões traumáticas (coito abrupto, lacerações da vagina), as afecções inflamatórias (colpites, parametrites) e lesões tróficas (atrofia vaginal). Pode ocorrer também sem alterações orgânicas em pacientes com dificuldades emocionais.

Frigidez

Frigidez é a impossibilidade de alcançar o orgasmo durante o coito. Em sentido mais amplo, é a impossibilidade de atingir o orgasmo durante qualquer tipo de atividade sexual.

Pode ser primária ou secundária, obrigatória ou circunstancial. É obrigatória quando há incapacidade absoluta para o orgasmo e circunstancial quando for seletiva com referência ao parceiro. A frigidez de qualquer tipo, de modo geral, é de origem psicogênica, e as raras exceções são constituídas pelos casos nos quais a frigidez acompanha a dispareunia orgânica, quando a dor, embora não impeça o coito, impossibilita o orgasmo.

Boxe

A queixa de diminuição da libido é mais frequente entre as mulheres. Apesar de ser um sintoma comum durante o uso de ansiolíticos e antidepressivos, a causa mais frequente é emocional.

Menopausa e climatério

Climatério é a fase transicional entre a menopausa e a senectude. Não tem limites etários precisos, podendo ocorrer dos 35 a 40 aos 55 a 60 anos, com grandes variações individuais.

A última menstruação é a menopausa. Portanto, ela é um curto momento, apenas marca o início do climatério. Não é seu fenômeno mais importante, apenas o mais evidente. A menopausa não tem, por si, importância alguma, senão aquela que a própria mulher lhe atribui.

Sem dúvida, a expressão menopausa é mais divulgada do que climatério, sendo usadas até como sinônimos, em consequência da falsa importância que o leigo atribui ao desaparecimento das menstruações.

O climatério não é tão facilmente reconhecível como a puberdade, que se exterioriza física e psicologicamente de maneira muito nítida; contudo, é possível observá-lo nas mulheres entre 40 e 60 anos, quando cessa o fluxo menstrual e se reduz a função ovariana, tendo início a regressão dos caracteres sexuais secundários.

Por analogia com a puberdade, pensava-se que o desaparecimento da função ovariana decorresse da falência hipotálamo-hipofisária, nas suas funções gonadotróficas. O que declina são os próprios ovários, sendo esta a essência fisiológica do climatério. Hipotálamo e hipófise continuam funcionantes, com atividade até aumentada, em uma tentativa de compensar a falência ovariana.

Ao hipogonadismo hipogonadotrófico da infância sucede-se o normogonadismo normogonadotrófico da menarca. No climatério, volta a haver hipogonadismo, mas agora o hipogonadismo acompanha-se de aumento das gonadotrofinas.

As modificações dos caracteres sexuais secundários não são acentuadas na menopausa ou imediatamente após. Elas aparecem gradativamente, confundindo-se com as alterações advindas do envelhecimento.

A falência ovariana é gradual, embora seja erroneamente identificada com a última menstruação. Aliás, inicia-se anos antes e, com ela, não termina, vindo a completar-se anos depois.

Os ciclos menstruais tornam-se irregulares e anovulatórios, havendo, também, diminuição da fertilidade.

Ao tempo da última regra, há muitos folículos que continuam a produção de estrogênios, embora em menor quantidade do que na menacme. Mais tarde, os folículos desaparecem, mas o estroma ainda é capaz de produzir estrogênios ou seus precursores. Cumpre salientar que as suprarrenais também elaboram estrogênios e seus precursores, os quais se convertem em estrogênios. Muitos anos após a menopausa, estando as suprarrenais ativas, estrogênios similares aos da pré-puberdade são produzidos em quantidades não desprezíveis, mas insuficientes para manter trofismo sexual idêntico ao da menacme.

As manifestações clínicas do climatério são muito variáveis. A maioria das mulheres, inclusive, ultrapassa este período sem nada sentir.

Os sintomas mais comuns são os fogachos ou ondas de calor, localizados principalmente no tórax e no rosto, sudorese, edema que se acentua no período menstrual, quando as regras ainda persistem, a insônia e as manifestações psicológicas, com predomínio da angústia e de quadros depressivos.

Aumento de peso, diminuição da libido e ressecamento vaginal são outras manifestações frequentes.

Alterações endócrinas

Ver *Sistema endócrino*, mais adiante.

Boxe

Infertilidade

A infertilidade, por causa feminina, pode resultar da incapacidade de ovular ou por função inadequada do corpo lúteo.

Doença inflamatória pélvica (salpingo-ooforite gonocócica) pode ser causa de infertilidade por fibrose das tubas uterinas.

Outras causas de infertilidade são o hipotireoidismo e a insuficiência hipofisária (síndrome de Sheehan).

MAMAS

Os principais sinais e sintomas das doenças das mamas são *dor, nódulos mamários, secreção papilar ou descarga papilar e galactorreia* (Figura 6.36).



Figura 6.36 Representação esquemática da estrutura da glândula mamária.

Dor

Os principais dados semióticos relativos à dor nas mamas (mastalgia) são o caráter cíclico da sensação dolorosa e sua relação com movimentos do tórax ou dos membros superiores.

Quanto ao caráter cíclico, a dor pode surgir apenas na segunda fase do ciclo menstrual ou logo após o término da menstruação, adquirindo intensidade crescente à medida que se aproxima a fase pré-menstrual.

A relação da dor com movimentos inspiratórios profundos, elevação e abdução do membro superior, indica alterações das estruturas musculares, ósseas ou cartilaginosas, com as quais a mama apresenta estreitas relações anatômicas.

É importante observar alterações do revestimento cutâneo da mama dolorosa porque os processos inflamatórios (mastites) acompanham-se de sinais flogísticos (calor e rubor) facilmente reconhecidos à inspeção.

Nódulos mamários

Merece especial atenção a referência pela própria paciente de “caroço” ou nódulo na mama.

As principais informações a serem obtidas são: época do aparecimento do nódulo ou nódulos, se é uni ou bilateral, velocidade de crescimento e se há modificações durante o ciclo menstrual.

Afecções benignas e malignas podem apresentar-se como nódulos. Por isso, encontrar um nódulo na mama obriga a uma avaliação diagnóstica rigorosa. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores serão os resultados terapêuticos, tanto nas afecções benignas como malignas.

Secreção mamilar ou descarga papilar

Nos casos de secreção papilar, deve-se apurar se é espontânea, recorrente ou intermitente, uni ou bilateral, se está relacionada com o ciclo menstrual, se surgiu na vigência de gestação, aborto ou lactação recente.

Além disso, é necessário obter dados sobre traumatismos, cirurgias e uso de medicamentos (anovulatórios, clorpromazina, fenotiazina, sulpirida, antidepressivos, antipsicóticos, opioides), sementes de erva-doce, cocaína.

Secreção serosa aparece no papiloma intraductal ou durante o uso de anticoncepcionais orais. Secreção purulenta indica processo infeccioso da mama. Secreção sanguinolenta está associada a papiloma intraductal e pode ser cíclica, aparecendo durante a menstruação.

Boxe

Ginecomastia

É o desenvolvimento excessivo das mamas no homem, principalmente por proliferação ductal. Pode ocorrer em adolescentes com resolução espontânea, em pacientes obesos e ser secundária a distúrbios hormonais ou por ação de medicamentos (hormônios, digitálicos, espironolactona, cimetidina, cetoconazol, anti-hipertensivos, agentes citotóxicos, antidepressivos, anfetamina) ou do uso de maconha.

Galactorreia

Chama-se galactorreia a produção de leite fora do período puerperal ou de lactação. Pode ocorrer no sexo masculino.

Faz parte da síndrome hiperprolactinêmica, mas ocorre também durante o uso de alguns medicamentos (sulpirida, neurolépticos, fenotiazínicos).

SISTEMA HEMOLINFOPOÉTICO

As doenças do sistema hemolinfopoético apresentam sintomatologia muito variada, com participação de todos os outros sistemas do organismo, destacando-se *astenia ou fraqueza, hemorragias, febre, adenomegalias, esplenomegalia e hepatomegalia, dor, icterícia, manifestações cutâneas* (palidez, prurido, lesões herpéticas), *sintomas osteoarticulares* (dor, edema, deformidades), *cardiorrespiratórios* (dispneia, palpitações, tosse), *gastrintestinais, geniturinários e neurológicos* (Figura 6.37) (Ver Capítulo 12, *Exame dos Linfonodos*.)

Astenia ou fraqueza

A astenia ou fraqueza pode ser de aparecimento súbito ou ter instalação lenta e progressiva.

Astenia, cansaço aos esforços, tonturas ou vertigens, juntamente com palidez da pele e das mucosas, sugerem um estado de *anemia*. Ainda é frequente a anemia por carência de ferro na alimentação, associada ou não a infestação parasitária ou perda crônica de sangue.

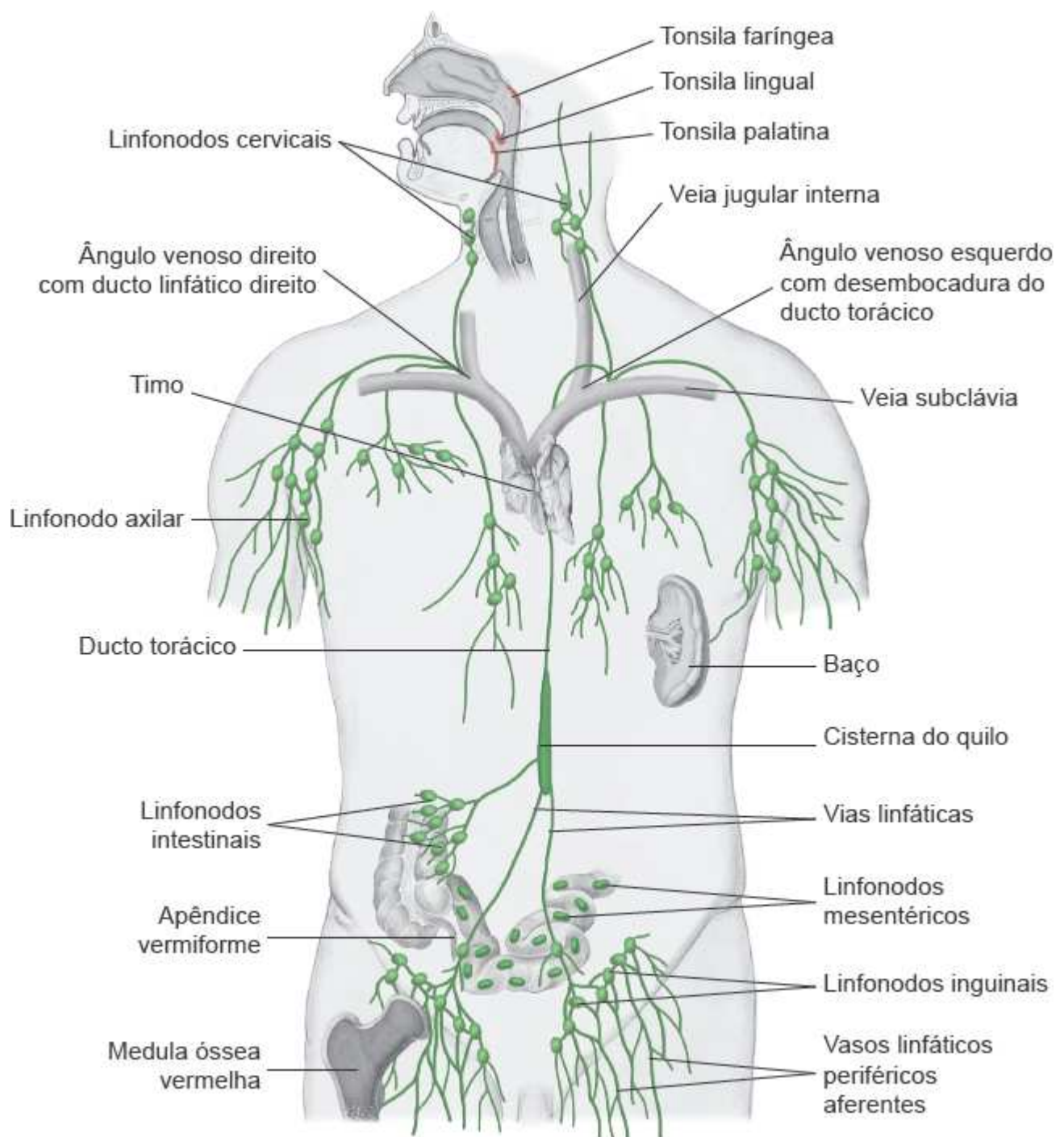


Figura 6.37 Sistema linfático.

Quando a astenia e a palidez estão associadas a perda progressiva de peso, deve-se suspeitar de uma hemopatia maligna. Reforça esta suspeita o relato de febre.

Hemorragia

As hemorragias na pele e nas mucosas podem ser puntiformes (*petéquias*), em placas (*equimoses*) ou formar coleções sanguíneas nas articulações (*hemartrose*) ou tecidos (*hematomas*). Podem ser espontâneas ou surgir após traumatismos, mesmo leves.

As hemorragias que aparecem nas doenças do sangue decorrem de alterações dos pequenos vasos, das plaquetas ou dos fatores da coagulação sanguínea.

Quando as paredes das arteríolas ou dos capilares estão alteradas, o sangue pode atravessá-las, causando hemorragia restrita à região perivascular. Sua expressão clínica são as petéquias na pele, mucosas ou em qualquer órgão.

Quando as plaquetas estão em número diminuído (plaquetopenia) ou funcionalmente alteradas (plaquetopatia), embora numericamente normais, pode ocorrer hemorragia através das mucosas (gengivorragia, metrorragia, enterorragia, hematúria) ou da pele. Nesse caso estarão presentes petéquias ou hemorragias mais extensas que dão ao tegumento cutâneo uma coloração

azul-arroxeadas (equimoses).

Boxe

Púrpura

Dá-se o nome de *púrpura* às doenças em que há alteração do número ou da função das plaquetas – *púrpuras plaquetárias* – ou dos vasos – *púrpuras vasculares*.

Grandes coleções de sangue em cavidades, como a cavidade peritoneal e as articulações, ou as que se localizam nos espaços intersticiais de qualquer órgão (hematomas) aparecem nas coagulopatias. Na hemofilia são frequentes as hemorragias intra-articulares que podem deixar graves sequelas.

Febre

A febre ocorre com frequência nas hemopatias, nas quais o número de leucócitos granulócitos está reduzido.

As neutropenias agudas ou crônicas quase sempre surgem com uma síndrome febril, que pode ser decorrente de infecções. Contudo, em hemopatias com crises hemolíticas ou hemorragias, comuns nos linfomas e nas leucemias, a febre nem sempre está relacionada com infecções. As próprias células malignas em proliferação são responsáveis pela produção e liberação de substâncias pirogênicas.

No linfoma de Hodgkin, com certa frequência registra-se uma curva térmica denominada “febre de Pel-Ebstein”. Trata-se de febre elevada, constante, que responde mal aos antitérmicos e persiste por 5 a 10 dias, após o que a temperatura cai a níveis normais durante dias seguidos, voltando a elevar-se tempos depois.

Em caso de febre persistente e sem aparente infecção localizada, com ou sem sinais de anemia ou hemorragia, há que se pensar sempre na possibilidade de hemopatia maligna.

Adenomegalias, esplenomegalia e hepatomegalia

O crescimento de linfonodos (*adenomegalias*), do baço (*esplenomegalia*) e do fígado (*hepatomegalia*) é frequente nas hemopatias malignas linfomatosas. Nas leucemias também ocorrem estas visceromegalias, cuja causa é a proliferação de células anômalas. Nas fases avançadas das leucemias encontra-se infiltração de praticamente todos os órgãos (cérebro, coração, pulmões, baço, glândulas endócrinas, gônadas, glândulas de secreção externa, pele e músculos), com múltiplas manifestações clínicas.

Os crescimentos tumorais em casos de linfomas causam desconforto por si, mas podem, também, ser acompanhados de sintomas de compressão, dependendo dos linfonodos mais comprometidos (ver *Diafragma e mediastino*, neste capítulo).

Dor

A dor pode ser localizada na orofaringe, no tórax, no abdome ou nos membros, sendo secundária à presença de infecções, crescimento tumoral com distensão de tecidos ou compressão de raízes nervosas. Pode ter localização óssea, articular ou muscular, nos pacientes com anemia crônica, especialmente naquelas de caráter hemolítico (anemia falciforme). Dores ósseas são frequentes também no mieloma múltiplo.

Nos distúrbios da coagulação observam-se grandes hematomas que causam dor intensa, se a coleção de sangue comprimir nervos ou distender alguma cápsula articular ou serosa. As adenomegalias secundárias à infiltração de células hemopoéticas malignas não costumam acompanhar-se de dor, nem de fenômenos flogísticos. Sempre que houver dor e calor, deve-se orientar o raciocínio diagnóstico no sentido de uma causa infecciosa ou inflamatória.

Icterícia

A icterícia ocorre nas crises de hemólise quando há destruição de eritrócitos.

Nas anemias hemolíticas constitucionais é permanente, com períodos de recrudescimento, quando há, então, aumento da palidez e icterícia, pela elevação da bilirrubina indireta no sangue, além de excreção aumentada do urobilinogênio urinário e fecal.

A icterícia pode ser de origem hepática, quando houver lesão parenquimatosa por infiltração de células leucêmicas ou

linfomatosas, ou secundária a lesões tóxicas dos hepatócitos provocadas por quimioterápicos utilizados no tratamento das doenças proliferativas.

Manifestações cutâneas

Além do aparecimento de *petéquias* e *equimoses*, várias outras alterações cutâneas podem ser observadas.

Palidez da pele é indicativa de anemia, relacionada com diminuição da massa eritrocitária e da hemoglobina do sangue, seja por produção inadequada de eritrócitos pela medula óssea, seja por perda ou destruição excessiva destas células já em circulação.

Como exemplo da primeira condição, destacam-se as anemias aplásicas, nas quais a medula óssea torna-se incapaz de produzir hemácias em quantidade normal. Nas leucemias agudas ou crônicas também há produção deficiente de eritrócitos em virtude da invasão da medula óssea por células leucêmicas ou malignas. Outro exemplo de anemia por falta de produção é a anemia secundária às intoxicações por agentes químicos (p. ex., benzeno).

Na segunda condição, enquadram-se as anemias pós-hemorragia, as anemias hemolíticas e as doenças próprias dos eritrócitos (eritropatias e hemoglobinopatias), nas quais, em geral, há grande fragilidade destas células por defeito congênito. Tanto nas anemias hemolíticas como nas eritropatias constitucionais, maior quantidade de eritrócitos é destruída na circulação, liberando a hemoglobina, a qual é mobilizada e transformada em bilirrubina. Este pigmento impregna a pele e as mucosas, surgindo, então, icterícia.

Outras manifestações cutâneas que podem ocorrer nas hemopatias são edema, eritemas, máculas, pápulas, bolhas e pústulas.

Pode ocorrer impregnação do derma por pigmento bilirrubínico (icterícia), ferro (hemocromatose) ou infiltração por células malignas (leucêmides), além da formação de verdadeiros tumores subcutâneos (infiltração linfomatosa e das reticuloendotelioses malignas).

A pele pode apresentar coloração avermelhada ou cianótica nas poliglobulias e na policitemia, além de descamação (micose fungoide e síndrome de Sézary).

O prurido cutâneo é observado com muita frequência nos linfomas, associado ou não a aumento da sudorese.

No linfoma de Hodgkin, o prurido é mais frequente do que nos linfomas tipo não Hodgkin. Este sintoma pode ser extremamente desagradável, só melhorando após o tratamento específico do linfoma. Sua causa não está totalmente esclarecida, parecendo coincidir, em determinados casos, com aumento da imunoglobulina tipo IgE no soro.

Outros tumores derivados da proliferação de linfócitos T também podem ocasionar prurido como sintoma inicial, sendo a micose fungoide um exemplo típico.

As leucemias linfoides raramente determinam quadro pruriginoso. As leucemias basofílicas e as mastocitoses podem apresentar um período inicial cuja única queixa é o prurido cutâneo. Nos casos de hiperplasia das células granulocíticas basófilas e de mastócitos o prurido se deve à liberação de histamina, presente nas grânulações citoplasmáticas dessas células.

Nos linfomas e nas leucemias crônicas, especialmente as linfocitárias, como consequência da imunodepressão, podem ocorrer afecções virais tipos *herpes simples* ou *herpes-zóster*, que adquirem grande gravidade com rápida disseminação.

Sintomas osteoarticulares

Sintomas osteoarticulares são comuns nas anemias crônicas constitucionais.

Boxe

Anemia falciforme e febre reumática

A anemia falciforme caracteriza-se por dores ósseas e articulares intensas. Como esta sintomatologia vem junto com febre e leucocitose e incide em crianças de baixa idade, não é raro que seja confundida com febre reumática.

Os sintomas dolorosos osteoarticulares se devem à presença de microêmbolos e infartos causados pela aglutinação de hemácias falcizadas que surgem em decorrência de isquemia e fluxo sanguíneo lento nos pequenos vasos. Além da *dor*, pode haver *edema* da articulação. Com o aparecimento dos infartos e a substituição de tecido ósseo por tecido conjuntivo, podem advir deformidades ósseas.

A hiperplasia dos eritroblastos ou de células precursoras das hemácias, no interior dos ossos chatos do crânio e da face, pode levar a *deformidades*, como as que se observam em crianças e adultos jovens portadores de talassemia, outra forma de anemia

crônica na qual há defeito na síntese de hemoglobina. A hiperplasia das células formadoras de eritrócitos na medula dos ossos ocasiona adelgaçamento das tábuas ósseas externas.

Nas leucemias e linfomas não Hodgkin, a proliferação de células malignas na região subperiosteal dos ossos e junto às articulações acarreta, em determinados pacientes jovens ou em crianças, o aparecimento de dor óssea e articular, simulando, às vezes, uma afecção reumática.

Hipodesenvolvimento estatural é significativo nos portadores de anemias crônicas, em especial nas anemias constitucionais (anemias hemolíticas e hemoglobinopatias), mas também, em nosso meio, nas anemias carenciais graves.

Sintomas cardiorrespiratórios

Os sintomas cardiorrespiratórios estão sempre relacionados com um grau maior de anemia. A anemia crônica determina redução da capacidade de realizar exercícios físicos, dispneia e palpitações. Na anemia aguda, decorrente de hemorragia volumosa, há diminuição do volume de sangue circulante causando tonturas e lipotímia, principalmente quando o paciente fica de pé.

Nas anemias nutricionais por carências múltiplas, especialmente de proteínas, pode ocorrer edema dos membros inferiores e até anasarca (ver *Metabolismo e condições nutricionais*, neste capítulo).

Tosse, dificuldade respiratória e dor torácica podem surgir nos portadores de linfomas nos quais haja massas tumorais mediastinais e derrame pleural.

Sintomas gastrintestinais

Perda de sangue através da mucosa do trato gastrintestinal, desde a boca até o reto, é um sintoma gastrintestinal frequente nas leucemias agudas e nas púrpuras plaquetopênicas. Pode ser observada como pequenos sangramentos no ato de escovar os dentes, mas pode ser espontânea. Perda de sangue junto com as fezes em associação com cólicas abdominais pode ocorrer com ou sem plaquetopenia.

Fezes escuras são indicativas de hemorragia gastrintestinal alta ou excesso de urobilinogênio fecal, como ocorre nas anemias hemolíticas.

Hematêmese grave pode ocorrer nas esplenomegalias do tipo congestivo, como na esquistossomose hepatoesplênica. Nesses casos, a causa é a ruptura de varizes esofágicas, mas pode estar associada a uma plaquetopenia por hiperesplenismo. Nas púrpuras plaquetopênicas, leucemias ou anemia aplásica, vômitos com sangue podem ocorrer. O sangue geralmente provém do nariz, é deglutido e, por irritação da mucosa gástrica, é eliminado pelo vômito.

Dores abdominais em cólica ou contínuas podem estar presentes, quando há crescimento tumoral intra-abdominal. O baço aumentado de volume nas síndromes mieloproliferativas pode comprimir o estômago e ocasionar desconforto pós-prandial.

Na anemia falciforme, quando ocorre infarto do baço por aglutinação das hemácias, ocorre dor especialmente se o local infartado estiver junto ao peritônio visceral.

Na anemia hemolítica esferocítica constitucional costuma surgir, em indivíduos mais velhos, litíase biliar que pode determinar crises de cólica e icterícia obstrutiva se o cálculo ocluir o colédoco.

Sintomas geniturinários

As hemorragias são manifestações geniturinárias importantes: menorrágia, metrorragia e hematúria, quase sempre causadas por plaquetopenia.

Em mulheres jovens que menstruam, estes sintomas podem ser muito graves, causando choque hipovolêmico e até morte se não for instituída reposição imediata do sangue.

Em pacientes com anemia crônica grave pode haver amenorreia.

O relato de urina escura é frequente nos episódios de hemólise das anemias hemolíticas, cuja causa é a excreção aumentada de urobilinogênio.

Determinados pacientes referem urina escura (cor de chá-mate ou Coca-Cola) pela manhã, na primeira micção, clinicamente chamada *hemoglobinúria paroxística noturna*. Outros eliminam urina escura após períodos longos na posição de pé ou após exposição ao frio.

Sintomas de insuficiência renal (edema, oligúria) podem estar presentes em casos de mieloma múltiplo, a doença proliferativa das células plasmocitárias.

Sintomas neurológicos

Os sintomas neurológicos dependem da plaquetopenia, que pode surgir nas leucemias, púrpuras e anemia aplásica.

Infiltração do sistema nervoso por células leucêmicas ou linfomatosas ou compressão da medula espinal são situações graves. As infiltrações caracterizam-se por cefaleia e vômitos (hipertensão intracraniana), e a compressão medular por diminuição da força muscular com paresia, paralisia ou mesmo tetraplegia de instalação lenta ou subaguda.

Na leucemia mieloide aguda ocorrem, embora raramente, quadros de proliferação celular no fundo das cavidades orbitárias, com lesão do nervo óptico e protrusão dos globos oculares (cloroma), com diminuição progressiva da acuidade visual.

Na policitemia vera o aumento da massa de eritrócitos e do volume sanguíneo total leva a um quadro de hiperviscosidade sanguínea com dificuldade de circulação do sangue no nível dos pequenos vasos. Daí surgem sintomas de hipertensão arterial, cefaleia, vertigens, escotomas, perturbações sensoriais e motoras nas extremidades e até alterações psíquicas.

OSSOS

Os principais sinais e sintomas das doenças ósseas são *dor* e *deformidades*, além das *manifestações gerais* (Figura 6.38).

(Ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*.)

Manifestações gerais

Algumas doenças ósseas apresentam sintomas gerais que podem chamar mais a atenção do médico do que as manifestações locais. Na fase inicial da osteomielite, por exemplo, o quadro clínico é dominado por febre alta, anorexia e mal-estar.

No escorbuto as lesões ósseas ocorrem após um período de tempo em que predomina inapetência, dificuldade de ganhar peso, hemorragias gengivais e da pele.

Dor

A dor das afecções ósseas origina-se no perióstio ou nos tecidos circunjacentes, incluindo os ligamentos, tendões, bursas e nervos. O osso propriamente tem pouca ou nenhuma sensibilidade.

As principais causas são as lesões traumáticas, neoplasias, osteomielite e os distúrbios metabólicos (raquitismo, osteoporose, escorbuto).

De modo geral, a localização da dor corresponde à área comprometida, mas se houver comprometimento de um nervo a sensação dolorosa pode irradiar para a região inervada por ele. Isso é comum nas afecções da coluna vertebral (lombociatalgia).



Figura 6.38 A e B. Vista de conjunto dos ossos e das articulações. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

O caráter e a intensidade da dor dependem da rapidez com que a lesão se desenvolve. Os tumores benignos, por crescerem lentamente, podem evoluir praticamente sem dor, enquanto os malignos e as infecções provocam dor precocemente, às vezes de grande intensidade. Nos distúrbios metabólicos e na doença de Paget a dor pode estar relacionada com estiramento do periósteo, sendo mais intensa ao se comprimir a região afetada.

A dor costuma ser manifestação precoce de osteomielite.

Deformidades ósseas

As *deformidades ósseas* podem adquirir diferentes aspectos: as mais simples são constituídas por “caroços” ou “tumefações” localizadas; as menores são detectadas mais pela palpação, enquanto as maiores deformam o segmento ou área correspondente e ficam visíveis. As principais causas são as neoplasias.

Um tipo especial de deformidade é o *arqueamento do osso*, sendo exemplo típico a *tíbia em sabre*, que aparece no raquitismo, na sífilis e na doença de Paget. O alargamento das extremidades anteriores das costelas nas crianças com raquitismo determina uma deformidade que recebe o nome de *rosário raquítico*.

ARTICULAÇÕES

Os sinais e sintomas mais comuns das enfermidades articulares são *dor*, *rigidez pós-reposo*, *fraqueza muscular*, *sinais inflamatórios (artrite)*, *crepitação articular* e algumas *manifestações sistêmicas*, principalmente *febre*, *astenia*, *perda de peso* e *anorexia* (Figura 6.39). (Ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*.)

Dor

Devem-se investigar todas as características semiológicas de uma dor articular (*artralgia*), porque esse sintoma constitui a queixa principal na maioria das enfermidades das articulações e pela sua análise quase sempre é possível levantar hipóteses diagnósticas corretas (Quadro 6.34).

O estímulo doloroso, captado pelas terminações nervosas das articulações, é conduzido à medula, de onde alcança o tálamo e o córtex cerebral. Através dos arcos reflexos víscero-motores, a dor articular pode determinar espasmo da musculatura circunvizinha e atrofia.

Distúrbios vasomotores periféricos podem acompanhar as alterações articulares, salientando-se a distrofia reflexo-simpática na síndrome ombro-mão.

A dor articular pode ser aguda (gota, bursite, osteomielite), crônica (artrite reumatoide, osteoartrose), localizada ou irradiada (cervicobraquialgia, lombociatalgia).

Por vezes junto com a dor o paciente relata parestesias (formigamento) decorrentes da compressão de raízes nervosas na coluna cervical ou lombar. A localização das parestesias permite inclusive diagnosticar o nível da compressão. Por exemplo, na compressão do nervo mediano as parestesias são percebidas na mão, enquanto na compressão no nível do punho, que ocorre na síndrome do túnel do carpo, as parestesias são percebidas nas mãos e dedos.

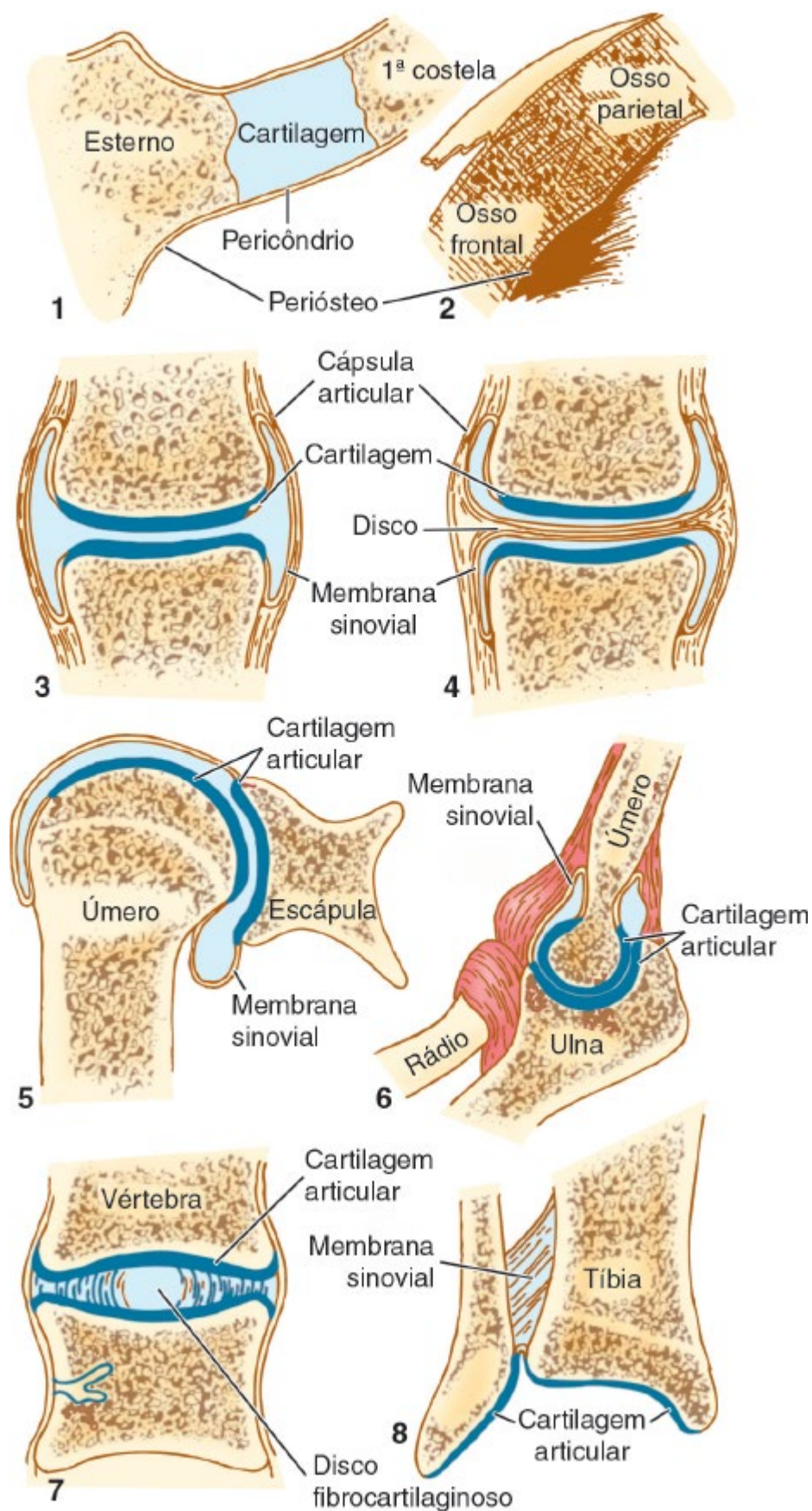


Figura 6.39 Tipos de articulações.

Quadro 6.34

Causas de dor articular.

Osteoartrose

Artrite reumatoide

Artrite gotosa

Febre reumática

Bursites e tendinites

Entorses

Colagenoses

Tensão nervosa

O momento do dia em que a dor é pior pode ser útil no diagnóstico. A tendinite piora durante as primeiras horas da manhã e melhora por volta da metade do dia. A osteoartrose piora com o decorrer do dia. A dor da artrite reumatoide ocorre logo pela manhã e pode causar despertar precoce.

A influência dos movimentos sobre a dor é bastante informativa. Assim, quando se faz abdução e rotação interna do braço e a dor no ombro se agrava, a primeira hipótese é de bursite ou tendinite no nível da articulação escapuloumeral.

Na febre reumática a dor costuma ter caráter migratório, ou seja, “pula” de uma articulação para outra sem deixar sequelas.

Contratura da musculatura lombar, levando o paciente a se curvar para diante ou para um lado, é observada nos pacientes com hérnia discal lombar.

Dor urente, acompanhada de intumescimento da mão, é uma queixa frequente nos pacientes com distrofia reflexo-simpática das extremidades.

Na fibromialgia, ocorrem dor musculoesquelética e pontos de hipersensibilidade em múltiplos locais, principalmente nos músculos.

Rigidez pós-reposo

A rigidez pós-reposo também é chamada de rigidez ou enrijecimento matinal. Dedos duros pela manhã, acompanhados de aumento de sua espessura (“não consigo colocar meus anéis pela manhã”, dizem alguns pacientes), em especial das pequenas articulações interfalângicas proximais, são queixas comuns e fazem parte dos critérios para o diagnóstico da artrite reumatoide.

Fraqueza muscular

A fraqueza muscular deve ser diferenciada da fadiga. É um sintoma diretamente relacionado com o comprometimento dos músculos (miopatias), mas, nos pacientes com alteração articular de longa duração, os músculos vão atrofiando e a fraqueza torna-se uma queixa importante.

Boxe

Artralgia e artrite

Artralgia significa apenas a presença de dor articular.

Artrite significa processo inflamatório da articulação, cuja base anatomopatológica é uma sinovite (inflamação da membrana sinovial) que se traduz clinicamente por aumento de volume da articulação (edema), elevação da temperatura local (calor), dor e modificações da coloração da pele circundante (rubor).

Os processos inflamatórios do aparelho locomotor (artrites) podem ser de causa traumática, imunológica, infecciosa, metabólica e neoplásica.

Artrite associada a lesões cutâneas sugere lúpus eritematoso sistêmico, artrite psoriática, artrite gonocócica, reação medicamentosa, síndrome de Reiter.

Crepitação ou estalido articular

Crepitação articular é sinal característico de comprometimento da cartilagem articular, sendo encontrada em todos os processos em que haja degeneração daquele elemento, como nas artroses e nas artropatias neurogênicas e quando há luxação do ombro, lesão do menisco do joelho e alterações na articulação temporomandibular.

Manifestações sistêmicas

As mais importantes são *febre*, *astenia*, *anorexia* e *perda de peso*. São frequentes nas mesenquimopatias difusas de natureza inflamatória e nos processos neoplásicos.

As mesenquimopatias difusas de natureza inflamatória (colagenoses) compreendem a artrite reumatoide, a moléstia reumática, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica progressiva, a dermatopolimiosite e as angiites necrosantes.

As doenças articulares degenerativas e metabólicas raramente se acompanham de manifestações sistêmicas, pois são doenças localizadas nas próprias articulações sem comprometer o organismo como um todo.

COLUNA VERTEBRAL

Os principais sinais e sintomas das afecções da coluna vertebral são *dor* e *rigidez pós-reposso* (Figura 6.40). (Ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*.)

Dor

A dor costuma estar localizada em um segmento da coluna vertebral (cervical, dorsal, lombossacro) ou ser mais ampla.

Os processos degenerativos (espondiloartrose) e metabólicos (osteoporose) costumam acarretar dor de pequena a média intensidade, enquanto nas afecções em que há compressão de raiz nervosa (hérnia discal e neoplasias) e nas doenças infecciosas ela costuma ser intensa.

Geralmente as dores agudas de curta duração indicam compressão, ao passo que as degenerativas ou inflamatórias caracterizam-se por dor crônica.

O segmento da coluna em que se localiza a dor pode ser característico. Assim, na doença reumatoide juvenil localiza-se no segmento cervical, na espondilite anquilosante do jovem predomina na região lombar. Nos processos degenerativos e metabólicos a dor tem diferentes localizações (cervical, dorsal e lombossacra).

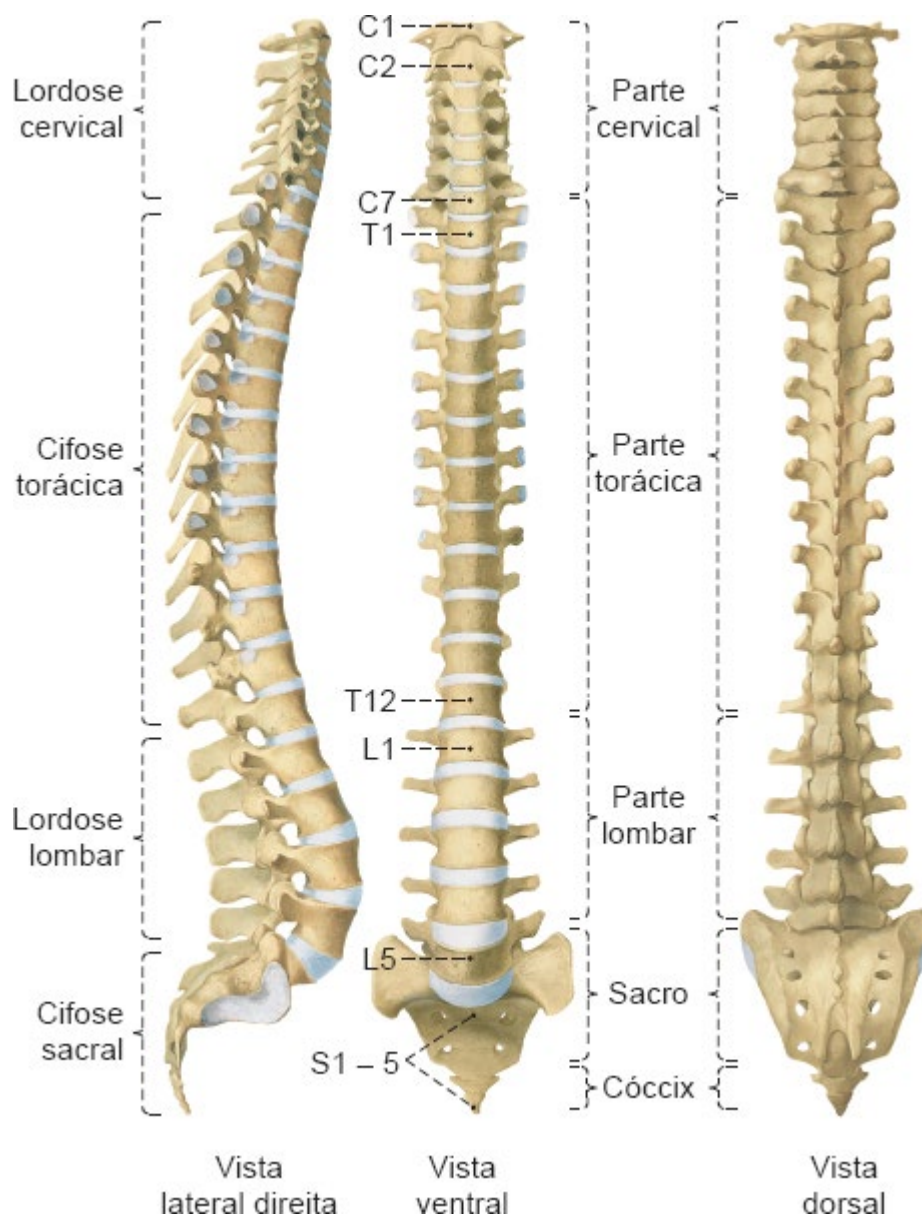


Figura 6.40 Coluna vertebral. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Dor na coluna vertebral, principalmente nos segmentos cervical e lombossacro, que se irradia para os membros superiores ou inferiores, sugere a possibilidade de comprometimento radicular, cuja etiologia pode ser degenerativa ou compressiva (hérnia discal ou tumor).

Dor que melhora com os movimentos e piora à noite surge nas afecções inflamatórias (espondilite anquilosante). Dor contínua, mesmo em repouso, que se agrava com os movimentos ocorre na hérnia discal. Na espondiloartrose e na osteoporose a dor melhora com o repouso, piora no início dos movimentos, mas melhora com o decorrer deles.

Boxe

Dor referida

Uma dor pode ser percebida no nível da coluna vertebral, sem ser nela originada. Exemplos importantes são a dor da pancreatite aguda, que pode ser percebida na topografia da coluna toracolombar; a da úlcera duodenal, na coluna torácica; a de origem renal, na coluna lombar; e das afecções ginecológicas, no nível da coluna lombossacra.

Considerando em conjunto as características da dor e tendo como referências principais sua localização e irradiação, é possível reconhecer três síndromes: *cervicalgia*, *dorsalgia*, *lombalgia* e *lombociatalgia* de diferentes causas (Quadro 6.35).

O raciocínio diagnóstico apoia-se fundamentalmente no exame clínico pela detalhada investigação das características

semiológicas da dor, dando-se especial atenção à localização, irradiação, sintomas acompanhantes e fatores que desencadeiam ou agravam a dor. Tem grande importância clínica o comportamento da dor durante a movimentação do tronco e dos membros.

Cervicalgia

As manifestações dolorosas originadas na coluna cervical, genericamente denominadas cervicalgias, compreendem várias síndromes: cefalalgia, cervicalgia simples, síndrome de compressão de raiz cervical e mielopatia espondilótica cervical.

Quadro 6.35
Causas de cervicalgia, dorsalgia, lombalgia ou lombociatalgia.
Posturas viciosas
Desvio da posição das vértebras (cifose, escoliose)
Degeneração discal
Hérnia de disco
Artrose interapofisária (espondiloartrose)
Artrite reumatoide
Espondilite anquilosante
Osteoporose
Tuberculose vertebral
Neoplasias
Espondilólise e/ou espondilolistese
Causas psicogênicas

Na *cefalalgia de origem cervical* a dor tem como localização principal a região occipital ou temporal, podendo irradiar-se para as regiões frontais.

A dor é aguda, relatada como um choque ou fígada que tem início na região occipital e se propaga para frente, às vezes até a fronte ou o olho. Geralmente, é unilateral, sendo desencadeada ou agravada pelos movimentos do pescoço e pelo esforço, mas na maioria das vezes é espontânea e evolui “em salvas”. Sua causa é a compressão do nervo occipital maior, seja na sua emergência na coluna cervical ou quando ultrapassa a fáscia mais superficial.

Um dos dados clínicos mais importantes da cefalalgia de origem cervical é sua nítida relação com a posição e a movimentação do pescoço.

Em alguns pacientes a dor é contínua, confundindo-se com a cefaleia tensional, a causa mais comum de dor na região occipital e na nuca. Dores occipitонуcais podem ocorrer também nos defeitos de refração ocular e na hipertensão arterial. Dor aguda na nuca pode ser parte da síndrome meníngea (meningite ou hemorragia), mas nesses casos chama a atenção a rigidez da nuca.

Na *cervicalgia simples*, a dor localiza-se na região cervical e se acompanha de contratura muscular, podendo haver torcicolo. A movimentação da coluna cervical torna-se difícil por causa do nítido agravamento da sensação dolorosa.

A causa mais comum são as alterações degenerativas da coluna (espondiloartrose), mas com frequência não se consegue definir com segurança alterações das vértebras e das estruturas circunjacentes. Má postura, posições forçadas, tensão emocional são condições estreitamente relacionadas com a cervicalgia simples.

A *síndrome de compressão de raiz cervical* ou *síndrome de radiculopatia cervical* é resultante da compressão de uma raiz nervosa na sua saída do canal raquidiano por um disco intervertebral deslocado (hérnia discal) e menos frequentemente por um tumor.

A principal manifestação clínica é a dor, tipo choque, que segue o trajeto radicular, piorando com os movimentos que distendem a raiz, como a tosse ou o espirro. Parestesias podem ocorrer principalmente na parte distal da raiz. Alterações dos reflexos, do tônus, da força ou alterações tróficas podem faltar ou ser tardias.

Dependendo da raiz comprometida, as radiculopatias cervicais podem ser sistematizadas da seguinte maneira:

Raiz C5 (entre C4 e C5): dor no pescoço, na borda medial da escápula, ocasionalmente no quadrante anterior e superior do tórax e ombro e na face lateral do braço, ocasionalmente sobre o deltoide. Déficit motor nos músculos supraespinhoso, deltoide, bíceps. Reflexos diminuídos ou ausência do reflexo do bíceps

Raiz C6 (entre C5 e C6): dor no pescoço, ombro, na borda medial da escápula, ocasionalmente no quadrante anterior e superior do tórax, na face lateral do braço e no dorso do antebraço. Parestesias na face lateral do antebraço, polegar e indicador (algumas vezes ausente). Déficit motor no músculo bíceps, raramente no extensor radial e ulnar do carpo. Diminuição ou ausência dos reflexos do bíceps e braquiorradial

Raiz C7 (entre C6 e C7): dor na mesma localização da dor da raiz C6. Parestesias no indicador e dedo médio (algumas vezes ausente). Déficit motor no tríceps (moderado a acentuado). Redução ou ausência dos reflexos do tríceps

Raiz C8 (entre C7 e T1): dor no pescoço, na borda medial da escápula, algumas vezes no quadrante anterior e superior do tórax, na face medial do antebraço. Parestesias no dedo anular e mínimo, ocasionalmente dedo médio. Déficit motor leve a acentuado em todos os músculos extensores do punho e dedos, com exceção do extensor radial do carpo; em todos os flexores do punho e dedos, com exceção do flexor radial do carpo e palmar longo; e em todos os músculos intrínsecos da mão. Reflexos sem alterações.

A *mielopatia espondilótica cervical* é uma afecção relativamente frequente em pessoas acima de 50 anos, quando as alterações degenerativas da coluna cervical começam a estreitar o canal raquidiano e os forames intervertebrais, comprometendo, progressivamente, a medula espinal e/ou as raízes cervicais.

O quadro clínico compõe-se de pescoço doloroso, limitação dos movimentos, cervicobraquialgia e diminuição da força dos membros superiores.

Dorsalgia

A dorsalgia costuma acompanhar a cervicalgia ou a braquialgia quando as lesões predominam nas últimas vértebras cervicais (C5, C6 e C7). Aliás, são frequentes estas associações: cervicobraquialgia, dorsobraquialgia e cervicodorsobraquialgia.

Em alguns pacientes a dor localiza-se predominantemente no dorso, especialmente na área correspondente aos metâmeros C6, C7, C8, T1, no nível dos músculos trapézio e grande dorsal.

A dor acompanha-se da contratura muscular e limitação dos movimentos.

As causas mais comuns são as alterações da mecânica da coluna (desvios), alterações degenerativas do disco intervertebral e posturas defeituosas. A tensão nervosa também pode causar dorsalgia.

Lombalgia e lombociatalgia

Duas síndromes podem ser reconhecidas – a lombalgia comum ou lumbago e a lombociatalgia ou ciática.

Em ambas, a dor tem localização lombar ou sacrolombar, quase sempre bilateral, mas predominando em um dos lados.

Na *lombalgia comum* a dor não apresenta irradiação importante, enquanto na *lombociatalgia* ela se irradia para a nádega e face posterior da coxa, podendo estender-se até o pé.

A intensidade da dor é variável, desde uma sensação de desconforto até uma dor lancinante. A movimentação da coluna agrava a dor. Quase sempre há distúrbio funcional, impedindo o paciente de trabalhar, recostar ou deitar. Em alguns casos, há completo bloqueio funcional, ficando o paciente em uma posição rígida, sem condições de exercer qualquer atividade.

A dor pode ser aguda, desencadeada por um esforço físico (levantar um peso, por exemplo) ou surgir gradativamente.

É comum a ocorrência de rigidez matinal que melhora com a movimentação. Mudanças de posição, o ato de sentar, deambulação, tosse, espirros e pequenos esforços provocam dor.

Observa-se limitação da mobilidade da coluna, dor à palpação da região lombar, podendo haver uma área extremamente sensível. A compressão da região lombar pode despertar dor pelo trajeto do nervo ciático; a isso denomina-se *sinal da campainha*.

As lombalgias são ocasionadas por processos inflamatórios, degenerativos, por alterações da mecânica da coluna vertebral (posturas defeituosas, escoliose), malformações e sobrecarga da musculatura lombar.

Admite-se que a principal causa da lombalgia seja uma alteração do disco intervertebral, que se tornaria incapaz de amortecer as cargas que lhe são transmitidas. Mas sabendo-se que a parte central do disco não apresenta inervação sensorial, admite-se que a dor só surge quando as alterações discais atingem as lamelas superficiais e o ligamento posterior, estruturas ricamente inervadas. Quando ocorre herniação do disco, a raiz nervosa comprimida é que dá origem à dor, a qual adquire, então, as características de uma síndrome radicular.

Nos casos de lombociatalgia ou síndrome ciática, deve-se pensar em primeiro lugar em hérnia de disco intervertebral.

As lombociatalgias por hérnia discal compreendem as seguintes variedades:

Raiz L4 (disco herniado entre L3 e L4): dor na região lombar, face posterior da coxa, face medial da perna. Parestesia na região medial do joelho ou do pé. Deficiência do movimento de inversão do pé. Diminuição ou abolição do reflexo patelar

Raiz L5 (disco herniado entre L4 e L5): dor lombar, na face posterior da coxa, face lateral da perna e região maleolar externa. Parestesias no dorso do pé e hálux. Déficit motor na flexão do pé. Reflexos normais

Raiz S1 (disco herniado entre L5 e S1): dor lombar, na face posterior da coxa, face posterior da perna e calcanhar. Parestesias na borda lateral do pé e dois últimos pododáctilos. Déficit motor na flexão plantar do pé. Diminuição ou abolição do reflexo aquileu.

Rigidez pós-reposo

A rigidez pós-reposo, geralmente matinal, costuma ocorrer tanto nas doenças inflamatórias como nas degenerativas. Há, contudo, uma diferença que merece ser destacada. A rigidez de origem inflamatória é mais persistente, ou seja, o paciente se levanta com dor e rigidez na coluna que persiste por tempo prolongado, enquanto nos processos degenerativos o paciente pode levantar-se com rigidez, mas esta é passageira, logo desaparecendo.

BURSAS E TENDÕES

As bursas são estruturas localizadas próximo às articulações que têm como função principal permitir o deslizamento de um tecido sobre o outro, entre os quais destacam-se os tendões. Há, aproximadamente, 78 bursas em cada lado do corpo.

Os sintomas principais das bursites são *dor e limitação dos movimentos*. Na maioria dos pacientes, a causa da bursite é traumática, mas a doença reumatoide, a gota e as infecções bacterianas podem desencadear o quadro. A mais frequente é a bursite subacromial.

Outras localizações: olécrano, trocanteriana, iliopectínea, isquiática, pré-patelar e anserina.

Dor e limitação dos movimentos

A localização da dor depende da bursa ou do tendão comprometido. A dor pode ser de início súbito, de grande intensidade, praticamente sem irradiação e tem estreita relação com a movimentação e compressão da área afetada.

A limitação dos movimentos tanto pode ser um mecanismo de aliviar ou impedir o aparecimento da dor, como depender de lesões inflamatórias ou calcificação das estruturas comprometidas.

MÚSCULOS

As doenças musculares se apresentam mais frequentemente com o sintoma *fraqueza muscular*, assim relatada pelo paciente, ou com outras queixas relacionadas com o déficit motor, incluindo *dificuldade para andar*, *dificuldade para engolir* (ver *Disfagia*), *diplopia*, *quedas imotivadas* (ver *Fraqueza muscular*). Mais raramente surgem *atrofia muscular*, *dor e espasmos musculares* (Figura 6.41).

Fraqueza muscular

A fraqueza muscular é consequência direta do comprometimento muscular. Deve-se distingui-la da astenia, da fadiga, da simulação e da histeria. Na astenia a diminuição da força é global, mas algumas vezes atinge músculos inervados pelos nervos cranianos; o paciente se diz mais cansado do que fraco; surge nas doenças crônicas ou debilitantes, sendo comum, também, no transtorno depressivo. Por isso, quase sempre se acompanha de falta de ânimo, perda da vontade e da alegria. No transtorno de conversão a instalação é quase sempre aguda, às vezes recidivante, desencadeada por fator emocional.

Nas distrofias musculares, a fraqueza, pelo fato de atingir grupos musculares, determina quadros clínicos mais ou menos específicos. Por isso, a topografia da fraqueza muscular é um elemento fundamental no diagnóstico. Assim, quando há comprometimento de músculos oculares com ptose, diplopia, estrabismo, paralisia de movimentos oculares e pupilas normais, a miastenia é a principal causa, principalmente se os sintomas são flutuantes; mas deve ser diferenciada da distrofia oculofaríngea, a qual, juntamente com a miopatia mitocondrial, apresenta-se como uma oftalmoplegia externa crônica progressiva.

Paresia facial bilateral com fácies pouco expressiva, dificuldade para assoviar, mostrar os dentes e fechar os olhos ocorre na distrofia facioescapuloumeral e na miastenia *gravis*.

Déficit motor nas cinturas escapular e pélvica causando dificuldade para elevar os braços (como para pentear os cabelos), levantar-se de uma cadeira ou do chão e subir escadas é bastante sugestivo de distrofia das cinturas, mas pode ocorrer também em qualquer miopatia e polimiosite. Quedas frequentes, imotivadas, podem sugerir debilidade dos quadríceps.

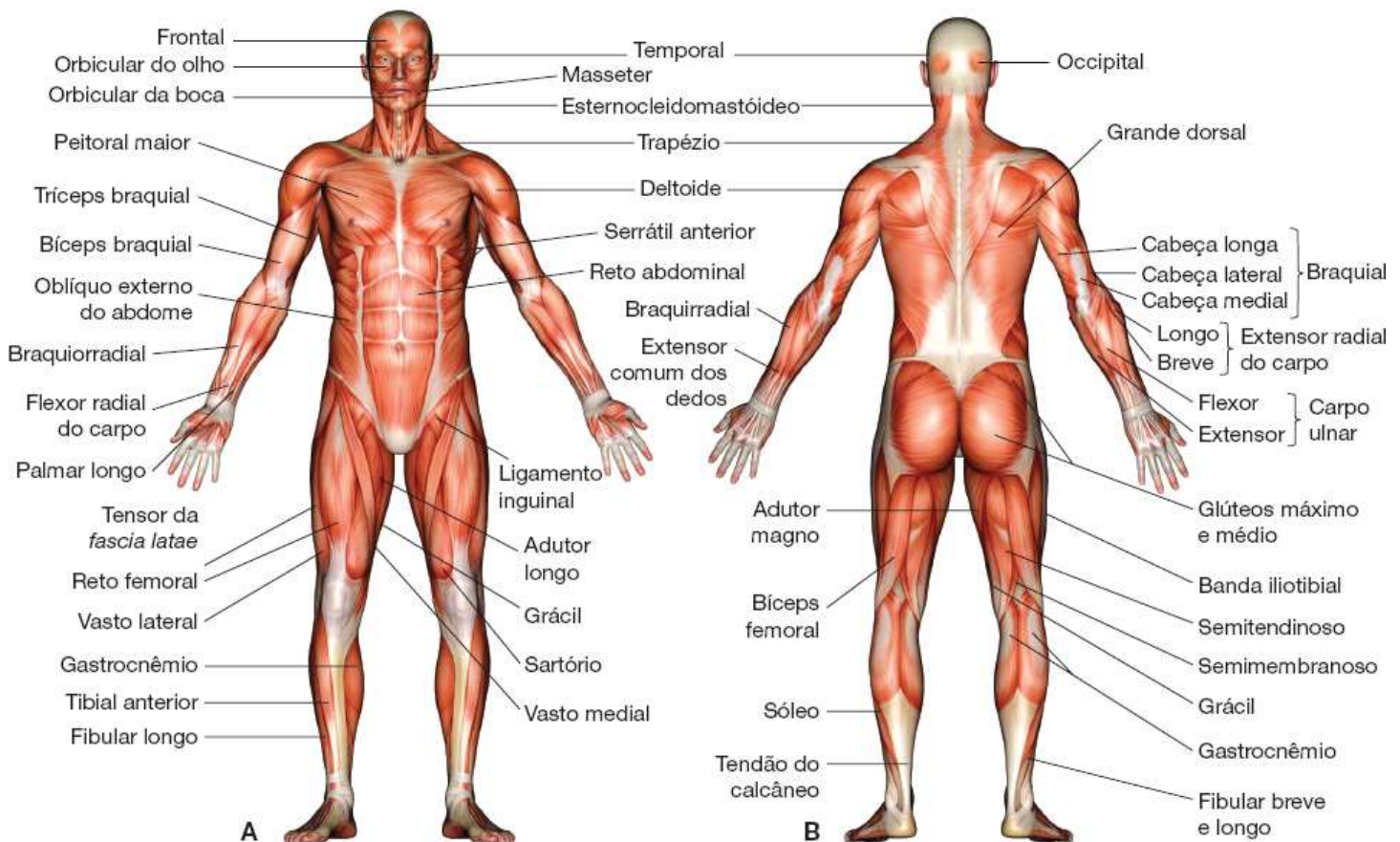


Figura 6.41 Músculos: vista anterior (A) e vista posterior (B).

Em crianças, a fraqueza muscular promove atraso no desenvolvimento motor, retardando sua capacidade para sustentar-se, levantar-se ou andar.

Fraqueza muscular associada à hipotonia torna a criança miopata flácida e fraca, sendo comparada a uma *boneca de pano* (*floppy baby*).

Dificuldade para andar

A *marcha* pode modificar-se, tornar-se difícil ou assumir aspectos peculiares e específicos (ver *Alterações da marcha* no item *Sistema Nervoso Central*, neste capítulo).

Atrofia muscular

Com a evolução das doenças musculares ocorre *atrofia da musculatura*, possibilitando confusão com as neuropatias periféricas e afecções do neurônio motor periférico. Na miopatia, a atrofia costuma ser discreta (a não ser nas formas graves), proximal, com hipotonia. A presença de fasciculações orienta para quadro neuropático.

Boxe

Sarcopenia

Síndrome caracterizada por perda da massa muscular, associada principalmente ao envelhecimento, que dificulta a realização de tarefas cotidianas, como levantar-se da cadeira sem ajuda, subir escada, carregar compras, abrir latas e garrafas. Aumenta o risco de quedas e fraturas.

É um dos fatores mais importantes para a síndrome do idoso frágil (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Dor

Quase todas as miopatias são indolores, mas alguma sensação dolorosa pode ocorrer na polimiosite, na polimialgia reumática e em outras miosites. Dores musculares difusas costumam ocorrer em doenças infecciosas sistêmicas e nas neuropatias. Não é incomum que a mialgia difusa seja manifestação de ansiedade e especialmente de depressão. Miopatia alcoólica aguda, tóxica, osteomalacia e mioglobulinúria paroxística são outros exemplos nos quais a dor pode fazer parte do quadro clínico.

Cãibras podem ser importantes nas doenças do neurônio motor, na tetania, na desidratação com perda de potássio, não sendo comuns em doenças musculares, a não ser na neuromiotonia.

A síndrome da *fibromialgia* é caracterizada por dor crônica com pontos dolorosos típicos em múltiplos locais. Além da dor, surgem rigidez musculoesquelética e fadiga (ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*).

Dor nas pernas é uma queixa muito frequente. As principais causas são apresentadas no Quadro 6.36.

Espasmos musculares

Espasmos musculares breves ou contração sustentada (contratura) são sintomas mais comuns no tétano e na tetania do que em doenças musculares.

Dificuldade na descontração muscular é um fenômeno clínico que caracteriza a miotonia.

Quadro 6.36

Principais causas de dor nas pernas.

- **Dor musculoesquelética.** Pode ter origem nos músculos, tendões, articulações e ossos. Bem localizada na região em que se origina com hipersensibilidade na área correspondente à lesão. Piora com movimentação ativa ou passiva e com a compressão da região em que tem origem. Cãibras são um tipo especial de dor de origem muscular
 - Causas: artrite, tendinite, osteomielite, neoplasias ósseas, miosites, lesões traumáticas (distensão, entorse, fraturas)
- **Dor isquêmica.** Diretamente relacionada com a isquemia de grupos musculares. Piora com o caminhar quando adquire a característica de claudicação intermitente e também na posição deitada (dor isquêmica de repouso). Acompanha-se de frialdade e cianose. Em casos avançados ocorrem alterações tróficas. Diminuição ou ausência dos pulsos arteriais do(s) membro(s) afetado(s)
 - Causas: aterosclerose de artérias periféricas, tromboangiite obliterante, trombose arterial

- **Dor da insuficiência venosa.** Sensação de peso, queimação ou dolorimento. Piora com a permanência na posição de pé por tempo prolongado. Melhora na posição deitada com as pernas elevadas. Em alguns pacientes ocorrem câibras ou síndrome das pernas inquietas. Frequente a presença de alterações tróficas
 - Causas: varizes, insuficiência venosa, trombose venosa profunda, síndrome pós-trombótica
- **Dor neuropática.** Dor sem localização precisa. Costuma haver sensação de formigamento, queimação
 - Causas: neuropatia periférica, diabetes, hanseníase, poliarterite nodosa, deficiência de vitaminas B₁, B₆ e B₁₂
- **Dor irradiada (ciatalgia).** Originada por compressão de raiz nervosa. Irradia no trajeto do nervo ciático (nádega, face posterior da coxa, panturrilha e dorso do pé). Piora com movimentação da coluna. A compressão da região lombar pode desencadear dor pelo trajeto do nervo ciático (sinal da campainha)
 - Causas: hérnia de disco, espondiloartrose lombar, postura defeituosa.

SISTEMA ENDÓCRINO

As manifestações das doenças endócrinas quase sempre afetam o organismo como um todo, mas muitos sinais e sintomas dependem da glândula comprometida (Figura 6.42).

HIPOTÁLAMO E HIPÓFISE

Os principais sinais e sintomas do hipotálamo e da hipófise são *alterações do crescimento e do desenvolvimento, alterações do apetite e do peso, galactorreia, polidipsia e poliúria e falta de lactação*.

Alterações do crescimento e do desenvolvimento

As alterações do crescimento compreendem o *nanismo*, o *gigantismo* e a *acromegalia*, enquanto as do desenvolvimento compreendem a *puberdade precoce verdadeira*, a *puberdade atrasada* e o *infantilismo genital*.

As medidas exatas da estatura e do peso, bem como o registro da curva de crescimento, constituem partes essenciais na avaliação clínica de uma criança e de um adolescente (ver Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

O tipo da curva de crescimento permite diferenciar os vários tipos de nanismo (ver Figuras 10.2 e 10.3). Se a causa for congênita, há desde o nascimento um permanente desvio, para baixo, da curva de crescimento. As crianças com afecção adquirida seguem uma curva de crescimento normal, durante determinado tempo, e só depois começam a se desviar dela. Quando se trata de alteração funcional a criança cresce a uma velocidade normal, embora a estatura fique abaixo ou acima da média, constituindo uma curva de crescimento paralela à curva padrão.

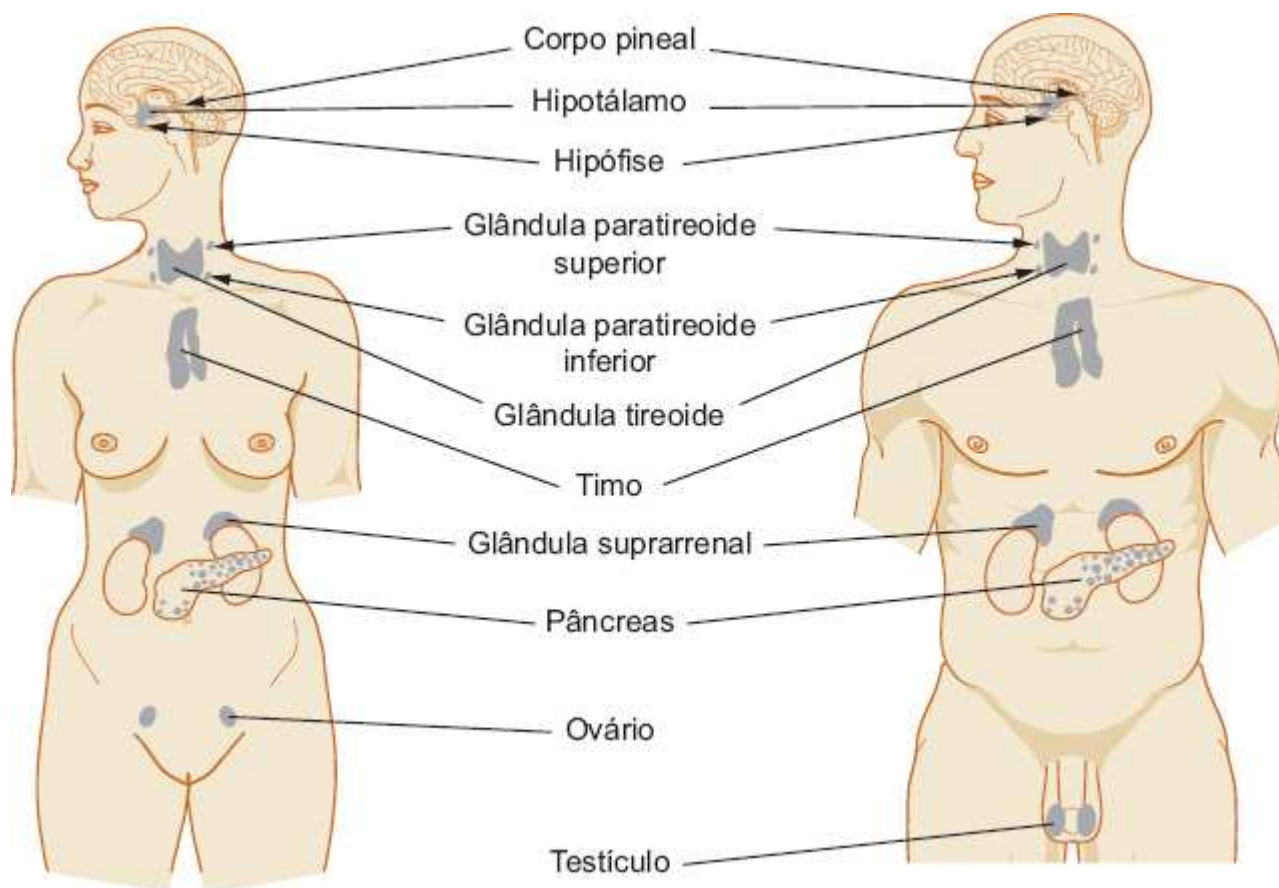


Figura 6.42 Sistema endócrino.

Boxe

Velocidade do crescimento

A velocidade do crescimento varia com a idade e com o sexo. *Entre o nascimento e os 6 meses de idade*, os meninos crescem em torno de 17 cm, e as meninas, mais ou menos 16 cm; *dos 6 aos 12 meses*, as crianças de ambos os sexos crescem no mínimo 8 cm; *entre 1 e 2 anos*, crescem pelo menos 10 cm; *dos 2 aos 5 anos*, a velocidade de crescimento cai para mais ou menos 6 cm; e *dos 5 anos até o início da puberdade*, meninos e meninas crescem entre 5 e 7 cm por ano.

De modo geral, pode-se dizer que uma criança que cresce menos de 4 cm por ano apresenta, provavelmente, uma causa orgânica para o déficit do crescimento.

Geralmente os pais só percebem que a criança tem atraso no crescimento quando ela atinge 3 ou mais anos de idade.

A determinação das proporções corporais fornece informações adicionais importantes para avaliar as alterações do crescimento e do desenvolvimento (Figura 10.7).

A comparação da envergadura com a altura e as distâncias pubovértice ou craniopúbis e pubopltar são as mais úteis (Figura 10.7). Assim, evidencia-se objetivamente que os pacientes de baixa estatura em consequência de distúrbios primários dos ossos ou cartilagens (acondroplasia, por exemplo) têm extremidades curtas com uma distância pubovértice maior que a pubopltar.

As crianças de baixa estatura causada por doenças não endócrinas, deficiência de hormônio do crescimento (GH), hipotireoidismo congênito, retardo constitucional do crescimento, baixa estatura como característica familiar, com retardo intrauterino do crescimento e o nanismo psicoafetivo apresentam nanismo harmônico, ou seja, têm os diversos segmentos corporais bem proporcionados.

Boxe

Idade óssea

A determinação do nível de maturação epifisária ou “idade óssea” também é indispensável na investigação das crianças com crescimento anormal. Está retardada em todos os pacientes com afecções endócrinas que determinam baixa estatura, no nanismo psicoafetivo, na baixa estatura constitucional e no retardo intrauterino do crescimento.

No nanismo primário ou familiar a idade óssea costuma ser normal. Entretanto, a maior utilidade da idade óssea não é para o diagnóstico da causa do déficit de crescimento, mas para avaliação prognóstica e terapêutica. As crianças com baixa idade óssea, em relação à sua idade cronológica, têm melhor resposta terapêutica em relação às que apresentam idade óssea igual ou próxima da idade cronológica.

As causas funcionais respondem pela maioria das crianças com déficit de crescimento e, se somadas ao grupo de doenças não endócrinas, sobram menos de 2% para as endocrinopatias como causa de nanismo. Na verdade, a deficiência hipotalâmica de GH/RH ou a deficiência hipofisária de GH (nanismo hipotálamo-hipofisário) são causas infrequentes de déficit de crescimento.

A desnutrição, as carências de vitaminas e as doenças que se acompanham de diarreia crônica constituem um grupo importante e muito comum de baixa estatura em nosso meio (Quadro 6.37).

Nanismo hipotálamo-hipofisário

A forma mais comum de deficiência de GH é o hipopituitarismo idiopático. Grande parte das crianças com esta afecção nascem em partos complicados (distócicos, pélvicos) ou apresentam asfixia perinatal com índice de Apgar baixo. A deficiência de GH é provavelmente secundária à disfunção hipotalâmica, pois pode-se comprovar que a maioria destas crianças secreta o hormônio do crescimento em resposta ao fator liberador de GH (GH/RH).

Alguns meninos com hipopituitarismo idiopático e nanismo por déficit de GH apresentam micropênis, testículos pequenos, escroto subdesenvolvido e criptorquidismo. Além disso, o crescimento dos ossos da face é retardado, originando nariz e mandíbula hipoplásicos. Podem apresentar fenda labial, dentes incisivos centrais defeituosos e voz de tonalidade aguda. Observa-se também obesidade com acúmulo de gordura nas regiões mamárias, periumbilical e suprapúbica.

Quadro 6.37

Causas de baixa estatura.

Doenças endócrinas

Hipotireoidismo

Anormalidade do cromossomo X (síndrome de Turner)

Deficiência de hormônio do crescimento (GH)

Nanismo psicoafetivo

Excesso de cortisol

Condições não endócrinas ou funcionais

Baixa estatura familiar ou genética

Retardo constitucional do crescimento

Retardo intrauterino do crescimento

Doenças crônicas não endócrinas

Cardiopatias

Pneumopatias

Doenças renais

Doenças do sistema digestivo com diarreia crônica

Hepatopatias

Neuropatias

Doenças ósseas e articulares

Desnutrição e carência de vitaminas

Vermínoses

Hemopatias

A fácies infantil, a obesidade do tronco e a microgenitália lembram a figura dos “querubins”, frequentes nas telas renascentistas com temas religiosos.

Desde a primeira infância, a deficiência de GH pode manifestar-se por crises de hipoglicemia matutina ou de jejum; por isso a combinação de hipoglicemia e microgenitália em recém-nascidos do sexo masculino desperta a suspeita de deficiência do GH.

Dentre as causas secundárias de deficiência de GH estão os tumores hipofisários, o craniofaringioma, os gliomas, os hamartomas, o pinealoma, as reticuloendotelioses (doença de Hand-Schüller-Christian), o traumatismo crânioencefálico, as meningites (principalmente a tuberculosa), a radioterapia de neoplasias encefálicas ou cervicais e as disgenesias hipofisárias.

Nanismo por hipotireoidismo

O nanismo por hipofunção congênita da glândula tireoide se caracteriza pela falta de desenvolvimento de todas as partes do corpo, conservando-se as proporções da criança, na qual a cabeça é relativamente grande. Salienta-se que o ventre é volumoso, os lábios e as pálpebras são grossos, o nariz é chato e a pele é espessa e seca. Chama a atenção o baixo nível mental ou a franca idiotia.

Boxe

Diagnóstico precoce do hipotireoidismo

É importante fazer o diagnóstico de hipotireoidismo o mais precocemente possível, pois a reposição hormonal desde o nascimento permite um desenvolvimento praticamente normal da criança.

Gigantismo e acromegalia

A alta estatura pode depender de distúrbios endócrinos com secreção excessiva de hormônio do crescimento, maturação sexual anormal ou de condições não endócrinas (constitucional, gigantismo cerebral e síndrome de Marfan).

No tipo *constitucional*, além de os pais também serem altos, a velocidade de crescimento e a curva de crescimento são paralelas à normal, se bem que um pouco acima.

O gigantismo hipofisário e a acromegalia são provocados por tumor hipofisário secretor de quantidades excessivas de GH. Nos pacientes jovens a estatura é mais elevada que a da idade cronológica, a velocidade de crescimento está acelerada e a curva de crescimento fica acima do percentil 97%.

Além da estatura elevada, observa-se aumento da mandíbula, das mãos e dos pés.

Alterações da visão e do campo visual podem acompanhar o excesso de GH, pois os adenomas costumam estender-se além da sela túrcica.

Como no adulto, as cartilagens de conjugação ou de crescimento dos ossos longos já se ossificaram, e o excesso de hormônio do crescimento hipertrofia os ossos das extremidades (mãos e pés), a mandíbula, o osso frontal e as vértebras.

A pele torna-se espessa e com poros dilatados.

A fâcies acromegálica é constituída por uma cabeça anormalmente grande, com arcadas supraorbitárias e queixo proeminentes.

O tórax assume a forma de barril, os ossos das extremidades inferiores se encurvam, os dentes se afastam uns dos outros, a língua se hipertrofia, o nariz e as orelhas alargam-se.

O paciente apresenta também sudorese excessiva de forte odor.

As dosagens de GH durante o teste oral de tolerância à glicose apresentam valores altos que não caem após 60 a 120 min após a ingestão de glicose.

No *gigantismo cerebral* ou *síndrome de Sotos* os pacientes exibem deficiência de coordenação e retardo mental.

No *gigantismo cerebral* e na *síndrome de Marfan* os níveis de GH são normais.

Puberdade precoce

A puberdade precoce caracteriza-se pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários e outras modificações somáticas, que ocorrem normalmente durante a puberdade, em crianças com menos de 8 anos no sexo feminino e de 9 anos no sexo masculino (Figuras 10.22 a 10.25).

Nas meninas observa-se arredondamento das formas, desenvolvimento das mamas, aparecimento de pelos axilares e pubianos e, mais raramente, menstruação.

Em meninos chama a atenção o nítido delineamento muscular, o aumento do pênis e dos testículos, além do surgimento de pelos pubianos, axilares e faciais.

O aumento do tamanho dos testículos é um dado fundamental para caracterizar a *puberdade precoce verdadeira*, em que há ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas.

Boxe

Pseudopuberdade precoce

Na *pseudopuberdade precoce*, causada pela secreção excessiva de esteroides sexuais pelas gônadas ou pelas suprarrenais, os testículos têm desenvolvimento proporcional à idade.

As formas mais comuns de puberdade precoce são as chamadas formas incompletas:

Telarca precoce: desenvolvimento precoce das mamas nas meninas

Adrenarca e pubarca precoces: aparecimento precoce dos pelos axilares e pubianos, respectivamente.

Puberdade atrasada

Quando as características sexuais secundárias não surgem até os 14 anos nas meninas ou 15 anos nos meninos, fala-se em puberdade atrasada (Figuras 10.22 a 10.25).

A forma mais comum desta síndrome é a constitucional. Os pais ou parentes próximos do paciente, comumente, também apresentaram o mesmo quadro.

A desnutrição e as doenças crônicas debilitantes podem causar atraso puberal.

Como causas endócrinas temos as de origem central ou hipotálamo-hipofisárias, em que há deficiência na produção/liberação de gonadorrelina hipotalâmica (GH/RH ou FSH/LH/RH) ou deficiência na produção/liberação de FSH e LH e pela hipófise. Este grupo constitui o chamado *hipogonadismo hipogonadotrófico*. Aqui, as dosagens de FSH/LH plasmáticos exibem valores baixos, infantis ou pré-puberais.

A falência congênita na produção de GH/RH ou de FSH/LH ou a adquirida (tumores cerebrais) respondem pela maioria dos casos. Convém lembrar que algumas síndromes genéticas, raras, acompanham-se de hipogonadismo e atraso puberal: síndrome de Kallmann (anosmia ou hiposmia com hipogonadismo) e síndrome de Lawrence-Moon-Biedl (obesidade, polidactilia e hipogonadismo).

Em outro grupo de pacientes com atraso puberal com hipogonadismo não há alteração no hipotálamo ou na hipófise mas sim nas gônadas, que estão ausentes, são malformadas ou foram destruídas. São exemplos, nas meninas, a síndrome de Turner e outras disgenesias gonadais. Nos meninos, a síndrome de Klinefelter (ginecomastia, testículos hipotróficos, azoospermia e sinais de hipogonadismo).

A anorquia congênita e a síndrome de Noonan (aspecto físico similar à síndrome de Turner das meninas) constituem os quadros mais comuns.

Nesses pacientes com hipogonadismo e alterações nas glândulas-alvo ou periféricas observam-se, no plasma, altas taxas de gonadotrofinas; daí o termo *hipogonadismo hipergonadotrófico*.

Infantilismo genital

Infantilismo genital ou sexual caracteriza-se pela falta de desenvolvimento das características sexuais secundárias após a época normal da puberdade. Faz parte do quadro de puberdade atrasada de causa constitucional ou decorrente de hipogonadismo.

Alterações do apetite e do peso

As principais alterações do apetite e do peso são a polifagia com obesidade e a anorexia nervosa.

Alterações cerebrais, congênitas ou adquiridas (transtornos psicológicos, neoplasias) podem ativar ou inibir os núcleos da fome e da saciedade, situados no hipotálamo, causando ganho de peso por excesso de apetite, como nas síndromes de Lawrence-Moon-Biedl ou de Prader-Willi. O contrário acontece na anorexia nervosa, em que há perda do apetite com magreza intensa e alterações menstruais.

A anorexia nervosa pode ser de origem emocional, mas mesmo nesses casos observam-se modificações hormonais.

Galactorreia

A produção de leite fora do período puerperal ou de lactação faz parte das chamadas síndromes hiperprolactinêmicas. Galactorreia pode ocorrer no sexo masculino, mas é mais comum no sexo feminino, comumente associada à amenorreia.

Perturbações hipotálamo-hipofisárias (síndromes de Argonz-Del Castillo ou Chiari-Frommel) ou o uso de medicamentos (fenotiazínicos, sulpirida, neurolépticos) podem produzir hiperprolactinemia. Merecem destaque os adenomas hipofisários prolactino-secretores.

A excessiva secreção de prolactina altera a produção harmoniosa de FSH/LH pelas células gonadotróficas e cria resistência nos ovários à ação gonadotrófica, responsável pela amenorreia.

Polidipsia e poliúria

Uma das manifestações das afecções hipotalâmicas é o diabetes insípido, caracterizado pela incapacidade dos rins em concentrar a urina, cuja causa é a deficiente secreção do hormônio antidiurético por lesão dos núcleos supraópticos ou paraventriculares.

Além da poliúria intensa, ocorrem sede e polidipsia.

Boxe

Diagnóstico diferencial

O *diabetes insípido hipotalâmico* deve ser diferenciado do *diabetes insípido nefrogênico*, no qual se encontra incapacidade renal de concentrar a urina, apesar de concentrações plasmáticas normais de hormônio antidiurético, e da *polidipsia psicogênica*, na qual não há lesão hipotalâmica nem renal, sendo a ingestão compulsiva de água de causa psicológica.

Falta de lactação

A *síndrome de Sheehan* é uma necrose adeno-hipofisária que ocorre após um parto hemorrágico e caracteriza-se por falta de lactação, amenorreia, adinamia, hipotensão postural e sinais de hipotireoidismo. É uma forma relativamente frequente de pan-hipopituitarismo.

TIREOIDE

As afecções tireoidianas podem manifestar-se por sintomas locais (*bócio, dor, dispneia, disfagia e rouquidão*) e por sintomas e sinais de *hiper* ou *hipofunção*. (Ver Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.)

Bócio

Quando a glândula tireoide aumenta de volume, tornando-se palpável ou visível, caracteriza-se a presença de bócio. Se o aumento da glândula for global, uniforme, dá-se a denominação de *bócio difuso*. A presença de nódulos caracteriza o *bócio nodular* (uni ou multinodular, conforme a presença de um ou mais nódulos). Nos bócios pequenos a glândula é apenas palpável, tornando-se visível somente com o pescoço em extensão. Em grau maior a glândula é visível com a cabeça em posição normal e à deglutição. Nos bócios mais evidentes a tireoide é facilmente visível e palpável, seja na forma difusa e nodular.

A maioria dos bócios desenvolve-se por carência de iodo na água ou nos alimentos. Outras causas de bócio são as tireoidites ou o uso de medicamentos (p. ex., amiodarona).

Dor

A dor de origem tireoidiana é localizada na face anterior do pescoço, podendo dar a impressão de estar na garganta; às vezes se irradia para os arcos mandibulares ou para os ouvidos. Pode ser espontânea ou piorar com a palpação e a deglutição.

Sua causa mais frequente é a inflamação aguda ou subaguda da glândula (tireoidite), mas é observada também na necrose hemorrágica de um nódulo preexistente ou no câncer da tireoide.

Dispneia, disfagia e rouquidão

A dispneia, a disfagia e a rouquidão são decorrentes da compressão da traqueia, esôfago ou nervo laríngeo por bócios volumosos ou de crescimento rápido (ver *Diafragma e mediastino*, neste capítulo).

Hipertireoidismo

O hipertireoidismo é uma síndrome complexa causada por níveis elevados de hormônios tireoidianos no sangue.

A intensidade dos sintomas depende não somente da doença causal, tamanho ou duração do bócio, mas também da idade e estado de saúde prévio do paciente. Um jovem pode queixar-se pouco, apesar de grave hipertireoidismo, enquanto uma pessoa idosa pode ter um quadro clínico intenso com um hipertireoidismo relativamente leve.

Três entidades clínicas são responsáveis pela maioria dos casos de hipertireoidismo: *doença de Basedow-Graves*, *doença de Plummer* ou *bócio uninodular tóxico* e *bócio multinodular tóxico*.

Doença de Basedow-Graves

A doença de Basedow-Graves é a forma mais comum. Acomete adultos jovens, preferencialmente mulheres. Trata-se de uma doença autoimune com produção de vários anticorpos, com predomínio dos dirigidos contra os receptores de TSH dos tireócitos.

A síndrome é composta por bócio difuso, alterações oculares, exoftalmia e sintomas dependentes dos níveis circulantes elevados de T3 e T4.

Geralmente o bócio, a exoftalmia e os sintomas de hipertireoidismo desenvolvem-se em tempo curto – 1 ano ou menos.

Mais raramente os pacientes apresentam mixedema pré-tibial e baqueteamento dos dedos.

Podem constituir manifestações importantes o nervosismo, as palpitações, os tremores finos das extremidades e o emagrecimento com preservação do apetite.

O paciente relata mudanças no aspecto dos olhos resultante da protrusão dos globos oculares (exoftalmia), edema periorbital, estrabismo ou dificuldade na movimentação ocular, fotofobia, lacrimejamento, sensação de corpo estranho, dor

retro-orbital e diplopia.

Boxe

Exoftalmo maligno

Grave exoftalmia, com sinais inflamatórios intensos e progressivos, e lagofthalmia, impedindo até o fechamento completo das pálpebras, constituem o chamado *exoftalmo maligno*.

A taquicardia relatada como palpitações constitui uma queixa frequente. Episódios súbitos de taquicardia com intensa irregularidade dos batimentos cardíacos levantam a suspeita de fibrilação atrial.

A pele apresenta-se fina, úmida e quente. As unhas tornam-se finas e podem descolar do leito ungueal, mais comumente no 4º e 5º dedos das mãos. São as chamadas *unhas de Plummer*.

Nos idosos pode ocorrer um quadro clínico diferente, constituído por anorexia, perda de peso, diarreia e apatia. Nesses casos, o médico deve valorizar uma taquicardia persistente e a fraqueza muscular, principalmente nos membros inferiores, que dificulta subir escadas ou levantar da cadeira.

Perda da libido, menstruações escassas com ciclos menstruais encurtados, amenorreia, infertilidade e abortos espontâneos são frequentemente relatados.

Doença de Plummer

A doença de Plummer ou bócio uninodular *tóxico* caracteriza-se pelo aparecimento de um nódulo único de crescimento lento, com características de um adenoma ou neoplasia folicular benigna da tireoide. O tecido nodular é bem diferenciado e secreta os hormônios tireoidianos de forma autônoma, produzindo supressão do hormônio tireotrófico (TSH). À medida que o TSH diminui, a função do tecido tireoidiano normal vai sendo suprimida.

Em geral os pacientes referem sintomas discretos, predominantemente relacionados com o sistema cardiovascular, principalmente palpitações, frequentes ou ocasionais. Nervosismo, tremor fino das mãos, pele quente e úmida e emagrecimento completam o quadro.

Não se observa exoftalmia na doença de Plummer.

Bócio multinodular tóxico

No bócio multinodular tóxico, outra afecção responsável por hipertireoidismo, a anamnese revela a presença de bócio difuso ou nódulos durante muitos anos, antes das manifestações de hiperfunção.

Os sintomas de hipertireoidismo são discretos e predominam no sistema cardiovascular, destacando-se as palpitações com características de fibrilação atrial ou taquicardia paroxística.

No bócio multinodular tóxico também não há exoftalmia.

Hipotireoidismo

A deficiência de hormônios tireoidianos produz sinais e sintomas em vários aparelhos, configurando uma síndrome complexa.

Hipotireoidismo congênito

O hipotireoidismo congênito é relativamente raro, contudo precisa ser reconhecido logo após o nascimento para impedir o retardamento físico e mental, irreversível, destas crianças, se não forem tratadas precocemente.

Os recém-nascidos com hipotireoidismo congênito exibem fontanelas amplas, têm choro rouco, icterícia prolongada (hiperbilirrubinemia por mais de 7 dias), bócio, macroglossia, micrognatismo, pele fria e descamativa, abdome distendido, hérnia umbilical, hipotonia e hipomotilidade, dificuldade para sugar e demora na eliminação do mecônio. Contudo, somente parte das crianças com hipotireoidismo congênito apresenta todos estes sinais nos primeiros meses de idade. Por isso, deve-se valorizar a presença de qualquer um deles.

Com graves consequências para elas, a maioria das crianças só tem o hipotireoidismo diagnosticado bem mais tarde, quando se tornam evidentes os sinais de hipodesenvolvimento somático (nanismo) e neuropsicomotor.

Hipotireoidismo do adulto

As manifestações clínicas do hipotireoidismo são menos evidentes que as do hipertireoidismo. Mesmo uma deficiência relativamente grave pode passar despercebida pelo médico não atento para esta síndrome.

Os sintomas mais frequentes são palidez e edema facial (pálpebras empapuçadas), bócio, cicatriz de cirurgia tireoidiana prévia, voz rouca e grossa, pele seca, fria e descamativa, sonolência, hipersensibilidade ao frio, câibras musculares, parestesias nas extremidades e dificuldade de memória.

A face infiltrada, pálida, inexpressiva, sem brilho no olhar, caracteriza a fácies mixedematosa, que só aparece em casos avançados. (Ver Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

PARATIREOIDES

Os sintomas das doenças das paratireoides dependem do distúrbio funcional, podendo haver *hipo* ou *hiperfunção*, sendo que em ambas as condições ocorrem alterações do metabolismo do cálcio, do fósforo e das unidades metabólicas dos ossos, origem de todas as manifestações clínicas.

Hipoparatiroidismo

O hipoparatiroidismo é uma complicação relativamente comum da tireoidectomia total ou subtotal pela ligadura dos vasos paratireoidianos ou retirada inadvertida das glândulas paratireoides.

Os sintomas mais importantes são decorrentes da hipocalcemia, que provoca aumento da excitabilidade neuromuscular, clinicamente expressa por *tetania*.

A tetania caracteriza-se por contratura das extremidades – espasmo carpopodal (mão de parteiro) – que pode estender-se aos membros e ao tronco.

Quase sempre a tetania é precedida de parestesia, rigidez muscular e câibras.

Boxe

Sinal de Trousseau e sinal de Chvostek

A tetania surge espontaneamente, mas pode ser desencadeada por duas manobras clínicas:

Compressão da artéria braquial pelo manguito do aparelho de pressão, mantendo-o insuflado por 3 a 10 min, 10 mm acima da pressão diastólica do paciente. Se houver hipocalcemia ocorre flexão do punho e adução do polegar com extensão dos outros dedos. É o que se chama *sinal de Trousseau*

Percussão do nervo facial adiante do pavilhão auricular. Quando há hipocalcemia observa-se contração da musculatura da face e do lábio superior no lado em que se fez a percussão. É o *sinal de Chvostek*.

A tetania não é exclusiva do hipoparatiroidismo, podendo ocorrer em outras condições nas quais o nível de cálcio no sangue permanece normal, destacando-se a alcalose provocada por hiperventilação respiratória e algumas doenças infecciosas (tétano).

O paciente com hipoparatiroidismo pode ter crises convulsivas, queda de cabelo, unhas frágeis e quebradiças, dentes hipoplásicos e catarata.

Hiperparatiroidismo

Entre as manifestações de hiperfunção das paratireoides destacam-se perda de peso, fraturas espontâneas, dores *ósseas e articulares*, arritmias cardíacas, alterações gastrintestinais e urinárias, alterações psíquicas e neuromusculares.

A *perda de peso* é consequência principalmente da anorexia.

As *alterações psíquicas* mais comuns são labilidade emocional, ansiedade e depressão. Letargia e até estado de coma ocorrem nos casos mais graves.

Entre as manifestações *neuromusculares* destacam-se a astenia, parestesias, câibras e diminuição da força muscular.

A *dor nos ossos e articulações* decorre de desmineralização por ação do paratormônio e depósito intra-articular de pirofosfato de cálcio.

As *arritmias cardíacas* são representadas pelas extrassístoles e pela taquicardia paroxística. São múltiplas as manifestações *gastrintestinais*, incluindo inapetência, vômitos, dor abdominal e obstipação. Poliúria, nictúria, nefrolitíase e nefrocalcinose são os sintomas que ocorrem no sistema urinário.

Boxe

As *alterações ósseas* podem ter lugar de destaque no hiperparatireoidismo, compreendendo encurvamento dos ossos longos, deformidade de vértebras, fraturas espontâneas ou por traumatismos mínimos, lesões osteolíticas subperiosteais nas falanges distais dos dedos das mãos e perda da lâmina dura dos dentes. (Ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*.)

No *hiperparatireoidismo secundário* salientam-se as alterações ósseas, representadas por raquitismo e osteomalacia. Mas são frequentes as dores ósseas, diminuição da força muscular, tetania, deformidades ósseas e dentes hipoplásicos. Tais manifestações são provocadas pela hipocalcemia decorrente da perda renal de cálcio. As paratireoides tornam-se hiperfuncionantes em resposta à diminuição dos níveis sanguíneos de cálcio.

SUPRARRENAIS

Os sinais e sintomas das doenças das suprarrenais decorrem da redução ou aumento de seus hormônios. Mais raramente, principalmente em crianças, neoplasias volumosas podem acarretar dor abdominal ou compressão de órgãos vizinhos.

As suprarrenais são constituídas histológica e funcionalmente por duas partes distintas: a *cortical*, em que são produzidos os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os esteroides sexuais; e a *medular*, em que são secretadas as catecolaminas.

Aumento da produção de glicocorticoides (síndrome de Cushing)

Esta síndrome apresenta quatro grupos de causas:

Adenoma hipofisário: capaz de secretar quantidade excessiva de ACTH, que vai produzir hiperplasia das suprarrenais, levando à hipercortisolemia: é o *Cushing hipofisário* ou *doença de Cushing*

Tumores da linha média do tronco (principalmente dos pulmões): produzem hormônio ACTH-símile, que também provoca hiperplasia das suprarrenais, com um quadro de *síndrome de Cushing*

Tumores benignos ou malignos das suprarrenais: capazes de produzir autonomamente grandes quantidades de esteroides, constituindo o *Cushing suprarrenal*

Uso prolongado de corticoides: é a causa mais comum (*Cushing iatrogênico*).

A principal característica da síndrome de Cushing é a obesidade centrípeta. Por não se acumular gordura nos membros superiores e inferiores, o corpo do paciente assume um aspecto característico: é um “gordo” de braços e pernas magras.

O rosto torna-se arredondado e pletórico, justificando a denominação de fâcies de “lua cheia”; há acúmulo de tecido adiposo na região nucal, configurando-se uma espécie de *cupim* ou *giba de búfalo*; o abdome torna-se volumoso, às vezes dobrando-se sobre si mesmo, e recoberto por estrias vinhosas nas porções laterais.

Nas crianças o aspecto corporal é o mesmo, mas como o excesso de cortisol inibe a produção de GH, observa-se também atraso no crescimento.

A hipotrofia da musculatura dos membros inferiores causa fraqueza muscular, responsável pela dificuldade para subir degraus.

Hipertensão arterial é detectada na maioria dos pacientes.

Acne no rosto e no dorso, hirsutismo (Quadro 6.38), distúrbios menstruais ou amenorreia, equimoses, facilidade para sangramento e labilidade emocional também são frequentes.

Quadro 6.38

Causas de hirsutismo ou virilismo.

Doença de Cushing

Hiperplasia da suprarrenal
Neoplasias da suprarrenal
Doença policística dos ovários
Neoplasias do ovário
Distúrbios genéticos
Hirsutismo idiopático
Medicamentos (minoxidil, fenitoína, ciclosporina, danazol, testosterona)

A hipercortisolemia causa resistência insulínica e intolerância à glicose com curva glicêmica alterada na maioria dos pacientes, mas diabetes franco só ocorre em 25% dos casos.

Diminuição da produção de glicocorticoides

A redução da secreção de glicocorticoides pode estar acompanhada ou não da dos mineralocorticoides, podendo-se diferenciar clinicamente uma forma aguda e uma crônica.

Insuficiência suprarrenal aguda

Na insuficiência suprarrenal aguda (síndrome de Waterhouse-Friderichsen) ocorrem hipotensão arterial grave, anorexia, náuseas, vômitos, sufusões hemorrágicas, podendo ocorrer o óbito em curto espaço de tempo.

Insuficiência suprarrenal crônica (doença de Addison)

Na insuficiência suprarrenal crônica há redução na secreção de glico- e mineralocorticoides, responsável pela astenia, hipotensão arterial ortostática, tonturas, desmaio, inapetência, náuseas e vômitos matinais.

Um elemento que chama a atenção para a possibilidade de insuficiência suprarrenal primária é a hiperpigmentação cutânea. O próprio paciente nota um progressivo escurecimento da sua pele, principalmente nas dobras, das gengivas e das cicatrizes. Esta pigmentação é explicada pela maior produção de ACTH e pró-melanocortina pela hipófise hiperplasiada.

Constituem as principais causas da insuficiência suprarrenal crônica a doença autoimune, a tuberculose e a blastomicose sul-americana.

Os baixos níveis de cortisol plasmático e a dosagem de ACTH confirmam o diagnóstico.

As doenças hipotálamo-hipofisárias com diminuição da produção de ACTH podem causar insuficiência suprarrenal secundária. Nesse caso não ocorre hiperpigmentação cutaneomucosa e tanto o cortisol plasmático quanto o ACTH apresentam níveis baixos.

Aumento da produção de mineralocorticoides

O principal mineralocorticoide é a aldosterona. Níveis altos deste hormônio provocam *hipertensão arterial e hipopotassemia*.

A hipopotassemia é a causa da fraqueza muscular, adinamia, câibras e parestesias nas extremidades. Quando a hipopotassemia for acentuada, pode ocorrer paralisia flácida.

Aumento da produção de esteroides sexuais

A hiperfunção da suprarrenal pode acompanhar-se da elevação não só dos níveis sanguíneos dos glico e mineralocorticoides, mas também dos esteroides sexuais (estrogênios e androgênios).

O excesso de esteroides androgênicos em crianças desencadeia o quadro de pseudopuberdade precoce com características

isosssexuais no sexo masculino (desenvolvimento do pênis, de pelos pubianos e axilares) e heterossexuais no sexo feminino (pelos pubianos e axilares e hipertrofia do clitóris).

Em ambos os sexos, ocorrem aceleração da velocidade do crescimento e avanço na maturação esquelética, que podem resultar no fechamento precoce das cartilagens de conjugação epifisária, determinando baixa estatura.

Na mulher adulta, o excesso de androgênios provoca hirsutismo ou virilismo (Quadro 6.38).

Boxe

Hirsutismo e virilismo

Hirsutismo: caracteriza-se pela presença de pelos com características masculinas, ou seja, escuros, grossos e crespos, em locais de implantação dos pelos masculinos (face, tronco, pernas)

Virilismo: além da acentuação do hirsutismo, surge recesso temporal dos cabelos (“entradas”), atrofia das mamas, engrossamento da voz, hipertrofia muscular, amenorreia, acne e hipertrofia do clitóris.

Em homens adultos o excesso de hormônios androgênicos não provoca alterações evidentes.

Aumento da produção de catecolaminas

Em geral, as manifestações decorrentes da hiperprodução de catecolaminas surgem em crises constituídas por cefaleia, sudorese excessiva, palidez, palpitações por taquicardia e hipertensão arterial.

As crises hipertensivas estão diretamente relacionadas com a secreção aumentada de catecolaminas, mas, com o passar do tempo, vão sendo substituídas por uma elevação tensional permanente. Todavia, mesmo nesses pacientes continua havendo aumentos paroxísticos da pressão arterial acompanhados das outras manifestações catecolamínicas.

A hiperprodução de catecolaminas é causada por neoplasias das células cromafins da medula da suprarrenal – o feocromocitoma.

GÔNADAS

Do ponto de vista endócrino devem-se distinguir as *alterações endócrinas testiculares* e as *ovarianas*.

Alterações endócrinas testiculares

Do ponto de vista endócrino, as principais manifestações clínicas são o hipogonadismo (síndrome de Klinefelter), caracterizado por desenvolvimento incompleto dos caracteres sexuais secundários, alteração das proporções corporais com membros inferiores anormalmente longos, ginecomastia bilateral e retardo mental.

Outra manifestação de produção insuficiente de testosterona é o atraso puberal.

Alterações endócrinas ovarianas

As principais síndromes endócrinas de origem ovariana têm como sintoma principal a *amenorreia*, que pode ser primária ou secundária:

Amenorreia primária: é a ausência de menarca após os 16 anos. A causa mais frequente é a disgenesia gonádica, que compreende a *síndrome de Turner* e suas variantes, que se expressam por infantilismo sexual, micrognatia, epicanto, orelhas de implantação baixa, “boca de peixe” e ptose palpebral. O pescoço é dito alado e o tórax adquire o aspecto de escudo. O desenvolvimento puberal está ausente ou é incompleto

Amenorreia secundária: é a ausência de menstruação em pacientes que tiveram catamênios anteriormente. A causa mais frequente é a síndrome de ovários policísticos, que se acompanha de produção aumentada de estrogênios. Quando há também secreção excessiva de androgênios, aparece hirsutismo ou virilismo.

METABOLISMO E CONDIÇÕES NUTRICIONAIS

O metabolismo é um conjunto de atividades bioquímicas extremamente complexas, com participação de todos os sistemas

orgânicos, com múltiplos mecanismos de regulação, o que obriga o médico a ter uma visão abrangente para reconhecer as alterações metabólicas.

Do ponto de vista semiológico, é mais prático analisar os principais distúrbios metabólicos, destacando-se *diabetes, síndrome hipoglicêmica, desnutrição, hipovitaminoses, erros inatos do metabolismo proteico* (fenilcetonúria, alcaptonúria, albinismo), *gota, desidratação, porfirias, dislipidemias* (aterosclerose, doença de Gaucher, doença de Niemann-Pick) e *hemocromatose*.

Ver *Avaliação do estado nutricional* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.

DESNUTRIÇÃO

A desnutrição deve ser conceituada como um conjunto de carências de natureza diversa, com predomínio de baixa ingestão de proteínas, daí a denominação *deficiência calórico-proteica*.

As manifestações clínicas dependem da gravidade da deficiência de nutrientes, da idade do paciente e da presença de outros fatores, direta ou indiretamente relacionados com a desnutrição, como é o caso do etilismo em adultos.

Em maior ou menor grau, todos esses pacientes apresentam astenia, irritabilidade e diminuição da atividade mental, que pode chegar à apatia.

Chama a atenção a magreza, com redução da massa muscular e do tecido celular subcutâneo, e no caso de crianças, o hipodesenvolvimento estatural que pode redundar em nanismo.

Em alguns pacientes, aparece um edema generalizado que chega a mascarar a magreza.

Lesões cutâneas, relacionadas com a deficiência de proteínas ou de vitaminas, são frequentes, salientando-se pele seca e sem brilho, dermatite com placas escuras disseminadas.

Os cabelos tornam-se quebradiços e sua coloração muda, tornando-se até avermelhados, como se observa no kwashiorkor.

Causas de desnutrição. Ver Quadro 6.39.

Ver *Avaliação do estado nutricional* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.

Boxe

Magreza e desnutrição

Magreza não é sinônimo de desnutrição. Significa apenas que o indivíduo tem um índice de massa corporal menor que 19,0, não acompanhado de alterações indicativas de carência de nutrientes, tais como anemia, deficiência de ferro, baixos níveis proteicos, hipovitaminoses.

Quadro 6.39 Causas de desnutrição.

Falta de alimentos (situação de miséria)

Inapetência provocada por doenças crônicas

Etilismo

Diarreia crônica

Síndrome de má absorção

Diabetes

Cirrose hepática

Insuficiência cardíaca

Hipertireoidismo

Neoplasias malignas em fase avançada

Dieta de emagrecimento não balanceada

Anorexia nervosa e bulimia

Síndrome de desidratação

A desidratação é uma síndrome com múltiplas causas, salientando-se vômitos, diarreia, sudorese, poliúria e ingestão de água em quantidade inferior à que o organismo necessita (principalmente em idosos).

Os sinais e sintomas dependem da intensidade da perda de água e eletrólitos, incluindo sede intensa, astenia, alterações do comportamento, apatia e até crises convulsivas nas condições mais graves (ver Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Hipovitaminoses

As carências vitamínicas produzem sinais e sintomas que permitem identificar o elemento predominantemente em falta, devendo-se, contudo, estar atento para o fato de que raramente há carência isolada de uma única vitamina.

Encontram-se manifestações clínicas em todos os sistemas, mas predominam na pele, boca, olhos, sistema hemopoético, sistema locomotor e sistema nervoso periférico, conforme se vê no Quadro 6.40.

Diabetes

O diabetes melito é uma síndrome basicamente devida à deficiência absoluta ou relativa de insulina, principal responsável pelo metabolismo dos carboidratos.

Admite-se que tal distúrbio seja de origem genética, mas desencadeado, agravado ou agudizado por diversos fatores, tais como virose na infância, obesidade, vida sedentária, estresse emocional ou físico.

Classifica-se o diabetes em tipo 1, tipo 2 e secundário. Distinguem-se destes o *diabetes gestacional* e a *tolerância diminuída à glicose*.

O diabetes pode permanecer assintomático, manifestar-se por sintomas isolados (prurido vulvar, por exemplo) ou constituir uma síndrome com *poliúria*, *polidipsia*, *polifagia* e *perda de peso* (para facilitar a memorização, poderia ser chamada síndrome dos 5 “P”).

Merecem referência outras manifestações que podem predominar no quadro clínico: alterações da acuidade visual, surtos de diarreia, disfunção erétil, queilite angular, necrobiose diabética, lesões isquêmicas ou tróficas dos membros inferiores e polineuropatias, estudadas em vários outros pontos deste capítulo.

Síndrome hipoglicêmica

Sensação de fraqueza, tremor, sudorese profusa, sensação de não saber onde se encontra, transtornos do comportamento, perda da consciência e até convulsões, dependendo da maneira como se instalou o quadro, sua duração e gravidade.

Um dado clínico útil no reconhecimento da síndrome hipoglicêmica é a rápida recuperação do paciente pela ingestão de açúcar, doce ou aplicação intravenosa de glicose.

Causas de hipoglicemia. Ver Quadro 6.41.

Dislipidemias

As alterações do metabolismo dos lipídios têm como característica principal o aumento dos vários componentes deste grupo de substâncias, principalmente do colesterol e dos triglicerídios.

As manifestações mais específicas das dislipidemias – *xantomas* e *xantelasmas* – são depósitos subcutâneos de substâncias

lipídicas nos cotovelos, tornozelos, mãos, tendão do calcâneo e pálpebras.

Relacionadas com as dislipidemias estão a *aterosclerose*, a *doença de Gaucher* e a *doença de Niemann-Pick*.

A aterosclerose, cuja lesão essencial é o espessamento da íntima das artérias, tem como elemento primordial a deposição de colesterol, sendo que vários outros fatores participam de sua patogênese.

Nas doenças de Gaucher e de Niemann-Pick, as alterações do metabolismo lipídico afetam o sistema reticuloendotelial com lesões em diferentes órgãos, principalmente pele, sistema nervoso central, fígado e baço (hepatoesplenomegalia).

Gota

É uma doença de caráter hereditário, decorrente de alteração do metabolismo das purinas, que se caracteriza pelo depósito de ácido úrico em várias estruturas, principalmente articulares.

O quadro clínico tem como manifestação principal a ocorrência de artrite aguda que se localiza na maioria dos casos na primeira articulação metatarsofalangiana (podagra).

A deposição de uratos pode fazer-se em outras articulações, inclusive das mãos, e em locais que não as articulações, como, por exemplo, no lobo da orelha (tofos).

Boxe

Pseudogota

Processo inflamatório agudo causado pela deposição de cristais de pirofosfato de cálcio na cartilagem hialina e na fibrocartilagem das grandes articulações.

Hemocromatose

A hemocromatose é uma alteração do metabolismo do ferro, que pode ser primário ou secundário.

No tipo primário há uma anomalia genética que produz aumento da absorção com deposição de hemossiderina nos tecidos (fígado, pâncreas, coração, hipófise e suprarrenal).

Quadro 6.40 Sinais e sintomas das carências vitamínicas (hipovitaminoses).	
Vitamina	Sinais e sintomas de hipovitaminose
Vitamina A	Cegueira noturna (sintoma mais precoce), xeroftalmia, placas superficiais na conjuntiva bulbar exposta (manchas de Bitot), alterações degenerativas da retina; ulceração e necrose da córnea (pode levar a perfuração e cegueira, particularmente em crianças e jovens). Pele áspera e seca, hiperqueratose. Atraso do crescimento, inapetência, anemia, tendência a infecções respiratórias em crianças
Vitamina B1	Fadiga, irritabilidade, transtornos do sono, inapetência, desconforto abdominal e constipação intestinal. Alterações neurológicas (parestesias nos dedos dos pés, queimação nos pés (que piora à noite), câibras nas panturrilhas, dificuldade em se levantar da posição de cócoras), alterações neuropsiquiátricas (confusão mental, afonia, confabulação, nistagmo, oftalmoplegia total), cardiovasculares (taquicardia, sudorese, pele quente [inicialmente], insuficiência cardíaca (dispneia, edema generalizado). Beribéri infantil (insuficiência cardíaca, afonia e ausência dos reflexos tendinosos profundos) ocorre em lactentes amamentados por mães com deficiência de tiamina

Vitamina B2	Estomatite angular, queilose, glossite, prurido e ardor nos olhos; fotofobia, neovascularização da córnea, ambliopia, dermatite seborreica, dermatite anogenital, ardor nos pés, anemia normocrômica e normocítica. Durante a gravidez, a deficiência resulta em anormalidades esqueléticas do feto (encurtamento dos ossos e crescimento deformado) Não há relatos de toxicidade com suplementação de riboflavina, embora a urina possa tornar-se amarelada
Vitamina B3	Pelagra (dermatose em áreas corporais expostas à luz solar, diarreia ou disfunção gastrointestinal; glossite, estomatite, vaginite e transtornos mentais iniciados por diminuição da memória, fadiga, insônia e apatia)
Vitamina B5	Irritabilidade, anorexia, dormência e formigamento nas mãos e nos pés; ardor nos pés, insônia, constipação intestinal, vômitos, náuseas, taquicardia aos esforços, cefaleia, astenia, hipotensão postural, fraqueza dos músculos extensores dos dedos
Vitamina B6	Lesões seborreicas na região nasolabial, erupção cutânea papular na face, glossite, hipertrofia das papilas gustativas, queilose, neuropatia periférica, linfopenia, convulsões em lactentes, anemia normoblástica em adultos, irritabilidade, depressão, ansiedade, cefaleia, insônia, confusão mental, maior risco de aterosclerose pelo aumento do colesterol total e do LDL-colesterol e redução do HDL-colesterol
Vitamina B7	Anorexia, depressão, náuseas, vômitos, glossite, mialgia, ataxia, hipotonia, hiperestesia, hipercolesterolemia, palidez, alopecia, unhas quebradiças, dermatite seborreica
Vitamina B9	Anemia megaloblástica, leucopenia, malformações fetais (meningomielocoele e anencefalia)
Vitamina B12	Glossite com sensação de queimação; perda de peso, anorexia, constipação intestinal intermitente, diarreia, dor abdominal. Alterações neurológicas (perda de sensibilidade vibratória das extremidades inferiores, perda do sentido de posição e ataxia; reflexos hiperativos e sinal de Babinski) e psiquiátricas (irritabilidade, depressão leve ou transtornos paranoides); constipação intestinal, palpitação, hipotensão postural. Anemia
Vitamina C	Alterações gengivais e dentárias (edema, friabilidade, sangramento, infecções secundárias e queda de dentes); petéquias, equimoses e hemorragias em várias regiões e órgãos; anemia normocítica e normocrômica; eritema e queratinização folicular; cicatrização deficiente ou reabertura de feridas recentemente cicatrizadas; astenia, cefaleia, dores ósseas, transtornos emocionais (depressão, transtornos somatoformes)
Vitamina D	Em lactentes, sono inquieto; mineralização reduzida nas suturas cranianas, com

	atraso no fechamento da fontanela; rosário raquítico; atraso psicomotor, <i>genu varum</i> e cifoescoliose (as alterações radiológicas precedem os sinais clínicos). Nos adultos, há desmineralização da coluna vertebral, pelve e extremidades inferiores (osteomalacia), podendo levar a encurtamento das vértebras e achatamento dos ossos da pelve, fraqueza muscular
Vitamina E	Arreflexia, distúrbios da marcha, deficiência na propriocepção e da sensação vibratória, paresia do olhar; hemólise, creatinúria e deposição de ceróide no músculo; dores musculares, anemia hemolítica em prematuros, esteatose hepática
Vitamina K	Hemorragia, por deficiência de protrombina, nas gengivas, nariz, mucosa gastrointestinal e feridas cirúrgicas, hematúria, epistaxes

Quadro 6.41 Causas de hipoglicemia.	
Orgânicas	
Hiperinsulinismo (adenoma ou carcinoma das células beta do pâncreas)	
Nesidioblastose (proliferação de células insulinossecretoras fora das ilhotas de Langerhans)	
Doença de von Gierke	
Galactosemia	
Funcionais	
Fase inicial do diabetes	
Jejum prolongado	
Trabalho muscular intenso com alimentação insuficiente	
Iatrogênica	
Uso de insulina ou hipoglicemiante em doses inadequadas	

O quadro clínico é constituído por pigmentação da pele, cianose e diabetes.

A hemocromatose secundária é consequente à excessiva introdução de ferro no organismo por via parenteral, por meio de repetidas transfusões de sangue ou terapêutica prolongada com sais de ferro.

Porfirias

As porfirias são enfermidades decorrentes de erro do metabolismo das porfirinas que resultam em superprodução e acúmulo destas substâncias na pele, causando fotossensibilidade, expressa pelo surgimento de bolhas e vesículas nas regiões expostas à luz, necrose e destruição de tecidos que culminam em mutilações nas mãos e na face. Esta forma é congênita e se denomina doença de Gunter.

Um tipo especial de porfiria é a hepática, na qual o local de superprodução de porfirinas é o fígado; manifesta-se clinicamente por crises de dor abdominal e lesões do sistema nervoso periférico, com dor, parestesias e paralisias.

Erros inatos do metabolismo proteico

Entre as afecções causadas por erro inato do metabolismo, conceituado como ausência congênita de vias metabólicas que normalmente deviam existir, destacam-se a *fenilcetonúria*, a *alcaptonúria* e o *albinismo*.

Fenilcetonúria. Ocorre acúmulo de fenilalanina no plasma e no liquor, por impossibilidade de hidrolisação da tironina, produto de sua metabolização.

As principais manifestações clínicas são dermatite, convulsões e retardo mental.

Alcaptonúria. Acumula-se no organismo o ácido homogentísico, produto do metabolismo da tirosina que não pode ser metabolizado e é excretado pela urina.

Pigmentação escura da pele, das cartilagens e tendões são as principais manifestações clínicas. A coloração cinza-castanha é visível nas escleróticas, nas orelhas e no nariz por transparência da pele.

Albinismo. O defeito está na síntese de melanina, causando hipopigmentação dos cabelos, da pele, que adquire cor leitosa, e da íris, que se torna translúcida.

Observam-se, também, fotofobia e nistagmo.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Os principais sinais e sintomas das afecções do sistema nervoso central são *transtornos da consciência, dor de cabeça e na face, tontura e vertigem, convulsões e outros movimentos involuntários, ausências, automatismos, amnésia, distúrbios visuais, alterações auditivas, manifestações digestivas, alterações da sensibilidade, da motilidade voluntária e da marcha, distúrbios esfínterianos, transtornos do sono, alterações das funções cerebrais superiores e avaliação do estado mental* (Figura 6.43).

Ver Capítulo 20, *Exame Neurológico*.

Transtornos da consciência

A percepção consciente do mundo exterior e de si mesmo caracteriza o estado de vigília, que é resultante da atividade de diversas áreas cerebrais coordenadas pelo sistema reticulotalâmico (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

Entre o estado de vigília ou plena consciência e o estado de coma profundo no qual o paciente perde completamente a capacidade de identificar seu mundo interior e os acontecimentos do meio que o circunda, é possível distinguir diversas fases intermediárias em uma graduação cujo principal elemento indicativo é o nível da consciência.

Estado de coma

Por haver dificuldade, em algumas ocasiões, para se estabelecer o limite entre o estado normal e o comprometimento da consciência, é muito usada a designação *obnubilado* quando o paciente apresenta apenas transtornos de ideação e certa confusão mental. Mas, independente desta dificuldade, deve-se lançar mão de quatro parâmetros sempre que se observar qualquer grau de alteração do nível de consciência: *perceptividade, reatividade, deglutição e reflexos*. (Ver Capítulo 20, *Exame Neurológico*.)

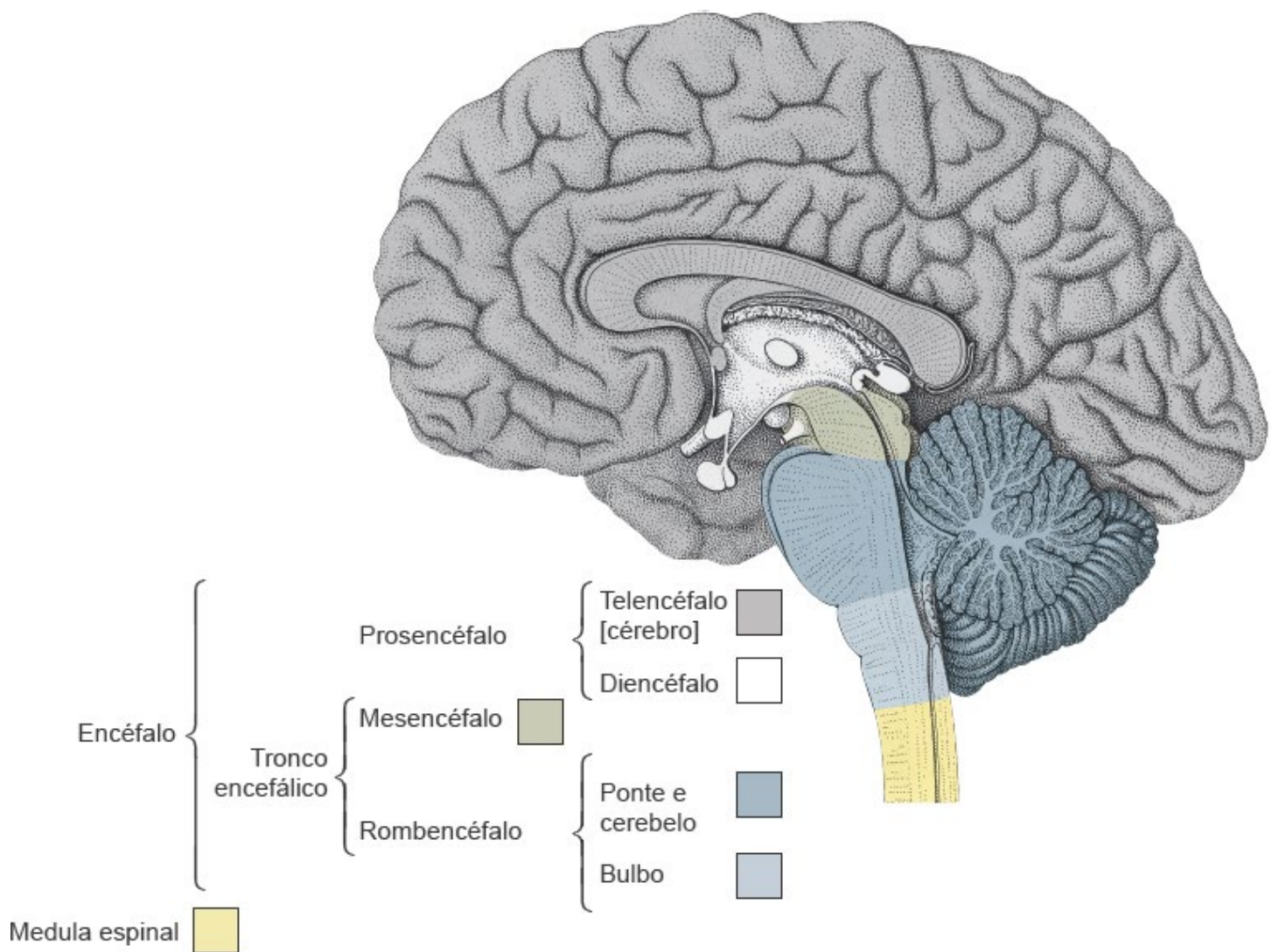


Figura 6.43 Sistema nervoso central. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

Perceptividade. Significa a capacidade para responder a perguntas simples, por exemplo, “Como vai?”, ou informar coisas corriqueiras, como o nome de seus familiares, seu endereço, ou atender a ordens do tipo “Sente-se na cama”, “Tire a camisa”.

Reatividade. É a capacidade de reagir a estímulos inespecíficos, como desviar os olhos e a cabeça para um ponto onde se faça um barulho, enquanto o médico apenas observa, sem interferir. Mas a reatividade pode ser avaliada, também, em relação à dor. Aqui há necessidade de executar alguma manobra apropriada. Costuma-se esfregar o esterno do paciente ou comprimir a unha de um dedo da mão ou do pé com a ajuda de um objeto rombo.

A reação do paciente se faz por reclamação verbal ou pela movimentação corporal, apropriada ou não.

Deglutição. Ao se oferecer um copo d’água, fica-se atento ao comportamento do paciente, analisando-se o modo como procura o copo com suas mãos, como o leva à boca e se deglute a água normalmente.

Reflexos. Durante o exame físico, faz-se a pesquisa de alguns reflexos tendinosos (patelar, por exemplo), plantares, cutâneos abdominais e pupilar. (Ver Capítulo 20, *Exame Neurológico*.)

Classificação do estado de coma. O estado de coma pode ser tradicionalmente classificado da seguinte maneira:

Coma leve, vígil ou grau I: é aquele no qual o comprometimento da consciência é leve, o paciente permanecendo capaz de atender às ordens do tipo “abrir e fechar os olhos”, “levantar os braços” e responder a perguntas pessoais. Reage bem e de modo apropriado à estimulação dolorosa. A deglutição e os reflexos são normais

Coma de grau médio ou grau II: a perda da consciência é quase total, estando a perceptividade do paciente bastante reduzida. Responde apenas à estimulação dolorosa enérgica e o faz desapropriadamente. A deglutição é feita com dificuldade. Continuam preservados os reflexos tendinosos, cutâneos e pupilar

Coma profundo, cárus ou grau III: a perda da consciência é completa, o paciente não responde às solicitações externas por mais intensas que sejam, ou seja, sua perceptividade é igual a zero. Não deglute água e nenhum estímulo doloroso desperta

reação. Além disso, observa-se arreflexia tendinosa, cutânea e pupilar, relaxamento completo da musculatura e incontinência esfinteriana

Coma *depassé* ou grau IV: além dos dados presentes no coma de grau III, no coma *depassé* há comprometimento inclusive das funções vitais; vale dizer, há parada respiratória, sendo a ventilação pulmonar mantida à custa de respiradores artificiais. É quase sempre um estado irreversível, e o EEG revela silêncio elétrico cerebral. O reconhecimento deste tipo de coma adquiriu interesse após o incremento de transplantes de órgãos retirados de indivíduos acidentados. Sua conceituação tem acompanhado as discussões éticas e médico-legais sobre os conceitos de “morte clínica” e “morte cerebral”.

Ainda do ponto de vista semiológico, deve ser investigada a maneira como se instalou o estado comatoso, o qual pode ter início súbito e instalação abrupta, ou ter início lento e instalação gradativa, levando horas ou dias para se definir inteiramente.

As principais causas de coma estão sumarizadas no Quadro 6.42.

Escala de Glasgow. Com o intuito de simplificar e quantificar os transtornos da consciência em pacientes com traumatismo cranioencefálico, surgiu uma escala que vem substituindo as classificações de coma.

A escala de Glasgow baseia-se em três parâmetros, facilmente compreendidos e aplicáveis à beira do leito, inclusive pelo pessoal auxiliar, constituídos pela abertura dos olhos, resposta motora e resposta verbal, cada um deles compreendendo várias alternativas que vão desde a resposta normal, própria de pacientes sem transtornos da consciência, até ausência completa de resposta, indicativa das situações mais graves.

Conforme se vê no Quadro 6.43, as alternativas de cada parâmetro recebem um valor quantitativo, que vai de 1 a 4, 1 a 5 ou 1 a 6.

Para se examinar a *abertura dos olhos*, observa-se, inicialmente, se o paciente mantém os olhos abertos espontaneamente (4 pontos), se abre os olhos quando solicitado verbalmente (3 pontos) ou só o faz após estímulo doloroso (2 pontos); quando não há resposta, computa-se 1 ponto.

A *resposta motora* corresponde à execução de movimentos por comando verbal (6 pontos) ou estímulo álgico (de 5 a 2 pontos, conforme o tipo de resposta). Sem resposta, apenas 1 ponto.

Resposta verbal significa a capacidade e a qualidade da resposta verbal que o paciente apresenta ao ser inquirido. Resposta orientada (5 pontos), desorientada ou confusa (4 pontos), se usa palavras impróprias ou inadequadas (3 pontos), se emite sons incomprensíveis (2 pontos); quando não há resposta, 1 ponto.

Terminada a avaliação, obtém-se um escore que vai de 15 a 3 pontos. Os extremos da escala, ou seja, valores próximos de 15 ou 3 pontos, caracterizam a normalidade ou o coma grave. Entre os dois extremos encontram-se vários graus que representam a transição entre o estado de consciência normal e o grau máximo de seu comprometimento. Em termos práticos, abaixo de 8 ou 7 pontos corresponde a estado de coma.

Causas (Quadro 6.42). Realizando-se um adequado exame clínico, a identificação da causa pode ser fácil. Mas, em alguns pacientes, podem ser necessários exames complementares de urgência (laboratoriais, exames de neuroimagem).

Quadro 6.42	
Causas de coma.	
Traumatismo cranioencefálico	
Acidente vascular encefálico (isquêmico e hemorrágico)	
Tumores cerebrais	
Infecções do sistema nervoso central (encefalites, meningites e abscessos)	
Epilepsia (crises convulsivas e pós-convulsivas)	
Diabetes	
Insuficiência hepática	

Quadro 6.44**Causas de dor de cabeça e na face.**

Febre de qualquer causa

Enxaqueca

Hipertensão intracraniana

Transtornos visuais

Glaucoma agudo

Sinusites

Neuralgia do trigêmeo

Arterite temporal

Hematoma subdural crônico

Pós-traumatismo cranioencefálico

Pós-convulsões

Meningite

Hemorragia subaracnóidea

Tumor cerebral

Espondiloartrose cervical

Medicamentos (vasodilatadores, quimioterápicos)

Tensão nervosa

Transtorno de ansiedade

Ver Dor, no item Região bucomaxilofacial.

Dor de cabeça

A dor de cabeça ou cefaleia é uma das queixas mais frequentes na prática médica e tem inúmeras causas (Quadro 6.44). Para bem analisá-la, é necessário reconhecer seus principais tipos.

Enxaqueca. A enxaqueca geralmente é hemicraniana (frontotemporal), de intensidade crescente, em muitos pacientes precedida por alterações visuais transitórias (escotomas cintilantes, hemianopsias, escurecimento visual) ou por parestesias fugazes (dormência em uma das mãos, por exemplo). Quase sempre existem sintomas acompanhantes, com destaque especial para náuseas e vômitos, fotofobia, hiperacusia e irritabilidade.

Outra característica importante da cefaleia é seu caráter pulsátil, latejante, acompanhando os batimentos cardíacos.

O paciente obtém alguma melhora quando se recolhe a um quarto escuro e silencioso. A enxaqueca típica se manifesta por crises que duram de algumas horas até 1 a 2 dias, intercaladas por períodos de acalmia de duração variável.

Boxe

Classificação da enxaqueca (Sociedade Internacional de Cefaleia)

Enxaqueca sem aura

Enxaqueca com aura (visuais, sensitivas, motoras)

Enxaqueca oftalmológica (paresia de um ou mais dos nervos oculomotores)

Enxaqueca retiniana (escotomas ou amaurose transitória)

Síndrome periódica da infância (sistemas recorrentes considerados como equivalentes aos da enxaqueca)

Cefaleia tipo tensão ou tensional. Este tipo de cefaleia costuma ser descrita pelos pacientes como uma dor constritiva, em aperto, às vezes como um peso no alto da cabeça. Geralmente há um fundo doloroso constante, de intensidade leve a moderada, com pioras ocasionais. Outra localização comum é nos músculos da nuca, a partir de onde se difunde para toda a cabeça. Indica contração prolongada da musculatura, em consequência de má postura, alterações da coluna cervical ou tensão psíquica.

Cefaleia em salvas. Dor de grande intensidade, unilateral fronto-orbitária, descrita como vinda detrás do olho. Distúrbios autônomos no lado da dor acompanham a crise (lacrimejamento, obstrução nasal, rinorreia, sudorese na fronte, ptose palpebral). Dura de 15 a 180 min, com frequência de um ataque a cada 2 dias. Dado importante: a inalação de O₂ corta a crise.

Hemicrania paroxística. Dor semelhante à cefaleia em salvas, mas as crises são mais curtas e mais frequentes. As manifestações autonômicas são semelhantes. Alívio rápido com indometacina.

Cefaleia pós-traumática. Instala-se após traumatismo cranioencefálico.

Boxe

Dor de cabeça e enxaqueca

Enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença neurológica caracterizada por um conjunto de sintomas, dentre os quais destaca-se a cefaleia.

Cefaleia da hipertensão intracraniana. O aumento da pressão no interior da caixa craniana ocasiona uma cefaleia pulsátil que toma a cabeça toda e perdura dias ou meses, cada vez mais intensa. Com o passar do tempo, torna-se resistente aos analgésicos. Quase sempre, exacerba-se pela manhã, quando passa a se acompanhar de vômitos.

Os sintomas associados mais comuns são náuseas e vômitos. Os vômitos podem ser abruptos, sem náuseas, sendo a substância vomitada projetada a distância – é o que se denomina “vômito em jato” ou “vômito cerebral”. Diplopia, diminuição da acuidade visual, convulsões e alterações psíquicas que variam desde apatia e indiferença até excitação e agressividade são outras manifestações concomitantes.

Cefaleia associada a distúrbios oculares e sinusites. A cefaleia pode ser provocada por erros de refração (hipermetropia e astigmatismo), glaucoma agudo (predomina no olho e ao seu redor), inflamação dos seios paranasais.

Outros tipos de cefaleia. Cervicogênica, associada a exercício ou atividade sexual, por uso crônico de analgésicos.

Dor na face

Podem ocorrer vários tipos de *dor facial*, variando a localização, a intensidade, o caráter e a irradiação de conformidade com a

etiologia, que compreende afecções odontológicas, sinusais, oftalmológicas, distúrbios da articulação temporomandibular, alterações do septo nasal (ver *Região bucomaxilofacial*, neste capítulo).

Uma dor facial muito característica, embora pouco frequente, é a *neuralgia do trigêmeo*, que se caracteriza por ser extremamente intensa, em agulhada (descrita como “choque” ou “faísca”), no território de um dos três ramos periféricos do V nervo craniano. É estritamente unilateral, podendo ser desencadeada por estimulação de uma determinada área (zona-gatilho), sendo a comissura labial o ponto mais comum, fato que obriga o paciente a não sorrir, conversar ou mastigar, com o intuito de não mover os lábios. A neuralgia do trigêmeo é mais frequente em pessoas idosas.

Tonturas e vertigem

Tontura ou tonteira, também relatada com as denominações “tontice”, “zonzeira”, “cabeça vazia”, é uma queixa bastante frequente, observada em quase todas as faixas etárias e que apresenta inúmeras causas (Quadro 6.45).

A partir das características semiológicas, distinguem-se vários tipos de tontura:

Tontura com sensação de iminente desmaio. Nessa condição o paciente se torna pálido, com escurecimento visual e transpiração profusa. Estes sintomas regridem rapidamente quando o paciente assume a posição deitada. Quando a causa é de origem cardíaca, as manifestações surgem de modo súbito e têm curta duração. Se os sintomas tiverem instalação gradual e forem persistentes, deve-se pensar em hipoglicemia ou queda do fluxo sanguíneo cerebral. Na maioria das vezes ela é oriunda da redução do fluxo sanguíneo cerebral por arritmia cardíaca ou queda abrupta da pressão arterial, quando o paciente se levanta bruscamente (hipotensão postural).

Tontura com sensação de desequilíbrio. Este tipo de tontura só ocorre quando o paciente anda, e regride quando se senta ou se deita.

Tontura com “sensação desagradável na cabeça”. É um tipo de difícil caracterização por ser mal definida e imprecisamente descrita pelos pacientes. Nessas circunstâncias, deve-se pensar em hipertensão arterial, hipotensão arterial, hiperventilação, arritmia cardíaca com baixo débito, depressão ou ansiedade.

Vertigem (tontura com sensação de rotação). O paciente tem a sensação de girar em torno do ambiente ou vice-versa. Com frequência a vertigem se instala abruptamente, acompanhada de náuseas, vômitos, desequilíbrio, palidez e sudorese. Se o paciente estiver de pé – parado ou andando – pode desabar no solo. A sensação vertiginosa independe da posição em que se encontre o paciente, mas piora com a mudança de posição. Pode ser suficientemente incômoda a ponto de obrigá-lo a permanecer imóvel no leito.

A vertigem decorre predominantemente de lesão ou disfunção das vias vestibulares, em especial de sua porção periférica (canais semicirculares e ramo vestibular do VIII nervo craniano), constituindo a síndrome vestibular periférica. Suas causas principais são infecções, intoxicações, tumores e edema do labirinto.

Um tipo especial é a vertigem postural paroxística benigna (ver *Ouvidos*, neste capítulo).

Convulsões

As convulsões são movimentos musculares súbitos e incoordenados, involuntários e paroxísticos, que ocorrem de maneira generalizada ou apenas em segmentos do corpo. Suas principais causas estão sumarizadas no Quadro 6.46.

As convulsões podem ser parciais (parciais simples e parciais complexas) ou generalizadas.

Há dois tipos fundamentais de convulsões: tônicas e clônicas, além de um tipo que soma as características de ambas – as convulsões tônico-clônicas.

Quadro 6.45

Causas de tontura e vertigem.

Labirintopatias

Vertigem postural paroxística benigna (VPPB)

Doença de Ménière

Hipoglicemia

Intoxicação alcoólica

Hipertensão arterial

Hipotensão arterial

Hiperventilação

Arritmia cardíaca

Tensão nervosa

Quadro 6.46

Causas de convulsões.

Distúrbios de excitabilidade (epilepsia)

Distúrbios metabólicos (hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, fenilcetonúria)

Lesões cerebrais expansivas (neoplasias, hemorragia intracraniana)

Edema cerebral (eclâmpsia, encefalopatia hipertensiva)

Hipoxia cerebral (acidente vascular cerebral, intoxicação por monóxido de carbono, síndrome de Stokes-Adams)

Infecções cerebrais (encefalite, meningite, malária, AIDS, raiva, tétano, neurocisticercose, toxoplasmose)

Intoxicações exógenas (bebidas alcoólicas, cocaína, estricnina, chumbo, anfetaminas)

Febre (convulsões febris de criança)

As convulsões *tônicas* caracterizam-se por serem sustentadas e imobilizarem as articulações.

As convulsões *clônicas* são rítmicas, alternando-se contrações e relaxamentos musculares em ritmo mais ou menos rápido.

As convulsões surgem em muitas condições clínicas, mas todas têm um denominador comum: descargas bioelétricas originadas em alguma área cerebral seguidas de estimulação motora.

O exemplo clássico são as várias formas de epilepsia. Aparecem também no tétano, crises hipoglicêmicas, intoxicações exógenas e por drogas (álcool, estricnina, inseticidas, cocaína), tumores cerebrais, neurocisticercose, meningites, síndrome de Stokes-Adams ou durante episódios febris em crianças.

Boxe

Crises tônico-clônicas generalizadas

O quadro mais típico se constitui de perda abrupta da consciência com queda ao solo, seguindo-se uma fase

de enrijecimento global (fase tônica), seguida por contrações musculares sucessivas, generalizadas e intensas (fase clônica). Ao cabo de 2 a 5 min a crise cessa, entrando o paciente em relaxamento total e sono profundo, do qual dificilmente é despertado. Acorda após algum tempo sem ter noção do que aconteceu, confuso e atordoado. Essa descrição corresponde às crises convulsivas generalizadas do tipo “grande mal”.

Há inúmeras variantes, sendo que uma das mais comuns tem início não abrupto, o que permite ao paciente perceber a instalação da crise, que se constitui de cefaleia, precedida de desconforto retroesternal, dor abdominal, parestesias, desvio forçado da cabeça e olhos para um lado. Outra variação são as crises não completas, nas quais pode faltar uma das fases descritas ou mesmo ficar restrita a um segmento ou a um dos hemisférios. Durante o episódio convulsivo observam-se geralmente cianose, sialorreia, incontinência de esfíncteres, mordedura da língua e ferimentos diversos.

Além das convulsões, o paciente pode apresentar vários outros movimentos involuntários (*tremores, coreia, atetose, hemibalismo, mioclônias, mioquinias, asterixe, tiques, tetania e fasciculações*), estudados no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.

Pseudoconvulsões podem ser manifestações de transtorno de conversão. Nesses casos, os movimentos podem ser um significado simbólico pessoal e, com frequência, não seguem um padrão neuroanatômico definido. O paciente não costuma se ferir.

Ausências

As ausências correspondem a breves períodos de perda da consciência (5 a 30 s) que podem passar despercebidos ao próprio paciente e aos familiares. Ocorrem quase exclusivamente em crianças, sendo descritas como se o paciente estivesse parado como uma estátua. Às vezes, se diz que a criança fica “distraída” ou “encantada”. Durante este curto período, a criança nem chega a cair, apenas interrompe brevemente suas atividades. Pode apresentar um leve tremor de pálpebras. A recuperação da consciência é rápida e a criança prossegue a atividade prévia como se nada houvesse ocorrido. Corresponde ao quadro clínico da epilepsia do tipo “pequeno mal”.

Automatismos

Os automatismos caracterizam-se por fenômenos complexos em que há perda da consciência, durante a qual o paciente executa atos de modo ordenado ou desordenado. No primeiro caso os circunstantes nada percebem de anormal. Estes atos são os mais variados, indo desde pequenos gestos até uma atividade complexa, como dirigir veículos. Tais automatismos representam atividade epiléptica do lobo temporal.

Amnésia

Amnésia significa perda da memória, podendo ser permanente, como nos idosos, mas também transitória, em crises, confundindo-se, às vezes, com alguns tipos de perda da consciência. Bastante típica é a amnésia pós-traumática, quando o paciente permanece por algum tempo sem se lembrar de alguns fatos (amnésia parcial), ou mesmo de toda a sua vida pregressa (amnésia total) após traumatismo cranioencefálico. Ressalte-se que não há perda global das funções cerebrais, mas apenas perda seletiva de uma destas funções – a memória (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

Distúrbios visuais

A redução da acuidade visual denomina-se *ambliopia*, e a perda total da visão, *amaurose*. Ambas podem ser uni ou bilaterais, definitivas ou transitórias, súbitas ou graduais, acompanhadas de dor ou não. Dependem de lesões da retina (oclusão da artéria central, insuficiência carotídea, coriorretinite macular), da papila ou do nervo óptico (papilite, neurite retrobulbar, tumor, hipertensão intracraniana). Podem também ser provocadas por descolamento da retina, hemorragia e glaucoma. Deve ser lembrado que a perda da visão pode estar presente em pacientes com transtorno de conversão.

Hemianopsia corresponde a um defeito campimétrico, no qual o paciente perde a visão da metade do campo visual, podendo ser homônima ou heterônima. Na hemianopsia heterônima existe lesão do quiasma óptico (tumor na região selar, aracnoidite), enquanto na homônima a lesão situa-se na via óptica retroquiasmática (distúrbios vasculares, infecções, tumores, doenças desmielinizantes).

Na *diplopia*, ou visão dupla, a pessoa vê em dobro as imagens, o que leva a fechar um dos olhos na tentativa de corrigir o defeito. Ocorre nos casos de estrabismo convergente e divergente, uni ou bilateral, indicando paresia ou paralisia de um ou mais músculos ligados aos movimentos dos olhos (ver *Olhos*, neste capítulo).

Alterações auditivas

Hipoacusia e *anacusia* expressam a diminuição e a perda total da audição. Podem ser uni ou bilaterais.

Na hipoacusia discreta, o paciente muitas vezes não se dá conta da deficiência; eventualmente, ao telefone, observa dificuldade de audição em um dos ouvidos.

Conforme a sede da lesão, as deficiências auditivas são denominadas de condução, quando localizadas nas partes externa e média do ouvido, e neurosensoriais, quando há comprometimento da cóclea e demais partes do nervo auditivo.

As causas de hipo e/ou anacusia estão relacionadas com as várias partes do aparelho auditivo: cerume, corpo estranho e atresia do ouvido externo; otite, otosclerose e colesteatoma na orelha média; defeitos neurosensoriais (congenitos, presbiacusia, tumor do ângulo pontocerebelar, síndrome de Ménière, traumatismo, labirintite, medicamentos) referentes à orelha interna.

O *zumbido* ou *tinido* (*tinnitus*), uni ou bilateral, constante ou não, deve ser entendido como um processo de estimulação anormal do ramo coclear do VIII nervo craniano, decorrente de múltiplas causas, tais como alteração vascular, infecções, intoxicação alcoólica ou medicamentosa e tumor (ver *Ouvidos*, neste capítulo).

Manifestações digestivas

As *náuseas* ou *enjoo* correspondem a uma sensação de mal-estar, tanto na região epigástrica quanto faríngea. Quando intensas, acompanham-se de palidez cutânea, bradicardia, sudorese, repulsa à ingestão de alimento e quase sempre precedem os vômitos. Ambas as manifestações são frequentes na enxaqueca e podem ser encontradas em doenças do sistema nervoso central, agudas ou crônicas, que aumentam a pressão intracraniana (meningite, neoplasias, hemorragia, traumatismo cranioencefálico). Ressalte-se, contudo, que nas encefalopatias o vômito não é precedido de náuseas. É o chamado vômito central ou cerebral, ou também, impropriamente, “vômito em jato”.

A *disfagia* de causa neurológica aparece nas afecções em que há alterações dos nervos cranianos bulbares, que se acompanham de paralisia da língua (XII) e do palato faríngeo (IX e X). Ao ingerir alimentos líquidos, há tendência de refluxo pelo nariz ou de penetração na árvore traqueobrônquica. A dificuldade se exacerba quando a neuropatia for bilateral (ver *Esôfago*, neste capítulo).

Alterações da sensibilidade

As alterações subjetivas da sensibilidade são representadas pela dor, parestesias e anestésias.

Parestesias são sensações anormais, não dolorosas, descritas pelo paciente como formigamento e dormência.

Ocorrem em várias afecções do sistema nervoso periférico (polineuropatia, tabes) ou central. No acidente vascular cerebral, antes da paralisia, o paciente pode apresentar dormência na área correspondente. Na esclerose múltipla são comuns parestesias migratórias de curta duração.

Anestesia é a abolição da sensibilidade em todos os seus modos. *Hipoanestesia* é a diminuição. *Analgesia* é a perda da sensibilidade dolorosa.

Nem sempre a perda da sensibilidade é completa ou total, abrangendo todos os modos da sensibilidade. Pode ser parcial ou dissociada. Por exemplo, nairingomielia estão abolidas a sensibilidade térmica e a dolorosa, com preservação da sensibilidade tátil e profunda.

Hiperestesia é o exagero da sensibilidade. Estímulos leves provocam sensação dolorosa intensa. A hiperestesia é observada nas neuralgias e nas neuropatias (ver *Sensibilidade* no Capítulo 20, *Exame Neurológico*).

Alterações da motilidade voluntária

Denomina-se *paralisia* a perda da motilidade voluntária por interrupção funcional ou orgânica em qualquer ponto da via motora, desde o córtex cerebral até o músculo.

Quando a motilidade não está completamente abolida, mas apenas diminuída, denomina-se *paresia* ou *paralisia incompleta*.

A paralisia pode limitar-se a um só membro ou a um determinado grupo muscular, constituindo a *monoplegia*. Designa-se, também, a localização em que a motilidade está comprometida: *facial*, *braquial*, *crural* e assim por diante.

Hemiplegia é a paralisia de um lado do corpo, falando-se, então, em hemiplegia direita e hemiplegia esquerda.

Diplegia é a paralisia de partes semelhantes de ambos os lados do corpo.

Paraplegia significa paralisia dos membros inferiores, e *tetraplegia*, dos membros superiores e inferiores.

Quando a *paralisia* se acompanha de hipotonia muscular, denomina-se *paralisia flácida*. Ao contrário, quando há hipertonia trata-se de *paralisia espástica*.

Tendo em consideração a sede da lesão causadora da perda da motilidade, dividem-se as paralisias em *central* e *periférica*.

Boxe

Diagnóstico diferencial

A diferenciação de uma paralisia histérica de uma paralisia orgânica depende de uma avaliação clínica minuciosa, incluindo o exame neurológico completo. Alguns dados, porém, devem ser realçados. De modo geral, a paralisia histérica se instala de repente após grande contrariedade, conflitos emocionais ou outras condições que agredem o mundo afetivo do paciente. Na paralisia histérica não se observa a fixidez das paralisias orgânicas, ou seja, modificam-se em função de fatores circunstanciais representados pelo próprio exame do paciente e pelos acontecimentos ao seu redor. Quando o médico concentra sua atenção sobre ele ou se executam alguns movimentos passivos, a “paralisia” se torna mais nítida. O contrário acontece quando o paciente se distrai.

Na paralisia histérica pode haver relato de episódios semelhantes que desapareceram subitamente, o que não acontece com as paralisias orgânicas que, quando regridem, isto se faz progressivamente.

Ao exame físico não há alterações dos reflexos neurológicos (ver *Motricidade voluntária* no Capítulo 20, *Exame Neurológico*).

Alterações da marcha

As modificações da marcha podem depender de alterações no revestimento cutâneo dos pés (calosidades, queratoses, alterações tróficas), de distúrbios do sistema vascular (a claudicação intermitente traduz isquemia de uma extremidade e a dor se acompanha de claudicação antes de o paciente interromper a marcha), de alterações do aparelho locomotor (aqui incluindo artroses, artrodeses, encurtamento de uma perna), do sistema nervoso periférico (polineuropatia), de alterações medulares e de raízes nervosas (tabes, hérnia de disco) e do sistema nervoso central (ver *Marcha ou equilíbrio dinâmico* no Capítulo 20, *Exame Neurológico*).

Distúrbios esfinterianos

O distúrbio esfinteriano de mais interesse nas doenças do sistema nervoso é o do esfíncter vesical, cuja alteração constitui a *bexiga neurogênica*.

Boxe

Bexiga neurogênica

A micção ocorre quando a parede da víscera se distende e estimula as raízes parassimpáticas aferentes, as quais, por sua vez, acionam o centro reflexógeno S2-S3-S4, que envia impulsos para a contração do detrusor, por meio das fibras eferentes. Trata-se, portanto, de um reflexo automático, de nível medular. Acrescente-se que a pessoa toma conhecimento desses fenômenos fisiológicos em razão das informações que chegam ao córtex por meio das vias sensoriais originadas na bexiga.

As causas mais frequentes de bexiga neurogênica são: após cirurgia que envolve as raízes sensorial e motora, tumor medular, traumatismo raquimedular com lesões do centro sacral, infecções, tumor e angioma, com o comprometimento das vias suprassegmentares (ascendente e descendente), acima do centro reflexógeno, em nível medular.

Transtornos do sono

O sono pode ser definido como um estado complexo caracterizado pela suspensão parcial da percepção dos fatos ambientais e da motricidade voluntária. É um processo cerebral ativo e estado peculiar de consciência, em que há perda da consciência e da sensibilidade, por ser funcional e periódico, isto é, espontaneamente reversível e recorrente.

Ritmo circadiano

Intimamente ligada ao sono está a vigília. A sucessão de ambos constitui o ciclo vigília-sono, que no homem obedece a um padrão de 24 h, conhecido por *ritmo circadiano*. Está fisiologicamente estruturado nos sistemas ativador e sincronizador do tronco encefálico, com a participação de neurotransmissores e moduladores (serotonina, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, peptídios e hormônios).

Por ser uma função orgânica de grande complexidade, podem-se observar profundas variações no ciclo vigília-sono. Em geral, o período de sono dura 6 a 8 h por dia, mas mesmo em indivíduos normais o sono pode ser mais curto (hiperativos, idosos) ou mais prolongado (hipoativos, sedentários, recém-nascidos e crianças de baixa idade).

Entre os transtornos do sono destacam-se a *insônia*, o *ronco*, a *sonolência*, o *sonilóquio*, os *pesadelos*, o *terror noturno*, o *sonambulismo*, o *briquismo*, os *movimentos rítmicos da cabeça* e a *enurese noturna*.

Insônia

A insônia é definida como dificuldade para dormir.

Pode ser inicial, intermediária ou terminal, significando, respectivamente, dificuldade para adormecer, ocorrência de vários despertares e despertar precoce.

As causas mais importantes da insônia são as modificações do ritmo circadiano (trabalho em regime de plantão, longas viagens com fusos horários diferentes, vigília prolongada voluntária), mioclonia noturna (os abalos musculares perturbam o sono), febre (supressão do sono REM), dor (intensificação do sistema ativador), insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica (ativação por anoxia da substância reticular), transtorno de ansiedade e obsessivo, psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia (anormalidades do sistema adrenérgico central regulador do sono), distúrbios respiratórios, síndrome da apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas, dor crônica, medicamentos (anfetamina, alguns neurolépticos, betabloqueadores, fluoxetina, bupropiona, venlafaxina, levotiroxina) e alcoolismo.

Há um tipo de insônia em que não se consegue definir a causa principal. Nesses casos, pode predominar um fator constitucional, ou seja, tendência para dormir menos, mas isto quase sempre estaria associado a transtornos psicológicos.

Ronco

Respiração ruidosa com sons grosseiros ou desagradáveis que ocorre durante o sono. Associação entre ronco e apneia obstrutiva do sono.

Sonolência ou hipersonia

É o sono excessivo ou prolongado, acompanhado de irresistível tendência para dormir.

A sonolência pode ser o resultado de inúmeras condições clínicas, tais como tumor do hipotálamo posterior e/ou do diencéfalo, traumatismo cranioencefálico que comprometa o diencéfalo, mixedema, síndrome de Kleine-Levin (hipersonia periódica e alimentação excessiva), síndrome de Pickwick (hipoxemia e hipercapnia por hipoventilação, em paciente obeso), estados depressivos, uso de sedativos e hipnóticos, ingestão de bebidas alcoólicas, narcolepsia (hipersonia e anormalidades do sono REM, incluindo cataplexia, paralisia do sono e alucinações hipnagógicas).

Sonilóquio

Durante o transcurso do sono a pessoa pode emitir sons ou mesmo formar frases sem sentido.

O sonilóquio corre em qualquer idade ou sexo, sendo mais comum em pré-escolares.

O significado da fala está em relação direta com o estágio do sono: no estágio N-REM, bem mais frequente, o conteúdo relaciona-se com fatos reais, cotidianos, enquanto no estágio REM os fatos estão ligados mais à afetividade. Ressalte-se que, ao acordar, a pessoa desconhece por completo o ocorrido.

Pesadelos

Pesadelos são sonhos aflitivos, acompanhados de ansiedade, grande mal-estar e agitação. Em geral o indivíduo mantém viva a memória do conteúdo do sonho ao acordar, sendo capaz de relatá-lo pormenorizadamente.

Ocorre em qualquer idade, com algum predomínio na primeira década. Mais comum no estágio de sono REM, durante o qual se observa aceleração cardiorrespiratória, logo reversível após terminado o sonho ou poucos minutos depois do despertar.

O pesadelo costuma ser considerado normal, porém é mais frequente em pacientes inseguros, ansiosos, deprimidos ou agressivos e na abstinência abrupta de algumas substâncias (anfetaminas, cocaína, barbitúricos, álcool). Pode ser provocado por alguns medicamentos (p. ex., propranolol).

Terror noturno

É um transtorno que ocorre no terço inicial da noite, em pleno sono tranquilo. O paciente põe-se sentado ou de pé e movimentar-se descontroladamente. Associa-se a grunhidos, choro ou gritos, olhos arregalados como se estivesse em pânico, grande ansiedade, taquicardia, taquipneia e sudorese. Embora aparentemente acordada, a pessoa não reconhece o ambiente nem a presença de outros, responde sem muito nexo e praticamente tudo se apaga da memória após o completo despertar. Cada crise pode durar de 30 s a 20 min e termina abruptamente, voltando o paciente a dormir de forma normal.

Dentre os fatores desencadeantes do *terror noturno* incluem-se o estado de tensão emocional, os estados febris e o uso de alguns medicamentos (betabloqueadores, antidepressivos), mas na maioria das vezes é espontâneo e sem uma causa evidente.

Sonambulismo

É uma condição na qual a pessoa caminha enquanto dorme. Este fenômeno costuma ocorrer, à semelhança do terror noturno, no primeiro terço da noite, quando o paciente, de modo mais ou menos súbito, levanta-se da cama e põe-se a caminhar pela casa, podendo também fazê-lo pela rua. Há verdadeira liberação motora, com movimentos grosseiros e automáticos, podendo acontecer de o indivíduo vestir-se, comer, pentear-se, abrir os cômodos da casa, aproximar-se de janelas ou sacadas, com risco de queda.

Durante a crise de sonambulismo, a pessoa pode emitir sons incompreensíveis, não responde às perguntas ou o faz com dificuldade. Os estímulos para acordá-la podem ser infrutíferos, mas quando despertada, de nada se recorda ou sua memória é fragmentária em relação à crise. O retorno ao sono normal costuma ocorrer antes do despertar completo ou após estado de vigília parcial. É mais comum que a pessoa volte a dormir sem o acordar pleno.

O sonambulismo atinge ambos os sexos, em qualquer idade, predominando na faixa dos 5 aos 10 anos, sendo frequente o registro de casos semelhantes na família.

Ainda não estão bem esclarecidas as causas de sonambulismo. Há vários estudos que mostram que este transtorno pode surgir pela ação isolada ou conjugada de diversos fatores: psicológicos, psicóticos, imaturidade cerebral, ingestão de neurolépticos e hipnóticos. Todavia, há forte tendência em aceitar o sonambulismo como decorrente de uma perturbação do despertar ou do despertar incompleto, tal como acontece com o terror noturno. Estando nos estágios profundos do sono normal, o paciente sofreria rápida mudança do sono para os estágios mais superficiais, ocorrendo, neste momento, o início da crise. Com base nessa teoria, o sonambulismo decorreria de uma perturbação da consciência com destacada liberação motora.

Boxe

Alterações do sono em idosos

As alterações do sono são queixas frequentes dos idosos e não raro são causa de iatrogenia, pois mesmo sem avaliação adequada esses pacientes são tratados com hipnóticos, os quais podem causar desde alterações leves da memória até estados confusionais. Inúmeras pesquisas têm demonstrado que o uso desses medicamentos é um dos principais fatores que contribuem para quedas nesse grupo de pacientes.

A necessidade de sono é variável e, ao contrário do que se pensa, não diminui com a idade. O que acontece é que o padrão do sono torna-se um pouco desorganizado, o período noturno sofre um encurtamento enquanto os períodos de sonolência diurna aumentam.

Ao lado dessas alterações fisiológicas existem problemas sociais e orgânicos levando a maior prevalência de insônia na velhice. A ansiedade e a depressão são causas importantes de insônia. Não se devem esquecer as situações que levam ao despertar noturno, como dispneia, nictúria, dor, hipoglicemia, já que as doenças que causam esses sintomas também são mais frequentes entre os idosos (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Briquismo

Também chamado *bruxismo*, consiste no ato de ranger os dentes, observado tanto em vigília quanto no sono, em pessoas de ambos os sexos, de qualquer idade, com predomínio entre crianças e adolescentes. Apresenta uma incidência familiar significativa.

Não se conhece a causa, mas observa-se a convergência de fatores que participam do seu aparecimento, tais como estado de ansiedade crônico e anormalidades dentárias (má oclusão, próteses imperfeitas).

Movimentos rítmicos da cabeça

Esta condição, classicamente denominada *jactatio capitis nocturnus*, consiste em movimentos rítmicos da cabeça no sentido lateral ou anteroposterior na transição entre sono e vigília. Os movimentos podem ser leves ou acentuados, às vezes violentos. Ocorre em ambos os sexos, preferencialmente a partir dos 7 meses de idade, desaparecendo após a idade de 2 ou 3 anos. Reconhece-se um componente familiar.

Várias causas têm sido propostas para explicar o fenômeno, sendo aceitas as que se baseiam em transtornos da esfera psicológica (tensão emocional, transtorno neurótico e expressão inconsciente de prazer).

Enurese noturna

Corresponde à emissão involuntária de urina durante o sono. Até a idade de 3 anos tal fato não tem importância clínica e é considerado normal. Acima desta idade chama a atenção dos pais e precisa ser investigado.

A enurese pode ser idiopática ou sintomática. Nesta, existem lesões orgânicas (neurológicas, urogenitais ou endócrinas) subjacentes. A forma idiopática se subdivide em primária, na qual não ocorreu ainda o controle vesical, e secundária, quando se perdeu tal controle.

A enurese predomina no sexo masculino e apresenta um componente familiar, embora não geneticamente determinado.

Admite-se atualmente que um mecanismo misto esteja envolvido na gênese do distúrbio: de um lado, fatores individuais fisiológicos e genéticos; de outro, fatores emocionais desencadeando e mantendo a anormalidade.

Alterações das funções cerebrais superiores

Dentre as funções cerebrais superiores impõe-se o conhecimento dos distúrbios da comunicação (linguagem, fala, escrita e leitura), das gnosias, das praxias e dos transtornos psíquicos (transtorno bipolar, depressivo, de ansiedade, depressivo, fóbico, do pânico, conversivos).

Distúrbios da comunicação (linguagem e fala)

Reconhece-se na linguagem um conteúdo simbólico no qual o pensamento encontra-se elaborado. Este conteúdo pode não ser exteriorizado, mas, quando ocorre, ele o faz habitualmente por meio da palavra e/ou da escrita. A linguagem, porém, pode exteriorizar-se por intermédio de sinais ou símbolos: gestos, mímica, olhar, dança, alfabeto dos cegos. A manifestação do conteúdo simbólico vai-se fazendo à medida que o sistema nervoso se modifica no processo natural de amadurecimento. A partir de determinado momento, inicia-se a palavra falada e, mais tarde, a escrita.

Os principais distúrbios de linguagem e fala são apresentados a seguir.

Disfonia. Consiste na alteração do timbre da voz, que se torna rouca ou bitonal. Depende da disfunção das cordas vocais por alterações locais ou lesão do nervo recorrente esquerdo (ver *Laringe*, neste capítulo).

Disartria. Caracteriza-se por alteração da articulação da palavra falada, decorrente de lesões centrais e/ou periféricas. Dentre as primeiras, sobressaem a paralisia pseudobulbar (misto de nasalada e explosiva), o parkinsonismo (arrastada, lenta) e a síndrome cerebelar (escandida, explosiva). A disartria por problemas periféricos decorre de lesão dos nervos cranianos VII, IX, X e XII (voz fanhosa).

Dislalia. É a perturbação da articulação da palavra falada sem que as causas estejam localizadas no sistema nervoso. Existem tipos diversos de dislalia. A fisiológica observa-se na criança até 4 anos de idade e consiste na troca ou supressão de sílabas ou letras (“papato” por sapato, “potão” por portão); a que se acompanha de retardo psicomotor, que se prolonga, em geral, até os 10 anos de idade; a secundária a lesões do palato, língua, dentes, lábios e mandíbula.

Disritmolalia. Consiste na perturbação do ritmo da fala, destacando-se a *taquilalia*, na qual se observa a alteração do ritmo da fala, que se torna imprecisa, e a *gagueira*, em que há perturbação do ritmo da fala. Considera-se gagueira fisiológica ou evolutiva até os 3 anos de idade. A que se prolonga pela idade adulta não é fisiológica.

Dislexia. Condição de natureza genética que consiste na dificuldade de aprender a leitura convencionalmente ensinada. A alteração reflete desorganização temporoespacial e a dificuldade se mostra mais na composição das palavras do que na identificação das letras isoladas. O grau máximo desta condição denomina-se *alexia*.

Disgrafia. Como indica o próprio termo, a escrita torna-se irregular, fragmentada, a ponto, muitas vezes, de ficar ilegível. Existem a disgrafia espacial ou de evolução, na qual não se observam transtornos neurológicos, e a disgrafia secundária a problemas orgânicos, como o parkinsonismo (micrografia) e a afecção cerebelar (macrografia).

Afasia. O termo afasia não corresponde rigorosamente ao que ocorre na linguagem. Melhor seria a denominação *disfasia*, mas a força do uso torna difícil restringir o vocábulo afasia apenas aos casos de perda total da linguagem.

A análise da linguagem deve envolver os transtornos da expressão verbal (fala e/ou escrita), em que se observa desintegração dos mecanismos que propiciam a palavra falada e/ou escrita; da recepção verbal (auditiva e/ou visual), nos quais são evidentes a dificuldade de compreensão das ideias-símbolos; e da atividade gestual, também denominada linguagem corporal, excluindo-se, todavia, os transtornos mentais. As mais importantes formas clínicas de afasia são:

Afasia motora ou verbal: classicamente denominada *afasia de Broca*, é caracterizada por dificuldade para expressar-se pela fala ou pela escrita. Habitualmente associa-se a hemiparesia ou hemiplegia direita, por lesão do opérculo frontal e área motora adjacente do hemisfério esquerdo

Afasia receptiva ou sensorial: denominada *afasia de Wernicke*, na qual o paciente apresenta de leve a extrema dificuldade para a compreensão da fala e da escrita, desacompanhada de outro déficit motor, por comprometimento do giro superior e posterior do lobo temporal esquerdo. Nessa forma clínica, o paciente pode apresentar:

- *Parafasia:* condição em que os vocábulos ou frases são erroneamente colocados
- *Perseveração:* repetição de um mesmo vocábulo
- *Jargonofasia:* fala com sintaxe aparentemente normal, mas o conteúdo não faz sentido (p. ex., o amigo onde passei as férias)

Afasia global: decorrente de lesão das duas regiões anteriormente mencionadas, constitui a forma mais importante de afasia, em virtude de sua gravidade. A compreensão e a expressão da linguagem ficam muito reduzidas. A pessoa apresenta hemiparesia ou hemiplegia à direita

Afasia de condução: constitui-se na repetição de vocábulos (parafasia). Embora consiga ler normalmente, o paciente encontra dificuldade para a escrita. Admite-se que a lesão esteja situada no feixe de fibras que liga os dois centros da linguagem: a sensorial e a motora

Afasia amnésica: admite-se que esta forma decorra de lesão de pequena área na junção dos lobos parietal, temporal e occipital esquerdos. O paciente apresenta incapacidade de reconhecer o significado dos vocábulos e de nomear corretamente objetos, conservando, contudo, o conhecimento de sua finalidade. Assim, o indivíduo sabe para que se presta o pente, por exemplo, mas não consegue lembrar nem falar a palavra pente

Afasia transcortical: trata-se de alteração da linguagem muito semelhante à do tipo motor, em que o paciente apresenta compreensão e repetição razoáveis, dificuldade para a leitura e escrita e leve incapacidade para designar o nome dos objetos. A lesão situa-se no hemisfério dominante próximo ao centro da linguagem de expressão ou área de Broca.

Alterações das gnosias

Gnosia significa reconhecimento, função específica do córtex cerebral. À sua perda dá-se o nome de *agnosia*, cujas formas mais importantes são incapacidade de reconhecimento de sons (agnosia auditiva), da visão de objetos (cegueira cortical ou psíquica), de objetos colocados na mão se os olhos estiverem fechados (estereoagnosia), do próprio corpo em relação ao espaço (somatoagnosia), da fisionomia alheia (prosopoagnosia) ou de sua própria (autoprosopoagnosia).

As lesões causadoras dos transtornos gnósticos localizam-se em áreas diversas, mas predominam no córtex dos lobos parietal, temporal e occipital. Tais lesões costumam ocorrer nos acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranioencefálicos e tumores.

Alterações das praxias

Praxia significa atividade gestual consciente e intencional, e a dificuldade ou incapacidade de coordenar movimentos voluntários denomina-se *apraxia*, subentendida a inexistência de paralisias, ataxias ou hipercinesias.

As formas clínicas mais frequentes são apresentadas a seguir.

Apraxia construtiva. Corresponde à perda dos gestos normalmente organizados, tais como desenhar, modelar ou copiar modelos.

Apraxia ideomotora. Reflete a dificuldade ou a incapacidade para a execução de gestos simples, permanecendo inalteradas a atividade automática e a ideia do ato a ser realizado. Assim, ordenando-se ao paciente que segure a sua orelha ou bata três vezes sobre a mesa, ele, apesar do entendimento, não consegue realizar os atos determinados ou os faz com dificuldade.

Apraxia ideatória. Consiste em que diferentes gestos simples, realizados isoladamente, ao serem reunidos em um ato mais complexo perdem ou reduzem a sua sequência lógica e harmoniosa. Dê ao paciente, por exemplo, um copo emborcado em uma bandeja com uma garrafa d'água. Ele terá dificuldade ou incapacidade para executar de maneira lógica todos os atos, ou seja, virar o copo, despejar a água, levar o copo à boca e beber a água.

Apraxia de vestir. Caracteriza-se pela dificuldade ou incapacidade para executar os atos habituais de despir-se ou vestir-se.

O paciente apresenta dificuldade para abotoar as roupas, vestir a manga da camisa, dar o nó na gravata, ou coloca-a antes da camisa. Nesses casos, as lesões localizam-se na região retrorrolândica direita.

Apraxia da marcha. Causada pela lesão frontal de ambos os hemisférios, que provoca o aparecimento de dificuldade da marcha, em especial o seu início.

Apraxia bucolinguofacial. Consiste na alteração dos gestos da mímica facial, da boca e da língua, permanecendo inalterado o automatismo. Decorre de lesões frontais e do hemisfério esquerdo. O paciente não consegue realizar adequadamente atos simples, como mostrar a língua ou os dentes, colocar a língua em diversas posições, reproduzir a mímica de sorrir, chorar ou beijar.

De modo geral, admite-se que a topografia das lesões nas apraxias situa-se nos lobos frontal e parietal do hemisfério dominante, mas outras regiões, tais como o corpo caloso, lobos temporais do mesmo lado ou do lado não dominante, também podem produzir alguns tipos de apraxia.

Movimentos involuntários

Os movimentos involuntários abrangem:

Coreia: movimentos involuntários rápidos, breves, entrecortados que podem acometer os membros, o tronco e a face

Distonia: contrações musculares mantidas que levam a posturas anormais e movimentos repetitivos, quase sempre acompanhados de dor (Figura 6.44)

Mioclônias: movimentos involuntários breves e rápidos de grupos musculares. Podem ser de origem central, espinal e periférica (ver *Movimentos involuntários* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*)

Tremor: são movimentos ritmados, alternados, entre músculos agonistas e antagonistas

Fasciculações: são movimentos involuntários de feixes de fibras musculares visíveis sob a pele. Só deslocam o segmento correspondente se ocorrem em músculos dos quirodáctilos

Mioquínias: movimentos musculares involuntários, mais lentos, mais grosseiros e mais duradouros que as fasciculações. Provocam ondulações de grupos musculares, visíveis sob a pele

Pseudoatetose: movimentos incoordenados, lentos e de grande amplitude, principalmente nas extremidades (mãos, pés) e face. São semelhantes à atetose. A pseudoatetose é relacionada à lesão do corpo estriado.



Figura 6.44 Distonía.

Avaliação do estado mental

A avaliação das funções psíquicas faz parte do exame neurológico (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

Trata-se aqui de uma adaptação do *Mini Mental State Examination (MMSE)*, universalmente adotado, por ser fácil de se aplicar.

Consiste em fazer uma avaliação superficial da orientação, memória e linguagem. O teste fornece respostas quantitativas, útil para avaliações evolutivas (Quadro 6.47):

Orientação: são feitas perguntas simples, cada uma valendo 1 ponto, sobre o ano, a estação climática, o mês, o dia da semana, para orientação no tempo. Sobre o país, o estado, a cidade, o hospital e o leito, para orientação espacial

Memória: o examinador diz o nome de três objetos e o paciente deve repeti-los. Outra prova é, a partir de 100, diminuir 7 gradativamente ($100 - 7 = 93$; $93 - 7 = 86$; $86 - 7 = 79$ etc.), por cinco vezes. Ao final desta prova, pede-se ao paciente para lembrar-se do nome dos três objetos que gravou

Linguagem: mostram-se ao paciente dois objetos para ele dizer o nome (caneta e relógio, por exemplo). Pede-se para ele repetir uma frase (trezentos e trinta e três – 333 – é a mais usada, porque serve também para se observar a pronúncia). Para a prova dos três comandos, pede-se ao paciente para tomar uma folha de papel, dobrá-la em três e colocá-la em local determinado. Em um papel escrito “feche os olhos”, o paciente tem que ler esta frase sem falar, e depois executar a ordem. A seguir deve escrever uma frase qualquer. Por fim, deve copiar um desenho simples (flor, casa, árvore).

Quadro 6.47

Avaliação do estado mental (*Mini Mental State Examination*).

Funções psíquicas a serem examinadas		Valores máximos	Paciente	Comentários
Orientação	Ano, estação, mês, dia do mês e da	5		

	semana			
	País, estado, cidade, hospital, no do leito	5		
<i>Memória</i>	Repetir nomes de 3 objetos	3		
	Diminuir 7			5
	Repetir os 3 objetos acima	3		
<i>Linguagem</i>	Nomear caneta e relógio	2		
	Repetir um conjunto de palavras (333)	1		
	Prova dos 3 comandos	3		
	Ler e executar “Feche os olhos”	1		
	Escrever uma frase	2		
<i>Função visuoespacial</i>	Copiar um desenho			
Total				(Normal: 27 a 30)

Normalmente qualquer pessoa tem um escore final de 27 a 30 pontos. Abaixo de 23 é considerado anormal. Para os analfabetos devem-se dispensar as provas que exigem saber ler e escrever.

É sempre conveniente, durante o exame neurológico, observar as condições psíquicas do paciente e anotá-las no final do roteiro do exame neurológico (normal, inquieto, apático, deprimido, exaltado, agressivo, instável).

Orientação direita/esquerda e a dominância manual (destro, canhoto, ambidestro) são dados que podem interessar na avaliação neurológica final.

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO

O sistema nervoso periférico (SNP) é constituído por todos os componentes nervosos que se localizam fora do sistema nervoso central e dos nervos cranianos, à exceção do segundo (nervo óptico), incluindo também os componentes simpático e parassimpático do sistema nervoso autónomo (SNA), as raízes nervosas, os nervos espinais, os nervos periféricos mistos, motores e sensoriais e dos fusos musculares, das glândulas e vasos sanguíneos e os receptores de estímulos periféricos, nas porções distais das fibras nervosas sensoriais.

Qualquer doença que comprometa algum componente do sistema nervoso periférico recebe a denominação de neuropatia

periférica.

São inúmeras as causas de neuropatia periférica, incluindo ação de agentes físicos (radiação ionizante, choque elétrico, resfriamento, vibrações), alterações genéticas, doenças infecciosas (herpes, hanseníase, difteria), colagenoses (poliarterite nodosa, artrite reumatoide, lúpus eritematoso disseminado), doenças sistêmicas (diabetes, alcoolismo, amiloidose, porfiria), deficiência nutricional (hipovitaminoses principalmente de vitamina B₁₂), doenças imunológicas (síndrome de Guillain-Barré) e medicamentos (nitrofurantoína, vincristina, isoniazida, hidralazina, dissulfiram, dapsona, amitriptilina); pode estar associada a ingestão de metais pesados (arsênio, chumbo, tálio, mercúrio), neoplasias malignas (síndrome paraneoplásica), e a insuficiência renal.

As manifestações clínicas das neuropatias periféricas são *dor, alterações da sensibilidade, movimentos involuntários e ataxia sensorial*.

Dor

A dor neuropática decorre de lesão do sistema nervoso periférico ou central. A maioria dos pacientes apresenta déficit sensorial clinicamente detectável. A localização da dor tende a sobrepor a área de perda sensorial.

A dor pode adquirir diferentes características semiológicas, incluindo:

Alodinia: sensação dolorosa desencadeada por estímulos táteis (ao toque ou às roupas) ou térmicos (frios ou quentes)

Híperalgesia: sensação dolorosa mais intensa do que a resposta normal a um estímulo doloroso

Causalgia: dor contínua com características de queimadura que piora aos estímulos táteis, mesmo leves. Acompanha-se de distúrbios vasomotores no mesmo território da dor

Cãibras: sensação dolorosa que acompanha contrações musculares involuntárias, circunscrita a um músculo ou grupo muscular sinérgico.

Alterações da sensibilidade

As alterações da sensibilidade compreendem:

Anestesia ou hipoestesia: ausência ou diminuição da sensibilidade dolorosa

Hiperestesia: exagero da sensibilidade

Parestesias: sensação de formigamento, dormência ou picadas sem estímulos desencadeantes

Disestesias: alterações da qualidade da percepção.

Boxe

Ataxia sensorial

Refere-se à incapacidade de coordenar movimentos voluntários e que não está relacionada com deficiência motora. Manifesta-se quando o paciente fica de pé ou se põe a andar. A ataxia sensorial, relacionada com neuropatias periféricas, é dependente da lesão de fibras nervosas grossas que conduzem impulsos das sensibilidades discriminativas (vibratória, cinético-postural e discriminatória entre dois pontos). Diferencia-se da ataxia cerebelar pela nítida acentuação quando o paciente fecha os olhos.

Roteiro pedagógico
para análise do sintoma dor

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:**Características semiológicas da dor**

Localização:

Irradiação:

Qualidade:

Intensidade:

Duração:

Evolução:

Relação com funções orgânicas:

Fatores desencadeantes ou agravantes:

Fatores atenuantes:

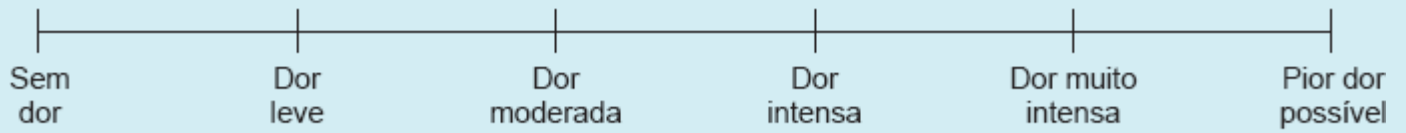
Manifestações concomitantes:

Tipos de dor

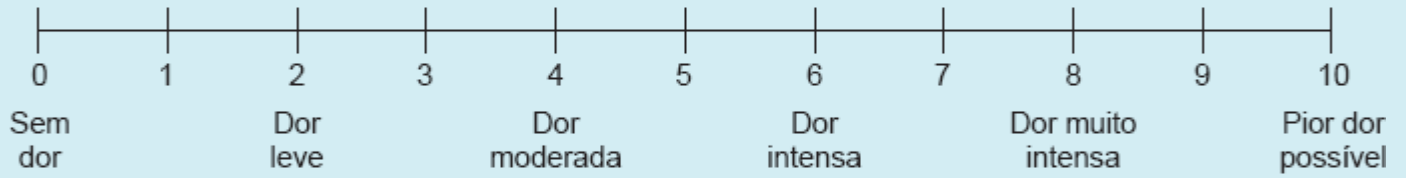
Dor somática superficial () Dor somática profunda () Dor visceral ()

Dor neuropática () Dor psicogênica ()

Escala descritiva simples de intensidade da dor

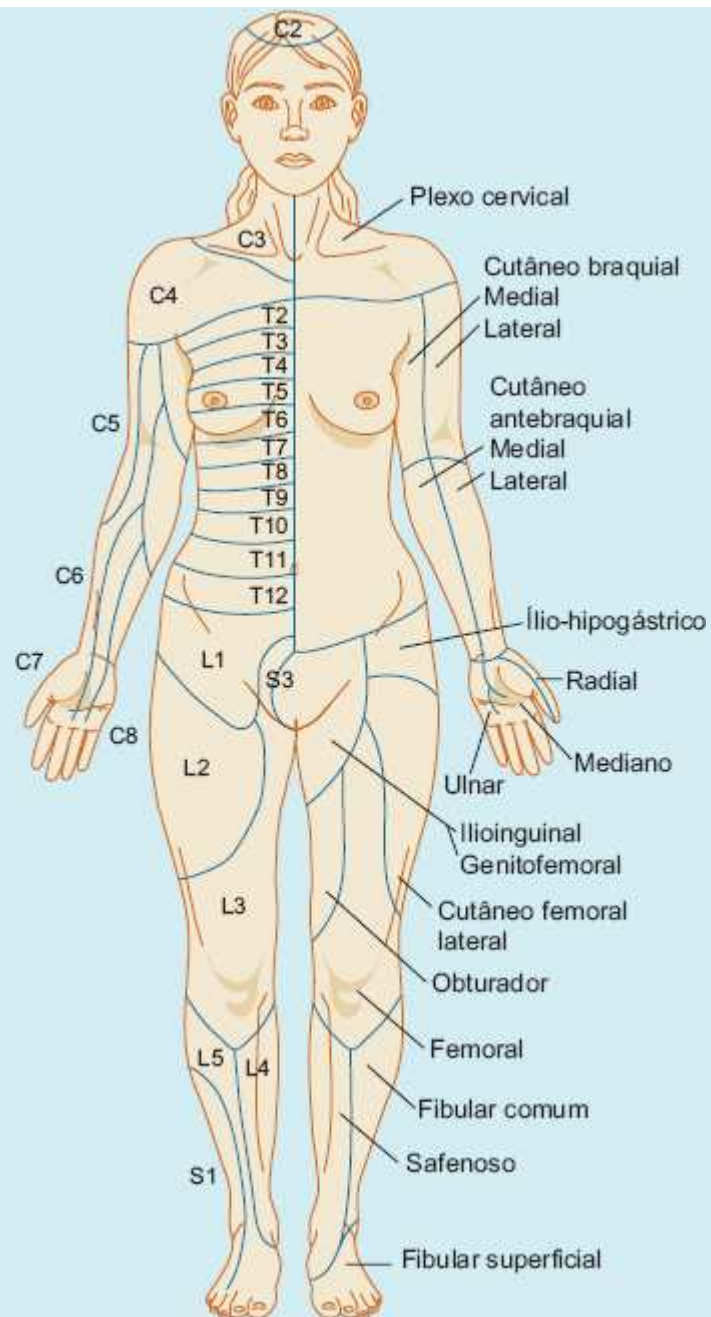


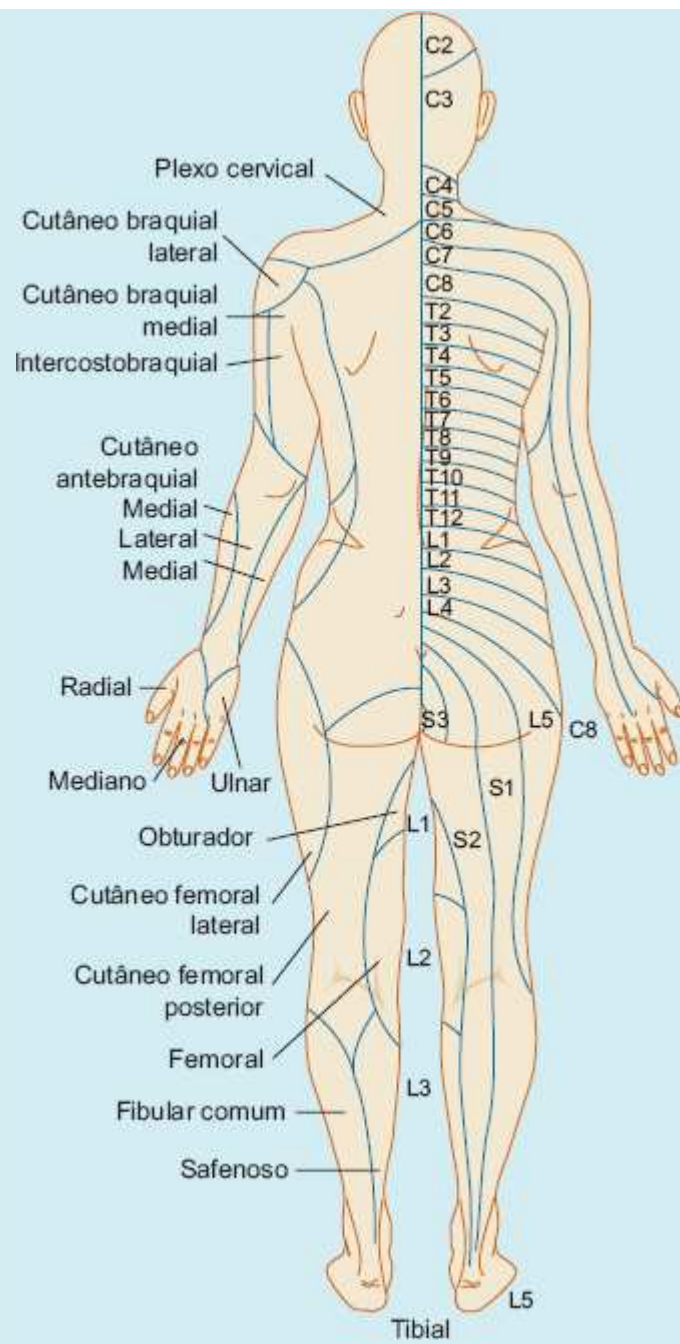
Escala analógica visual de 0 a 10 de intensidade da dor



Escala facial de expressão de intensidade da dor







Capítulo 7



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais

Marco Antonio Alves Brasil

José Reinaldo do Amaral

Celmo Celeno Porto

- Introdução
- Sistematização do exame psíquico
- Roteiro pedagógico para o exame psíquico e avaliação das condições emocionais

INTRODUÇÃO

O exame psíquico e a avaliação das condições emocionais do paciente são etapas fundamentais do exame clínico.

Significativa parcela dos pacientes que procuram atenção médica apresenta tão somente problemas emocionais, muitos deles somatizados nos mais diversos órgãos sob a condição de dor ou outras manifestações clínicas. A incapacidade de fazer uma avaliação clínica adequada quase sempre leva o médico a solicitar diversos exames complementares que se mostram inúteis; além de dispendiosos, alguns apresentam certo risco e, pior ainda, redundam em tratamentos inadequados e até cirurgias malsucedidas.

Boxe

Quando não consegue identificar uma lesão orgânica, cria-se no médico uma frustração, justamente porque ele não está preparado para investigar, compreender e tratar os transtornos psíquicos e emocionais.

É preciso ressaltar, também, que mesmo nos pacientes com lesões orgânicas é comum o aparecimento concomitante de manifestações de fundo psicogênico. O desconhecimento deste lado da medicina é uma das deficiências mais visíveis na formação do médico. Talvez isso aconteça porque, na era das máquinas e dos aparelhos, os médicos almejem ser sempre “objetivos”. O interesse pelos problemas dos pacientes torna-se diretamente proporcional à possibilidade de se “fotografar”, “dosar” ou “radiografar” as *queixas* por eles relatadas. Se isso não for possível, o médico não sabe o que fazer, rotula o paciente de “neurótico” ou diz a ele que “não tem nada” ou que os seus “exames estão normais”; depois disso, dá sua tarefa por terminada. É claro que tal conduta é muito prejudicial ao paciente e uma das causas da perda de prestígio do médico e da medicina.

É preciso ficar claro que o exame psíquico e a avaliação das condições emocionais como aqui propomos não são um *exame psiquiátrico*, da mesma maneira que medir a pressão arterial não é um *exame cardiológico*. Por que será que o médico, ao fazer o exame clínico, sente-se comprometido com a medida da pressão, mas deixa de lado, como se não tivesse importância, o exame psíquico? É apenas um tabu a ser superado? Incorporar o exame psíquico e a avaliação das condições emocionais do paciente ao exame clínico é uma necessidade inadiável.

Não saber se um paciente está deprimido ou vivendo uma tristeza normal, compreensível diante das limitações e dos sofrimentos impostos por uma doença qualquer, pode ser tão grave quanto confundir *angina do peito* com *dispepsia*, por exemplo. Deixa-se de realizar os exames necessários e a terapêutica instituída é inútil e ineficaz, obviamente. Além disso, o paciente passa a correr risco de morte por falha de uma orientação correta; e isso é um erro médico: por negligência, se ele não soube avaliar o psiquismo do paciente, ou por imperícia, se não foi bem manejado terapeuticamente.

Tão logo começa a anamnese, o médico analisa o nível de atenção, a capacidade de dialogar, de recordar fatos, de fazer indagações, o comportamento, como o paciente se deita (se estiver acamado) ou se senta, como se movimenta, os gestos, a maneira de levantar-se, de andar, presta atenção na expressão facial, especialmente o olhar e os traços fisionômicos.

Uma das maneiras de incluir na prática médica o exame psíquico é sistematizando-o de maneira simples e objetiva, como se faz no exame físico geral (ver *Transtornos da consciência e Avaliação do estado mental* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*, e Capítulo 20, *Exame Neurológico*).

SISTEMATIZAÇÃO DO EXAME PSÍQUICO

A avaliação do estado mental e das condições psicológicas deve ser feita pela investigação dos seguintes itens:

- Impressão geral
- Consciência
- Atenção
- Orientação
- Sensopercepção
- Memória
- Inteligência
- Pensamento
- Afetividade, humor e condições emocionais
- Vontade

Impressão geral

Observa-se o paciente desde o primeiro momento, atento para as seguintes questões: Como se apresenta? Faz o contato inicial com desembaraço ou de maneira tímida, amedrontada, desconfiada, relutante, hostil ou arrogante? Mostra-se indiferente ao ambiente? Senta-se espontaneamente ou espera que seja convidado a fazê-lo? Como se senta? Joga-se na cadeira, de maneira confortável, ou senta-se de maneira tensa (na “ponta da cadeira”)? Permanece sentado na mesma posição ou se movimenta constantemente? Com o decorrer da entrevista, sua atitude e postura sofrem modificações? Tranquiliza-se? Permanece inquieto? Como são suas vestes? Encontram-se limpas e em alinhio? Como está seu asseio corporal? Apresenta barba por fazer? Está penteado? Usa maquiagem? Mostra-se silencioso ou falante? Qual o ritmo, a intensidade e o tom de sua voz? Fala espontaneamente ou só responde às perguntas? Como responde? Monossilabicamente, lentamente, de maneira clara, confusa, prolixa? Quais as características de sua expressão fisionômica? Expressa tristeza, alegria, indiferença, medo, ansiedade, desconfiança? Apresenta rigidez facial (“face de cera”)? Toma a iniciativa de cumprimentar o médico ou aguarda que ele o faça? Como é seu aperto de mão (firme, vacilante, oferece as pontas dos dedos)? Apresenta sudorese palmar? Mãos trêmulas? Mãos frias ou quentes? Olha o médico frontalmente ou de soslaio? Adota atitude sedutora, irônica, desrespeitosa, hostil ou cooperativa?

Se o médico estiver atento a todas essas questões, ele será capaz de fazer uma avaliação das condições psíquicas e emocionais, bem como obter uma *impressão geral*, formulando algumas possibilidades básicas.

Uma das possibilidades é que tudo lhe pareça normal, apenas uma ou outra particularidade que pode merecer registro. Outra possibilidade é levantar a suspeita de que algo diferente está se passando com o paciente. Algumas vezes, a alteração psíquica ou emocional fica logo evidente; em outras ocasiões, apenas uma suspeita pode ser levantada a necessitar de mais aprofundamento que o próprio médico pode fazer, apoiando-se em outros parâmetros analisados a seguir.

Consciência

Chama-se *consciência* o conhecimento que temos de nós mesmos e do mundo externo. O ciclo vigília-sono encerra as variações normais, fisiológicas, da consciência. Assim, dentro desse ciclo, temos os diferentes níveis ou graus de consciência. O nível de consciência refere-se ao estado de alerta e de consciência do indivíduo em relação ao meio ambiente. Nos extremos, apresentam-se os estados de: sono profundo, sem sonho e acordado pleno. Como níveis intermediários, apresentam-se: sono com sonho (quando existe contato com o mundo interior) e sonolência do despertar e do adormecer.

Boxe

O significado clínico da palavra inconsciência é a ausência de consciência, o que é diferente do termo inconsciente no sentido freudiano.

Para se fazer a exploração do nível de consciência, recorre-se à observação de determinados aspectos objetivos, mais ou menos evidentes em cada caso, que são os seguintes: expressão fisionômica sonolenta, com tendência a fechar os olhos; desinteresse frente ao mundo externo; dificuldade de manter a atenção; diminuição da capacidade de concentração; desorientação; incoerência das ideias; incapacidade de memorizar (memória de fixação); incapacidade de raciocinar; pensamento lento. A estes dados objetivos somam-se os subjetivos, ou seja, o paciente queixa-se de “cabeça oca”, de estar “tonto” e de ver as coisas de maneira confusa.

Verificar se o paciente está obnubilado ou torporoso. *Obnubilação* corresponde a um estado de apatia, estando o paciente com pensamento lento e obscuro; *torpor* é uma condição em que o paciente apresenta sonolência patológica com prejuízo importante da consciência, mas da qual o paciente pode ser despertado.

Boxe

Estados crepusculares e confusão mental

Estados crepusculares constituem um modo de alteração da consciência na qual a atividade mental permanece enfocada em um objeto ou grupo de objetos, e tudo o mais fica esmaecido e sem relevo. O paciente atua como um autômato, com olhar vago, respondendo de maneira semicoerente e, em geral, com esquecimento quase

total do que realizou nesse período. Pode surgir e desaparecer abruptamente, tendo duração variável (horas ou semanas).

Confusão mental ocorre nos quadros de *delirium*, quando, além da diminuição do nível de consciência, há alucinações e ilusões, provocando um estado parecido com o sonho, em que se misturam percepções reais com ideias fantásticas, podendo ser acompanhada de grande ansiedade, desorientação temporoespacial, agitação psicomotora, com flutuação ao longo do dia, em geral com piora ao anoitecer.

Ver Roteiro pedagógico para avaliação do exame psíquico e avaliação das condições emocionais.

Atenção

É a capacidade de concentrar a atividade psíquica, durante determinado período, em uma tarefa ou atividade.

Costuma-se comparar a consciência à luz que incide sobre um palco. Sua intensidade é o nível de consciência, e a área iluminada, o campo da consciência.

Atenção seria, então, a capacidade de a pessoa dirigir e concentrar o foco de luz sobre um determinado ponto do palco.

O paciente pode estar tão voltado para sua vida interior que atende com dificuldade (ou não atende) aos estímulos exteriores; pode estar desviando sua atenção de um ponto para outro, sem conseguir fixar-se em nenhum; ou pode ainda concentrar-se em determinado ponto, mas por apenas poucos minutos. Em todos esses casos, dizemos que há uma *diminuição da atenção*.

Nos estados maníacos, tudo desperta a atenção do paciente, mas sua capacidade de concentração encontra-se bastante diminuída. No caso do paciente deprimido, ocorre o contrário: apresenta-se distante (os estímulos externos não lhe despertam a atenção), tão voltado que está para suas ideias depressivas.

A avaliação da atenção é feita basicamente pelo comportamento do paciente durante a entrevista, observando se ele consegue concentrar-se nas perguntas que lhe são feitas ou se ele se distrai com facilidade diante dos estímulos ambientais.

O médico pode recorrer a testes simples, como, por exemplo, solicitar ao paciente que diga os meses do ano e os dias da semana em ordem inversa, mas as perguntas habituais da anamnese permitem avaliar o nível de atenção do paciente.

Boxe

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade

Alteração do desenvolvimento caracterizada por um nível de desatenção impróprio para a idade, com ou sem hiperatividade e impulsividade, por um período mínimo de 6 meses. Tem início na infância e a maioria destas crianças apresenta alguns sintomas na vida adulta.

Orientação

É a capacidade de uma pessoa saber quem ela é (orientação autopsíquica) e de localizar-se no tempo e no espaço (orientação temporoespacial).

Na exploração da *orientação*, o comportamento e as informações que o paciente fornece ao longo da entrevista costumam ser suficientes, sem necessidade de um questionamento direto. Havendo dúvidas, solicita-se ao paciente que informe, por exemplo, de onde veio e como chegou ao local do exame. Perguntas diretas, como “O senhor sabe onde está?”, “Que lugar é este aqui?”, “Que dia é hoje?”, devem ser evitadas, podem ser impertinentes ou fornecer uma ideia errônea sobre a orientação do paciente.

Geralmente, a capacidade de *orientação temporal* é a primeira a ser comprometida. No entanto, sua avaliação deve ser feita com cuidado, pois, mesmo em situações normais, pode-se esquecer o dia do mês e da semana em que se encontra, simplesmente por não se estar atento a isso.

Situação semelhante, mas já em nível patológico, ocorre com pacientes geralmente deprimidos, que, por apatia, podem não saber o dia, o mês ou, mesmo, o ano em que estão, ou para onde foram levados.

Quando há *desorientação espacial*, geralmente, além de não saber em que local se encontra, o paciente desconhece por que está ali e, paralelamente à desorientação espacial, pode tomar pessoas desconhecidas por conhecidas, ou, ao contrário, desconhecer familiares e amigos próximos. Às vezes, ele pode perceber sua desorientação e tentar justificá-la (como nos casos iniciais de demência e na síndrome de amnésia alcoólica), mas geralmente suas argumentações são frágeis.

A *orientação psíquica*, em geral, é a última a ser comprometida. O paciente não consegue informar seus dados pessoais, e, nem mesmo, seu nome. Isso pode ocorrer de maneira transitória (traumatismo cranioencefálico, estado crepuscular epiléptico e em quadros funcionais – transtorno de conversão, estados agudos de ansiedade e choques emocionais graves).

Em pacientes esquizofrênicos, pode ocorrer o *fenômeno da dupla orientação*; ao mesmo tempo que o paciente fornece corretamente seus dados de identidade, afirma, por exemplo, que é presidente da República; embora saiba o nome do hospital no qual se encontra e, nele, se oriente sem dificuldades, pode afirmar que aquele lugar não é um hospital, mas sim seu palácio presidencial.

Denomina-se *despersonalização* quando o paciente, ainda que sabendo quem ele é, sente-se estranho, mudado, diferente. Não consegue explicar por que isso está acontecendo. Passa a olhar-se no espelho de modo diferente, tocando no seu rosto, como se estivesse procurando reconhecer sua própria imagem.

Esse estado de estranheza pode ser projetado no mundo externo, constituindo o chamado “sentimento de desrealização”. O paciente vê lugares conhecidos como estranhos. As coisas e as pessoas parecem-lhe mudadas, diferentes. Há a impressão de distanciamento: “Ando pelas ruas e vejo as pessoas distantes, como se eu estivesse vendo um filme ou sonhando.”

O sentimento de estranheza do “eu” pode evoluir para uma completa *perda de identidade*. O paciente já não é mais ele, é outra pessoa. Quando essa perda é parcial, fazendo com que o paciente reconheça como própria apenas parte de sua personalidade, ocorre o fenômeno do *desdobramento da personalidade*. O paciente vivencia, concomitantemente, duas pessoas, duas personalidades, a sua e uma estranha. Fenômeno diverso é a chamada *personalidade alternante*, em que o paciente pode apresentar outra personalidade, durante estados crepusculares epilépticos ou histéricos. Não há aqui superposição de personalidade, mas duas personalidades que se alternam. O desdobramento da personalidade e a personalidade alternante são fenômenos bastante raros.

Perda do sentimento de existência pode ocorrer quando o paciente acha que as partes do seu corpo não existem – “não tenho mais estômago”, “retiraram meu cérebro”, “estou completamente vazio” –, podendo chegar até a um sentimento de inexistência completa – “eu estou morto, o que parece ser o meu corpo é ar”. Esses sintomas ocorrem, particularmente, nos casos graves de psicose esquizofrênica.

Perda do controle da atividade do “eu” e do limite entre o “eu” e o mundo externo é quando o paciente tem a impressão, vivida com angústia, de não controlar as suas funções psíquicas. Isso é expresso de diferentes modos: seus pensamentos, sua fala, seus movimentos são feitos, controlados ou influenciados por pessoas ou aparelhos. Os pacientes acreditam que lhes roubaram o pensamento, introduzindo-lhes ideias que não são suas. Pode haver a impressão de “pensar alto” – tudo o que se pensa é ouvido pelos outros. Isso faz com que um paciente possa ficar calado diante de uma pergunta do examinador, para, logo depois, dizer: “Você já sabe de tudo, por que me pergunta?”

Boxe

As noções de “eu psíquico” e “eu físico” estão indissoluvelmente unidas. Quando há alteração patológica de um deles, o outro é afetado em maior ou menor grau. No entanto, em alguns transtornos o que é primordialmente afetado é o “eu psíquico” (como na maioria dos exemplos até agora citados), enquanto, em outros, é a representação mental do próprio corpo – essa representação é denominada “imagem corporal”.

A imagem corporal pode estar comprometida em várias doenças neurológicas e psiquiátricas. Um paciente pode perceber em seu corpo “partes” que na realidade não existem. É o caso do chamado *membro-fantasma* – pacientes que perderam um membro (ou parte dele) porque foi amputado continuam a “senti-lo”.

As alterações da imagem corporal vão desde sua valorização exageradamente positiva (falsa ideia de beleza, vigor físico) ou negativa (impressão irreal de obesidade, magreza, pênis pequeno), de pacientes neuróticos, até as distorções grosseiras de pacientes psicóticos delirantes.

Algo semelhante é o significado simbólico que nossos órgãos adquirem em nossa mente em função de nossas crenças e características culturais. O significado simbólico do coração, por exemplo, está relacionado com o amor, a paixão, os sentimentos e as emoções. Este é um dado importante para compreendermos a somatização de distúrbios emocionais. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa sofre uma decepção amorosa. Ao lado das manifestações de tristeza ou mesmo de depressão, podem aparecer sintomas de sofrimento do coração simbólico, manifestado como precordialgia e palpitações.

Sensopercepção

É a capacidade de uma pessoa apreender as impressões sensoriais, conferindo-lhes um significado. Essa apreensão depende do

tipo do estímulo, da higidez dos órgãos sensoriais e da integridade do sistema nervoso central, sendo também influenciada por várias funções psíquicas, como a vontade, a afetividade e a inteligência.

Os principais transtornos da *sensopercepção* são as *ilusões* e as *alucinações*.

Ilusões são percepções deformadas. Ocorrem comumente em situações normais (p. ex., uma pessoa, a partir de um som, tem a impressão de ter sido chamada; ou ver, momentaneamente, uma pessoa conhecida na figura de um desconhecido).

Os estados de exaustão podem propiciar ilusões. Situação comum é a ilusão de uma pessoa amedrontada que confunde, principalmente à noite, um tronco de madeira com uma pessoa ou animal. São ilusões sem significado patológico.

Nos estados de tensão emocional podem surgir as chamadas ilusões catatímicas, nas quais o objeto percebido é deformado por influência das emoções. Por exemplo, uma pessoa com medo pode “ver”, na sombra de um galho de árvore sobre a janela, o braço de um ladrão.

As ilusões podem estar aumentadas em frequência e intensidade. No entanto, elas têm pouco valor diagnóstico.

Alucinações são percepções sem objeto, ou seja, ouvir vozes que ninguém em volta está ouvindo, ver objetos ou figuras que não estão presentes, e assim por diante, em relação a todas as funções sensoperceptivas.

Alucinações auditivas podem consistir em ouvir apenas ruídos (alucinações elementares) ou podem ser complexas (ouvir palavras, frases ou diálogos). Geralmente ocorrem em pacientes esquizofrênicos, mas podem também ocorrer nos transtornos bipolares do humor, nas síndromes orgânicas e no transtorno de conversão.

Pacientes podem relatar que estão escutando o seu próprio pensamento (eco do pensamento); vozes que comentam o seu comportamento (p. ex., um paciente, intensamente angustiado, reclama que tem uma voz que diz tudo que ele está fazendo: “Se saio de casa, a voz diz *“saiu de casa”*; se vou ao banheiro, *“entrou no banheiro”*). A alucinação pode acontecer sob a forma de diálogos, com referências ao paciente na terceira pessoa (p. ex., “O que vamos fazer com ele?”). Esses tipos de alucinações estão incluídos nos chamados “sintomas de primeira ordem” no diagnóstico da esquizofrenia.

Alucinações visuais são mais características de transtornos orgânicos, ocorrendo especialmente nos quadros agudos. Elas podem coexistir com alucinações auditivas e ter caráter aterrorizante, como no *delirium tremens* (alcoolismo grave, síndrome de abstinência) e na intoxicação por cocaína. Elas não são específicas da esquizofrenia, podendo ocorrer no luto normal (a visão do parente morto), na psicose depressiva (ver a si próprio dentro de um caixão) e em episódios psicóticos reativos.

As *alucinações hipnagógicas* são experiências visuais que podem ocorrer nas fases de transição entre a vigília e o sono (especialmente na fase do adormecer). Embora possam ocorrer em pessoas normais (enxergar um vulto dentro do quarto), essas experiências, quando repetidas, podem estar ligadas a transtornos do sono.

Outras circunstâncias que podem provocar alucinações visuais incluem a privação sensorial (p. ex., depois de uma operação de catarata ou em pessoas com perda total de visão), o *delirium* e outros distúrbios orgânicos, quadros nos quais o que se encontra são ilusões, ligadas às fantasias do paciente de modo bastante evidente.

Essas alterações visuais devem ser distinguidas de um tipo especial de ilusão em que os objetos podem parecer maiores e mais próximos (macropsia) ou menores e distantes (micropsia), que podem ocorrer no deslocamento da retina, transtornos da acomodação visual, lesões temporais posteriores, auras epiléticas e intoxicações por alucinógenos.

Outro tipo de alucinação visual observado, ainda que raramente, é a chamada *autoscopia* – o paciente visualiza sua própria imagem projetada no espaço. Pode ocorrer no transtorno de conversão, na depressão e na esquizofrenia.

Alucinações olfatórias e *gustativas* podem ocorrer em quadros orgânicos (p. ex., gostos e cheiros estranhos como auras epiléticas) ou como parte de um quadro delirante (p. ex., o paciente percebe gostos e cheiros ruins, denunciadores de que seus inimigos envenenaram os alimentos e a atmosfera).

Alucinações táteis podem ser vividas como insetos que caminham pela pele, sendo características da intoxicação cocaínica, psicose anfetamínica e do *delirium tremens* (alcoolismo).

As alucinações táteis devem ser distinguidas da hiperestesia (extrema sensibilidade tátil) e da hipoestesia (diminuição do tato), que podem ocorrer nas doenças neurológicas e no transtorno de conversão.

Alucinações extracampinas são alucinações em que o paciente “percebe” um objeto fora do seu campo perceptivo (p. ex., um paciente esquizofrênico afirmava que estava vendo a figura do diabo na sala ao lado de onde se encontrava).

Memória

Memória é a capacidade de recordar, ou seja, de reviver estados de consciência anteriores, de reconhecê-los como tais e de localizá-los no tempo e no espaço.

Boxe

A anamnese, como mostra a própria origem da palavra, significa trazer de volta à mente os fatos relacionados

com a doença e com a pessoa doente.

A memória é dividida em: *memória de fixação* – capacidade de registrar e fixar fatos e informações – e *memória de evocação*, que é a capacidade de retornar à consciência o que foi apreendido e conservado. Utiliza-se também a divisão segundo o tempo de duração da lembrança – *memória recente* (para fatos recentes, ocorridos há minutos, dias ou semanas) e *remota* (para fatos ocorridos há meses ou anos).

Os transtornos quantitativos da memória compreendem *hipermnésia* e *amnésia*.

Hipermnésia é o aumento da memória que tem pouco valor semiológico, podendo, eventualmente, ocorrer em estados crepusculares epiléticos, na mania e em outros estados de exaltação emocional (condições que põem em risco a vida da pessoa, como desastres, pós-operatório de grandes cirurgias, doenças súbitas), nos quais geralmente as representações afluem em grandes quantidades, perdendo, no entanto, em clareza e precisão.

Denomina-se *amnésia de fixação* a incapacidade de recordar fatos recentes. O paciente pode esquecer o que fez minutos antes, fazendo com que não saiba onde se encontra, o que acabou de fazer, levando-o a uma desorientação temporoespacial. *Amnésia de evocação* é a incapacidade de recordar fatos vivenciados há meses ou, sobretudo, anos.

Geralmente, a memória para os fatos recentes é comprometida em primeiro lugar, permanecendo preservadas as lembranças mais remotas. Pacientes na fase inicial do processo demencial podem apresentar apenas amnésia de fixação.

A *amnésia lacunar* caracteriza-se pelo esquecimento do ocorrido em determinado período de tempo, com boa capacidade de evocação para os acontecimentos anteriores e posteriores a esse período; pode ser de origem orgânica (traumatismo craneoencefálico) ou psicogênica (transtorno de conversão).

As alterações qualitativas da memória incluem o fenômeno do “já visto”, em que o paciente, diante de um fato novo (cena, filme, música), tem a clara impressão de tê-lo vivido anteriormente, ocorrendo em estados de ansiedade, crises epiléticas, embora possa ocorrer também em situações normais; e a *confabulação*, em que o paciente toma como recordação verdadeira sonhos ou fantasias.

Durante toda a entrevista, o médico deve estar atento à rapidez, precisão e orientação cronológica das informações fornecidas pelo paciente. O retorno a tópicos já tratados anteriormente permite avaliar a memória de fixação (pacientes com amnésia de fixação, sem perceber, repetem o que disseram no início da entrevista).

A todo o momento, o médico depende da memória do paciente, não só para confiar no relato de seus padecimentos, mas também para avaliar sua capacidade de reter as informações que passa para ele com relação a dietas, medicamentos e vários outros aspectos de interesse recíproco. Detectando alterações da memória, o médico se adapta à situação, simplificando suas recomendações, ou escrevendo tudo o que achar que não pode ser esquecido.

Boxe

Memória da pessoa idosa

A diminuição da memória é queixa muito frequente entre as pessoas idosas. Quase sempre atribuída ao processo de envelhecimento. Não há dúvida de que pode ocorrer uma diminuição da memória para fatos recentes, mas nunca de intensidade suficiente para perturbar as atividades do paciente e sua relação com os familiares. Quando isso ocorre, a queixa precisa ser valorizada e bem avaliada. As causas vão desde problemas potencialmente reversíveis, como o hipotireoidismo e deficiência de algumas vitaminas, até doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, que costuma levar o paciente a extrema dependência.

Inteligência

É a capacidade de adaptar o pensamento às necessidades do momento presente ou de adquirir novos conhecimentos. Essa capacidade pressupõe três tipos: *inteligência abstrata* – capacidade de compreender e lidar com ideias abstratas e símbolos; *inteligência mecânica* – capacidade de compreender, inventar e manipular aparelhos; e *inteligência social* – capacidade de atuar adequadamente nas relações humanas e situações sociais.

A inteligência do paciente pode ser avaliada, sumariamente, pela maneira como ele responde às perguntas do médico, por seus conhecimentos gerais, seu vocabulário (número de palavras e de que maneira as emprega), sempre de acordo com sua idade, nível de escolaridade e condições socioculturais.

Observando um déficit intelectual, procuram-se dados, no sentido de esclarecer se tal deficiência sempre existiu (oligofrenia) ou se surgiu na fase adulta (demência). O nível de escolaridade atingida pelo paciente, sua *performance*

profissional e social anteriores ajudam a esclarecer essa questão.

Pensamento

O *pensamento* é um conjunto de funções integrativas capazes de associar conhecimentos novos e antigos, de integrar os estímulos internos e externos, de analisar, abstrair, sintetizar, bem como criar.

No funcionamento do pensamento, outras funções psíquicas estão envolvidas – consciência, orientação, atenção, memória, inteligência e percepção –, e qualquer alteração em uma delas acarreta consequências ao funcionamento global do pensamento.

Os transtornos do pensamento são observados por meio da linguagem, que não é nada mais do que uma expressão simbólica do pensamento destinada à comunicação. Evidentemente, nada têm a ver com alterações do pensamento as perturbações da linguagem resultantes de lesão cerebral (afasias, agraphias, alexias e suas variantes), as dificuldades de articulação da fala (disartrias), as afonias e disfonias, resultantes de problemas da laringe.

O pensamento que predomina em uma pessoa normal é o *pensamento realista*, caracterizado por partir de diretrizes básicas ou tendências determinantes que servem de “guia” para ideias, associadas entre si por vínculos de significado no tempo e no espaço.

Boxe

São inúmeras as alterações do pensamento, a maioria surgindo nos quadros psicóticos. É necessário que todo médico tenha a capacidade de reconhecer tais alterações ao fazer o exame clínico, mas a investigação detalhada desses transtornos só será possível com conhecimentos especializados.

Ao pensamento realista contrapõe-se o *pensamento fantástico*, modo de pensar que não segue a lógica e a realidade, podendo ser comparado à “arte de construir castelos no ar”. O pensamento fantástico encontra-se presente especialmente em crianças e adolescentes, e, durante toda a vida, nos tímidos e inseguros, embora também ocorra, em menor grau, em qualquer pessoa. Quando essa fantasia ocupa grande parte da vida de um indivíduo e o leva a aceitá-la como realidade (como um ator que vive como realidade o seu papel), caracteriza-se um transtorno psicopatológico.

O *pensamento acelerado* ou maníaco é um pensamento com um ritmo muito acelerado, que muda com frequência a diretriz básica, sem aparente motivo para fazê-lo.

O *pensamento inibido* ou *depressivo* apresenta características opostas ao pensamento acelerado, ou seja, alentecimento, falta de material associativo, adesão pertinaz a um mesmo tema ideativo e dificuldade de desviar a atenção para estímulos exteriores. O paciente utiliza poucas palavras e fala geralmente de maneira muito lenta.

A *desagregação do pensamento* consiste na associação de ideias sem vínculos de sentido entre si, o que dá a aparência de um pensamento ilógico ou pouco lógico. Um modo ligeiro de desagregação é o *pensamento paralógico*, em que o paciente diz uma série de frases, aparentemente relacionadas, mas que nada dizem.

O *concretismo reificante* é uma modalidade particular do pensamento em que as expressões abstratas permanecem, mas são utilizadas de maneira concreta. Um paciente esquizofrênico, ao falar da beleza de uma moça, diz: “ela é linda, uma deusa”, vivenciando esta última palavra de maneira concreta, uma real divindade.

Na *interceptação* ou *bloqueio do pensamento*, há uma interrupção súbita do curso do pensamento. Às vezes, o paciente não retorna ao tema anterior, passando a falar de assunto completamente diferente, configurando o sintoma denominado *descarrilamento*.

Ambivalência é a coexistência de dois pensamentos contraditórios e inclusive antagônicos. Além da ambivalência ideativa, há a afetiva e a volitiva (dois sentimentos e dois desejos em um só tempo).

A *perseveração* ou *iteração de ideias* caracteriza-se pela repetição frequente das mesmas ideias ou palavras. Nos estados esquizofrênicos de agitação catatônica, a repetição das mesmas palavras ou frases é incessante.

Pensamentos subtraídos caracterizam-se pela vivência de influência externa sobre o pensamento, como ocorre igualmente em relação aos atos, sentimentos e vontade. Este transtorno de pensamento é considerado altamente sugestivo de esquizofrenia.

Na *sonorização do pensamento*, o paciente relata que todas as suas ideias têm um eco que chega aos demais. Fenômenos afins são a difusão e o roubo do pensamento. O que caracteriza esses transtornos é que a comunicação dos pensamentos próprios, diretamente ou mediante algum artifício, chega ao conhecimento dos demais.

O *pensamento incoerente* não se distingue do pensamento esquizofrênico desagregado. A associação de ideias desprovidas de lógica e sentido é característica de ambos. Quando isso ocorre com a consciência diminuída – torpor (lentidão psíquica, sonolência, falta de capacidade para concentrar-se e orientar-se) – ou confusa – *delirium* (presença de alucinações e ilusões) –,

denomina-se pensamento incoerente, reservando-se o termo desagregação para quando há lucidez de consciência.

O *pensamento prolixo* caracteriza-se unicamente pelo exagero de dados desnecessários e acessórios. Isto se deve à incapacidade de sintetizar, ou seja, de distinguir o essencial do acessório. Esse modo de pensamento é frequente entre os deficientes mentais leves, nos quadros iniciais de demência e na epilepsia.

O *pensamento oligofrênico* caracteriza-se pela pobreza de vocabulário. É estritamente limitado às situações mais imediatas e concretas. As atividades de generalização, abstração, síntese e diferenciação conceitual entre o real e o imaginário, entre causa e efeito, entre as partes, estão realmente ausentes no pensamento oligofrênico.

O *pensamento demencial* decorre da deterioração intelectual. O pensamento é vago e inadequado. Isso se reflete na insuficiente compreensão dos conceitos, juízos e raciocínios que ficaram ou ainda estão preservados. Os pacientes com demência incorrem, frequentemente, em erros grosseiros ao tentar aplicar suas ideias a uma situação ou raciocínio.

Boxe

Ideias delirantes

As *perturbações do conteúdo do pensamento* compreendem as ideias delirantes, sendo de utilidade diagnóstica a separação entre ideias delirantes primárias e ideias delirantes secundárias.

Ideia delirante primária é toda ideia ou juízo patologicamente falso, com as seguintes características: (a) convicção extraordinária, sendo o paciente tomado de uma certeza subjetiva incomparável; (b) impossibilidade de dados da realidade e do raciocínio lógico moverem aquela certeza; (c) impossibilidade do conteúdo.

As ideias delirantes primárias não são passíveis de serem seguidas psicologicamente, do ponto de vista fenomenológico, ou seja, são incompreensíveis. Não são ideias compartilhadas por outras pessoas do mesmo meio cultural, diferenciando-se assim da superstição.

O delírio pode surgir a partir de uma súbita intuição (cognição ou intuição delirante). Por exemplo, um paciente, de súbito, sente-se detentor de poderes especiais e que é Jesus Cristo. É uma convicção irresistível que o domina completamente. Pode aparecer a partir de uma determinada percepção (percepção delirante), que passa a ter um sentido completamente novo. O paciente confere um significado singular, aparentemente absurdo, a uma frase que ouviu, a um movimento de uma pessoa (mímica, gesto, maneira de cumprimentar), a uma notícia de jornal.

O paciente pode construir a partir de um delírio toda uma história ou trama delirante. Diz-se então que o delírio é sistematizado. O paciente passa a fazer interpretações de fatos, comentários, gestos, de acordo com seu delírio – são as interpretações delirantes. Por exemplo, um paciente diz-se vítima de um complô, que uma quadrilha internacional de traficantes de drogas quer exterminá-lo, usando os mais diversos métodos. Quando o médico oferece-lhe um copo d'água, o paciente passa a incluí-lo entre seus perseguidores, achando que ele quer envenená-lo.

Ideia delirante secundária é aquela que tem as características de ideia falsa patológica, irredutível à argumentação lógica, mas é secundária a algum acontecimento da vida do paciente ou a algum outro sintoma. Ao lado do caráter de ser derivada, ela é compreensível psicologicamente. Fala-se que uma ideia ou grupo de ideias é compreensível psicologicamente quando o observador, uma vez diante da história do paciente, “compreende” o que ocorre com ele, suas ideias têm uma lógica ligada a vivências atuais e anteriores e a sua aparente absurdidade deve-se ao fato de partir de premissas falsas, mas que, se fossem corretas, as ideias seriam pertinentes. Por exemplo, um paciente deprimido com ideias de autorreprovação, sentimento de culpa intenso, acredita que poderá ser preso a qualquer momento, pois a polícia está à sua procura, por ter cometido uma irregularidade em uma transação comercial feita há 20 anos. A autorrecreminação por essa irregularidade adquiriu uma dimensão delirante e atual, por meio do medo da perseguição policial.

Fobia

É um medo irracional e persistente, advindo de algum estímulo fóbico específico, com as consequentes manobras para evitá-lo. Medo de baratas, ratos e outros insetos é uma situação bastante comum, sem significado clínico; contudo, quando tais medos impedem um funcionamento social normal passam a constituir uma *fobia*. Um incontável número de objetos e situações podem funcionar como estímulo fóbico – lugares altos, abertos, fechados, elevadores, túneis, trovões, água, sangue, sujeira, cadáver, escuro, doença, medo de ser enterrado vivo, ser envenenado, de animais, principalmente cães.

O paciente fóbico pode ficar imobilizado por seu medo, mas poderá vencê-lo quando acompanhado por uma pessoa confiável (denominado “companheiro fóbico”). As fobias podem estar associadas a ataque de pânico (sensação crescente de medo e perda de autocontrole). Esses ataques são imprevisíveis, podendo ocorrer nos mais variados locais, fazendo com que o paciente tenha medo de sair de casa.

Obsessões e compulsões

Obsessões são pensamentos, sentimentos ou impulsos desagradáveis, irresistíveis, que não podem ser eliminados da consciência por meio da vontade e do raciocínio lógico. O paciente tem consciência de que os pensamentos são seus, embora apareçam contra sua vontade. Geralmente, ele se sente compelido a realizar atos ritualizados ou estereotipados, denominados compulsões, com o objetivo de diminuir o desconforto provocado pelas ideias obsessivas. As compulsões adquirem frequentemente a forma de “dúvida imotivada” sobre algo que pode ser importante, como, por exemplo, se fechou a porta da frente, o gás etc. – após confirmar o fechamento, minutos depois, é tomado da mesma dúvida, obrigando-o a nova confirmação. Isto é feito inúmeras vezes, apesar da indignação e exasperação do paciente.

Afetividade, humor e condições emocionais

O ser humano é uma unidade constituída por dois componentes que se completam – o físico e o psíquico –, e isso não pode ser esquecido durante o exame clínico, ato médico fundamental sobre o qual se apoia tudo o que o médico faz.

O sistema nervoso central tem como função mais nobre a criação dos processos psíquicos, no plano consciente e no inconsciente, além de ser o responsável pela coordenação entre os diversos órgãos do corpo e a integração entre a pessoa e o meio ambiente.

A *afetividade*, um dos processos psíquicos essenciais, abrange o humor ou estado de ânimo, os sentimentos, as emoções e as paixões; constitui, na verdade, a essência da vida humana, pois regula a qualidade e a quantidade de energia psíquica que entra em jogo em qualquer ato que praticamos, com profundos reflexos em todo o organismo.

Dos constituintes da afetividade, os mais elementares são as emoções que se manifestam no comportamento, na postura, na expressão facial e na maneira de falar, ao mesmo tempo que determinam reações neurofisiológicas importantes no nível das glândulas, vísceras e músculos.

Por isso, é indispensável a qualquer médico saber avaliar as condições emocionais do paciente. Às vezes, basta entabular uma conversa amena sobre assuntos triviais para se vencer uma inibição inicial, criando, em seguida, um clima favorável para a entrevista ou os procedimentos diagnósticos; outras vezes, ao constatar transtornos emocionais com repercussão no organismo inteiro, o médico saberá valorizá-los, não só para definir sua maneira de agir, como também para interpretar os dados que encontrar no paciente.

Todos os componentes da esfera afetiva estão sempre presentes em nós e são decisivos na caracterização de nossa personalidade, mas um traço ou outro costuma aparecer como característica predominante; outras vezes, permanece em “estado de latência”, manifestando-se apenas diante de situações ou acontecimentos estressantes, incluindo as doenças de uma maneira geral e alguns procedimentos diagnósticos. Até o exame clínico pode representar um acontecimento relevante que atinge o lado emocional em maior ou menor grau, em função de fatores pessoais ou culturais.

As principais alterações da afetividade são a *ansiedade*, a *depressão*, a *euforia*, a *indiferença*, a *labilidade afetiva*, a *incongruência afetiva* e a *incontinência afetiva*.

As expressões *angústia* e *ansiedade* ora são usadas como sinônimos, ora adquirem significados diversos. *Angústia* é mais referida na linguagem leiga para traduzir uma sensação psíquica desagradável, quase sempre acompanhada de opressão precordial, enquanto o termo *ansiedade* é mais corrente na linguagem científica e inclui um conjunto de manifestações psíquicas e somáticas – uma verdadeira síndrome – com características especiais. A tendência atual, entretanto, é considerá-las como sinônimos, sendo a *angústia* a expressão subjetiva da *ansiedade*.

Admite-se que certa dose de *ansiedade* ou *angústia* – *angústia* existencial, como se costuma dizer – faz parte da natureza humana e seria até indispensável à plenitude existencial. Permanece, no entanto, a dificuldade de se estabelecer a linha divisória entre o normal e o patológico, entre *ansiedade normal* e *ansiedade patológica*.

A *ansiedade* pode ser considerada uma sensação próxima ao medo, mas que se aplica a um perigo vago, não concreto, inespecífico. Em grau moderado, faz parte da vivência normal de todos nós; porém, quando passa a interferir no bem-estar da pessoa, pela sua maior ou menor duração ou intensidade, perturba as funções do organismo, expressando-se por meio de alterações neurovegetativas, como sensação de aperto no peito ou dificuldade respiratória, opressão precordial, palpitações, boca seca, sudorese, mãos frias e sudorentas, podendo, inclusive, adquirir a forma de alguns transtornos, como a *síndrome do pânico*.

A *depressão* constitui o outro transtorno básico da afetividade e caracteriza-se essencialmente por uma tristeza profunda e sem motivo aparente, a qual se acompanha de inibição ou lentidão dos processos psíquicos. As manifestações somáticas da depressão compreendem pobreza de movimentos, mímica apagada, conversa lenta e, às vezes, sussurrada. Podem ocorrer, também, inapetência, obstipação intestinal, despertar precoce, astenia, palidez da face e respiração lenta.

Pode-se caracterizar o transtorno depressivo como a *doença das perdas* (perda da alegria, perda do interesse, perda do sono, perda do apetite, perda da atenção, perda até da vontade de viver), não necessitando que estejam todas juntas ao mesmo tempo.

Denomina-se *humor ou estado de ânimo* a tonalidade afetiva básica, ou seja, o estado afetivo predominante. Considera-se humor normal o observado em pessoas que não exibem variações afetivas persistentes e polarizadas. Nos estados patológicos, o humor pode estar alterado em duas direções opostas – em um polo estão a tristeza, a ansiedade, o tédio e a inibição; no outro, a alegria, o entusiasmo e a exaltação.

Em condições normais, ficamos entre os dois polos, dependendo dos acontecimentos de nossa vida, mas os estados patológicos precisam ser reconhecidos pelo médico durante o exame clínico, o que é de indiscutível importância na prática médica.

Na exaltação do humor – *euforia* –, o paciente encontra-se excessivamente alegre, otimista, com profunda sensação de bem-estar, mas esta alegria é imotivada e sem razão. Paradoxalmente, este estado pode ser acompanhado de episódios de irritabilidade, chegando, em seus paroxismos, a momentos de fúria. Ocorre tipicamente na fase maníaca do transtorno bipolar do humor, mas pode ocorrer em outros transtornos mentais (demência, reações medicamentosas, uso de drogas psicoativas). Um tipo especial de euforia é o denominado *moria*, em que o paciente apresenta uma expressão de alegria estúpida, ri por motivos pueris, absurdos. Tal alteração costuma indicar lesões do lobo frontal.

Humor depressivo caracteriza-se por tristeza, desânimo e pessimismo, enquanto no humor ansioso o paciente é tomado por um temor – “sem saber a quê” –, que o leva a um estado de tensão.

Indiferença ou ausência de resposta afetiva ocorre em pacientes deprimidos, que podem chegar ao completo desinteresse pelo mundo externo – tudo lhes é indiferente, nada os mobiliza emocionalmente.

Situações diversas, mas que também podem levar à indiferença afetiva, ocorrem na demência e em casos graves de esquizofrenia, em que há um esvaziamento afetivo progressivo, levando inclusive à perda das ligações afetivas mais sólidas. A indiferença afetiva pode aparecer no transtorno de conversão, sendo denominada, pelos franceses, com certa dose de ironia, como “*la belle indifférence*”. O paciente mostra-se indiferente, por exemplo, diante da paralisia de suas pernas.

Labilidade emocional significa rápidas mudanças de um estado afetivo para outro. Ocorre no transtorno de conversão, nos estados mistos dos transtornos bipolares do humor (em que o paciente alterna gargalhadas com choro) e nas doenças agudas, nas quais o humor pode mudar da ansiedade para o terror ou pânico. A labilidade afetiva ou instabilidade emocional é comum em pacientes que sofreram uma doença que pôs em risco a vida (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, traumatismo cranioencefálico). Pode aparecer, também, em pessoas idosas sem motivo aparente.

Incongruência afetiva ocorre quando há uma resposta emocional inadequada a um relato ou situação (o paciente ri enquanto relata a cena trágica de um desastre). Pode levantar a suspeita de esquizofrenia. Deve ser diferenciada do chamado “riso nervoso”, que pode ocorrer em pessoas sem comprometimento psicológico em situações de grande tensão emocional.

Incontinência afetiva apresenta-se quando o paciente ri ou chora por longos períodos, sem controle, diante de um pequeno, ou nenhum, estímulo. Sugere lesões orgânicas, como a demência “multi-infarto”, decorrente de repetidos episódios isquêmicos, ou esclerose múltipla.

A procura de uma sintonização efetiva por parte do médico é fundamental à compreensão do estado do paciente. Considera-se incompreendido ou até hostilizado se for perguntado como se sente, quando ele sabe que sua fisionomia já o demonstra. Sendo assim, o médico deve mostrar que já percebeu o distúrbio sobre o qual deseja obter informação. Por exemplo: “Há quanto tempo sente-se triste?”, “Por que está triste (ou irritado, alegre, preocupado, desconfiado)?”, “A que atribui a sua tristeza (ou irritação, entusiasmo)?” Os termos “depressão” e “ansiedade” devem ser evitados. Se o paciente os utiliza, deve-se procurar saber o que ele está querendo dizer (já que pode empregá-los com significados diversos).

Vontade

Vontade é a disposição que uma pessoa tem para a ação, a partir de uma escolha ou decisão sua.

O paciente deprimido relata, comumente, uma *perda da vontade*. Nada lhe interessa; sente-se, às vezes, incapaz de realizar as mais simples tarefas (tomar banho, trocar de roupa). Por mais que seja estimulado, permanece sem disposição para qualquer ação. Em pacientes esquizofrênicos, a vontade pode estar comprometida em nível da iniciativa (pragmatismo). Embora possam realizar tarefas, quando ordenadas e supervisionadas, não conseguem por iniciativa própria começá-las ou sustentá-las por muito tempo.

Negativismo é um termo que denomina as situações em que o paciente não atende ao que lhe é pedido. Esta oposição pode

ser de maneira ativa, quando tende a fazer o contrário daquilo que lhe é pedido – por exemplo, solicitado a abrir a boca, cerra os lábios – ou de forma passiva, quando simplesmente abstém-se de colaborar. Pode ocorrer em diversos transtornos, como esquizofrenia, depressão, mania, síndromes cerebrais orgânicas, neurose e simulação.

Pacientes esquizofrênicos podem ainda apresentar outros transtornos da vontade, bastante sugestivos da doença, que são: *automatismo ao comando* – o paciente obedece instantaneamente ao que lhe é ordenado, como um autômato, sem o controle de sua vontade; *ecolalia* – repete por imitação todas as palavras que lhe são dirigidas (p. ex., às perguntas “você está melhor?”, “já almoçou?”, responde “você está melhor?”, “já almoçou?”). Esta imitação pode também ocorrer em relação a gestos – *ecopraxia*.

Aumento da vontade ocorre, sobretudo, na fase maníaca do transtorno bipolar do humor, quando o paciente experimenta uma grande disposição para realização de tarefas, mas as concretiza de maneira desordenada e sem persistência.

Atos impulsivos são aqueles que não passam pela vontade do paciente ou, em que pese a sua intervenção, não consegue controlá-los. Podem ser impulsos aparentemente imotivados, súbitos, como os impulsos auto e heteroagressivos de pacientes esquizofrênicos ou em estado confusional, ou podem ser impulsos sistematizados, como os atos compulsivos do transtorno obsessivo-compulsivo. O paciente sente-se pressionado pelas suas ideias obsessivas a realizar inúmeras vezes um mesmo ato, de modo estereotipado; por exemplo, lavar as mãos, confirmar se as luzes estão apagadas e o gás desligado. Outros atos impulsivos sistematizados são a necessidade incontrolável de realizar pequenos furtos (cleptomania), participar de jogos de azar ou usar bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas.

Psicomotricidade

A vida psíquica do paciente tem a expressão objetiva no conjunto de seus gestos e movimentos, a que se denomina *psicomotricidade*.

O aumento da psicomotricidade pode ocorrer em situações normais, como a atividade frenética de uma pessoa dinâmica, passando pela inquietação do ansioso, até as graves situações dos pacientes psicóticos.

A diminuição da psicomotricidade oferece, por sua vez, um quadro exatamente oposto – ao contrário de uma mímica rica, alternante, há uma expressão pobre, parada. A imobilidade contrasta com a mudança constante de posições do paciente inquieto ou com a tempestade de movimentos do agitado. Um grau extremo de diminuição da psicomotricidade é o *estupor*, em que, além de inibição completa da psicomotricidade, há uma diminuição da resposta aos estímulos dolorosos. Nesses casos a expressão facial tem grande valor semiológico: sonolência e torpor no paciente orgânico, tristeza no paciente deprimido e alheamento no esquizofrênico.

O examinador pode notar em algumas situações que os gestos do paciente “não lhe dizem nada”, ou seja, carecem de conteúdo afetivo, que não têm as características de uma expressão normal, tendo um caráter afetado e antinatural. Pode ocorrer na esquizofrenia, no transtorno de conversão e nos transtornos de personalidade. Quando a essa afetação de gestos e posturas somam-se movimentos absurdos e reiterados, falamos de *estereotipias*. Se a repetição é de uma expressão facial (fechar os olhos, torcer a boca para um lado), denomina-se mímica estereotipada. Na ausência de causa neurológica (tiques faciais), estereotipias podem sugerir esquizofrenia.

Boxe

Exame psíquico do paciente idoso

O processo de envelhecimento influi na função mental dos idosos, em função da diminuição do número de células do córtex cerebral e de alterações histológicas e bioquímicas dos neurônios, de comprometimento da visão e de outros fatores, tais como morte de entes queridos, aposentadoria, perda de renda e diminuição da capacidade física.

Muitos idosos reclamam de perda da memória, com dificuldade para recordar nome de pessoas ou objetos, e manifestam receio de estar sofrendo da doença de Alzheimer, que apresenta essa alteração entre seus principais sintomas.

Para se interpretarem os dados do exame psíquico de um idoso, é necessário fazer a diferenciação entre as mudanças relacionadas com a idade e as manifestações de distúrbios mentais específicos, principalmente demência.

As pessoas idosas podem apresentar confusão mental como parte do quadro clínico de diferentes enfermidades, tais como infecções (pneumonia, infecção urinária), infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Roteiro pedagógico

para o exame psíquico e avaliação das condições emocionais

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Impressão geral. Aspecto geral, fâcies, expressão fisionômica, apresentação, cuidados pessoais (roupas, adornos), porte, colaboração, desconfiança, hostilidade, dificuldade de contato

Consciência. Alerta, atento, lúcido, obnubilado, torpor, confusão mental, estado crepuscular, dissociação, transe, estado hipnótico, estado comatoso (ver no *Roteiro pedagógico para exame neurológico – Miniexame do estado mental* – no Capítulo 20, Exame Neurológico.)

Atenção. Atento, capacidade de concentração, desatento, indiferente

Orientação. Orientado (nome, idade, sexo, profissão, estado civil), tempo e espaço, despersonalização, perda de identidade, desdobramento da personalidade, imagem corporal

Sensopercepção. Estabilidade, ilusões, manias, alucinações (auditivas, visuais, olfatórias, gustativas, táteis, hipnagógicas), pseudoalucinações, autoscopia, *delirium*

Memória. Fatos recentes e antigos, amnésia (de fixação, de evocação), episódica, operacional, fenômeno do “já visto”, confabulação, rememorações delirantes, hipermnésia

Psicomotricidade. Gesticulação, mímica, hiperatividade, agitação, inquietude, discinesias, estereotípias, maneirismos, movimentos repetitivos, tiques, estupor

Vontade. Perda da vontade (hipo e abulia), negativismo, atos impulsivos, atos compulsivos, pragmatismo, ecolalia, ecopraxia, automatismo ao comando

Linguagem. Afasia, mutismo, gaguejante, solilóquios, ecolalia, coprolalia

Pensamento. Alentecimento, aceleração, desagregação, desorganização, ambivalência, roubo de pensamento, descarrilhamento, perseveração, logorreia, ideias delirantes, fobias, obsessões, lacônico, persecutório, depreciativo

Inteligência. Nível de compreensão, capacidade de abstração, desconexão do pensamento

Afetividade e humor. Irritável, triste, depressão, euforia, disforia, ansiedade, labilidade afetiva, dissociação afetiva, indiferença, labilidade emocional, incongruência afetiva, incontinência afetiva, ambivalência (amor/ódio)

Capítulo 8



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Médicos, Pacientes e Famílias

Celmo Celeno Porto

Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira

- Introdução
- Médicos
- Pacientes
- Famílias

INTRODUÇÃO

Os componentes essenciais do encontro clínico são o médico e o paciente, mas não se pode desconhecer que algum membro da família sempre está presente, introduzindo nesta relação dual novos e importantes elementos (Ver Capítulo 1, *Iniciação ao Exame Clínico*).

MÉDICOS

A dinâmica do encontro clínico depende do padrão de comportamento dos que dele participam. O médico se coloca nesta relação de acordo com sua disponibilidade interna, fruto de questões conscientes e inconscientes, mecanismos de defesa e, mais do que tudo isso, dos traços dominantes de sua personalidade.

Os padrões de comportamento mais comuns são: paternalista, autoritário, agressivo, inseguro, “frustrado”, tecnicista, otimista, pessimista, rotulador, além de outro que pode ser denominado “sem vocação”.

Padrão paternalista. O médico assume a posição de pai, adota atitudes protetoras, trata o paciente como criança, como se não tivesse condições de participar das decisões relacionadas com o tratamento, é receptivo ao relato de acontecimentos da vida pessoal do paciente, mas dá “conselhos” ou ordens como se somente ele soubesse o que é o certo e o errado.

Este tipo de comportamento, ainda que justificável em várias situações, principalmente quando o paciente se mostra muito inseguro, pode conflitar com o princípio da autonomia. É necessário saber identificar os momentos em que possa ser benéfico.

Padrão autoritário. O médico sempre procura impor suas decisões, não aceita nem analisar com o paciente as prescrições que faz para ele. Sente-se ofendido por qualquer tipo de questionamento feito pelo paciente ou seus familiares. Acredita ser o “dono da verdade”! Considera que o paciente deve ser submisso, obediente e humilde. O autoritarismo cria relações frágeis e pouco duráveis, principalmente nas doenças de longa duração que exigem uma permanente troca de opiniões entre médico e paciente. O comportamento autoritário frequentemente se associa ao paternalista.

Padrão agressivo. Por temperamento ou como consequência de condições profissionais inadequadas – excesso de trabalho, baixa remuneração, por exemplo –, o médico transforma o paciente em “bode expiatório”. A agressividade pode ser aberta, por meio de palavras ou atitudes ofensivas, ou disfarçada, por meio de mau atendimento, frieza no relacionamento, atos como não olhar no rosto do paciente, tom de voz grosseiro. Algumas maneiras simbólicas de agressividade incluem a prescrição de medicamentos injetáveis no lugar dos medicamentos por via oral, quando não há uma razão científica para isso, prescrições de regimes alimentares desnecessários ou até proibições de atividades sexuais, sem que haja nenhuma justificativa para isso. Este padrão de comportamento jamais se justifica.

Padrão inseguro. A insegurança, tal como a agressividade, pode ser um traço da personalidade ou ter origem em uma formação profissional deficiente. Conhecimentos insuficientes, incapacidade de fazer um exame clínico adequado, dúvidas na interpretação de exames complementares e na prescrição terapêutica, desenvolvem no médico mecanismos de defesa para disfarçar sua insegurança. O paciente acaba percebendo isso e perde a confiança no profissional, que pode tornar-se hostil, criando péssimas condições para o relacionamento entre ambos.

Padrão tecnicista. Em geral, o médico tecnicista apenas se interessa pela doença, deixando a condição humana do paciente em segundo plano ou até descartando-a.

Dá excessivo valor às “máquinas” de fazer diagnósticos ou tratamentos. Adota o mesmo comportamento de um mecânico que conserta ou troca peças de uma máquina e não tem o mínimo interesse pelo seu dono. Não dá valor à relação médico-paciente por não conseguir ver o doente como pessoa. Costuma ser um médico sem vocação para a profissão ou frustrado por não estar fazendo o que desejava em sua vida.

Para se sentir realizado na profissão é mais conveniente atuar em uma área da medicina em que não precise ter relação direta com pacientes.

Padrão otimista. Não vê dificuldade em nada, tudo lhe parece simples e sem gravidade, não sabe – ou não consegue – reconhecer os casos de prognóstico ruim. Falta-lhe precaução, não tem noção do imprevisto, antevê sempre sucesso em suas ações e costuma fazer promessas vãs em situações de dificuldades.

Sente-se como herói e, quando algo não dá certo, procura transferir para outros ou para fatores imponderáveis a culpa pela não concretização de suas expectativas.

Padrão pessimista. Tende a ver maior gravidade nas doenças do que a real, expressa desânimo e desesperança mesmo antes de conhecer o diagnóstico e deixa de tomar decisões diagnósticas ou terapêuticas porque, de antemão, em seu íntimo, não

acredita na possibilidade de bons resultados.

O pessimista agrava a angústia do paciente e pode levá-lo ao pânico. Tranquilizar e alimentar a esperança do paciente não significa que se deve falsear a verdade e esconder a realidade; entre o otimismo inconsequente e o pessimismo descabido é que deve se enquadrar o comportamento do médico.

Os pacientes com doenças de prognóstico reservado sofrem muito com o médico pessimista.

Padrão rotulador. O médico com este padrão de comportamento tem sempre pronto um “rótulo diagnóstico” que agrada o paciente. Dá impressão de competência e segurança, mas, na verdade, o que o “rotulador” procura é recobrir suas deficiências e limitações. O “rótulo” quase sempre é um engodo, uma tapeação, uma maneira de enganar os pacientes mais crédulos.

Padrão “frustrado”. A frustração pode começar durante o curso de medicina, quando o estudante percebe que há uma enorme distância entre as fantasias juvenis que podem ter influenciado a escolha da carreira e a realidade. Começa a reconhecer as limitações da medicina e verifica que suas possibilidades são menores que as sonhadas por ele. Outra fonte mais séria de frustração é a má qualidade do curso.

Perder um ente querido por limitações da medicina ou, pior ainda, por mau atendimento pode se transformar em profunda decepção cuja repercussão no mundo emocional do estudante ou do médico pode ser significativa.

A impossibilidade de atingir um ideal, longamente acalentado, é outra causa de frustração e até de revolta, quando um médico não consegue um trabalho digno ou recebe baixos salários para exercer tarefas exaustivas, como, por exemplo, dar inúmeros plantões para sobreviver.

Um estudante de medicina ou um médico frustrado quase sempre vai ficando cada vez mais pessimista e chega a tornar-se agressivo com os pacientes. No entanto, sua principal característica é a frieza na relação com o paciente. Mostra-se indiferente ao relato de sintomas que trazem profundo sofrimento para o paciente. Dissocia totalmente seu “eu pessoal” do “eu profissional”. Examina mal os pacientes, passa a trabalhar com má vontade e pressa, não tem interesse pelos resultados do tratamento que institui, perde o entusiasmo pelo estudo, não se importa de ficar desatualizado, distanciando-se cada vez mais dos progressos científicos.

Padrão “sem vocação”. A falta de vocação gera graves consequências principalmente quando o médico se dedica a atividades clínicas que exigem disposição espiritual e emocional para uma boa relação com os pacientes.

O médico sem vocação – aliás, isso já é perceptível desde o curso de medicina – desenvolve mecanismos para se distanciar do paciente. Algumas vezes, esses mecanismos ficam camuflados sob atitudes racionalizadas que podem ser enganadoras; outras vezes, o médico hostiliza aberta ou veladamente os pacientes.

Permanecer no curso ou no exercício da profissão médica é profundamente nocivo para o estudante ou para o médico e para os pacientes. A atitude mais sensata para aqueles que não têm vocação para a medicina é dedicar-se a outra profissão.

PACIENTES

Ao adoecer, o indivíduo quase sempre enfrenta novas situações, acentuando alguns traços de sua personalidade: os pessimistas passam a ver os fatos sempre pelo lado pior; os inseguros tornam-se completamente dependentes e ficam sem iniciativa; os agressivos perdem o controle de seus impulsos reprimidos.

A gama de comportamentos é extremamente vasta, e somente as vivências conferem ao médico a capacidade de reconhecer cada um deles.

Resumiremos, a seguir, os “tipos de paciente” que até certo ponto correspondem a padrões de comportamento mais comuns e algumas orientações que podem ser úteis para se relacionar com cada um deles.

Os dados obtidos no exame psíquico, analisado no Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*, são fundamentais para reconhecê-los.

Paciente ansioso. Os transtornos da ansiedade apresentam vários modos de manifestação clínica, incluindo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, agorafobia, transtorno do estresse agudo, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do estresse pós-traumático.

Quase toda enfermidade ou o medo de estar doente provoca certo grau de ansiedade, e, em muitas ocasiões, é a própria ansiedade que leva o indivíduo ao médico.

A ansiedade é “contagiosa” e envolvente, passando facilmente para os familiares, provocando, por meio de um mecanismo de círculo vicioso, maior ansiedade no paciente.

O reconhecimento da ansiedade se faz pelas manifestações psíquicas e somáticas que a acompanham: inquietude, voz embargada, mãos frias e sudorentas, taquicardia e boca seca. Alguns pacientes esfregam as mãos sem interrupção, enquanto outros as apresentam trêmulas. Bocejos repetidos ou fumar um cigarro atrás do outro também indicam o desejo inconsciente de o paciente reforçar suas defesas psicológicas.

Reconhecida a ansiedade, o estudante deve preparar-se psicologicamente para enfrentar a situação. Em primeiro lugar, há que demonstrar segurança e tranquilidade, conduzindo a entrevista sem precipitar a indagação dos fatos que possam intensificar ainda mais a ansiedade do paciente.

É preferível gastar alguns minutos conversando sobre fatos aparentemente desprovidos de valor, de modo a dar tempo para certo relaxamento da tensão.

Em contrapartida, não são corretas nem surtem efeito as tentativas de “acalmar” o paciente, exortando-o a ficar tranquilo e dizendo, de antemão, quando ainda não há uma decisão diagnóstica, que ele não tem nada ou que sua doença não é grave.

O estudante deve estar prevenido de que a própria ansiedade poderá ser responsável por todas as queixas relatadas pelo paciente. Essa condição, designada *transtorno de ansiedade*, é muito comum na prática médica.

Outras vezes, as manifestações ansiosas se expressam em algum órgão e, aí, então, passam a predominar os sintomas relativos a ele (p. ex., palpitações, dispneia suspirosa e precordialgia podem caracterizar a somatização do transtorno de ansiedade ou depressivo no coração).

Mesmo que a ansiedade seja o único ou o principal problema, sempre será necessário reconhecê-la, porquanto o comportamento do médico é muito influenciado por esta situação.

Boxe

Reconhecendo a ansiedade (Bird)

“Certa vez, tive ocasião de estar junto ao leito de uma paciente que estava sendo preparada para uma operação muito arriscada. Os médicos que a rodeavam foram amáveis, gentis e sinceros, procurando tranquilizá-la; afirmavam que nada sentiria e que despertaria, completamente bem, em sua cama. Percebi que ela estava tão ansiosa que não podia ouvir e entender absolutamente nada do que lhe estava sendo explicado com todo interesse por aqueles médicos, os quais também notaram sua ansiedade, o que os levou a lhe reassegurarem que nada havia a temer. Neste momento, entrou o cirurgião, um homem atarefado e um tanto seco. Pensei: ‘Oh! Deus, que acontecerá agora?’. Contudo, o médico ignorou todos nós e foi direto à paciente. Apresentou-se, apertou-lhe a mão e disse: ‘Você parece estar terrivelmente assustada.’ A mulher prorrompeu em lágrimas e se agarrou a ele, que a enlaçou em um afetuoso abraço. Por alguns instantes, esteve parado ali em completo silêncio, mas a eloquência do silêncio nunca foi mais claramente tão evidenciada. Havia dito mais do que era necessário dizer e depois de um minuto retirou-se, sorrindo e dizendo-lhe que a veria na manhã seguinte para operá-la. Então, e somente então, pôde a paciente relaxar e começar a escutar e a compreender as explicações dos outros médicos.”

O ato do cirurgião tem valor científico, e não foi uma simples amabilidade. Conscientemente ou não, comportou-se como se soubesse que aquela paciente, tomada de tamanha ansiedade, nada podia ver ou ouvir e que a melhor maneira de se relacionar com ela era reconhecendo sua ansiedade e permitindo que a expressasse da maneira que pudesse; no caso, foi pelo choro.

Por outro lado, não se pode negligenciar a ansiedade dos próprios médicos ou, o que é mais evidente ainda, dos estudantes de medicina quando estão iniciando o aprendizado clínico. A principal causa é a insegurança, associada muitas vezes ao receio de estar importunando o paciente. Esses sentimentos são normais e são superados à medida que o estudante aprende os fundamentos da relação médico-paciente. Se a ansiedade, em vez de diminuir, aumentar, será necessário fazer uma avaliação mais profunda da situação.

Paciente deprimido. O paciente deprimido aparenta desinteresse por si mesmo e pelas coisas que acontecem ao seu redor, tem forte tendência a se isolar e, durante a entrevista, pode ter dificuldade em descrever seus padecimentos, ignorando ou respondendo pela metade às nossas perguntas.

É comum que se ponha cabisbaixo, tenha os olhos sem brilho e exprima tristeza, não sendo raro que caia em pranto durante o exame. Relata choro fácil e imotivado, despertar precoce, inapetência, redução da capacidade de trabalho/perda da vontade de viver. Entristecimento e perda gradativa do prazer em geral são sintomas essenciais para o diagnóstico.

De maneira geral, a primeira tarefa do examinador é conquistar sua atenção e sua confiança. Só se consegue isso demonstrando sincero interesse pela sua pessoa. Moderada dose de otimismo pode transparecer na linguagem e no comportamento do médico.

A anamnese, nesses casos, pode ser difícil em razão da dificuldade do paciente em manifestar claramente seus sentimentos, ou por estar francamente desesperançado. Ouvir e perguntar no ritmo do paciente é um meio de conseguir uma boa relação e uma futura adesão ao tratamento. Dar atenção ao familiar acompanhante e pedir sua colaboração complementa as informações necessárias para uma boa sintonia entre o médico, o paciente e a família.

A depressão é uma das patologias psiquiátricas mais conhecidas e faladas entre os leigos, levando várias pessoas a identificarem seus sintomas como depressivos, sem que isso tenha comprovação médica. Socialmente, é comum que as pessoas digam que passaram a semana ou o dia deprimidas, ao passo que o que sentiam era apenas uma grande tristeza ou aborrecimento por alguma causa social ou familiar. Assim, é importante que o médico esteja atento para os sintomas que se apresentam no paciente internado no hospital geral ou no ambulatório, para diferenciá-los dos quadros depressivos verdadeiros.

A *depressão unipolar* hoje é reconhecida como uma doença biológica, resultante de uma predisposição genética, de aspectos constitucionais da pessoa e do ambiente em que ela está inserida.

Assim, um episódio depressivo pode acontecer sem motivo aparente, após uma situação traumática ou até secundário a uma doença física. Da mesma maneira pode apresentar-se inicialmente com sintomas somáticos que não são correlacionados com sintomas depressivos e evoluir para um quadro mais grave, com ideias suicidas e desesperança.

A *depressão bipolar* tem características semelhantes à unipolar, mas cursa em ciclos com estados eufóricos, chamados de maníacos, e que são parte do transtorno bipolar do humor.

Ambas as formas de depressão são graves e exigem medidas urgentes e enérgicas, pois, além de causarem intenso sofrimento pessoal e aos familiares, podem incapacitar o paciente de modo acentuado para o desempenho das suas atividades, podem levá-lo ao suicídio.

Paciente que chora. Não é raro que o paciente caia em pranto durante a entrevista médica; outras vezes, percebe-se que o paciente está prestes a chorar. Ambas as situações provocam mal-estar no médico, mais ainda no estudante de medicina. Em primeiro lugar, deve-se deixar claro que não há nada demais no paciente chorar; quase sempre ele está precisando aliviar uma tensão que vem crescendo junto com sua doença. O primeiro a ser feito é deixá-lo chorar sem indagação e sem consolo com palavras vazias ou exortações inúteis. Os pacientes quase sempre se sentem constrangidos quando acabam de chorar, mas confessam estar aliviados, fazendo com que a entrevista seja retomada até com mais facilidade. As lágrimas podem representar o início de uma relação médico-paciente em nível mais profundo e, portanto, de melhor qualidade. Pequenos gestos – um leve toque na mão do paciente –, palavras de compreensão ou mesmo um silêncio respeitoso podem ajudar o paciente a sair daquela situação, que não deve prolongar-se demasiadamente. Às vezes, o paciente pode desejar interromper a anamnese, e o estudante deve respeitar sua vontade, voltando algum tempo depois, no mesmo dia ou no dia seguinte.

Paciente que demonstra medo. Aquele que tem medo exagerado de tudo. Seus receios são relacionados com a própria doença ou com exames aos quais será submetido.

Uma palavra de esclarecimento pode ser suficiente para vencer esses temores, e, nos momentos precisos, há que mostrar firmeza e energia para que o paciente supere sua pusilanimidade.

Paciente verborreico. Aquele que fala muito, com irresistível tendência para descrições minuciosas e cheias de interpretações pessoais a respeito de fatos relacionados com a sua doença e com episódios de sua vida.

Este tipo de paciente precisa ser reconduzido, a todo momento, ao relato de seus sintomas, pois mostra forte inclinação para divagações e longos rodeios. Impaciência por parte do examinador só servirá para inibi-lo. Consegue-se uma atitude correta juntando compreensão e firmeza, que irão conter o paciente dentro de certos limites, sem, no entanto, provocar inibições.

Paciente hostil. A hostilidade pode ser percebida à primeira vista, após as primeiras palavras, ou pode ser velada, traduzida em respostas reticentes e insinuações mal disfarçadas.

É comum percebermos que a agressividade disfarça ou é uma defesa contra a ansiedade.

Muitas situações podem determinar esse comportamento. Doenças incuráveis ou estigmatizantes costumam induzir, gradativamente, uma atitude de hostilidade contra o médico ou contra a medicina de maneira geral. Operações malsucedidas, complicações terapêuticas ou decisões errôneas de outros médicos podem provocar um comportamento hostil que o paciente não é capaz de esconder diante de qualquer médico; na verdade, ele perde a crença na medicina. Determinadas condições, como o etilismo crônico e o uso de drogas ilícitas, por si mesmas capazes de despertar sentimento de autocensura, reforçadas por atitudes recriminatórias dos familiares, determinam também o surgimento de hostilidade. Paciente inevitavelmente hostil é aquele cuja consulta foi determinada à sua revelia, por insistência dos familiares. O trabalho apressado, o exame feito às pressas, a pouca atenção dispensada ao paciente, tudo isso vai levando-o a sentir-se desprezado. Daí, surge uma hostilidade que,

às vezes, é específica, mas que pode se tornar genérica contra todos os médicos.

Os estudantes, por sua vez, podem ser alvo de uma hostilidade por parte dos pacientes dos hospitais de ensino, pelo fato de serem muito solicitados e nem sempre se sentirem dispostos a atender tais solicitações.

São inúmeras as fontes de hostilidade, e o examinador tem obrigação de reconhecê-las para assumir uma atitude correta diante desses pacientes.

A pior conduta consiste em adotar uma posição agressiva, revidando com palavras ou atitudes a hostilidade do paciente. Serenidade e autoconfiança são as qualidades básicas do examinador.

Paciente agitado. A agitação pode ser leve, traduzida apenas pelo fato de o paciente não conseguir ficar deitado ou sentado, ou intensa, quando, então, torna-se inquieto, reclamando em voz alta, não aceitando que seja examinado ou medicado, podendo chegar à agressividade.

Boxe

Agitação psicomotora

A agitação psicomotora tem diferentes causas, incluindo ansiedade, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas, insuficiência hepática, quadros psicóticos.

Na agitação leve, a maneira como o médico se comporta pode ser suficiente para acalmar o paciente; nos casos mais graves, o paciente fica inacessível e não é possível dominá-lo, sendo necessário lançar mão de processos de contenção. A melhor alternativa, desde que não haja contraindicação, é sedar o paciente com um tranquilizante, por via oral, ou, se necessário, injetável.

Paciente eufórico. O paciente eufórico fala e movimenta-se exageradamente. Sente-se muito forte e sadio e faz referências às suas qualidades. Seu pensamento é rápido, e ele muda de assunto inesperadamente, podendo haver dificuldade de ser compreendido. O médico faz uma pergunta, ele inicia a resposta, mas logo desvia seu interesse para outra questão e continua falando.

A euforia pode aparecer após ingestão de bebida alcoólica ou uso de droga estimulante (anfetamina ou cocaína ou ainda durante a fase maníaca do transtorno bipolar do humor). Há um tipo de exaltação do humor que aparece em quadros psicóticos.

Paciente com déficit de inteligência ou com retardo mental. É fácil reconhecer esse tipo de paciente, e é preciso fazê-lo para que se adote um raciocínio mais simples e linguagem adequada, no nível da compreensão do doente. Do contrário, ele irá se retrair ou dará respostas simplesmente despropositadas, pelo simples fato de não estar compreendendo a conversa. Prefere retrair-se a deixar transparecer a incapacidade de nos entender.

Perguntas simples e diretas, usando apenas palavras corriqueiras, ordens precisas e curtas, bem como muita paciência são os componentes para se conseguir um bom relacionamento com esse tipo de paciente.

Paciente hipocondríaco. É o que tem o hábito de estar sempre queixando-se de alguma doença e até gosta de relatar seus padecimentos. São pessoas muito sugestionáveis, e é preciso cuidado na maneira de falar com elas, pois, a partir de uma explicação mal compreendida, desenvolvem novas fantasias que vão juntar-se às que elas próprias engendraram.

O hipocondríaco sempre tem alguns diagnósticos a oferecer à guisa de queixas. O estudante deve estar prevenido, e, quando o paciente disser, por exemplo, que sofre de “hemorroidas”, pode ser que seu problema seja apenas “constipação intestinal”, mas que, em sua imaginação, foi transformado em um diagnóstico taxativo.

Contradizê-lo não ajuda em nada. Ridicularizá-lo só trará dificuldades no estabelecimento de uma boa relação médico-paciente. Ouvi-lo com paciência e compreensão e atitudes firmes bem fundamentadas são as qualidades necessárias no relacionamento com o paciente hipocondríaco.

Paciente surdo. A comunicação entre o médico e um paciente que não escuta depende do interesse do primeiro e da inteligência do segundo.

Quase sempre alguma pessoa da família faz o papel de intérprete, e, nesse caso, a entrevista assume características idênticas às que exigem a participação de uma terceira pessoa que pode ser um intérprete que domine a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Em tais situações, é óbvio, a anamnese terá de ser resumida aos dados essenciais, e suas possibilidades de ajuda no diagnóstico terão sido irremediavelmente restringidas; contudo, as poucas informações que se conseguem poderão ser cruciais para a correta orientação diagnóstica.

A capacidade de ser médico pode ser avaliada exatamente nestas condições em que se torna mais difícil a relação médico-paciente.

Paciente psicótico. Reconhecer o paciente psicótico ou com transtorno mental costuma ser difícil para o estudante ou até mesmo para o médico pouco experiente nesta área.

As principais alterações mentais são a confusão mental, as alucinações, os delírios, a desagregação do pensamento, a depressão, a excitação patológica do humor e as alterações do juízo crítico que levam à alteração do comportamento.

No paciente psicótico, ao exame clínico, consegue-se, geralmente com o auxílio da família, delimitar o início da doença, que é marcado pela interrupção do sentido da continuidade existencial. É a pessoa que tinha uma vida normal e, a partir de um determinado momento, passa a apresentar uma das alterações anteriormente referidas. O psicótico vive em um mundo incompreensível do ponto de vista fenomenológico.

Paciente em estado grave. O paciente em estado grave não quer ser perturbado por ninguém, e o exame não deixa de ser um incômodo para ele.

É necessário ser objetivo e só fazer o que for estritamente necessário para coletar os dados que permitirão o diagnóstico.

As perguntas têm de ser diretas e objetivas, pois a capacidade de colaborar está reduzida, e todas as manobras devem ser feitas com a preocupação de não aumentar o sofrimento do paciente.

Paciente terminal ou sem possibilidade terapêutica. Conceituar esse tipo de paciente é uma tarefa difícil. Em senso estrito, paciente terminal ou sem possibilidade terapêutica, como tem sido a denominação preferida, atualmente, é o que sofre de uma doença incurável em fase avançada e para o qual não há recursos médicos capazes de alterar o prognóstico de morte a curto prazo. Os exemplos mais frequentes são as neoplasias malignas avançadas, as cardiopatias graves, as nefropatias com insuficiência renal avançada, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

Boxe

Não se deve confundir o conceito de paciente em estado grave com paciente terminal. Por mais graves que sejam as condições de um paciente, quando há possibilidade de reversão do quadro clínico, as reações psicológicas do paciente e os mecanismos psicodinâmicos da relação médico-paciente são diferentes dos que ocorrem quando não há esperança de recuperação.

A relação médico-paciente nos casos terminais costuma ser difícil e causar perturbação emocional para o médico. Muitos médicos têm grande dificuldade de se relacionar com esses pacientes.

Contribuição relevante nesta área foi dada por Kübler-Ross (1987). Após conviver com centenas de pacientes terminais, ela pôde distinguir cinco fases pelas quais passam estas pessoas, ao terem consciência de que caminham para a morte. Aliás, cumpre ressaltar que os conhecimentos obtidos por esta psiquiatra são válidos para qualquer paciente. O que acontece no paciente terminal é apenas uma amplificação dos fenômenos psicológicos que fazem parte do sentir-se doente.

A primeira fase é a de *negação*. O paciente usa todos os meios para desconhecer o que está acontecendo com ele. É comum que se expresse assim: “Não, não é possível que isto esteja acontecendo comigo!” Quase sempre a família e o próprio médico reforçam esta negação – a família escondendo todas as informações que lhe são fornecidas e o médico dando ao paciente uma ideia falsamente otimista de seu estado de saúde. A fase de negação é mais evidente nas pessoas que estão vivendo um momento de grandes responsabilidades, prestígio e poder. Não adianta o médico enfrentar a negação do paciente com exortações ou levantando falsas esperanças. É mais conveniente calar-se e deixá-lo vivenciar sua frustração, só falando o essencial e respondendo às questões de maneira sincera e serena.

A segunda fase é a de *raiva*. A pessoa, que até então negava sua realidade, começa a aceitá-la como concreta, mas passa a agredir os familiares e os profissionais que lhe prestam assistência. Alguns se revoltam contra Deus, expressam desencanto, proferem blasfêmias. Nesta fase, a relação médico-paciente apresenta suas maiores dificuldades, uma vez que o paciente quase sempre mostra decepção com a medicina, e o médico pode ser o alvo de suas palavras de desespero e raiva. Nestes momentos, é fundamental o sentimento de compaixão, acompanhado de compreensão e tolerância.

A terceira fase é a de *barganha* ou *negociação*. Depois de negar e protestar, o paciente descobre que a negação e a raiva de nada adiantam e passa a procurar uma solução para o seu problema. Promessas de mudança de vida, reconciliação com pessoas da família e busca a Deus são os meios encontrados pelo doente nesta fase de negociação, na qual o médico pode ter papel muito ativo, apoiando e conversando abertamente com o paciente.

A quarta fase é a de *depressão*. Nesta fase, o paciente questiona toda sua vida, seus valores, suas aspirações, seus desejos, suas ambições, seus sonhos. O paciente costuma manifestar vontade de ficar só e em silêncio. Deixa de ter interesse pelos

assuntos corriqueiros e cotidianos – negócios, problemas familiares –, aos quais dava grande importância. A revolta e a raiva cedem lugar a um sentimento de grande perda. Muito influem na depressão as alterações físicas, representadas por emagrecimento acentuado, queda de cabelos, cirurgias mutiladoras. Nessa fase, o papel do médico pode ser decisivo para o paciente vencer suas angústias e aliviar sua decepção. Nunca é necessário falar palavras duras, mas a verdade precisa imperar na relação do médico com o paciente e a família. Medidas paliativas que aliviem o sofrimento e melhorem a qualidade de vida contribuem para o paciente superar esta fase.

A quinta fase é a de *aceitação*. Perceber a realidade não é desistir da luta ou sentir-se derrotado. É a plena consciência de um fato – a morte próxima – como parte de seu ciclo vital. Muito influem para a entrada nesta fase os valores, as crenças e as ideias daquela pessoa ao longo de sua vida, antes de adoecer. Aqueles que tiveram formação religiosa ou um desenvolvimento espiritual mais avançado são mais capazes de aceitar a morte do que as pessoas que se apoiam apenas em objetivos materiais para viver.

Boxe

É lógico que, na prática, os fatos não se passam de maneira tão esquemática. O processo é muito complexo e a descrição didática proposta por Kübler-Ross (1987) é válida por ter referências facilmente compreensíveis dentro da complexidade desses fenômenos. Nem sempre as fases se sucedem na ordem referida. Às vezes, o paciente, em vez de avançar na busca da aceitação, regride às fases de negação ou de raiva. De qualquer modo, é necessário reconhecê-las, porque o médico deve procurar adotar as atitudes mais adequadas para cada uma delas.

Os estudantes que iniciam sua formação clínica se deparam com frequência com pacientes terminais, pois são comuns estes casos nas enfermarias dos hospitais universitários. Sem dúvida, é um momento muito difícil para eles. São vivências sofridas e que deixam marcas profundas. Ali, aprendem que reconhecer as limitações da medicina é tão importante quanto saber usar as possibilidades que ela nos dá para o controle ou cura das doenças. Naqueles momentos, a referência mais útil que o estudante pode ter é nossa condição humana, tudo mais se torna secundário.

Crianças e adolescentes

O comportamento das crianças varia conforme a idade, e o examinador deve adaptar-se para conseguir estabelecer uma boa relação com o pequeno paciente.

Comumente, as crianças têm medo do médico e dos aparelhos. Este receio é lógico porque a criança teme o desconhecido.

Talvez a qualidade mais importante para lidar com elas seja a bondade, traduzida na atenção, no manuseio delicado e no respeito pela sua natural insegurança. Conquistar a confiança e a simpatia de uma criança doente é mais do que um ato profissional: é um ato de amor cujo significado será facilmente percebido pelo estudante sensível.

O adolescente apresenta muitas particularidades. Sua luta pela conquista da própria identidade inclui necessariamente conflitos com o mundo adulto, representado por sua família. O médico é visto pelo adolescente como parte desse mundo, às vezes como um representante da própria família. Alguns médicos se equivocam ao acharem que, para um bom relacionamento com adolescentes, devem comportar-se como um deles; essa postura tem efeito negativo. O estudante de medicina, muitas vezes ainda adolescente, fica em posição inversa com os pacientes adultos, mas ele não pode se esquecer de que está exercendo o papel de médico junto ao paciente, seja qual for sua idade.

Idosos

O envelhecimento é um processo inexorável, o qual só não será vivenciado por aqueles que morrerem jovens.

O processo de envelhecimento é complexo e o comportamento que cada indivíduo vai apresentar na velhice dependerá das alterações biológicas inerentes a esse processo, mas principalmente de sua personalidade, suas vivências e condições sociais e culturais.

Os idosos estão sujeitos às mesmas alterações de comportamento que os mais jovens. A irritabilidade, o pessimismo, a sensação de menos-valia, as inúmeras queixas orgânicas, a falta de interesse por suas atividades normais não devem ser considerados comportamentos normais dos velhos. Na verdade, podem ser sintomas de doenças psíquicas, como a depressão, que também ocorrem nessa faixa etária.

O que se observa, no entanto, é que a civilização ocidental tende a considerar o envelhecimento como um sinônimo de perdas e limitações. Isso se deve à valorização excessiva da capacidade de produção e de consumo. Como os velhos são

considerados pouco produtivos e, conseqüentemente, pouco consumistas, eles perdem sua importância social. Muitos idosos assimilam esse preconceito e consideram-se incapazes e limitados. Isso, ao contrário do que se pensa, não os torna políquelxosos, mas faz com que eles aceitem ter sintomas e sofrer em silêncio, dificultando o diagnóstico de suas doenças.

Antes de cuidar de um idoso, o médico deve estar ciente de tudo isso; mais ainda, precisa aprender a ver a velhice como mais uma etapa da vida, pela qual todos nós deveremos e gostaríamos de passar (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

FAMÍLIAS

A participação das famílias em tudo o que se refere ao paciente é um direito inquestionável e precisa ser levado em conta pelo médico e pelos demais profissionais da saúde.

Boxe

A família é coadjuvante em tempo integral, cabendo-lhe transformar em ações concretas as prescrições e as recomendações dadas pelo médico. É obrigação do médico explicar corretamente o diagnóstico e sua repercussão no contexto familiar.

Com relação à decisão terapêutica, praticamente sempre há envolvimento familiar. Cumpre salientar que a família tem interesse especial em tudo o que se refere ao prognóstico. Momento difícil na prática médica é a comunicação de um diagnóstico de doença incurável ou de um prognóstico reservado; mais delicado ainda é informar aos familiares um fracasso terapêutico ou, pior que isso, o desenlace do paciente. É um aprendizado doloroso, porém indispensável, pois não se pode excluir a família, ou um membro dela, em tudo que diz respeito ao paciente.

O médico é a figura de maior destaque no cenário em que um paciente em estado grave ou em fase terminal ocupa a posição central. Não é apenas em sua condição de um profissional com domínio do lado científico das doenças; cabem a ele compreender e atuar em tudo que possa ter influência na recuperação e bem-estar do paciente.

Boxe

Nunca é demais repetir que o paciente não é uma “simples máquina” que apresenta uma “peça danificada”. Mais do que isso: além de sua individualidade, ele está inserido no seio de uma família. A compreensão destes aspectos humanos é um dos principais componentes da medicina de excelência.

Não resta dúvida de que uma rede familiar e social estável e sensível protege a pessoa contra doenças. Ao contrário, a presença de doença em uma pessoa compromete a qualidade de sua interação na família e na rede social mais próxima. São inter-relações complexas e com múltiplas facetas, nem sempre devidamente valorizadas pelos médicos. Valendo-se dos conhecimentos sobre a repercussão das doenças físicas e mentais sobre a família, o médico tem o dever de reconhecer a dimensão relacional entre o paciente, sua família e o contexto no qual vive.

Um aspecto a ser ressaltado é que os pacientes, hospitalizados ou não, que recebem apoio de seus familiares e de seus amigos, que não se isolam, beneficiam-se desses contatos, o que atenua as reações emocionais desencadeadas pelas doenças. Pacientes que sofreram infarto do miocárdio, por exemplo, e que contam com o acompanhamento de seus familiares, tendem a se recuperar mais rapidamente que aqueles que são mantidos isolados, distantes da família. O afastamento de uma criança doente de sua família tem graves consequências na evolução da doença. A presença da mãe pode fazer grande diferença na recuperação de uma criança.

Na ausência de familiares, como mecanismo de defesa, não é incomum o paciente hospitalizado desenvolver laços afetivos com outros pacientes internados, com fragilidade física ou emocional. Um exemplo que ilustra tal aspecto é o caso de Joana, 57 anos, internada na enfermaria de um Hospital Universitário, que assim se expressou:

“Sabe, eu não me sinto muito só aqui. Minha família não vem me visitar porque reside em outra cidade, mas, quando eu olho de um lado e de outro e encontro pessoas para conversar, aí me sinto bem. É como se elas fossem minha família.”

O médico precisa reconhecer que sempre há uma relação entre a enfermidade e o estado emocional do paciente. A existência de uma doença grave ou debilitante produz impacto não só sobre a pessoa doente, mas também sobre sua família, amigos e colegas de trabalho.

Não é raro ocorrer um distanciamento por parte da família e dos amigos de uma pessoa doente, tendo em vista as

dificuldades que se instalam no processo de internação. Visitar um parente ou amigo em estado grave, ou em estado terminal, acompanha-se de dor e sofrimento psíquico. Daí serem frequentes as condutas de evitação. Fato é que se visita os doentes cada vez menos. As notícias sobre ele passam a ser obtidas, muitas vezes, apenas por meio do boletim médico ou de algum parente.

É importante que os profissionais que trabalham com pacientes graves ou terminais e convivem com suas famílias tenham uma compreensão sobre um tipo de luto, denominado *luto antecipatório*, de modo que possam ajudá-los neste momento difícil. O processo do luto começa antes da morte e envolve vários aspectos inerentes à vivência do luto.

A família, por ser o grupo mais próximo do indivíduo, vive muitas vezes o luto antecipatório. O luto ocorre antes de acontecer a perda real, mas apresenta as mesmas características e manifestações do processo de luto normal.

Pessoas com doenças terminais influem na natureza dos sentimentos vividos por seus familiares neste período. É frequente ocorrer ambivalência de sentimentos dos familiares que é transferida ao paciente que ainda vive. Sentimentos de culpa e reações de negação podem ser observados nos familiares. Também podem surgir comportamentos de esquiva em permanecer ao lado do paciente, impedindo, assim, que os membros da família entrem em contato com sinais de agravamento do quadro clínico do paciente.

Um período muito longo de luto antecipatório pode desencadear muitas dificuldades: a família pode regredir emocionalmente muito cedo, antes mesmo de a pessoa falecer, o que pode estabelecer uma relação inadequada. Eis um exemplo:

A mãe de Renato estava morrendo de uma doença degenerativa progressiva. Ele, bem como as outras pessoas da família, “anteciparam” a sua morte. Todos se despediram e organizaram os preparativos. Contudo, a mãe continuava viva, embora muito mal. O filho conversou com o médico que acompanhava o caso, mostrando-se confuso e com uma grande dúvida: sairia de férias, como era de costume acontecer todos os anos, naquela época? Sentia-se angustiado por não poder continuar a fazer planos enquanto ela estivesse viva. Renato se sentia culpado e indigno ao pensar que, se ela morresse, tudo estaria resolvido.

Este é um dos modos de luto antecipatório que ocorre quando um familiar sente-se exigido a dar inteira atenção, cuidando de uma pessoa que, a cada dia, piora fisicamente e se encontra ausente psicologicamente. Ao contrário, há casos em que os membros da família se aproximam mais da pessoa que está morrendo. Eles ficam muito próximos no intuito de resolver sentimentos de culpa e perda e, nesses casos, podem querer lidar de maneira intensa e excessiva com o paciente, exigindo mais atenção e presença da equipe médica ou buscando tratamentos não tradicionais, o que pode se tornar um problema não só para o paciente, mas, também, para a equipe médica.

Outro aspecto importante refere-se ao conhecimento de que o período que precede a morte pode ser utilizado de modo positivo, significando uma singular oportunidade para os familiares enlutados expressarem e comunicarem coisas que devem ser ditas antes de a pessoa morrer. O médico pode ajudá-los a aproveitar os momentos que antecedem a morte de um familiar.

As pessoas que estão morrendo podem sentir o luto antecipatório, embora isso aconteça de maneira um pouco diferente das pessoas de sua família. Estas estão perdendo apenas uma pessoa querida. A pessoa que está morrendo geralmente tem muitas ligações na vida; neste sentido, estará perdendo muitas pessoas significativas de uma só vez. A antecipação da perda que o paciente vivencia o faz recuar diante do tratamento, levando-o a não cooperar. Uma das maneiras de fazer isso é voltar seu rosto para a parede, recusando-se a se comunicar.

Outro aspecto importante que auxilia na compreensão do luto familiar refere-se a três áreas citadas por Worden (1998). A primeira diz respeito à posição funcional ou o papel que a pessoa doente ocupa na família. A proximidade da morte vai criar mudanças no equilíbrio funcional da família. A segunda área refere-se à integração emocional da família. Membros de uma família bem integrada conseguem ajudar uns aos outros a lidar com a proximidade da morte, possibilitando a expressão livre de sentimentos diante da perda, evitando que se instalem, posteriormente, comportamentos vivenciados como sintomas, físicos ou emocionais, consequência da não elaboração do luto. A terceira área diz respeito à maneira como as famílias facilitam ou dificultam a expressão emocional. Falar e chorar são comportamentos esperados e que, facilitados na sua manifestação, poderão evitar o estabelecimento de um luto problemático.

Existem manifestações de luto que evoluem de maneira complicada. É importante que o médico os conheça, como, por exemplo, reações de luto mascaradas. Isso acontece quando uma pessoa não expressa seus sentimentos abertamente, por não se encontrar suficientemente capaz de manifestar a dor diante da perda.

Ao médico importa saber que uma pessoa da família pode apresentar sintomas similares àqueles que a pessoa que faleceu apresentava ou outro tipo de queixa psicossomática; por exemplo, a dor frequentemente pode significar um luto reprimido. Entre as outras manifestações que podem ser mascaradas por sintomas psiquiátricos, está a depressão.

Uma família que perdeu um ente querido por suicídio pode apresentar em seus membros sobreviventes reações distintas, em diferentes momentos. A culpa é um sentimento comum entre os familiares enlutados por uma vítima de suicídio. Pais que perderam um filho nessa condição querem assumir a responsabilidade pelo ato ocorrido, evoluindo para condutas inexplicáveis.

Em decorrência da intensidade da culpa podem sentir a necessidade de serem punidos ou de se autoagredirem. Uma doença física ou mental pode surgir como modo de efetivar tal desejo.

O sentimento de culpa pode ter variadas consequências, podendo desencadear na família diferentes comportamentos, como superproteção, afastamento, aparecimento de doenças em outros membros, entrega precoce da pessoa à morte.

É muito difícil para a equipe de saúde compreender a reação de afastamento dos familiares na iminência da morte de um membro da família. Por outro lado, a pessoa gravemente enferma pode não se sentir mais com direito à vida, já que sua família encontra-se sofrendo. Dessa maneira, poderá responder debilmente aos estímulos, mostrando-se apática, chegando a recusar a medicação e a alimentação.

Em situações de maior gravidade, a família, com poucos recursos internos, lança mão de mecanismos de defesa para se proteger do aniquilamento. Como exemplo, temos a reação de negação da família frente ao diagnóstico de uma doença grave e a possibilidade da morte. Os profissionais de saúde devem compreender e aceitar essa reação. Contudo, reações extremas como descontrole, angústia ou reações irrealis e maníacas de otimismo exigem intervenção da equipe, pois tais comportamentos dificultam o contato da família com a realidade.

Segundo Kübler-Ross (1987), a família, ao receber a notícia de um diagnóstico de doença grave ou incurável, tal como o paciente, pode passar pelos estágios de negação, raiva, barganha ou negociação, depressão e aceitação.

Cuidar de um paciente, em sua integridade, implica atenção aos seus familiares. Ante o impacto causado pela enfermidade de um de seus membros, a família deve ser reconhecida como capaz de fornecer dados importantes à equipe médica.

Ignorar os sentimentos da família ou não reconhecer a necessidade de cuidados que o grupo familiar demanda constitui uma grande falha. Manter a família distante das informações e dos profissionais que cuidam do paciente somente contribui para o aumento da ansiedade e do estresse. O envolvimento dos familiares no tratamento torna-se fator relevante à medida que podem ajudar o paciente na travessia de sua doença, atenuando a carga emocional, o medo e a insegurança que o invadem e as incertezas diante da fragilidade de viver. Quando a interação médico-paciente-família é plena, nascem laços e forças essenciais para que os componentes dessa tríade exerçam da melhor maneira possível o papel de cada um.

Capítulo 9



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Exame Clínicodo Idoso

Elisa Franco de Assis Costa

Siulmara Cristina Galera

Celmo Celeno Porto

Claudio Henrique Teixeira

- Introdução
- Anamnese do paciente idoso
- Modificações decorrentes do envelhecimento
- Avaliação funcional do idoso
- Considerações finais
- Roteiro pedagógico para exame clínico do idoso e avaliação geriátrica ampla

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS), com base em fatores socioeconômicos, considera idoso todo indivíduo com 65 anos ou mais; porém, nos países com expectativa média de vida ao nascer mais baixa do que a de países desenvolvidos, pode-se reduzir o limite para 60 anos. No Brasil, em outubro de 2003 foi instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (Lei nº 10.741/2003).

Do ponto de vista biológico, conceitua-se o envelhecimento como um fenômeno caracterizado pela perda progressiva da reserva funcional, que torna o indivíduo mais propenso a ter doenças e aumenta a chance de óbito.

Boxe

Costuma-se dividir os idosos em grupos conforme a faixa etária; no Brasil, os limites são:

Idosos jovens: 60 a 69 anos

Idosos velhos: 70 a 79 anos

Muito idosos: 80 anos ou mais.

Convém ressaltar que o grupo dos “muito idosos” é o que mais cresce proporcionalmente no país e também o grupo que engloba os indivíduos mais frágeis e portadores de incapacidade funcional. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira total cresceu, em 10 anos (1997-2007), 21,6%, ao passo que a população com 60 anos ou mais cresceu 47,8% e aquela com 80 anos ou mais, 65%. A previsão é de que esse grupo de “muito idosos” cresça, até 2050, o dobro da população de 60 a 79 anos.

Boxe

Muito mais importante é a classificação do envelhecimento em três tipos:

Bem-sucedido: quando predominam as modificações fisiológicas do envelhecimento (senescência), sem perdas funcionais significativas

Malsucedido: quando predominam as alterações provocadas por doenças (senilidade) associadas a perdas funcionais significativas

Envelhecimento usual: situa-se entre os dois polos, com doenças interagindo com as perdas funcionais.

As condutas e os procedimentos a serem executados dependem dessa classificação e do exame clínico global do idoso, os quais vão ditar as intervenções diagnósticas e terapêuticas.

O exame clínico é o único método que possibilita uma avaliação global do paciente idoso. Sua estrutura geral e as técnicas básicas são as mesmas usadas para qualquer paciente, mas é necessário levar em conta as modificações anatômicas e funcionais que acompanham o processo de envelhecimento a fim de se realizar um exame clínico adequado e interpretar corretamente os dados obtidos.

No atendimento de um idoso (seja no consultório, no hospital, no pronto-socorro, no asilo ou no domicílio), é frequente a presença de um ou mais acompanhantes, e o médico deve estar preparado para ouvi-los, levar em conta as suas informações, e, se for o caso, discutir com eles o prognóstico e as decisões diagnósticas ou terapêuticas, porém sem alijar o idoso dessa relação, por mais frágil e incapacitado que ele seja.

A presença de muitos acompanhantes certamente diminuirá o tempo de que o médico dispõe para conversar com o paciente, mas, nos casos de pacientes com deficiência cognitiva ou sensorial, eles podem ser fontes valiosas de informações e estímulo à adesão ao plano terapêutico. Entretanto, em alguns casos, o acompanhante pode querer tomar o lugar do paciente durante a entrevista, respondendo por ele todas as perguntas. Cabe ao médico, então, intervir para garantir os direitos do paciente no que se refere ao relato de seus padecimentos e sua privacidade e autonomia. Nas consultas podemos ter familiares, cuidadores e outros tipos de acompanhantes.

Os cuidadores são as pessoas que assistem o idoso em suas atividades da vida diária e podem ser especialmente contratados para essa finalidade, sendo então chamados de cuidadores formais.

Não raro ocorrem divergências entre os acompanhantes durante a consulta, podendo o médico ter de contorná-las e buscar o consenso. Por fim, convém ressaltar que a presença de qualquer acompanhante deve ser autorizada pelo paciente quando for capaz de tomar essa decisão ou por seu responsável legal quando não for.

Boxe

Como o médico pode atuar para melhorar a relação com o paciente e o cuidador

- Estabelecer uma boa relação sem preconceitos e estereótipos
- Não infantilizar o idoso
- Estar sempre ciente de que os valores com os quais os idosos foram educados são muito diferentes dos atuais
- Avaliar todos os aspectos da capacidade funcional do paciente
- Conversar sobre expectativas e medos do paciente e do cuidador
- Dar atenção às informações de cuidadores e familiares, mas, de modo algum, alijar o paciente idoso, mesmo aquele com problemas de comunicação
- Estar disponível
- Estar preparado para múltiplas queixas, muitas vezes inespecíficas
- Ficar atento e contornar barreiras que dificultem a obtenção de uma boa história clínica, com os déficits cognitivo e afetivo
- Simplificar a abordagem e os regimes terapêuticos
- Orientar e educar sobre a doença
- Valer-se da equipe multiprofissional
- Recomendar a divisão de tarefas entre familiares e cuidadores
- Recomendar grupos de apoio.

Boxe

Tipos de cuidadores e acompanhantes dos idosos à consulta

- Cuidadores formais:
 - Totalmente leigos
 - Com curso de cuidador
 - Auxiliares e técnicos de enfermagem
- Outros possíveis acompanhantes:
 - Empregados (muito comumente o motorista ou a empregada doméstica)
 - Amigos e/ou vizinhos
 - Outros profissionais de saúde que assistem o idoso (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional)
 - Intérpretes (p. ex., no caso de estrangeiros)
 - Assistentes sociais
 - Funcionários de instituições de longa permanência (asilos)
 - Advogados
- Familiares que podem ser os cuidadores, só acompanhantes ou mesmo os responsáveis legais pelo paciente:
 - Cônjuge, filhos, noras ou genros, netos, irmãos
 - Outros.

ANAMNESE DO PACIENTE IDOSO

A anamnese é, e sempre será, a base para se cuidar de um paciente. No caso dos idosos, não é diferente.

A relação médico-paciente surge durante o exame clínico. Se este for bem conduzido, a relação cresce e se fortalece; caso contrário, o paciente vai se desligando do médico ainda durante o exame clínico. Além disso, o principal fator que faz o paciente seguir as recomendações – fazer exercícios físicos, modificar hábitos alimentares – e as prescrições é a boa relação médico-paciente. Quando se consegue despertar confiança no paciente, inicia-se o que se chama de aliança terapêutica, indispensável para prestar o cuidado adequado aos pacientes idosos.

As particularidades mais comuns da anamnese do paciente idoso são:

O paciente informa pouco sobre sua doença, seja porque a aceita como inevitável, seja por considerar seus sintomas uma consequência natural do processo de envelhecimento

O paciente fica intimidado pela pressa manifestada pelo médico

O paciente esconde os sintomas ou nega a doença por não querer fazer exames ou ser internado, ou até por receio de ter gastos

O processo de envelhecimento pode alterar as manifestações clínicas de muitas doenças, por exemplo: diminuição do limiar da dor nos casos de infarto do miocárdio, abdome agudo e fratura óssea

Em indivíduos muito idosos ou frágeis, várias doenças podem manifestar-se de maneira atípica, inclusive em condições agudas que demandem atendimento de urgência. Os tipos mais comuns de apresentações atípicas são o *delirium* (confusão mental aguda), as quedas e a perda funcional. As doenças que mais se manifestam de maneira atípica são as infecções (pneumonias, infecções urinárias), os efeitos adversos de medicamentos (principalmente psicotrópicos) e as doenças cardiovasculares (insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio)

Múltiplas doenças – o que é frequente em idosos – interagem entre si, tornando mais complexa a elaboração da história clínica, mascarando sintomas e dificultando o raciocínio diagnóstico. Ter conhecimento das doenças preexistentes facilita a compreensão das manifestações clínicas, que podem ser atípicas quando ocorrem complicações ou novas afecções

Nunca deixar de tomar conhecimento dos medicamentos em uso pelo paciente, inclusive os usados por conta própria (automedicação é muito comum em idosos). Tanto podem interferir nas manifestações clínicas como ser responsáveis principais pelos sintomas relatados pelo paciente. Faça um inventário rigoroso e, se possível, verifique pessoalmente as embalagens dos medicamentos, anotando as doses e os horários em que são usados.

Boxe

Inventário medicamentoso

Essa verificação é chamada de “teste da sacola de remédios” (Figura 9.1). Não é raro verificarmos o uso de um tranquilizante pela manhã, causando sonolência ao longo do dia, ou de um diurético à noite, responsável pela “insônia” do paciente, já que ele precisa levantar-se várias vezes para ir ao banheiro. Mas ainda: não é infrequente o uso de medicamentos com nomes diferentes, mas com o mesmo fármaco.

A anamnese deve ser realizada pesquisando todos os sistemas orgânicos como no adulto jovem. Enfatizam-se, porém, os seguintes aspectos:

Deficiência de memória imediata, recente e remota

Deficiência auditiva

Deficiência visual

Transtornos do comportamento, como agressividade, irritabilidade, desinibição, atitude sexual ou social inapropriada, deambulação compulsiva, apatia, isolamento

Alterações da marcha e necessidade de uso de dispositivos auxiliares como bengala e andador

Alterações da mobilidade, flexibilidade e força muscular em membros e tronco

Tontura, vertigem e síncope

Episódios de quedas, avaliando o número e as situações facilitadoras ou desencadeadoras

Traumatismos

Alterações do nível de consciência

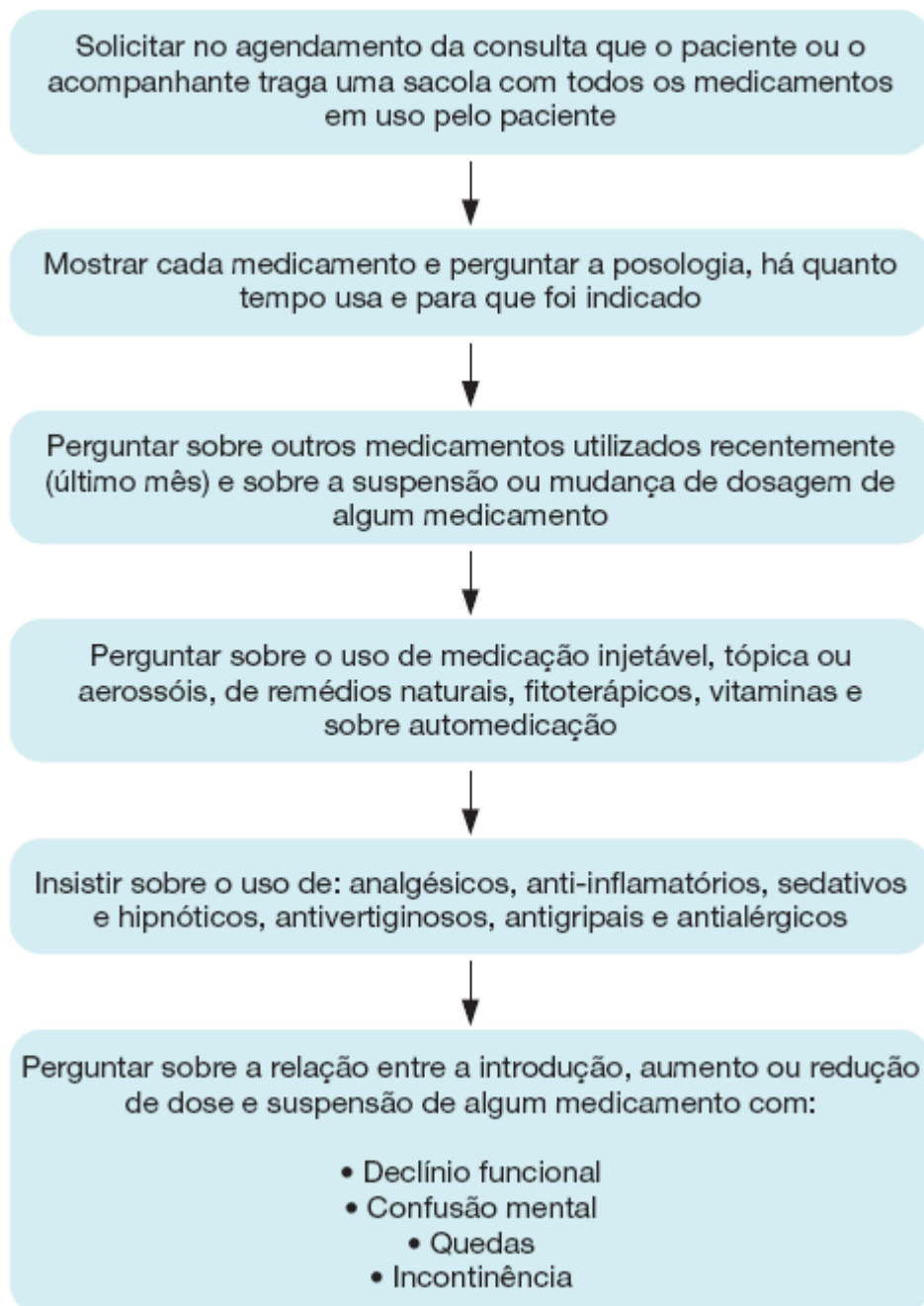


Figura 9.1 Teste da sacola de remédios.

Afecções da cavidade oral, estado de conservação dos dentes, alterações de gengivas e mucosas, presença e adaptação de próteses, ferimentos, tumores, úlceras, dor e dificuldade ao mastigar

Distúrbios alimentares

Necessidade de dietas especiais

Perda ou ganho de peso

Modificações no padrão do sono: sonolência diurna; insônia inicial, intermediária ou final; agitação noturna; terror noturno; perambulação noturna; apneia do sono; pernas irrequietas; sono não restaurador

Fadiga crônica

Disfunções sexuais

Incontinência urinária

Incontinência fecal

Sintomas depressivos

Sintomas de ansiedade

Úlceras de pressão (escaras).

MODIFICAÇÕES DECORRENTES DO ENVELHECIMENTO

A pele torna-se flácida, formando pregas nos braços, nas coxas e no abdome. Na nuca pode ficar mais evidente o quadriculado normal da pele, alteração denominada *cútis romboidal*. Em virtude da redução do número das glândulas sudoríparas e sebáceas, a pele torna-se rugosa e seca.

É comum o aparecimento de manchas hiperocrômicas, planas e lisas, principalmente na face e no dorso das mãos (*melanose senil*).

Os pelos do corpo diminuem, os cabelos embranquecem, podendo surgir calvície.

As unhas passam a crescer mais lentamente do que nos jovens e tornam-se espessas e curvas, de modo que as unhas dos pés podem adquirir formato irregular e tamanho excepcional (*onicogrifose*).

Os ossos, as articulações e os músculos sofrem modificações importantes, incluindo perda de tecido ósseo (*osteoporose*), desgaste dos ossos maxilares e da mandíbula, ancilose das articulações costoverbrais, fazendo com que a caixa torácica perca sua elasticidade e mobilidade. As curvaturas da coluna vertebral acentuam-se em virtude da diminuição da espessura dos discos intervertebrais. Ocorrem, também, perdas dos arcos dos pés. Essas alterações resultam em diminuição da estatura.

As alterações esqueléticas podem acentuar a curvatura dorsal da coluna torácica e produzir cifose, com consequente aumento no diâmetro anteroposterior do tórax, podendo atingir o que se chama *tórax em tonel*, mas com pouca repercussão sobre a função respiratória. Os pulmões perdem a capacidade de retração elástica; os músculos atrofiam, com substituição das fibras musculares por fibras colágenas, enquanto os ligamentos perdem parte de sua força de tensão.

Os pavilhões auriculares aumentam com a idade pelo crescimento de cartilagens e acúmulo de gordura. A acuidade auditiva vai se reduzindo, predominando para sons agudos (*presbiacusia*).

Observam-se, com frequência, hiperpigmentação, edema das pálpebras inferiores e queda das superiores (*ptose palpebral*).

O processo de envelhecimento afeta os tecidos oculares e em torno dos olhos. O globo ocular pode afundar um pouco na órbita. A pálpebra inferior pode afastar-se ou sofrer uma eversão, resultando no que se chama *ectrópio*. Há diminuição da secreção lacrimal com ressecamento ocular.

No sistema cardiovascular, também ocorrem modificações que precisam ser identificadas no exame físico, destacando-se endurecimento e tortuosidade de veias e artérias, alterações que não podem ser confundidas com aterosclerose. Em virtude do aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, fica mais difícil detectar o *ictus cordis*.

O envelhecimento espessa a base das cúspides aórticas, a expensas de aumento do tecido fibroso, seguindo-se de calcificação, originando vibrações audíveis (sopro sistólico). No início, não há prejuízo do fluxo sanguíneo, mas, com a evolução do processo, pode surgir uma estenose aórtica verdadeira com obstrução ao fluxo de sangue.

As alterações bucais são comuns, principalmente quando não foram cultivados hábitos adequados de higiene. A perda de dentes é quase inevitável nestes casos. A doença periodontal é frequente, sendo a principal causa de halitose nos idosos.

As glândulas submandibulares ficam mais fáceis de palpar.

Pode haver reabsorção óssea e alterações degenerativas da articulação temporomandibular (ATM), facilitando o deslocamento da mandíbula.

Boxe

Manifestações atípicas das doenças nos idosos

Fatores predisponentes	Formas mais comuns	Doenças que comumente podem manifestar-se de modo atípico
Idade avançada	Piora do estado mental (<i>delirium</i>)	Pneumonias
Diminuição da reserva funcional	Quedas	Infecções urinárias
Incapacidade de manter a homeostase	Imobilidade e alterações inexplicáveis de capacidade funcional	Efeitos adversos de medicamentos (principalmente psicotrópicos)
Percepções equivocadas	Início ou intensificação de	Meningite

sobre o envelhecimento	incontinência urinária e/ou fecal	Tuberculose
Síndrome do idoso frágil	Astenia	Infarto agudo do miocárdio
Presença de múltiplas doenças crônicas (multimorbidade)	Perda de peso ou dificuldade em aumentá-lo	Insuficiência cardíaca
Incapacidade funcional prévia	Dores generalizadas e mal definidas	Tromboembolismo pulmonar
Deficiência cognitiva	Pressão arterial instável	Hematoma subdural crônico
Polifarmácia (uso de 4 ou mais medicamentos)	Taquicardia e taquipneia	Acidente vascular encefálico
	Febre ausente ou de valor inferior à gravidade do processo infeccioso	Hipotireoidismo
		Hipertireoidismo
		Depressão

À medida que se envelhece, a tireoide sofre atrofia, com substituição do tecido glandular por tecido fibroso e gordura.

Os órgãos genitais femininos sofrem modificações mais acentuadas do que os masculinos. A função ovariana começa a diminuir durante a quinta década de vida da mulher, e os ciclos menstruais cessam entre 45 e 50 anos de idade.

As mamas tornam-se flácidas e pendentes, e o tecido glandular é substituído por tecido fibroso, mudando sua textura.

Os lábios e o clitóris ficam menores. A vagina diminui em comprimento e largura, sua mucosa atrofia e torna-se fina e ressecada. Os ligamentos que sustentam o útero afrouxam-se, favorecendo a ptose do órgão.

No homem, observa-se diminuição dos testículos – que pendem em uma região mais baixa da bolsa escrotal –, das vesículas seminais e das dimensões do pênis, que perde sua elasticidade. O volume prostático aumenta na maioria dos idosos, mas suas glândulas atrofiam-se.

O sistema nervoso sofre alterações progressivas com a idade. Às vezes, é difícil distinguir as alterações decorrentes do envelhecimento normal daquelas associadas às doenças mais comuns nesta fase da vida. Os reflexos podem diminuir de intensidade, e o tremor é comum.

Boxe

Critérios de gravidade de uma doença

É importante ressaltar que os critérios de gravidade de uma doença não diferem entre adultos jovens e idosos. Os valores indicativos de gravidade na avaliação das frequências cardíaca (< 50 bpm ou > 120 bpm) e respiratória (< 10 irpm ou > 29 irpm), da pressão arterial (sistólica < 90 mmHg) e da saturação de oxigênio (< 93% no ar ambiente e na ausência de DPOC), assim como da escala de Glasgow (< 12 pontos) para avaliação da consciência, são iguais nos idosos. Entretanto, é essencial que o médico, ao atender o idoso com um problema agudo ou subagudo, tenha em mente que o principal fator determinante do prognóstico é a sua capacidade funcional prévia; por isso, a avaliação funcional é parte importante do exame clínico do idoso, inclusive na urgência.

Boxe

Exame físico do idoso

O exame físico deve ser realizado de maneira sistematizada e completa, abrangendo todos os segmentos do

corpo, como no adulto jovem. Os seguintes aspectos devem ser enfatizados:

Avaliação da postura

Tipo de marcha

Equilíbrio

Modo de realizar transferência de um lugar para outro

Hidratação

Condição da pele e das mucosas

Índice de massa corpórea

Medida da pressão arterial e frequência cardíaca nas posições de decúbito e ortostática

Avaliação da força muscular em graus, mobilidade e flexibilidade dos membros e do tronco

Palpação dos pulsos nos membros

Palpação e ausculta de pulsos no pescoço e no trajeto da aorta abdominal

Ausculta das carótidas

Palpação suprapúbica cuidadosa

Toque retal

Avaliação criteriosa de mãos e pés – deformidades, mobilidade, ferimentos, trofismo muscular, sinais de inflamação e isquemia, tremores

Avaliação dos nervos cranianos, reflexos, sinais piramidais e extrapiramidais.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO IDOSO

É importante ressaltar que não se pode separar a *avaliação funcional do idoso* de uma cuidadosa avaliação clínica. Tudo começa pela anamnese, sendo que muitas vezes um cuidador ou familiar deve ser solicitado a fornecer informações ou completar as do paciente.

É fundamental o reconhecimento de que existe uma enorme heterogeneidade entre os idosos, sem se esquecer de que a idade cronológica não guarda relação com o prognóstico do paciente. Na verdade, os principais determinantes de melhor evolução na história natural das doenças dos idosos são o seu estado funcional e o contexto social em que vivem.

Muitos gerontes padecem de doenças crônicas que resultam em graus variáveis de incapacidade. Sem dúvida, o número de idosos com algum grau de incapacidade aumenta em razão da idade, e cerca de 50% daqueles com mais de 80 anos apresentam limitações em suas atividades diárias. Contudo, alguns indivíduos, mesmo em idade muito avançada, mantêm-se vigorosos em todos os aspectos de sua vida, o que é chamado de *envelhecimento bem-sucedido*.

Os objetivos da avaliação funcional são:

Melhorar a precisão diagnóstica

Determinar o grau e a extensão da incapacidade (motora, mental e cognitiva)

Servir de guia para a escolha de medidas que visam restaurar e preservar a saúde (farmacoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia)

Identificar fatores que predisõem à iatrogenia e estabelecer medidas para sua prevenção

Estabelecer critérios para a indicação de internação e institucionalização.

Parâmetros da avaliação funcional do idoso

Na avaliação funcional do idoso, os seguintes parâmetros devem ser avaliados:

Força muscular

Função cognitiva

Condições emocionais

Disponibilidade e adequação de suporte familiar e social

Condições ambientais

Capacidade para executar as atividades da vida diária

Capacidade para executar as atividades instrumentais da vida diária.

Força muscular

Antes de iniciar a avaliação funcional, deve-se quantificar a força muscular, que pode ser a causa de alterações do equilíbrio, mobilidade e dificuldade para execução de atividades da vida diária:

Grau 0: nenhum movimento do músculo

Grau 1: esboço de contração muscular

Grau 2: movimento completo, mas não vence a força da gravidade

Grau 3: movimento completo que vence a força da gravidade

Grau 4: movimento que vence certa resistência imposta pelo examinador

Grau 5: força normal.

Equilíbrio e mobilidade. Podem-se avaliar a mobilidade e o equilíbrio do paciente por meio de um exame bastante simples conhecido como Teste do levantar e andar (*Get up and go test*) (Figura 9.2), indispensável naqueles que sofrem quedas com frequência. Durante a realização do teste, observa-se a base do paciente, se há instabilidade postural, o tipo de marcha e o tempo de execução do teste. Idosos normais levantam-se da cadeira, caminham 3 metros e voltam em 10 s. Um teste com 30 s ou mais de duração está relacionado com incapacidade moderada e alto risco de quedas.

Pode-se executar a *prova de Romberg* antes de o paciente caminhar (ver *Equilíbrio estático* no Capítulo 20, *Exame Neurológico*) e solicitar a ele que, de olhos abertos, sustente o peso de seu corpo primeiro nos calcanhares e, depois, na ponta dos pés. Avaliam-se, assim, o equilíbrio e a mobilidade do paciente.

Função cognitiva

As doenças que causam limitações da função cognitiva constituem um dos maiores problemas dos pacientes idosos, pois resultam em perda da autonomia e grande sobrecarga para os familiares e cuidadores.

Há vários testes para a avaliação da função mental dos idosos, com o objetivo de detectar alterações precoces e determinar a extensão das limitações em função do planejamento terapêutico. Alguns testes são extremamente complexos e demorados, cabendo a profissionais especializados aplicá-los; servem para esclarecer os casos duvidosos e determinar melhor o grau e a extensão da deficiência. No entanto, há testes simples e rápidos que duram 5 a 10 min e podem ser aplicados no consultório médico. O mais utilizado é o Miniexame do estado mental (ver Capítulo 20, *Exame Neurológico*).

A pontuação máxima é 30, sendo normal acima de 26 pontos. Valores abaixo de 24 indicam comprometimento cognitivo (demência) e valores entre 24 e 26 são considerados limítrofes.

É importante lembrar que os resultados são influenciados pela escolaridade do paciente. São necessários pelo menos 8 anos de escolaridade para que o teste tenha valor, pois um idoso com menos de 8 anos de escolaridade pode obter uma pontuação baixa apenas por não ter conhecimentos suficientes e não porque esteja com deterioração da função mental. Isso é um fator limitante no nosso meio, no qual o analfabetismo e a baixa escolaridade são muito prevalentes. Nesses casos, sugere-se o Questionário resumido do estado mental (Quadro 9.1).

Para cada resposta errada conta-se 1 ponto. O máximo são 10 pontos, e a avaliação é a seguinte:

0-2: estado mental intacto

3-4: dano intelectual leve

5-7: dano intelectual moderado

8-10: dano intelectual grave.

Quadro 9.1

Questionário resumido do estado mental (Pfeiffer, 1974).

	Certo	Errado
1. Que dia é hoje? (dia/mês/ano)		
2. Qual é o dia da semana?		

3. Qual é o nome deste lugar?		
4. Qual é o número do seu telefone? (Se não tiver telefone, qual é o seu endereço?)		
5. Quantos anos você tem?		
6. Qual é a sua data de nascimento?		
7. Quem é o atual presidente do seu país?		
8. Quem foi o presidente antes dele?		
9. Como é o nome de solteira de sua mãe?		
10. Subtraia 3 de 20 e continue subtraindo até o número final.		

Por se tratar de um teste muito simples, os casos indicativos de dano intelectual devem ser submetidos a uma avaliação mais aprofundada. É importante lembrar que, mesmo em teste simples como esse, há influências da escolaridade.

Condições emocionais

Os distúrbios do humor, a angústia, a ansiedade e o luto podem contribuir para a diminuição da capacidade funcional. Para isso, são necessárias uma boa relação médico-paciente e a disponibilidade do médico para observar as reações do seu paciente (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

A depressão merece atenção especial, por ser um problema muito prevalente entre os idosos e, na maioria das vezes, manifestar-se de maneira atípica, o que dificulta o diagnóstico. O idoso deprimido costuma apresentar mais alterações de memória, fadiga crônica, perda do interesse pelas atividades habituais, irritabilidade, afastamento social e somatização do que as queixas clássicas de depressão representadas por tristeza, choro fácil, pessimismo, desesperança e desejo suicida. Por isso, é importante pesquisar depressão em todos os pacientes idosos, e um dos instrumentos mais utilizados é a Escala de depressão geriátrica de Yessavage (Quadro 9.2).

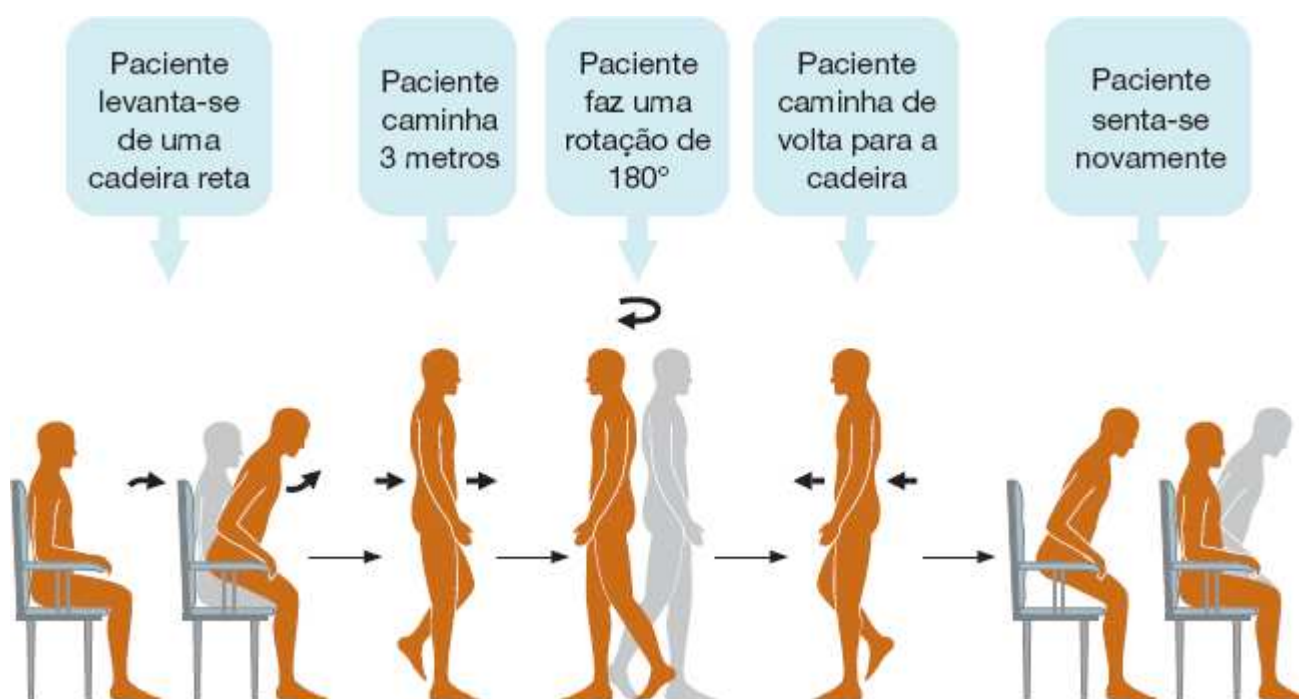


Figura 9.2 Teste do levantar e andar.

- A avaliação é feita da seguinte maneira:
Verifica-se a resposta de cada pergunta
Os pontos das duas colunas são somados
Compara-se com a seguinte escala de valores:
- Até 5: *normal*
 - 7 ou mais: *depressão*
 - 11 ou mais: *depressão grave*.

Disponibilidade e adequação de suporte familiar e social

A falta de suporte e de adequação do idoso à vida familiar e social é um dos fatores que contribuem negativamente para as suas condições de saúde e seu estado funcional. Cabe ao médico avaliar esses parâmetros por meio de perguntas direcionadas tanto ao paciente como aos familiares. É importante indagar:

- O paciente sente-se satisfeito e pode contar com familiares para ajudá-lo a resolver seus problemas?
- O paciente participa da vida familiar e oferece seu apoio quando os outros membros têm problemas?
- Há conflitos entre as gerações que compõem a família?
- As opiniões emitidas pelo paciente são acatadas e respeitadas pelos membros do núcleo familiar?
- O paciente aceita e respeita as opiniões dos demais membros da família?
- O paciente participa da vida comunitária e da sociedade em que vive?
- O paciente tem amigos e pode contar com eles nos momentos difíceis?
- O paciente apoia os seus amigos quando eles têm problemas?

Um grave problema relaciona-se aos “maus-tratos” infligidos por familiares ou outras pessoas da sua convivência. Trata-se de uma questão complexa, que contribui para o agravamento das condições clínicas do paciente, e, em muitos países, inclusive no Brasil, pode configurar crime. O médico tem a obrigação de reconhecer os tipos de maus-tratos (Quadro 9.3), quais situações sugerem que o paciente está sendo vítima dessa síndrome (Quadro 9.4) e os fatores de risco (Quadro 9.5).

Condições ambientais

A residência do paciente deve ser visitada, ou pelo menos algumas informações de como ele vive devem ser obtidas. Ambientes inadequados contribuem para diminuição da capacidade funcional do idoso. É necessário avaliar a possibilidade de introduzir modificações que podem tornar a casa mais conveniente às limitações do paciente, procurando garantir para ele o máximo de autonomia possível. Como exemplo, pode-se lembrar o fato de que um paciente com comprometimento motor pode não usar o vaso sanitário por não conseguir sentar-se e levantar-se (a simples elevação do assento resolve o problema); ou o de que um paciente cai com frequência e se torna cada vez mais dependente porque as escadas e o piso de sua residência são inadequados (basta eliminar esses problemas para melhorar o seu estado funcional).

Quadro 9.2 Escala de depressão geriátrica de Yessavage.		
	Sim	Não
1. Em geral, você está satisfeito com sua vida?	0	1
2. Você abandonou várias de suas atividades ou interesses?	1	0
3. Você sente que sua vida está vazia?	1	0
4. Você se sente aborrecido(a) com frequência?	1	0

5. Você está de bom humor durante a maior parte do tempo?	0	1
6. Você teme que algo de ruim aconteça com você?	1	0
7. Você se sente feliz durante a maior parte do tempo?	0	1
8. Você se sente desamparado(a) com frequência?	1	0
9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?	1	0
10. Você acha que apresenta mais problemas com a memória do que antes?	1	0
11. Atualmente, você acha maravilhoso estar vivo(a)?	0	1
12. Você se considera inútil da forma em que se encontra agora?	1	0
13. Você se sente cheio de energia?	0	1
14. Você considera a situação em que se encontra sem esperança?	1	0
15. Você considera que a maioria das pessoas está melhor do que você?	1	0

Quadro 9.3

Tipos de maus-tratos.

Abuso físico

Tapas, beliscões, contusões, queimaduras, contenção física

Abuso psíquico

Insultos, humilhações, tratamento infantilizado e amedrontador

Abuso material

Apropriação indevida de proventos, de dinheiro, bens e propriedades

Abuso sexual

Contato sexual de qualquer tipo, sem consentimento

Negligência

Não fornecer os cuidados de que a pessoa necessita

Quadro 9.4

Situações que sugerem maus-tratos.

Lesões físicas (contusões, lacerações, hematomas, feridas cortantes, queimaduras, fraturas inexplicáveis)

Descuido com a higiene

Desidratação e desnutrição difíceis de serem explicadas

Explicações vagas de ambas as partes

Diferenças entre a história contada pelo paciente e a contada pelo familiar ou cuidador

Demora entre o aparecimento dos sintomas ou da lesão e a solicitação de atendimento médico

Visitas frequentes ao médico em razão da piora de uma doença crônica apesar de tratamento correto

Quadro 9.5

Fatores de risco para maus-tratos em idosos.

Do idoso

Doença e diminuição da capacidade funcional (fragilidade), alteração cognitiva, transtorno de comportamento, incontinência, transtorno do sono

Do cuidador

Toxicodependência, alcoolismo, transtorno mental, dependência material em relação à vítima, ignorância e incapacidade, sobrecarga

Do ambiente

Carência de recursos, isolamento social, ambiente violento

Capacidade para executar as atividades da vida diária

Englobam todas as tarefas que uma pessoa precisa realizar para cuidar de si própria. A incapacidade de executar essas tarefas implica alto grau de dependência (Quadro 9.6).

Quadro 9.6

Atividades da vida diária.

Cuidados

Comer, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro

Mobilidade

Deambulação com ou sem ajuda, transferência da cama para a cadeira, mobilidade na cama

Continência urinária, fecal

Utilizam-se escalas para avaliar as AVD; embora existam inúmeras, nenhuma é completa. A escala de Barthel é de fácil aplicação e permite uma ampla graduação, entre máxima dependência (0 ponto) e máxima independência (100 pontos). Pacientes com pontuação abaixo de 70 necessitam de supervisão (Quadro 9.7).

Capacidade para executar as atividades instrumentais da vida diária

Compreendem a habilidade do idoso para administrar o ambiente em que vive, incluindo procurar e preparar comida, lavar as roupas, cuidar da casa, movimentar-se fora de casa para fazer compras, ir ao médico e comparecer aos compromissos sociais.

Quadro 9.7 Escala de Barthel.	
Pontuação	Atividade
Alimentação	
10 pontos	Independente – Ser capaz de usar qualquer talher; comer em tempo razoável.
0 pontos	Ajuda – Necessitar de ajuda para cortar, passar manteiga etc.
0 ponto	Dependente
Banho	
5 pontos	Independente – Ser capaz de lavar-se por completo sem ajuda; entrar e sair da banheira.
0 ponto	Dependente
Vestuário	
10 pontos	Independente – Vestir-se, despir-se e arrumar a roupa sem ajuda; amarrar os sapatos.
5 pontos	Ajuda – Necessitar de ajuda, mas realizar pelo menos metade das tarefas em tempo razoável.
0 ponto	Dependente
Higiene pessoal	
5 pontos	Independente – Ser capaz de lavar o rosto e as mãos, escovar os dentes, barbear-se e usar a tomada sem problemas.
0 ponto	Dependente
Evacuações	
10 pontos	Continente – Não apresentar episódios de incontinência. Ser capaz de colocar, sozinho, enemas e supositórios.
5 pontos	Incontinente ocasional – Apresentar episódios ocasionais de incontinência ou necessitar de ajuda para a aplicação de enemas ou supositórios.
Micção	

10 pontos	Continente – Não apresentar episódios de incontinência. Tomar suas próprias providências quando faz uso de sondas ou de outro dispositivo.
5 pontos	Incontinente ocasional – Apresentar episódios de incontinência ou necessitar de ajuda para o uso de sonda ou outro dispositivo.
0 ponto	Incontinente
Uso do vaso sanitário	
10 pontos	Independente – Ser capaz de usar o vaso ou o urinol; sentar-se e levantar-se sem ajuda, mesmo usando barras de apoio; limpar-se e vestir-se sem ajuda.
5 pontos	Ajuda – Necessitar de ajuda para manter o equilíbrio, limpar-se e vestir-se.
0 ponto	Dependente
Passagem cadeira-cama	
15 pontos	Independente – Não necessitar de ajuda. Ser capaz de fazer tudo sozinho, se utiliza cadeira de rodas.
10 pontos	Ajuda mínima – Necessitar de pequena ajuda ou supervisão.
5 pontos	Grande ajuda – Ser capaz de sentar-se, mas necessitar de ajuda total para a mudança para a cama.
0 ponto	Dependente
Deambulação	
15 pontos	Independente – Ser capaz de caminhar pelo menos 50 metros, mesmo com bengalas, muletas, prótese ou andador.
10 pontos	Ajuda – Ser capaz de caminhar pelo menos 50 metros, mas necessitar de ajuda ou supervisão.
5 pontos	Independente em cadeiras de rodas – Ser capaz de movimentar-se na sua cadeira de rodas por pelo menos 50 metros.
0 ponto	Dependente
Escadas	
10 pontos	Independente – Ser capaz de subir ou descer escadas sem ajuda ou supervisão, mesmo com muletas ou bengalas.

5 pontos	Ajuda – Necessitar de ajuda física ou de supervisão.
0 ponto	Dependente
Total de pontos	
Marcar com um “x” se o paciente é independente, necessita de ajuda ou é dependente e somar os pontos. Atividades para as quais é totalmente dependente:	

Na avaliação das AIVD, é importante a informação de familiares e cuidadores, pois, além de determinar se o paciente é ou não capaz de executar tais tarefas, é preciso estabelecer o grau de supervisão ou ajuda de que ele necessita quando for incapaz de executá-las sozinho (Quadro 9.8).

Sugerimos utilizar para esta avaliação a escala de Lawton, por ser de fácil aplicabilidade, variando de 8 pontos (total incapacidade para AIVD) até 24 pontos (total independência para AIVD) (Quadro 9.9).

Quadro 9.8

Atividades instrumentais da vida diária.

Dentro de casa

Preparar a comida, fazer o exercício doméstico, lavar e cuidar do vestuário, executar trabalhos manuais, manusear a medicação, usar o telefone

Fora de casa

Manusear dinheiro, fazer comprar (alimentos, roupas), usar os meios de transporte, deslocar-se (ir ao médico, compromissos sociais e religiosos)

Objetivo principal da avaliação funcional do idoso

O principal objetivo da avaliação funcional do idoso (Figura 9.3) é identificar as limitações e incapacidades que ele apresenta, quantificá-las e, com isso, identificar os idosos de alto risco para se estabelecerem medidas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras.

A diminuição da reserva funcional do processo de envelhecimento torna o idoso mais vulnerável às agressões; entretanto, alguns idosos são muito mais vulneráveis que outros e sujeitos a desfechos desfavoráveis como quedas, declínio funcional (diminuição da capacidade para executar as atividades da vida diária), iatrogenias, alterações da função mental, hospitalizações e morte. Convém ter em mente que as condições que aumentam a vulnerabilidade de idosos podem se sobrepor. É importante que o médico identifique esses idosos vulneráveis e atue em conjunto com a equipe multiprofissional para minimizar seus riscos (Figura 9.4).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar o exame clínico de uma pessoa, quase sempre conseguimos identificar mais de uma doença, além de aventarmos a possibilidade de várias outras. Isto porque o surgimento de múltiplas enfermidades faz parte do envelhecimento. Todas podem ter importância para se cuidar bem de uma pessoa idosa, mas, do ponto de vista prático, deve-se fazer três perguntas: (1) o que mais o incomoda?; (2) o que está interferindo em sua capacidade funcional?; (3) o que põe em risco sua vida?

Este é um bom ponto de partida para a escolha dos exames complementares, quase sempre necessários, e para a definição da proposta terapêutica.

As três perguntas não são excludentes; pelo contrário, elas se completam. Ao respondê-las, o médico terá elementos para planejar suas ações, não sendo omissos, nem exagerando, ao solicitar exames ou prescrever medicamentos, ou seja, vai encontrar o ponto de equilíbrio na difícil tarefa de cuidar de pessoas idosas.

A implantação da Caderneta de Saúde do Idoso na Atenção Primária poderá ser um instrumento de grande utilidade para

bem cuidar destas pessoas.

Quadro 9.9 Escala de Lawton.		
Atividade	Pontuação de cada item	Pontos do paciente
Preparo das refeições		
Ser capaz de organizar e preparar as refeições sem ajuda ou supervisão	3	
Necessitar de ajuda ou supervisão para organizar e/ou preparar as refeições	2	
Ser completamente incapaz de organizar e/ou preparar refeições	1	
Tarefas domésticas		
Ser capaz de realizar sozinho todo o trabalho doméstico, mesmo os mais pesados (esfregar o chão, limpar banheiros)	3	
Ser capaz de realizar apenas o trabalho doméstico leve (lavar louça, fazer a cama)	2	
Ser incapaz de realizar qualquer trabalho doméstico	1	
Lavar a roupa		
Ser capaz de lavar toda a sua roupa sem ajuda ou supervisão	3	
Ser capaz de lavar apenas peças pequenas	2	
Ser incapaz de lavar qualquer peça de roupa	1	
Manuseio da medicação		
Ser capaz de tomar toda e qualquer medicação na hora e nas doses corretas sem supervisão	3	
Necessitar de lembretes e de supervisão para tomar a medicação nos horários e nas doses corretas	2	
Ser incapaz de tomar a medicação	1	
Capacidade para usar o telefone		
Ser capaz de utilizar o telefone por iniciativa própria	3	

Ser capaz de responder as ligações, porém, com ajuda ou aparelho especial para discar	2	
Ser completamente incapaz para o uso do telefone	1	
Manuseio de dinheiro		
Ser capaz de administrar seus assuntos econômicos, pagar contas, manusear dinheiro, preencher cheques	3	
Ser capaz de administrar seus assuntos econômicos, porém, necessitar de ajuda para lidar com cheques e pagamentos de contas	2	
Ser incapaz de lidar com dinheiro	1	
Compras		
Ser capaz de realizar todas as compras necessárias sem ajuda ou supervisão	3	
Necessitar de supervisão para fazer compras	2	
Ser completamente incapaz de fazer compras, mesmo com supervisão	1	
Uso de meio de transporte		
Ser capaz de dirigir carros ou viajar sozinho de ônibus, trem, metrô e táxi	3	
Necessitar de ajuda e/ou supervisão quando viajar de ônibus, trem, metrô e táxi	2	
Ser incapaz de utilizar qualquer meio de transporte	1	
Total de pontos		
Atividades para as quais é totalmente dependente:		

Idoso frágil e já portador de incapacidades

Idosos de risco: viúvos, que moram sozinhos, portadores de múltiplas doenças crônicas, muito velhos (> 85 anos)

Idoso no qual se detectou um novo fator de risco (p. ex., etilismo)

Idoso com um ou mais dos “gigantes da geriatria”: depressão, distúrbio cognitivo, quedas, imobilidade, incontinência

Idoso no qual se detectou deterioração nas condições de saúde ou novas alterações nos exames complementares (p. ex., fratura vertebral na radiografia de coluna)

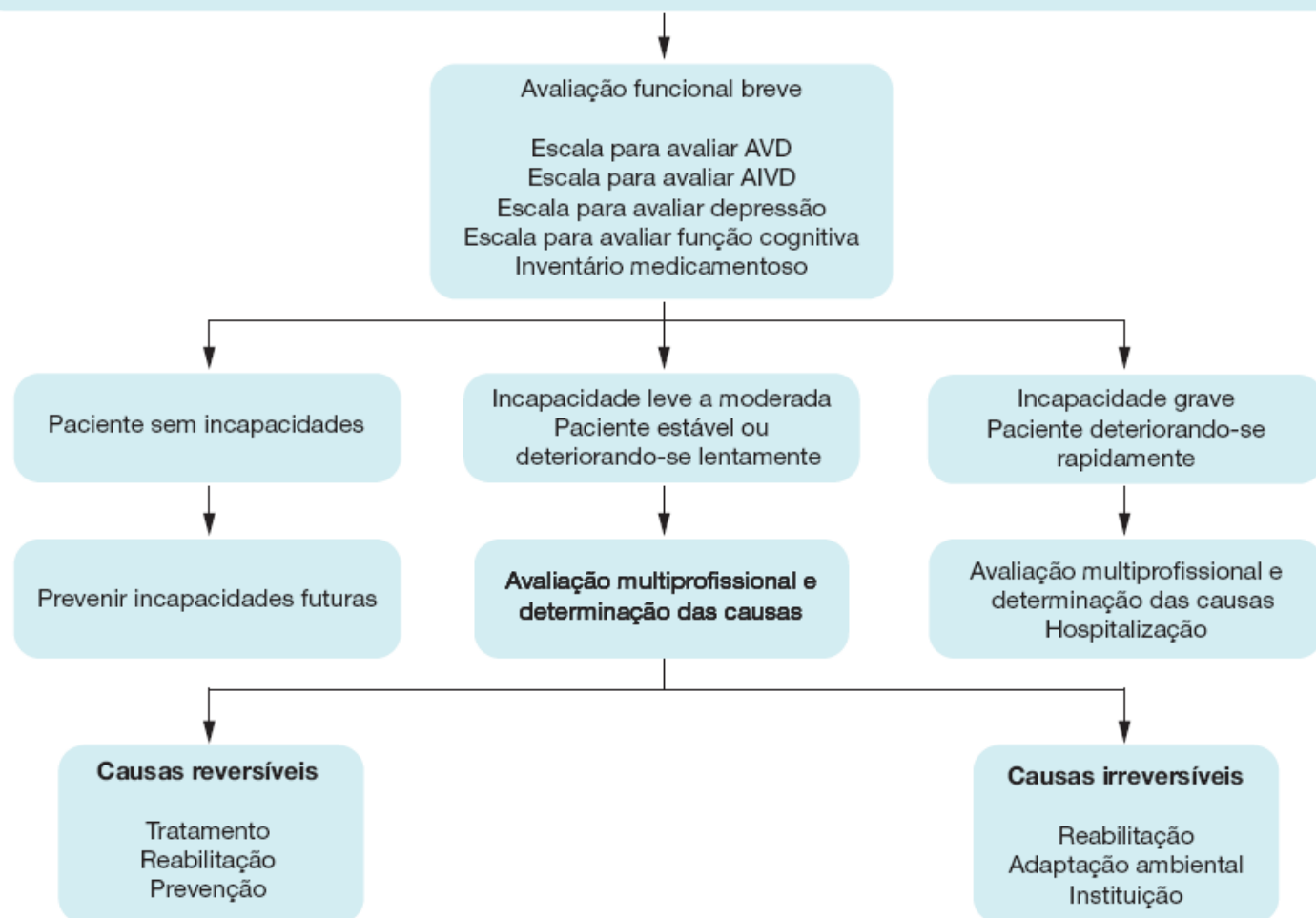


Figura 9.3 Avaliação funcional do idoso. (Adaptada de Rubenstein e Rubenstein, 1998.)

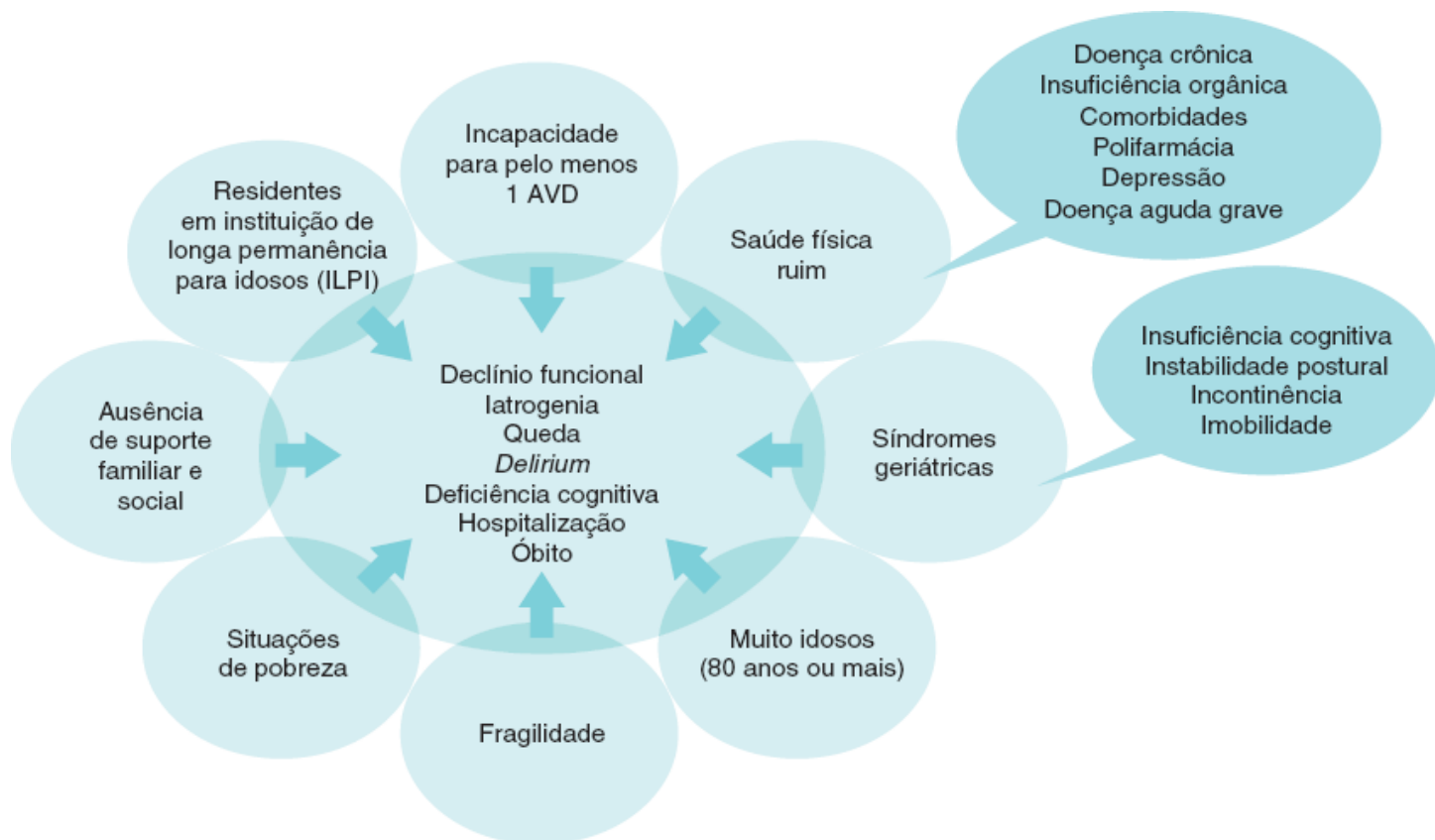


Figura 9.4 Identificação do idoso vulnerável.

Roteiro pedagógico para exame clínico do idoso e avaliação geriátrica ampla

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente

Nome: Idade: Sexo: Religião:

Escolaridade: Situação conjugal: Ocupação: Renda:

Local residência: Companhia residência: Cuidador/tipo:

Dados antropométricos

Peso: kg Altura: m IMC: kg/m²

Circunferência abdominal: cm Circunferência da panturrilha: cm

Circunferência do braço: cm Altura do joelho: cm

Dobra cutânea subescapular: cm

Sinais vitais

Frequência cardíaca: bpm Frequência respiratória: ipm

Temperatura: °C PA deitado: mmHg Sentado: mmHg De pé: mmHg

Pulsos periféricos:

Mobilidade

Acamado: () Sim () Não

Cadeira de roda: () Sim () Não

Faz transferência: () Sim () Não

Instrumento auxiliar de marcha: () Sim () Não Qual?

Postura:

Marcha:

Exame físico geral

Estado geral:

Hidratação:

Pele e mucosas:

Úlceras por pressão: () Sim () Não Estádio: Sinais de infecção: () Sim () Não

Cabeça e pescoço

Fácies:

Orofaringe:

Dentes:

Otoscopia:

Pescoço e carótidas:

Exame do tórax

Ectoscopia:

Ausculta pulmonar:

Ausculta cardíaca:

Exame do abdome

Ectoscopia:

Palpação:

Ausculta:

Toque retal:

Exames dos membros

Ectoscopia:

Tremores: () Sim () Não Descrever:

Edema: () Sim () Não Localização: Intensidade:

Rigidez: () Sim () Não Localização: Intensidade:

Mobilidade articular:

Deformidades:

Exame neurológico

Consciência:

Orientação:

Pares cranianos:

Reflexos (cutaneoabdominais, patelares, aquileus e cutaneoplantares):

Sensibilidade:

Motricidade e tônus muscular:

Observações:

Avaliação geriátrica ampla

1. Estado funcional

Escore do paciente

Interpretação

1.1 Equilíbrio e mobilidade

Risco baixo de quedas

☐

Risco aumentado de quedas

☐

“Teste do levantar e andar” (GUG)

1. Normal

☐

2. Anormalidade leve

☐

3. Anormalidade média

☐

4. Anormalidade moderada

☐

5. Anormalidade grave

☐

1.2 Atividades Básicas de Vida Diária

Independente

☐

Dependente

☐

Escala de Barthel para avaliação funcional

< 20 – Dependência total

☐

20 a 35 – Dependência grave

☐

40 a 55 – Dependência moderada

☐

	60 a 95 – Dependência leve	☐
	= 100 – Independente	☐
Atividades instrumentais de vida diária	Independente	☐
	Dependente	☐
Questionário de Pfeffer para atividades funcionais	< 6 pontos – Normal	☐
	≥ 6 pontos – Comprometido	☐
2. Cognição	Normal	☐
	Déficit	☐
Miniexame do estado mental	Pontuação normal para escolaridade	☐
	Pontuação alterada para escolaridade	☐
Fluência verbal (categoria semântica)	Pontuação normal para escolaridade	☐
	Pontuação diminuída para escolaridade	☐
3. Humor	Normal	☐
	Alterado	☐
Escala de depressão geriátrica de Yesavage (versão 15 itens)	≤ 5 pontos – Normal	☐
	≥ 7 pontos – Depressão	☐
	≥ 11 pontos – Depressão moderada a grave	☐
4. Estado nutricional	Ausência de risco nutricional	☐
	Presença de risco nutricional	☐
Miniavaliação nutricional de Guigóz	< 17 pontos – Desnutrido	☐

		17 a 23,5 pontos – Risco de desnutrição	☐
		≥ 24 pontos – Nutrido	☐
5. Suporte social: Apgar da família e dos amigos		< 3 pontos – Acentuada disfunção	☐
		4-6 pontos – Moderada disfunção	☐
		> 6 pontos – Leve disfunção	☐
6. Outras avaliações			
7. Outras informações	Número de quedas no último ano:	Atividade física:	
	Órtese:	Prótese:	
8. Observações			

Capítulo 10



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Exame Físico Geral

Fábia Maria Oliveira Pinho

Rita Francis Gonzalez y Rodrigues Branco

Paulo Sérgio Sucasas da Costa

Érika Aparecida da Silveira

Marianne de Oliveira Falco

Delson José da Silva

Arnaldo Lemos Porto

Celmo Celeno Porto

- Introdução
- Semiotécnica
- Roteiro pedagógico para exame físico geral
- Roteiro pedagógico para avaliação nutricional

INTRODUÇÃO

Terminada a anamnese, inicia-se o exame físico; contudo o examinador deve continuar suas indagações, complementando pontos não muito bem esclarecidos durante a anamnese. O contrário também ocorre, ou seja, começa-se o exame físico tão logo se encontra com o paciente, observando-o cuidadosamente. Em outras palavras: não pode haver uma rígida separação entre a anamnese e o exame físico.

O exame físico pode ser dividido em duas etapas: a primeira constitui o que se costuma designar *exame físico geral*, *somatoscopia* ou *ectoscopia*, por meio do qual são obtidos dados gerais, independentemente dos vários sistemas orgânicos ou segmentos corporais, o que possibilita uma visão do paciente como um todo; a segunda etapa corresponde ao exame dos diferentes sistemas ou segmentos corporais, com metodologia própria, a qual será estudada em capítulos subsequentes.

Boxe

Preliminares para um adequado exame físico: *local adequado, iluminação correta e posição do paciente*. Além disso, a parte a ser examinada deve estar descoberta, sempre se respeitando o pudor do paciente (ver Capítulo 5, *Técnicas Básicas do Exame Físico*).

SEMIOTÉCNICA

O paciente deve ser examinado nas posições de decúbito, sentada, de pé e andando.

Para conforto do paciente a melhor sequência é: primeiro, deve-se examiná-lo sentado na beira do leito ou da mesa de exame, a menos que ele seja incapaz de permanecer nessa posição. O examinador deve ficar de pé, em frente ao paciente, deslocando-se para os dois lados, conforme necessário. Todavia, pode-se iniciar o exame com o paciente deitado, caso essa posição seja mais confortável para ele.

Algumas etapas do exame físico exigem que o paciente fique em outras posições, inclusive de pé ou andando.

Boxe

O exame físico geral inclui:

- Avaliação do estado geral
- Avaliação do nível de consciência
- Fala e linguagem
- Avaliação do estado de hidratação
- Altura e outras medidas antropométricas
- Avaliação do estado nutricional
- Desenvolvimento físico
- Fácies
- Atitude e decúbito preferido no leito
- Mucosas
- Pele, fâneros (ver Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*)
- Tecido celular subcutâneo e panículo adiposo (ver Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*)
- Musculatura
- Movimentos involuntários
- Enfisema subcutâneo
- Exame dos linfonodos (ver Capítulo 12, *Exame dos Linfonodos*)
- Veias superficiais (ver Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*)
- Circulação colateral
- Edema

Temperatura corporal
Postura ou atitude na posição de pé
Biotipo ou tipo morfológico
Marcha.

Avaliação do estado geral

É uma avaliação subjetiva com base no conjunto de dados exibidos pelo paciente e interpretados de acordo com a experiência de cada um.

Para descrever a impressão obtida, usa-se a seguinte nomenclatura:

Estado geral bom
Estado geral regular
Estado geral ruim.

A avaliação do estado geral tem utilidade prática, principalmente para se compreender até que ponto a doença comprometeu o organismo, visto como um todo.

Serve ainda de alerta para o médico nos casos com escassos sinais ou sintomas indicativos de uma determinada enfermidade, obrigando-o a aprofundar sua investigação diagnóstica na busca de uma afecção que justifique a deterioração do estado geral.

Situação inversa também pode ocorrer, ou seja, a manutenção de um estado geral bom, na presença de uma doença sabidamente grave. Isso indica uma boa capacidade de reação do organismo que tem, inclusive, valor prognóstico.

Avaliação do nível de consciência

A avaliação do nível de consciência e do estado mental implica dois aspectos da mesma questão: a avaliação neurológica e a psiquiátrica.

A percepção consciente do mundo exterior e de si mesmo caracteriza o estado de vigília, que é resultante da atividade de diversas áreas cerebrais coordenadas pelo sistema reticular ativador ascendente.

Entre o estado de vigília ou plena consciência e o estado comatoso, no qual o paciente perde completamente a capacidade de identificar seu mundo interior e os acontecimentos do meio que o circunda, é possível distinguir diversas fases intermediárias em uma graduação cujo principal indicador é o *nível de consciência*. Quando a consciência é comprometida de modo pouco intenso, mas seu estado de alerta é moderadamente comprometido, chama-se *obnubilação*. Na *sonolência*, o paciente é facilmente despertado, responde mais ou menos apropriadamente e volta logo a dormir. A *confusão mental* configura-se por perda de atenção, o pensamento não é claro, as respostas são lentas e não há percepção normal do ponto de vista temporoespacial, podendo surgir alucinações, ilusão e agitação. Se a alteração de consciência for mais pronunciada, mas o paciente ainda for despertado por estímulos mais fortes, tiver movimentos espontâneos e não abrir os olhos, caracteriza-se o *torpor* ou *estupor*. Se não há despertar com estimulação forte, e o paciente está sem movimentos espontâneos, caracteriza-se o estado de *coma*.

Atualmente, usa-se a escala de coma de Glasgow (EG) para se avaliar alterações do nível de consciência. Tal avaliação consiste na análise de três parâmetros: abertura ocular, reação motora e resposta verbal, obtidos por vários estímulos, desde a atividade espontânea e estímulos verbais até estímulos dolorosos (Quadro 10.1). (Ver Capítulo 20, *Exame Neurológico*.)

Quadro 10.1

Escala de coma de Glasgow.

Parâmetro	Resposta observada	Escore
Abertura ocular	Abertura espontânea	4
	Estímulos verbais	3
	Estímulos dolorosos	2
	Ausente	1

Melhor resposta verbal	Orientado	5
	Confuso	4
	Palavras inapropriadas	3
	Sons ininteligíveis	2
	Ausente	1
Melhor resposta	Obedece a comandos verbais	6
	Localiza estímulos	5
	Retirada inespecífica	4
	Padrão flexor	3
	Padrão extensor	2
	Ausente	1

Pontuação de 3 a 15. Interpretação: 3 – coma profundo (vegetativo); 4 – coma profundo; 7 – coma intermediário; 11 – coma superficial; 15 – normalidade.

Fala e linguagem

Durante a entrevista, o examinador deve prestar atenção à linguagem do paciente, particularmente na linguagem falada (fala).

A fala depende de mecanismos bastante complexos que compreendem o órgão fonador (laringe), os músculos da fonação e a elaboração cerebral (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

As alterações da fala classificam-se da seguinte maneira:

Disfonia ou afonia: é uma alteração do timbre da voz causada por algum problema no órgão fonador. A voz pode tornar-se rouca, fanhosa ou bitonal

Dislalia: é o termo que se usa para designar alterações menores da fala, comuns em crianças, como a troca de letras (“tasa” por “casa”). Uma forma especial é a *disritmolalia*, que compreende distúrbios no ritmo da fala, tais como a gagueira e a taquilalia

Disartria: decorre de alterações nos músculos da fonação, incoordenação cerebral (voz arrastada, escandida), hipertonia no parkinsonismo (voz baixa, monótona e lenta) ou perda do controle piramidal (paralisia pseudobulbar)

Disfasia: aparece com completa normalidade do órgão fonador e dos músculos da fonação e depende de uma perturbação na elaboração cortical da fala. Há diversos graus de disfasia, desde alterações mínimas até perda total da fala. A disfasia pode ser de recepção ou sensorial (o paciente não entende o que se diz a ele), ou de expressão ou motora (o paciente entende, mas não consegue se expressar), ou ainda do tipo misto, que é, aliás, o mais frequente. A disfasia traduz lesão do hemisfério dominante: o esquerdo no destro, e vice-versa, mas não chega a ter valor localizatório muito preciso

Outros distúrbios: deve-se ter em mente ainda outros distúrbios, como, por exemplo, o *retardo do desenvolvimento da fala* na criança, que pode indicar alguma anormalidade neurológica. Cite-se, por fim, a *disgrafia* (perda da capacidade de escrever) e a *dislexia* (perda da capacidade de ler).

Avaliação do estado de hidratação

O estado de hidratação do paciente é avaliado tendo-se em conta os seguintes parâmetros:

- Alteração abrupta do peso
- Alterações da pele quanto à umidade, à elasticidade e ao turgor
- Alterações das mucosas quanto à umidade
- Alterações oculares
- Estado geral
- Fontanelas (no caso de crianças).

Um paciente estará normalmente hidratado quando a oferta de líquidos e eletrólitos estiver de acordo com as necessidades do organismo e quando não houver perdas extras (diarreia, vômitos, febre, taquipneia, sudorese excessiva) sem reposição adequada.

Estado de hidratação normal

Em pessoas de cor branca, a pele é rósea com boa elasticidade e com leve grau de umidade, as mucosas são úmidas, não há alterações oculares nem perda abrupta de peso.

No caso de crianças, as fontanelas são planas e normotensas, e o peso mantém curva ascendente, a criança se apresenta alegre e comunicativa, bem como sorri facilmente.

Desidratação, como o próprio nome indica, é a diminuição de água e eletrólitos totais do organismo, caracterizando-se pelos seguintes elementos:

- Sede
- Diminuição abrupta do peso
- Pele seca, com elasticidade e turgor diminuídos
- Mucosas secas
- Olhos afundados (enftalmia) e hipotônicos
- Estado geral comprometido
- Excitação psíquica ou abatimento
- Oligúria
- Fontanelas deprimidas no caso de crianças.

Todas as alterações enumeradas variam de acordo com o grau de desidratação (Figura 10.1).

A desidratação pode ser classificada segundo dois aspectos: a intensidade e a osmolaridade.

A classificação de acordo com a intensidade baseia-se na perda de peso:

Leve ou de 1º grau: perda de peso de até 5%

Moderada ou de 2º grau: perda de peso de 5 a 10%

Grave ou de 3º grau: perda de peso acima de 10%.

Para se classificar a desidratação quanto à osmolaridade, característica útil para reposição de água e eletrólitos, toma-se como elemento-guia o nível sanguíneo de sódio. Assim (Quadro 10.2):

Isotônica: quando o sódio está nos limites normais (130 a 150 mEq/l)

Hipotônica: quando o sódio está baixo (< 130 mEq/l)

Hipertônica: quando o sódio está acima dos limites normais (> 150 mEq/l).

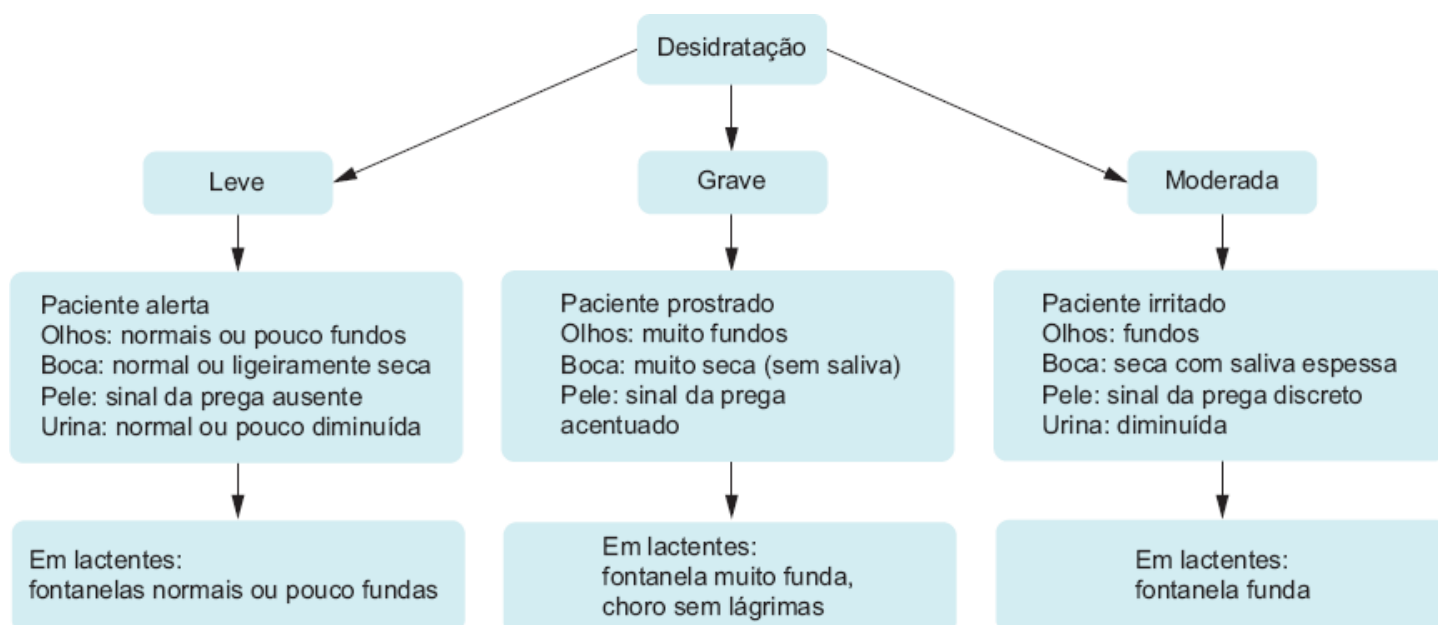


Figura 10.1 Sinais e sintomas da desidratação.

Boxe

Síndrome de desidratação: oferta deficiente ou perda excessiva

A falta de oferta é importante em recém-nascidos cujas mães não são devidamente orientadas e para os idosos que geralmente não ingerem água em quantidade suficiente.

O excesso de perdas quase sempre se relaciona com diarreia, vômitos e febre.

Em crianças assume importância especial a diarreia, cujas causas podem ser agrupadas da seguinte maneira:

- Diarreia de causa neuropsicomotora (incluindo reflexo gastrocólico exaltado e diarreia por transtorno emocional)
- Diarreia por infecção enteral (vírus, colibacilos, shigelas e salmonelas) e parenteral (otite média)
- Diarreia por enteroparasitoses (amebíase, giardíase e estrongiloidíase)
- Diarreia por perturbações primárias da digestão e/ou absorção (intolerância a dissacarídeos, monossacarídeos e glúten).

Quadro 10.2
Sinais e sintomas da desidratação isotônica, hipotônica e hipertônica.

Parâmetros	Isotônica (perda de água proporcionalmente igual à de sal)	Hipertônica (perda de água proporcionalmente maior que a de sal)	Hipotônica (perda de água proporcionalmente menor que a de sal)
Pele Cor Temperatura Turgor Umidade e textura	Pálida Normal ou elevada Diminuído Seca	Pálida Elevada Regular Engrossada	Acinzentada Baixa Muito diminuído Viscosa
Mucosas	Secas	Muito secas	Viscosas
Fontanelas	Deprimidas	Deprimidas	Deprimidas
Globo ocular	Afundado	Afundado	Afundado
Psiquismo	Apatia	Agitação, hiperirritabilidade	Coma
Sede	Intensa	Muito intensa	Discreta ou ausente
Pulso	Rápido	Ligeiramente alterado	Acelerado
Pressão arterial	Baixa	Normal	Muito baixa

Avaliação antropométrica

Existem várias medidas antropométricas de utilidade prática, incluindo altura ou estatura, peso, circunferências, dobras cutâneas e índices como o índice de massa corporal (IMC).

Altura/estatura

A altura ou estatura expressa o crescimento linear. Existem diferentes formas para determinar a altura ou métodos para estimá-la em pacientes em condições especiais.

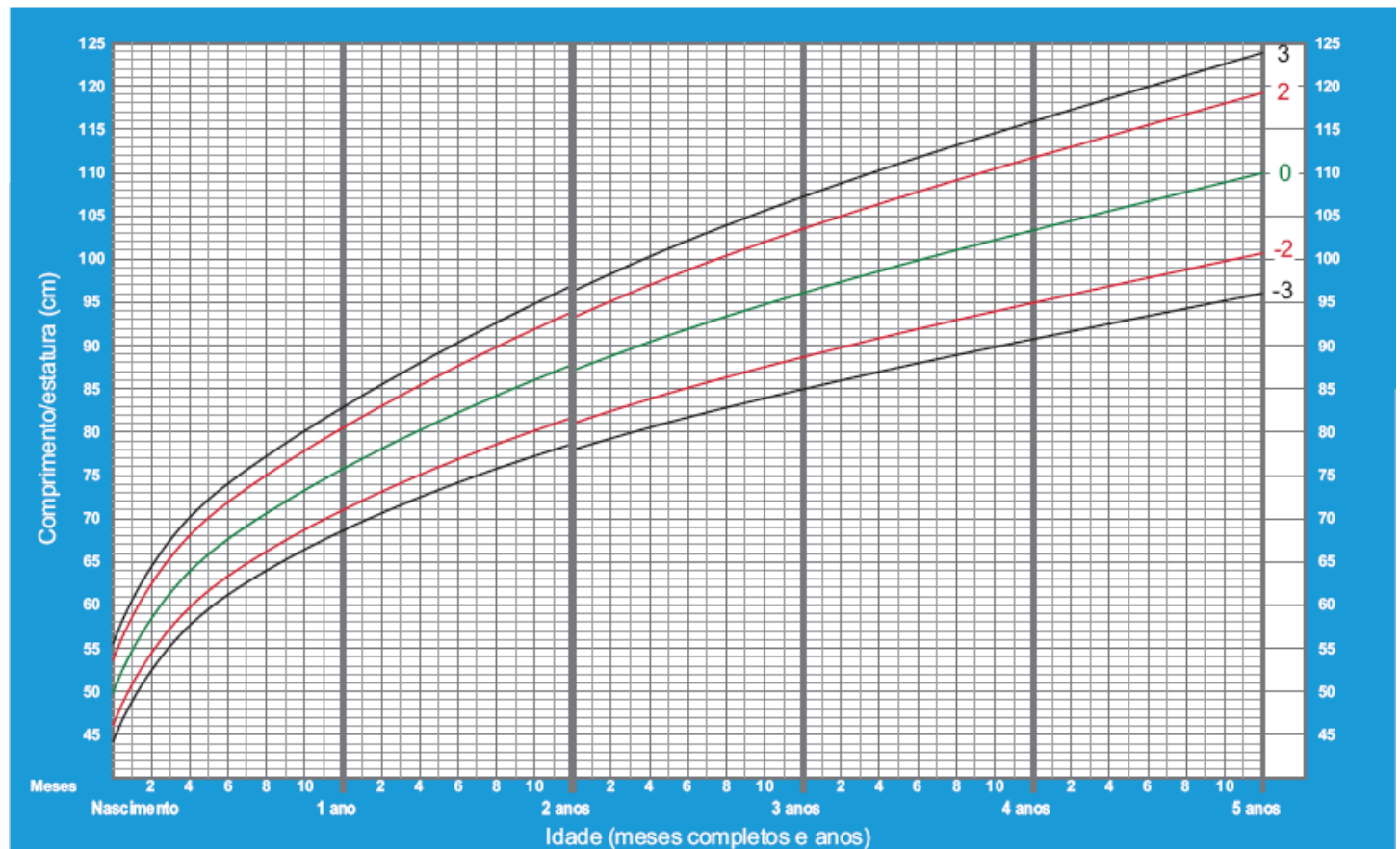
Quando o paciente é capaz de ficar em posição ortostática, a altura é aferida em balança com estadiômetro ou com fita métrica inextensível com precisão de 0,1 cm, afixada em superfície lisa, vertical e sem rodapé. Para uma medida precisa é importante que cinco pontos anatômicos estejam próximos à parede ou ao estadiômetro: calcanhares, panturrilha, glúteos, escápulas e ombros. Os joelhos devem estar esticados, os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. A cabeça deve estar erguida, formando um ângulo de 90° com o solo, e os olhos mirando um plano horizontal à frente. Em seguida, o estadiômetro é baixado até que encoste na cabeça, com pressão suficiente para comprimir o cabelo. (O cabelo não pode estar preso por tiaras ou outros adornos, pois podem comprometer a acurácia da medida.)

Em crianças até 2 anos de idade, recomenda-se medir a altura (comprimento) com ela deitada, utilizando uma régua antropométrica que possui uma base fixa no zero e um cursor. Após essa faixa etária, mede-se a altura (estatura) da criança em pé, comparado-se a altura obtida com tabelas pediátricas para a idade e sexo (Figuras 10.2 a 10.5).

Nos primeiros anos de vida é muito importante verificar se a criança está atingindo o padrão de crescimento esperado para idade e sexo. Deve-se marcar o ponto na curva de crescimento que existe na *caderneta de saúde da criança*, que está disponível no *site* do Ministério da Saúde e também nas unidades de saúde do SUS e nas maternidades (Quadros 10.3 e 10.4).

Comprimento/estatura por idade MENINOS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

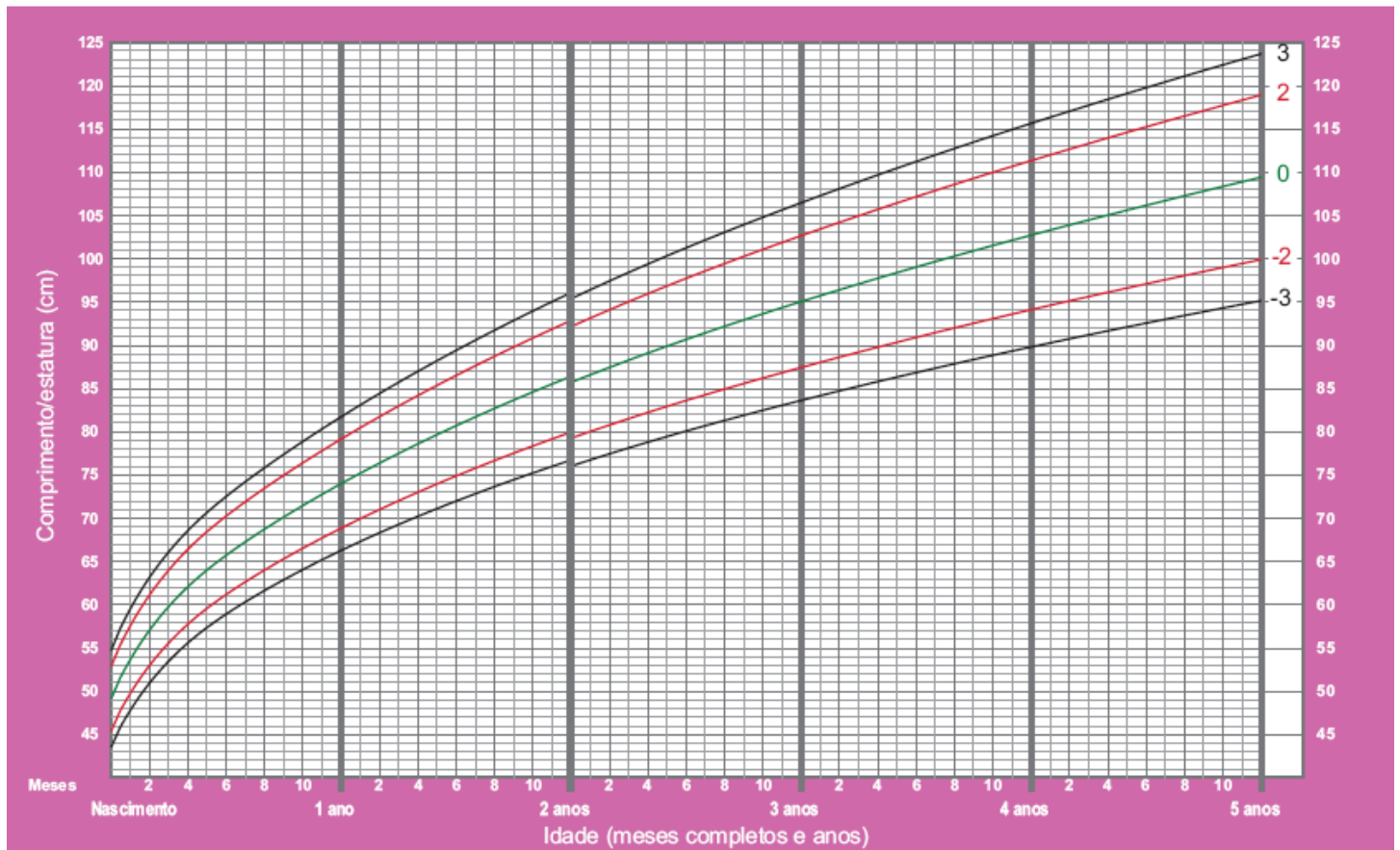


WHO Child Growth Standards

Figura 10.2 Curva de crescimento (comprimento/estatura por idade) para meninos de 0 a 5 anos com base em escores-z (WHO).

Comprimento/estatura por idade MENINAS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

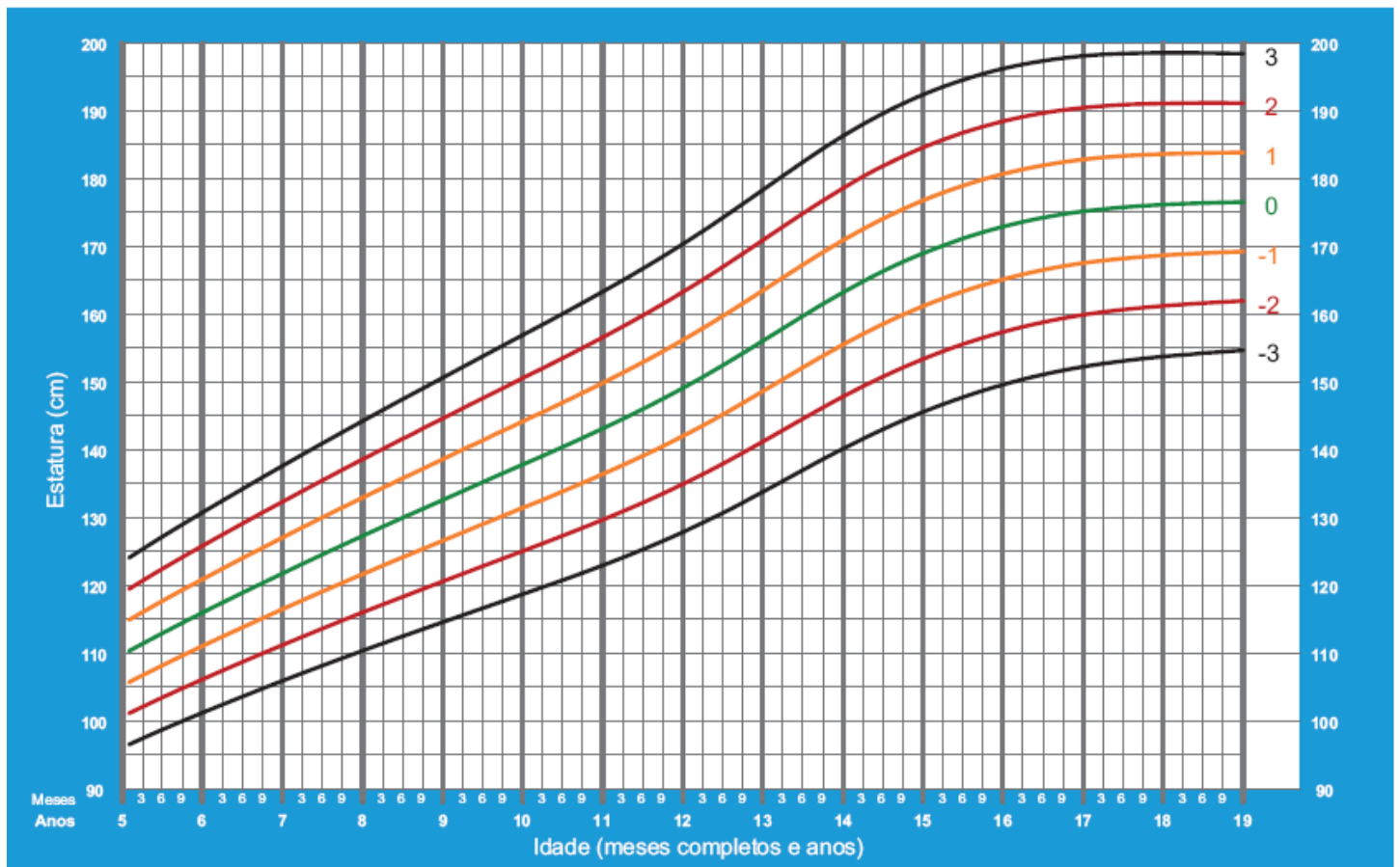


WHO Child Growth Standards

Figura 10.3 Curva de crescimento (comprimento/estatura por idade) para meninas de 0 a 5 anos com base em escores-z (WHO).

Estatura por idade MENINOS

Dos 5 aos 19 anos (escores-z)

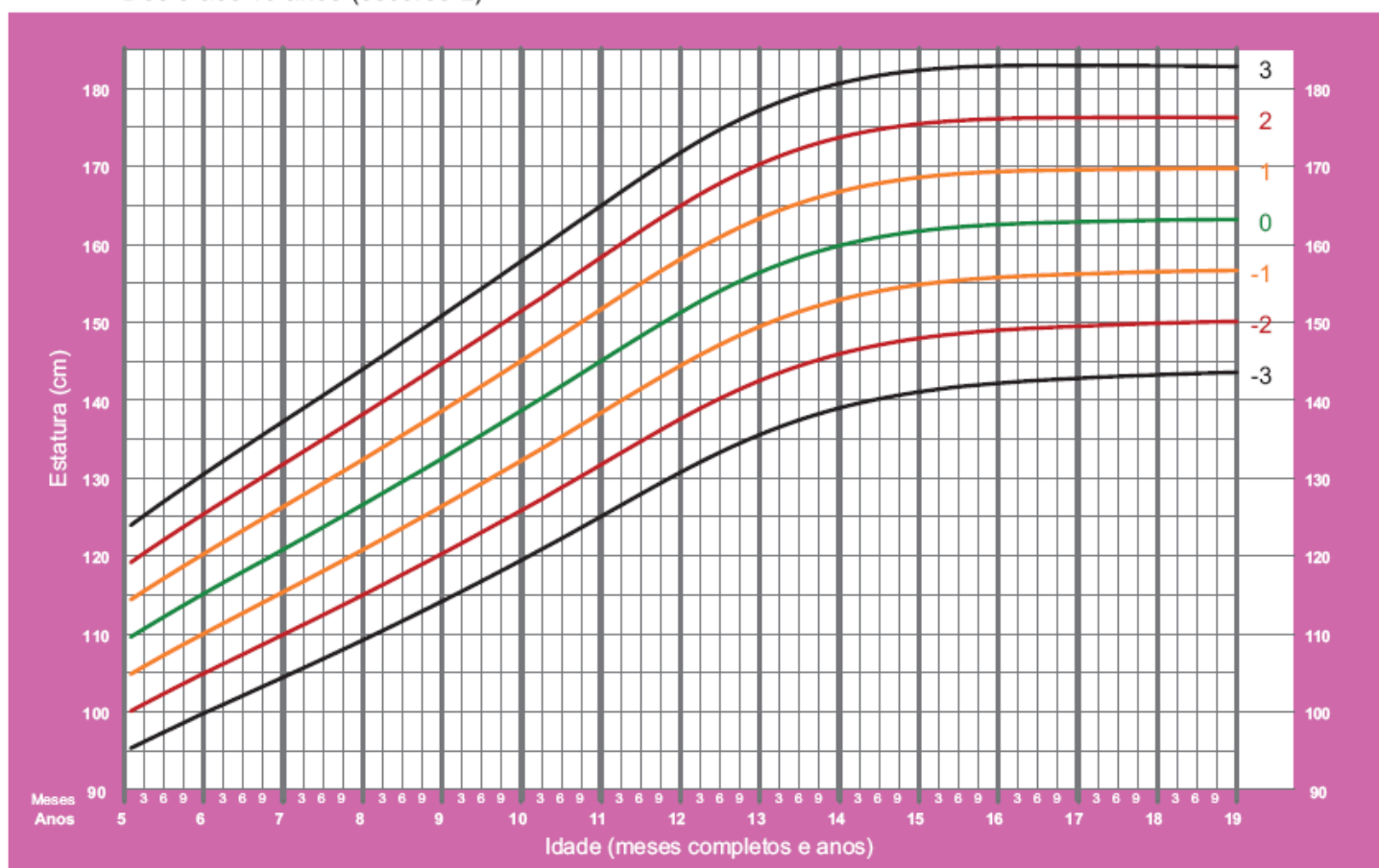


2007 WHO Reference

Figura 10.4 Curva de crescimento (estatura por idade) para meninos de 5 a 19 anos com base em escores-z (WHO).

Estatura por idade MENINAS

Dos 5 aos 19 anos (escores-z)



2007 WHO Reference

Figura 10.5 Curva de crescimento (estatura por idade) para meninas de 5 a 19 anos com base em escores-z (WHO).

Quadro 10.3

Classificação do estado nutricional de crianças menores de cinco anos para cada índice antropométrico.

Valores críticos		Índices antropométricos para menores de 5 anos			
		Peso-para-idade	Peso-para-estatura	IMC-para-idade	Estatura-para-idade
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Magreza acentuada	Muito baixa estatura para a idade
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3	≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2	Baixo peso para a idade	Magreza	Magreza	Baixa estatura para a idade
≥ Percentil 3 e < Percentil 15	≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z -1	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Eutrofia	Estatura adequada para a idade

$\geq$ Percentil 15 e $\leq$ Percentil 85	$\geq$ Escore-z -1 e $\leq$ Escore-z $+1$	Peso elevado para a idade	Risco de sobrepeso	Risco de sobrepeso	
$>$ Percentil 85 e $\leq$ Percentil 97	$<$ Escore-z $+1$ e $\leq$ Escore-z $+2$				
$>$ Percentil 97 e $\leq$ Percentil 99,9	$>$ Escore-z $+2$ e $\leq$ Escore-z $+3$		Sobrepeso	Sobrepeso	
$>$ Percentil 99,9	$>$ Escore-z $+3$		Obesidade	Obesidade	

Adaptado de OMS, 2006.

Quadro 10.4

Classificação do estado nutricional de crianças de 5 a 10 anos para cada índice antropométrico.

Valores críticos		Índices antropométricos para crianças de 5 a 10 anos		
		Peso-para-idade	IMC-para-idade	Estatura-para-idade
$<$ Percentil 0,1	$<$ Escore-z -3	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Muito baixa estatura para a idade
$\geq$ Percentil 0,1 e $<$ Percentil 3	$\geq$ Escore-z -3 e $<$ Escore-z -2	Baixo peso para a idade	Magreza	Baixa estatura para a idade
$\geq$ Percentil 3 e $<$ Percentil 15	$\geq$ Escore-z -2 e $<$ Escore-z -1	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Estatura adequada para a idade
$>$ Percentil 15 e $<$ Percentil 85	$\geq$ Escore-z -1 e $<$ Escore-z $+1$			
$\geq$ Percentil 85 e $\leq$ Percentil 97	$>$ Escore-z $+1$ e $\leq$ Escore-z $+2$		Sobrepeso	
$>$ Percentil 97 e $\leq$ Percentil 99,9	$>$ Escore-z $+2$ e $\leq$ Escore-z $+3$	Peso elevado para a idade	Obesidade	
$>$ Percentil 99,9	$>$ Escore-z $+3$		Obesidade grave	

Adaptado de OMS, 2006.

Em adultos, não sendo possível aferir a altura, pode-se perguntar se ele sabe a medida, pois alguns estudos já mostraram a validade da altura referida. Em homens, a precisão é maior, principalmente se a medida tiver sido feita na época em que se alistou no exército.

Medida da altura do idoso

No idoso, observa-se diminuição na altura com o passar dos anos devido ao encurtamento da coluna vertebral, em virtude da redução dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais. Além disso, há aumento da curvatura e/ou osteoporose. Dessa forma, para o idoso é mais adequado fazer a medida da altura, uma vez que a referida será quase sempre maior que a atual.

Há algumas equações para estimar a altura a partir de medidas de segmentos corporais, tais como altura do joelho, da envergadura ou semienvargadura.

Altura do joelho. A estimativa da estatura por meio da altura do joelho é a forma mais utilizada, pois não se altera com o aumento da idade. O paciente deve estar sentado, com os pés no chão. Contudo, nas situações em que não haja possibilidade de sentá-lo, ele deve ser disposto no leito em posição supina com a perna colocada perpendicularmente ao colchão. A medida é realizada tomando como referência o ponto ósseo externo, logo abaixo da rótula (cabeça da tíbia), até a superfície do chão ou colchão. Preferencialmente a medida deve ser realizada na parte interna da perna (Figura 10.6).

Após a mensuração da altura do joelho, pode-se estimar a altura do paciente usando as fórmulas no Quadro 10.5, que contemplam diferentes faixas etárias, sexo e etnias. Cumpre salientar que essas fórmulas não foram desenvolvidas para a população brasileira, mas algumas pesquisas com amostras de idosos ou grupos de pacientes realizadas no Brasil encontraram boa correlação entre a altura real e a estimada pelas fórmulas de Chumlea.

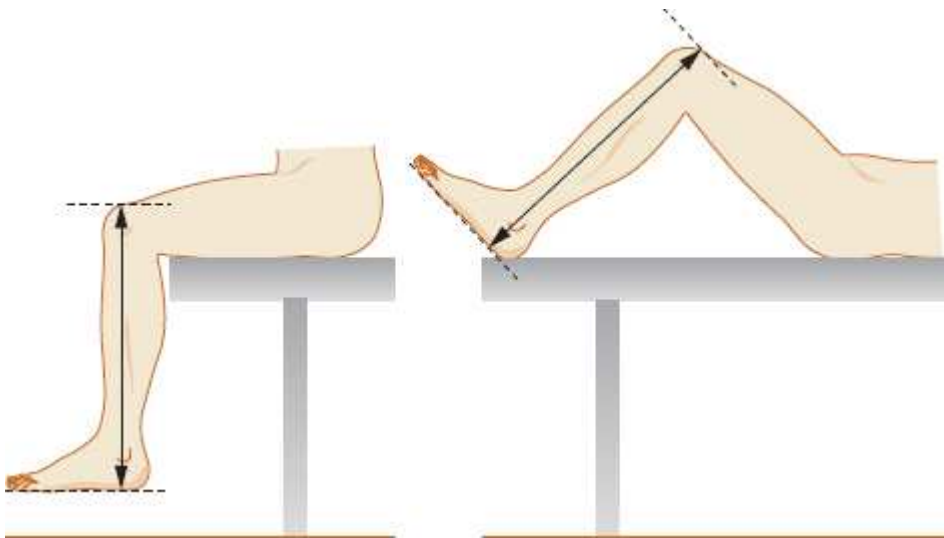


Figura 10.6 Técnica de mensuração da altura do joelho.

Quadro 10.5 Equações para estimativa da altura pela altura do joelho e idade.		
População	Sexo masculino	Sexo feminino
Crianças	$64,19 - (0,04 \times id) + (2,02 \times AJ)$	$84,88 - (0,24 \times id) + (1,83 \times AJ)$
Adultos brancos (18 a 60 anos)	$71,85 + (1,88 \times AJ)$	$70,25 + (1,87 \times AJ) - (0,06 \times id)$
Adultos negros (18 a 60 anos)	$73,42 + (1,79 \times AJ)$	$68,10 + (1,86 \times AJ) - (0,06 \times id)$

Idosos brancos	$78,31 + (1,94 \times AJ) - (0,14 \times \text{idade})$	$82,21 + (1,85 \times AJ) - (0,21 \times \text{idade})$
----------------	---	---

id: idade em anos; AJ: altura do joelho em centímetros. Fonte: Chumlea *et al.*, 1985.

Envergadura e semi-envergadura do braço. Outra alternativa para estimar a altura é pela medida da envergadura ou semi-envergadura do braço. Para isso, o paciente não pode estar com vestimentas que dificultem a total extensão do braço (Figura 10.7). Com o paciente de frente para o avaliador, em posição ereta, recostado na parede, tronco reto, ombros nivelados, braços abertos em abdução de 90°, mede-se a semi-envergadura com uma fita métrica inextensível paralelamente à clavícula, verificando a distância entre o ponto médio do esterno e a falange distal do terceiro quirodáctilo. A medida da semi-envergadura vezes dois corresponde à estatura real, obtida de acordo com a fórmula de Rabito.

Boxe

Fórmula de Rabito

Recomenda-se o uso dessa fórmula para estimar a altura em adultos e idosos hospitalizados, usando a medida da semi-envergadura:

$$\text{Altura (cm)} = 63,525 - (3,237 \times \text{sexo}^*) - (0,06904 \times \text{idade}) + (1,293 \times \text{SE})$$

*Fator de multiplicação de acordo com o sexo: 1 para o sexo masculino e 2 para o sexo feminino. SE = semi-envergadura.

Para a envergadura, mede-se toda a extensão de uma ponta a outra da falange distal. A medida da envergadura é similar à altura real (Figura 10.7).

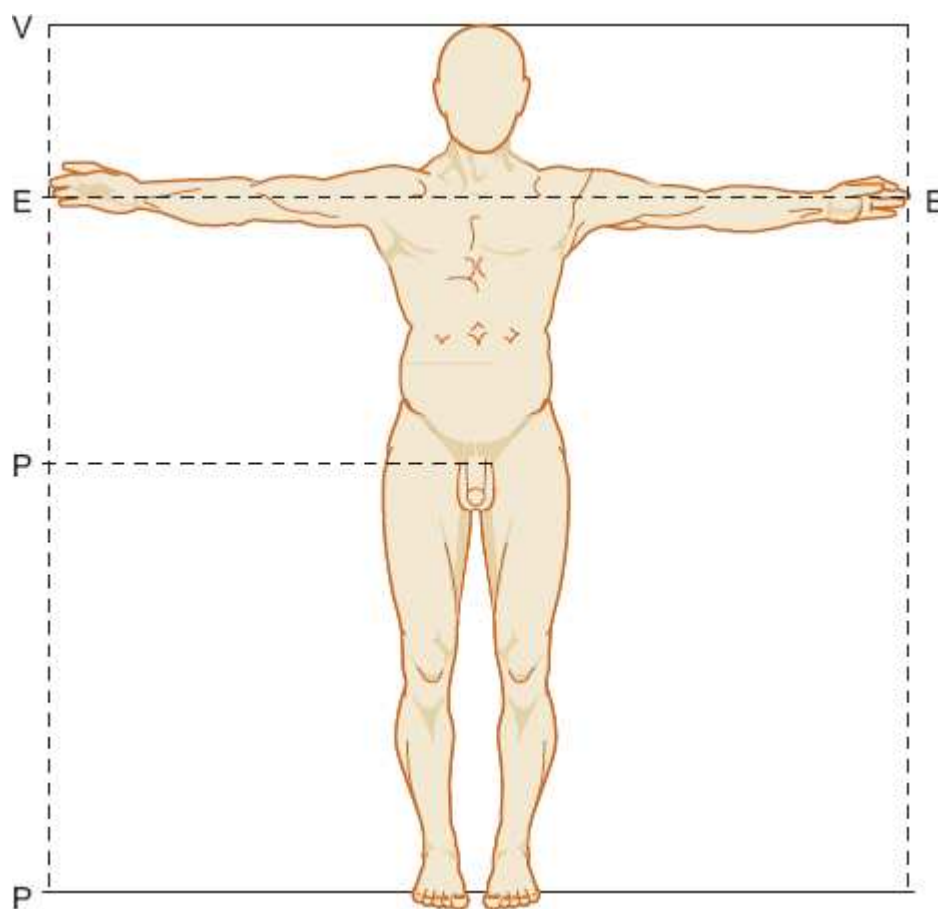


Figura 10.7 Medidas antropométricas. PV = distância pubovértice; PP = distância puboplantar; EE = envergadura.

Altura recumbente

Embora a altura recumbente possa superestimar a altura real (aproximadamente 3 cm no sexo masculino e 4 cm no sexo feminino), essa é uma opção para pacientes acamados em virtude de politrauma ou outras condições que inviabilizem a medida da altura do joelho e/ou da semienvargadura ou da envargadura.

Semiotécnica. Com o paciente em posição supina, o leito em posição horizontal completa, a cabeça em posição reta, realizam-se as medidas pelo lado direito do corpo por meio da marcação no lençol na altura do topo da cabeça e da base do pé (pode ser utilizado um triângulo). Em seguida, mede-se o comprimento entre as duas marcas com fita métrica inextensível (Figura 10.8).

Peso

O peso corporal é a soma de todos os componentes da composição corporal: água e tecidos adiposo, muscular e ósseo. Sua avaliação é útil para determinar e monitorar o estado nutricional, utilizado como marcador indireto da massa proteica e reserva de energia.

Peso atual. Utiliza-se uma balança mecânica tipo plataforma ou digital. Antes da aferição, é necessário sempre calibrar a balança. O paciente deve ser pesado descalço, com a menor quantidade de roupa possível, posicionado no centro da balança, com os braços ao longo do corpo. A leitura do peso é realizada com o avaliador à frente da balança e à esquerda do paciente.

Boxe

Determinação do peso de paciente acamado

Em paciente incapacitado de se colocar em posição ortostática ou de deambular, o peso pode ser aferido em cama-balança ou em balança para pesagem em leito, que não é muito usada pelo alto custo. É importante ressaltar que no momento da pesagem, algumas variáveis podem interferir, como: colchão casca de ovo ou pneumático, coxim, lençóis, cobertores, excesso de travesseiros, hastes para soro e medicamentos, bomba de infusão, bolsa para coleta de urina, entre outras. Se possível, a fim de evitar um peso superestimado, considerar apenas o peso da cama contendo um colchão comum, um travesseiro, um lençol e uma fronha.

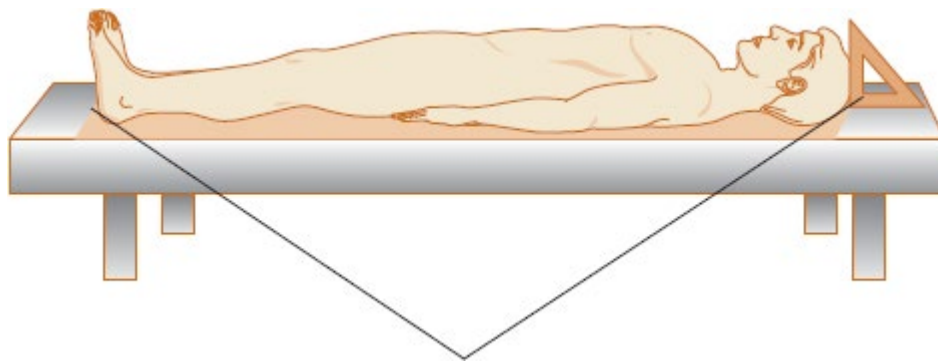


Figura 10.8 Técnica de mensuração da altura recumbente.

Para recém-nascidos, utiliza-se a balança pediátrica. A criança deve estar sem fraldas e outras vestimentas, pois pequenos gramas podem resultar em alteração significativa na classificação do peso. Uma criança que nasce a termo deve ter peso superior a 2,5 kg. Se estiver abaixo desse valor é considerada de baixo peso e deve receber os cuidados específicos para ganhar peso.

Boxe

Perda de peso fisiológica

Após o nascimento pode ocorrer perda fisiológica de 3 a 5% do peso corporal e algumas mães podem se assustar ao levar a criança à consulta de 1 semana. É muito importante que se explique isso para os pais dos recém-nascidos, pois esta perda fisiológica pode provocar ansiedade e até levar ao abandono do aleitamento materno, uma vez que a mãe pode pensar que a perda de peso decorreu da amamentação. Essa crença deve ser desfeita e o estímulo ao aleitamento materno, sempre reforçado. Após 7 a 10 dias, a criança recupera o

Em relação à criança, vale o mesmo já mencionado sobre o uso da caderneta de saúde e uso das curvas de peso para acompanhar o ganho de peso até os 10 anos de idade (Figuras 10.9 a 10.12). Deve-se sempre explicar para os pais ou responsáveis como está a curva de peso para a idade da criança em relação às linhas coloridas:

A linha verde significa a média

Se a criança estiver entre a linha vermelha e a preta abaixo da média, está com baixo peso

Se estiver entre a linha vermelha e a preta acima da média, está com sobrepeso

Quanto mais perto os dados estiverem da linha vermelha, é necessário tomar as devidas providências, investigando as condições familiares e sociais, o aleitamento, a alimentação e os sinais e sintomas de problemas de saúde.

Peso usual/habitual. Utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e em casos de impossibilidade de medir o peso atual. Geralmente é o peso que se mantém por maior período de tempo.

Peso ideal/desejável/teórico. É o peso definido de acordo com alguns parâmetros, tais como idade, biótipo, sexo e altura. Devido a variações individuais no adulto, o peso ideal pode variar 10% para abaixo ou para cima do peso teórico. A utilização do peso ideal no cálculo calórico do suporte nutricional para pacientes gravemente desnutridos deve ser individualizada, pois podem ser “superalimentados”, originando complicações respiratórias, metabólicas e hepáticas. Além disso, obesos podem ser “subalimentados”. Nos casos extremos de desnutrição é aconselhável a utilização do peso ideal ou atual estimado, enquanto nos obesos mórbidos, o peso ideal deve ter o seu valor ajustado (Quadros 10.6 a 10.9).

O peso ideal pode ser calculado a partir do IMC, pela seguinte fórmula:

$$\text{Peso ideal} = \text{altura}^2 \times \text{IMC médio}$$

IMC ideal: homens: 22 kg/m²; mulheres: 21 kg/m².

Peso ajustado. É estimado a partir do peso atual (PA) e do ideal (PI). É bastante utilizado para realizar prescrições de dietas em pacientes ambulatoriais ou para suporte nutricional em pacientes hospitalizados.

Peso ajustado para obesidade:

$$\text{Peso ajustado} = (\text{PA} - \text{PI}) \times 0,25 + \text{PI}$$

Peso ajustado para desnutrição:

$$\text{Peso ajustado} = (\text{PI} - \text{PA}) \times 0,25 + \text{PA}$$

Peso corrigido. Deve ser utilizado para pacientes amputados (Quadro 10.10).

$$\text{Peso corrigido} = \frac{(\text{peso antes da amputação} \times 100)}{(100\% - \% \text{ de amputação})}$$

Peso estimado. É o peso obtido a partir de fórmulas ou tabelas. É utilizado quando inexiste a possibilidade de obtenção do peso atual ou quando não se pode pesar o indivíduo. A fórmula mais aplicada é a que utiliza a altura do joelho e a circunferência do braço (Quadro 10.11).

A circunferência do braço é aferida no ponto médio entre o acrômio e o olécrano, com o braço estendido lateralmente ao tronco. Para encontrar o ponto médio, o cotovelo deve estar fletido em 90°.

Peso seco. O peso corporal seco é o peso descontado de edema e ascite. O valor a ser descontado depende do local e grau do edema. A classificação do edema e a estimativa de correção de peso de edema/ascite estão mostradas nos Quadros 10.12 a 10.14.

Índice de massa corporal

O índice de massa corporal (IMC) é amplamente utilizado como indicador do estado nutricional, por ser obtido de forma rápida e de fácil interpretação (Quadros 10.15 e 10.16). É expresso pela fórmula: $\text{IMC} = \text{peso atual (kg)} / \text{altura}^2 \text{ (m)}$.

Cumprir salientar que o IMC não distingue massa gordurosa de massa magra; assim, um paciente musculoso pode ser classificado com “excesso de peso”. Deve-se ainda estar atento ao biótipo do paciente. Um IMC entre 17 e 19 não

necessariamente é indicativo de desnutrição, pois outros aspectos devem ser considerados no exame físico e na anamnese, como o histórico de evolução do peso.

O IMC também é utilizado para crianças e adolescentes, conforme Figuras 10.13 a 10.16. Para adolescentes a partir de 15 anos é necessário avaliar o estágio de maturação sexual e se o mesmo já passou pela fase do estirão, ou seja, rápido crescimento em estatura (ver *Desenvolvimento físico*, neste capítulo).

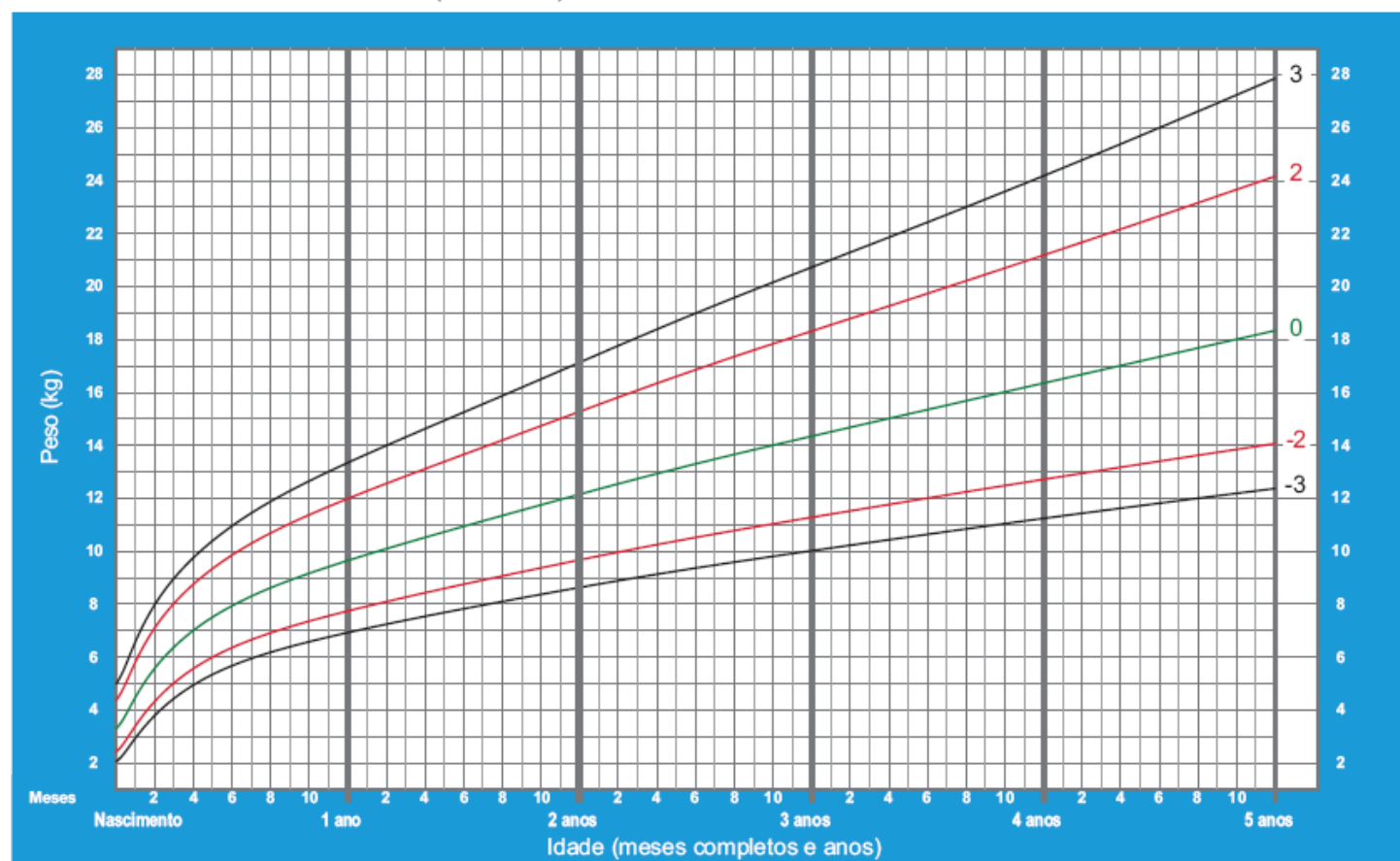
Circunferência da cintura

A circunferência da cintura (CC) é utilizada para o diagnóstico de obesidade abdominal e reflete o conteúdo de gordura visceral, ou seja, aquela aderida aos órgãos internos, como intestinos e fígado. Essa gordura apresenta grande associação com a gordura corporal total, sendo o tipo de obesidade mais comumente associada à síndrome metabólica e às doenças cardiovasculares.

Semiotécnica. A medida da CC é determinada com uma fita métrica inextensível, em centímetros, posicionada no ponto entre a última costela e a crista ilíaca, sem fazer pressão, em plano horizontal. Indivíduos com CC muito aumentada têm maior risco cardiovascular e são classificados como apresentando obesidade abdominal (OA) (Quadro 10.17).

Peso por idade MENINOS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

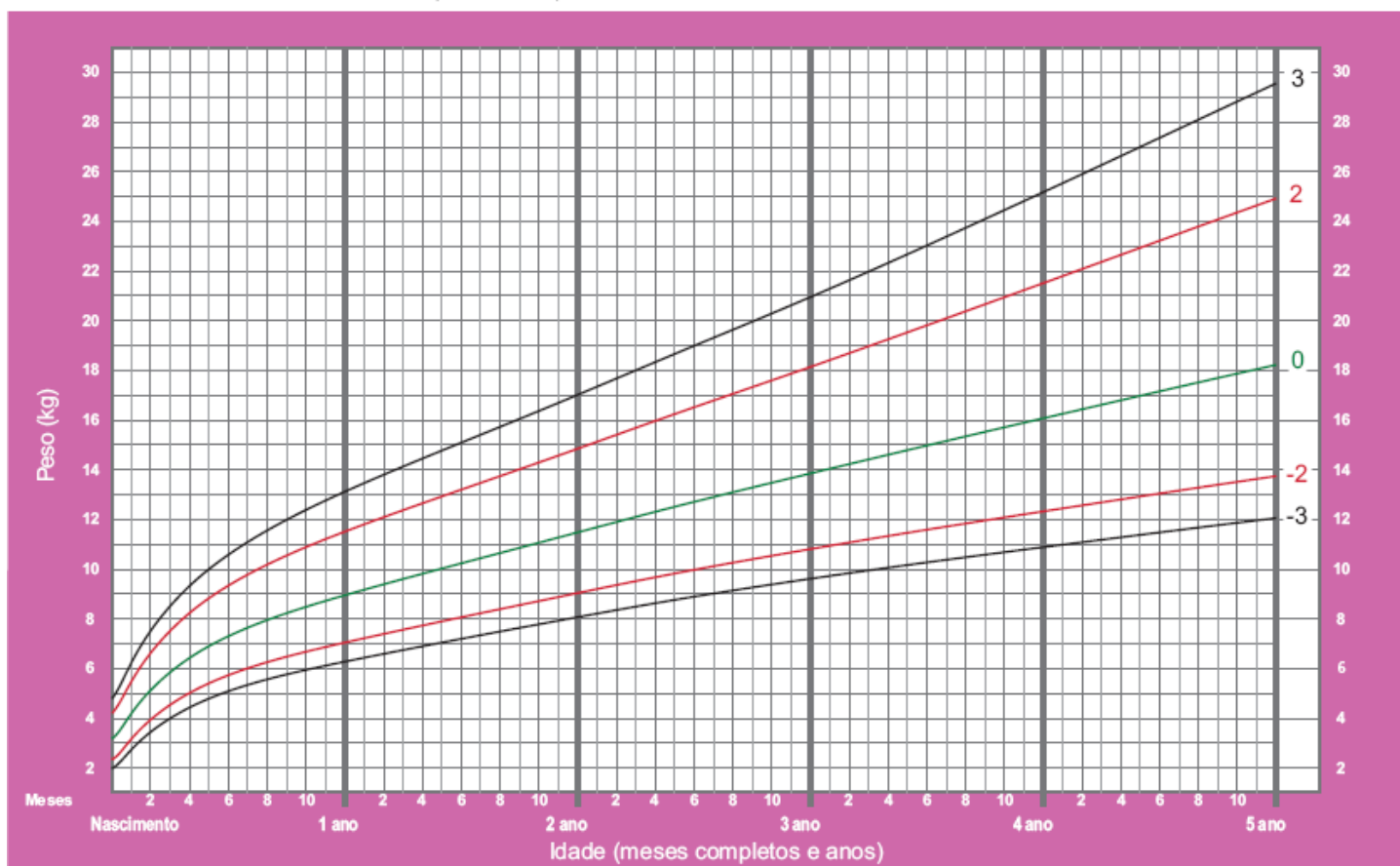


WHO Child Growth Standards

Figura 10.9 Curvas de crescimento (peso por idade) para meninos de 0 a 5 anos com base em escores-z (WHO).

Peso por idade MENINAS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

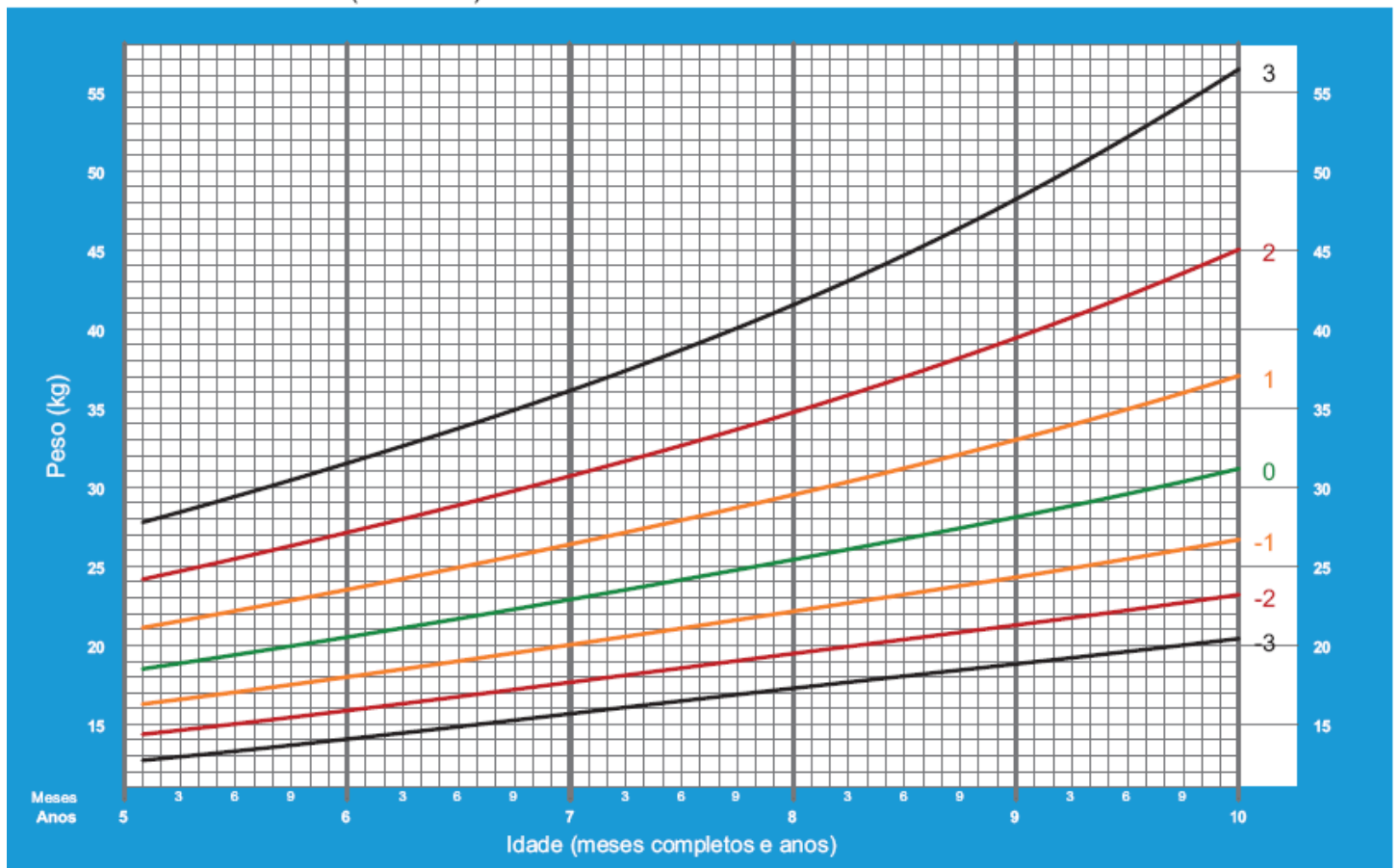


WHO Child Growth Standards

Figura 10.10 Curvas de crescimento (peso por idade) para meninas de 0 a 5 anos com base em escores-z (WHO).

Peso por idade MENINOS

Dos 5 aos 10 anos (escores-z)

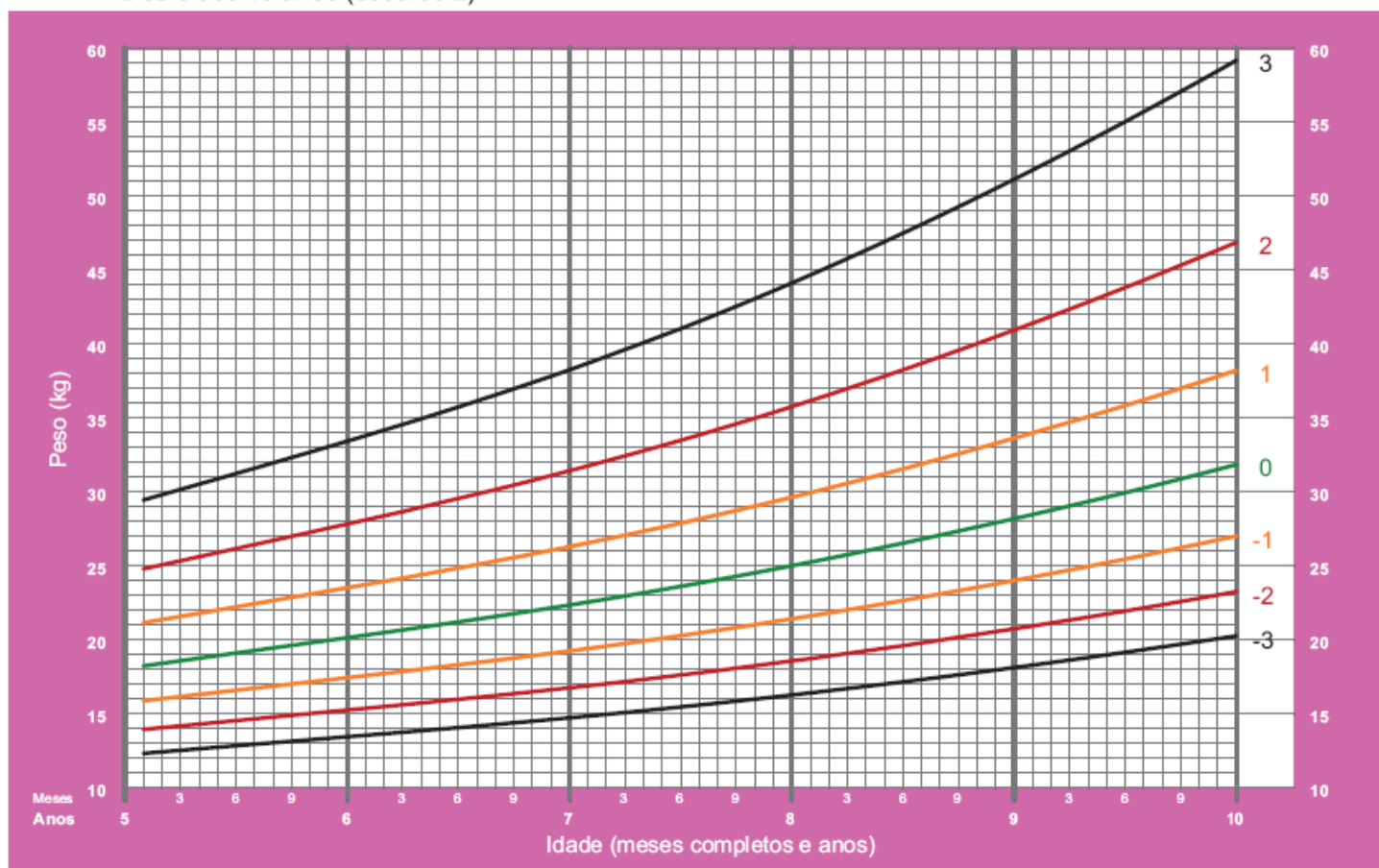


2007 WHO Reference

Figura 10.11 Curvas de crescimento (peso por idade) para meninos de 5 a 10 anos com base em escores-z (WHO).

Peso por idade MENINAS

Dos 5 aos 10 anos (escores-z)



2007 WHO Reference

Figura 10.12 Curvas de crescimento (peso por idade) para meninas de 5 a 10 anos com base em escores-z (WHO).

Quadro 10.6

Altura e peso em relação à idade (até 20 anos).

Idade	Altura (cm)				Peso (kg)			
	Masc.		Fem.		Masc.		Fem.	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Recém-nascido	49	53,5	48	53	2,812	3,900	2,900	3,900
6 meses	64,5	69,5	63,5	66,5	6,900	8,800	6,450	8,200
1 ano	72	77,5	71	76	8,500	10,800	8,000	10,150
1½	78	84	77	82,5	9,900	12,400	9,300	11,700
2	83	89	82	86	11,000	13,650	9,380	12,900
2½	87,5	93,5	86	92	11,800	14,650	11,200	13,900
3	91,5	98	90	96,5	13,000	16,000	12,000	15,000

3½	95	102	93,5	100,5	13,800	17,000	12,900	16,000
4	98,5	105,5	97,5	104	14,400	17,800	12,800	17,000
4½	102,5	109	100,5	107,5	15,300	18,800	14,700	18,100
5	104,5	112,5	103,5	111	15,900	19,700	15,300	18,900
5½	107,5	115,5	106,5	114	16,900	21,000	16,300	20,200
6	110,5	118	109,5	117	17,800	22,000	17,000	21,000
6½	113	121	112,5	120	18,600	23,000	17,800	22,100
7	116	124	115	123	19,500	24,100	19,100	23,700
7½	118,5	126,5	117,5	125,5	20,400	25,100	20,000	24,900
8	120,5	129,5	120	128,5	21,400	26,500	21,000	26,100
8½	123	132	122,5	131	22,300	27,800	22,000	27,500
9	125,5	134,5	125	133,5	23,400	29,200	23,100	28,900
9½	128	137	127	136,5	24,600	30,800	24,300	30,500
10	130,5	139,5	130	139	25,900	32,500	25,500	32,200
10½	133	142	133	142	27,200	34,200	26,900	34,000
11	135,5	145	135,5	145,5	28,500	36,000	28,900	36,800
11½	138,5	147,5	138,5	148,5	30,000	37,700	30,300	38,800
12	140	150	142	151,5	31,500	39,500	32,000	41,000
12½	142	152,5	144	154	33,000	41,400	33,800	43,400
13	144,5	154,5	146,5	156,5	34,400	43,400	35,700	45,900
13½	147	157	146,5	159,5	36,000	45,500	37,900	46,600
14	149	159,5	150,5	161,5	36,800	46,700	40,500	51,500
14½	151	162	152	163	38,500	49,000	41,900	52,900
15	153	164	153,5	164	40,500	51,500	43,400	54,300

4½	102,5	109	100,5	107,5	99	106	97	104,5
5	104,5	112,5	103,5	111	101	109	99,5	107
5½	107,5	115,5	106,5	114	105	113	103,5	111,5
6	110,5	118	109,5	117	107,5	116	106	114
6½	113	121	112,5	120	110	119	109	117
7	116	124	115	123	113	121,5	112,5	121
7½	116,5	126,5	117,5	125,5	115,5	124,5	115,5	124
8	120,5	129,5	120	128,5	119	128	118	126,5
8½	123	132	122,5	131	122	131	120,5	130
9	125,5	134,5	125	133,5	124,5	134,5	123,5	132,5
9½	128	137	127	136,5	128	137,5	126	135,5
10	130,5	139,5	130	139	130,5	140,5	129	138,5
10½	133	142	133	142	133,5	143,5	131,5	141,5
11	135,5	145	135,5	145,5	136	146,5	135,5	145,5
11½	138,5	147,5	138,5	148,5	138,5	149,5	137,5	146,5
12	140	150	142	151,5	141,5	152,5	140,5	151,5
12½	142	152,5	144	154	144,5	155,5	143	154
13	144,5	154,5	146,5	156,5	147,5	158,5	146,5	157
13½	147	157	148,5	159,5	150	161,5	149	160
14	149	159,5	150,5	161,5	151,5	163	150	161,5
14½	151	162	152	163	154	166	153	164
15	153	164	153,5	164	156,5	169	154	166
15½	155	166	154,5	165	158	170,5	155,5	167,5
16	157	168	155	166	161	173	155,5	168

[illegible]

55	62,1	64,4	67,6	71,7	76,2	80,7	86,6	92,9	99,3
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Boxe

Circunferência da cintura e circunferência abdominal

É muito importante não confundir a medida da circunferência da cintura (CC) com a medida da circunferência abdominal (CA), que é mensurada ao nível da maior extensão abdominal, a qual não possui pontos de corte de classificação como a CC (Quadro 10.17), não podendo, portanto, ser utilizada para diagnóstico de obesidade abdominal. No entanto, a CA pode ser utilizada para acompanhamento da redução de medidas da circunferência abdominal em um mesmo paciente.

Circunferência da panturrilha

A circunferência da panturrilha (CP) é uma medida importante para acompanhar o estado nutricional de pacientes hospitalizados, principalmente os acamados, pois permite avaliar a depleção da massa muscular. É utilizada também no rastreamento de sarcopenia em idosos, por ser a medida mais sensível e de fácil aplicação para avaliar massa muscular. É útil também para indicar depleção de massa muscular em processo de desnutrição.

A *caderneta de saúde do idoso* incorporou a medida da CP entre as avaliações antropométricas, baseando-se no estudo de Pagotto e Silveira (2013).

- Pontos de corte de CP para idosos brasileiros:
- Menor que 35 cm, deve-se realizar acompanhamento de rotina
- De 31 a 34 cm, exige vigilância nutricional ao idoso (atenção)
- Menor que 31 cm caracteriza depleção de massa muscular (sarcopenia) (necessária intervenção).

Quadro 10.9
Peso ideal para mulheres acima de 20 anos em relação à idade e à altura.

Altura (cm)	155	160	165	170	175	180	185
Idade (anos)	Peso (kg)						
20	48,9	50,8	52,6	55,3	58,1	61,7	64,9
21	49,4	51,3	53,1	55,8	58,5	62,1	65,3
22	49,4	51,3	53,1	55,8	58,5	62,1	65,8
23	49,9	51,7	53,5	56,2	58,9	62,6	66,2
24	50,3	52,2	53,9	56,2	58,9	62,8	66,2
25	50,3	52,2	53,9	56,2	59,4	63,1	66,7
26	50,8	52,6	54,4	56,7	59,4	63,1	66,7
27	50,8	52,6	54,4	56,7	59,9	63,5	67,1

28	51,3	53,1	54,8	57,1	60,3	63,9	67,6
29	51,3	53,1	54,8	57,1	60,3	63,9	67,6
30	51,7	53,5	55,3	57,6	60,8	64,4	68,1
31	52,2	53,9	55,8	58,1	61,2	64,9	68,5
32	52,2	53,9	55,8	58,1	61,7	65,3	68,9
33	52,6	54,4	56,2	58,5	62,1	65,8	68,4
34	53,1	54,9	56,7	58,9	62,6	66,2	69,8
35	53,1	54,9	56,7	58,9	62,6	66,2	69,8
36	53,5	55,3	57,1	59,4	63,1	66,7	70,3
37	53,5	55,3	57,1	59,9	63,5	67,1	70,8
38	53,9	55,8	57,6	60,3	63,9	67,6	71,2
39	54,4	56,2	58,1	60,8	64,4	68,1	71,1
40	54,9	56,7	58,5	61,2	64,4	68,1	71,7
41	55,3	57,1	58,9	61,7	64,9	68,5	72,1
42	55,3	57,1	58,9	61,7	64,9	68,5	72,1
43	55,8	57,6	59,4	62,1	65,3	68,9	72,6
44	56,2	58,1	59,9	62,6	65,8	69,4	73,1
45	56,2	58,1	59,9	62,6	65,8	69,4	73,1
46	56,6	58,5	60,3	63,1	66,2	69,8	73,5
47	56,6	58,5	60,3	63,1	66,2	70,3	73,9
48	57,1	58,9	60,8	63,5	66,7	70,7	74,4
49	57,1	58,9	60,8	63,5	66,7	70,8	74,8
50	57,6	59,4	61,2	63,9	67,1	70,8	74,8
51	57,6	59,4	61,2	63,9	67,1	71,2	75,3

52	57,6	59,4	61,2	63,9	67,1	71,2	75,3
53	57,6	59,4	61,2	63,9	67,7	71,2	75,3
54	57,6	59,4	61,2	63,9	67,1	71,7	75,7
55	57,6	59,4	61,2	63,9	67,1	71,7	75,7

Quadro 10.10
Percentuais de peso das partes do corpo para cálculos após amputação.

Membro amputado	Proporção de peso (%)
Tronco sem membros	50,0
Mão	0,7
Antebraço com mão	2,3
Antebraço sem mão	1,6
Parte superior do braço	2,7
Braço inteiro	5,0
Pé	1,5
Perna abaixo do joelho com pé	5,9
Coxa	10,1
Perna inteira	16,0

Fonte: Osterkamp, 1995.

Semiotécnica. A medida da CP deve ser feita com o indivíduo sentado, com os pés aproximadamente a 20 cm do corpo, joelho em ângulo de 90°, sendo considerada a medida mais larga da panturrilha da perna esquerda (Figura 10.17).

Perímetro cefálico

O perímetro cefálico (PC) é outra importante medida antropométrica, realizada logo após o nascimento, e importante para acompanhamento da criança até 2 anos de idade. Em crianças com algum déficit, deve ser medido até os 5 anos de idade. É um dado importante para o diagnóstico de algumas condições clínicas (microcefalia e macrocefalia) e não pode faltar no exame físico da criança. Para diagnóstico da microcefalia, o valor do PC deve ser inferior a 33 cm na criança a termo (Figura 10.18).

Quadro 10.11
Equações para estimativa de peso corporal pela altura do joelho.

Raça	Idade	Sexo masculino	Sexo feminino
------	-------	----------------	---------------

Branca	19 a 59	$(AJ \times 1,19) + (CB \times 3,21) - 86,82$	$(AJ \times 1,01) + (CB \times 2,81) - 66,04$
	60 a 80	$(AJ \times 1,10) + (CB \times 3,07) - 75,81$	$(AJ \times 1,09) + (CB \times 2,68) - 65,51$
Negra	19 a 59	$(AJ \times 1,09) + (CB \times 3,14) - 83,72$	$(AJ \times 1,24) + (CB \times 2,97) - 82,48$
	60 a 80	$(AJ \times 0,44) + (CB \times 2,86) - 39,21$	$(AJ \times 1,50) + (CB \times 2,58) - 84,22$

AJ: altura do joelho; CB: circunferência do braço; ambas em centímetros (cm). Fonte: Chumlea, 1988.

Quadro 10.12

Classificação de edema para avaliar o peso seco.

Edema +	Depressão leve (2 mm) Contorno normal Associado com volume de líquido intersticial > 30%
Edema ++	Depressão mais profunda (4 mm) Contorno quase normal Prolonga mais que edema +1
Edema +++	Depressão profunda (6 mm) Permanece vários segundos após a pressão Edema de pele óbvio pela inspeção geral
Edema ++++	Depressão profunda (8 mm) Permanece por tempo prolongado após a pressão Inchaço evidente Presença de sinal de cacifo

Adaptado de Heyward e Stolarczyk, 2000.

Quadro 10.13

Estimativa de peso em pacientes edemaciados.

Edema	Localização	Excesso de peso hídrico (kg)
+	Tornozelo	1
++	Joelho	3 a 4
+++	Base da coxa	5 a 6
++++	Anasarca	10 a 12

Fonte: Materese, 1997.

Quadro 10.14

Estimativa de peso em pacientes com ascite.

Edema	Peso da ascite (kg)	Edema periférico (kg)
Leve	2,2	1,0
Moderado	6,0	5,0
Grave	14,0	10,0

Fonte: James, 1989.

Quadro 10.15
Classificação do índice de massa corporal para adultos.

IMC	Estado nutricional
< 16,00	Magreza grau III
16,00 a 16,99	Magreza grau II
17,00 a 18,49	Magreza grau I
18,50 a 24,99	Eutrófico (normal)
25,00 a 29,99	Sobrepeso
≥ 30,0	Obesidade

Fonte: WHO, 1995.

Quadro 10.16
Classificação do índice de massa corporal para idosos.

IMC	Estado nutricional
< 22	Baixo peso
22 a 27	Eutrófico
> 27	Excesso de peso

Fonte: Lipschitz, 1994.

Semiotécnica. A medida do PC é realizada com fita inextensível, observando os pontos anatômicos das bordas supraorbitárias (arco das sobrancelhas) e a proeminência occipital em seu ponto mais saliente, na parte posterior (Figura 10.19).

Boxe

Perímetro cefálico no primeiro ano de vida para crianças nascidas a termo

0 a 3 meses: 2 cm por mês

3 a 6 meses: 1 cm por mês
6 a 9 meses: 0,5 cm por mês
9 a 12 meses: 0,5 cm por mês.

Avaliação do estado nutricional

Na avaliação do estado nutricional, é necessário obter informações corretas, a fim de se identificar distúrbios e/ou agravos ligados à alimentação e à doença de base.

A avaliação nutricional é um processo dinâmico, feito por meio de comparações entre os dados obtidos no paciente e os padrões de referência, sendo importante a reavaliação periódica do estado nutricional no curso da doença. Ver *Metabolismo e condições nutricionais* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Sobrepeso e obesidade

Boxe

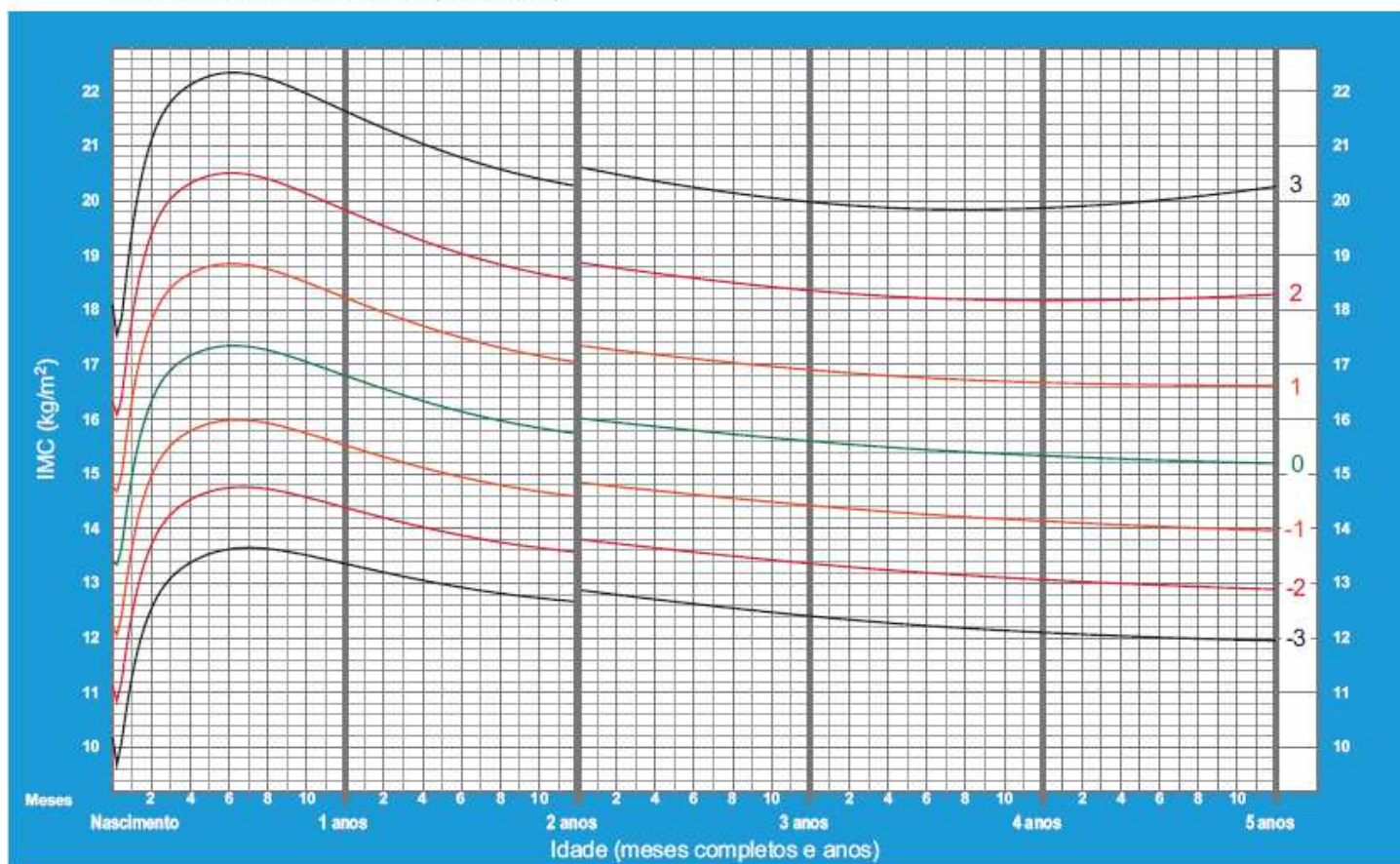
Sobrepeso e obesidade são definidos como o acúmulo excessivo de gordura corporal, condição que acarreta prejuízos à saúde global, além de favorecer o surgimento de enfermidades como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial.

A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, em 2014, segundo dados do Ministério da Saúde, 52,5% dos adultos apresentavam excesso de peso e 17,9% eram obesos.

O excesso de peso tem caráter multifatorial, com interações entre genética, meio ambiente e comportamento. Dentre esses fatores, destacam-se aumento da ingestão de alimentos, com elevado aporte energético, e redução da prática de atividade física, com baixo gasto energético. Esse desequilíbrio no balanço energético leva à obesidade, pois ocorre uma grande oferta de energia e um baixo gasto, resultando em energia não utilizada, que é depositada na forma de gordura corporal nos adipócitos. Além destes fatores, é importante considerar na gênese da obesidade fatores ambientais desfavoráveis, neuroendócrinos, emocionais e/ou psiquiátricos.

IMC por idade MENINOS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

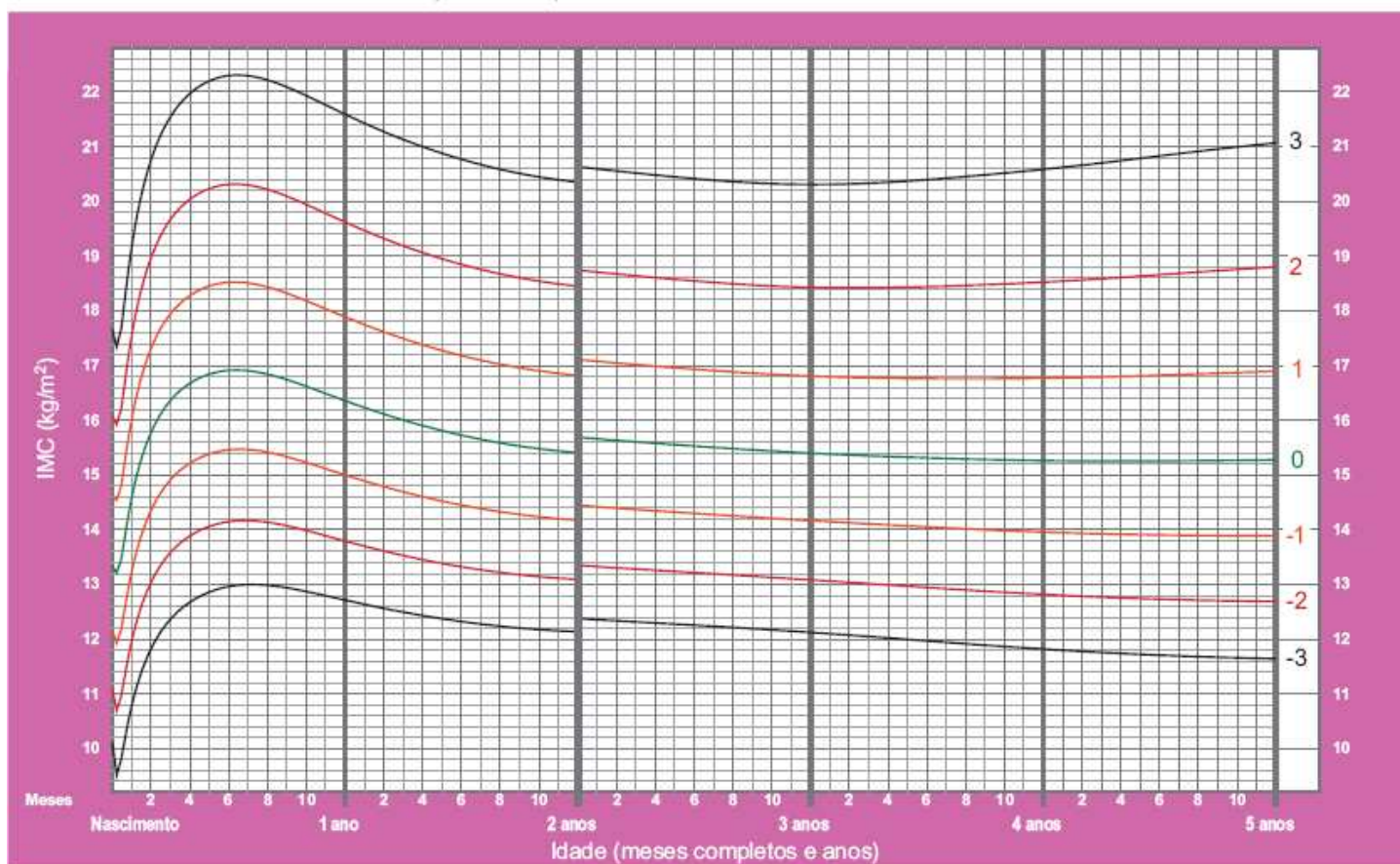


WHO Child Growth Standards

Figura 10.13 Curvas de IMC (índice de massa corporal por idade) para meninos de 0 a 5 anos com base em escores-z (WHO).

IMC por idade MENINAS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

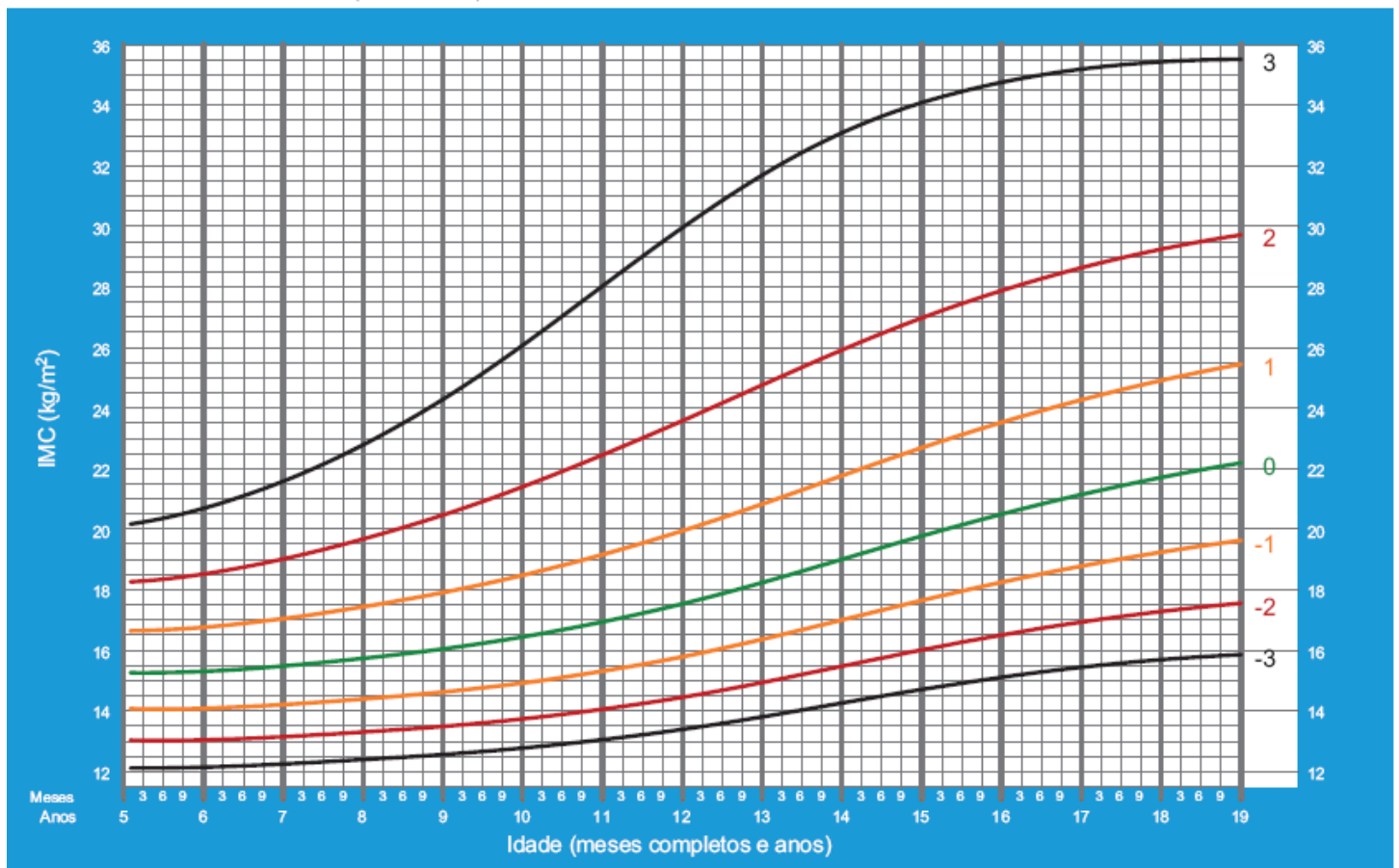


WHO Child Growth Standards

Figura 10.14 Curvas de IMC (índice de massa corporal por idade) para meninas de 0 a 5 anos com base em escores-z (WHO).

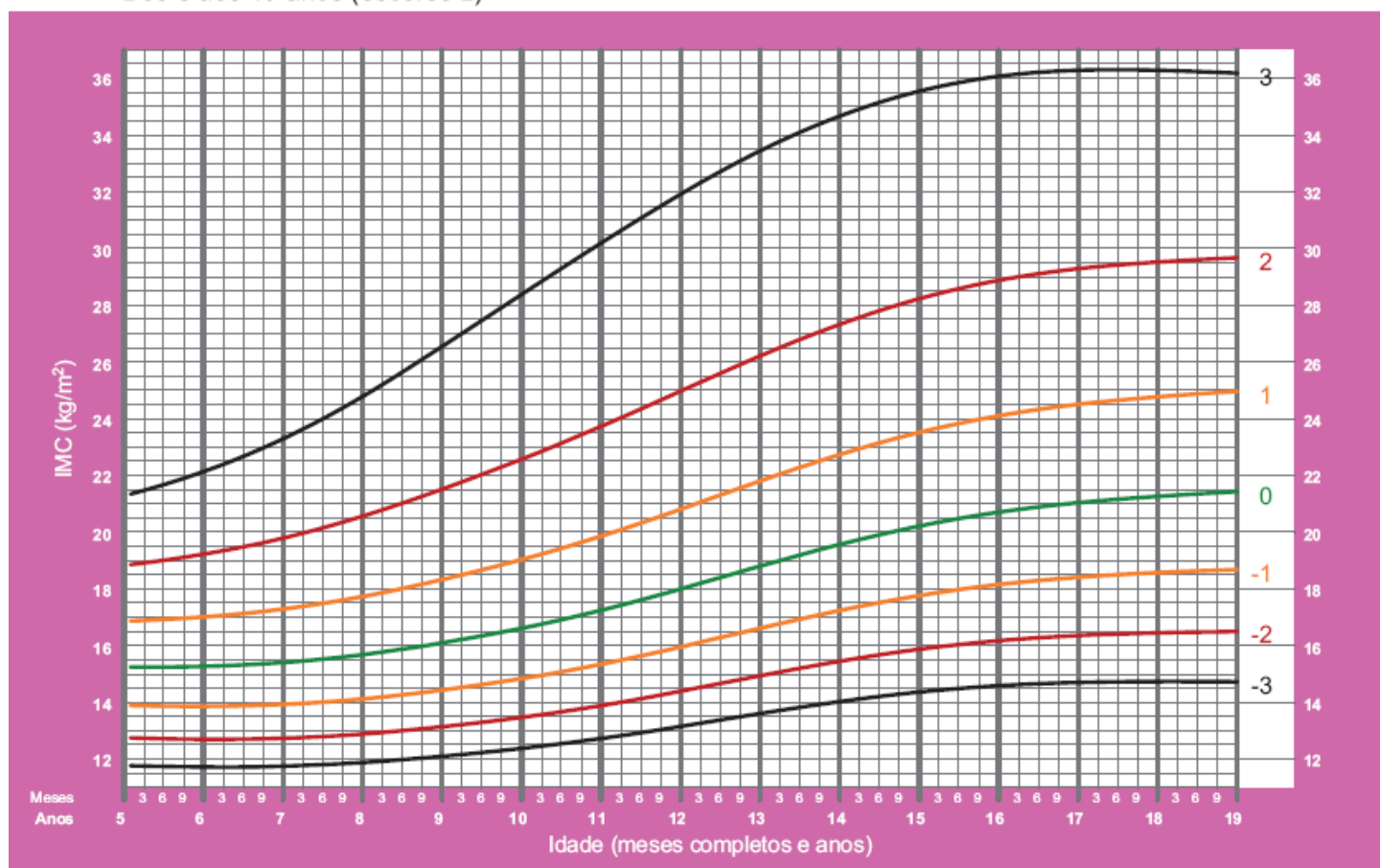
IMC por idade MENINOS

Dos 5 aos 19 anos (escores-z)



2007 WHO Reference

Figura 10.15 Curvas de IMC (índice de massa corporal por idade) para meninos de 5 a 19 anos com base em escores-z (WHO).



2007 WHO Reference

Figura 10.16 Curvas de IMC (índice de massa corporal por idade) para meninas de 5 a 19 anos com base em escores-z (WHO).

Quadro 10.17

Classificação da circunferência da cintura (cc).

Sexo	Normal	Aumentada	Muito aumentada
Masculino	< 94 cm	94 a 102 cm	≥ 102 cm
Feminino	< 80 cm	80 a 88 cm	≥ 88 cm

Fonte: WHO, 1998.

Para avaliação de sobrepeso e obesidade, o IMC é um indicador prático, de baixo custo e com boa validade diagnóstica (Quadro 10.18).

Cumpramos ressaltar, contudo, que atletas que possuem elevado percentual de massa muscular podem ser considerados com sobrepeso ou obesos, o que seria um falso-positivo (Figura 10.20). Para indivíduos com esse perfil, o mais adequado seria realizar uma análise de composição corporal por bioimpedância tetrapolar ou densitometria corporal total. Contudo, esses exames requerem aparelhos específicos, não fazendo parte do exame físico padrão. Como alternativa a esses métodos complexos, pode-se utilizar protocolos com a utilização do adipômetro para mensurar a gordura subcutânea em diversos pontos anatômicos, tais como: bíceps, tríceps, suprailíaca, subescapular, coxa. Com esses dados e utilizando tabelas, é possível estimar o percentual de gordura corporal. Esses protocolos são mais comumente aplicados por nutricionistas e profissionais de educação física.

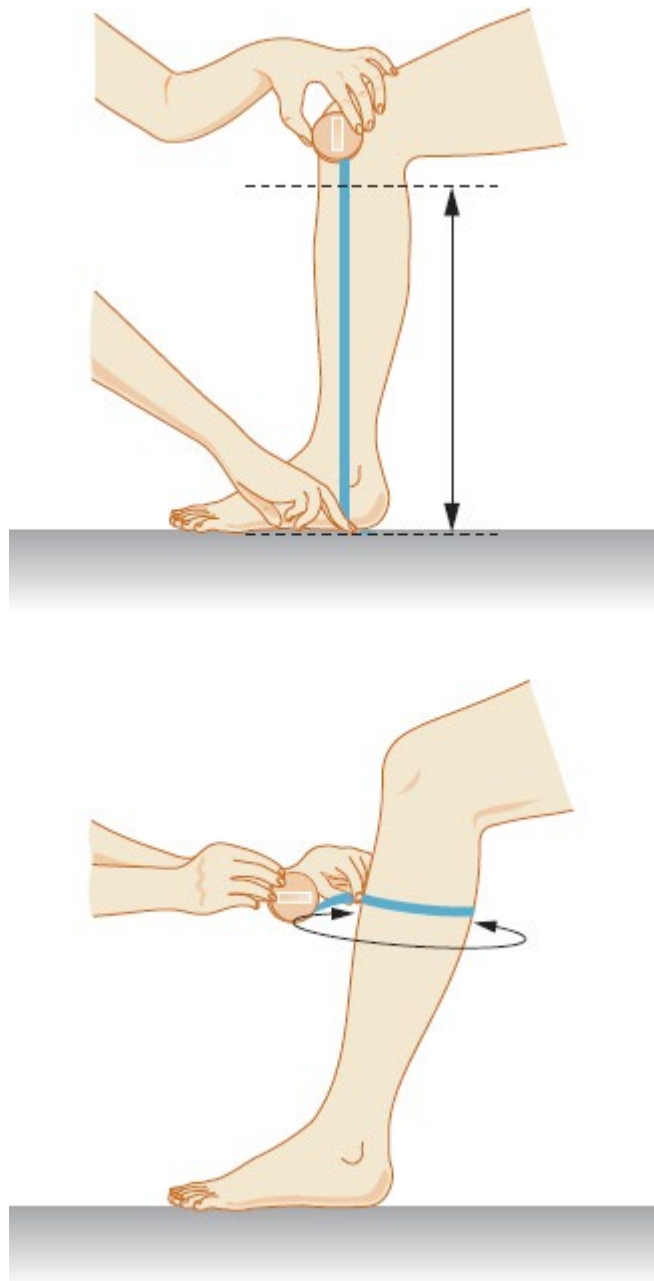


Figura 10.17 Técnica de medida da circunferência da panturrilha.



Figura 10.18 Posicionamento correto para a medida do perímetro cefálico do bebê.

Boxe

Obesidade central e obesidade periférica

A obesidade abdominal está associada a: dislipidemia, diabetes tipo 2, resistência insulínica, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio. Este tipo de obesidade está associado a maior risco de mortalidade.

De maneira representativa, a obesidade abdominal ou central, também denominada obesidade androide, configura forma de maçã ao corpo, na qual a gordura se concentra mais na região do tórax e abdome, sendo mais comum em homens. A deposição de gordura é visceral.

Na obesidade periférica ou ginecoide, mais frequente em mulheres, o acúmulo de gordura predomina nos quadris e nas coxas. O corpo lembra o formato de uma pera. A deposição de gordura predominante é a subcutânea (Figura 10.21).

Desnutrição

A American Dietetics Association (ADA) e a American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) recomendam um conjunto de parâmetros para identificar a desnutrição em adultos na prática clínica, fazendo-se necessária a presença de dois ou mais dos seguintes elementos:

Ingestão insuficiente de energia

Perda de peso

Perda de gordura subcutânea

Perda de massa muscular

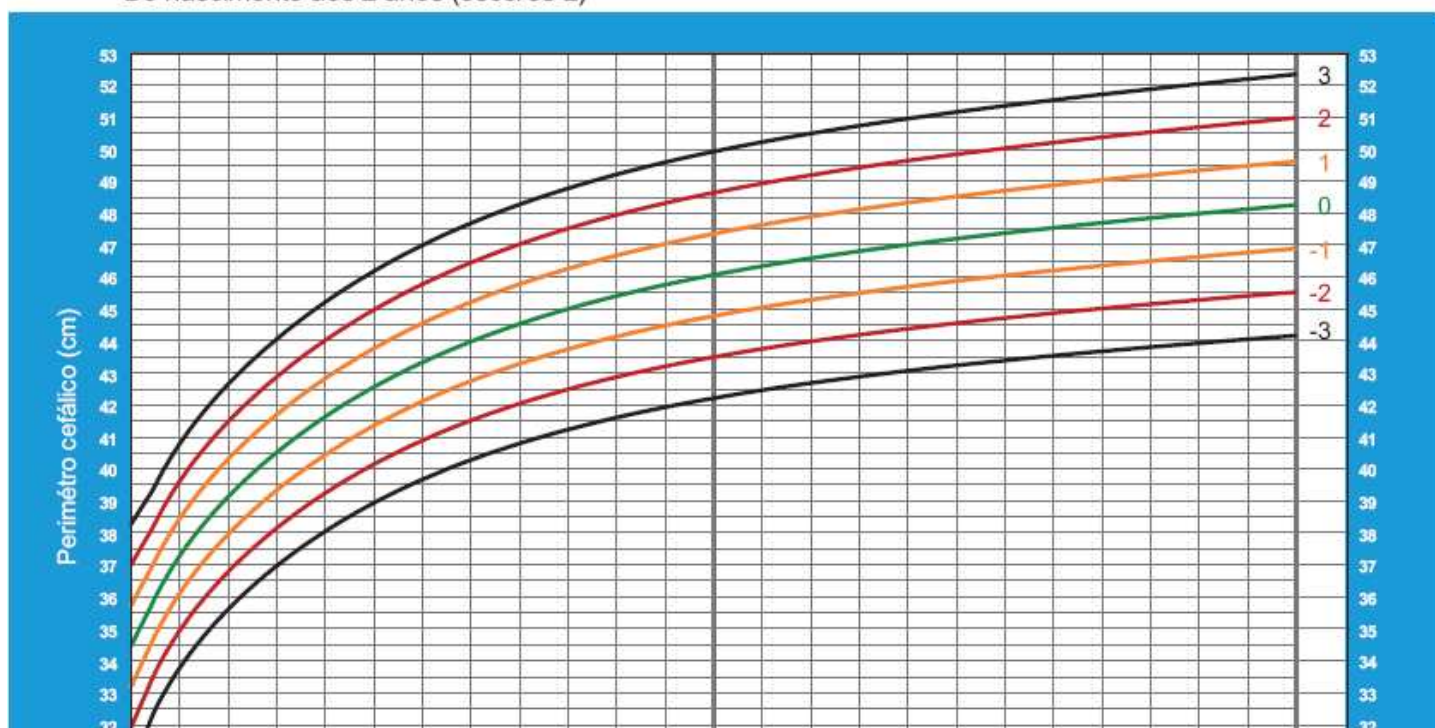
Acúmulo de líquido localizado ou generalizado, que, em algumas ocasiões, pode mascarar a perda de peso

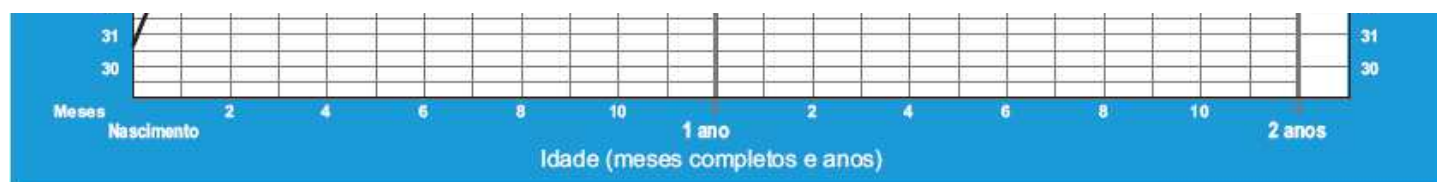
Capacidade funcional diminuída, medida pela força do aperto de mão, com uso de dinamômetro.

A ingestão insuficiente de alimentos pode estar relacionada a: inanição, áreas de insegurança alimentar, pobreza, anorexia, dependência do idoso, como incapacidade de sair de casa para comprar alimentos e/ou de cozinhar, condição patológica, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) avançada, qualquer acometimento inflamatório da boca ou esôfago.

Perímetro cefálico por idade MENINOS

Do nascimento aos 2 anos (escores-z)

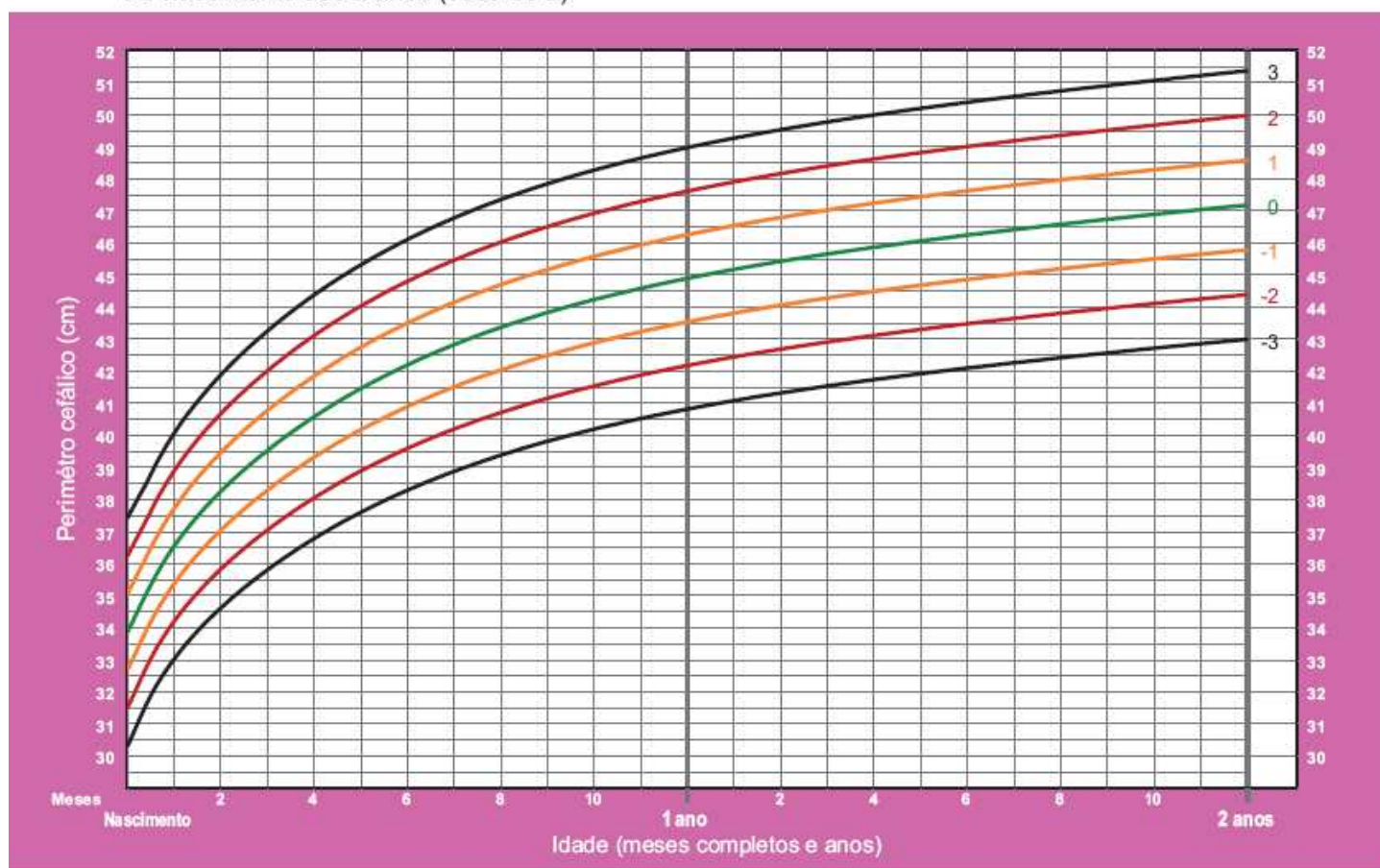




WHO Child Growth Standards

Perímetro cefálico por idade MENINAS

Do nascimento aos 2 anos (escores-z)



WHO Child Growth Standards

Figura 10.19 Curvas de crescimento (perímetro cefálico por idade) em crianças de 0 a 2 anos com base em escores-z (WHO). A linha verde significa os valores médios do PC, onde se espera encontrar os valores das medidas da criança ao longo do tempo. Valores na linha vermelha inferior indicam microcefalia e na linha vermelha superior, macrocefalia.

Quadro 10.18

Classificação de sobrepeso e obesidade em adultos pelo IMC.

IMC	Estado nutricional
25,00 a 29,99	Sobrepeso
30,00 a 34,99	Obesidade grau I
35,00 a 39,99	Obesidade grau II ou obeso grave
40 a 49,9	Obesidade grau III ou obesidade mórbida
≥ 50	Superobesidade

Fonte: Renquist, 1998.

A avaliação é verificada pela perda de peso ponderal, a qual se refere à porcentagem de perda de peso tendo como base o peso usual (PU). Seu grau é estimado, conforme o Quadro 10.19. Para isso, deve-se obter o PU ou o peso máximo do paciente há 6 meses e seu peso atual (PA).

Há instrumentos que facilitam o diagnóstico de desnutrição em adultos e idosos. A avaliação subjetiva global (Detsky *et al.*), utilizada para adultos, é um método simples de avaliação nutricional, que consta de um questionário sobre a história clínica, o exame físico e a capacidade funcional do paciente, sendo mais utilizada no ambiente hospitalar. Classifica-se o estado nutricional do paciente em bem nutrido, moderadamente desnutrido ou suspeito de desnutrição e gravemente desnutrido (ver *Roteiro pedagógico para avaliação nutricional*.)

A Miniavaliação Nutricional, validada para a população idosa brasileira, é um instrumento multidimensional de avaliação nutricional que permite o diagnóstico da desnutrição e do risco de desnutrição nesta faixa etária, de modo a permitir intervenção nutricional multidisciplinar precoce quando necessário (http://www.mna-elderly.com/forms/mna_guide_portuguese.pdf).

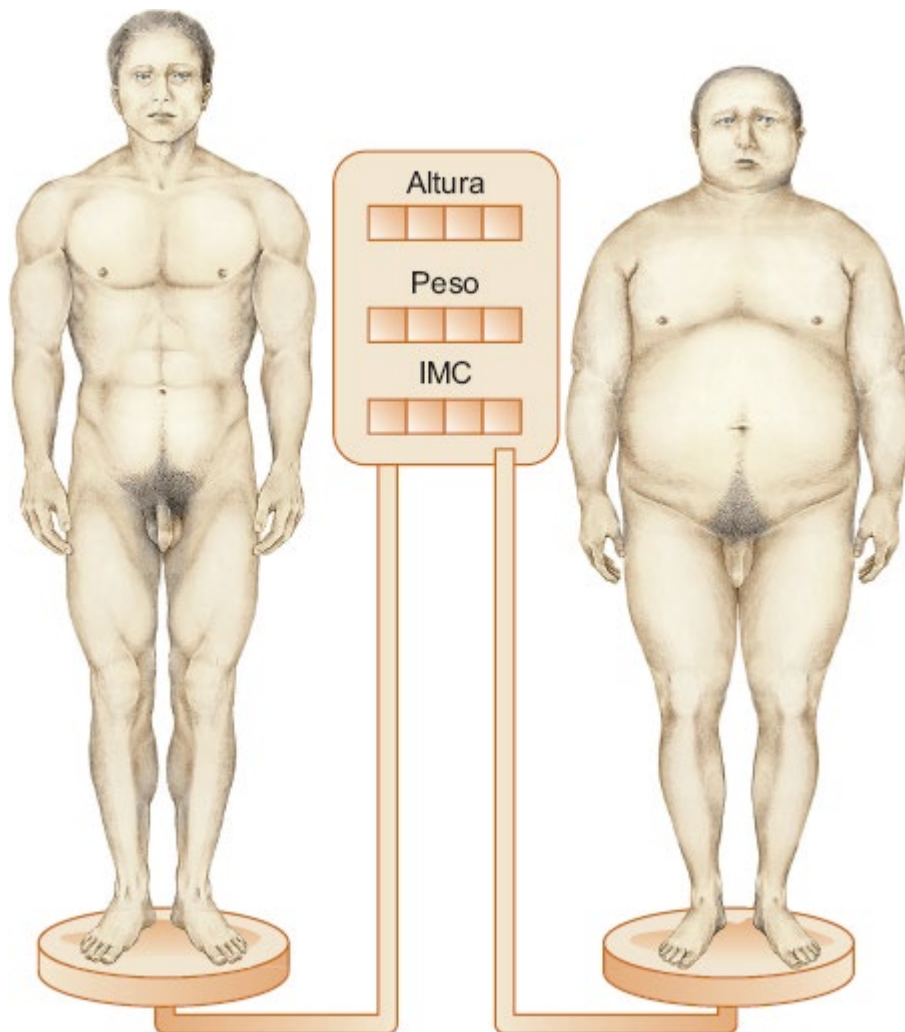


Figura 10.20 Comparação do IMC em indivíduos com diferentes perfis de composição corporal.

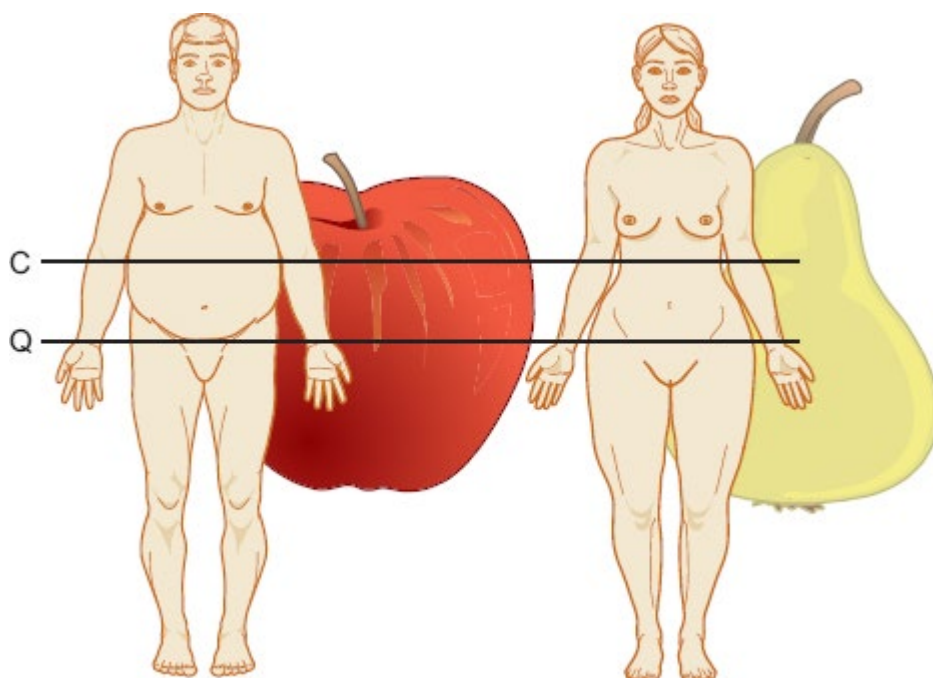


Figura 10.21 Relação cintura-quadril. Obesidade tipo androide (forma de maçã) e tipo ginecoide (forma de pera). C = cintura; Q = quadril. (Porto, 2001.)

Quadro 10.19

Classificação do percentual de perda de peso conforme tempo.

Tempo	Perda significativa (%)	Perda grave (%)
1 semana	1 a 5	> 2
1 mês	5	> 5
3 meses	7,5	> 7,5
6 meses	10	> 10

Fonte: Blackburn *et al.*, 1977.

A perda de gordura subcutânea e a massa magra devem ser avaliadas, sendo importante a observação, durante o exame físico, de todos os parâmetros expostos no Quadro 10.20.

A avaliação da presença de edema deve ser criteriosa em pacientes com distúrbios venosos, linfáticos, insuficiência cardíaca, hepatopatias, síndrome nefrótica. Além dessas condições clínicas, o decúbito do paciente pode influenciar a avaliação. Em pacientes que ficam muito tempo em posição ereta ou sentada, deve-se investigar a presença de edema nos membros inferiores, começando pelo tornozelo, enquanto nos que permanecem acamados o local a ser examinado é a região lombossacra.

Capacidade funcional diminuída está associada à desnutrição grave e à redução das atividades da vida diária. Pode ser avaliada por dinamômetro, pela força do aperto de mão ou, ainda, pode-se solicitar que o paciente segure uma folha de papel e a tracione. Pacientes com déficit funcional deixam a folha escorregar por entre os dedos facilmente.

Outros sinais clínicos de desnutrição e hipovitaminoses estão descritos no Quadro 10.21 (ver *Metabolismo e condições nutricionais* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Boxe

Desnutrição e morbimortalidade

A desnutrição aumenta a morbimortalidade de pacientes institucionalizados, incluindo risco de infecções,

úlceras por pressão e complicações pós-cirúrgicas. As hipovitaminoses também são frequentes e muitas vezes passam despercebidas nestes pacientes. Assim, identificar precocemente desnutrição e hipovitaminoses promove ganhos na saúde e na qualidade de vida dos pacientes, bem como redução de custos nos sistema de saúde.

Quadro 10.20

Avaliação do estado nutricional segundo gordura subcutânea e massa muscular.

Área corporal	Dicas	Estado nutricional		
		Desnutrição grave	Desnutrição leve/moderada	Bem nutrido
Gordura subcutânea				
Abaixo do olhos	—	Círculos escuros, depressão, pele solta e flácida, “olhos fundos”	—	Depósito de gordura visível
Face	Observar bochechas bilateralmente	Perda da bola gordurosa de Bichat	Depressão leve	Bola gordurosa de Bichat preservada
Região do tríceps e bíceps	Cuidado para não prender o músculo ao pinçar o local, movimentar a pele entre os dedos	Pouco espaço de gordura entre os dedos ou os dedos praticamente se tocam	—	Tecido adiposo abundante
Abdome	Observar região supraumbilical	Umbigo em forma de chapéu	Umbigo em forma de chapéu, pouco evidente	Não há alteração
Massa muscular				
Têmporas	Observar de frente, olhar os dois lados	Depressão Sinal da “asa quebrada” quando em associação à perda da bola gordurosa de Bichat	Depressão leve	Músculo bem definido
Clavícula	Observar se o osso está proeminente	Osso protuberante	Osso levemente proeminente	Osso não proeminente

Ombros	O paciente deve posicionar os braços ao lado do corpo: procurar por ossos proeminentes	Ombro em forma quadrada (formando ângulo reto), ossos proeminentes	Acrômio levemente protuberante	Formato arredondado na curva da junção do ombro com o pescoço e do ombro com o braço
Escápula	Procurar por ossos proeminentes; o paciente deve estar com o braço esticado para a frente e a mão encostada em uma superfície sólida	Ossos proeminentes, visíveis, depressão entre a escápula, as costelas, o ombro e a coluna vertebral	Depressão leve ou ossos levemente proeminentes	Ossos não proeminentes, sem depressão significativa
Músculo paravertebral	Observar redução de sustentação do tronco e exposição de arcos costais	Arcos costais proeminentes e presença de cifose	Depressão leve ou arcos costais levemente proeminentes	Arcos costais são proeminentes
Abdome	Observar abdome bilateralmente	Abdome escavado	Pode não apresentar alterações	Abdome sem alterações
Músculo interósseo	Observar no dorso da mão o músculo entre o polegar e o indicador quando esses dedos estão unidos e/ou separados	Área entre o dedo indicador e o polegar achatada ou com depressão	Depressão leve	Músculo proeminente
Quadríceps	Pinçar e sentir o volume do músculo	Parte interna da coxa com depressão	Depressão leve	Sem depressão
Músculo da panturrilha	Com o paciente em posição supina, erguer sua perna	Panturrilha solta	Panturrilha levemente solta	Musculatura aderida à ossatura

Fonte: Kamimura *et al.*, 2006.

A desnutrição infantil não pode ser negligenciada, pois ainda há muitas crianças em situação de risco alimentar, e não deve ser avaliada apenas pela determinação do peso. Devem ser incluídas medidas antropométricas, dados clínicos e exames laboratoriais. Pode ser leve, moderada ou grave. Em qualquer grau aumenta o risco de infecções de diversas naturezas, com elevado índice de mortalidade.

O kwashiorkor e o marasmo são formas clínicas especiais, relacionadas a baixa ingestão de proteínas.

Avaliação do consumo de alimentos

Ver *Alterações do peso* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Desenvolvimento físico

Uma determinação exata requer um estudo antropométrico rigoroso. Contudo, na prática, é suficiente uma avaliação simplificada, levando-se em conta a idade e o sexo. Para isso, tomam-se como elementos básicos a altura e a estrutura somática.

Em primeiro lugar, compara-se a altura encontrada com as medidas constantes das tabelas de valores normais.

Para avaliação da estrutura somática, não se dispõe de tabelas. É feita pela inspeção global, acrescida de informações a respeito do desenvolvimento osteomuscular.

Os achados podem ser enquadrados nas seguintes alternativas:

- Desenvolvimento normal
- Hiperdesenvolvimento
- Hipodesenvolvimento
- Hábito grácil
- Infantilismo.

Hábito grácil corresponde à constituição corporal frágil e delgada, caracterizada por ossatura fina, musculatura pouco desenvolvida, juntamente com uma altura e um peso abaixo dos níveis normais. É uma condição constitucional, sem significado patológico.

Quadro 10.21 Sinais físicos indicativos ou sugestivos de desnutrição.			
Área corporal	Aparência normal	Sinais associados com desnutrição	Doença possível ou deficiência de nutriente
Cabelo	Firme, brilhante, difícil de arrancar	Perda do brilho natural; seco e feio Fino e esparso Seroso e quebradiço; fino Despigmentado Sinal da bandeira Fácil de arrancar (sem dor)	Kwashiorkor e, menos comum, marasmo
Face	Cor da pele uniforme; lisa; rósea; aparência saudável; sem edema	Seborreia nasolabial (pele estratificada em volta das narinas) Face edemaciada (face em lua cheia) Palidez	Riboflavina Ferro Kwashiorkor
Olhos	Brilhantes; claros; sem feridas nos epicantos; membranas úmidas e róseas; sem vasos proeminentes ou acúmulo de tecido esclerótico	Conjuntiva pálida Membranas vermelhas Manchas de Bitot Xerose conjuntival (secura) Xerose córnea (secura) Queratomalacia (córnea adelgada)	Anemia (ferro) Vitamina A Riboflavina, piridoxina

		Vermelhidão e fissuras nos epicantos Arco córneo (anel branco ao redor do olho) Xantelasma (pequenas bolsas amareladas ao redor dos olhos)	Hiperlipidemia
Lábios	Lisos sem edemas ou rachaduras	Estomatite angular (lesões róseas ou brancas nos cantos da boca) Escaras no ângulo Queilose (avermelhamento ou edema dos lábios e boca)	Riboflavina
Língua	Aparência vermelha profunda; não edemaciada ou lisa	Língua escarlate e inflamada Língua magenta (púrpura) Língua edematosa Papila filiforme (atrofia e hipertrofia)	Ácido nicotínico Riboflavina Niacina Ácido fólico Vitamina B ₁₂
Dentes	Sem cavidades; sem dor; brilhantes	Esmalte manchado Cáries (cavidades) Dentes faltando	Flúor Açúcar em excesso
Gengivas	Saudáveis; vermelhas; não sangrantes e sem edema	Esponjosas, sangrando Gengiva vazante	Vitamina C
Pele	Sem erupções; edema ou manchas	Xerose (secura) Hiperqueratose folicular (pele em papel de areia) Petéquias (pequenas hemorragias na pele) Dermatose pelagra (pigmentação edematosa avermelhada nas áreas de exposição ao sol) Equimoses em excesso Dermatose cosmética descamativa Dermatoses vulvar e escrotal Xantomias (depósitos de gordura sob a pele e ao redor das articulações)	Vitamina A Vitamina C Ácido nicotínico Vitamina K Kwashiorkor Riboflavina Hiperlipidemia
Unhas	Firmes; róseas	Colloníquia (forma de colher)	Ferro

Fonte: Vannucchi, Unamuno e Marchini, 1996.

Infantilismo refere-se à persistência anormal das características infantis na idade adulta.

Hiperdesenvolvimento é praticamente sinônimo de *gigantismo*.

Hipodesenvolvimento confunde-se com *nanismo*. Todavia, não são condições absolutamente iguais, havendo entre um e outro diferenças de grau e qualidade.

O reconhecimento do nanismo e do gigantismo tem na altura um elemento fundamental. Não se pode esquecer, contudo, de que os limites máximos e mínimos aceitos como normais variam conforme a etnia e em função de muitos outros fatores, entre os quais se destacam as condições nutricionais.

Boxe

Altura normal

No Brasil, aceitam-se os seguintes limites máximos de altura para indivíduos adultos normais: 1,90 m para o sexo masculino e 1,80 m para o feminino. Como altura mínima normal para ambos os sexos, 1,50 m. Para crianças, ver Figuras 10.2 a 10.5.

O desenvolvimento na sua fase embrionária e fetal parece ser primariamente regulado por fatores nutricionais e hereditários. Entretanto, alguns hormônios têm ação na diferenciação de determinados tecidos. Com relação ao crescimento linear *in utero*, a insulina talvez funcione como “hormônio de crescimento”, haja vista a criança de mãe diabética. O hormônio tireoidiano é necessário para a manutenção normal do cérebro e dos ossos fetais, enquanto os androgênios determinam a diferenciação sexual masculina.

Após o nascimento, o desenvolvimento físico resulta do processo de crescimento e de maturação musculoesquelética. Eventos patológicos que, porventura, acometam o indivíduo nessas etapas podem levar a deficiências no seu desenvolvimento global. Esse fato é nitidamente observado nos portadores de doenças crônicas, carências nutricionais graves, como também nas deficiências hormonais.

O crescimento das diferentes dimensões do corpo (estatura, segmento superior e segmento inferior) depende do crescimento do esqueleto, o qual determina o crescimento total e as proporções corporais. As doenças ósseas congênicas e adquiridas rompem o equilíbrio dessas dimensões.

No que se refere aos aspectos do desenvolvimento sexual de caráter eminentemente funcional, duas etapas são marcantes. Na primeira, que corresponde à fase embrionária e fetal, ocorre diferenciação das gônadas, formação da genitália interna e externa. Alterações em nível cromossômico, por deficiência de hormônios hipotalâmicos ou hipofisários, defeito de síntese, uso de medicamentos, drogas e neoplasias produtoras de hormônios, podem ser a causa de genitália ambígua, com virilização ou feminilização, levando a quadros de pseudo-hermafroditismo masculino ou feminino. A segunda etapa ocorre na puberdade, por ocasião do aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Nos adolescentes do sexo masculino, é comum o aparecimento de ginecomastia puberal. No sexo feminino, anormalidades do ciclo menstrual, com hiperprodução de androgênios e aparecimento de hirsutismo, podem ter início nesta fase.

Os distúrbios originados na etapa embrionária e fetal tornam-se mais evidentes por ocasião da puberdade.

Durante a adolescência, utilizam-se os critérios de Tanner para avaliação da maturidade sexual (Figuras 10.22 a 10.25).

Outros aspectos do desenvolvimento não podem ser considerados isoladamente, como psicomotor, intelectual, afetivo e social. O próprio desenvolvimento físico encontra-se sob estreita dependência de fatores emocionais e sociais. Prova disso é a *síndrome de privação materna*, interferindo no crescimento da criança, fato observado em orfanatos e instituições similares. Do mesmo modo, distúrbios no desenvolvimento físico e sexual podem acarretar sérias consequências na esfera emocional, como se observa nos adolescentes com ginecomastia, nas moças com hirsutismo e em pacientes com nanismo.

Outro aspecto relevante é o da proporcionalidade entre os diversos segmentos do corpo. Pacientes portadores de gigantismo, hipogonadismo hipergonadotrófico (eunuco), apresentam envergadura maior que a altura.

Boxe

Distúrbios do desenvolvimento físico e sexual

Gigantismo acromegálico: decorre de hiperfunção do lóbulo anterior da hipófise. Além da estatura elevada, a cabeça é maior, as arcadas supraorbitárias, os malaras e o mento são proeminentes. Nariz aumentado de tamanho, pele grossa, mãos e pés enormes completam o quadro.

Gigantismo infantil: caracteriza-se por apresentar extremidades inferiores muito longas, lembrando o aspecto dos eunucos. Dependem de hiperfunção da hipófise anterior que tenha começado antes da soldadura das epífises. Persistindo o hiperfuncionamento da hipófise depois da união epifisária, instala-se a acromegalia.

Nanismo acondroplásico: chama a atenção a nítida desigualdade entre o tamanho da cabeça e do tronco e o comprimento dos membros. A cabeça e o tronco têm dimensões aproximadas às do adulto normal, enquanto as pernas são curtas e arqueadas. A musculatura é bem desenvolvida, e os órgãos genitais são normais.

Cretinismo: o nanismo por hipofunção congênita da glândula tireoide caracteriza-se pela falta de desenvolvimento de todos os segmentos do corpo – cabeça, tronco e membros. Conservam-se as proporções da criança, na qual a cabeça é relativamente grande. Salienta-se o ventre volumoso, os lábios e as pálpebras são grossos, o nariz é chato, e a pele grossa e seca. Os cretinos são sempre de baixo nível mental e chegam, com frequência, à idiotia.

Nanismo hipofisário: tem a cabeça e o tronco normalmente proporcionados, mas pequenos. A falta do crescimento é geral, mas acaba por ter os membros desproporcionalmente longos em relação ao resto do corpo, ou seja, a envergadura é maior que a altura. Os órgãos genitais são hipodesenvolvidos. Estes indivíduos adquirem precocemente aspecto senil, a que se denomina *progeria*.

Nanismo do raquitismo: depende fundamentalmente de mau desenvolvimento e deformidades da coluna e dos ossos longos, destacando-se a escoliose e o encurvamento dos ossos das pernas. Observam-se ainda tórax cariniforme, rosário raquítico e outras anormalidades.



Figura 10.22 Critérios de Tanner para avaliação da maturidade sexual. Desenvolvimento mamário feminino.

Fácies

É o conjunto de dados exibidos na face do paciente. É a resultante dos traços anatômicos mais a expressão fisionômica. Não apenas os elementos estáticos, mas, e principalmente, a expressão do olhar, os movimentos das asas do nariz e a posição da boca.



Figura 10.23 Critérios de Tanner para avaliação da maturidade sexual. Desenvolvimento puberal feminino.

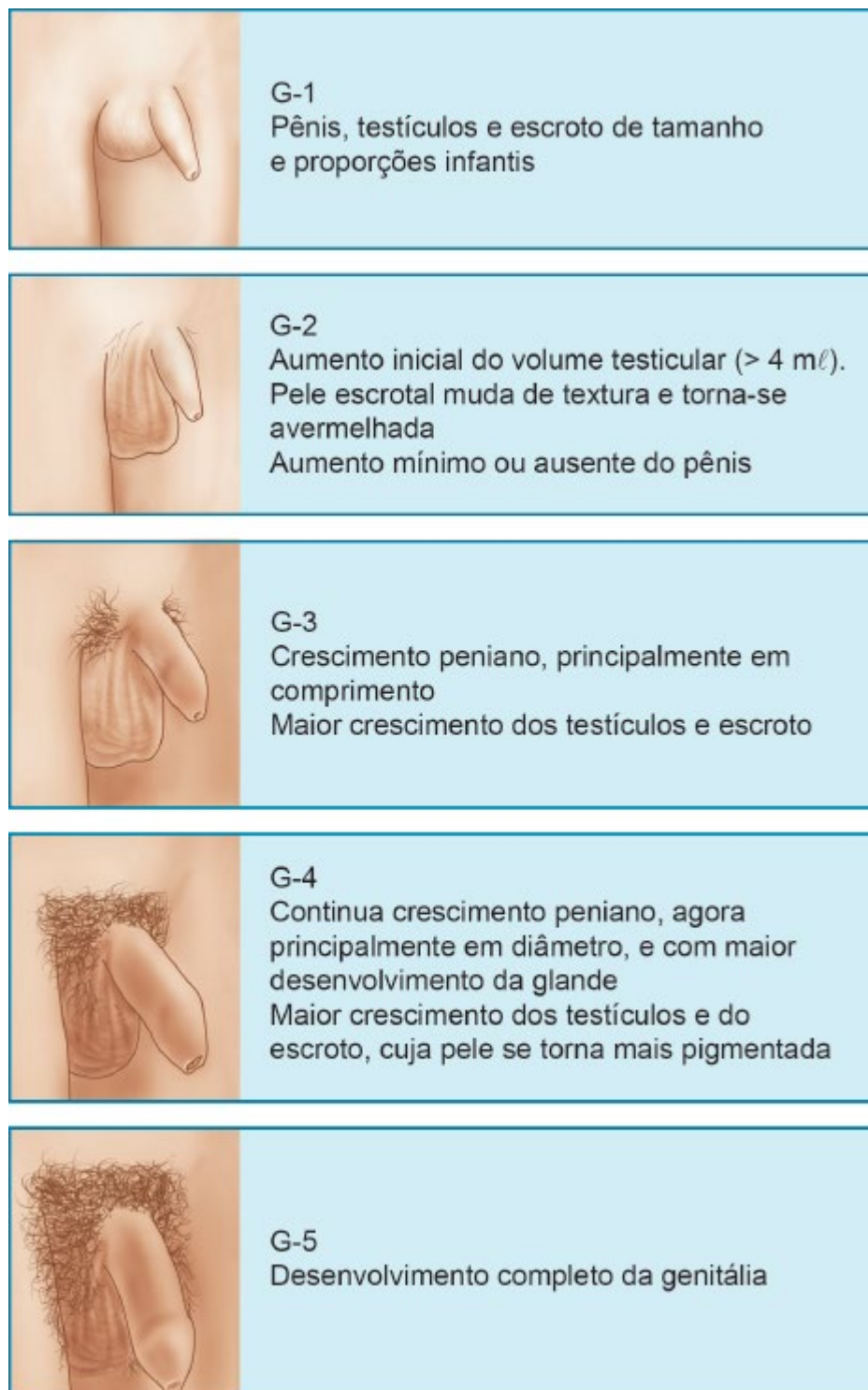


Figura 10.24 Critérios de Tanner para avaliação da maturidade sexual. Desenvolvimento genital masculino.

Certas doenças imprimem na face traços característicos, e, algumas vezes, o diagnóstico nasce da simples observação do rosto do paciente (Figura 10.26).

Os principais tipos de fâcies são:

Fâcies normal ou atípica: comporta muitas variações, facilmente reconhecidas por todos, mas é preciso ensinar o *olho a ver*, conforme disse William Osler. Mesmo quando não há traços anatômicos ou expressão fisionômica para caracterizar um dos tipos de fâcies descrito a seguir, é importante identificar, no rosto do paciente, sinais indicativos de tristeza, ansiedade, medo, indiferença, apreensão (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*)

Fâcies hipocrática: olhos fundos, parados e inexpressivos chamam logo a atenção do examinador. O nariz afila-se, e os lábios se tornam adelgaçados. “Batimentos das asas do nariz” também costumam ser observados. Quase sempre o rosto está coberto de suor. Palidez cutânea e uma discreta cianose labial completam a fâcies hipocrática. Esse tipo de fâcies indica doença grave e quase nunca falta nos estados agônicos das afecções que evoluem de modo mais ou menos lento (Figura 10.27)

Fâcies renal: o elemento característico desse tipo de fâcies é o edema que predomina ao redor dos olhos. Completa o quadro

a palidez cutânea. É observada nas doenças dos rins, particularmente na síndrome nefrótica e nas glomerulonefrites

Fácies leonina: as alterações que a compõem são produzidas pelas lesões do mal de Hansen. A pele, além de espessa, é sede de grande número de lepromas de tamanhos variados e confluentes, em maior número na fronte. Os supercílios caem, o nariz se espessa e se alarga. Os lábios tornam-se mais grossos e proeminentes. As bochechas e o mento se deformam pelo aparecimento de nódulos. A barba escasseia ou desaparece. Essas alterações em conjunto conferem ao rosto do paciente um aspecto de cara de leão, origem de sua denominação



Figura 10.25 Critérios de Tanner para avaliação da maturidade sexual. Desenvolvimento puberal masculino.



Figura 10.26 Duas fotografias de uma mesma pessoa mostrando como certas doenças imprimem na face traços característicos de grande valia no diagnóstico. Em **A**, são visíveis os elementos que caracterizam a fácies mixedematosa, ao passo que em **B** a paciente já apresenta fácies normal após tratamento adequado.

Fácies adenoidiana: os elementos fundamentais são o nariz pequeno e afilado e a boca sempre entreaberta. Aparece nos indivíduos portadores de hipertrofia das adenoides, as quais dificultam a respiração pelo nariz ao obstruírem os orifícios posteriores das fossas nasais

Fácies parkinsoniana, cérea ou em máscara: caracteriza-se por ser inexpressiva, com rigidez facial (Figura 10.28). A fácies parkinsoniana é observada na síndrome ou na doença de Parkinson

Fácies basedowiana: seu traço mais característico reside nos olhos, que são salientes (exoftalmia) e brilhantes, destacando-se sobremaneira no rosto magro. A expressão fisionômica indica vivacidade. Contudo, às vezes, tem um aspecto de espanto e ansiedade. Outro elemento que salienta as características da fácies basedowiana é a presença de um bócio. Indica hipertireoidismo (Figura 10.29)

Fácies mixedematosa: constituída por um rosto arredondado, nariz e lábios grossos, pele seca, espessada e com acentuação de seus sulcos. As pálpebras tornam-se infiltradas e enrugadas. Os supercílios são escassos e os cabelos secos e sem brilho. Além dessas características morfológicas, destaca-se uma expressão fisionômica indicativa de desânimo, apatia e estupidez (Figura 10.26). Esse tipo de fácies aparece no hipotireoidismo ou mixedema

Fácies acromegálica: caracterizada pela saliência das arcadas supraorbitárias, proeminência das maçãs do rosto e maior desenvolvimento do maxilar inferior, além do aumento do tamanho do nariz, lábios e orelhas. Nesse conjunto de estruturas hipertrofiadas, os olhos parecem pequenos (Figura 10.30)

Fácies cushingoide ou de lua cheia: como a própria denominação revela, chama a atenção de imediato o arredondamento do rosto, com atenuação dos traços faciais (Figura 10.31). Secundariamente, deve ser assinalado o aparecimento de acne. Este tipo de fácies é observado nos casos de síndrome de Cushing por hiperfunção do córtex suprarrenal. Pode ocorrer também nos pacientes que fazem uso prolongado de corticoides

Fácies mongoloide: está na fenda palpebral seu elemento característico: é uma prega cutânea (epicanto) que torna os olhos oblíquos, bem distantes um do outro, lembrando o tipo de olhos dos chineses. Acessoriamente, nota-se um rosto redondo, boca quase sempre entreaberta e uma expressão fisionômica de pouca inteligência ou mesmo de completa idiotia. É observada no mongolismo ou trissomia do par 21 ou síndrome de Down, que é tradução de um defeito genético (Figura 10.32)



Figura 10.27 Fácies hipocrática.



Figura 10.28 Fácies parkinsoniana.



Figura 10.29 Fácies basedowiana.



52 anos

Figura 10.30 Fácies acromegálica.



Figura 10.31 Fácies cushingoide ou de lua cheia. **A.** Por hiperfunção do córtex suprarrenal. **B.** Iatrogênica (tratamento com corticoide), observando-se, além da forma em lua cheia, o rubor facial.

Fácies de depressão: as características desse tipo de fácies estão na inexpressividade do rosto. O paciente apresenta-se cabisbaixo, os olhos com pouco brilho e fixos em um ponto distante. Muitas vezes o olhar permanece voltado para o chão. O sulco nasolabial se acentua, e o canto da boca se rebaixa. O conjunto fisionômico denota indiferença, tristeza e sofrimento emocional. Esse tipo de fácies é observado na síndrome de depressão

Fácies pseudobulbar: tem como principal característica súbitas crises de choro ou riso, involuntárias, mas conscientes, que levam o paciente a tentar contê-las, dando um aspecto espasmódico à fâcies. Aparece geralmente na paralisia pseudobulbar

Fácies da paralisia facial periférica: é bastante comum. Chama a atenção a assimetria da face, com impossibilidade de fechar as pálpebras, repuxamento da boca para o lado são e apagamento do sulco nasolabial

Fácies miastênica ou de Hutchinson: caracterizada por ptose palpebral bilateral que obriga o paciente a franzir a testa e levantar a cabeça. Ocorre na miastenia *gravis* e em outras miopatias que comprometem os músculos da pálpebra superior (Figura 10.33)

Fácies do deficiente mental: é muito característica, mas de difícil descrição. Os traços faciais são apagados e grosseiros; a boca constantemente entreaberta, às vezes com salivação. Hipertelorismo e estrabismo, quando presentes, acentuam essas características morfológicas. Todavia, o elemento fundamental desse tipo de fâcies está na expressão fisionômica. O olhar é desprovido de objetividade, e os olhos se movimentam sem se fixarem em nada, traduzindo um constante alheamento ao meio ambiente. É comum que tais pacientes tenham sempre nos lábios um meio sorriso sem motivação e que se acentua em resposta a qualquer solicitação. Acompanha tudo isso uma voz grave percebida por um falar de meias-palavras, às vezes substituído por um simples ronronar



Figura 10.32 Fâcies mongoloide.



Figura 10.33 Fácies miastênica.

Fácies etílica: chamam a atenção os olhos avermelhados e certa ruborização da face. O hálito etílico, a voz pastosa e um sorriso meio indefinido completam a fácies etílica

Fácies esclerodérmica: denominada também *fácies de múmia*, justamente porque sua característica fundamental é a quase completa imobilidade facial. Isso se deve às alterações da pele, que se torna apegaminhada, endurecida e aderente aos planos profundos, com repuxamento dos lábios, afinamento do nariz e imobilização das pálpebras. A fisionomia é inexpressiva, parada, imutável, justificando a comparação com múmia.

Atitude e decúbito preferido no leito

Para facilitar a compreensão, é conveniente analisar conjuntamente “atitude” e “decúbito preferido”, definindo-se atitude como a posição adotada pelo paciente no leito ou fora dele, por comodidade, hábito ou com o objetivo de conseguir alívio para algum padecimento.

Algumas posições são conscientemente procuradas pelo paciente (voluntárias), enquanto outras independem de sua vontade ou são resultantes de estímulos cerebrais (involuntárias).

Só têm valor diagnóstico as atitudes involuntárias ou as que proporcionam alívio para algum sintoma. Se isso não for observado, pode-se dizer que o paciente não tem uma atitude específica ou que ela é indiferente.

A classificação mais objetiva é a que separa as atitudes em *voluntárias* e *involuntárias*.

Atitudes voluntárias

As atitudes voluntárias são as que o paciente adota por sua vontade e compreendem a *ortopneica*, a *genupeitoral*, a *posição de cócoras*, a *parkinsoniana* e os *diferentes decúbitos*.

Atitude ortopneica (ortopneia). O paciente adota essa posição para aliviar a falta de ar decorrente de *insuficiência cardíaca*, *asma brônquica* e *ascite volumosa*. Ele permanece sentado à beira do leito com os pés no chão ou em uma banqueta, e as mãos apoiadas no colchão para melhorar um pouco a respiração, que se faz com dificuldade.

Boxe

Nos pacientes em estado grave, costuma-se ver uma posição ortopneica diferente, quando, então, o paciente permanece deitado com os pés estendidos ao longo da cama, mas recosta-se com a ajuda de dois ou mais

travesseiros, na tentativa de colocar o tórax o mais ereto possível.

Atitude genupeitoral (ou de “prece maometana”). O paciente posiciona-se de joelhos com o tronco fletido sobre as coxas, enquanto a face anterior do tórax (peito) põe-se em contato com o solo ou colchão. O rosto descansa sobre as mãos, que também ficam apoiadas no solo ou colchão. Essa posição facilita o enchimento do coração nos casos de derrame pericárdico (Figura 10.34).

Atitude de cócoras (*squatting*). Esta posição é observada em crianças com *cardiopatias congênitas cianóticas*. Os pacientes descobrem, instintivamente, que ela proporciona algum alívio da *hipoxia generalizada*, que acompanha essas cardiopatias, em decorrência da diminuição do retorno venoso para o coração (Figura 10.35).

Atitude parkinsoniana. O paciente com doença de Parkinson, ao se pôr de pé, apresenta semiflexão da cabeça, tronco e membros inferiores e, ao caminhar, parece estar correndo atrás do seu próprio eixo de gravidade.

Atitude em decúbito. A palavra decúbito significa “posição de quem está deitado”. Decúbito preferido, portanto, indica como o paciente prefere ficar no leito, desde que o faça conscientemente, seja por hábito, seja para obter alívio de algum padecimento. Os tipos de decúbito são:

Decúbito lateral (direito e esquerdo): é uma posição que costuma ser adotada quando há dor de origem pleurítica. Por meio dela, o paciente reduz a movimentação dos folhetos pleurais do lado sobre o qual repousa. Ele se deita sobre o lado da dor

Decúbito dorsal: com pernas fletidas sobre as coxas e estas sobre a bacia, é observado nos *processos inflamatórios pelviperitoneais*

Decúbito ventral: é comum nos portadores de *cólica intestinal*. O paciente deita-se de bruços e, às vezes, coloca um travesseiro debaixo do ventre.

Boxe

Lombalgia

Decúbitos com variados graus de *flexão da coluna* são observados nas lombalgias (posição antálgica).



Figura 10.34 Atitude genupeitoral.



Figura 10.35 Atitude de cócoras.

Atitudes involuntárias

As atitudes involuntárias independem da vontade do paciente e incluem a *atitude passiva*, o *ortótono*, o *opistótono*, o *emprostótono*, o *pleurostótono* e a *posição em gatilho e torcicolo e mão pêndula da paralisia radial*.

Atitude passiva. Quando o paciente fica na posição em que é colocado no leito, sem que haja contratura muscular. É observada nos pacientes inconscientes ou comatosos.

Ortótono (*orthos* = reto; *tonus* = tensão). Atitude em que todo o tronco e os membros estão rígidos, sem se curvarem para diante, para trás ou para um dos lados.

Opistótono (*opisthen* = para trás; *tonus* = tensão). Atitude decorrente de contratura da musculatura lombar, sendo observada nos casos de *tétano* e *meningite*. O corpo passa a se apoiar na cabeça e nos calcanhares, emborcando-se como um arco.

Emprostótono (*emprosthen* = para diante; *tonus* = tensão). Observada no *tétano*, na *meningite* e na *raiva*, é o contrário do opistótono, ou seja, o corpo do paciente forma uma concavidade voltada para diante.

Pleurostótono (*pleurothen* = de lado; *tonus* = tensão). É de observação rara no *tétano*, na *meningite* e na *raiva*. O corpo se curva lateralmente.

Posição em gatilho. Encontrada na *irritação meníngea*, é mais comum em crianças e caracteriza-se pela hiperextensão da cabeça, flexão das pernas sobre as coxas e encurvamento do tronco com concavidade para diante.

Torcicolo e mão pêndula da paralisia radial. São atitudes involuntárias relacionadas a determinados segmentos do corpo (Figura 10.36).

Exame das mucosas

As mucosas facilmente examináveis a olho nu e sem auxílio de qualquer aparelho são as *mucosas conjuntivais* (olhos) e as

mucosas labiobucal, lingual e gengival. (Ver Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*.)

O método de exame é a inspeção, coadjuvado por manobras singelas que exponham as mucosas à visão do examinador. Assim, no caso das mucosas orais, solicita-se ao paciente que abra a boca e ponha a língua para fora.

É indispensável uma boa iluminação, de preferência com luz natural, complementada com o emprego de uma pequena lanterna.

Os seguintes parâmetros devem ser analisados:

Coloração

Umidade

Presença de lesões.

Coloração

A coloração normal é róseo-avermelhada, decorrente da rica rede vascular das mucosas. A nomenclatura habitual é *mucosas normocoradas* (ver *Mucosas* no Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*).

As alterações da coloração são apresentadas a seguir.

Descoramento das mucosas. É a diminuição ou a perda da cor róseo-avermelhada. Designa-se este achado *mucosas descoradas* ou *palidez das mucosas*. Procura-se fazer também uma avaliação quantitativa usando-se a escala de uma a quatro cruzeiros (+, ++, +++ e ++++).

Boxe

Mucosas descoradas (+) significam leve diminuição da cor normal, enquanto mucosas descoradas (++++) indicam desaparecimento da coloração rósea. As mucosas tornam-se, então, brancas como uma folha de papel. As situações intermediárias (++ e ++++) vão sendo reconhecidas pela experiência.

O encontro de mucosas descoradas é um achado semiológico de grande valor prático, pois indica a existência de anemia.

Boxe

Anemia

Anemia é uma síndrome de grande importância prática. Há muitos tipos de anemia, e cada uma pode ser determinada por várias causas. O denominador comum é a diminuição das hemácias e da hemoglobina no sangue circulante, responsável pelo descoramento das mucosas. Além de *mucosas descoradas*, fazem parte desta síndrome os seguintes sintomas e sinais: *palidez da pele, fadigabilidade, astenia, palpitações*. Em função do tipo de anemia, outros sinais e sintomas vão se associando. Assim, nas *anemias hemolíticas* observa-se icterícia, nas *anemias megaloblásticas* aparecem alterações nervosas localizadas nos membros inferiores, e assim por diante.

Desde já, o estudante deve aprender os passos a serem dados quando se depara com um paciente portador de anemia. Os achados semiológicos não são suficientes para reconhecer o tipo de anemia. O hemograma é indispensável em todos os pacientes e, quando necessário, são feitos outros exames, tais como testes de resistência das hemácias, teste de falcização, chegando até ao mielograma em alguns casos especiais.

Mucosas hipercoreadas. Significam acentuação da coloração normal, podendo haver inclusive mudança de tonalidade, que passa a ser vermelho-arroxeadas. *Mucosas hipercoreadas* traduzem aumento das hemácias naquela área, como ocorre nas inflamações (conjuntivites, glossites, gengivites) e nas policitemias.



Figura 10.36 Mão pêndula da paralisia radial.

Boxe

Poliglobulia

Poliglobulia pode ser observada em diversas condições: poliglobulia secundária a algumas doenças respiratórias, poliglobulia compensadora das grandes altitudes, policitemia vera de causa desconhecida, considerada o processo neoplásico da série eritrocitária.

Cianose. Consiste na coloração azulada das mucosas cujo significado é o mesmo da cianose cutânea analisada posteriormente.

Icterícia. As mucosas tornam-se amarelas ou amarelo-esverdeadas; da mesma maneira que na pele, resulta de impregnação pelo pigmento bilirrubínico aumentado no sangue.

Os locais mais adequados para detectar icterícia são a mucosa conjuntival, a esclerótica e o freio da língua. As icterícias mais leves só são perceptíveis nessas regiões. Nas pessoas negras, a esclerótica costuma apresentar uma coloração amarelada, que não deve ser confundida com icterícia.

Umidade

Em condições normais são úmidas, especialmente a lingual e a bucal, traduzindo bom estado de hidratação. Podemos ter: *umidade normal* ou *mucosas secas*.

As *mucosas secas* perdem o brilho, os lábios e a língua ficam pardacentos, e todas essas mucosas adquirem aspecto ressequido.

Musculatura

Para a investigação semiológica da musculatura, utilizam-se a *inspeção* e a *palpação* (Figura 10.37).

Todos os grupos musculares devem ser examinados. Existem doenças que comprometem a musculatura de modo generalizado, mas algumas acometem apenas grupos musculares ou músculos isolados.

Para a inspeção não se exige técnica especial; basta olhar atentamente a superfície corporal com o paciente em repouso, observando o relevo das massas musculares mais volumosas.

A palpação é feita com as polpas digitais colocadas em forma de pinça, com o polegar em oponência aos demais dedos da

mão.



Figura 10.37 Palpação de musculatura abdominal usando o polegar e o indicador, formando uma “pinça” para verificação de tônus muscular.

De início, palpa-se o músculo ou o grupo muscular em estado de repouso e, em seguida, solicita-se ao paciente que faça uma leve contração do segmento que está em exame para se investigar o músculo em estado de contração (Figura 10.38).

Assim procedendo, conseguem-se informações quanto à:

Troficidade: corresponde à massa do próprio músculo

Tonicidade: é o estado de semicontração própria do músculo normal.

Boxe

Classificação da musculatura

Quanto à troficidade:

Musculatura normal

Musculatura hipertrófica: aumento da massa muscular

Musculatura hipotrófica: diminuição da massa muscular.

Quanto à tonicidade:

Tônus normal

Hipertonicidade, espasticidade, musculatura espástica ou rigidez: nota-se um estado de contração ou semicontração do músculo, mesmo em repouso, evidenciado pelo relevo muscular e aumento da consistência à palpação

Hipotonicidade ou flacidez: significa que o tônus está diminuído ou ausente, com perda do contorno da massa muscular e diminuição da consistência.

As alterações encontradas devem ser descritas topograficamente. Exemplos de alterações da musculatura: nas hemiplegias, encontra-se espasticidade da musculatura correspondente; nas lesões extrapiramidais, é típico o aumento da tonicidade sem alterações da troficidade; os atletas e os trabalhadores braçais desenvolvem os grupos musculares mais diretamente relacionados com seu trabalho, que se tornam hipertróficos; os idosos e os pacientes acamados durante longo tempo ficam com a musculatura hipotrófica (sarcopenia) e flácida.

Nas crianças e nas mulheres, há normalmente certo grau de hipotonia.

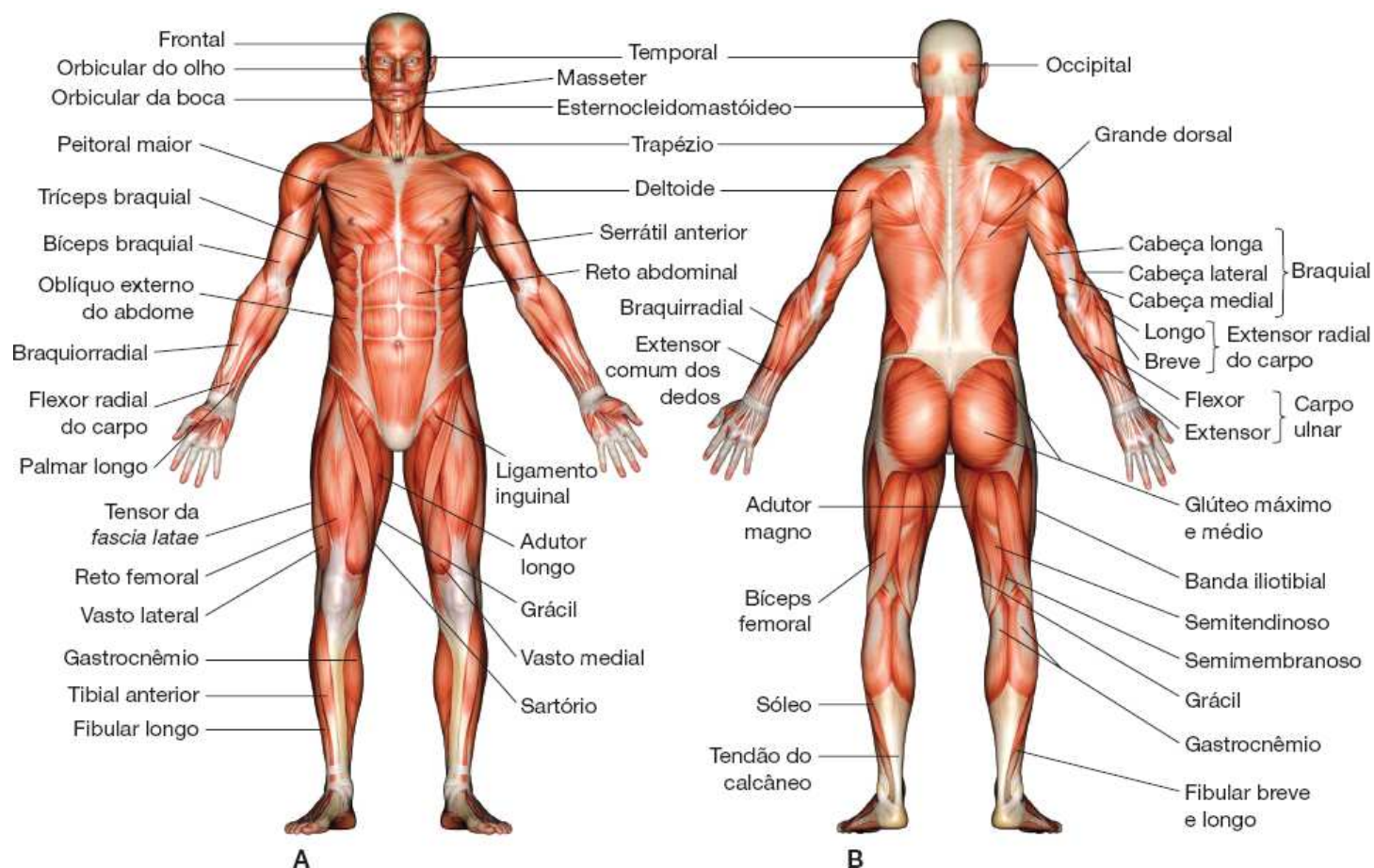


Figura 10.38 Músculos. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

Em idosos é importante o reconhecimento de avaliação da massa muscular. (Ver *Músculos* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Boxe

Rigidez muscular

É expressa pela resistência aumentada à movimentação passiva e que afeta a musculatura estriada.

Na rigidez parkinsoniana, o exagero dos reflexos tônicos de postura determina o aparecimento do “sinal da roda dentada”.

Movimentos involuntários

Enquanto o paciente estiver na presença do médico, este estará atento para surpreender movimentos anormais ou involuntários (ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Alguns movimentos involuntários são constantes, ao passo que outros ocorrem periodicamente ou em crises.

Os principais são:

- Tremores
- Movimentos coreicos (coreia)
- Movimentos atetósicos (atetose)
- Pseudoatetose
- Hemibalismo
- Mioclonias
- Mioquinias
- Asterix (*flapping*)

Tiques
Convulsões
Tetania
Fasciculações
Bradicinesia
Discinesias orofaciais
Distonias.

Tremores

São movimentos alternantes, mais ou menos rápidos e regulares, de pequena ou média amplitude, que afetam principalmente as partes distais dos membros.

Utilizam-se duas manobras para a pesquisa dos tremores:

Solicita-se ao paciente que estenda as mãos com as palmas voltadas para baixo e com os dedos separados. Essa manobra pode ser completada colocando-se uma folha de papel sobre o dorso de uma das mãos. Isso provocará uma ampliação dos movimentos (Figura 10.39)

Ordena-se que o paciente leve um copo, com uma das mãos, da mesa à boca. Pode ser substituído pela execução de um movimento, qual seja tocar o próprio nariz com a ponta do indicador. Essa manobra é indispensável para caracterizar os tremores de repouso e os de ação.

Boxe

Classificação dos tremores

Tremor de repouso: surge durante o repouso e desaparece com os movimentos e o sono; é um tremor oscilatório, em regra mais evidente nas mãos, simulando o gesto de “enrolar cigarro”. Ocorre no parkinsonismo. Pode ser pesquisado com o paciente sentado ou deitado.

Tremor de atitude ou postural: surge quando o membro é colocado em uma determinada posição, não sendo muito evidente no repouso ou no movimento. Ocorre no pré-coma hepático, quando é designado *flapping* ou *asterix*, e na doença de Wilson. Contudo, o tremor de atitude mais frequente é o *tremor familiar*, que é regular, não muito grosseiro, acentuado pelas emoções e, como sua própria designação indica, acomete vários membros de uma família.

Tremor discinético ou intencional: é o que surge ou se agrava quando um movimento é executado. Aparece nas doenças cerebelares.

Tremor vibratório: é fino e rápido como se fosse uma vibração. Pode surgir no hipertireoidismo, no alcoolismo e na neurossífilis, mas a grande maioria é de origem emocional.

Movimentos coreicos (coreia)

São movimentos involuntários, amplos, desordenados, de ocorrência inesperada e arrítmicos, multiformes e sem finalidade. Localizam-se na face, nos membros superiores e inferiores.

Quando muito frequentes, são surpreendidos sem dificuldade pelo examinador, mas em algumas ocasiões são raros, e o próprio paciente procura escondê-los ou disfarçá-los.

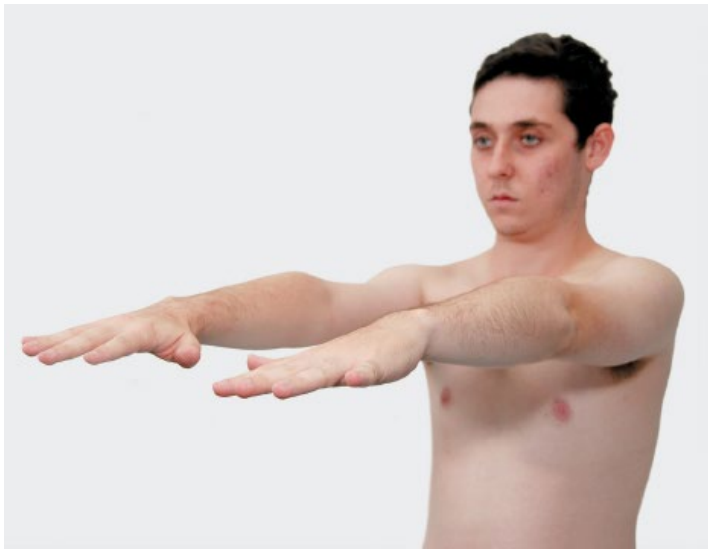


Figura 10.39 Manobras para pesquisa de tremores.

Para melhor observá-los, solicita-se ao paciente que se deite o mais relaxado possível ou que fique sentado à beira do leito com as pernas pendentes. Devem ser diferenciadas de tiques.

Boxe

Síndrome coreica

Os movimentos coreicos são as manifestações principais da *síndrome coreica*.

Coreia de Sydenham: também denominada coreia infantil ou dança de São Guido, tem etiologia infecciosa e relaciona-se estreitamente com a moléstia reumática.

Coreia de Huntington: é um distúrbio neurológico hereditário raro que se caracteriza por movimentos corporais anormais e incoordenação, também afetando habilidades mentais e aspectos de personalidade.

Movimentos atetósicos (atetose)

São movimentos involuntários que ocorrem nas extremidades e apresentam características muito próprias: são lentos e estereotipados, lembrando movimentos reptiformes ou os movimentos dos tentáculos do polvo. Podem ser uni ou bilaterais (Figura 10.40).

Determinam a atetose as lesões dos núcleos da base. Frequentemente ocorrem como sequela de impregnação cerebral por hiperbilirrubinemia do recém-nascido (*kernicterus*).

Pseudoatetose

Movimentos incoordenados, lentos e de grande amplitude, nas mãos, nos pés, na face. São relacionados à lesão do corpo estriado.

Hemibalismo

São movimentos abruptos, violentos, de grande amplitude, rápidos e geralmente limitados a uma metade do corpo. São extremamente raros e decorrem de lesões extrapiramidais.

Mioclonias

São movimentos involuntários breves, rítmicos ou arrítmicos, localizados ou difusos, que acometem um músculo ou um grupo muscular. Geralmente são relatados como “abalos”, “choques”, “sacudidas” e “trancos”. Podem ser de origem central, espinal e periférica.

Devem-se a descargas de neurônios subcorticais e podem ocorrer em diversas situações patológicas.

Mioquínias

São contrações fibrilares de tipo ondulatório que surgem em músculos íntegros, principalmente no orbicular das pálpebras, quadríceps e gêmeos (“tremor na carne”).

Não apresentam significado patológico, surgindo em pessoas normais, talvez com maior frequência nos pacientes neuróticos e em pessoas fatigadas.

Asterix (flapping)

São movimentos rápidos, de amplitude variável, que ocorrem nos segmentos distais e apresentam certa semelhança com o bater de asas das aves.



Figura 10.40 Movimentos atetósicos.

Para melhor notar o *flapping*, deve-se realizar a seguinte manobra: o paciente estende os braços e superestende as mãos de modo a formar um ângulo de quase 90° com o antebraço. A manobra é completada pelo médico, que, com suas mãos, força para trás as mãos do paciente.

Este tipo de movimento involuntário é frequente na insuficiência hepática, mas pode ser encontrado também no coma urêmico.

Tiques

São movimentos involuntários que aparecem em determinado grupo muscular, repetindo-se sucessivamente. São domináveis pela vontade. Podem ser funcionais ou orgânicos.

Boxe

Classificação dos tiques

Tiques motores:

Simples: envolvem grupos musculares isolados, resultando em piscamentos, abertura da boca, balanceio da cabeça e pescoço para os lados e para trás, elevação dos ombros ou fechamento dos punhos

Complexos: caracterizam-se por padrões elaborados de movimento (contrações faciais bizarras, desvios oculares, dar pequenos pulos durante a marcha, tocar ou cheirar objetos, gesticulação obscena). A síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado por tiques complexos (pelo menos um tique vocal)

Tiques vocais:

Simples: incluem-se ato de limpar a garganta, grunhidos, estalos com lábios ou língua

Complexos: abrangem palavras ou fragmentos de palavras, frases curtas, elementos musicais, repetição da última palavra ouvida do interlocutor ou repetição da última palavra emitida pelo próprio paciente.

Convulsões

As convulsões são movimentos musculares súbitos e incoordenados, involuntários e paroxísticos, que ocorrem de maneira generalizada ou apenas em segmentos do corpo.

Boxe

Classificação das convulsões

Tônicas: caracterizam-se por serem mantidas por longo tempo e imobilizarem as articulações

Clônicas: são rítmicas, alternando-se contrações e relaxamentos musculares em ritmo mais ou menos rápido

Tônico-clônicas: esse tipo soma as características de ambas.

As convulsões surgem em muitas condições clínicas, mas todas têm um denominador comum: descargas bioelétricas originadas em alguma área cerebral com imediata estimulação motora.

O exemplo clássico são as várias formas de *epilepsia* (grande mal, pequeno mal, psicomotora, Bravais-jacksoniana). Aparecem também no tétano, estados hipoglicêmicos, intoxicações exógenas (álcool, estriquina, inseticidas), tumores cerebrais, meningites, síndrome de Adams-Stokes ou durante episódios febris em crianças.

Tetania

É uma forma particular de movimentos involuntários e caracteriza-se por crises exclusivamente tônicas quase sempre localizadas nas mãos e pés, por isso denominados “espasmos carpopodais”.

A tetania pode ocorrer independentemente de qualquer manobra; porém, às vezes, é necessário usar um artifício para desencadeá-la, o que é feito com a compressão do braço com o manguito do esfigmomanômetro. A compressão adequada corresponde a um nível pressórico intermediário entre a pressão máxima e a mínima, ou seja, se a pressão arterial do paciente é de 140/90 mmHg, insufla-se o manguito até 110 mmHg durante 10 min, ao fim dos quais poderá aparecer um movimento involuntário naquela extremidade, o qual nada mais é do que um “espasmo carpal”. É chamado “mão de parteiro”, e o

fenômeno em sua totalidade recebe a designação de *sinal de Trousseau* (Figura 10.41).



Figura 10.41 Tetania desencadeada pela compressão da artéria braquial (sinal de Trousseau).

A tetania ocorre nas hipocalcemias (p. ex., hipoparatiroidismo) e na alcalose respiratória por hiperventilação.

Fasciculações

São contrações breves, arrítmicas e limitadas a um feixe muscular. Não devem ser confundidas com as mioquinias.

Discinesias

São alterações dos movimentos voluntários que podem adquirir a forma coreiforme, atetoide ou movimentos rítmicos em determinadas regiões corporais que diminuem com os movimentos voluntários da parte afetada.

As discinesias tardias relacionam-se ao uso crônico de antipsicóticos.

Bradicinesia refere-se à lentidão de movimentos apresentada pelos pacientes com doença de Parkinson, que pode ser detectada de diferentes maneiras.

Discinesias orofaciais

São movimentos rítmicos, repetitivos e bizarros, que comprometem, principalmente, a face, a boca, a mandíbula e a língua, sendo expressos sob a forma de caretas, franzir dos lábios, protrusão da língua, abertura e fechamento da boca e desvios da mandíbula. Ocorrem em psicoses de longa evolução, uso prolongado de fenotiazinas e em pessoas idosas, em geral desdentadas.

Distonias

São contrações musculares mantidas que levam a posturas anormais e movimentos repetitivos, quase sempre acompanhados de dor (Figura 10.42).



Figura 10.42 Distonia cervical (torcicolo espasmódico).

Enfisema subcutâneo

A presença de bolhas de ar debaixo da pele recebe a denominação de enfisema subcutâneo.

A técnica para reconhecê-lo é a palpação, deslizando-se a mão sobre a região suspeita. A presença de bolhas de ar proporcionará ao examinador uma sensação de crepitação muito característica.

O ar pode ser procedente do tórax, em decorrência de um pneumotórax, ou ter origem em processo local por ação de bactérias produtoras de gás; isso é o que ocorre nas gangrenas gasosas.

Circulação colateral

Circulação colateral, do ponto de vista semiológico, significa a presença de circuito venoso anormal visível ao exame da pele.

Em pessoas de cor branca e de pele clara e delgada (crianças, velhos, pacientes emagrecidos), pode-se ver com certa facilidade uma rede venosa desenhada no tronco ou nos membros. Isso não é circulação colateral; trata-se, simplesmente, do que se pode designar desenho venoso (Figuras 10.43 a 10.46).

Distinguir *desenho venoso* de *circulação colateral* é fácil na maioria das vezes: a rede visível está na topografia normal, simétrica, não é intensa, e as veias não são sinuosas.

Circulação colateral indica dificuldade ou impedimento do fluxo venoso através dos troncos venosos principais (cava inferior, cava superior, tronco venoso braquicefálico, ilíacas primitivas, veia cava). Por causa desse obstáculo, o sangue se desvia para as colaterais previamente existentes, tornando-se um caminho vicariante capaz de contornar o local ocluído, parcial ou totalmente.

A circulação colateral deve ser analisada sob os seguintes aspectos:

Localização

Direção do fluxo sanguíneo

Presença de frêmito e/ou sopro.

Localização. Tórax, abdome, raiz dos membros superiores, segmento cefálico; estas são as regiões em que se pode encontrar circulação colateral e que serão analisadas com mais detalhes quando se descreverem os principais tipos.

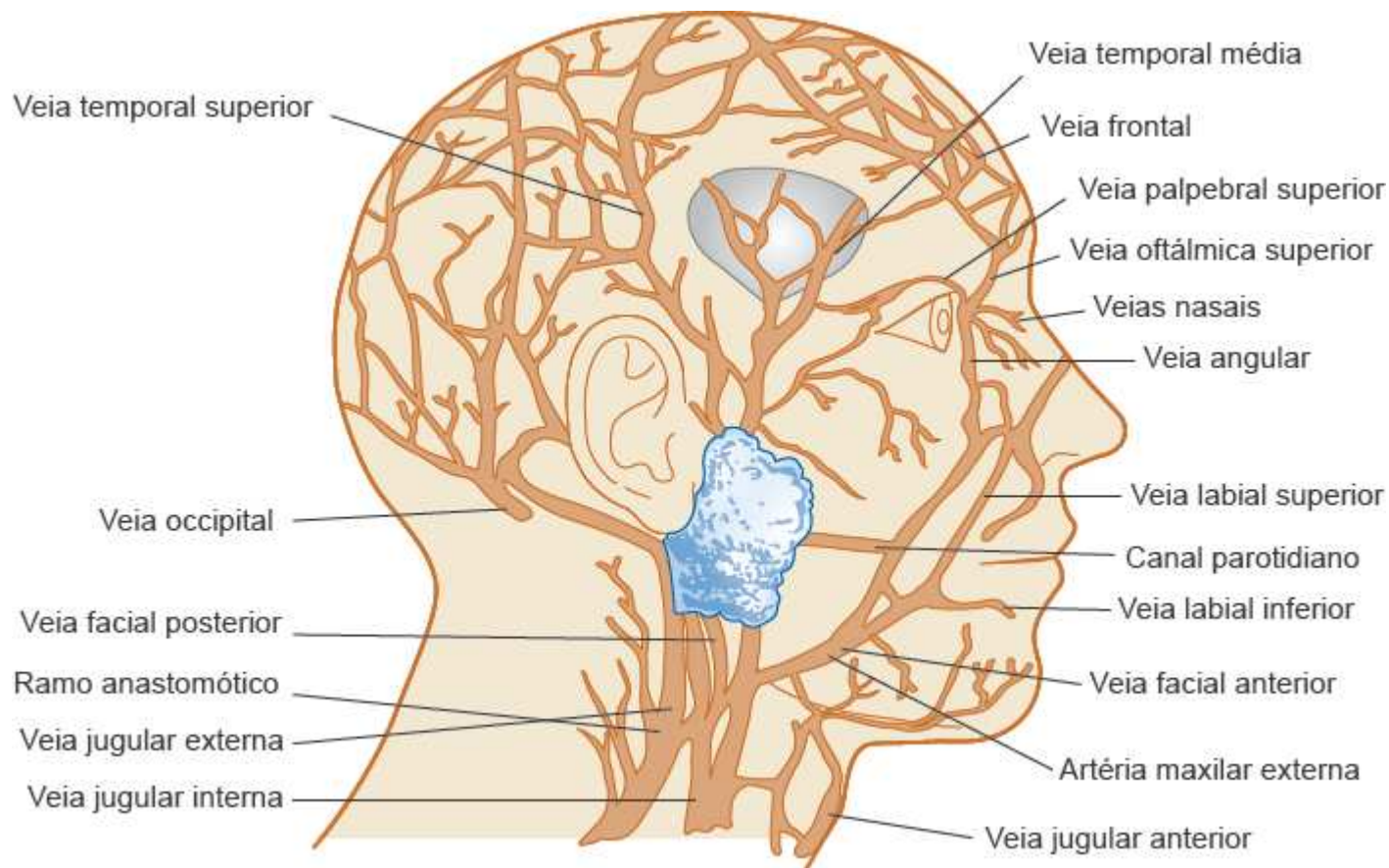


Figura 10.43 Veias superficiais da cabeça e do pescoço.

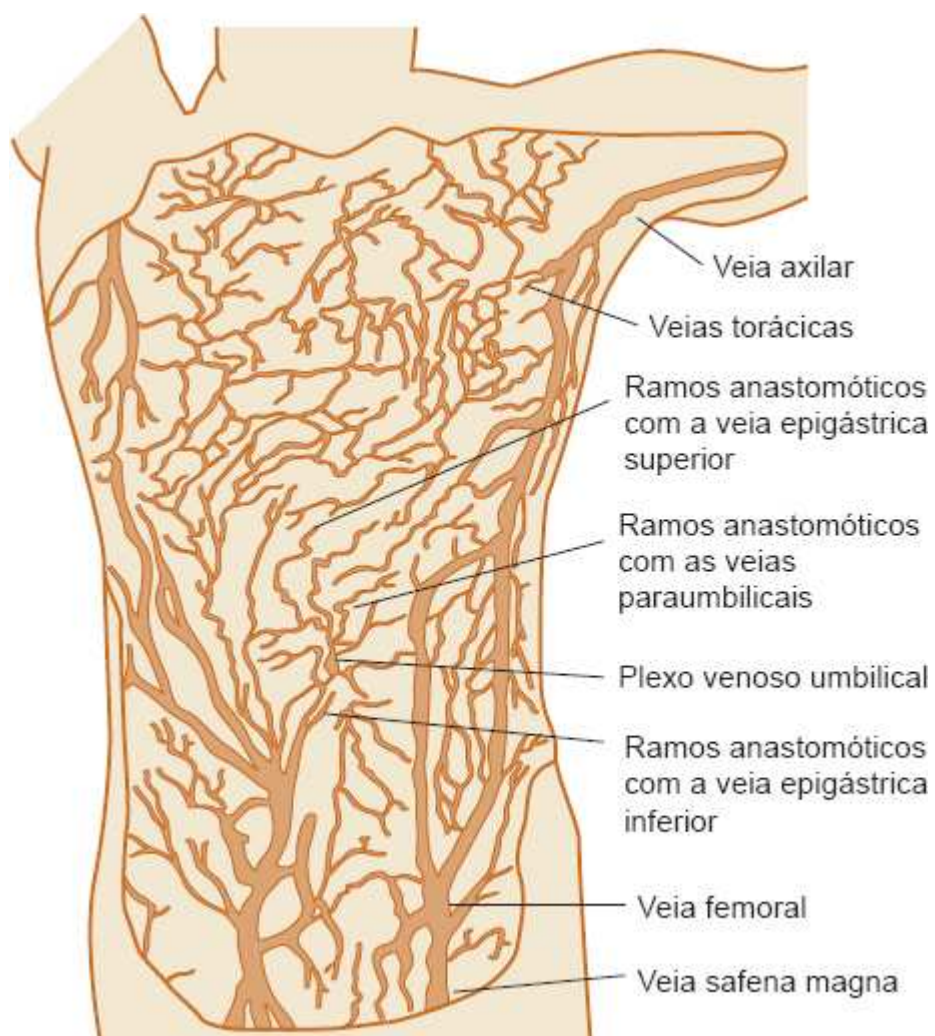


Figura 10.44 Veias superficiais do abdome e do tórax.

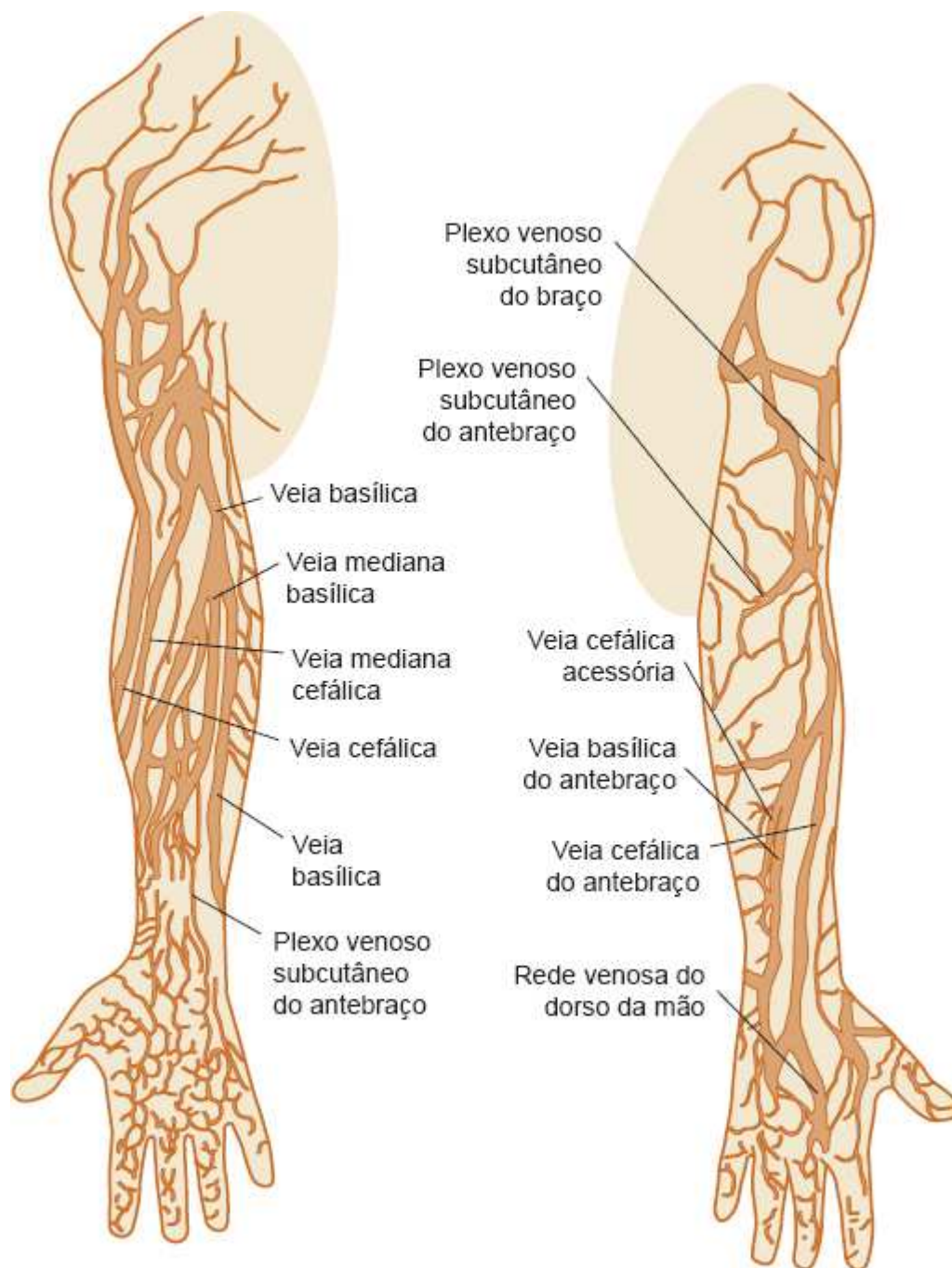


Figura 10.45 Veias superficiais dos membros superiores.

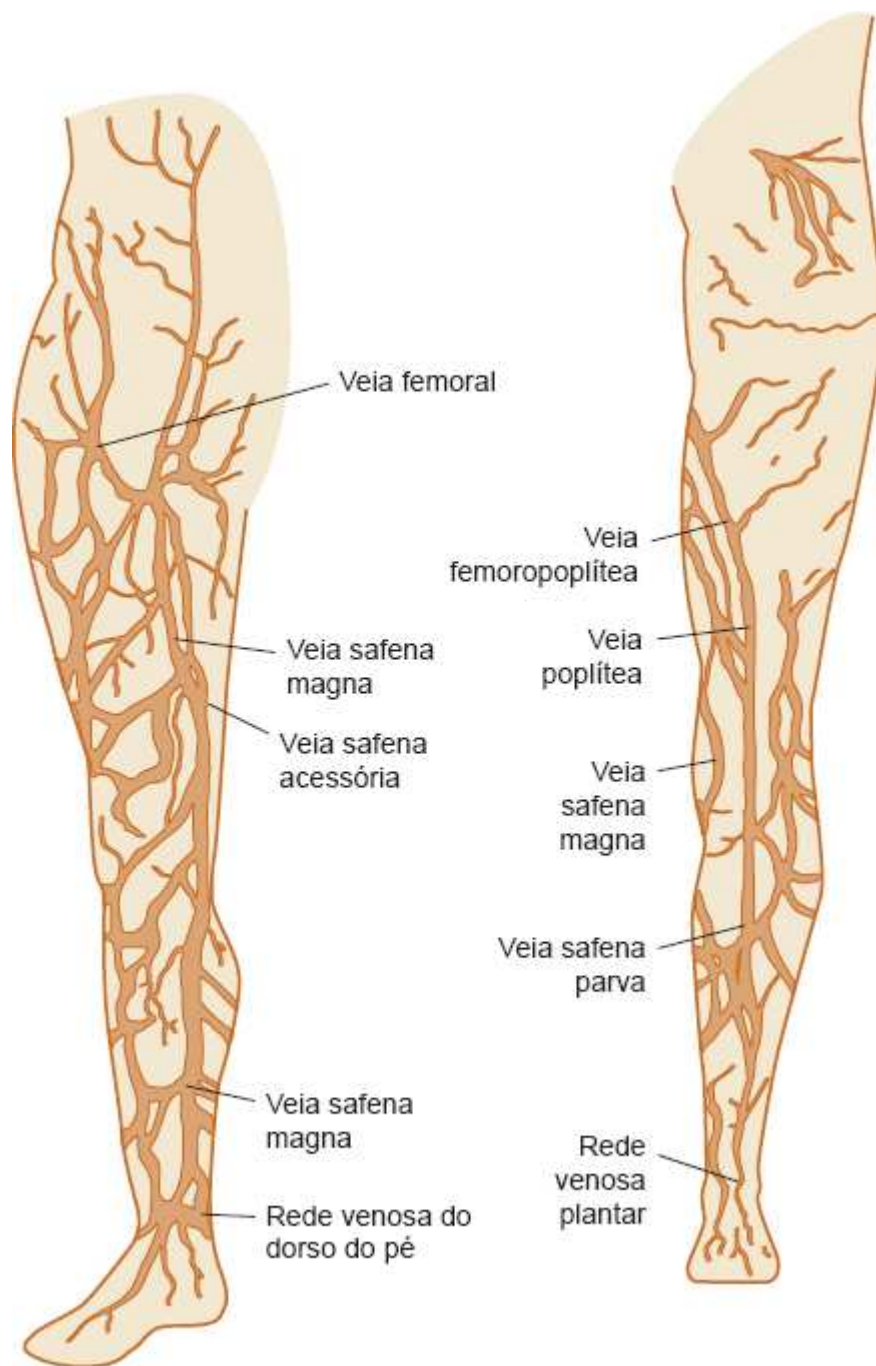


Figura 10.46 Veias superficiais dos membros inferiores.

Direção do fluxo sanguíneo. É determinada com a seguinte técnica: comprime-se com as polpas digitais dos dois indicadores, colocados rentes um ao outro, um segmento da veia a ser analisada; em seguida, os dedos vão se afastando lentamente, mantida constante a pressão, de modo a deslocar a coluna sanguínea daquele segmento venoso (Figura 10.47).

Quando os indicadores estão separados cerca de 5 a 10 cm, são imobilizados e se assegura se realmente aquele trecho da veia está exangue. Se estiver, executa-se a outra parte da manobra, que consiste em retirar um dos dedos, permanecendo comprimida apenas uma extremidade. Feito isso, procura-se observar o reenchimento daquele segmento venoso. Se ocorrer o enchimento imediato da veia, significa que o sangue está fluindo no sentido do dedo que permanece fazendo a compressão. Permanecendo colapsado o segmento venoso, repete-se a manobra, agora descomprimindo-se a outra extremidade e verificando se houve enchimento do vaso. A manobra deve ser repetida 2 ou 3 vezes para não haver dúvida, e, ao terminá-la, o examinador terá condições de saber em que sentido corre o sangue. Este fenômeno se registra usando-se as seguintes expressões:

- Fluxo venoso abdome-tórax
- Fluxo venoso ombro-tórax
- Fluxo venoso pelve-abdome.

Presença de frêmito e/ou sopro. A presença de *frêmito*, perceptível pelo tato, ou *sopro*, perceptível pela ausculta, necessita

ser pesquisada. A única condição em que se costuma perceber frêmito e/ou sopro é quando há recanalização da veia umbilical (síndrome de Cruveillier-Baumgarten).

Boxe

Tipos fundamentais de circulação colateral

Tipo braquicefálica: caracteriza-se pelo aparecimento de veias superficiais ingurgitadas em ambos os lados da parte superior da face anterior do tórax, com o sangue fluindo de fora para dentro, na direção das veias mamárias, toracoaxilares e jugulares anteriores. Esse tipo de circulação colateral pode apresentar variações, na dependência do tronco venoso comprometido. Assim, se o obstáculo estiver no tronco braquicefálico direito em decorrência de adenomegalia ou aneurisma do joelho anterior da crosse da aorta, haverá estase na veia jugular externa direita, que permanece não pulsátil. Se o obstáculo estiver no tronco braquicefálico esquerdo em consequência de adenomegalia ou aneurisma da convexidade da crosse da aorta, surgirão os seguintes sinais: jugular esquerda túrgida e não pulsátil e empastamento da fossa supraclavicular esquerda

Tipo cava superior: a rede venosa colateral vai se distribuir na metade superior da face anterior do tórax; às vezes, também na parte posterior, nos braços e no pescoço. A direção do fluxo sanguíneo é toracoabdominal, indicando que o sangue procura alcançar a veia cava inferior através das veias xifoidianas e torácicas laterais superficiais (Figuras 10.48 a 10.50). Além da rede de veias, costumam surgir os seguintes sinais: estase jugular bilateral não pulsátil, cianose e edema localizado na porção superior do tronco, pescoço e face. Esse tipo de circulação colateral se instala quando há um obstáculo na veia cava superior, seja compressão extrínseca por neoplasias ou outras alterações mediastinais, principalmente do mediastino superior

Tipo porta: o obstáculo pode estar situado nas veias supra-hepáticas (síndrome de Budd-Chiari), no fígado (cirrose hepática) ou na veia porta (pileflebite) (Figura 10.51). A rede venosa vicariante localiza-se na face anterior do tronco, principalmente nas regiões periumbilical, epigástrica e face anterior do tórax. A direção do fluxo sanguíneo será de baixo para cima, do abdome para o tórax, à procura da veia cava superior através das veias xifoidianas e torácicas laterais. Quando a circulação colateral se torna mais intensa, podem-se ver vasos nos flancos e fossas ilíacas. Neste caso, a direção da corrente sanguínea é de cima para baixo, do abdome para os membros inferiores, à procura da veia cava inferior. Outras vezes, a rede venosa colateral se concentra na região umbilical, de onde se irradia como os raios de uma roda, ou, melhor comparando, como as pernas de aranha que se destacam de um corpo central – o umbigo –, recebendo o nome de circulação colateral tipo “cabeça de Medusa”

Tipo cava inferior: o obstáculo situa-se na veia cava inferior, e a circulação colateral vai se localizar na parte inferior do abdome, região umbilical, flancos e face anterior do tórax. O sangue fluirá no sentido abdome-tórax à procura da veia cava superior (Figura 10.52). A causa mais frequente desse tipo de circulação colateral é compressão extrínseca por neoplasias intra-abdominais.

Edema

É o excesso de líquido acumulado no espaço intersticial ou no interior das próprias células (edema intracelular). Pode ocorrer em qualquer sítio do organismo, mas, do ponto de vista semiológico, interessa-nos apenas o edema cutâneo, ou seja, a infiltração de líquido no espaço intersticial dos tecidos que constituem a pele e o tecido celular subcutâneo.

As coleções líquidas nas cavidades serosas são fenômenos fisiopatologicamente afins ao edema e é comum que sejam vistas associadas no mesmo paciente; contudo, os derrames cavitários (hidrotórax, ascite, hidropericárdio e hidrartrose) serão estudados na semiologia dos diferentes aparelhos.

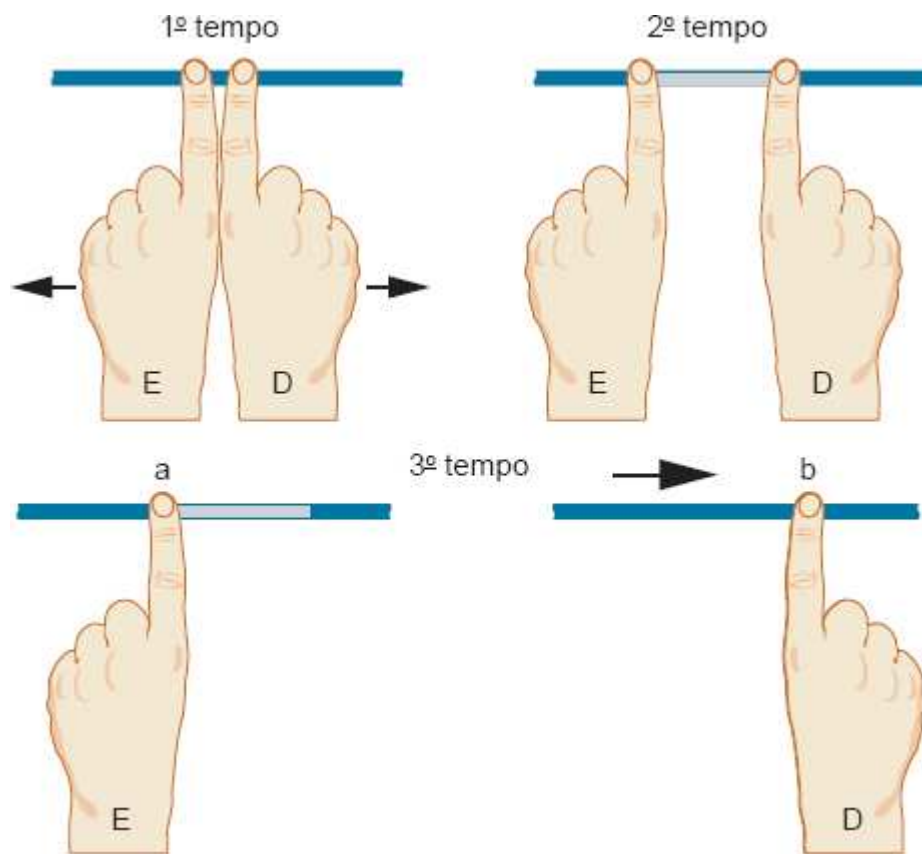


Figura 10.47 Manobra para determinar a direção do fluxo sanguíneo. No 1º tempo aplicam-se sobre um segmento de veia as polpas digitais dos indicadores justapostos. No 2º tempo, os dedos se afastam um do outro enquanto comprimem o vaso, que vai se tornando exangue. O 3º tempo consiste na retirada da compressão: em *a* retirou-se a mão direita, e o vaso permaneceu vazio; em *b* foi retirada a mão esquerda e aí, então, ocorreu o reenchimento da veia. Pode-se concluir que o sangue está fluindo da esquerda para a direita.



Figura 10.48 Circulação colateral tipo cava superior.

A investigação semiológica do edema tem início na anamnese, quando se indaga sobre *tempo de duração, localização e evolução*.

No exame físico completa-se a análise, investigando-se os seguintes parâmetros:

Localização e distribuição

Intensidade

Consistência

Elasticidade

Temperatura da pele circunjacente

Sensibilidade da pele circunjacente

Outras alterações da pele adjacente

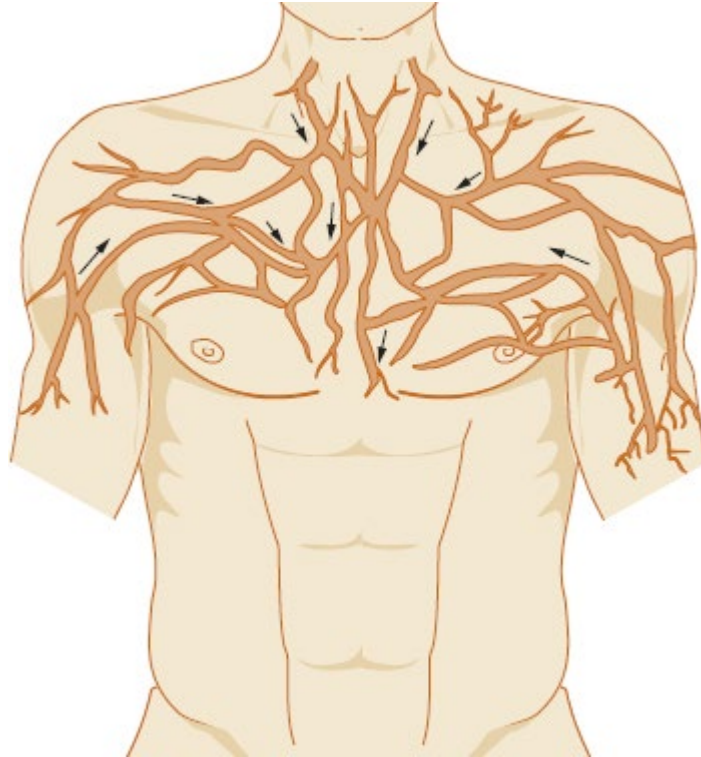


Figura 10.49 Circulação colateral tipo cava superior.

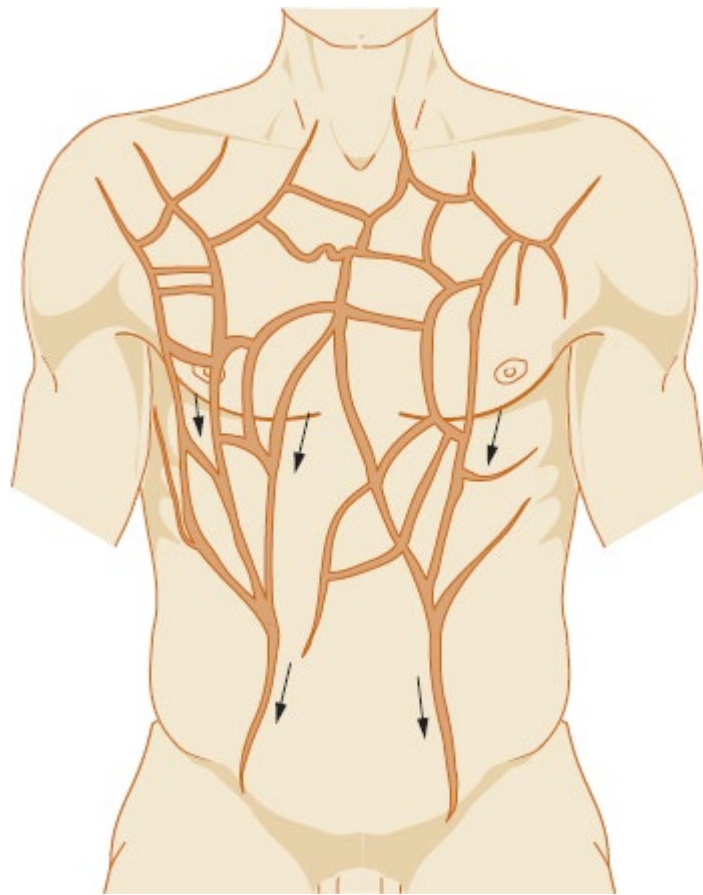


Figura 10.50 Circulação colateral tipo cava superior.

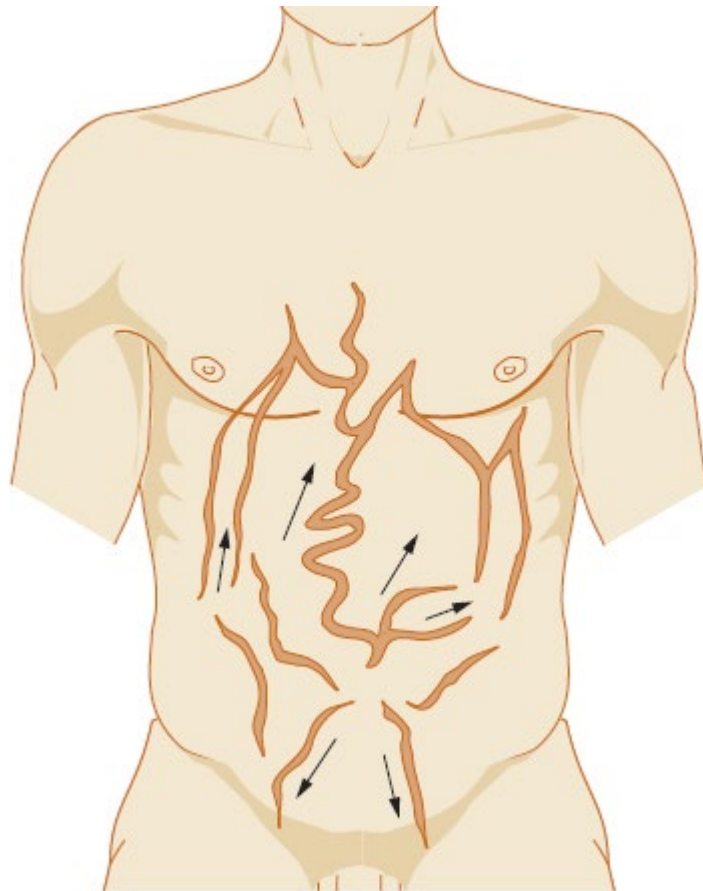


Figura 10.51 Circulação colateral tipo porta.

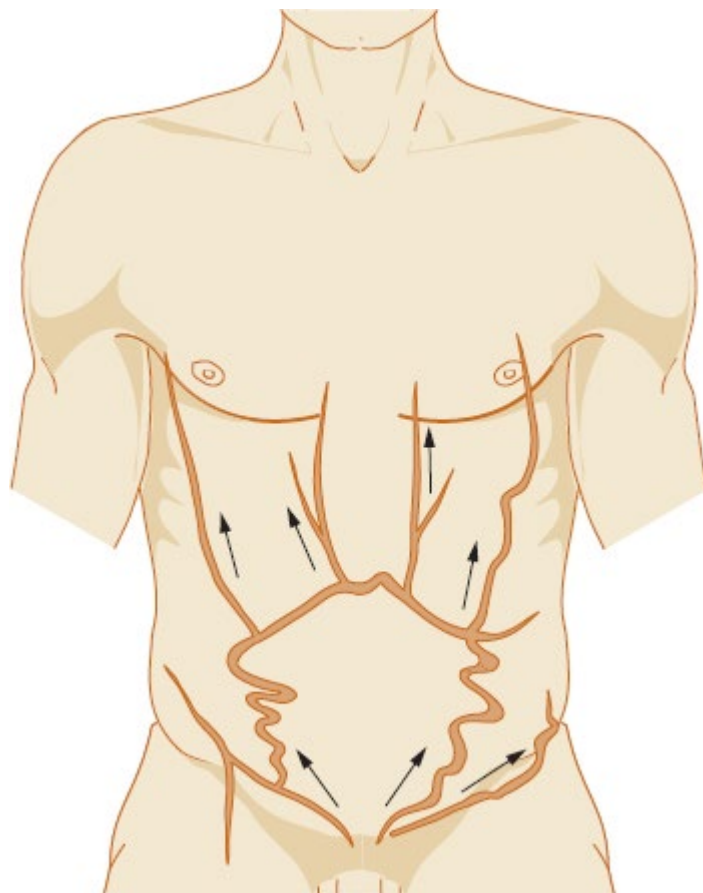


Figura 10.52 Circulação lateral tipo cava inferior.

Localização e distribuição. A primeira grande distinção a ser feita é se o edema é *localizado* ou *generalizado* (Figuras 10.53 a 10.56).

O edema localizado restringe-se a um segmento do corpo, seja a um dos membros inferiores, seja a um dos membros superiores, seja a qualquer área corporal.

Excluída essa possibilidade, consideramos o edema como generalizado mesmo que aparentemente se restrinja a uma parte do organismo.

É nos membros inferiores que mais frequentemente se constata a existência de edema; todavia, duas outras regiões devem ser sistematicamente investigadas: *face* (especialmente regiões palpebrais) e *região pré-sacra*, esta particularmente nos pacientes acamados, recém-natos e lactentes.

Intensidade. Para determinar a intensidade do edema, emprega-se a seguinte técnica: com a polpa digital do polegar ou do indicador, faz-se uma compressão, firme e sustentada, de encontro a uma estrutura rígida subjacente à área em exame, seja a tíbia, o sacro ou os ossos da face.

Havendo edema, ao ser retirado o dedo vê-se uma depressão, no local comprimido, chamada de *fóvea*. Estabelece-se a intensidade do edema referindo-se à profundidade da *fóvea* graduada em cruces (+, ++, +++ e ++++). Com a experiência, vai sendo adquirida capacidade de estabelecer o grau do edema.

Duas outras maneiras podem ser usadas para avaliar a magnitude da retenção hídrica:

Pesando-se o paciente diariamente, pela manhã ou à noite. Variações muito acentuadas do peso traduzem retenção ou eliminação de água. Todo paciente que apresenta edema deve ser pesado diariamente.

Medindo-se o perímetro da região edemaciada, como se pode fazer no caso do edema de membros inferiores, e comparando-se um lado com o outro em dias sucessivos.

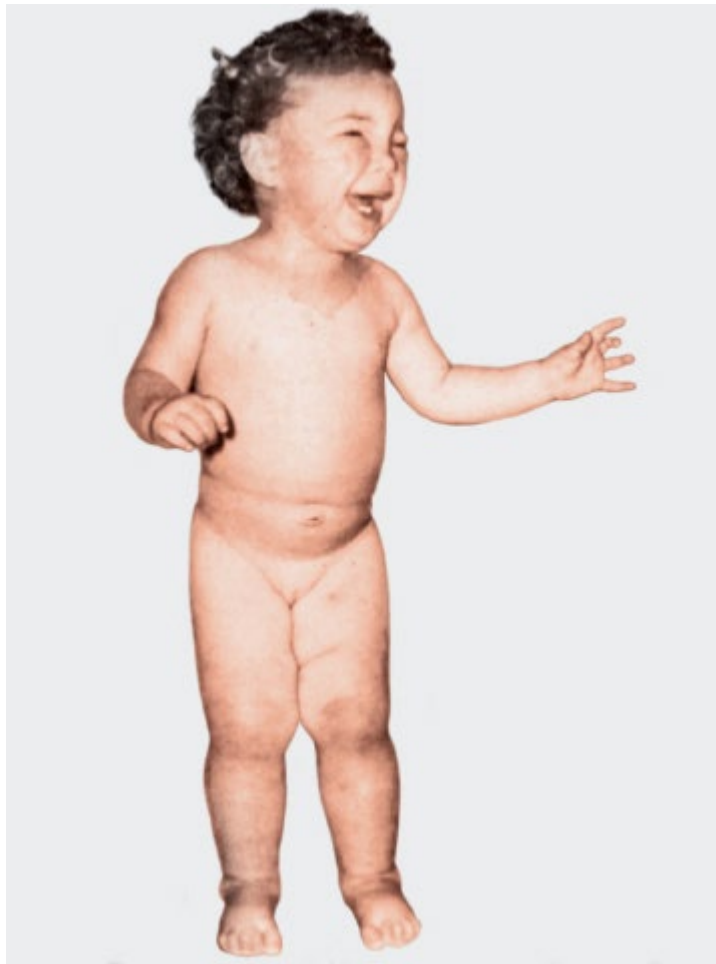


Figura 10.53 Edema generalizado ou anasarca (síndrome nefrótica).

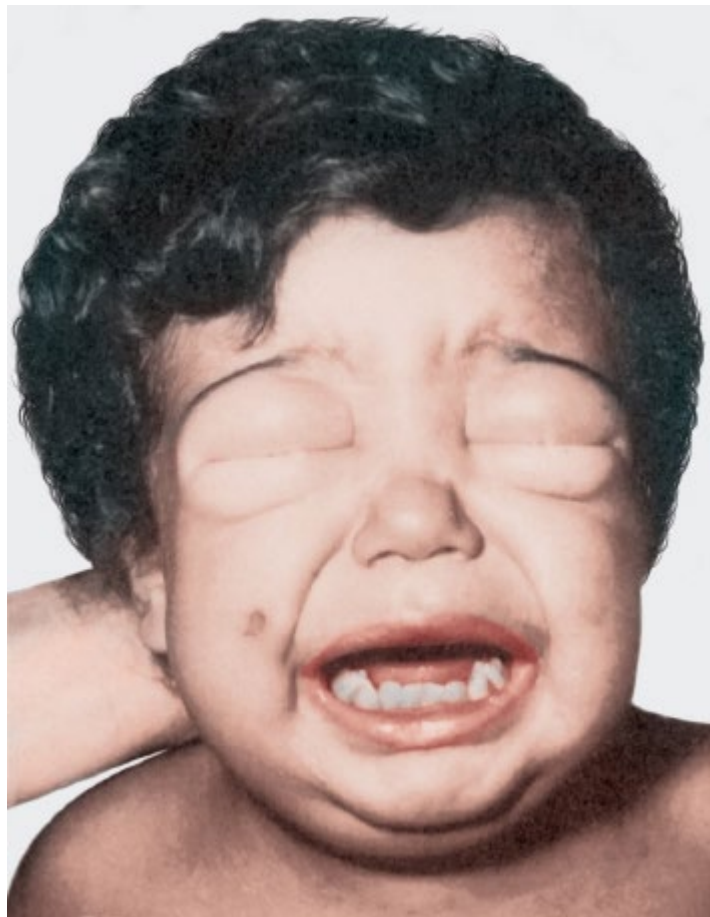


Figura 10.54 Edema facial muito acentuado nas regiões periorbitárias.

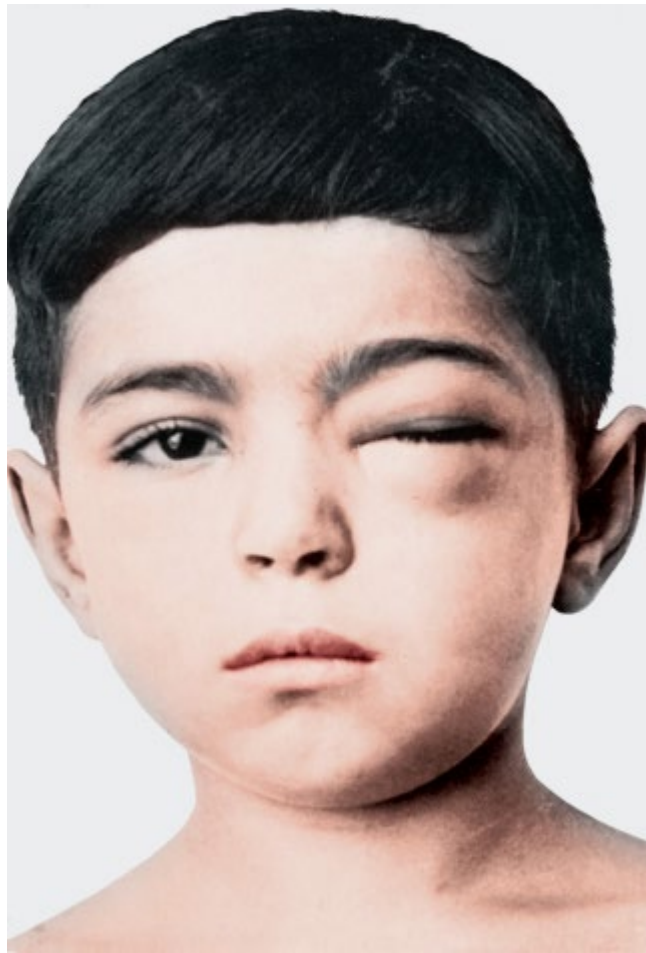


Figura 10.55 Edema localizado em uma das regiões orbitárias (caso agudo de doença de Chagas com sinal de Romaña).



Figura 10.56 Edema dos membros inferiores. Em uma das pernas podem ser vistas as depressões provocadas por digitopressão.

Consistência. A mesma manobra adotada para avaliar a intensidade serve também para investigar a consistência do edema, a qual pode ser definida como o grau de resistência encontrado ao se comprimir a região edemaciada.

Boxe

Classificação

Edema mole: é facilmente depressível. Observado em diferentes condições, significa apenas que a retenção hídrica é de duração não muito longa, e o tecido celular subcutâneo está infiltrado de água

Edema duro: nesse tipo de edema, depara-se com maior resistência para obter a formação da fôvea. Traduz a existência de proliferação fibroblástica que ocorre nos edemas de longa duração ou que se acompanharam de repetidos surtos inflamatórios. O mais típico é o que se observa na *elefantíase*, uma síndrome caracterizada por hiperplasia cutânea regional em decorrência de obstrução da circulação linfática, com represamento de linfa (linfedema) e proliferação fibroblástica intensa. Acomete comumente os membros inferiores. As principais causas são filariose e erisipela.

Elasticidade. Ao se avaliar a intensidade e a consistência, verifica-se, também, a elasticidade. Esta é indicada não só pela sensação percebida pelo dedo que comprime, mas principalmente observando-se a volta da pele à posição primitiva quando se termina a compressão.

Dois tipos são encontrados:

Edema elástico: a pele retorna imediatamente à sua situação normal, ou seja, a fôvea perdura pouquíssimo tempo. O edema elástico é típico dos edemas inflamatórios

Edema inelástico: é aquele cuja pele comprimida demora a voltar à posição primitiva, ou seja, a depressão persiste por certo tempo.

Temperatura da pele circunjacente. Usa-se o dorso dos dedos ou as costas das mãos, comparando-se com a pele da vizinhança e da região homóloga.

Há três possibilidades:

Pele de temperatura normal: frequentemente a temperatura na região edemaciada não se altera, o que é desprovido de qualquer significado especial

Pele quente: significa edema inflamatório

Pele fria: traduz comprometimento da irrigação sanguínea daquela área.

Sensibilidade da pele circunjacente. Para apreciação da sensibilidade, aproveita-se uma vez mais a manobra inicialmente descrita: digitopressão da área que está sendo investigada.

Doloroso é o edema cuja pressão desperta dor, e *indolor*, quando tal não ocorre. Edema doloroso é o inflamatório.

Outras alterações da pele adjacente. A primeira a ser investigada consiste na mudança de coloração. Pode-se notar palidez, cianose ou vermelhidão. A palidez atinge maior intensidade nos edemas que se acompanham de transtorno da irrigação sanguínea. A cianose é indicativa de perturbação venosa localizada, mas pode ser parte de uma cianose central ou mista. Vermelhidão indica processo inflamatório.

Deve-se observar, ainda, a textura e a espessura da pele: pele lisa e brilhante acompanha o edema recente e intenso; pele espessa é vista nos pacientes com edema de longa duração; pele enrugada aparece quando o edema está sendo eliminado.

Fisiopatologia e causas

A formação do edema depende de vários fatores, incluindo alteração da pressão hidrostática, da pressão oncótica das proteínas, do fluxo linfático, da permeabilidade capilar e do balanço hidrossalino, em especial retenção de sódio. Dependendo da causa, predomina um ou mais destes fatores no aparecimento de edema.

Causas de edema

Síndrome nefrítica
 Síndrome nefrótica
 Pielonefrite
 Insuficiência cardíaca
 Cirrose hepática
 Hepatite crônica
 Desnutrição proteica
 Fenômenos angioneuróticos (edema alérgico)
 Gravidez
 Toxemia gravídica
 Obesidade
 Edema pré-menstrual
 Climatério
 Medicamentos (corticosteroides, anti-inflamatórios, antagonistas do cálcio, estrogênios, esteroides anabolizantes, interleucina 2, pramipexol, docetaxel).

Qualquer que seja a causa do edema, há sempre participação de dois ou mais mecanismos, quase sempre com predomínio de um ou outro. No entanto, a retenção de sódio e água constitui fator importante em todo edema generalizado.

Engloba-se sob a designação de *edema renal* o que se observa na *síndrome nefrítica*, na *síndrome nefrótica* e na *pielonefrite*.

Embora se diferencie nos seus mecanismos fisiopatológicos, o edema renal, seja qual for a causa, apresenta características semiológicas comuns. É um edema generalizado, predominantemente facial, acumulando-se de modo particular nas regiões subpalpebrais. Tal fato torna-se mais evidente no período matutino, e os pacientes costumam dizer que “amanhecem com os olhos inchados ou empapuçados”.

Na síndrome nefrótica, o edema é intenso (+ + + a + + + +) e se acompanha frequentemente de derrames cavitários. Já na síndrome nefrítica e na pielonefrite, é discreto ou moderado (+ a + +). Além disso, o edema renal é mole, inelástico, indolor, e a pele adjacente mantém temperatura normal ou discretamente reduzida.

Na formação do edema da síndrome nefrítica, além da retenção de sódio e água por desequilíbrio glomerulotubular, outro fator que se destaca é o aumento da permeabilidade capilar.

De outra parte, os grandes edemas da síndrome nefrótica encontram no hiperaldosteronismo secundário e na hipoproteinemia sua principal explicação fisiopatológica.

O edema constitui um dos *sinais cardíais* da insuficiência cardíaca congestiva e se caracteriza por ser generalizado, predominando nos membros inferiores. Diz-se que é vespertino por ser mais observado no período da tarde após o paciente manter-se de pé por várias horas. Tanto é assim, que nos pacientes acamados a retenção hídrica se acumula na região pré-sacra. O edema cardíaco varia de intensidade (+ a + + + +), é mole, inelástico, indolor, e a pele adjacente pode apresentar-se lisa e brilhante.

Decorre, sobretudo, do aumento da pressão hidrostática associado à retenção de sódio e água. É provável que haja, também, aumento da permeabilidade capilar em consequência da ação do fator natriurético atrial. Em uma primeira fase esse distúrbio hidrossalino se deve à estase renal e à diminuição do débito cardíaco. Posteriormente, passa a ter importância um aumento secundário da produção de aldosterona.

O aumento da pressão hidrostática, por sua vez, reflete o aumento da pressão venosa, que é o denominador comum de todos os sinais de insuficiência ventricular direita.

Na *cirrose hepática*, o edema é generalizado, mas quase sempre discreto (+ a + +). Predomina nos membros inferiores, sendo habitual a ocorrência de ascite concomitante. É mole, inelástico e indolor.

Além da hipoproteinemia consequente ao transtorno no metabolismo proteico, admite-se que participe de modo relevante da sua formação um hiperaldosteronismo secundário, responsável pela retenção de sódio e água, e a hipoalbuminemia.

O *edema da desnutrição proteica*, também chamado edema carencial ou discrático, é generalizado, predominando nos membros inferiores. É mole, inelástico, indolor e não costuma ser de grande intensidade (+ a + +).

Considera-se fator primordial na sua produção a diminuição da pressão osmótica das proteínas plasmáticas, decorrência da ingestão reduzida dessas substâncias. Por isso, é designado também edema da fome crônica.

O *edema alérgico* acompanha os fenômenos angioneuróticos, e o fator principal na sua formação é o aumento da permeabilidade capilar. Da reação antígeno-anticorpo surgem diferentes substâncias, entre as quais a histamina e as cininas que, agindo no nível do capilar, alteram sua permeabilidade. Tal alteração permite a passagem de água para o interstício entre as células.

Esse tipo de edema pode ser generalizado, mas costuma restringir-se a determinadas áreas, principalmente a face. Instala-se de modo súbito e rápido, e a pele, por esse motivo, torna-se lisa e brilhante, podendo também apresentar-se com temperatura aumentada e coloração avermelhada. Trata-se de um edema mole e elástico.

A causa principal do *edema medicamentoso* é a retenção de sódio. Predomina nos membros inferiores, mas, quando é mais intenso, pode ser facial.

Na *gravidez* normal, não é raro aparecer um discreto edema, principalmente nos membros inferiores. Todavia, nas toxemias gravídicas o edema quase sempre é intenso, e sua explicação fisiopatológica reside nas alterações renais – nefropatia gravídica – combinadas com as modificações hormonais advindas da própria gravidez.

Por fim, cumpre lembrar o *edema pré-menstrual*, que surge na semana que antecede a menstruação, e o edema que acompanha as alterações que advêm no *climatério*.

Edema localizado

Antes de analisar as características semiológicas e os mecanismos de formação dos edemas localizados, é necessário relacionar suas principais causas:

Varizes

Flebites e trombose venosa

Processos inflamatórios

Afecções dos linfáticos

Postura.

O edema observado nos portadores de varizes – edema varicoso – localiza-se nos membros inferiores, preponderando em uma ou outra perna: acentua-se com a longa permanência na posição de pé; não é muito intenso (+ a + +); a princípio é de consistência mole, porém, nos casos muito antigos, torna-se cada vez mais duro; é inelástico, e, com o passar do tempo, a pele vai alterando sua coloração, até adquirir tonalidade castanha ou mais escura. Pode tornar-se espessa e de textura grosseira.

O edema da trombose venosa é mole, chega a ser intenso, e a pele costuma estar pálida. Em certos casos, adquire tonalidade cianótica. Classicamente essas condições são chamadas *flegmasia alba dolens* e *flegmasia alba cerulea*.

O mecanismo básico na formação do edema varicoso e da trombose venosa encontra-se no aumento da pressão hidrostática, seja por insuficiência das valvas das veias, seja por oclusão do próprio vaso.

O edema da flebite em parte decorre do componente inflamatório que aumenta a permeabilidade capilar e também das alterações já assinaladas no caso de varizes e de trombozes venosas.

Como os demais edemas inflamatórios, caracteriza-se por ser localizado, de intensidade leve a mediana (+ a + +), elástico, doloroso, com a pele adjacente se apresentando lisa, brilhante, vermelha e quente.

O edema postural é o que ocorre nos membros inferiores das pessoas que permanecem por longo tempo na posição de pé ou que ficam com as pernas pendentes por várias horas, como acontece em viagens longas. Decorre de aumento da pressão hidrostática. É localizado, discreto (+ a + +), mole, indolor e desaparece rapidamente na posição deitada. A obesidade predispõe à formação do edema postural.

Boxe

Linfedema e mixedema

Linfedema: é a designação que se dá ao edema originado nas afecções dos vasos linfáticos. Depende da obstrução dos canais linfáticos (pós-erisipela, filariose) e caracteriza-se semiologicamente por ser localizado, duro, inelástico, indolor, e com francas alterações da textura e da espessura da pele, que se torna grossa e áspera. Nos casos avançados, configura o quadro chamado de elefantíase (Figura 10.57).

Mixedema: é uma forma particular de edema observado na hipofunção tireoidiana. Não se trata de uma

retenção hídrica conforme ocorre nos edemas de maneira geral. No mixedema, há deposição de substância mucopolissacarídica (glicoproteínas) no espaço intersticial e, secundariamente, retenção de água. É um edema pouco depressível, inelástico, não muito intenso, e a pele apresenta as alterações próprias da hipofunção tireoidiana.



Figura 10.57 Linfedema de longa duração com hiperpigmentação e alteração da textura e espessura da pele, configurando o que se chama de elefantíase.

Temperatura corporal

A temperatura do interior do corpo permanece quase constante, com uma variação de no máximo $0,6^{\circ}\text{C}$, mesmo quando se fica exposto a extremos de frio ou de calor, graças ao aparelho termorregulador. A temperatura da parte externa do corpo, ao contrário, está sujeita às variações das condições ambientais.

Pequenas variações na temperatura normal são observadas, de pessoa a pessoa, e em uma mesma pessoa, em diferentes regiões do corpo.

Os valores térmicos estão aumentados em certas condições, tais como refeições copiosas, exercícios físicos intensos, gravidez ou ovulação. Na mulher sadia, a ovulação exerce um efeito tão característico sobre a temperatura corporal que é possível determinar a época da ovulação durante os ciclos menstruais. A temperatura baixa 24 a 36 h antes do início da menstruação e continua nesse nível durante o período menstrual. Coincidindo com a ovulação, a temperatura se eleva, mantendo-se até 1 ou 2 dias antes da menstruação seguinte. Como a diferença entre esses níveis térmicos raramente ultrapassa 1°C , a temperatura deve ser medida em condições basais, ou seja, pela manhã, antes de se levantar e de realizar qualquer atividade.

Locais de verificação da temperatura e valores normais

A temperatura corporal é verificada por intermédio do termômetro clínico, que no Brasil é graduado em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$). Os

termômetros clínicos registram temperaturas entre 35°C e 42°C. Os termômetros eletrônicos têm como limites 32°C e 43°C.

A temperatura corporal pode apresentar variações na dependência do local em que seja procedida sua mensuração. Pode ser: axilar, oral, retal, timpânico, arterial pulmonar, esofágico, nasofaringiano e vesical.

No Brasil, o local habitual é o oco axilar. Para utilização correta desse método é necessária a higiene da axila e do termômetro, evitando-se a presença de umidade no local.

A mensuração da temperatura na cavidade oral, bastante comum em outros países, é feita pela colocação do termômetro na região sublingual. Para isso, são necessários termômetros individuais.

A temperatura retal é feita pela aplicação do termômetro na ampola retal. Nesse caso, além do uso de termômetros individuais, há uma diferença no modelo de termômetro, visto que seu bulbo é redondo.

A membrana timpânica é o local de eleição para mensuração da temperatura central; contudo, não tem grande aplicação na prática clínica.

É importante conhecer as diferenças fisiológicas existentes entre os três locais – oco axilar, boca e reto –, porque, em determinadas situações patológicas (abdome agudo, afecções pélvicas inflamatórias), devem ser medidas as temperaturas axilar e retal, tendo valor clínico uma diferença maior que 0,5°C, assim:

Temperatura axilar: 35,5 a 37°C, com média de 36 a 36,5°C

Temperatura bucal: 36 a 37,4°C

Temperatura retal: 36 a 37,5°C, ou seja, 0,5°C maior que a axilar.

Febre

Significa temperatura corporal acima da faixa da normalidade.

Pode ser causada por transtornos no próprio cérebro ou por substâncias tóxicas que influenciam os centros termorreguladores.

Muitas proteínas ou seus produtos de hidrólise, além de outras substâncias tóxicas, como toxinas bacterianas, podem provocar elevação do ponto de ajuste do termostato hipotalâmico. As substâncias que causam esse efeito são chamadas pirogênicos.

Os pirogênios são secretados por bactérias ou liberados dos tecidos em degeneração. Quando o ponto de ajuste do termostato hipotalâmico é elevado a um nível mais alto que o normal, todos os mecanismos de regulação da temperatura corporal são postos em ação, inclusive os mecanismos de conservação e de aumento da produção de calor. Poucas horas depois de o termostato ter sido ajustado a um nível mais alto, a temperatura corporal se aproxima desse nível.

A regulação da temperatura corporal requer um equilíbrio entre produção e perda de calor, cabendo ao hipotálamo regular o nível em que a temperatura deve ser mantida. Na febre, este ponto está elevado. A produção de calor não é inibida, mas a dissipação do calor está ampliada pelo fluxo sanguíneo aumentado através da pele e pela sudorese.

A febre pode ser resultado de infecções, lesões teciduais, processos inflamatórios e neoplasias malignas, além de outras condições.

Há evidências de que endotoxinas bacterianas (lipopolissacarídeos provenientes da parede celular) estimulam a síntese e a liberação de um pirogênio endógeno ao agir sobre os neutrófilos.

Uma vez liberado dentro da circulação geral, o pirogênio alcança o sistema nervoso central e estimula a liberação de prostaglandinas no cérebro, em particular na área pré-óptica hipotalâmica. Este último estágio é sensível a substâncias como o ácido acetilsalicílico. (Ver *Febre* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Boxe

Significado biológico da febre

A febre é benéfica ao paciente? Pode-se dizer que, em algumas infecções, a hipertermia parece ser nitidamente benéfica. É o caso da neurosífilis, das infecções gonocócicas e da brucelose crônica. Algumas outras doenças, tais como a artrite reumatoide e a uveíte, às vezes melhoram após piretoterapia. Não obstante, na imensa maioria das doenças infecciosas não há razão para se acreditar que a hiperpirexia acelere a fagocitose, a formação de anticorpos ou quaisquer outros mecanismos de defesa. Assim sendo, a febre é mais um sinal de alerta do que um mecanismo de defesa.

Além disso, a febre apresenta alguns aspectos nocivos; desse modo, a maior velocidade de todos os processos metabólicos acentua a perda de peso, e a espoliação do nitrogênio aumenta o trabalho e a

frequência do coração. A sudorese agrava a perda de líquidos e eletrólitos. Pode haver mal-estar consequente à cefaleia, fotofobia, indisposição geral ou uma desagradável sensação de calor. Os calafrios e os suores profusos das febres sépticas são particularmente penosos para o paciente.

Sintomas subjetivos da febre

Varia muito entre as pessoas a percepção do estado febril. Muitos pacientes são capazes de avaliar com precisão as elevações térmicas de seu organismo, enquanto outros, com temperaturas elevadas, nada sentem. Quando a temperatura se eleva subitamente, o paciente pode mesmo sentir frio ou, mais frequentemente, calafrios. Por vezes, ele não se dá conta de que está febril porque outros sintomas dominam o quadro clínico.

Boxe

Síndrome febril

A febre não é apenas um sinal, constituindo, na verdade, parte de uma síndrome (síndrome febril) na qual, além de elevação da temperatura, ocorrem vários outros sintomas e sinais, cujo aparecimento e intensidade variam em relação direta com a magnitude da hipertermia, destacando-se a astenia, inapetência, cefaleia, taquicardia, taquipneia, taquisfigmia, oligúria, dor no corpo, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, delírio, confusão mental e até convulsões, principalmente em recém-nascidos e crianças.

Características semiológicas da febre

Devem ser analisadas as seguintes características semiológicas da febre:

- Início
- Intensidade
- Duração
- Modo de evolução
- Término.

Início. Pode ser súbito ou gradual. No primeiro caso, instala-se de um momento para outro a elevação da temperatura. Nesse caso, acompanha-se quase sempre dos sinais e sintomas que compõem a síndrome febril. É frequente a sensação de calafrios nos primeiros momentos da hipertermia.

A febre pode instalar-se de maneira gradual e o paciente nem perceber seu início. Em algumas ocasiões, predomina um ou outro sintoma da síndrome febril, prevalecendo a cefaleia, a sudorese e a inapetência.

Conhecer o modo de início da febre tem utilidade prática. Em algumas afecções, a instalação é súbita, enquanto, em outras, é gradual, levando dias ou semanas para caracterizar-se o quadro febril.

Intensidade. Aplica-se a seguinte classificação, tomando por referência o nível da temperatura axilar:

Febre leve ou febrícula: até 37,5°C

Febre moderada: de 37,6° a 38,5°C

Febre alta ou elevada: acima de 38,6°C.

A intensidade da febre depende da causa e da capacidade de reação do organismo. Pacientes em mau estado geral, os indivíduos em choque e as pessoas idosas podem não apresentar febre ou ter apenas uma febrícula quando acometidos de processos infecciosos.

Duração. A duração da febre é uma característica de grande relevância, influenciando inclusive na conduta do médico, que é diferente nos casos cuja febre se instalou há poucos dias em relação a outros que vêm apresentando febre por tempo prolongado.

Por isso, tem-se procurado estabelecer um conceito de *febre prolongada*, mas não existe consenso quanto ao tempo mínimo de duração para que se aplique esta designação; em geral, ela é usada quando a febre permanece por mais de 1 semana, tenha ou não caráter contínuo.

Esse conceito é prático e conveniente, pois é possível fazer-se uma lista relativamente curta das principais doenças que causam febre prolongada, destacando-se: *tuberculose, septicemia, malária, endocardite infecciosa, febre tifoide, colagenoses,*

linfomas, pielonefrite, brucelose e esquistossomose.

Modo de evolução. A rigor, só se poderá saber o modo de evolução da febre por meio da análise de um quadro térmico, mas a simples informação obtida da anamnese pode servir de base para se conhecer essa característica.

O registro da temperatura em uma tabela, dividida no mínimo em dias, subdivididos em 4 ou 6 horários, compõe o que se chama *gráfico* ou *quadro térmico*, elemento indispensável para se estabelecer com rigor o tipo de evolução da febre. Unindo-se por uma linha os valores de temperatura, fica inscrita a curva térmica do paciente (Figura 10.58).

A anotação costuma ser feita 1 ou 2 vezes/dia, mas, em certos casos, registra-se a temperatura de 4 em 4 ou de 6 em 6 h.

O mais comum é a mensuração de temperatura pela manhã e à tarde.

Classicamente descrevem-se os seguintes tipos evolutivos de febre:

Febre contínua: aquela que permanece sempre acima do normal com variações de até 1°C e sem grandes oscilações; por exemplo, febre tifoide, endocardite infecciosa e pneumonia (Figura 10.59)

Febre irregular ou séptica: registram-se picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou períodos de apirexia. Não há qualquer caráter cíclico nestas variações. Mostram-se totalmente imprevisíveis e são bem evidenciadas quando se faz a tomada da temperatura várias vezes ao dia; um exemplo típico é a septicemia. Aparece também nos abscessos pulmonares, no empiema vesicular, na tuberculose e na fase inicial da malária (Figura 10.60)

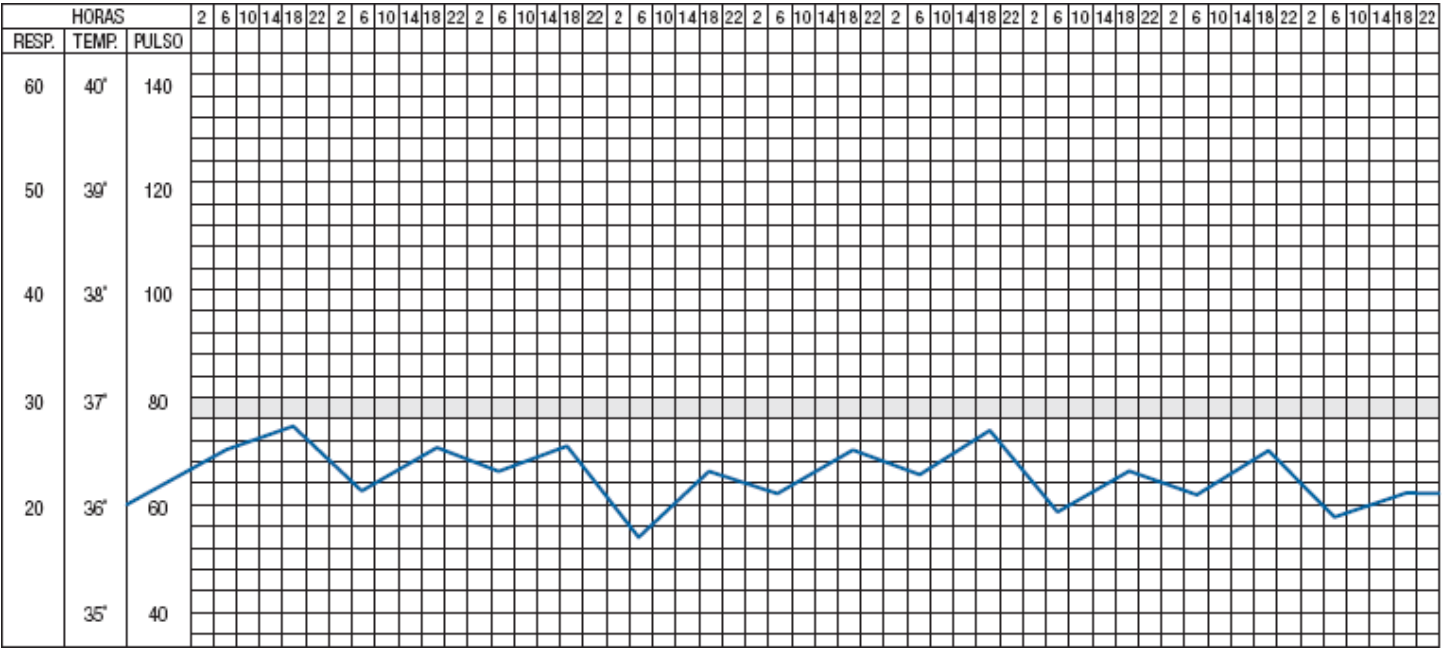


Figura 10.58 Gráfico ou quadro térmico normal.

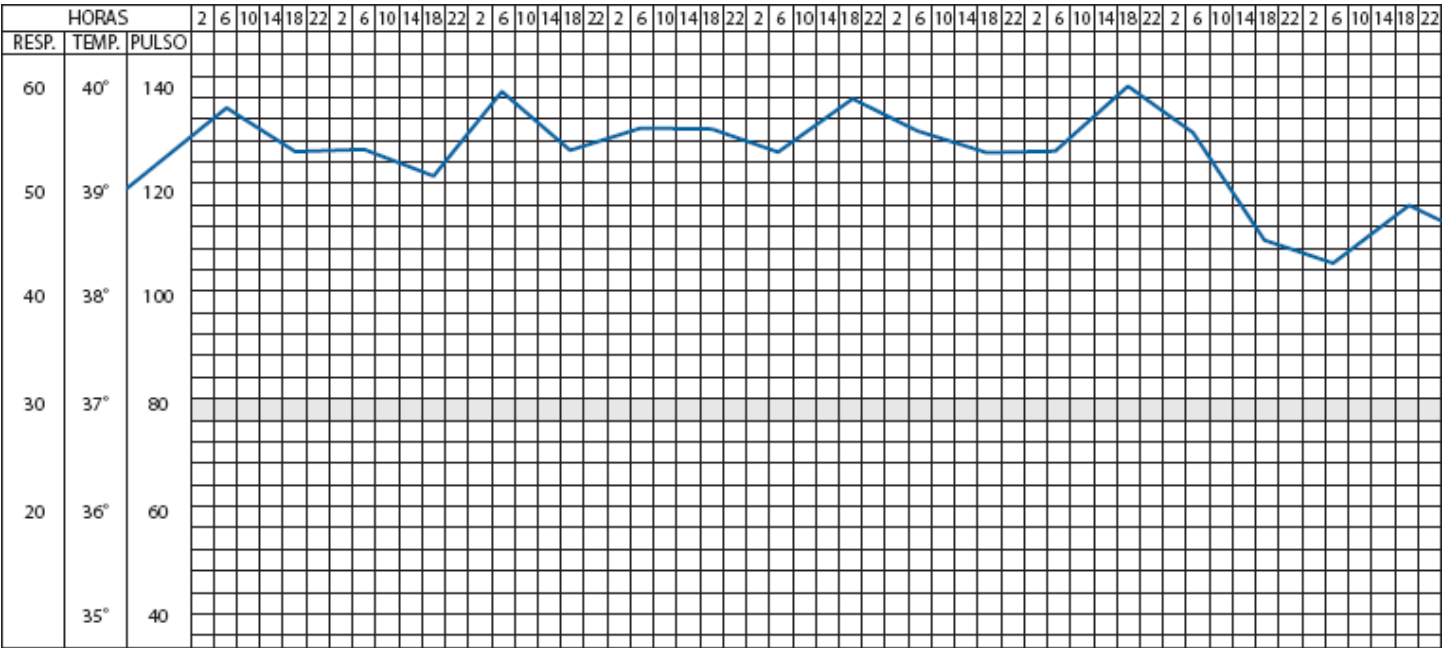


Figura 10.59 Febre contínua. A temperatura permanece acima do normal, com variações de até 1°C, mas sem grandes oscilações.

Febre remitente: há hipertermia diária, com variações de mais de 1°C e sem períodos de apirexia. Ocorre na septicemia, pneumonia, tuberculose (Figura 10.61)

Febre intermitente: nesse tipo, a hipertermia é ciclicamente interrompida por um período de temperatura normal; isto é, registra-se febre pela manhã, mas esta não aparece à tarde; ou então, em 1 dia ocorre febre, no outro, não. Por vezes, o período de apirexia dura 2 dias. A primeira se denomina *cotidiana*, a segunda *terça* e a última *quarta*. O exemplo mais comum é a malária. Aparece também nas infecções urinárias, nos linfomas e nas septicemias (Figura 10.62)

Febre recorrente ou ondulante: caracteriza-se por período de temperatura normal que dura dias ou semanas até que sejam interrompidos por períodos de temperatura elevada. Durante a fase de febre não há grandes oscilações; por exemplo: brucelose, doença de Hodgkin e outros linfomas.

Término. É clássico conceituar o término da febre em:

Crise: quando a febre desaparece subitamente. Neste caso costumam ocorrer sudorese profusa e prostração. Exemplo típico é o acesso malárico

Lise: significa que a hipertermia vai desaparecendo gradualmente, com a temperatura diminuindo dia a dia, até atingir níveis normais. Observado em inúmeras doenças, é mais bem reconhecido pela análise da curva térmica.

Boxe

Febre e antibióticos

Deve ser ressaltado que não são somente as doenças infecciosas as causadoras de elevação térmica. Todavia, no trabalho cotidiano do médico, é nos germes e nos parasitos que se encontram as causas mais frequentes de febre. Com grave prejuízo para os pacientes, assiste-se com frequência a um erro elementar, qual seja o uso de antibióticos, indiscriminadamente, em todo paciente febril, sem a preocupação de estabelecer o agente responsável pelo processo infeccioso. Os antibióticos são uma das maiores conquistas da ciência médica. Não saber usá-los corretamente constitui erro imperdoável do médico com muitas consequências práticas, incluindo o desenvolvimento de cepas resistentes.

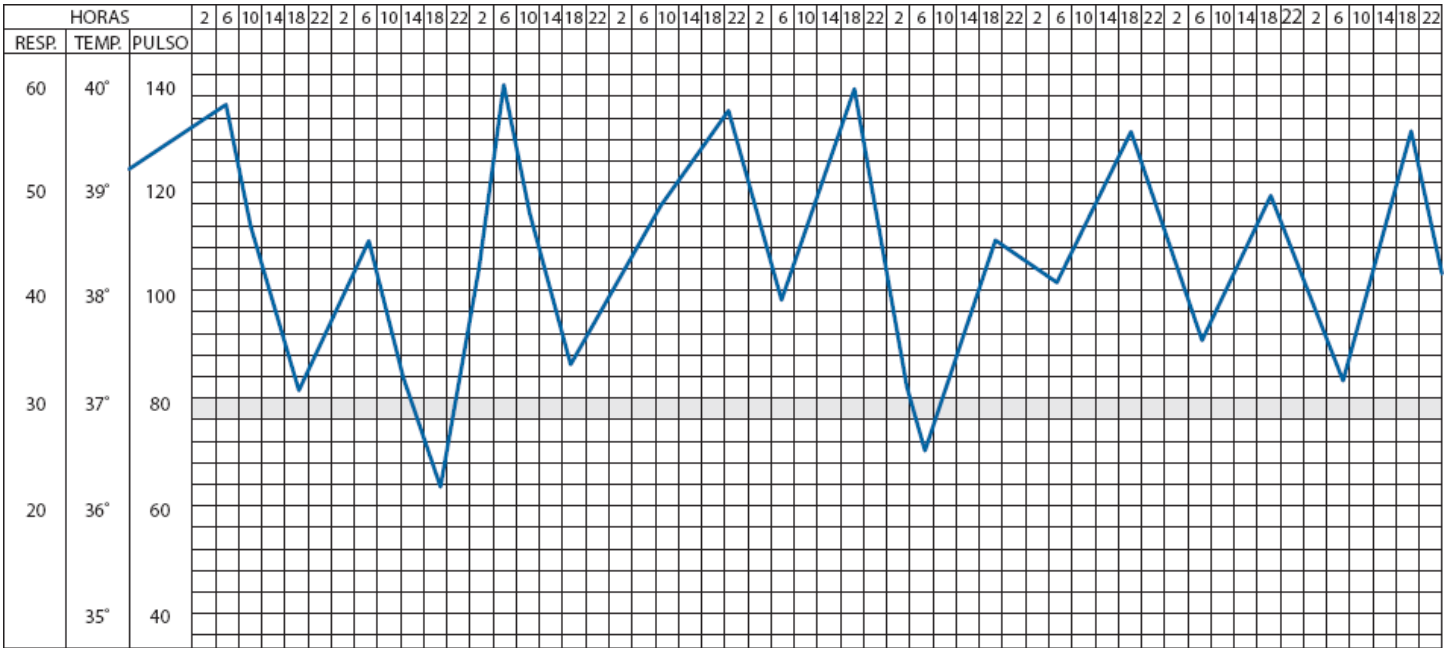


Figura 10.60 Febre irregular ou séptica. Registram-se picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou períodos de apirexia.

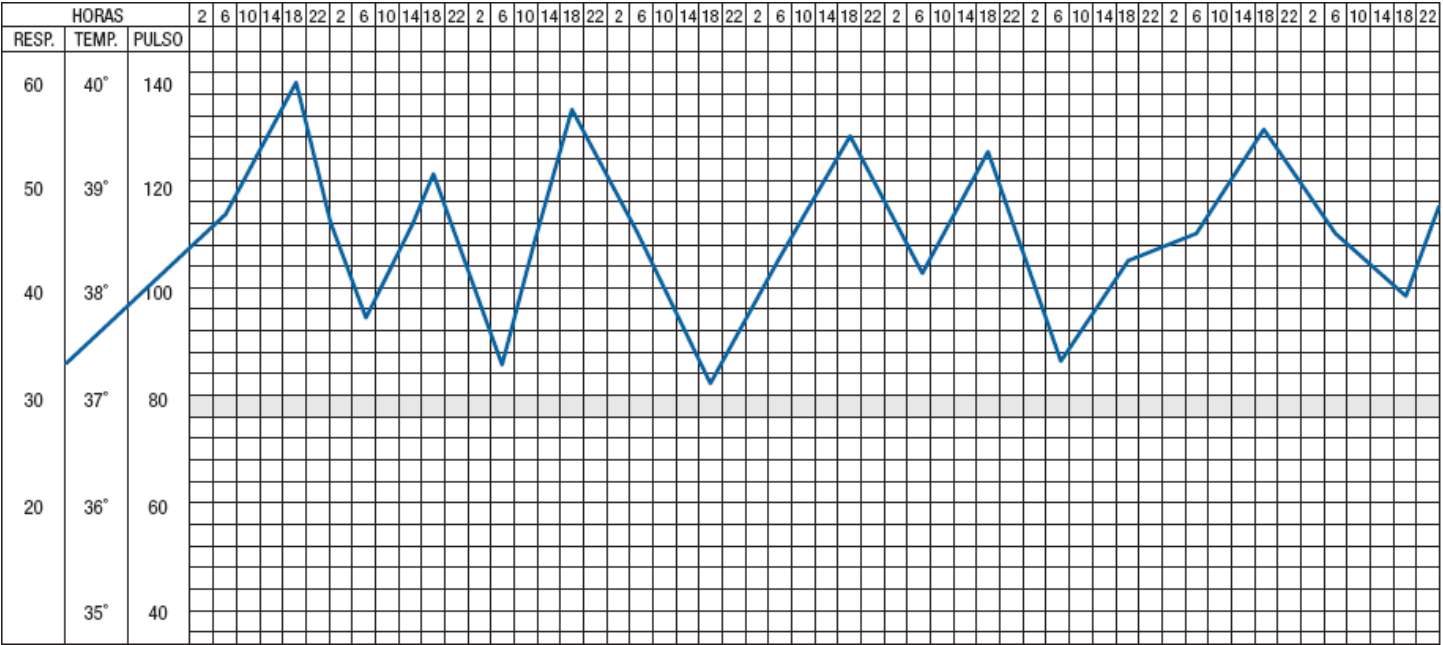


Figura 10.61 Febre remitente. Hipertermia diária com variações de mais de 1°C, sem períodos de apirexia.

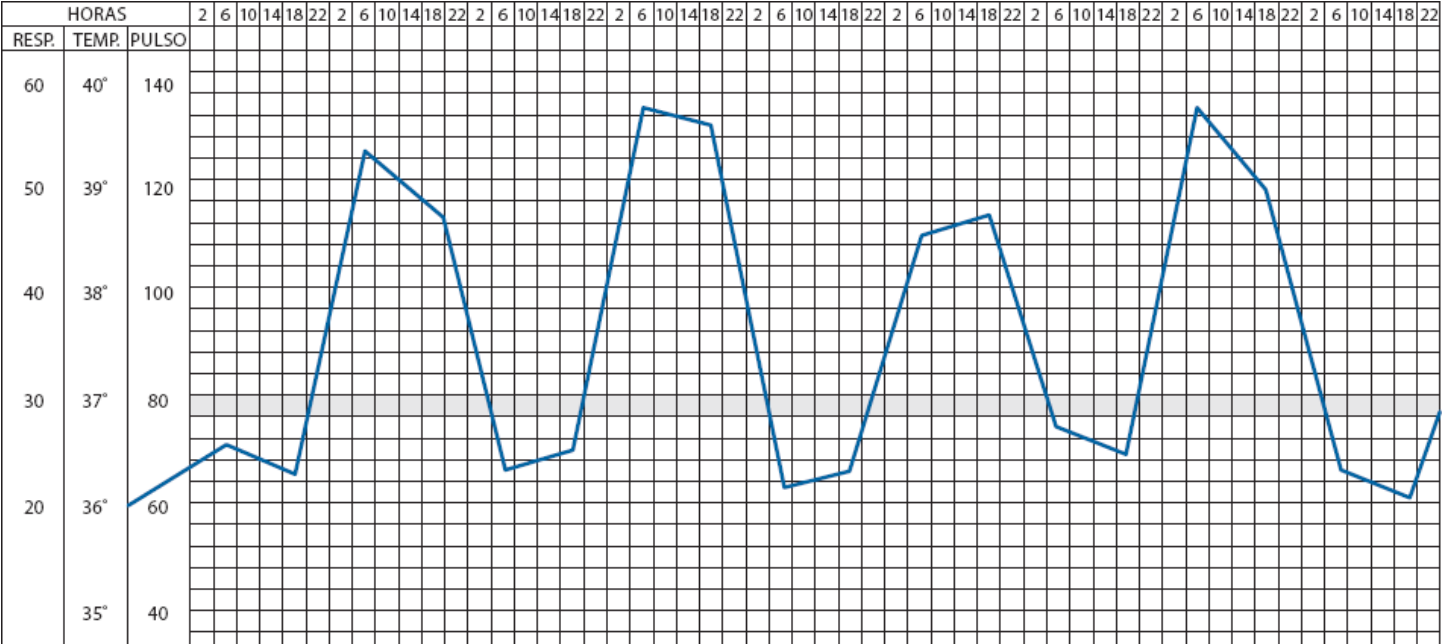


Figura 10.62 Febre intermitente. A hipertermia é interrompida por um período de temperatura normal. Neste caso configura-se o tipo terçã, ou seja, em 1 dia ocorre febre e no outro não.

Causas de febre

As doenças causadoras de febre podem ser divididas em três grupos:

- Por aumento da produção de calor, como ocorre no hipertireoidismo (atividade aumentada da glândula tireoide)
- Por bloqueio na perda de calor, como acontece na insuficiência cardíaca congestiva, na ausência congênita das glândulas sudoríparas (produtoras de suor) e em certas doenças da pele (p. ex., ictiose)
- Por lesão dos tecidos, grupo no qual se inclui a maioria das doenças febris, ou seja:
 - Todas as infecções por bactérias, riquetsias, vírus e outros microrganismos
 - Lesões mecânicas, como nos processos cirúrgicos e nos esmagamentos
 - Neoplasias malignas
 - Doenças hemolinfopoéticas
 - Afecções vasculares, incluindo infarto do miocárdio, hemorragia ou trombose cerebral e trombose venosa
 - Distúrbios dos mecanismos imunitários ou doenças imunológicas: colagenoses, doença do soro e febre resultante da ação de

medicamentos

- Doenças do sistema nervoso central.

Doenças do sistema nervoso. Quase sempre há febre após *lesão cerebral*, e o nível da temperatura pode ter algum valor na avaliação prognóstica. Nos casos mais graves, quase sempre a febre é elevada, podendo haver rápida ascensão da temperatura antes do óbito.

O *acidente vascular cerebral* é acompanhado de febre moderada, de 37,5°C a 38,5°C. Nas grandes hemorragias pode surgir temperatura muito elevada.

Na *hipertermia neurogênica*, a temperatura pode elevar-se após intervenções cirúrgicas na região da fossa hipofisária e no 3º ventrículo. A hipertermia pode ser grave.

A *lesão da medula* acompanha-se de grave distúrbio da regulação da temperatura. Lesões da medula cervical inferior produzem temperatura corporal muito baixa, enquanto as pessoas com lesão da parte alta da medula cervical apresentam com frequência febre elevada. A causa dessa perturbação da temperatura é, talvez, a interrupção de feixes aferentes e eferentes do hipotálamo.

Neoplasias malignas. As neoplasias malignas quase sempre causam febre.

No *carcinoma broncogênico*, a febre pode ser o resultado de infecção associada; porém, muito comumente, o próprio tumor parece ser o responsável.

Hipernefroma e *carcinoma primitivo ou metastático do fígado* com frequência determinam febre prolongada.

Acredita-se que a causa da febre seja a liberação de substâncias pelas células neoplásicas ou produtos do tecido destruído pelo tumor. Contudo, há pouca correlação entre o grau de febre e a extensão da necrose tecidual. Na verdade, a infecção secundária é a principal causa da febre nas doenças malignas. A febre não apresenta aspecto característico, embora a febre baixa ou recidivante seja mais comum em neoplasias não associadas à infecção.

Nos *linfomas*, a febre é quase constante, sendo frequentemente o primeiro sintoma.

A *leucemia aguda* geralmente é uma enfermidade febril, mesmo quando não há infecção.

Anemias hemolíticas e púrpura. Algumas anemias hemolíticas são associadas à febre, especialmente as de causa imunológica, e as crises de hemólise na anemia falciforme.

Também as doenças hemorrágicas (púrpura trombocitopênica, hemofilia e escorbuto) provocam febre se houver hemorragia nos tecidos.

Doenças infecciosas e parasitárias. A febre está quase sempre presente nas infecções virais, bacterianas e por protozoários e nos processos inflamatórios de fundo imunoalérgico (artrite reumatoide, lúpus eritematoso).

Na maior parte das doenças infecciosas e parasitárias, a febre logo se acompanha de sinais e sintomas indicativos do órgão afetado, facilitando o reconhecimento da enfermidade. Exemplos: febre e dor de garganta nas *amigdalites*; febre, dor pleurítica e tosse com expectoração hemoptoica nas *pneumonias*; febre, náuseas e icterícia na *hepatite infecciosa*; febre e lesões cutâneas na *erisipela*; febre, dor abdominal e contratura da parede no *abdome agudo*.

Contudo, o paciente com febre pode ser visto pelo médico antes do aparecimento de sintomatologia específica da enfermidade. Nesses casos, dados epidemiológicos podem colocar o médico de sobreaviso.

Há um grupo de doenças infecciosas que têm como uma de suas características o aparecimento de febre prolongada, nem sempre acompanhada de sintomatologia indicativa da enfermidade responsável por ela.

Neste grupo destacam-se as seguintes afecções:

Tuberculose: a tuberculose é capaz de provocar quadros febris desorientadores, com frequência surpreendente, apesar de que uma simples radiografia de tórax costuma ser suficiente para elucidar sua forma mais comum – a tuberculose pulmonar. Nas outras localizações, principalmente a intestinal e a geniturinária, pode haver maior dificuldade diagnóstica

Endocardite infecciosa: na forma subaguda clássica da doença, quase sempre está presente um sopro cardíaco; contudo, a ausência de um sopro não elimina a possibilidade de estar em causa esta doença. O diagnóstico torna-se difícil quando se trata de pessoas idosas, porquanto em tais casos pode-se deixar de dar a devida importância à presença de um sopro cardíaco

Brucelose: essa infecção deve ser levada em consideração sempre que se trate de fazendeiros, veterinários ou pessoas que trabalham em matadouros. Existe uma concepção errônea de que a brucelose sempre se acompanha de artrite. Ela de fato determina com frequência artralgias e mialgias, porém é muito raro que haja um processo inflamatório com rubor e intumescimento articular

Salmonelose: a febre tifoide apresenta grandes variações clínicas, podendo determinar uma febre que dura semanas praticamente sem outros sintomas

Infecções piogênicas: certas localizações inflamatórias podem ser relativamente assintomáticas, estando enquadrados neste

grupo a osteomielite vertebral e dos ossos pelvianos, certos abscessos, as colangites e as bronquiectasias infectadas

Amebíase: geralmente a colite amebiana provoca sintomas que indicam tratar-se de uma doença do cólon. Em contrapartida, o comprometimento hepático pode não oferecer um quadro clínico característico e a febre prolongada pode ser sua principal manifestação

Esquistossomose: as pessoas que vivem em regiões endêmicas podem apresentar febre prolongada decorrente dessa parasitose. A diarreia, a hepatoesplenomegalia e a anemia são sugestivas

Malária: a malária é uma causa frequente de febre em várias regiões do país. Antes de adquirir o caráter intermitente, a febre é contínua ou irregular, podendo causar alguma dificuldade diagnóstica

Doença de Chagas aguda: febre de duração prolongada é um dos principais sintomas da fase aguda da doença de Chagas.

Outras causas de febre

Podem apresentar quadro febril as *colagenoses* (lúpus eritematoso disseminado, artrite reumatoide, periarterite nodosa, moléstia reumática), as *crises hemolíticas* que ocorrem em alguns tipos de anemia, a *tromboflebite*, a *arterite temporal*, a *sarcoidose*, além do uso de alguns medicamentos, inclusive antibióticos.

Boxe

Hipotermia

Consiste na diminuição da temperatura corporal abaixo de 35,5°C na região axilar ou de 36°C no reto.

Pode ser induzida artificialmente quando se vai submeter o paciente a determinados tipos de cirurgia ou pode ser consequente a congelamento acidental, choque, síncope, doenças consuntivas, hemorragias graves e súbitas, coma diabético e nos estágios terminais de muitas doenças.

Boxe

Controle da temperatura e envelhecimento

Os pacientes idosos apresentam alterações no sistema de regulação da temperatura corporal responsáveis não só pela ausência de febre, quando acometidos por doenças infecciosas, como também os predispõem a um maior risco de apresentar hipotermia ou hipertermia em situações de frio ou calor extremos.

A fisiopatologia do descontrole de temperatura no idoso pode ser assim sumariada:

Hipotermia:

Sensação de frio diminuída

Capacidade de perceber as alterações da temperatura diminuída

Resposta autonômica vasoconstritora ao frio anormal

Resposta de calafrios diminuída

Termogênese diminuída

Hipertermia:

Limiar central de temperatura elevado

Sudorese diminuída ou ausente

Capacidade de percepção do calor diminuída

Resposta vasodilatadora ao calor diminuída

Reserva cardiovascular diminuída.

Quanto à febre, é importante lembrar que podem apresentar infecções sem resposta febril, sendo a ausência desta um sinal de mau prognóstico. Podem apresentar, com mais frequência, confusão mental, delírios e alucinações quando têm elevação da temperatura.

Postura ou atitude na posição de pé

Deve-se observar a atitude ou posição do paciente não apenas no leito, mas também quando ele se põe de pé.

Uma postura defeituosa pode ser consequência de mau costume ou de afecção da coluna vertebral.

Entre as queixas mais comuns na prática médica estão a *dorsalgia* e a *lombalgia*, que, em muitos casos, advêm de má postura.

Boxe

Classificação

A postura pode ser classificada da seguinte maneira (Figura 10.63)

Boa postura:

- Cabeça ereta ou ligeiramente inclinada para diante
- Peito erguido, fazendo adiantar ao máximo essa parte do corpo
- Abdome inferior achatado ou levemente retraído
- Curvas posteriores nos limites normais

Postura sofrível:

- Cabeça levemente inclinada para diante
- Peito achatado
- Abdome algo protruso, passando a ser a parte mais saliente do corpo
- Curvas posteriores exageradas

Má postura:

- Cabeça acentuadamente inclinada para diante
- Peito deprimido
- Abdome saliente e relaxado
- Curvas posteriores extremamente exageradas.

Essas posturas guardam certa relação com o biótipo da pessoa. Assim, os longilíneos frequentemente reúnem as características de má postura.

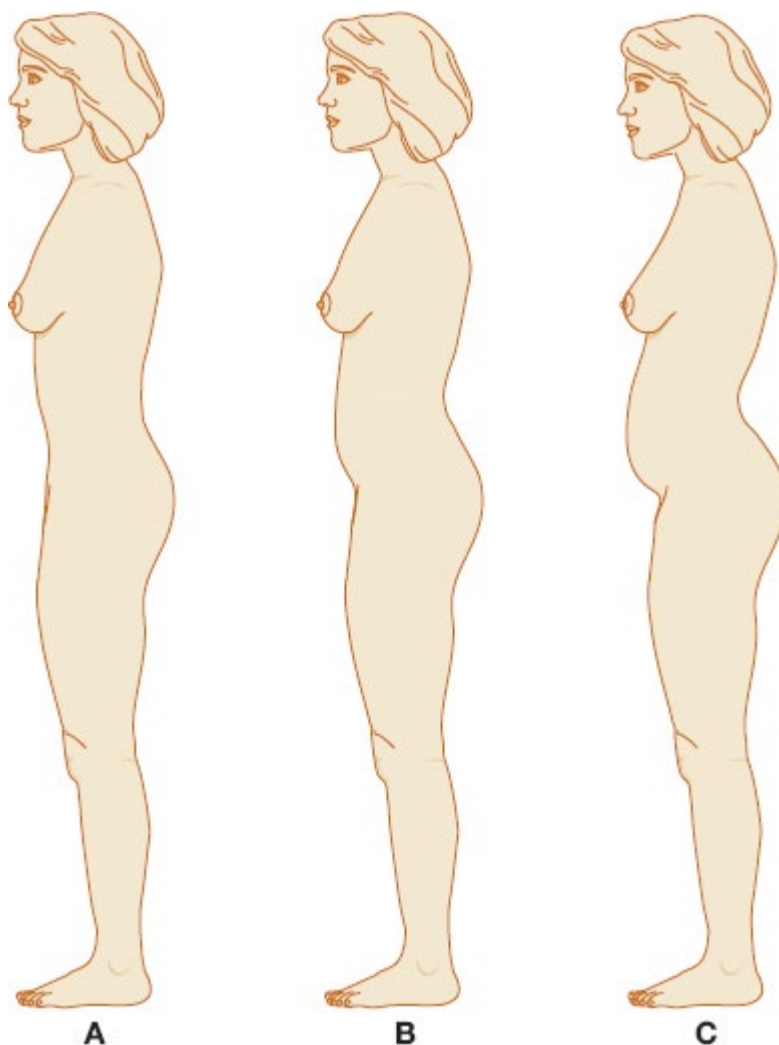


Figura 10.63 Postura ou atitude na posição de pé de pessoa jovem. **A.** Boa postura. **B.** Postura sofrível. **C.** Má postura.

Uma atitude muito típica pode ser vista nos parkinsonianos e é determinada pela rigidez muscular generalizada. O paciente permanece com o tronco ligeiramente fletido para a frente, os membros superiores igualmente fletidos, enquanto as mãos e os dedos se movem continuamente, tomados de um tremor lento e de amplitude sempre igual.

Outras atitudes – da síndrome cerebelar, da síndrome de Little, das hemiplegias – serão vistas no Capítulo 20, *Exame Neurológico*.

Cifose, lordose e escoliose

As afecções da coluna costumam acompanhar-se de alterações da posição, cabendo referências a:

Cifose: é uma alteração da forma da coluna dorsal com concavidade anterior, vulgarmente designada “corcunda”. A causa mais comum é o vício de postura. Pode ser consequência de tuberculose da coluna (mal de Pott), osteomielite, neoplasias, ou ser de origem congênita

Lordose (cervical ou lombar): é o encurvamento da coluna vertebral, formando concavidade para trás. Decorre de alterações de vértebras ou de discos intervertebrais, podendo ser citada como exemplo a espondilite reumatoide

Escoliose: é o desvio lateral da coluna em qualquer segmento vertebral, sendo mais frequente na coluna lombar ou lombodorsal. Pode ser de origem congênita ou secundária a alterações nas vértebras ou dos músculos paravertebrais.

É frequente a combinação de desvio lateral com encurvamento posterior que se denomina *cifoescoliose*. (Ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*.)

Boxe

Postura e envelhecimento